

百病中醫針灸療法

学苑出版社

刘寿永 蒋莉莉 主编



内 容 提 要

本书是介绍用针灸疗法治疗常见病、多发病的专书。分总论和各论两部分。总论概述了经穴主治及刺灸法。各论按内、外、皮、骨、妇、儿、五官及其他的顺序,根据病名,将针灸方法、选穴贯之于后,供读者选用。全书本着全而不复,简而有要,学而能用,用之有效,启发思路,方便易行的宗旨,共收录了300余种病症的治疗方法。

(京) 新登字151号

百病中医针灸疗法

主 编: 刘寿永 蒋莉莉

责任编辑: 陈 辉

责任校对: 叶金寿

封面设计: 张 弢 封面题字: 赵家熹

出版发行: 学苑出版社 邮政编码: 100032

社 址: 北京市西城区成方街33号

印 刷: 北京印刷三厂

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 787×1092 1/32

印 张: 17 字数: 522千字

印 数: 0001—5550

版 次: 1991年10月北京第1版第1次印刷

ISBN 7—5077—0248—0/R·31

定 价: 9.00元

学苑版图书印、装错误可随时退换。



主 编

刘寿永 蒋莉莉

副主编

翟若金 叶 明 殷兆华 张云云 王尚勇

编委及编写人员名单

(以下按姓氏笔划为序)

王 凡	王丽平	王 斌	王兆凯	毛克臣	石春敏
石 岩	冯秀杰	刘 轩	刘剑君	刘保延	刘桂芬
刘丹华	曲立新	关德安	江玉文	江 丹	孙兰平
齐国柱	苏秀海	李守良	李 建	李晓梅	李 黎
李祖荣	李秩伦	庞晓颖	陈映辉	沈 军	周迺英
张德旗	张 建	张永平	赵炎凌	赵纯有	赵玉东
姚君弘	姚念宏	侯丽萍	袁晓宁	高继宁	韩臣子
徐大鹏	徐湘江	崔远卓	黄 俭	黄宝棟	储真真
裴 胜	樊惠兰	穆希泉			

前 言

这是一部汇集当代针灸学精华、实用性强、应用范围广、查阅方便的针灸学工具书，它反映了当今我国针灸学的治疗特点及临床水平，是众多针灸专家临床经验的结晶。

当前，针灸学日益受到世界医学界的重视，得到了迅速发展，各种针灸学文献层出不穷。特别是众多的临床报道，有着很高的学术价值和临床价值。然而，这些宝贵的经验犹如零金碎玉，散见于众多的学术期刊及文献资料中，给广大基层针灸工作者的学习与交流带来了诸多的不便。因此，收集整理文献资料，把它们系统分类归纳显得非常必要。我们编写《百病中医针灸疗法》一书的目的，就是要把针灸学散在的临床经验串集起来，为基层针灸工作者提供一部全面反映我国当代针灸学临床全貌，学而能用，用之有效，启发思路的临床工具书。

在本书的编写过程中，得到了广大针灸学专家的大力支持，我们表示衷心的感谢。由于我们水平有限，难免出现缺点和错误，敬请广大读者批评指正。

刘寿永 蒋莉莉

总 论

在原始社会，人类在烘火取暖的基础上，逐渐发现局部取暖可以消除某些病痛。以后又经过无数次的反复实践，用树枝、干草作燃料，对人体局部进行烧灼、烫、熨，治愈了更多的疾病，逐渐形成了灸法。后来人们选用了艾绒、做为灸法所用的专门材料。

古代的灸治方法，一般为直接灸。直接灸艾炷较大，施灸的壮数也较多。晋朝以降，人们逐渐把艾灸与别的药物结合起来，形成各种间接灸法。如隔蒜灸、隔姜灸等等。在宋代的医籍里，记载了“天灸”。到了明代，人们发明了“神针火灸”，“雷火针”，灯火灸”等。时至今日，灸法的内容更加丰富，出现了“化学灸”，“电热灸”等众多的新方法。

在石器时代的生产活动中，人们发现某些工具可作为医疗之用，出现了“以石刺病”的砭。这就是我国针术的萌芽。随着冶金术的发明，出现了金属针具。在《内经》一书中，已经有了“九针”的记载。其后随着生产的发展，出现了金针、银针、马衔针、合金针等。

九针中最常用的为毫针，直到目前仍是针刺疗法的主要用具。圆针、鍤针为体表揩摩和按压的用具。鑱针为浅刺针，即箭头针，近代的皮肤针和滚刺筒都是根据它研制而成的。锋针为现在的三棱针，用于刺络。铍针又称剑针，用于切开皮肤排脓。圆利针为锐利粗针，用于速刺。长针为毫针的加长，近代的芒针即由长针发展而来。大针为毫针的增大，火烧后针刺称为火针。近代用于皮下埋藏的短针称为皮内针。针刺与电刺激相结合称为电针。针刺与药液相结合称为水针。穴位注射的无菌空气称气针。用电流直接刺激俞穴称为电兴奋疗法。耳针、面针、眼针、手针、足针、腕踝针等疗法属部位针法。在穴位

上导入药物称为离子导入法、利用光能穴位照射称为穴位照射法。此外，还有和外科手术相结合的挑针疗法、割治疗法、穴位埋线疗法等。近年来，随着医疗水平的逐渐提高，针具及针刺疗法仍在不断地发展，如小针刀疗法等。

目 录

总论	1
第一章 经穴主治及刺灸法	1
第一节 十二经脉	1
1. 手太阴肺经	1
2. 手阳明大肠经	3
3. 足阳明胃经	6
4. 足太阴脾经	12
5. 手少阴心经	15
6. 手太阳小肠经	16
7. 足太阳膀胱经	19
8. 足少阴肾经	29
9. 手厥阴心包经	33
10. 手少阳三焦经	34
11. 足少阳胆经	37
12. 足厥阴肝经	43
第二节 奇经八脉	45
1. 任脉	45
2. 督脉	49
第三节 经外奇穴	53
1. 头颈部	53
2. 躯干部	54
3. 四肢部	55
各论	59
第二章 内科疾病	59
第一节 传染病	59

1. 急性病毒性黄疸型肝炎·····	59
附：阳黄·····	62
2. 乙型甲型肝炎双重感染·····	62
3. 乙脑后遗症·····	63
4. 脑炎后遗症候群·····	65
5. 流行性出血热·····	66
6. 破伤风·····	68
7. 疟疾·····	68
8. 细菌性痢疾·····	69
9. 乳糜尿·····	71
第二节 消化系统疾病·····	71
1. 食道癌、胃癌·····	71
2. 溃疡病·····	72
3. 慢性浅表性胃炎·····	74
4. 慢性胃炎·····	75
5. 胃下垂·····	76
6. 胃痉挛·····	80
7. 膈肌痉挛·····	80
8. 神经性呕吐·····	84
9. 急性胃肠炎·····	85
10. 急性肠炎·····	87
11. 霉菌性肠炎·····	87
12. 胃肠功能紊乱·····	88
13. 慢性结肠炎·····	89
14. 急性腹泻·····	89
15. 慢性腹泻·····	90
附：五更泄·····	92
16. 便秘·····	92
17. 老年习惯性便秘·····	94
18. 习惯性便秘·····	94

19. 肝硬化	95
第三节 呼吸系统疾病	96
1. 感冒	96
附：发热	97
附：太阳中风	97
附：外感咳嗽	98
2. 哮喘	99
3. 支气管哮喘	105
4. 慢性支气管炎	107
5. 肺炎	112
6. 肺结核咯血	113
附：咳引尻痛	114
第四节 心血管系统疾病	115
1. 心律失常	115
2. 室上性心动过速	116
3. 早搏	117
4. 肺心病	118
5. 风湿性关节炎	119
附：痹症	123
6. 高血压病	124
附：高血压眩晕	128
附：眩晕	128
7. 冠状动脉粥样硬化性心脏病	129
8. 冠心病心绞痛	131
9. 高脂血症	132
第五节 泌尿系统疾病	134
1. 尿道炎	134
2. 小便不禁	134
3. 泌尿系统结石	135
4. 肾绞痛	139

5. 尿潴留	140
6. 慢性前列腺炎	141
7. 阳萎	143
8. 功能性不射精	145
9. 精液异常	147
10. 精液不液化症	148
11. 不育症	149
第六节 血液、新陈代谢、结缔组织疾病	150
1. 白细胞减少症	150
2. 化疗引起白细胞减少症	151
3. 苯引起白细胞减少症	152
4. 血液病出血	153
5. 血小板减少性紫癜	155
6. 糖尿病	156
7. 红斑狼疮	157
第七节 神经、精神系统疾病	158
1. 原发性三叉神经痛	158
附：眉棱骨痛	161
2. 偏头痛	161
3. 头痛	165
4. 颈源性头痛	167
5. 血管神经性头痛	168
6. 多发性神经炎	171
7. 急性感染性多发神经根炎	171
8. 根性神经痛	173
9. 进行性脊肌萎缩症	174
10. 脑动脉硬化症	175
11. 脑出血	175
12. 脑血栓形成	176
13. 缺血性中风	177

14. 脑梗塞	178
附：中风及后遗症	179
附：中风患肢浮肿	186
15. 脑血管意外	186
附：脑源性瘫痪、失语	191
16. 假性延髓麻痹	193
附：肌注所致下肢瘫痪	194
17. 癫痫	195
18. 面肌痉挛	201
19. 面神经炎	203
20. 颈椎病	216
21. 颈椎综合征	223
22. 神经衰弱	223
附：失眠症	225
23. 焦虑性神经症	228
24. 抑郁状态	229
25. 幻觉	230
26. 梅核气	231
27. 癔症	232
28. 精神分裂症	233
29. 精神病症	233
附：癫狂	234
第八节 内分泌系统疾病	235
1. 甲状腺瘤	235
2. 甲状腺机能减退症	236
3. 甲状腺功能亢进症	237
4. 内分泌性突眼	238
5. 单纯性肥胖症	239
6. 男子乳房发育症	242
第三章 外、皮、骨科疾病	243

第一节 外科疾病.....	243
1. 脑外伤及后遗症	243
2. 脑外伤昏迷	244
3. 颈淋巴结核	244
4. 胃扭转	246
5. 急性痉挛性腹痛	246
6. 急性阑尾炎	247
7. 急腹痛	248
8. 溃疡病急性穿孔	249
9. 肠粘连	250
10. 术后腹胀	251
11. 腹股沟疝及嵌顿疝	251
12. 胆囊炎	252
13. 胆石症	253
14. 胆绞痛	259
15. 胆道蛔虫症	261
16. 精索神经痛	263
17. 砍头疮	264
18. 脓疮	264
19. 软组织感染	265
20. 臀上皮神经炎	266
21. 臀上皮神经损伤	267
22. 肋间神经痛	267
23. 股外侧皮神经炎	268
24. 坐骨神经痛	270
25. 肌注损伤坐骨神经后遗症	277
26. 腓总神经麻痹	278
第二节 肛肠科疾病	278
1. 痔疮	278
2. 痔疮疼痛	280

3. 内痔便血症	281
4. 内外痔急性炎症性水肿	281
5. 痔科术后尿潴留	282
6. 脱肛	283
7. 肛裂	283
第三节 皮肤科疾病	284
1. 疖痈	284
2. 指(趾)头炎	285
3. 疮	286
4. 带状疱疹	286
5. 扁平疣	291
6. 睑疣	291
7. 跖疣	292
8. 冻伤	292
9. 鸡眼	293
10. 黄褐斑	294
附: 蝴蝶斑	294
11. 雀斑	295
12. 黧黑斑	296
13. 皮肤表面病症	297
14. 蜘蛛状血管瘤	298
15. 湿疹	298
16. 阴囊湿疹	299
17. 荨麻疹	300
18. 寒冷性荨麻疹	300
19. 皮肤瘙痒	301
20. 神经性皮炎	302
21. 银屑病	303
22. 掌跖脓疱性银屑病	304
23. 痤疮	305

24. 斑秃	309
25. 早秃	310
26. 脱发	311
27. 脂溢性脱发(油风)	312
28. 褥疮	312
29. 过敏性皮肤病	313
第四节 骨科疾病	314
1. 踝部骨折并下胫腓分离	314
2. 踝关节扭伤	316
3. 肱二头肌长腱滑脱	316
4. 臀肌筋膜炎	317
5. 软组织损伤	318
6. 颞下颌关节功能紊乱症	320
7. 落枕	321
8. 肩臂痛	322
9. 肩关节周围炎	323
10. 肱骨外上髁炎	330
11. 肘关节骨化性肌炎	333
12. 腕管综合征	333
13. 腱鞘囊肿	334
14. 腰软组织伤痛	336
15. 梨状肌综合症	337
16. 腰椎肥大性脊椎炎	338
17. 急性腰扭伤	339
18. 慢性腰背关节痛	346
19. 四肢慢性关节疼痛	347
20. 腰肌劳损	347
21. 腰痛	348
附: 瘀血腰痛	348
22. 腰椎间盘突出症	349

23. 腰棘间韧带损伤	351
24. 胸胁挫伤	351
25. 肋软骨炎	352
26. 胸胁痛	353
27. 膝关节创伤性滑膜炎	353
28. 膝关节侧副韧带损伤	354
29. 腓肠肌痉挛	354
30. 跖腱膜炎	355
31. 类风湿性关节炎	355
32. 增生性关节炎	356
33. 急性关节扭伤	357
34. 增生性脊柱炎	357
35. 强直性脊柱炎	358
36. 脊柱退行性病变	359
37. 骨质增生	359
38. 足跟骨骨质增生	360
39. 足跟疼痛	361
附: 足跟痹	362
40. 外伤性截瘫	362
41. 外伤性截瘫所致尿闭	365
42. 伤筋	366
第四章 妇、儿科疾病	369
第一节 妇科疾病	369
1. 功能性子宫出血	369
2. 痛经	370
3. 慢性盆腔炎	374
4. 带下	375
5. 单纯性外阴瘙痒	376
6. 外阴白斑	377
7. 子宫肌瘤	378

8. 子宫后位不孕	379
9. 促排卵	379
10. 妊娠恶阻	380
11. 胎位不正	381
12. 滞产	382
13. 产后病	383
14. 产后尿潴留	384
15. 产后缺乳	385
16. 急性乳腺炎	388
17. 乳腺小叶增生症	391
18. 乳腺增生	391
19. 乳痛症	392
20. 预防人流综合征	393
21. 脏躁病	394
22. 功能性肢体瘫痪（绝育术后神经症）	395
第二节 儿科疾病	396
1. 腮腺炎	396
2. 百日咳	400
3. 小儿麻痹	403
4. 小儿麻痹后遗症	404
5. 小儿腹泻	405
6. 小儿泄泻	411
7. 小儿肠炎	412
8. 小儿单纯性消化不良	413
9. 小儿疳积	414
10. 小儿积滞内热	416
11. 小儿厌食症	417
12. 小儿呼吸系统疾患	418
13. 发热惊厥	419
附：小儿惊风	420

14. 哮喘	421
15. 缺铁性贫血	422
16. 不安腿综合征	423
17. 小儿尿频	423
18. 遗尿	424
19. 下肢软瘫	433
20. 脑积水	434
21. 脑瘫	434
22. 智力低下	437
23. 尺偏型肱骨髁上骨折	438
24. 小儿睾丸鞘膜积液	439
25. 疥疮	439
26. 单纯性腹痛	440
27. 肠痉挛	441
28. 肠套叠	442
29. 蛔虫症	442
30. 小儿流涎症	443
31. 急性扁桃体炎	444
32. 慢性鼻炎	445
33. 急性中耳炎	445
34. 乳牙慢性尖周炎伴瘻管	446
第五章 五官科疾病及其它	447
第一节 眼科疾病	447
1. 睑腺炎 (麦粒肿)	447
2. 睑板腺囊肿 (霰粒肿)	450
3. 上睑下垂	451
4. 急性结膜炎	452
5. 出血性结膜炎	455
6. 急性眼痛	456
7. 弥漫性细点状角膜炎	457

8. 慢性青光眼	457
9. 老年性初期白内障	458
10. 白内障	459
11. 中央性视网脈絡膜炎	461
12. 视网膜静脉周围炎	461
13. 视网膜动脉阻塞	462
14. 视网膜色素变性	463
15. 视神经萎缩	464
16. 皮质盲	464
17. 眼底病	465
18. 视神经疾患(视神经萎缩、球后神经炎、视网膜炎)	466
19. 色盲	467
20. 青少年近视	469
21. 假性近视	478
22. 屈光不正	478
23. 眼外直肌麻痹	479
24. 麻痹性斜视	480
25. 先天性内外斜视	482
26. 共转性内斜视	482
27. 癥病性弱视	483
28. 电光性眼炎	483
29. 外伤性瞳孔散大	484
第二节 鼻科疾病	485
1. 鼻衄	485
2. 过敏性鼻炎	486
3. 鼻炎	489
第三节 咽喉科疾病	491
1. 急性扁桃体炎	491
2. 扁桃体摘除术后咽痛	492
3. 咽喉肿痛	493

4. 咽异感症	494
5. 口舌痛	494
6. 声带肥厚	495
7. 声带疾患	495
8. 功能性失音	496
9. 软腭麻痹	497
第四节 耳科疾病	498
1. 美尼尔氏综合征	498
2. 聋哑	499
3. 抗生素中毒性耳聋	500
4. 突发性耳聋	501
第五节 口腔科疾病	502
1. 牙痛	502
2. 针麻拔牙术	504
3. 智齿冠周炎	505
第六节 其它	505
1. 戒烟	505
2. 戒酒	507
3. 施行颈部手术	508
4. 施行扁桃体摘除术	508
5. 行切脾术	509
6. 行妇科手术	510
7. 休克病人手术	511
8. 术后切口痛	511
9. 微波针刺麻醉	512
10. 纤维胃镜检查	513
11. 痛证	514
12. 竞技综合症	520
13. 梦游	521
14. 痛性结节	521

15. 少阳证	522
16. 阴虚盗汗	523
17. 厥证足膝厥冷	523

第一章 经穴主治及刺灸法

第一节 十二经脉

1. 手太阴肺经

<1> 中府（肺募穴）

〔定位〕距胸骨正中线6寸，平第一肋间处取穴。

〔主治〕咳嗽，气喘，喉痹，胸中胀满或疼痛，肩背痛。

〔刺灸法〕向外斜刺0.5—0.8寸。

<2> 云 门

〔定位〕距胸骨正中线6寸，锁骨下缘凹陷处。

〔主治〕咳嗽，气喘，喉痹，胸中烦热，胸痛。

〔刺灸法〕向外斜刺0.5—0.8寸。

<3> 天 府

〔定位〕上臂内侧，当腋前皱襞上端水平线下3寸，肱二头肌桡侧缘。

〔主治〕咳嗽，气喘，鼻衄，肩部及上臂内侧痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<4> 侠 白

〔定位〕天府穴下1寸，肘横纹上5寸，肱二头肌桡侧缘。

〔主治〕咳嗽，气短，胸痛烦满，上臂内侧痛，干呕。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<5> 尺 泽 (合穴)

〔定位〕肘横纹上，肱二头肌腱桡侧缘。

〔主治〕咳嗽，气喘，潮热，咳血，鼻衄，咽喉肿痛，胸满胸痛，肘臂疼痛，小儿惊风，乳痈。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸

<6> 孔 最 (郄穴)

〔定位〕前臂内侧，尺泽与太渊连线上，腕横纹上7寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，咳血，咽喉肿痛，失音，肘臂挛痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸

<7> 列 缺 (络穴、八脉交会穴)

〔定位〕侧掌，桡骨茎突上方，腕横纹上1.5寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，咽喉肿痛，腕部疼痛，头项强痛，口眼喎斜，牙痛。

〔刺灸法〕向上斜刺0.3—0.5寸。

<8> 经 渠 (经穴)

〔定位〕掌侧，腕横纹上1寸，动脉桡侧取穴。

〔主治〕咳嗽，气喘，咽喉肿痛，胸痛，腕部疼痛。

〔刺灸法〕避开动脉直刺0.3—0.5寸，禁灸。

<9> 太 渊 (输穴、原穴、八会穴)

〔定位〕掌后横纹上，桡动脉桡侧凹陷处。

〔主治〕咳嗽，气喘，咳血，咽喉肿痛，胸痹，脉涩(无脉症)，腕关节疼痛。

〔刺灸法〕避开动脉，直刺0.3—0.5寸。

<10> 鱼 际 (荥穴)

〔定位〕手掌侧面鱼际部赤白肉际间，当第一掌骨中点处。

〔主治〕咳嗽，气喘，咳血，咽喉肿痛，失音，身热，掌中热。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<11> 少 商 (井穴)

〔定位〕拇指桡侧，指甲角旁约0.1寸处。

〔主治〕咳嗽，咽喉肿痛，鼻衄，身热，昏厥。

〔刺灸法〕稍向上刺0.1—0.2寸，或点刺出血。

2. 手阳明大肠经

< 1 > 商阳（井穴）

〔定位〕食指桡侧，指甲角旁约0.1寸处。

〔主治〕齿痛，颊肿，咽喉肿痛，手指麻木，热病汗不出，昏厥。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸或点刺出血。

< 2 > 二间（荥穴）

〔定位〕微握拳，第二掌指关节前，桡侧赤白肉际处。

〔主治〕齿痛，口喎，咽喉肿痛，目赤肿痛，指关节肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.2—0.3寸。

< 3 > 三间（输穴）

〔定位〕微握拳，第二掌指关节后，第二掌骨小头桡侧凹陷处。

〔主治〕齿痛，咽喉肿痛，目赤肿痛，指节疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 4 > 合谷（原穴）

〔定位〕第一、二掌骨间，约当第二掌骨中点之桡侧缘处。

〔主治〕齿痛，牙关紧闭，口眼喎斜，面肿，咽喉肿痛，目赤肿痛，发热，多汗或无汗，咳嗽，上肢麻痹、瘫痪，经闭，滞产，小儿惊风，瘾疹。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。孕妇注意。

< 5 > 阳溪（经穴）

〔定位〕腕背横纹桡侧，拇长伸肌腱与拇短伸肌腱之间凹陷中。

〔主治〕目赤肿痛，咽喉肿痛，头痛，手腕部疼痛，耳鸣耳聋。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 6 > 偏历（络穴）

〔定位〕在阳溪穴与曲池穴连线之间，阳溪穴上3寸。

〔主治〕口喎，目赤肿痛，咽喉肿痛，手臂疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<7> 温溜（郄穴）

〔定位〕在阳溪穴与曲池穴连线上，阳溪穴上5寸。

〔主治〕口喎，面肿，咽喉肿痛，头痛，口舌肿痛，手臂疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<8> 下 廉

〔定位〕在阳溪穴与曲池穴连线上，曲池穴下4寸。

〔主治〕目赤肿痛，头痛，眩晕，肘臂痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<9> 上 廉

〔定位〕在阳溪穴与曲池穴连线上，曲池穴下3寸。

〔主治〕半身不遂，头痛，手臂麻木疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<10> 手 三 里

〔定位〕在阳溪穴与曲池穴连线上，曲池穴下2寸。

〔主治〕齿痛颊肿，失音，上肢麻木不遂，肩臂疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<11> 曲池（合穴）

〔定位〕屈肘，肘横纹桡侧端凹陷处。

〔主治〕齿痛，目赤肿痛，咽喉肿痛，上肢不遂，热病，瘰癧，癰疹，眩晕。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<12> 肘 髻

〔定位〕屈肘，曲池外上方1寸，当肱骨边缘处。（图2—10）

〔主治〕臂、肘、肩部麻木、疼痛等症。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<13> 手 五 里

〔定位〕在曲池穴与肩髃穴连线上，曲池穴上3寸。

〔主治〕肘臂挛痛，瘰癧。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<14> 臂 臑

〔定位〕在曲池穴与肩髃穴连线上，曲池上7寸，适当三角肌下端。

〔主治〕目疾，肩臂疼痛，瘰癧。

〔刺灸法〕直刺或向上斜刺0.8—1寸。

<15> 肩 髃

〔定位〕肩峰前下方，当肩峰与肱骨大结节间取穴。当上臂平举时，肩前之凹陷处取穴。

〔主治〕齿痛，上肢不遂，肩臂疼痛。

〔刺灸法〕直刺或斜刺0.8—1.5寸。

<16> 巨 骨

〔定位〕锁骨肩峰端与肩胛冈之间凹陷中。

〔主治〕肩臂及背部疼痛，瘰癧，瘰气。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<17> 天 鼎

〔定位〕喉结旁开3寸，下1寸（即扶突穴下1寸），胸锁乳突肌后缘。

〔主治〕咽喉肿痛，暴瘡，瘰癧，瘰气。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<18> 扶 突

〔定位〕喉结旁开3寸，约当胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间。

〔主治〕咳嗽，气喘，咽喉肿痛，暴瘡，瘰癧，瘰气。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<19> 禾 髃

〔定位〕水沟穴旁0.5寸。

〔主治〕口喎，口噤，鼻塞，鼻衄。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。禁灸。

<20> 迎 香

〔定位〕鼻翼外缘中点旁开，鼻唇沟处。

〔主治〕鼻塞，鼻渊，鼻衄，口喎，面痒。

〔刺灸法〕直刺0.1—0.2寸，或向上斜刺0.5—0.8寸。不宜灸。

3. 足阳明胃经

< 1 > 承 泣

〔定位〕目正视，瞳孔直下，当眶下缘与眼球间。

〔主治〕目赤肿痛，夜盲，迎风流泪，眼睑瞤动，口眼喎斜，近视。

〔刺灸法〕固定眼球，沿眶缘缓慢直刺0.5—0.8寸，不宜提插，以防刺破血管引起血肿。

< 2 > 四 白

〔定位〕目正视，瞳孔直下，当眶下孔凹陷处。

〔主治〕目赤肿痛，目翳，眼睑瞤动，口眼喎斜，头痛眩晕。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。注意不可刺伤眼球。

< 3 > 巨 髃

〔定位〕目正视，瞳孔直下，与鼻翼下缘水平线的交点。

〔主治〕口眼喎斜，眼睑瞤动，鼻衄，齿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 4 > 地 仓

〔定位〕口角旁约0.4寸处。

〔主治〕口喎，流涎，齿痛，颊肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.2寸，向颊车方向平刺0.8—1寸。

< 5 > 大 迎

〔定位〕下颌骨上，下颌角下1.3寸，咬肌附着部的前缘。

〔主治〕口喎，口噤，齿痛，颊肿痛。

〔刺灸法〕直刺或平刺0.2—0.5寸。

< 6 > 颊 车

〔定位〕下颌角前上方一横指，上下齿咬紧时，咬肌隆起的最高点处。

〔主治〕口喎，口噤，齿痛，面肿，颊肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸，平刺0.5—1寸。

<7> 下 关

〔定位〕颧骨弓下缘凹陷处，下颌骨髁状突的前方。

〔主治〕齿痛，口噤，口喎，耳鸣耳聋。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<8> 头 维

〔定位〕额角发际直上0.5寸，距神庭穴4.5寸处。

〔主治〕目赤肿痛，眼睑眵动，头痛，头晕。

〔刺灸法〕平刺0.5—1寸，禁灸。

<9> 人 迎

〔定位〕平喉结，喉结旁开1.5寸，当胸锁乳突肌前缘处。

〔主治〕咽喉肿痛，胸满喘息，瘰癧，瘰气，头痛，眩晕，偏瘫。

〔刺灸法〕避开动脉直刺0.3—0.5寸，禁灸。

<10> 水 突

〔定位〕人迎穴与气舍穴之连线中点，胸锁乳突肌前缘处。

〔主治〕咽喉肿痛，咳嗽，气喘，瘰癧。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<11> 气 舍

〔定位〕人迎穴直下，锁骨内侧端上缘。

〔主治〕咽喉肿痛，气喘，颈项强痛，瘰气。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸，不可深刺。

<12> 缺 盆

〔定位〕前正中线旁开4寸，锁骨上窝正中处。

〔主治〕咳嗽气喘，咽喉肿痛，缺盆中痛，瘰癧。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸，孕妇禁针。

<13> 气 户

〔定位〕锁骨下缘，前正中线旁开4寸处。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛胀满。

〔刺灸法〕直刺0.2—0.5寸。

<14> 库 房

〔定位〕第一肋间，前正中线旁开4寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸肋胀痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<15> 屋 翳

〔定位〕第二肋间，前正中线旁开4寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸肋胀痛，乳痈。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

<16> 膺 窗

〔定位〕第三肋间，前正中线旁开4寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸肋胀痛，乳痈。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

<17> 乳 中

〔定位〕乳头正中。为取穴的定位标置。

<18> 乳 根

〔定位〕第五肋间，前正中线旁开4寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，乳痈，乳汁少。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

<19> 不 容

〔定位〕脐上6寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕胃痛，呕吐，腹胀腹痛，食欲不振。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<20> 承 满

〔定位〕脐上5寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕胃痛，呕吐，腹胀，肠鸣，胁痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<21> 梁 门

〔定位〕脐上4寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕胃痛，呕吐，腹胀，泄泻，食欲不振。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<22> 关 门

〔定位〕脐上3寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕腹胀腹痛，肠鸣泄泻，水肿。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<23> 太 乙

〔定位〕脐上2寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕胃痛，腹痛，消化不良，心烦，癫狂。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<24> 滑 肉 门

〔定位〕脐上1寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕胃痛，呕吐，癫狂。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<25> 天枢（大肠募穴）

〔定位〕脐旁2寸。

〔主治〕绕脐腹痛，腹胀肠鸣，泄泻，便秘，痢疾，肠痛，痛经，月经不调，癥瘕。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<26> 外 陵

〔定位〕脐下1寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕腹痛，痛经，疝气。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<27> 大 巨

〔定位〕脐下2寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕小腹胀满，小便不利，疝气，遗精。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<28> 水 道

〔定位〕脐下3寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕小腹胀满，小便不利，痛经。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<29> 归 来

〔定位〕脐下4寸，前正中线旁开2寸。

〔主治〕小腹胀痛，痛经，月经不调，阳萎，遗精，疝气。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<30> 气 冲

〔定位〕脐下5寸，前正中线旁开2寸。（当曲骨穴旁开2寸）。

〔主治〕小腹痛，疝气，月经不调，痛经，阳萎，阴肿。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<31> 髀 关

〔定位〕髂前上棘与髌骨外上缘的连线，与臀后横纹延长线的交点。

〔主治〕腹痛，下肢不遂，下肢麻痹疼痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<32> 伏 兔

〔定位〕在髂前上棘与髌骨外上缘连线上，膝髌骨上缘上6寸。

〔主治〕下肢不遂、疼痛，腰膝疼痛。

〔刺灸法〕直刺1—2寸。

<33> 阴 市

〔定位〕髂前上棘与髌骨外上缘连线上，髌骨上缘上3寸。

〔主治〕下肢不遂，痹痛，膝部疼痛，屈伸不利，疝气。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.5寸。

<34> 梁丘（郄穴）

〔定位〕在髂前上棘与髌骨外上缘连线上，髌骨外上缘上2寸。

〔主治〕胃痛，膝部肿痛，下肢不遂，乳痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<35> 犊 鼻

〔定位〕髌骨下缘，髌韧带外侧凹陷中。

〔主治〕膝关节疼痛。

〔刺灸法〕稍向韧带内方斜刺0.8—1.2寸。

<36> 足三里（合穴、胃下合穴）

〔定位〕犊鼻穴下3寸，胫骨前嵴外一横指。

〔主治〕胃痛，腹胀，呕吐，泄泻，痢疾，消化不良，水肿，肠

痛，乳痛，癲狂，癲病，下肢痿痹，喘咳，眩暈，心悸，虚劳羸瘦。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<37> 上巨虚（大肠下合穴）

〔定位〕足三里穴下3寸。

〔主治〕腹痛，肠鸣，泄泻，痢疾，肠痛，下肢不遂。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<38> 条口

〔定位〕犊鼻下8寸（或外踝上8寸），胫骨前嵴外一横指。

〔主治〕下肢不遂，痹痛，转筋，肩部疼痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<39> 下巨虚（小肠下合穴）

〔定位〕犊鼻穴下9寸，胫骨前嵴外一横指。

〔主治〕小腹胀痛，泄泻，痢疾，下肢不遂，睾丸痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<40> 丰隆（络穴）

〔定位〕条口穴外一横指。

〔主治〕咳嗽，哮喘，癲狂，癲病，头痛，眩暈，下肢不遂。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<41> 解溪（经穴）

〔定位〕足背踝关节横纹中点，拇长伸肌腱和趾长伸肌腱之间。

〔主治〕腹胀，便秘，狂癲，下肢不遂及痹痛，头痛，眩暈。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<42> 冲阳（原穴）

〔定位〕足背，陷谷穴上3寸，动脉搏动处。

〔主治〕胃痛，腹胀，口眼喎斜，面肿齿痛，足背肿痛。

〔刺灸法〕避开动脉，直刺0.3—0.5寸。

<43> 陷谷（输穴）

〔定位〕足背，第二、三跖趾关节后，二、三跖骨结合部前凹陷中。

〔主治〕腹痛，肠鸣，面浮身肿，足背肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

〈44〉 内庭（荥穴）

〔定位〕足背，第二、三趾间缝纹端。

〔主治〕腹胀，胃痛，泄泻，痢疾，齿痛，口渴，咽喉肿痛，足背肿痛。

〔刺灸法〕稍向上斜刺0.3—0.5寸。

〈45〉 厉兑（井穴）

〔定位〕第二趾外侧甲角旁约0.1寸。

〔主治〕腹胀，面肿，口渴，齿痛，咽喉肿痛，鼻衄，癫狂，足胫寒冷。

〔刺灸法〕浅刺0.1—0.2寸。

4. 足太阴脾经

〈1〉 隐白（井穴）

〔定位〕拇趾内侧，指甲角旁约0.1寸。

〔主治〕腹胀，泄泻，呕吐，月经过多，崩漏，尿血，心烦，癫狂。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸，或点刺出血。

〈2〉 大都（荥穴）

〔定位〕拇趾内侧赤白肉际，第一跖趾关节前缘。

〔主治〕胃痛，呕吐，腹胀，泄泻，便秘，心烦。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

〈3〉 太白（输穴、原穴）

〔定位〕第一跖趾关节后缘，赤白肉际处。

〔主治〕胃痛，腹胀腹痛，泄泻，痢疾，便秘，肢倦身重，心痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

〈4〉 公孙（络穴、八脉交会穴）

〔定位〕第一跖骨底的前缘赤白肉际处。

〔主治〕胃痛，呕吐，腹痛，泄泻，痢疾，心烦失眠。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<5> 商丘（经穴）

〔定位〕内踝前下方凹陷处。

〔主治〕腹胀，泄泻，便秘，食不化，黄疸，足踝疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<6> 三阴交

〔定位〕内踝上3寸，胫骨内侧面后缘。

〔主治〕腹胀肠鸣，泄泻，痢疾，月经不调，痛经，崩漏，难产，不孕，带下，阳萎，遗精，小便不利，遗尿，水肿，失眠，下肢不遂，麻痹疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<7> 漏谷

〔定位〕内踝上6寸，胫骨内侧面后缘。

〔主治〕腹胀，肠鸣，小便不利，遗尿，下肢麻痹。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<8> 地机（郄穴）

〔定位〕阴陵泉穴下3寸。

〔主治〕腹胀，腹痛，泄泻，痢疾，月经不调，痛经，小便不利。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<9> 阴陵泉（合穴）

〔定位〕胫骨内侧面下缘凹陷。

〔主治〕腹胀，泄泻，痢疾，水肿，黄疸，小便不利，气喘，膝、大腿内侧疼痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<10> 血海

〔定位〕屈膝，膝腓骨内上缘上2寸。

〔治主〕月经不调，痛经，崩漏，膝内侧及大腿内侧疼痛，瘾疹，湿疹搔痒。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<11> 箕 门

〔定位〕血海穴上6寸，缝匠肌内侧。

〔主治〕小便不利，遗尿，大腿内侧疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<12> 冲 门

〔定位〕耻骨联合上缘中点（曲骨穴）旁开3.5寸。

〔主治〕腹痛，泄泻，带下，疝气。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<13> 府 舍

〔定位〕腹部前正中线旁开4寸，冲门外上方0.7处。

〔主治〕腹痛，积聚，疝气。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<14> 腹 结

〔定位〕前正中线旁开4寸，府舍穴上3寸。

〔主治〕绕脐腹痛，泄泻，疝气。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<15> 大 横

〔定位〕脐旁4寸。

〔主治〕腹痛，泄泻，便秘。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<16> 腹 哀

〔定位〕脐上3寸，前正中线旁开4寸。

〔主治〕腹痛，泄泻，便秘。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<17> 食 窋

〔定位〕第五肋间，前正中线旁开6寸。

〔主治〕胸胁胀满，水肿。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<18> 天 溪

〔定位〕第四肋间，前正中线旁开6寸。

〔主治〕胸痛，咳嗽，乳痈。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<19> 胸 乡

〔定位〕第三肋间，前正中线旁开6寸。

〔主治〕胸胁胀痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<20> 周 荣

〔定位〕第二肋间，前正中线旁开6寸。

〔主治〕胸胁胀痛，咳嗽气逆。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<21> 大包（脾之大络）

〔定位〕第六肋间，腋中线上。

〔主治〕胸胁胀痛，咳嗽气喘。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

5. 手少阴心经

<1> 极 泉

〔定位〕腋窝正中，动脉搏动处。

〔主治〕心悸，心痛，咽干，胸闷，肘臂冷痛或不举。

〔刺灸法〕避开动脉，直刺0.3—0.5寸。

<2> 青 灵

〔定位〕少海穴上3寸，肱二头肌内侧缘。

〔主治〕目黄，胁痛，肘臂疼痛，头痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<3> 少海（合穴）

〔定位〕屈肘，肘横纹尺侧端。

〔主治〕心痛，胁痛，肘臂疼痛，头痛，瘰癧。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<4> 灵道（经穴）

〔定位〕腕横纹上1.5寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘。

〔主治〕心悸，心痛，舌强不语，暴瘖，肘臂疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 5 > 通里（络穴）

〔定位〕腕横纹上1寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘。

〔主治〕心悸，心痛，咽喉肿痛，暴瘖，舌强不语，腕臂疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 6 > 阴郄（郄穴）

〔定位〕腕横纹上0.5寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘。

〔主治〕心痛，心悸、盗汗，失语。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 7 > 神门（输穴、原穴）

〔定位〕腕横纹上，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

〔主治〕心痛，心惊，不寐，癫狂，癫痫，失音，腕臂疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 8 > 少府（荥穴）

〔定位〕手掌第四、五掌骨间，掌指关节后方取穴。

〔主治〕心悸，胸痛，掌中热，小指挛痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 9 > 少冲（井穴）

〔定位〕小指桡侧指甲角旁约0.1寸。

〔主治〕昏迷急救，心悸，心痛，指节疼痛，热病。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸或点刺出血。

6. 手太阳小肠经

< 1 > 少泽（井穴）

〔定位〕小指尺侧指甲角旁约0.1寸。

〔主治〕耳鸣，目痛，头痛，咽喉肿痛，肩臂外侧疼痛，乳汁少，乳痈，中风昏迷。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸或点刺出血。

< 2 > 前谷（荣穴）

〔定位〕握拳，第五掌指关节前尺侧，横纹头赤白肉际处。

〔主治〕头痛，耳鸣耳聋，咽喉肿痛，目痛，疟疾，癫狂，肘、腕、臂部疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 3 > 后溪（输穴、八脉交会穴）

〔定位〕握拳，第五掌指关节后赤白肉际，横纹头处。

〔主治〕头项强痛，目赤目翳，耳鸣耳聋，咽喉肿痛，腕、肘、臂部疼痛，疟疾，癫狂，热病。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

< 4 > 腕骨（原穴）

〔定位〕腕前赤白肉际，三角骨的前缘。

〔主治〕头项强痛，耳鸣，目翳，黄疸，肩、臂、腕部疼痛，热病无汗。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 5 > 阳谷（经穴）

〔定位〕腕背横纹尺侧端，当腕豆骨与尺骨茎突之间取穴。

〔主治〕头项强痛，耳鸣耳聋，目痛，颌肿，臂及腕部疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 6 > 养老（郄穴）

〔定位〕屈肘掌心向胸，当尺骨茎突桡侧缘凹陷中。

〔主治〕目视不明，肩、臂、腰部疼痛。

〔刺灸法〕向上斜刺0.5—0.8寸。

< 7 > 支正（络穴）

〔定位〕阳谷穴与小海穴连线上，阳谷穴上5寸

〔主治〕头项强痛，肘、臂及指部疼痛，热病，癫狂。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

< 8 > 小海（合穴）

〔定位〕屈肘，当尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间。

〔主治〕头痛颈痛，颌肿，肘臂挛痛，屈伸不利。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<9> 肩 贞

〔定位〕正坐，上臂内收，腋后纹头上1寸。

〔主治〕耳鸣耳聋，肩臂疼痛不举。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<10> 臑 俞

〔定位〕肩贞直上，肩胛岗下缘处。

〔主治〕肩臂疼痛，瘰癧。

〔刺灸法〕直刺或向外斜刺0.5—1寸。

<11> 天 宗

〔定位〕肩胛岗下窝的中央处。

〔主治〕肩胛部疼痛，肘臂外后侧痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<12> 臑 风

〔定位〕天宗穴直上，肩胛上窝正中处。

〔主治〕肩胛部疼痛，肩臂酸痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<13> 曲 垣

〔定位〕肩胛岗上窝内侧凹陷处。

〔主治〕肩部、肩胛部挛痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<14> 肩 外 俞

〔定位〕第一胸椎棘突下旁开3寸处。

〔主治〕项背拘急，肩背疼痛，上肢冷痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<15> 肩 中 俞

〔定位〕第七颈椎棘突下（大椎）旁开2寸。

〔主治〕肩背疼痛，咳嗽，气喘，寒热。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<16> 天 窗

〔定位〕平甲状软骨，喉结旁开3.5寸，胸锁乳突肌后缘处。

〔主治〕耳鸣耳聋，咽喉肿痛，颊肿，暴瘡。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<17> 天 容

〔定位〕平下颌角，胸锁乳突肌前缘处。

〔主治〕耳鸣耳聋，咽喉肿痛，颈项肿痛，瘰气。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<18> 颧 髆

〔定位〕目外眦直下，颧骨下缘凹陷处

〔主治〕口眼喎斜，眼睑瞤动、齿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸

<19> 听 宫

〔定位〕耳屏与下颌关节间，张口凹陷处。

〔主治〕耳聋耳鸣，聾耳，齿痛，下颌关节痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

7. 足太阳膀胱经

<1> 睛 明

〔定位〕目内眦上方约0.1寸处。

〔主治〕目疾（如目赤肿痛，目翳，目视不明等）眼睑闭合不全。

〔刺灸法〕闭目，将眼球固定在眼眶外侧，针沿眶缘缓慢进针约0.5—1寸。不宜作大幅度捻转、提插。出针时缓慢提退，并按压针孔，以防出血。禁灸。

<2> 攒 竹

〔定位〕眉毛内侧端，眶上切迹处。

〔主治〕前头痛，眉棱骨痛，目赤肿痛，目视不明，眼睑瞤动。

〔刺灸法〕向下及向鱼腰穴方向平刺0.3—0.5寸。禁灸。

<3> 眉 冲

〔定位〕眉头直上，入发际0.5寸处。

〔主治〕头痛，鼻塞，眩晕，癫痫。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。禁灸。

<4> 曲 差

〔定位〕前正中线旁开1.5寸，入发际0.5寸处（当神庭穴旁1.5寸）。

〔主治〕头痛，鼻塞，鼻衄，目视不明。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<5> 五 处

〔定位〕曲差穴上0.5寸（上星穴旁1.5寸）。

〔主治〕头痛，目眩，癫痫。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<6> 承 光

〔定位〕五处穴上1.5寸。

〔主治〕头痛，目眩，鼻塞，热病无汗。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<7> 通 天

〔定位〕承光穴上1.5寸处。

〔主治〕头痛，目眩，鼻塞，鼻衄。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<8> 络 却

〔定位〕通天穴后1.5寸。

〔主治〕眩晕，耳鸣，目视不明，项肿，癫狂，痫证。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<9> 玉 枕

〔定位〕脑户穴旁1.3寸，枕外粗隆上缘外侧处。

〔主治〕头项痛，目赤肿痛，鼻塞。

〔刺灸法〕向下平刺0.3—0.5寸。

<10> 天 柱

〔定位〕哑门穴旁1.3寸，斜方肌外缘凹陷处。

〔主治〕头痛项强，咽喉肿痛，鼻塞，癫狂。

〔刺灸法〕斜刺0.5—1寸，注意不可深刺。

<11> 大杼（八会穴）

〔定位〕第一胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕头痛项强，脊强，发热，鼻塞，咳嗽。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。注意不可深刺。

<12> 风 门

〔定位〕第二胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕伤风咳嗽，身热，头痛项强，胸背疼痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<13> 肺俞（背俞穴）

〔定位〕第三胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，潮热盗汗，吐血，胸背疼痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<14> 厥阴俞（背俞穴）

〔定位〕第四胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕咳嗽，心悸，心痛，胸闷痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<15> 心俞（背俞穴）

〔定位〕第五胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕心悸，心痛，心烦，失眠，胸闷痛，癫狂，痫证。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<16> 督 俞

〔定位〕第六胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕发热恶寒，心痛，胃痛，腹痛，肠鸣，呃逆。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<17> 膈俞（八会穴）

〔定位〕第七胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕呕吐，呃逆，食不下，咳嗽，气喘，潮热，盗汗，血虚

头晕、心悸。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<18> 肝俞（背俞穴）

〔定位〕第九胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕胁痛，黄疸，吐衄，目疾，癫狂。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<19> 胆俞（背俞穴）

〔定位〕第十胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕胁痛，黄疸，口苦，潮热。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<20> 脾俞（背俞穴）

〔定位〕第十一胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕腹胀，泄泻，黄疸，痢疾，水肿，呕吐，便血，脾胃虚

弱。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<21> 胃俞（背俞穴）

〔定位〕第十二胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕胃脘痛，腹胀，肠鸣，呕吐，脾胃虚弱。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<22> 三焦俞（背俞穴）

〔定位〕第一腰椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕腹胀肠鸣，泄泻，痢疾，小便不利，水肿，腰背强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<23> 肾俞（背俞穴）

〔定位〕第二腰椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕阳萎，遗精，月经不调，白带，不孕不育，小便不利，
遗尿，水肿，耳鸣耳聋，腰膝疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<24> 气海俞（背俞穴）

〔定位〕第三腰椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕腰背痛，痛经，痔疮，下肢痿痹。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<25> 大肠俞（背俞穴）

〔定位〕第四腰椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕腹胀，肠鸣，泄泻，痢疾，腰痛，下肢痹痛，痔疮出血。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<26> 关元俞

〔定位〕第五腰椎棘突下，督脉旁开1.5寸。

〔主治〕腹胀，泄泻，小便不利，腰痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<27> 小肠俞（背俞穴）

〔定位〕第一骶椎棘突下，督脉旁开1.5寸。平第一骶孔。

〔主治〕小腹胀痛，小便不利，遗尿，遗精，白带，腰痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<28> 膀胱俞（背俞穴）

〔定位〕第二骶椎棘突下，督脉旁开1.5寸。平第二骶孔。

〔主治〕小便淋涩不通，遗尿，遗精，腰脊强痛，下肢痹痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<29> 中膂俞

〔定位〕第三骶椎棘突下，督脉旁开1.5寸。平第三骶孔。

〔主治〕痢疾，疝气，腰脊强痛，消渴。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<30> 白环俞

〔定位〕第四骶椎棘突下，督脉旁开1.5寸。平第四骶孔。

〔主治〕遗尿，疝气，白带，月经不调。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<31> 上髎

〔定位〕第一骶后孔中。

〔主治〕腰骶疼痛，月经不调，带下，遗精，小便不利。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

〈32〉 次 髎

〔定位〕第二骶后孔中。

〔主治〕腰骶疼痛，月经不调，白带，阳萎，遗精，疝气，下肢痹痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

〈33〉 中 髎

〔定位〕第三骶后孔中。

〔主治〕腰骶疼痛，月经不调，白带，小便不利。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

〈34〉 下 髎

〔定位〕第四骶后孔中。

〔主治〕腰痛，腹痛，肠鸣，泄泻，小便不利。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

〈35〉 会 阳

〔定位〕尾椎下端旁开0.5寸处。

〔主治〕痢疾，泄泻，便血，痔疮，阳萎。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

〈36〉 承 扶

〔定位〕臀横纹正中处。

〔主治〕腰痛，下肢痹痛，痔疮。

〔刺灸法〕直刺1—2.5寸。

〈37〉 殷 门

〔定位〕承扶与委中连线上，承扶下6寸。

〔主治〕腰脊强痛，下肢痹痛。

〔刺灸法〕直刺1—2寸。

〈38〉 浮 郤

〔定位〕委阳穴上1寸，当股二头肌腱内侧处。]

〔主治〕臀股部疼痛，麻木，腘窝疼痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<39> 委阳（三焦下合穴）

〔定位〕腓横纹外端，股二头肌内缘。

〔主治〕小便不利，小腹胀满，腰脊强痛，下肢挛痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<40> 委中（合穴、膀胱下合穴）

〔定位〕腓横纹中央处。（股二头肌腱与半腱肌腱之间）

〔主治〕腹痛吐泻，小便不利，腰、腿、腓部疼痛，下肢不遂，中暑。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸或点刺出血。除慎用疤痕灸外，其他灸法可行。

<41> 附 分

〔定位〕第二胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕项、肩、背部拘急疼痛，上肢麻痹。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<42> 魄 户

〔定位〕第三胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，项背强痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<43> 膏 肓

〔定位〕第四胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕肺癆，咳嗽，气喘，遗精，盗汗，脾胃虚弱，肩背疼痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<44> 神 堂

〔定位〕第五胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，肩背痛，胸痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<45> 谿 堂

〔定位〕第六胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，疟疾，肩背痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<46> 膈 关

〔定位〕第七胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕呕吐，噎气，食不下。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<47> 魂 门

〔定位〕第九胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕胸胁胀痛，呕吐，饮食不下。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<48> 阳 纲

〔定位〕第十胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕黄疸，腹痛，肠鸣，泄泻，消渴。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<49> 意 舍

〔定位〕第十一胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕腹胀，肠鸣，泄泻，呕吐，食不下。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<50> 胃 仓

〔定位〕第十二胸椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕腹胀，胃脘痛，水肿，小儿食积。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<51> 育 门

〔定位〕第一腰椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕腹痛，痞块，便秘，妇人乳疾。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<52> 志 室

〔定位〕第二腰椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕遗精，阳萎，小便不利，水肿，腰痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<53> 胞 肓

〔定位〕第二骶椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕肠鸣腹胀，二便不利，腰脊痛，阴肿。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<54> 秩 边

〔定位〕第四骶椎棘突下，督脉旁开3寸。

〔主治〕小便不利，大便难，腰骶痛，下肢痹痛，下肢不遂，痔疮。

〔刺灸法〕直刺1—2寸。

<55> 合 阳

〔定位〕委中直下2寸。

〔主治〕腰脊强痛，下肢痹痛，疝气，崩漏。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<56> 承 筋

〔定位〕合阳穴与承山穴之间。

〔主治〕腰背疼痛，腿痛转筋，痔疾。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<57> 承 山

〔定位〕腓肠肌两肌腹之间凹陷的顶端。

〔主治〕腰痛，腿痛转筋，痔疾，便秘。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<58> 飞扬（络穴）

〔定位〕昆仑穴直上7寸处。

〔主治〕腰背疼痛，下肢痿痹，头痛，目眩，痔疾。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<59> 跗阳（郄穴—阳跷脉）

〔定位〕昆仑穴直上3寸处。

〔主治〕腰腿疼痛，下肢不遂，足踝肿痛，头痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<60> 昆仑（经穴）

〔定位〕外踝与跟腱之间凹陷处。

〔主治〕头痛项强，目眩，疟疾，腰痛，足跟肿痛，小儿痫证，

难产。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<61> 仆参

〔定位〕昆仑穴直下，跟骨凹陷赤白肉际处。

〔主治〕下肢痿痹，足跟肿痛，癫痫。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<62> 申脉（八脉交会穴）

〔定位〕外踝下缘凹陷中。

〔主治〕头痛项强，眩晕，失眠，癫痫，下肢痹痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<63> 金门（郄穴）

〔定位〕申脉前下方，当骰骨外侧凹陷处。

〔主治〕腰痛，小便淋涩，下肢痹痛，足踝痛，癫痫，小儿惊风。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<64> 京骨（原穴）

〔定位〕足附外侧，第五跖骨粗隆下，赤白肉际处。

〔主治〕癫痫，头痛，项强，目翳，腰腿疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<65> 束骨（输穴）

〔定位〕足附外侧，第五跖骨小头后下方，赤白肉际处。

〔主治〕癫痫，头痛项强，目眩，腰腿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<66> 足通谷（荣穴）

〔定位〕第五趾跖关节前下方，赤白肉际处。

〔主治〕头项强痛，目眩，癫狂，癫痫。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<67> 至阴（井穴）

〔定位〕足小趾外侧，趾甲角旁约0.1寸处。

〔主治〕头痛，鼻塞，目痛，胎位不正，难产，胞衣不下。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸。

8. 足少阴肾经

<1> 涌泉（井穴）

〔定位〕踞足时，足心前三分之一的凹陷处。

〔主治〕昏厥，头痛眩晕，舌干咽肿，失音，小便不利，小儿惊风，癫疾。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<2> 然谷（荥穴）

〔定位〕足舟骨粗隆前下缘凹陷中。

〔主治〕遗精，消渴，黄疸，月经不调，阴痒，阴挺，足跗肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<3> 太溪（输穴、原穴）

〔定位〕足内踝与跟腱之间凹陷中。

〔主治〕阳萎遗精，小便频数，消渴，月经不调，头痛，眩晕，失眠、耳聋，气喘，咽喉肿痛，腰痛，牙痛，足踝肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<4> 大钟（络穴）

〔定位〕太溪穴下0.5寸，跟腱内侧缘。

〔主治〕咳血，气喘，小便不利，腰痛，痴呆，月经不调，足踝肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<5> 水泉（郄穴）

〔定位〕太溪穴直下方1寸。

〔主治〕小便不利，经闭，痛经，月经不调，阴挺，目昏花。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<6> 照海（八脉交会穴）

〔定位〕足内踝下缘凹陷处。

〔主治〕咽喉肿痛，失眠，月经不调，痛经，带下，小便频数，小便不利，目赤肿痛，癫痫。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<7> 复溜（经穴）

〔定位〕太溪穴直上2寸。

〔主治〕腹胀，泄泻，水肿，足肿，盗汗，热病汗不出或汗出不止。

〔刺灸法〕0.5—1寸。

<8> 交 信

〔定位〕太溪穴直上2寸，复溜与胫骨内侧面后缘之间。

〔主治〕月经不调，崩漏，阴挺，泄泻，疝气，睾丸肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<9> 筑 宾

〔定位〕太溪穴直上5寸。

〔主治〕癫狂，痫证，疝气，小腿疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<10> 阴谷（合穴）

〔定位〕腘窝横纹内侧端，半腱肌腱与半膜肌腱之间。

〔主治〕阳痿，遗精，月经不调，崩漏，小便不利，膝膑疼痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<11> 横 骨

〔定位〕耻骨联合上缘，任脉（曲骨穴）旁开0.5寸。

〔主治〕小腹胀痛，阳痿，遗精，小便不利，遗尿，疝气。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<12> 大 赫

〔定位〕横骨穴直上1寸。（中极旁开0.5寸）。

〔主治〕遗精，阳痿，月经不调，带下，阴部痛，子宫脱垂，泄泻。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<13> 气 穴

〔定位〕横骨直上2寸（关元穴旁0.5寸）。

〔主治〕经闭，月经不调，带下，小便不利，泄泻，阳痿。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<14> 四 满

〔定位〕横骨穴直上3寸。（石门穴旁0.5寸）。

〔主治〕腹痛，泄泻，水肿，疝气，月经不调，遗精。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<15> 中 注

〔定位〕脐下1寸，任脉旁开0.5寸。

〔主治〕腹痛，泄泻，便秘，月经不调。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<16> 育 俞

〔定位〕脐旁0.5寸。

〔主治〕腹痛腹胀，便秘，泻泄，疝气，月经不调。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<17> 商 曲

〔定位〕脐上2寸，任脉旁开0.5寸。

〔主治〕腹痛，腹胀，泄泻，便秘。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<18> 石 关

〔定位〕脐上3寸，任脉旁开0.5寸。

〔主治〕腹痛，便秘，呕吐，不孕。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<19> 阴 都

〔定位〕脐上4寸，任脉旁开0.5寸。

〔主治〕腹胀，腹痛，泄泻，便秘，不孕。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<20> 腹 通 谷

〔定位〕脐上5寸，任脉旁开0.5寸。

〔主治〕腹胀，腹痛，呕吐，脾胃虚弱。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<21> 幽 门

〔定位〕脐上6寸，任脉旁开0.5寸。

〔主治〕腹痛，呕吐，泄泻，痢疾，胸胁痛，心烦。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<22> 步 廊

〔定位〕第五肋间，任脉旁开2寸。

〔主治〕胸痛，咳嗽，气喘，呕吐。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

<23> 神 封

〔定位〕第四肋间，任脉旁开2寸。

〔主治〕咳嗽，胸痛，气喘，呕吐，乳痛。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

<24> 灵 墟

〔定位〕第三肋间，任脉旁开2寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，乳痛。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

<25> 神 藏

〔定位〕第二肋间，任脉旁开2寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，心烦。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

<26> 臑 中

〔定位〕第一肋间，任脉旁开2寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸胀痛，不嗜食。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

<27> 膺 府

〔定位〕锁骨下缘，任脉旁开2寸。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，不嗜食。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

9. 手厥阴心包经

<1> 天池

〔定位〕第四肋间，乳头外1寸处。

〔主治〕心烦，腋肿，胸胁胀痛，咳嗽，气喘，瘰癧。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸，不可深刺。

<2> 天泉

〔定位〕上臂内侧，腋前纹头下2寸，肱二头肌长短头之间。

〔主治〕心痛，胸胁胀痛，肘臂痛，咳嗽。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<3> 曲泽（合穴）

〔定位〕肘横纹上，肱二头肌腱的尺侧缘。

〔主治〕心悸，心痛，心烦，肘臂痛，热病，呕吐。

〔刺灸法〕直刺0.8—1寸，或点刺出血。

<4> 郄门（郄穴）

〔定位〕腕横纹上5寸，掌上肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

〔主治〕心痛，心悸，心烦，癫痫，衄血。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<5> 间使（经穴）

〔定位〕腕横纹上3寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

〔主治〕心悸，心痛，癫狂，癫痫，胸胁痛，胃痛，疟疾。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<6> 内关（络穴、八脉交会穴）

〔定位〕腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

〔主治〕心痛，心悸，癫痫，失眠，肘臂疼痛，胸胁痛，胃痛，呕吐。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<7> 大陵（输穴、原穴）

〔定位〕腕横纹上，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

〔主治〕心痛，心悸，癫狂，癫痫，胸胁痛，胃痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 8 > 劳宫（荥穴）

〔定位〕掌心横纹中，第二、三掌骨间。

〔主治〕心痛，中风昏迷，中暑，癫狂，痫证，口疮，口臭。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 9 > 中冲（井穴）

〔定位〕中指尖端处。

〔主治〕昏迷，中暑，心痛，心烦，语言不利，舌下肿痛。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸或点刺出血。

10. 手少阳三焦经

< 1 > 关冲（井穴）

〔定位〕无名指尺侧指甲角旁约0.1寸处。

〔主治〕头痛，目赤肿痛，耳鸣耳聋，咽喉肿痛，心烦，舌强。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸或点刺出血。

< 2 > 液门（荥穴）

〔定位〕第四、五指缝间，掌指关节前凹陷处。

〔主治〕头痛，目赤肿痛，耳鸣耳聋，咽喉肿痛，疟疾，指节疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 3 > 中渚（输穴）

〔定位〕液门穴后1寸，第四、五掌骨间。

〔主治〕头痛，目赤肿痛，耳鸣耳聋，咽喉肿痛，疟疾，臂、腕、指节疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

< 4 > 阳池（原穴）

〔定位〕腕背横纹上，指总伸肌腱尺侧缘凹陷中。

〔主治〕耳聋，疟疾，咽喉肿痛，臂、腕疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 5 > 外关 (络穴、八脉交会穴)

〔定位〕腕背横纹上 2 寸，两骨之间。

〔主治〕头痛，目赤肿痛，耳鸣耳聋，胁肋痛，肩背痛，热病，瘰癧。

〔刺灸法〕直刺 0.5—1 寸。

< 6 > 支沟 (经穴)

〔定位〕腕背横纹上 3 寸，两骨之间。

〔主治〕耳鸣耳聋，暴瘡，胁肋痛，肩背痛，热病，便秘。

〔刺灸法〕直刺 0.5—1 寸。

< 7 > 会宗 (郄穴)

〔定位〕支沟穴旁，尺骨桡侧缘取穴。

〔主治〕耳聋耳鸣，臂痛，癰疽。

〔刺灸法〕直刺 0.5—1 寸。

< 8 > 三 阳 络

〔定位〕腕背横纹上 4 寸，两骨之间。

〔主治〕暴聋，牙痛，暴瘡，臂痛。

〔刺灸法〕直刺 0.5—1 寸。

< 9 > 四 渚

〔定位〕肘尖下 5 寸，两骨之间。

〔主治〕耳鸣耳聋，咽喉肿痛，暴瘡，臂痛。

〔刺灸法〕直刺 0.5—1 寸。

< 10 > 天井 (合穴)

〔定位〕屈肘，尺骨鹰嘴上 1 寸凹陷处。

〔主治〕耳鸣耳聋，偏头痛，胁肋痛，项、肩、臂疼痛。

〔刺灸法〕直刺 0.5—1 寸。

< 11 > 清 冷 渊

〔定位〕屈肘，尺骨鹰嘴上 2 寸。

〔主治〕头痛，目黄，肩臂疼痛不举。

〔刺灸法〕直刺 0.5—1 寸。

< 12 > 消 泺

〔定位〕尺骨鹰嘴与肩髃穴连线上，清冷渊穴上3寸。

〔主治〕头痛，项强，齿痛，肩背、臂部疼痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.2寸。

<13> 肩髃 会

〔定位〕尺骨鹰嘴与肩髃穴连线上，肩髃下3寸，三角肌后缘。

〔主治〕肩臂痛，痿气，痹病。

〔刺灸法〕直刺0.5—1.2寸。

<14> 肩髃 髃

〔定位〕肩峰后下方，当上臂外展平举时，肩髃后寸许之凹陷处。

〔主治〕肩臂疼痛不举。

〔刺灸法〕向肩关节直刺1—1.5寸。

<15> 天髃 髃

〔定位〕肩井穴下1寸处。

〔主治〕肩臂痛，项背强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

〔刺灸法〕向肩关节直刺1—1.5寸。

<16> 天髃 髃

〔定位〕乳突后下方，胸锁乳突肌后缘，约平下颌角处。

〔主治〕头痛，项强，暴痞，眩晕。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<17> 翳风 风

〔定位〕耳垂后方，下颌角与乳突间凹陷处。

〔主治〕耳鸣耳聋，口喎，颊肿。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<18> 瘰 脉

〔定位〕乳突中央，当翳风与角孙沿耳轮连线下1/3与上2/3交点处。

〔主治〕头痛，耳鸣耳聋，惊痫。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<19> 颞 患

〔定位〕耳后，翳风与角孙沿耳轮连线下2/3与上1/3交点处。

〔主治〕头痛，耳鸣，耳痛，小儿惊痫。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<20> 角 孙

〔定位〕耳尖直上入发际处。

〔主治〕耳鸣耳聋，目赤肿痛，目翳，眼睑肿，项强。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<21> 耳 门

〔定位〕屏上切迹前，下颌骨髁状突后缘凹陷，张口取穴。

〔主治〕耳聋，耳鸣，耳痛，齿痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<22> 和 髻

〔定位〕鬓发后缘，平目外眦，颞浅动脉后缘。

〔主治〕头痛，耳鸣，牙关拘急，口喎。

〔刺灸法〕斜刺0.3—0.5寸。

<23> 丝 竹 空

〔定位〕眉毛外端凹陷处。

〔主治〕头痛，目赤肿痛，眩晕，眼睑翳动。

〔刺灸法〕平刺0.5—1寸。

11. 足少阳胆经

<1> 瞳 子 髻

〔定位〕外眼角旁0.5寸处。

〔主治〕头痛，目赤肿痛，目翳，青盲。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<2> 听 会

〔定位〕耳屏间切迹前，下颌骨髁状突后缘处，张口取穴。

〔主治〕耳鸣耳聋，口喎，头痛，面痛。

〔刺灸法〕张口，直刺0.5—1寸。

＜3＞ 上 关

〔定位〕下关穴直上，颧骨弓上缘处。

〔主治〕头痛，耳鸣耳聋，齿痛，口眼喎斜，面痛，惊痫。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

＜4＞ 颌 厌

〔定位〕头维穴与曲鬓穴弧形连线上1/4与下3/4交界处。

〔主治〕偏头痛，眩晕，齿痛。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

＜5＞ 悬 颅

〔定位〕头维穴与曲鬓穴弧形连线上的中点处。

〔主治〕偏头痛，目外眦痛，耳鸣。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

＜6＞ 悬 厘

〔定位〕头维穴与曲鬓穴弧形连线上3/4与下1/4交界处。

〔主治〕偏头痛，目外眦痛，耳鸣，齿痛。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

＜7＞ 曲 鬓

〔定位〕鬓发内，角孙穴向前平移一横指处。

〔主治〕头痛，目赤肿痛，颊颌肿痛，牙关紧闭，暴瘡。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

＜8＞ 率 谷

〔定位〕耳尖直上，入发际1.5寸处。

〔主治〕偏头痛，眩晕，呕吐，小儿急慢惊风。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

＜9＞ 天 冲

〔定位〕耳廓根后上方，入发际2寸处。

〔主治〕头痛，耳鸣耳聋，惊悸，癫痫。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

＜10＞ 浮 白

〔定位〕耳廓根直上，入发际处向后横量1寸处。

〔主治〕头痛，耳鸣耳聋，项强，瘰癧，瘰气。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<11> 头 窍 阴

〔定位〕乳白穴下，乳突后上方处。

〔主治〕头痛，眩晕，耳鸣耳聋。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<12> 完 骨

〔定位〕乳突后下方凹陷中。

〔主治〕头痛，项强，耳聋，口喎，颊肿。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<13> 本 神

〔定位〕神庭穴旁开3寸处。

〔主治〕头痛，目眩，癫痫，小儿惊痫。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<14> 阳 白

〔定位〕目正视，瞳孔直上，眉上1寸处。

〔主治〕头痛，目眩，眉棱骨痛，口眼喎斜，眼睑瞤动。

〔刺灸法〕向下平刺0.5—0.8寸。

<15> 头 临 泣

〔定位〕阳白穴直上，入发际0.5寸处。

〔主治〕头痛，目眩，目赤肿痛，鼻塞鼻渊，小儿惊痫。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<16> 目 窗

〔定位〕头临泣穴与风池穴连线上，临泣穴后1寸处。

〔主治〕头痛，目眩，青盲，目赤肿痛，头面浮肿。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<17> 正 营

〔定位〕头临泣穴与风池穴连线上，目窗穴后1寸处。

〔主治〕头痛，眩晕，齿痛。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<18> 承 灵

〔定位〕头临泣穴与风池穴连线上，正营穴后1.5寸处。

〔主治〕头痛，眩晕，鼻塞，目痛。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<19> 脑 空

〔定位〕在头临泣穴与风池穴连线上，风池穴直上1.5寸处。

〔主治〕头痛，项强，眩晕，目赤肿痛，癫痫。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<20> 风 池

〔定位〕平风府穴，当斜方肌与胸锁乳突肌之间凹陷处。

〔主治〕头痛，眩晕，目赤肿痛，项背强痛，中风，口眼喎斜，热病，感冒，疟疾，瘕气。

〔刺灸法〕向对侧眼眶内侧缘或鼻尖斜刺0.8—1寸。

<21> 肩 井

〔定位〕肩上，大椎与肩峰连线的中点处。

〔主治〕项背强痛，肩臂疼痛不举，乳痛，乳汁少，瘰癧。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。不可深刺，孕妇禁针。

<22> 渊 液

〔定位〕腋中线上，第四肋间。举臂取穴。

〔主治〕胸胁胀痛，腋肿，上肢疼痛不举。

〔刺灸法〕平刺或斜刺0.5—0.8寸。不可深刺。

<23> 辄 筋

〔定位〕第四肋间，渊液前1寸处。

〔主治〕胸胁痛，气喘，腋肿，肩臂痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<24> 日月（胆的募穴）

〔定位〕乳头直下，第七肋间。

〔主治〕黄疸，呕吐，腹胀，胸胁肋疼痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<25> 京门 (肾的募穴)

〔定位〕当第十二肋端处。

〔主治〕腹胀，肠鸣，泄泻，腰胁痛，小便不利。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<26> 带 脉

〔定位〕第十一肋端 (章门穴) 直下，当与脐相平处。

〔主治〕月经不调，闭经，白带病，腰肋痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<27> 五 枢

〔定位〕髂前上棘前0.5寸，约平脐下3寸 (关元穴) 处。

〔主治〕阴挺，白带病，疝气，少腹痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<28> 维 道

〔定位〕五枢穴前下方0.5寸处。

〔主治〕少腹痛，阴挺，白带病，疝气。

〔刺灸法〕直刺或向前下方斜刺1—1.5寸。

<29> 居 髎

〔定位〕髂前上棘与股骨大转子最高点连线的中点处。

〔主治〕疝气，腰腿疼痛，下肢痿痹。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<30> 环 跳

〔定位〕股骨大转子最高点与骶骨裂孔连线的外1/3与内2/3的交点。

〔主治〕下肢痿证，痹证，不遂。

〔刺灸法〕直刺2—3寸。

<31> 风 市

〔定位〕大腿外侧正中，腘窝横纹上7寸处。

〔主治〕下肢痿痹不遂，通身搔痒，脚气。

〔刺灸法〕直刺1—2寸。

<32> 中 渎

〔定位〕风市穴下2寸处。

〔主治〕下肢痿痹，下肢不遂。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<33> 膝 阳 关

〔定位〕阳陵泉穴上3寸，股骨外髁边缘的凹陷处。

〔主治〕膝部疼痛，胭窝部挛急疼痛，下肢痹痛。

〔刺灸法〕直刺0.8—1寸。

<34> 阳陵泉（合穴、胆下合穴、八会穴）

〔定位〕腓骨小头前下方凹陷处。

〔主治〕黄疸，口苦，呕吐，胸胁痛，下肢痿痹，膝部疼痛。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<35> 阳 交

〔定位〕外丘穴后1寸处（腓骨后缘）。

〔主治〕胸胁胀痛，下肢痿痹，癫疾，喉痹。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<36> 外丘（郄穴）

〔定位〕外踝尖上7寸，腓骨前缘。

〔主治〕胸胁胀痛，下肢痿痹，癫疾。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<37> 光明（络穴）

〔定位〕外踝尖上5寸，腓骨前缘。

〔主治〕目痛，视物模糊，夜盲，乳胀痛，下肢痿痹。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<38> 阳辅（经穴）

〔定位〕外踝尖直上4寸，腓骨前缘稍前处。

〔主治〕胸胁痛，腋肿，目外眦痛，下肢痿痹。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<39> 悬钟（八会穴）

〔定位〕外踝尖上3寸，腓骨后缘。

〔主治〕胸、胁、腹部胀痛，下肢痿痹不遂，痔疮出血。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<40> 丘墟（原穴）

〔定位〕外踝前下方，趾长伸肌腱外侧凹陷中。

〔主治〕目赤肿痛，疟疾，胸胁胀痛，腋下肿，足踝肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<41> 足临泣（输穴、八脉交会穴）

〔定位〕第四、五跖骨结合部前缘凹陷处。

〔主治〕偏头痛，疟疾，目眩，目外眦痛，瘰癧，足跗肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<42> 地 五 会

〔定位〕第四、五跖骨间，小趾伸肌腱内侧缘处。

〔主治〕头痛，耳鸣耳聋，乳肿，胸胁满痛，足跗肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<43> 侠溪（荥穴）

〔定位〕足背第四、五趾间缝纹端。

〔主治〕头痛、眩晕，耳鸣耳聋，目外眦痛，胸胁胀痛，足跗肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<44> 足窍阴（井穴）

〔定位〕第四趾外侧甲角旁约0.1处寸。

〔主治〕头痛，目眩，目赤肿痛，耳鸣耳聋，胸胁胀痛，心烦。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸。

12 足厥阴肝经

<1> 大敦（井穴）

〔定位〕拇趾外侧趾甲角旁约0.1寸处。

〔主治〕疝气，遗溺，小便不通，月经不调，崩漏，癫狂，阴肿。

〔刺灸法〕浅刺0.1寸。

<2> 行间（荥穴）

〔定位〕足背第一、二趾间缝纹端。

〔主治〕头痛，眩晕，目赤肿痛，青盲，疝气，小便不利，月经不调，癫痫。

〔刺灸法〕向上斜刺0.5—0.8寸。

< 3 > 太冲（输穴、原穴）

〔定位〕足背第一、二跖骨结合部前凹陷中。

〔主治〕头痛、眩晕，疝气，月经不调，黄疸，目赤肿痛，青盲，癫痫，口喎，胸胁痛，下肢痿痹。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

< 4 > 中封（经穴）

〔定位〕内踝前1寸，胫骨前肌腱内侧凹陷中。适当商丘穴与解溪穴之间。

〔主治〕遗精，小便不利，疝气，黄疸，少腹肿痛，胸胁痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

< 5 > 蠡沟（络穴）

〔定位〕内踝上5寸，胫骨内侧面的中央。

〔主治〕月经不调，白带病，疝气，小便不利，胫部疼痛。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

< 6 > 中都（郄穴）

〔定位〕内踝尖上7寸，胫骨内侧面中央处。

〔主治〕泄泻，腹胀，疝气，胁痛，崩漏。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

< 7 > 膝 关

〔定位〕胫骨内踝后下方，阴陵泉后1寸处。

〔主治〕咽喉肿痛，下肢痿痹，膝部肿痛。

〔刺灸法〕直刺0.8—1寸。

< 8 > 曲泉（合穴）

〔定位〕屈膝，膝内侧横纹头上方凹陷中。

〔主治〕小便不利，小腹痛，头痛，眩晕，月经不调，阴挺，膝部疼痛。

〔刺灸法〕直刺0.8—1寸。

<9> 阴 包

〔定位〕股骨内上髁上4寸，股内肌与缝匠肌之间。

〔主治〕小便不利，遗溺，月经不调，腰骶痛。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.5寸。

<10> 足 五 里

〔定位〕曲骨穴旁开2寸，直下3寸处。

〔主治〕小便不通，阴挺，小腹胀满。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.5寸。

<11> 阴 廉

〔定位〕曲骨穴旁开2寸，直下2寸处。

〔主治〕月经不调，白带病，小腹痛，大腿内侧痛。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.5寸。

<12> 急 脉

〔定位〕气冲穴外下方，当耻骨联合下旁开2.5寸处。

〔主治〕疝气，阴挺，阴茎痛，少腹痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<13> 章门（脾的募穴、八会穴）

〔定位〕第十一肋端处。

〔主治〕腹胀，泄泻，黄疸，呕吐，痞块，胸胁痛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<14> 期门（肝的募穴）

〔定位〕锁骨中线上，第六肋间隙间。

〔主治〕腹胀，泄泻，呕吐，痞块，胸胁胀痛。

〔刺灸法〕斜刺或平刺0.5—0.8寸。

第二节 奇经八脉

1. 任 脉

<1> 会 阴

〔定位〕在前后阴之间。

〔主治〕二便不利，遗精，阴挺，痔疾，脱肛，癫痫，溺水窒息。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。孕妇慎用。

< 2 > 曲 骨

〔定位〕腹正中线上，耻骨联合上缘。

〔主治〕小便淋沥，遗尿，少腹胀满，遗精，阳痿，疝气，月经不调，白带病。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

< 3 > 中极（膀胱募穴）

〔定位〕腹正中线上，脐下4寸处。

〔主治〕小便不利，遗尿，遗精，阳痿，疝气，月经不调，阴挺。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

< 4 > 关元（大肠募穴）

〔定位〕腹正中线上，脐下3寸。

〔主治〕阳痿，遗精，遗尿，小便不利，月经不调，白带病，阴挺，中风脱证，虚劳体弱。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

< 5 > 石门（三焦募穴）

〔定位〕腹正中线上，脐上2寸处。

〔主治〕小便不利，水肿，泄泻，腹痛，疝气，遗精，月经不调。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

< 6 > 气海（盲之原穴）

〔定位〕腹正中线上，脐下1.5寸处。

〔主治〕小腹痛，遗尿，尿失禁，小便不利，泄泻，阳痿，遗精，疝气，月经不调，阴挺，中风脱证，虚劳体弱。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

< 7 > 阴 交

〔定位〕腹正中线上，脐下1寸处。

〔主治〕腹痛，腹胀，小便不利，水肿，泄泻，经闭，白带病。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<8> 神 阙

〔定位〕脐窝中央处。

〔主治〕中风脱证，腹痛肢厥，泄泻，水肿。

〔刺灸法〕禁针，可灸。

<9> 水 分

〔定位〕腹正中线上，脐上1寸处。

〔主治〕腹痛，腹胀，水肿，泄泻，反胃呕吐。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<10> 下 脘

〔定位〕腹正中线上，脐上2寸处。

〔主治〕胃脘痛，腹胀，呕吐，反胃，呃逆。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<11> 建 里

〔定位〕腹正中线上，脐上3寸处。

〔主治〕胃脘痛，腹胀，泄泻，呕吐。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<12> 中脘（胃募穴、八会穴）

〔定位〕腹正中线上，脐上4寸处。

〔主治〕胃脘痛，腹胀，呕吐，呃逆，泄泻，黄疸，咳喘痰多，脾胃虚弱。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<13> 上 脘

〔定位〕腹正中线上，脐上5寸处。

〔主治〕腹胀，胃脘痛，呕吐，癫痫。

〔刺灸法〕直刺0.8—1.2寸。

<14> 巨阙（心募穴）

〔定位〕腹正中线上，脐上6寸处。

〔主治〕心痛，心悸，癫痫，胸痛，胃痛，呕吐。

〔刺灸法〕向下斜刺0.5—1寸。

<15> 鸠尾（络穴、膏之原穴）

〔定位〕腹正中线上，脐上7寸处。

〔主治〕心痛，心悸，胸痛，癫狂，癫痫。

〔刺灸法〕向下斜刺0.5—1寸。

<16> 中 庭

〔定位〕胸剑联合的中点。

〔主治〕胸胁胀满，呕吐，食不下，梅核气。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<17> 膻中（心包募穴、八会穴）

〔定位〕胸骨正中线上，平第四肋间隙。

〔主治〕心悸，胸痛，咳嗽气喘，乳汁少。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<18> 玉 堂

〔定位〕胸骨中线上，平第三肋间隙。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，咽喉肿痛，两乳肿痛。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<19> 紫 宫

〔定位〕胸骨中线上，平第二肋间隙。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，喉痹，呕吐。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<20> 华 盖

〔定位〕胸骨中线上，平第一肋间隙。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，咽喉肿痛。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<21> 璇 玑

〔定位〕胸骨中线上，约当胸骨柄中点处。

〔主治〕咳嗽，气喘，咽喉肿痛。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<22> 天 突

〔定位〕胸骨上窝正中。

〔主治〕咳嗽，气喘，咽喉肿痛，暴瘡，瘰气，梅核气。

〔刺灸法〕先直刺0.2寸，然后将针尖朝向下方，沿胸骨柄后缘、气管前缘缓慢进针0.5—1寸。注意不能刺向左右。

<23> 廉 泉

〔定位〕舌骨体上缘中点

〔主治〕舌下肿痛，舌强不语，暴瘡吞咽困难，喉痹。

〔刺灸法〕向舌根方向斜刺0.5—1寸。

<24> 承 浆

〔定位〕颊唇沟正中点凹陷处。

〔主治〕口喎，齿齲肿痛，暴瘡，流涎，癫痫，面肿。

〔刺灸法〕斜刺0.3—0.5寸。

2 督 脉

<1> 长强（络穴）

〔定位〕尾骨尖下0.5寸处。

〔主治〕痔疮，脱肛，癫狂，癫痫，泄泻，便秘。

〔刺灸法〕紧靠尾骨前面斜刺0.5—0.8寸。

<2> 腰 俞

〔定位〕当骶骨裂孔处。

〔主治〕癫狂，癫痫，痔疮，月经不调，下肢痿痹。

〔刺灸法〕稍向上斜刺0.5—0.8寸。

<3> 腰 阳 关

〔定位〕第四腰椎棘突下。

〔主治〕阳痿，遗精，月经不调，腰骶痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<4> 命 门

〔定位〕第二腰椎棘突下。

〔主治〕阳萎，遗精，月经不调，白带病，不育不孕，腰痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<5> 悬 枢

〔定位〕第一腰椎棘突下。

〔主治〕腰痛，腹胀，泄泻，痢疾。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<6> 脊 中

〔定位〕第十一胸椎棘突下。

〔主治〕泄泻，黄疸，痔疾，癫痫，腰脊强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<7> 中 枢

〔定位〕第十胸椎棘突下。

〔主治〕腹胀满，黄疸，腰痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<8> 筋 缩

〔定位〕第九胸椎棘突下。

〔主治〕癫痫，胃痛，脊强。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<9> 至 阳

〔定位〕第七胸椎棘突下。

〔主治〕黄疸，咳喘，胸胁胀痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<10> 灵 台

〔定位〕第六胸椎棘突下。

〔主治〕咳嗽，气喘，疔疮，脊背强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<11> 神 道

〔定位〕第五胸椎棘突下。

〔主治〕心悸，心痛，中风不语，癫痫，咳嗽，脊背强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<12> 身 柱

〔定位〕第三胸椎棘突下。

〔主治〕咳嗽，气喘，癫痫，腰脊强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<13> 陶 道

〔定位〕第一胸椎棘突下。

〔主治〕头痛，疟疾，发热，项背强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<14> 大 椎

〔定位〕第七颈椎棘突下。

〔主治〕热病，感冒，疟疾，咳嗽，气喘，癫痫，风疹，项背强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<15> 哑 门

〔定位〕后发际正中上0.5寸处。

〔主治〕哑症，舌强不语，暴瘖，癫狂，癫痫。

〔刺灸法〕直刺或稍向下刺0.5—1寸。

<16> 风 府

〔定位〕后发际正中直上1寸处。

〔主治〕中风不语，半身不遂，头项强痛，癫狂，癫痫。

〔刺灸法〕直刺或稍向下斜刺0.5—1寸。

<17> 脑 户

〔定位〕风府穴直上1.5寸处。

〔主治〕头痛，眩晕，音哑，癫痫，项强。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<18> 强 间

〔定位〕脑户穴直上1.5寸处。

〔主治〕头痛，眩晕，项背强痛，失眠，癫痫。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<19> 后 顶

〔定位〕强间穴直上1.5寸。

〔主治〕头痛，眩晕，项强，失眠，癫痫。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<20> 百 会

〔定位〕后发际正中直上7寸处。

〔主治〕头痛，眩晕，中风失语，癫狂，癫痫，脱肛，阴挺，昏厥。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<21> 前 顶

〔定位〕百会穴前1.5寸处。

〔主治〕头痛，眩晕，癫痫，目赤肿痛，鼻渊。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<22> 凶 会

〔定位〕前顶穴前1.5寸处。

〔主治〕头痛，眩晕，癫痫，小儿惊病，鼻渊，鼻衄。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<23> 上 星

〔定位〕前发际正中上1寸处。

〔主治〕头痛，眩晕，目赤肿痛，癫狂，鼻渊，鼻衄，热病。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<24> 神 庭

〔定位〕前发际正中上0.5寸。

〔主治〕头痛，眩晕，癫狂，失眠，鼻衄，鼻渊。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<25> 素 髎

〔定位〕鼻尖正中处。

〔主治〕鼻塞、鼻衄、鼻渊等鼻疾，昏厥。

〔刺灸法〕向上斜刺0.3—0.5寸，或点刺出血，不灸。

<26> 水 沟

〔定位〕人中沟上1/3与中1/3交界处。

〔主治〕昏迷，晕厥，牙关紧闭，癫痫，口喎，唇肿，面肿。

〔刺灸法〕向上斜刺0.3—0.5寸，不灸。

<27> 兑 端

〔定位〕上唇尖端，人中沟与口唇接连处。

〔主治〕癫狂，口喎，唇肿，齿龈肿痛。

〔刺灸法〕向上斜刺0.2—0.3寸，不灸。

<28> 龈 交

〔定位〕上唇系带与齿龈交接处。

〔主治〕齿龈肿痛，癫狂，鼻渊。

〔刺灸法〕向上斜刺0.2—0.3寸，不灸。

第三节 经外奇穴

1. 头 颈 部

<1> 四 神 聪

〔定位〕百会穴前后左右各1寸，共计四穴。

〔主治〕头痛，眩晕，失眠，癫痫，五迟五软。

〔刺灸法〕平刺0.5—0.8寸。

<2> 印 堂

〔定位〕两眉头之间取穴。

〔主治〕头痛，眩晕，鼻渊，鼻衄，失眠，小儿惊风。

〔刺灸法〕向下平刺0.3—0.5寸。

<3> 鱼 腰

〔定位〕眉毛的中央。

〔主治〕眉棱骨痛，眼睑瞤动，眼睑下垂，目赤肿痛。

〔刺灸法〕平刺0.3—0.5寸。

<4> 太 阳

〔定位〕眉梢与目外眦之间旁开1寸。

〔主治〕头痛，目赤肿痛，口眼喎斜，牙痛，三叉神经痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 5 > 牵 正

〔定位〕在耳垂前0.5—1寸处。

〔主治〕口眼喎斜，下牙痛。

〔刺灸法〕向前斜刺0.5—0.8寸。

< 6 > 金津、玉液

〔定位〕卷舌，舌系带两旁静脉处，左为金津，右为玉液。

〔主治〕口舌生疮，舌肿，失语，消渴。

〔刺灸法〕点刺出血，禁灸。

< 7 > 百 劳

〔定位〕大椎穴上2寸，旁开1寸处。

〔主治〕咳嗽，骨蒸潮热，瘰癧，落枕。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

2. 躯 干 部

< 8 > 定 喘

〔定位〕大椎穴旁开0.5寸处。

〔主治〕咳嗽，气喘，项背强痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

< 9 > 华佗夹脊

〔定位〕第一胸椎至第五腰椎止，各椎棘突下旁开0.5寸处。

〔主治〕与背俞穴相似。上背部夹脊主胸、心、肺病证；下背部夹脊穴主上腹部、肝、胆、脾、胃病证；腰夹脊部主下腹部、肠、膀胱及下肢病证。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

< 10 > 胃管下俞

〔定位〕背部，第八胸椎棘突下旁开1.5寸。

〔主治〕胃痛，腹痛，呕吐，胸胁痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<11> 痞 根

〔定位〕第一腰椎棘突下，后正中线旁开3.5寸处。

〔主治〕痞块，肝脾肿大，腰痛。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<12> 腰 眼

〔定位〕第四腰椎棘突下，旁开3—4寸之凹陷处。

〔主治〕腰痛，月经不调，带下，虚劳。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<13> 十 七 椎

〔定位〕第五腰椎棘突下凹陷中。

〔主治〕腰骶痛，下肢痹痛，遗尿。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<14> 腰 奇

〔定位〕在尾骨尖端上2寸处。

〔主治〕癫痫，头痛，便秘。

〔刺灸法〕向上平刺1—1.5寸。

<15> 三 角 灸

〔定位〕以患者两口角的长度为一边，作一等边三角形。将顶角置于患者脐中心，底边是水平线，于两底角处取穴。

〔主治〕疝气，绕脐疼痛，妇人不孕。

〔刺灸法〕灸而不针。

<16> 子 宫

〔定位〕中极穴旁开3寸。

〔主治〕阴挺，月经不调，痛经，疝气。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

3. 四 肢 部

<17> 十 宣

〔定位〕两手十指尖端，距指甲约0.1寸处。

〔主治〕昏迷，晕厥，中暑，热病，咽喉肿痛。

〔刺灸法〕点刺出血。

<18> 大 骨 空

〔定位〕在拇指背侧指骨关节横纹中点处。

〔主治〕目翳，目痛，衄血。

〔刺灸法〕灸而不针。

<19> 中 魁

〔定位〕握拳，掌心向下，中指背侧近端指骨关节横纹中点处。

〔主治〕噎膈，反胃，呕吐，呃逆，牙痛。

〔刺灸法〕灸而不针。

<20> 小 骨 空

〔定位〕握拳，掌心向下，小指背侧近端指骨关节横纹中点处。

〔主治〕目赤肿痛，目翳，指节疼痛。

〔刺灸法〕灸而不针。

<21> 八 邪

〔定位〕手背第一—五指间缝纹端，双手共八穴。

〔主治〕手背肿痛，指节麻木疼痛、拘挛。

〔刺灸法〕向上斜刺0.5—0.8寸。

<22> 中 泉

〔定位〕阳溪穴与阳池穴之间，当指总伸肌腱桡侧凹陷中。

〔主治〕胸胁胀痛，胃痛，咳喘，吐血。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

<23> 四 缝

〔定位〕第二、三、四、五指掌面近端指关节横纹中点。

〔主治〕疳积，百日咳。

〔刺灸法〕点刺0.1—0.2寸，挤出黄白色粘液。

<24> 二 白

〔定位〕伸臂仰掌，腕横纹上4寸，桡侧腕屈肌腱之两侧缘处。

〔主治〕痔疮，脱肛。

〔刺灸法〕直刺0.5—0.8寸。

<25> 肩 前

〔定位〕垂臂、腋前皱襞端与肩髃连线中点。

〔主治〕肩部疼痛不举，上肢不遂。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<26> 百 虫 窝

〔定位〕髌髁骨内上角上3寸处。

〔主治〕蛔虫病，皮肤搔痒。

〔刺灸法〕直刺0.5—1寸。

<27> 膝 眼

〔定位〕屈膝，髌韧带两侧之凹陷处，共4穴。

〔主治〕膝关节病变，下肢疼痛。

〔刺灸法〕向膝中斜刺0.5—1寸。

<28> 胆 囊 穴

〔定位〕阳陵泉穴直下1寸左右的压痛点处。

〔主治〕胁痛，黄疸，下肢痿痹。

〔刺灸法〕直刺1—1.5寸。

<29> 阑 尾 穴

〔定位〕足三里穴与上巨虚穴之间的压痛点处。

〔主治〕肠痈，胃脘痛，下肢痿痹。

〔刺灸法〕直刺0.5—1.2寸。

<30> 八 风

〔定位〕足背五趾各趾间缝纹端处，共八穴。

〔主治〕足跗肿痛，趾节麻木疼痛、拘挛。

〔刺灸法〕斜刺0.5—0.8寸。

<31> 独 阴

〔定位〕足第二趾跖侧面，远端趾关节横纹中点处。

〔主治〕卒心痛，胸胁痛，死胎，胞衣不下。

〔刺灸法〕直刺0.1—0.2寸。

<32> 里 内 庭

〔定位〕足底第二、三趾间，与内庭穴相对处。

〔主治〕趾节疼痛，小儿惊风，癫痫，胃痛。

〔刺灸法〕直刺0.3—0.5寸。

各 论

第二章 内科疾病

第一节 传染病

1. 急性病毒性黄疸型肝炎

针刺法及针刺加穴位注射法

(一) 针刺主穴 黄疸期 针刺组：足三里、至阳、胆俞；针刺加穴位注射组：阳陵泉、蠡沟、肝俞。另：针刺组加刺大椎、太冲。黄疸消退期 针刺组：足三里、三阴交、肝俞；针刺加穴位注射组：三阴交、阳陵泉、脾俞。

(二) 辨证取穴 发热配合谷、曲池；腹疼、腹泻配天枢、公孙；腹胀、食欲不振配中脘；恶心呕吐配内关；肝郁不舒配章门；胁痛配期门。

(三) 针刺方法 针具严密消毒，防止交叉感染，每日针刺1次，每次留针15~30分钟，隔5~10分钟行针1次（小儿不留针），每组穴位隔日交替使用，7~10天为1疗程。每疗程间休息2天。

(四) 穴位注射三阴交 常规消毒后，针刺1.5厘米左右，得气后缓慢注药，每侧0.5~1毫升，每日注射1次（药物维生素B₁₂）。

治疗结果 痊愈：临床症状消失，肝在肋弓下1.5厘米以内，肝功能试验均在正常范围。

好转：临床症状明显好转，肝功能试验大部分正常。

无效：临床症状和肝功能试验改变不大或中途改用综合治疗。

针刺组84例，痊愈77例，好转3例，无效4例；针刺加穴位注射组51例，痊愈49例，好转1例，无效1例。

刘汉城等 针刺治疗急性病毒性黄疸型肝炎 湖南中医杂志 (6)；21, 1988

针 刺 法

主穴：足三里，太冲透涌泉。配穴：恶心呕吐甚者，加内关。

方法：主穴每日针刺一次，左右交替选用，深浅以病人针感程度灵活掌握。针感有否或正确与否以针感是否循行于所刺穴位的经络路线上为准。有针刺感后留针30分钟，配用6805治疗机通电治疗，脉冲电疏密波，通电强度由小至大，以病人耐受为宜。

疗程：10次为1疗程，一般2—3个疗程。

治疗效果 共治疗88例，临床治愈72例，占81.8%。(1)隔离期满，自发病日起至少1月。(2)目黄、身黄消退，恶心、腹胀、肝区痛消除。(3)肿大的肝脏、脾脏恢复正常或明显缩小，缩小的肝脏、脾脏质地柔软，肝区无明显压痛或叩痛。(4)肝功能检查恢复正常。

好转16例，占18.2%。(1)目黄、身黄消退，恶心、腹胀、肝区痛减轻。(2)肿大的肝脏、脾脏恢复正常或缩小，缩小的肝脏质地柔软，可有轻度触病或叩击痛。(3)查肝功能黄疸指数6个单位以下，胆红质1.0毫克%以下，谷丙转氨酶轻度高于正常。

熊泉平 针刺治疗急性病毒性黄疸型肝炎 88例 江苏中医 (8)；29, 1988

激光针刺法

用氦氖激光双管治疗机，波长为6328埃，输出功率10毫瓦，光斑直径1.5厘米，照射距离为10厘米左右。选双侧足三里和肝俞穴，每日照射一次，每次每穴照射15分钟，20次为一疗程。加用维生素C片0.2克，一日三次；复合维生素B片，一日三次。

共治疗78例。近期治愈：20天内临床症状消失，肝区无压痛或叩击痛，肝功能连续两次检查均阴性，共73例，占93.5%。

好转：20天内临床主要症状消失，肝功能各项指标下降 $>50\%$ 或肝功能接近正常，共2例，占2.7%。

无效：20天内临床症状、肝功能检查均无改善，共3例，占3.8%。

王富龙等 激光针刺治疗急性病毒性黄疸型肝炎 78 例疗效观察
黑龙江中医药 (6); 39, 1990

耳穴压迫法

以留行子粘于小块胶布上压迫耳穴。取穴：肝、胆、脾、三焦，配穴：胃、胰、内分泌、神门、交感。每隔3日换另一侧耳穴，并嘱患者自己每日压穴位3~4次，每次1~2分钟，同时内服维生素C、B₁，若进食少，静脉点滴10%葡萄糖500毫升、维生素C2.5克，15天为1疗程。

治疗结果 共治疗40例。1.疗效标准：治愈：治疗2个月主要临床症状消失，黄疸消退，肝功能恢复正常。好转：治疗2个月，肝功能改善，临床症状减轻。2.结果：1个月治愈30例，2个月治愈38例，好转2例。

临床症状和肝功能平均恢复天数：纳差：6.7天，恶心：4.3天，呕吐：2天，腹胀：6天，黄疸：13天，瘀浊：24天，锌浊：26天。

陈桂芳等 耳穴压迫治疗急性黄疸型肝炎40例 上海中医药杂志

附：阳 黄

针 刺 法

1. 配穴原则：针刺肝胆经穴位以疏利肝胆，清利湿热，刺脾胃经穴位则益气健脾，化浊利湿。

2. 选穴：阳陵泉透阴陵泉，足三里，太冲。

3. 配穴：腹胀纳差配中脘，恶心呕吐配内关，胁痛甚配章门。

4. 手法：平补平泻、进针快，留针15分钟，留针期间捻转6～7次，10天为一个疗程，直至黄疸退症状体征完全消失，肝功检验、肝脏超声波复查正常为止。针刺期间不另投中西药物。

治疗结果 共治疗53例，谷丙转氨酶恢复到50个单位以下，黄疸指数降到6个单位以下，症状消失者为治愈，48例。谷丙转氨酶下降到60单位内，黄疸指数下降到10个单位以内，症状部分消失为好转，5例。

冀文国 针刺治疗阳黄证53例 河南中医 (5); 33, 1990

2. 乙型甲型肝炎双重感染

水 针 法

选穴分3疗程，第1疗程10次，每日1次，取双侧足三里、阳陵泉，两组穴交替使用。第2疗程10次，间日1次，取双侧阳陵泉、三阴交，两组穴交替使用。第3疗程15次，间日1次，随证选取双侧足三里、阳陵泉、三阴交中一组穴。总疗程为60日。每次每穴注射蒸馏水1～2ml。注射时，嘱患者仰卧，术者先用左手拇指揉按其穴位2～3

次，然后半握拳，顺该穴所属经脉的走向叩打数下，再常规消毒后注射。注射足三里，直刺入1cm左右，缓慢推注0.5~1ml后，向下刺入1cm许，再推注0.5~1ml，然后轻提至皮下而疾出针，用消毒干棉球重按针孔片刻。注射阳陵泉，向前下方呈60度角斜刺约2cm，缓慢推注0.5~1ml后，上提1cm左右，再推注0.5~1ml，缓慢出针，不按针孔，而令出血少许。注射三阴交，向上方呈60度角斜刺约1.5cm，缓慢推注1~1.5ml后出针，用消毒干棉球轻按针孔片刻。针刺诸穴，患者均有胀、酸、麻并沿本经传导的感应。如果仅有局部胀痛，大多与紧张及体位不当有关。个别患者偶有剧痛，点按同侧阳溪穴可止。

共治疗8例，均获临床治愈。症状消退时间 6.50 ± 3.07 天，体征消退时间 11.87 ± 6.34 天；黄疸指数恢复正常时间 20.15 ± 10.44 天，SGPT恢复正常时间 35.62 ± 13.12 天。

连维真等 穴位水针治疗乙型甲型肝炎双重感染 浙江中医杂志 (4), 176, 1991

3. 乙脑后遗症

针 刺 法 (一)

主穴：人中、内关（双）、四神聪、三阴交（患侧）、足三里（患侧）。吞咽障碍选翳风（双），失语选廉泉，上肢瘫痪选肩髃、臂中，下肢瘫痪选委中、阳陵泉。先刺双侧内关，直刺0.5~1寸，用提插捻转泻法半分钟，不留针。以后刺人中，针向鼻中隔下斜刺3分，用雀啄泻法半分钟，不留针。再直刺足三里0.5~1寸，用提插捻转补法。再刺三阴交用提插捻转补法。其余均用平补平泻法，得气后留针15分钟。每日1次，10次为1疗程。

治疗效果 共治疗30例，16例治愈（临床症状消失，语言清楚，智力恢复正常，肢体运动功能恢复），9例显效（智力恢复正常，语言或上下肢有一项恢复不完全者），3例好转（智力有一定恢复，语

言及肢体有一定恢复)，2例无效（智力、语言、肢体运动功能等无改善者）。

孟昭璞 针刺治疗乙脑后遗症 30 例临床观察 浙江中医杂志 (8); 378, 1988

针 刺 法 (二)

1. 取穴：以四神聪、风池、角孙、人中为主穴。配以肩髃、曲池、外关、四关、腰阳关、环跳、阳陵泉、足三里、绝骨。

2. 对症加穴：失语、流涎加哑门、廉泉、通里；牙关不利加颊车、下关；眼睑麻痹加阳白、鱼腰、阳陵泉、攒竹；手指关节屈伸难加八邪、后溪透劳宫；小便滴沥不禁加关元、中极、三阴交。

3. 操作方法：用单手快速进针至皮下，然后将针往下捻进，持续捻转 5 分钟。6 岁以内有针感后捻转数次即出针，7 岁以上留针 20 分钟，每隔 5 分钟运针一次，以保持良好的针感以加强疗效。

治疗效果 (一) 疗效标准：瘫痪肢体功能基本恢复，生活能自理者为痊愈。瘫痪肢体明显恢复，生活大部分能自理者为显效。瘫痪肢体较治疗前进步，肌力和其他症状有一些改善者为好转。针刺前后病情无变化者为无效。

(二) 疗效：本组 25 例中，痊愈 6 例，显效 8 例，好转 9 例，无效 2 例，总有效率为 92%。

梁栋富 针刺四神聪穴治疗病毒性脑炎后遗症 25 例疗效观察 中国针灸 (3); 38, 1986

针 刺 法 (三)

1. 取穴：清心开窍：百会、风池、神门、通里、心俞、肝俞、肾俞；祛风解痉，祛痰止咳：照海、申脉、太冲、合谷、大椎、足三里、三阴交、血海、丰隆；治疗瘫痪：肩髃、曲池、外关、大肠俞、环跳、风市、阳陵泉、秩边、承扶、殷门、委中、昆仑；语言障碍：

金津、玉液、廉泉；舒筋活血，增强全身功能；华佗夹脊、膏肓、气海。耳穴：神门、脑、肝、肺、心、肾、皮质下、内分泌、肾上腺等。据病情配组，每次各症兼取6—8穴。

2. 手法：用28号毫针，遵“凡用针者，虚则实之，满则泻之，菀陈则除之，邪盛则虚之。”之旨辨证施用。瘫痪者用电针。有时不留针。

3. 水针疗法：用板兰根注射液，维生素B₁ B₁₂，加兰他敏作穴位注射。板兰根液多用于早期，作清热解毒抗病毒，维生素加兰他敏则用于治瘫痪。

4. 视病情辅以中药。

5. 7日为一疗程，休息1—3天。

共治疗5例。一例全瘫患儿，治疗三个月后神智、语言及肢体功能均全部恢复正常，一例抽风与上下肢瘫痪者一月康复，一例失语患儿，两周能言，一例失明病孩，8日能见人影晃动，10日可视蚂蚁爬行，半月后恢复如常人。另一例于病后一年多方接受针刺疗法，经治疗年余，神智基本恢复，现能扶凳行走。

邱鹤岑 针刺为主治疗乙脑后遗症的体会 重庆中医药杂志(1)，19，1988

4. 脑炎后遗症候群

针 刺 法

主要穴位分三组：①，哑门、肾俞；②，风池、足三里；③，大椎、内关。每次顺次轮流选择一组穴位。有其它后遗症者则根据不同症状随症配穴，隔日一次，十次为一疗程，休息7~10天后再进行第二、三疗程。头部穴位每采用乙酰各酰胺注射液，四肢躯干穴位用活血注射液或盐酸呋喃硫胺液。

分别在治疗前后描记脑电图，以观察其变化。两次检查时间平均

间隔3~4个月左右。

50例脑炎后遗症候群患儿，治疗前脑电图表现不正常38例，占76%，有背景电活动变慢、不对称，其中22例伴有痫性放电。界限性脑电图4例，占8%，基本电活动属正常范围，但 θ 波、 δ 波偏多。脑电图正常8例，占16%。经针刺治疗后，随着临床症状的好转，3个月以后随访脑电图，发现8例正常脑电图，4例波幅增高，2例电活动稍增快，但均变化不大。4例界限性脑电图，1例 δ 波减少，电活动出现节律性转为正常脑电图，2例无变化，1例电活动变慢，此3例在随访第二次脑电图中均出现痫样放电，临床治疗效果也不理想。而38例不正常脑电图中有30例，占78.9%，脑电图均有不同程度改善，有的表现为背景电活动增快，有的表现为左右半球电活动对称性好转，及痫性放电减少。

施炳培等 针刺治疗50例脑炎后遗症候群患者对脑电图影响的观察
辽宁中医杂志 (12); 35, 1986

5. 流行性出血热

灸 法

一、熏灸 采用艾条熏灸器（自制），根据辨证原则，熏相应孔穴，一般均以一穴为准，不超过两穴。每次熏灸时间为1.5~2小时，时间太短无效。每日1~2次。

二、火针代灸 与传统的火针不一样，仅是刺及表皮、真皮，灸疮既小又浅，可以收到灸与针的双重作用。故火针代灸也常称之为针，而统称则为灸。

1. 深浅 可分为Ⅲ度，Ⅰ度约深1~1.5毫米，Ⅱ度约深2~3毫米，Ⅲ度约为5毫米。

2. 轻重 手法应轻巧稳准，用力均衡，可分快、中、慢三种。快刺用力轻，一触即去；慢刺停针时间较长，用力稍重；中等手法则是

介于快慢之间。

3. 壮数 点刺1下为1壮，2下为2壮，3下为3壮。

三、选穴

1. 舍症求穴：流行性出血热的患者，约有半数在背部能出现压痛反应，因之无论症状表现如何，直对这种反应穴进行灸治，均可收到不同程度的效果。

2. 因症选穴：

(1) 大椎五针（火针代灸，下同）或熏灸，在流行性出血热之早期，头痛发热，颜面青紫或浮肿，球结膜充血等，以此解表泄热。

(2) 三阴交四针，以此止腰痛。(3) 三脘五针，以此宽中除痞，止呕进食。(4) 巨阙或至阳熏灸，以此升压复脉，抢救休克。亦可配合火针代灸，点刺内关与复溜。(5) 百会五针，以此醒脑安神，对谵妄昏迷，烦躁发狂，惊悸抽搐等症，颇有效。(6) 阳陵泉三针，口渴，口苦，唇焦咽燥、胸中烦热等症，常入针后即可缓解或消失。(7) 膈俞与血愁，常用于鼻血，牙龈出血及内脏腔道出血。上部出血可配尺泽、鱼际；下部出血可配血海，三阴交。(8) 列缺、照海，对小便黄赤短少，尿血及尿道刺痛效果明显，特别是以尿道刺痛为最有效。(9) 局部取穴火针代灸，对局部红肿青紫，硬结肿痛，疗效较好。

四、治法

1. 熏灸与火针代灸交替使用，以火针为主。

2. 每日灸治1~2次。

3. 熏灸以1穴为准，火针一般不超过5穴。

4. 间或采用普通针刺及三棱针点刺出血，也常采用刮法相配合。

治疗结果 共治疗79例，症状与体征全部消失，饮食恢复，尿蛋白(-)，其它检查均在正常范围者为痊愈，共56例，占70.89%；症状与体征基本消失，但仍有轻度食欲不振，尿蛋白(±)其它检查接近正常范围者为显效，共21例，占26.58%；灸治15天以上，症状与体征均无改善，或虽经灸治，但中途停灸又改用他法治疗者，均属

无效，共2例，占2.53%。

周楣声等 灸法治疗流行性出血热 79 例临床观察 中国针灸 (4); 15, 1987

6. 破 伤 风

针 刺 法

取穴：风府、大椎、身柱、至阳、筋缩、命门、腰阳关、下关、颊车、曲池、合谷、环跳、阳陵泉、丰隆、太冲。以上各穴每次针刺时尽可能轮流刺完。针法：强刺激，不留针，1日2次或根据情况酌加针刺次数。其它治疗：葡萄糖盐水1500~2000毫升加Vc3克静脉滴注，每日1次。鲁米那0.1克肌注，每日2次，10%水化氯醛15毫升灌肠，每日1次，青霉素80万单位肌注，6小时1次。创口处理：清创、引流、不予包扎，创口外用九一丹，复盖纱布。

治疗结果 共治疗28例，针刺后患者口噤得开，抽搐停止，肌肉松软，感到舒适，有的绵绵欲睡，即证明已获疗效。结果：治愈25例，死亡3例。

何止湘 针刺治疗破伤风28例 中国针灸 (4); 2, 1987

7. 疟 疾

针 刺 法

取穴：主穴大椎。配穴间使、后溪。头痛者加太阳。

针刺手法：大椎穴进针深度需达1.2寸，体型肥胖者进针需1.5寸。间使、后溪二穴进针深度控制在1寸即可。均行提插手法，以产生强的得气感为佳。留针20~30分钟，每隔5分钟行间歇术一次，于发

病前2小时进行针刺，3次为一疗程。

治疗结果 针刺1~3次后症状完全消失，复查血片未见疟原虫，半月后随访未见复发者为痊愈；针刺3次后症状略有减轻，但复查血片仍见疟原虫者为无效。

45例患者，痊愈41例（91.1%），其中间日疟33例，一日疟8例。无效4例，其中间日疟1例，一日疟3例。经针刺一次治愈的17例，二次治愈的13例，三次治愈的11例。余4例，有3例经3次针刺治疗，症状有所减轻，但复查血片仍见原虫，后来未坚持治疗改服药获愈，另1例经治疗1次因恐针而中断治疗，故归于无效。

王振琴 针刺治疗疟疾45例临床疗效观察 中国针灸（5），18，1986

8. 细菌性痢疾

针 灸 法

穴方：通过精选确定为下脘、天枢、关元、足三里和神阙。

操作：前四穴针刺，用直径 $\phi 0.32\text{mm}$ 长度4cm不锈钢毫针，进针至适当深度，行提插捻转手法，使腹部穴针感向四周放散，下肢穴针感向上下传导。同时隔盐艾灸神阙两壮，每壮用艾绒2克。高烧体温在 39°C 以上者加大椎、曲池针刺；腹痛剧烈、小便短赤者加三阴交针刺。

每日针灸次数视病情轻重而定。每日腹泻10次以下，腹痛等症较轻者，针灸一次；腹泻10次以上，腹痛等症较重者，二次；腹泻在20次以上，腹痛等症剧烈者三次。留针30—60分钟，每隔5—10分钟行针一次，连续治疗5—9日，治愈为止。

对无症状痢疾杆菌带菌者重用艾灸，即隔盐灸下脘、神阙、关元三穴，每穴灸3壮，每壮用艾绒2克，针刺天枢、足三里二穴，采用快速进针至适当深度，进行提插捻转得气后，留针30分钟，隔10分钟

行针一次。每日一次，连续7—14日，治愈为止。

治愈：①临床症状与体征全部消失。②粪便成形无粘液脓血。③粪便镜检红细胞、脓细胞连续三日消失。④粪便细菌培养连续三日阴转。⑤体温、血象恢复正常。

无效：急性细菌性痢疾九日，无症状带菌者14日大便培养未阴转者。

针灸共治疗330例，其中急性菌痢317例，治愈286例，治愈率为90.6%，平均治愈日为4.12天（3.9—5.25天）。症状与体征平均消失或恢复日分别为：发烧2.19，血象2.75，腹泻4.15，腹痛3.93，里急后重3.48。粪便镜检平均阴转日为5.24。

13例无症状痢疾杆菌带菌者，经针灸治疗7—14天全部治愈，细菌培养平均阴转日为6.8（5—14）。

张涛清等 针灸治疗细菌性痢疾的临床研究 中国针灸（4），3，1987

水 针 法

以注射用水作腹部双侧天枢和关元穴位注射。注射时病人取仰卧位，皮肤局部常规消毒后，用4½～5号皮肤针头，快速刺入穴位（穴位在肌肉层），并上下提插、待病人局部有酸、麻、胀感后，回抽，无回血，即由深至浅，分层推注注射用水。注射后立即用拇指尖切水沟（即人中），这样既可防止晕针，又可减轻病人局部的胀痛感。初次注射量为0.5毫升，让病人体会一下腹部穴位的注射感觉，使其逐步适应，1小时以后再注射1～2毫升。以后每日视病情注射1～2次，直至症状体征消失，化验大便恢复正常2～3天后为止。

治疗效果 本组101例，全部近期治愈。即临床症状、体征消失，复查大便常规正常，细菌培养阴转。

张生理 注射用水注入穴位治疗菌痢101例 中国针灸（3），22，1986

9. 乳 糜 尿

耳穴注射法

(1) 取穴：耳穴肾透膀胱，皮质下，神门，枕，内分泌，(2) 药物：每日用维生素 B_{12} 100微克（等于1毫升），加维生素 B_1 50毫克（1毫升），备用。(3) 注射：耳穴每日注射1次，每次2~3穴，每穴注射0.1~0.2毫升，余下肌注。两耳轮流注射，10次为1疗程。(4) 配穴，有的可配三阴交、阴陵泉等体穴。

共治疗13例，经用本法治疗：症状消失，尿常规正常，乳糜尿转阴者9人；症状基本消失，乳糜尿转阴，但尿还不完全正常者4人。

高琪瑜 耳穴注射治疗乳糜尿 中国针灸 (4)，55，1987

第二节 消化系统疾病

1. 食道癌、胃癌

针 刺 法

取穴：选用胃募中脘，脾募章门补其元气，再配以相应的背俞。如肝胃不和取胃经合穴足三里培土御木，配肝经荣穴行间泄木安土。气血双亏补足三里、三阴交、膈俞、脾俞和胃健脾，滋阴补血，升清降浊，抗癌扶正。痰湿结聚者取丰隆、公孙等化痰散结，健脾运湿，脾肾阳虚怕冷者可灸背部俞穴。同时配合耳针具有镇痛安神，增强免疫力和调节躯体内脏功能的耳穴。

手法：体针得气后进行提插捻转补泻，令针感传向病所或针感沿经络上下传导，留针20分钟，中间行针2次或用6805治疗仪通电20分钟。耳针进针后略加捻转3分钟，留针4至8小时，隔日治疗一次，20次为一疗程。

共治疗30例，自觉症状好转，病灶缩小50%以上，稳定在一年以上者为显效；自觉症状好转维持在半年以上者为有效；病灶缩小不到25%，自觉症状好转不满半年或病情恶化者为无效。30例中显效3例，占10%，有效9例占30%，无效18例，占60%，总有效率40%。

崔开贤 针刺治疗食道癌、胃癌30例的临床观察 中国针灸(2)；7,1987

2. 溃 疡 病

经穴埋线法

选定胃俞、中脘、足三里穴位后，用龙胆紫标明。局部常规消毒，按外科无菌操作，用2%奴夫卡因作浅层局麻，皮丘大小约2厘米左右，用三角皮针穿1号肠线，从局麻皮丘处进针，经穴位深层肌肉组织穿过穴位，从穴位另一端出针，然后剪断两端露在皮外的线头，把肠线两端埋入皮肤内，清除积血，用无菌敷料包扎伤口5至7天。一般一个月埋线一次，为一个疗程。根据病情需要，决定埋线疗程。肠线埋入穴内后，7天内局部不要沾水，以防感染。大部分患者埋线1至5天内，上腹部出现疗效反应，但一般不需要处理可自行消失。如有上腹部疼痛加剧者，可给口服阿托品或普鲁本辛等药物。在埋线期间，禁服对胃有刺激性的药物或食物。

症状与体征恢复后，经X线钡餐或纤维胃镜复查证实炎症和溃疡面消失或仅留疤痕者为治愈。炎症和溃疡面缩小二分之一者为明显好转。炎症和溃疡面缩小三分之一者为好转。炎症和溃疡面无改变者为无效。本组500例中，治愈332例（占66.4%），明显好转81例（占

16.2%)，好转58例(占11.6%)，无效29例(占5.8%)。总有效率为94.2%。

魏金奎等 经穴埋线治疗慢性胃炎及溃疡病500例 北京中医(1)，46，1991

羊肠线穴位埋藏法

1. 羊肠线埋藏穴位：中脘透上脘，胃俞透脾俞（双侧）。

2. 操作方法：常规皮肤消毒，用1~2%普鲁卡因分别在上脘上1厘米处和中脘下1厘米处作一皮丘，将1号羊肠线（双线）用大号直三角针从中脘皮丘处进针，穿至上脘皮丘处出针，将羊肠线埋藏在皮下、腹白线以上（穿线时患者有胀感）。然后消毒皮肤，纱块复盖，胶布固定。患者改俯卧位，在背部的胃俞至脾俞部位照上法再行羊肠线埋藏。

共治疗43例。有效：经治疗后，三个月至半年胃脘无疼痛，无嗝气反酸，但胃脘仍有压痛者。

显效：经治疗后，半年至一年胃脘无疼痛，无嗝气反酸，胃脘有轻度压痛者。

痊愈：经治疗后，胃脘一直无疼痛，无嗝气反酸，胃脘部无压痛，钡餐或纤维胃镜检查正常者。

无效：经治疗后，疼痛无缓解或加重。

在羊肠线穴位埋藏的43例患者中，总有效率74.4%。其中：有效5例，显效6例，痊愈21例，无效11例。在36例球部溃疡中，31例有效，占86.1%。其中：有效4例，显效6例，痊愈21例，无效5例。

王茂祥 羊肠线穴位埋藏治疗溃疡病43例 北京中医(6)，83，1989

针 灸 法

主穴取中脘、章门、胃俞、脾俞。脾胃虚寒型配足三里、三阴

交，偏虚寒疼痛者取中脘、足三里，加艾条熏灸，配用黄芪建中汤加减；脾胃不和型偏火郁者配阳陵泉、期门、大陵，偏气滞者配足三里、行间。住院患者每天治疗1次以上。两组主穴交替使用。针刺手法均用提插捻转补泻。每次留针30min，50天为1个疗程。

共治疗40例。1.临床疗效标准：基本痊愈：症状基本消失，观察2个月未发；显效：主要症状消失或大部分消失，如疼痛、嘈杂、胀闷、泛酸；有效：症状有所减轻；无效：症状基本无改善。

2.胃镜观察标准：痊愈：溃疡面从胃镜下消失或处在愈合中；显效：溃疡面缩小1/2以上者；有效：溃疡面有所缩小，但在1/2以下者；无效：溃疡面大小与治疗前后相同或扩大者。

临床疗效中，基本痊愈29例，显效8例，有效2例，无效1例，有效率97.5%；胃镜疗效中，痊愈12例，显效6例，有效4例，无效8例，有效率80%。

孙 静等 针灸治疗消化性溃疡40例 陕西中医 (3); 130, 1991

3. 慢性浅表性胃炎

子午流注纳甲法

根据“子午流注逐日按时定穴歌”，依病人来诊时辰按时取穴，不配用其它腧穴。针刺得气后，行平补平泻手法（井穴除外），然后接通G—6805电针仪，用频率为120次/分的连续波形，电流大小以患者能忍耐为宜，通电20分钟。10次为1疗程，每日1次，疗程中间不休息。若坚持治疗2个疗程者，可在第2疗程结束后休息3天或停止治疗。

共治疗31例。临床治愈：胃脘疼痛消失，胃脘无任何不适，并在治疗过程中无反复者，共13例。显效：胃脘疼痛消失但稍有胃脘不适，或在治疗过程中，因饮食不当而诱发轻微的胃脘疼痛和不适。

者，共12例。好转：胃脘疼痛发作次数减少和持续时间变短及疼痛程度减轻并时有主症消失者，共4例。无效：主症改变不明显或加重者，共2例。

周章玲等 子午流注纳甲法治疗慢性浅表性胃炎31例临床观察
中西医结合杂志 (2); 94, 1991

4. 慢性胃炎

时辰针刺法

每天早晨7~9点针刺双侧足三里。根据中医辨证分为三型，①肝胃不和(28人)用泻法，留针15~30分钟；②脾胃虚寒(36人)用补法加温针，留针30~60分钟；③胃阴不足(4人)，先泻后补，留针30~60分钟。一般一日一次，15次为一疗程，疗程间停5天，症状消失后连续观察3个月。

共治疗68例，近期治愈28例，上腹疼痛，脘部胀满，脘部压痛，食欲欠佳，嗳气五项主要症状完全消失，三个月内未复发者；显效20例，上述主要症状减轻，并有三项以上症状消失者；好转16例，主要症状减轻，有的症状消失；无效4例。总有效率为94.1%。

张连城等 辰时针足三里治疗慢性胃炎 四川中医 (2); 49, 1991

穴位注射当归注射液法

药用5%当归注射液2毫升(江西青峰制药厂生产)，注射时另加2%普鲁卡因2毫升作穴位封闭，主穴足三里、中脘、内关。每次注射左右两穴，轮流注射。取卧位，局部常规消毒后，以6½号针头刺入，待有针感后缓慢注射。隔日1次。10次为1疗程，疗程间隔时间为7~10天。

共有43例经用本法治疗，1个疗程即可见效，但经4~5个疗程后评定疗效，结果痊愈33例（均经胃镜复查，临床症状消失），有效8例（临床症状显著改善），无效2例。除2例局部疼痛和下肢酸麻外，其余无毒、无痛、无副作用。

肖栎秀 穴位注射当归注射液治疗慢性胃炎43例 湖北中医杂志 (3); 39, 1989

针 刺 法

取中脘、足三里（双）为主穴、施平补平泻手法。肝气犯胃型加内关、阳陵泉以疏肝和胃，刺用透天凉泻法；脾胃虚寒型加脾俞、胃俞以温中散寒，刺用烧山火补法。每10分钟行针一次，留针30分钟。每日针一次，10次为一疗程，休息两天，再进行第二疗程。

共治疗20例。1.疗效标准：症状消失，胃镜检查正常者为痊愈；症状消失或部分症状消失，胃镜检查接近正常者为显效；症状改善，胃镜检查胃粘膜炎症病变较前好转者为有效；症状未见好转，胃镜检查胃粘膜炎症病变未见改善者为无效。

2.治疗结果：痊愈6例，显效9例，有效5例。治疗次数最多者40次，最少者6次。按中医辨证分型，肝气犯胃型14例中，痊愈5例，显效6例，有效3例；脾胃虚寒型6例中，痊愈1例，显效3例，有效2例。按西医分型，浅表性胃炎10例中，痊愈3例，显效3例，有效4例；萎缩性胃炎10例中，痊愈3例，显效6例，有效1例。

孙学忠等 针刺治疗慢性胃炎20例的疗效观察 河南中医 (3); 30, 1988

5. 胃 下 垂

长针升提补益法

针具：28~30号、3.0~15.0寸长毫针。

取穴：主穴：升提1、升提2。配穴：百会、足三里、天枢、胃俞、脾俞。

操作方法：嘱病人平卧，穴位局部消毒，针体与皮肤表面呈30度角，快速将针刺入皮肤，进皮下大约3~5分许即将针放平，贴近皮肤表面，沿皮下顺直线经中脘透对侧胃俞或天枢穴，然后右手持针缓慢捻转，指下有滞针感后将针体缓慢上提60次，同时用左手轻压下腹部，向上轻推胃下极，使胃有向上牵拉感为得气。施手法1分钟，休息10~20分钟，反复2次即可。配合针百会、足三里、脾俞、胃俞、施补法，留针1小时，隔日或1日1次。20次为1疗程，休息3~7天。针后嘱病人卧床休息10~20分钟。

共治疗120例。治愈：临床症状消失，胃肠钡透胃下极上升至正常范围者。显效：临床症状消失，胃肠钡透胃下极上升2厘米以上者。好转：临床症状明显好转，胃肠钡透胃下极上升1厘米以上者。无效：临床症状及钡透所见均无明显改变者。

治疗结果 治愈33例（27.5%）；显效33例（27.5%）；好转51例（42.5%）；无效3例（2.5%）。总有效率为97.5%。无效3例均为合并胃、十二指肠溃疡者。

刘亚坤等 长针升提补益法治疗胃下垂120例 吉林中医药（8），23，1991

四

针 灸 法

1. 取穴分两组：第一组：中脘（直刺1.5~2寸，也可透下脘），感应：上腹部有抽胀沉重感。胃上穴（下脘旁开4寸，沿皮向脐中或天枢方向横刺2~3寸），感应：腹部发胀，脐部抽动，胃部有收缩感。足三里（直刺或向上斜刺，进针1.5~2寸），感应：酸胀感向下扩散至足背，向上扩散至膝上。

第二组：胃俞（微斜向椎体，进针1~1.5寸），感应：局部酸胀、麻、抽搐感。脾俞：同胃俞穴。百会（横刺，向前或向后，进针0.5~1.5寸），感应：局部胀痛。

上列两组穴位，每日一组，交替针刺，对中脘、胃俞穴除针刺外，可加用艾灸或拔罐，留针15~30分钟。加减配穴：兼肝下垂者加期门、肝俞。兼肾下垂者配肾俞、京门。兼胃、十二指肠溃疡者配公孙、内关、梁门。胃下垂较重者加刺气海、关元、肾俞。10次为一疗程，第一疗程每日针灸一次，第二疗程间日针灸一次。间隔疗程5~7天。

2. 功能锻炼：①腹式呼吸法：平卧、休息片刻，作腹式深呼吸10~20次，使腹壁随呼吸起伏，目的以增强膈肌升降功能，使腹肌收缩加强。②仰卧起坐法：平卧，全身肌肉放松，两足平伸，两手置于两腿外侧，离体1~2寸不用力，以自然姿势起坐至90度，然后再平卧，如此反复8~5次。③上肢运动法：平卧，向上伸直上肢，然后向前后左右方向活动5~10次，采用坐位，站立锻炼均可。

以上锻炼，按次序并根据本人情况选择锻炼方式和次数，以不感疲劳为度。

共治疗103例。痊愈：临床症状消失，钡餐透视胃位恢复到正常位置。显效：临床症状明显改善，钡餐透视胃下极回升3~6cm以上。好转：临床症状改善，钡透检查，胃下极回升不足2cm。无效：临床症状改善或无改善，胃下极回升不明显或无回升。

治疗结果 痊愈46例，显效31例，好转23例，无效3例，总有效率为97.1%。

全例功 针灸治疗胃下垂103例临床观察 陕西中医 (5), 205, 1988

针 刺 法

以中脘、天枢、气海、足三里为主穴，用热补法，留针10~20分钟。兼胃痛、恶心、呕吐的，配上脘、内关，用平补平泻法，留针20~30分钟。兼胃、十二指肠溃疡的，配巨阙、梁门、内关、公孙、脾俞、胃俞，用补法，留针10~20分钟。兼肝炎的，配期门、膈俞、肝俞，用平补平泻法，留针20~30分钟。

共治疗91例。症状完全消失，X线钡餐检查胃上升至正常位置，两个月后复查，未复发者为痊愈。症状基本消失，X线钡餐检查胃上升3厘米以上者为显效。症状明显好转，X线钡餐检查胃上升一厘米以上者为进步。症状无改善，X线钡餐检查胃未见上升及自行停诊者为无效。

91例中，痊愈者25例，占27.5%；显效者27例，占29.6%；进步者37例，占40.7%；无效者2例，占2.2%；有效率为97.8%。

孟昭敏等 针刺治疗胃下垂91例的临床观察 中国针灸 (1)，18，1986

穴位注射法

胃下垂2~4厘米者，用维生素B₁100毫克加10%葡萄糖液至8毫升，取双侧脾俞、肾俞、足三里及胃上1（上脘和中脘穴之间中心点）四穴，每穴注射上药液1毫升；胃下垂4.5~6厘米者，用维生素B₁100毫克加胎盘组织注射液至9毫升，取双侧脾俞、提托穴（脐前上节内4寸下5分处）、健胃穴（足三里下5分处）、肾俞及中脘穴，每穴注射1毫升。快速进针，得气后速推药，每日一次，10次为一疗程，休息3~5天可重新注射。

共治疗46例。本组病例经2个疗程治疗后，进行X钡餐透视检查，结果：显效（症状消失，X线钡餐复查胃角切迹上升到髂嵴连线水平以上者）38例；有效（症状基本消失，胃角切迹在髂嵴连线下1厘米以内者）5例；无效3例。

曾英书 穴位注射治疗胃下垂46例 湖北中医杂志 (1)，48，1988

针刺八脉交会穴法

取公孙、内关穴，用普通1.5~2寸长毫针，快速进针，提插捻转轻刺激，得气后留针30分钟，此间每隔10分钟行针1次。隔日针刺1

次，10次为一疗程。针后卧床休息2小时，并嘱患者每日进行仰卧起坐，锻炼腹肌数次。

共治疗36例。治愈：胃角在髂嵴连线以上，胃下极在髂嵴连线下6厘米以内，临床症状消失。计10例。

显效：胃下极上升3厘米以上，临床症状明显改善者。计7例。

好转：胃下极上升1~3厘米，临床症状好转者。计10例。

无效：胃下极上升不明显者。计9例。

何玉倍 针刺八脉交会穴治疗胃下垂 36例临床观察 江苏中医 (10), 13, 1989

6. 胃痉挛

针 刺 法

先取鸠尾穴，用30号2寸长毫针，使针柄与胸壁呈15°角，向下方进针约1.5寸，行捻转补泻约1分钟，继而取中脘穴，毫针垂直刺入穴位约1.5寸，行捻转补泻3~5次，然后将酒精棉球裹于针柄之上，用火柴点燃，加拔火罐，再取内关、足三里（均双侧）穴，分别刺入1寸或2寸深，行捻转，提插补泻各5次。以上4穴均留针30分钟。留针期间，每10分钟行针1次，中脘穴除外。每天治疗1次。

共治疗25例。针刺3次后，症状完全消失者17例，症状明显消失者6例，无效者2例。

王亚东 针刺鸠尾穴治疗胃痉挛 25例 浙江中医杂志 (2), 90, 1988

7. 膈肌痉挛

直刺膈神经加服呃逆汤法

1. 直接刺激膈神经 从颈部环状软骨上缘平开，至胸锁乳突肌

前缘处进针，直刺略偏向外方，当针至1.5~2寸时，可刺中膈神经或膈神经附近，然后接通电针仪，予低频脉冲电刺激，但需由小逐步加大，通电15~20分钟。

2. 针刺膈神经后加服呃逆汤。

呃逆汤组成及服法：生石决明先煎30克，柿蒂30枚，党参30克，水煎服 每日1剂，分二次或数次服用。

共治疗86例，用直接针刺膈神经后即刻（1小时之内）能止呃者38例，仍加服止呃汤7帖以巩固。即刻未能止呃者48例加服呃逆汤7帖，1周内呃止者35例，呃未止者13例，但呃逆程度均较原来减轻。

马瑞寅 针刺膈神经治疗呃逆86例 上海针灸杂志（2），15，1987

针 刺 法（一）

均以内关、中脘、足三里、膈俞为主穴，结合辨证配穴：

1. 胃中寒冷：加艾灸中脘。
2. 胃火上逆：加泻内庭。
3. 肝气犯胃：加泻太冲、阳陵泉。
4. 气逆痰阻：加泻丰隆、膻中。
5. 脾胃阳虚：加补脾俞、胃俞及艾灸气海。
6. 胃阴不足：加补太溪。

内关、中脘均采用进针得气后留针，间歇捻转的手法。足三里用1.5寸针，进针得气后催气上传至腹部，实证用泻法，（如不能气至病所，亦必须使之局部能有较强的针感）。膈俞穴用1寸针，进针得气后行强刺激捻转手法，持续行针1分钟后即出针。

其余各穴均按补泻要求施术，每日治疗一次，六次为一疗程，一疗程结束后，休息两天，继续第二次疗程治疗。

共治疗54例。痊愈：经治疗呃逆症状完全消失，追踪观察一周以

上无复发者为痊愈，共49例。

好转：经治疗后呃逆发作减少，伴随症状减轻，共3例。

无效：经两个疗程以上的治疗，症状无改善而停止治疗者，共2例。

梁东辉 针灸治疗顽固性呃逆54例疗效观察 广东中医学院学报 (4)；219, 1990

耳 针 法

主穴：膈、胃、肝、脾、交感。配穴：神门、皮质下、肾上腺。
共治疗47例，均经1~2次治疗后治愈。

刘淑兰 耳针治疗重症呃逆(膈肌痉挛)47例 中国针灸 (2)；46, 1987

针 刺 法 (二)

取双侧涌泉穴，仰卧位，常规消毒后，以26~28号1寸毫针分别快速刺入双侧涌泉穴，得气后行呼吸补泻手法之泻法，留针30分钟。

共治疗12例。治疗1次后呃逆控制者11例，2次控制者1例，其中个别病例有复发，用原法仍立即收效。

夏晓川 针刺治疗顽固性呃逆12例 湖北中医杂志 (5)；48, 1989

指 压 法

以常法选定内外关穴。患者站立取端坐位，掌面朝上，曲肘成90°，施术者面对患者，以双手拇指分别平放于患者左右手内关穴上，食指及中指分别置于外关穴及其下方，以中指托住双肘，然后再用拇指用力针压内外关穴，给以强度或中度刺激。同时，令患者作深呼吸。

吸运动，每次指针 3～5 分钟。一般患者可每天施针 1 次，个别患者可进行 2～3 次。

共治疗 30 例。施治后呃逆终止，症状消除者为痊愈；经 1 次或 1 次以上治疗，呃逆明显减少者为有效；经 5 次以上治疗，呃逆仍不能控制者为无效。

治愈 29 例（其中 1 次治愈者 12 例，2 次治愈者 8 例，3～4 次治愈者 5 例，5 次治愈者 4 例，有 2 例配合中药治疗），1 例无效。

黄景阳 指压内外关穴治疗膈肌痉挛 30 例 陕西中医 (1), 35, 1991

通气于天法

一、令患者张口深长呼吸；二、取膻中穴，针尖向上沿皮刺 3 分—2 寸，直至取效；三、取双列缺穴，向肘部斜刺 2—5 分，强刺激，直至取效；四、针刺制止呃逆后，可按发作规律的时间适当针刺内关、足三里巩固疗效，一日一次，三、五日即可。

共治疗 39 例。针刺后 5 分钟内呃逆停止 22 例；15 分钟内呃逆停止 16 例；1 例无显效，即止又发。总有效率为 97.4%。

陈高材 “通气于天”针刺呃逆 39 例 江西中医药 (2), 36, 1986

灸 法

取膈俞、脾俞、胃俞、中脘、足三里，用艾条各灸 5～10 分钟，穴位表面皮肤微现红晕为度，每日施灸一次。

共治疗 6 例。1 次治愈者 3 例，2 次治愈者 1 例，6 次治愈者 1 例，无效 1 例为胃火型患者。

冯春英 灸治呃逆 6 例 上海针灸杂志 (3), 44, 1987

按压睛明穴法

具体手法是用右手（左手亦可）拇食两指，分别按在两侧睛明穴上，力量逐渐加大（可稍加旋转），以患者能忍受为度，大约半分钟左右，呃逆即可缓解。

在所治疗的6例中，肝硬化2例，中风2例，胃癌1例，肝癌1例。

赵建平 按压睛明穴治疗危重病人呃逆6例 河南中医 (2), 40, 1991

8. 神经性呕吐

针 刺 法

1. 取穴：天突为主穴，内关、足三里为配穴。

2. 操作：病人采取正坐体位。常规消毒后，医者面对病人以押手食指尖轻按其胸骨切迹上缘，持手以寸长毫针顺贴食指爪甲沿胸骨柄后缘与气管前缘之间，垂直向下徐徐刺入天突穴约1.2寸深，行大幅度捻转，待病人咽部出现紧迫，胀闷感觉后，送针3~5分而留之。然后，依次取左内关，右足三里，按照常规刺入方法和进针深度，得气后，再施以平补平泻手法。术毕，主穴留针15分钟（但应随时查看病人是否保持正坐体位，针身有无偏向，以免发生意外情况），配穴留针30分钟。

3. 疗程：每天针刺一次，五次为一疗程。疗程之间休息二天。

治愈：呕吐休止，兼证消失，追访三个月未曾复发。

显效：呕吐偶发，兼证基本消失。

有效：呕吐与兼证有所缓解。

无效：治疗后，病情无好转。

治疗81例中，治愈63例，占77.8%，显效12例，占14.8%，有效

4例,占4.9%;无效2例,占2.5%。总有效率为97.5%。

李勇等 针刺治疗神经性呕吐81例 中医药学报 (6);27,1988

9. 急性胃肠炎

针 刺 法

嘱患者仰卧屈膝,取内庭、公孙、水分、中庭、曲池,直刺,得气后用迎随补泻法。留针30分钟,10分钟捻转一次。

共治疗210例。症状、体征完全消失者为治愈,症状、体征无明显改变者为无效。本组210例经1~3次治疗治愈201例,治愈率为95.7%,无效9例,为4.3%。

张玉璞 针刺治疗急性胃肠炎210例 中国针灸 (4);41,1987

水 针 法

采用注射用水作穴位注射,以天枢为主穴,发烧加曲池。注射时病人取仰卧位,皮肤局部消毒后,用4½~5号皮试针头,快速刺入穴位至肌层,并上下提插,待病人局部有酸、麻、胀感后,回抽未见血即注射,注射后即用拇指尖切水沟(即人中)1~2分钟,这样既可防止晕针,又可减轻病人的局部胀痛感。注射用水量为每穴注1~2毫升,每日2次。

共治疗203例。自觉症状、体征消失为痊愈,共185例;自觉症状改善,体征减轻者为好转,共9例;症状体征无改善者为无效,共9例。

张生理 注射用水注入穴位治疗急性胃肠炎203例 中国针灸 (3);22,1987

走 罐 法

1. 取穴:①足阳明胃经,中脘、天枢(双)、足三里(双)、

下巨虚(双)。②足太阳膀胱经,大肠俞、小肠俞。

2. 操作: 在火罐将要走行的经穴部位与火罐口的边缘涂上一层润滑油, 左手持罐, 右手拿夹有棉球的镊子, 蘸上95%酒精, 点火后插入罐内1~2秒钟迅速拔出, 左手熟练准确地将罐子扣在经穴上。腹部先在中脘穴上拔一个罐, 然后一手扶罐底, 一手扶罐体, 慢慢将罐子移向左侧天枢穴, 再以同样方法返回中脘, 移向右侧天枢穴。如罐内的吸力不够可重新拔上, 这样往返移动5~6遍, 待患者有一种暖和舒适感后, 固定在中脘穴上, 再在左右天枢穴各拔上一个罐, 约15~20分钟后取下。下肢在足三里穴上各拔一个火罐, 从上至下向下巨虚移动, 反复7~8遍, 然后固定在足三里穴上, 治疗全程15~20分钟。起罐后用右手掌面按在局部紫斑上, 轻柔按摩1~2分钟, 促使局部瘀血消散。中度以上急性胃肠炎12小时后可在第2组穴位上继续操作一次, 固定在大肠俞上; 轻度患者24小时一次, 不用第2组穴位。

共治疗52例患者, 50例治愈。其中轻度者11例, 治疗2次后, 症状消失; 中度者23例, 治疗2次后, 呕吐停止, 大便次数明显减少, 经治4次后诸症消失; 重度者16例, 经治6次后获愈。全部疗程3~5天, 无不适反应。其余2例因局部皮肤长有小疮, 不便走罐, 只是在穴位上拔罐, 加口服胃复安、黄连素, 静脉补液, 均于2天后症状缓解, 泻泄停止。

张傲清等 走罐法治疗急性胃肠炎 52 例疗效观察 江苏中医(5); 26, 1991

穴位注药法

足三里处常规消毒, 将抽吸维生素 K₃ 的注射器针头刺入足三里后, 边进针边捻转, 得气后, 将维生素 K₃ 注入, 每穴4毫克。每日一次, 每次两侧穴同时注入。

共治疗14例。一次痊愈2例, 2次痊愈9例, 3次痊愈3例, 总有效率为100%。

刘爱国 足三里穴注射维生素K₃治疗急性胃肠炎14例 中国针灸
(1); 23, 1986

10. 急性肠炎

穴位注药法

本组病例全部应用市售654—2注射液(北京制药厂)各1 ml 分别于双侧止泻穴位(踝关节背屈90°体位, 外踝尖垂直向下赤白肉际交界处即为止泻穴)注射治疗, 可根据病情每天1次或隔天1次注射。同时可根据脱水程度, 辅以补水和电解质。

共治疗42例, 治愈38例, 总疗程3~5天。

孙仕柱等 止泻穴注射治疗肠炎42例 陕西中医 (3); 131,
1991

11. 霉菌性肠炎

艾灸法

(一) 艾炷制备: 将陈艾叶、细辛以10:1的比例混合捣绒, 将艾绒放在平板上, 用手指搓捏成圆锥状, 其高为2厘米, 底直径为2厘米。

(二) 穴位: 取中脘、神阙、关元、天枢(双)、足三里(双)。

(三) 方法: 采用无瘢痕直接灸。先将施灸穴位涂以少量京万红软膏, 以增加粘附作用并可防烫伤, 再放上艾炷点燃, 当艾炷燃剩五分之二左右, 病人感到有疼痛时, 即更换艾炷再灸, 每穴灸五壮, 以局部皮肤充血起红晕为度。每日灸一次, 十次为一疗程, 疗程间休息三天, 一般灸一至四个疗程。二疗程结束后, 复查粪便, 霉菌阴性者

停灸观察，阳性者继续施灸。

(四) 疗效标准：临床症状消失，大便正常，粪便镜检三次霉菌均为阴性者为痊愈；临床症状消失，大便正常，粪便镜检霉菌时为阴性时有少许者为显效；临床症状减轻，大便每日三次以下，粪便镜检霉菌仍为阳性者为好转；临床症状无变化，粪便镜检霉菌多次为阳性者为无效。

(五) 治疗结果：59例患者经过一至五个疗程的治疗，其中痊愈32例，显效19例，好转8例，没有无效者。

张 正 艾灸治疗霉菌性肠炎59例临床观察 北京中医 (4)，38, 1988

12. 胃肠功能紊乱

穴位注药法

采用维生素 B₁、B₁₂、奴夫卡因混合穴位注射法治疗。主穴取足三里、中脘、胃俞或脾俞。腹胀者配气海；恶心嗝气者配内关；腹泻者配天枢。注射方法：先用 5ml 注射器抽吸维生素 B₁100mg、B₁₂250mg、1% 奴夫卡因 2ml 充分混合，以 6 号针头刺入消毒好的选定穴位，待有针感时将药液缓慢推入，每穴注射 0.5~1ml，每次选 3~5 个穴位，隔天1次，5 次为 1 疗程。

共治疗80例。治愈：临床症状全部消失，食欲明显增加，睡眠良好，体重增加；显效：症状基本消失，食欲增加；好转：症状减轻，食欲增加；无效：症状无明显改变者。

治疗结果 治愈59例，显效14例，好转6例，无效1例，总有效率98.75%。

杨淑苓 穴位注射治疗胃肠功能紊乱80例临床观察 陕西中医 (11)；516, 1990

13. 慢性结肠炎

针刺和经穴灸疗仪照射法

1. 针刺：取穴：中脘、天枢（双）、气海、足三里（双）、三阴交（双）、公孙（双）。手法：平补平泻，留针 15min，每日 1 次。12 次为 1 疗程。2. JJY—1 型经穴灸疗仪穴位照射：神阙、天枢、大肠俞、胃俞、脾俞等穴。在选好的俞穴上涂一些艾油，然后将灸头对准穴位并固定好，打开机器开关，灸头发亮，温度逐渐上升至患者感到温热为宜，并根据患者对温热的感受程度，选择照射时间，一般每穴照射 15~30min，每日 1 次，12 次为 1 疗程。

共治疗 82 例。痊愈：临床症状消失，大便成形，便次正常，食欲较好，体重明显增加，粪便镜检连续两次阴性，结肠镜检查肠粘膜皱壁表面光滑，钡剂灌肠无钡剂停留。好转：临床症状明显改善，大便基本正常，粪便镜检有少量上皮细胞或脓球，结肠镜检查肠粘膜轻度充血，溃疡面消失或变浅，钡剂灌肠示肠粘膜微粗糙，或有较小充盈面。无效：治疗前后临床症状及粪便结肠检查均无明显改善。

治疗结果 痊愈 62 例（75.61%），好转 20 例（24.39%），82 例患者全部有效。治疗时间为 2~5 个疗程。

聂汉云等 针刺和经穴灸疗仪照射治疗慢性结肠炎 82 例 辽宁中医杂志（8），28，1988

14. 急性腹泻

艾 灸 法

将艾叶搓绒，做成 16 个似鸽蛋大小圆锥形堆，备适当精盐。咐患者仰卧屈膝。急性腹泻用盐填神阙、关元，稍高于皮肤 2mm，直径

大于艾底平面，点燃艾炷，分别放于两穴。待患者感到灼热时，另换艾炷，如此，每穴灸 8 壮，每天 1 次。急性一般 1～2 次即愈。

共治疗 58 例。急性经灸治 1～2 次，大便正常，临床症状消失，观察随访 10 天，无复发者为痊愈；经灸治 2 次，大便次数减少，临床症状明显改善或消失，偶有复发者为有效；经灸治 2 次以上，症状无明显改善，需用其它方法治疗者为无效。

治疗结果 急性 58 例，痊愈 51 例，有效 4 例，无效 3 例。

彭光连 艾灸神阙关元治疗急慢性腹泻 64 例 陕西中医 (1)，36，1991

15. 慢性腹泻

针 刺 法

取天枢、上巨虚穴，手法采用提插、捻转补法，得气后留针 30 分钟，每日 1 次，以 6 次为一个疗程。

共治疗 35 例。痊愈为便次减少至每日 1 次，大便成形，腹痛缓解；好转为便次减少或腹痛减轻。无效为治疗后症状无改善。

近期疗效：痊愈 24 例，占 68.6%，有效 11 例，占 31.4%，总有效率为 100%；

远期疗效：全部病例均进行了半年至 2 年的随访。治愈有效者（35 例）中，有 1 例复发，为 2.9%。

王富春等 针刺治疗功能性腹泻的疗效分析 江西中医药 (6)，48，1990

电兴奋配合穴位法

1. 电兴奋：患者取仰卧位，要求病人腹肌放松。采用 EGL-1 型直流感应电流机感应电位部分，两个圆形点状手柄电极，直径 4 厘米，

用六层纱布包好，温水浸湿，在腹部并置，沿降结肠至乙状结肠，用强感应电流移行通电 5 分钟，继后断续通电 2 分钟，最后在腹部与下肢穴位（天枢、气海、足三里）配穴使用 2—3 分钟，电流强度缓慢增加，感应电流以能引起肌肉明显节律性收缩，自感舒服为宜。每次一般不超过 15 分钟。2. 超短波透热疗法：电兴奋治疗完毕，休息 10 分钟后行超短波治疗。采用北京产 66—4 型超短波电疗机，功率 800 瓦，频率 40.68MHZ，波长 7.73 米，大号电极于腹部前后对置，间隙 3.4 厘米，微热量，每次 15 分钟。两种治疗方法，每日各 1 次，15—20 天为 1 疗程。

疗效：16 例患者中痊愈 13 例，显效 2 例，进步 1 例。

唐瑜震 电兴奋配合穴位治疗慢性腹泻 16 例 江苏中医 (2)，10，1988

针 灸 法

选用 32 号 1.5 寸毫针，取天枢、关元、足三里、三阴交、太溪、公孙、关元，天枢用附子饼作间接灸，每次 2 壮，留针 20 分钟，每周 3 次，每 10 次为一疗程。

一、脾胃虚弱型：治为健脾温中。取穴：天枢、关元、足三里、三阴交、公孙。

二、肾阳不振型：治以温养脾肾。取穴：天枢、关元、足三里、三阴交、太溪。

共治疗 20 例。痊愈：大便每日一次，粪质坚实成形。

好转：大便次数减少，每日不超过 3 次，粪质松而易化，偶有反复。

无效：治疗 3 个疗程以上症状无改善，或因故中止治疗。

痊愈 7 例（占 35%），好转 9 例（占 45%），无效 4 例（占 20%），总有效率为 80%。

王世惠 针灸治疗慢性泄泻 20 例 上海针灸杂志 (4)，14，1987

附：五更泄

针 刺 法

主穴：天枢、中脘、足三里；配穴：属酒积者加水分、膀胱俞；食积者加建里、脾俞；肝火者加期门、肝俞；肾虚者加命门、肾俞。

手法：肾虚者采用捻转补法为主，或可加灸。其余各型均采用大幅度的捻转泻法为主。留针20~30分钟，每日1次，以6次为1疗程，隔日进行下一疗程。

共治疗70例。症状与体征完全消失者为痊愈，共64例，占91.4%；症状与体征基本消失，但易复发者为好转，共5例，占7.2%；治疗1疗程后，症状与体征无任何改善者为无效，共1例，占1.4%。总有效率为98.6%。

王富春 针刺辨证治疗五更泄70例疗效观察 陕西中医 (9)，417, 1988

16. 便 秘

耳 压 法

主穴：大肠、便秘点、脾、直肠下端；配穴：热秘加耳尖、肾上腺、热点等穴，气秘加肝、交感；虚秘加肾、小肠、脾；冷秘加肾、肾上腺。

主穴每次3个，配穴2个。治疗时先用探针在所选穴区探查，找到敏感压痛点后，划点为号，然后把粘有王不留行籽的0.5cm的胶布，对点准确地贴压在敏感点上，嘱患者每天每穴按压5次，每次4分钟左右，隔天换贴1次，7次为1个疗程。

共治疗134例。大便每天1次，粪便稀软，便时畅利，其它兼症消失，1年内无复发为痊愈；大便每天1次，粪便成条畅利，其它兼症大部分消失，半年内无复发为显效；大便2天1次，兼症部分消失为有效；大便无明显变化为无效。

治疗效果 治愈93例，显效29例，有效7例，无效5例，总有效率96.3%。耳压最少2次，最多16次，平均7次治愈。

耳压组最早4小时排便，耳压1天后27例排便，占总例数的20%；

潘纪华 耳压法治疗便秘 134例临床观察 陕西中医 (9)，416，1989

耳 针 法

取穴：便秘区、交感。燥热配耳尖（放血），气泄配肝，阴寒固结配脾、肾，气虚血少配肺、心。

操作：常规消毒耳廓，用28或30号0.5针由后向前平刺便秘区，其他诸穴依部位不同给予斜刺或直刺，留针40分钟，每10分钟捻转行针1次。隔日针1次，连针3次。

共治疗33例。本组患者全部仅经针刺1次而大便顺利解下，大部分在针后3至5个小时获效，最短不到10分钟最长13个小时。

张耕圃 耳针治便秘 33例 上药中医药杂志 (2)，29，1987

穴位埋线法

取穴：选大肠经的“下合穴”上巨墟、“俞穴”大肠俞、“募穴”天枢为主穴，部分病例配以调理脾胃运化功能的足三里、三阴交穴。

方法：通过9号腰椎穿刺针，将000号2厘米长之医用羊肠线垂直植入上述诸穴内，每隔15~30天可以重复埋线一次，以巩固疗效。

本组病例埋线 1 ~ 2 次者共 18 例，最多者达 8 次。

共治疗 29 例。埋线治疗后能保持正常排便 10 天以上者为近期有效，否则为无效。保持正常排便 3 个月以上者为远期有效。

近期疗效观察：本组 29 例于埋线治疗后 48 小时内排便者 25 例，于第 4 天排便者 3 例。此 28 例均能保持正常排便 10 天以上。无效 1 例为先天性巨结肠症患者。全部病例于埋线治疗后，均有肠蠕动及便意增强的效应。

远期疗效：对近期有效者 11 例进行了 3 个月 ~ 2.5 年的随访观察。便秘病程 4 ~ 29 年，其中埋线治疗 1 ~ 2 次者 8 例，3 ~ 6 次者 3 例。随访 11 例均能保持疗效。

林蕙兰等 穴位埋线治疗顽固性便秘 中医杂志 (10) ; 49, 1987

17. 老年习惯性便秘

温针灸法

其法是天枢穴取双侧，每穴温针灸 4 艾段，每段艾长 2.5 厘米。时间约 30 分钟后起针，再过 30 分钟左右排便。每日 1 次，10 次为 1 疗程。

所治 33 例中 27 例痊愈（大便通畅，且随访半年以上无复发），4 例有效（治疗过程中大便通畅，治疗后又复发），2 例无效（治疗过程中大便通畅不超过 3 天）。

姜旭强 天枢穴温针灸治疗老年习惯性便秘 33 例 浙江中医杂志 (8) ; 372, 1989

18. 习惯性便秘

耳压法

取穴：一般取大肠、直肠、腹、艇中。久病体弱、年老或产后者

加脾胃、内分泌、皮质下。按压手法要轻。实证加肺、三焦。按压手法要重。用探棒按压所选穴位，找出最敏感点后，在此穴按压中药王不留行。5至7天换1次。换压耳穴前的两天嘱患者自行取掉，以免造成耳廓骨膜炎。每次取双耳。

共治疗53例。贴压5次以上，大便通畅，停止治疗2月以内大便保持正常者为基本痊愈，贴压过程中大便通畅，停止治疗后复发者为显效，贴压后只在3天内大便正常者为有效，贴压耳穴两天大便无变化者为无效。

基本痊愈12例，显效24例，有效12例，无效5例，总有效率90%。

宋君惠 耳压法治习惯性便秘53例 中国针灸 (4), 14, 1987

19. 肝硬化

中药穴位敷贴法

根据健脾补肝肾、破血祛瘀的治则，方由黄芪、当归、熟地、柴胡、桃仁、三棱等中药组成，根据药典炮制方法而制成外用膏药，膏药摊在 $8 \times 8\text{cm}^2$ 不吸水的棉纸上，敷贴在期门、神阙穴，伴腹水者另加甘遂末1克。每天换药1次，共观察3个月。患者做自身对照。

共治疗34例，治疗前后情况如下：

1. 治疗前后主要症状和体征的变化

患者中药穴位敷贴1个月后，腹胀、肝脾区胀痛、纳差症状缓解，继续治疗2个月后，上述症状基本消失，乏力、腹水、牙龈出血、鼻衄等症状明显好转。

2. 治疗前后对肝功能的影响

患者治疗后血浆白蛋白略有升高，经统计学处理差异不显著（ P

>0.05)。34例中10例治疗后血浆白蛋白增高0.5克%，最高增加1.7克%。血浆球蛋白治疗前后差异显著 ($P<0.05$)。由于白蛋白略升高，球蛋白下降，白球蛋白比值由1.1:→1.3:1。 γ -球蛋白治疗前5例正常，29例异常，治疗后有13例正常，经四格表精确检验法统计 ($P<0.025$)。麝油 and 锌油各观察了22例，麝油治疗前无1例正常，治疗后有9例恢复正常，经四格表精确检验法统计 ($P<0.001$)；锌油治疗前2例正常，治疗后有7例正常，经四格表精确检验法统计 ($P<0.025$)。说明中药穴位敷贴可改善肝炎后肝硬化患者的肝功能。

3. 治疗前后补体 C_3 和血小板的变化

C_3 共观察30例，其中4例 C_3 治疗前大于145mg%，不作观察对象，26例 C_3 由治疗前 90.2 ± 16.9 上升到治疗后 101.9 ± 24.2 mg%。另观察20例正常人为 131.6 ± 13.2 。血小板共观察31例，治疗前13例正常，18例低下者由治疗前 8.03 ± 1.5 上升到治疗后 12.4 ± 4.9 万/mm³。说明中药穴位敷贴对肝炎后肝硬化患者的血小板和补体 C_3 有影响作用。

黄琴峰等 中药穴位敷贴治疗肝炎后肝硬化临床研究 上海中医药杂志 (3)，17，1991

第三节 呼吸系统疾病

1. 感 冒

腧穴走罐法

令患者仰卧或座位上伏案，光露背部，沿着膀胱经的循行线抹上麻油。然后取中号拔火罐一只，用闪光法把罐吸在患者背部，沿太阳

膀胱经循行线上下来回走罐多次，直到循行线上的皮肤出现潮红为度，四条循行线均应走罐。接着可把罐停在大椎穴上，留罐5分钟，最后用草纸把麻油擦尽。若能加灯芯草灸风池、肺俞则疗效尤佳。

共治疗26例，均经1~3次治愈。

陈石 膂穴走罐法治疗感冒26例 浙江中医杂志 (8), 378, 1988

附：发 热

针 刺 法

取俯卧位，选准穴位常规消毒，以华佗牌28号2.5寸毫针，于下午3时整针刺，室温 $32\sim 26^{\circ}\text{C}$ ，但同一患者在针刺前后观察时间内，室温变化小于 0.5°C 。深刺：针经皮肤、皮下组织，针尖微斜向上穿过深筋膜、棘上韧带、达棘间韧带深处接近黄韧带后，做小幅度捻转，一息10次，并用力提针。患者先觉肩背部酸沉，继之出现沿督脉的感传，大部分病例针感可至大腿和上臂部，此时，立即出针。

共治疗36例。深刺在针刺出针后均见手掌湿润。15分钟时，深刺患者均见周身汗出，深刺患者体温都有所下降。针刺前体温 $39.9\pm 0.58^{\circ}\text{C}$ ，针刺后15分钟体温 $38.2\pm 0.38^{\circ}\text{C}$ 。

李澎涛 大椎穴深浅刺法的退热效应研究 山东中医杂志 (4), 17, 1989

附：太阳中风

针 灸 法

主穴：大椎、风门、合谷、复溜、足三里。

方法：先用火罐拔大椎、风门，留罐5~10分钟，以皮肤呈紫红色为度；再针补复溜、足三里，针泻合谷。视患者得气程度，掌握刺激量，并根据症状缓解程度，留针5~20分钟。

临证加减：1.汗出多者，加针补阴郄，汗漏不止者，用米粒大的艾柱加灸太溪7壮；2.头痛明显者，加针风池；3.初诊针刺后缓解，次日复作且心烦者，加刺风池、风府；4.发热在39℃以上者，加针泻曲池；5.兼项背强几几者，加针新设（风池穴直下5厘米，督脉旁开3.3厘米处）；6.兼咳喘者，加针孔最及膻中拔罐；7.凡既往反复发作者，在太阳中风证罢后，用化脓灸法灸风门、肺俞、膏肓、足三里；8.兼腹泻者，加神阙、天枢拔罐。

共治疗42例。本组经施治1~3次后，除3例针感不佳无效改服汤药外，其余39例均有不同程度的即时效应，即在针灸后10~30分钟症状显著缓解或全部消失。经第1次针治后症状消失者16例，经2次针治后症状消失者18例，经3次针治后症状消失者5例，总有效率为93%。31例既往易反复发作者，经加化脓灸法后，又经6个月~1年随访，未复发者25例，偶有复发但症状减轻者4例，仍反复发作如前者2例。以上提示，针灸治疗太阳中风有较好的疗效；症状消失后加用化脓灸，对预防虚人感冒亦获有意义的苗头。

焦 焰 针灸治疗太阳中风42例疗效小结 湖南中医杂志 (3), 24, 1991

附：外感咳嗽

双针一罐法

“双针一罐疗法”是由三棱针、梅花针和可调式吸罐器合一的治疗方法。融三者之功效为一体，这样就大大提高了治疗效果。其具体治疗方法如下：

1. 先用酒精棉球消毒太冲、少商、丰隆、风门穴，然后用三棱

针在以上穴位点刺微出血。

2. 用梅花针叩刺大椎、膻中、肺俞穴，然后用可调式吸罐器拔出血。

3. 每日1次，3天为1疗程，一疗程未愈者停2天继续治疗。

共治疗170例外感咳嗽患者。1疗程痊愈者115例（占67.64%），2疗程痊愈者15例（占8.3%），3疗程痊愈者9例（占5.23%），3疗程以上者，配合中西药物治疗痊愈者29例（占17.07%），无效者2例（占1.19%）。

黄再军 双针一罐治疗外感咳嗽170例小结 江苏中医（6），30，1991

耳穴压迫法

主穴：肺、大肠、神门、对屏尖。配穴：咳嗽频繁加下屏尖、内分泌、支气管；痰多加肺、口；发热加耳尖放血；胸闷胁痛加下屏尖、胸；咽喉痛加咽喉、扁桃腺；鼻塞加外鼻、内鼻；过敏性、刺激性咳嗽加结节内、内分泌。用王不留行子贴压，2~3天更换，每日按压3~5次，每穴2分钟。一般换1~2次即可，为巩固疗效可换3~5次。

共治疗36例。25例显效（3天内咳嗽消失），9例有效（3天内缓解，7天内咳嗽消失），2例无效。获效快的，按压5分钟左右即使咳嗽减轻。

黄静国等 王不留行贴压耳穴治疗咳嗽 36例 浙江中医杂志（12），536，1988

2. 哮喘

穴位埋藏兔脑垂体法

1. 操作：取当年达1.5公斤，未生育、交配（公母不限）的活家兔1只，于耳背静脉注射空气使其气栓死亡，即作头颅正中分离，

用75%酒精消毒，作头颅正中切开，取垂体（勿破碎）置于消毒盘内备用。即作患者穴位皮肤消毒，用2%副肾素并普鲁卡因5ml作浸润麻醉，切口约1.5~2cm，取部分皮下脂肪，再埋入兔脑垂体，缝合包扎，7天拆线。视病情可连续2~3次，并加定喘穴（双）埋80号羊肠线。

2. 取穴：主穴膻中，配穴定喘（双）。

本法适用于各型哮喘。但患有重度肺气肿，肺结核活动期，心脏病，高血压，孕妇及7岁以下幼儿均不宜用本法治疗。禁忌有：终身不食兔肉，当年忌生冷、酸辣、刺激气味，鲤鱼、公鸡、牛肉及交配与产仔的公、母猪肉。

共治疗600例。治愈：不需任何药物，保持无症状，体征达1年以上者；显效：偶用支气管舒张药物或不用药物能自行缓解喘息者；有效：喘息症状有所减轻，次数减少，但有时仍需药物治疗者；无效：治疗后症状、体征无变化。

治疗结果 本组2年后进行随访评定：临床治愈179例（29.8%），其中外源型127例（39%），内源型52例（19.6%）；显效216例（36%），其中外源型122例（37.5%），内源型94例（34.1%）；有效157例（26.1%），其中外源型91例（28%），内源型66例（24%）；无效48例（8%），其中外源型25例（7.6%）内源型23例（8.31%）。总有效率为92%。

半年后，复查痰中嗜酸细胞。结果：治疗前30例平均值为148.5，治疗后30例平均值53.4。（用高倍镜每片选择均匀的区域计数3个视野的平均值计算）。嗜酸细胞治后比治前显著下降，说明具有一定的脱敏作用。

蔡永良 穴位埋藏兔脑垂体治疗哮喘600例 陕西中医（12）；
552, 1989

穴位贴药法

1. 穴位：定喘（双）、肺俞（双）、膏肓（双）、膻中。痰多

者加丰隆（双）、肾虚者加肾俞（双）、脾虚体弱者加脾俞（双）、足三里（双）。

2. 药物制备：白芥子33%，细辛17%，元胡33%，甘遂17%，按比例混合，研为细末备用；六神丸2支研末备用；生姜适量，用时捣烂取汁。

3. 贴药方法：首先将四味混合药末用生姜汁调和后摊在油纸上，做成直径为4厘米，厚度为0.8厘米的小饼，再将六神丸粉末（每次2/3支量）均匀按压在药饼中心处，然后将药饼贴在事先选准的穴位上，用胶布固定。于每年夏天的初、中、末三个“伏天”各贴一次，每次药贴3至6个小时。

共治疗347例。经穴位贴药后一年进行观察随访。患者在二年以上，在原先哮喘病好发季节未见发病，且肺部听诊哮鸣音消失者为治愈；患者虽有发病，但临床症状、发作次数显著减轻、减少，发病时听诊哮鸣音亦明显减轻者为显效；患者虽有发病，但发病时的临床症状和发作次数减少，且哮鸣音亦有所减轻者为好转；若临床症状和体征均无改善，仍经常发病者为无效。

结果：347例中，治愈90例（占26%），显效119（占34.3%），好转101例（占29%），无效37例（占10.6%）。总有效率为89.3%。其中年龄较大，病程较长的效果较差。

姚云任等 穴位贴药治疗347例哮喘病疗效观察 河南中医（4），40，1988

针刺埋针法

针刺

1. 主穴：定喘、太渊，视病情轻重取单侧或双侧，一般以右侧为主。

2. 操作方法：令患者以“俯伏式”坐位，舒适为度。用 $\phi 0.26$ 毫米或0.32毫米不锈钢毫针为宜。取定喘穴时，针尖向脊椎下斜刺1寸左右，太渊穴直刺5分左右（针感放射至胸部则疗效显著）。每次

针刺得气后，留针15~20分钟，每隔5分钟捻转1次。二穴均以平补平泻手法。

3. 配穴：风寒者，加风池、风门，用泻法以解表散寒；风热者，加大椎、合谷，用泻法以宣肺泻热；肺虚者，加膻中、偏历，用补法以补肺平哮；肾虚者，加肾俞、太谿，用补法以补肾纳气。此外根据不同症状，随症加减取穴，灵活掌握。

4. 疗程：每日针刺1次，连续10次另加埋针1次为1疗程。

埋针

1. 取穴：肺俞、中府（均取双侧）。

2. 操作方法：先将穴位和图钉型（或麦粒型）皮内针用75%酒精进行常规消毒，然后用持针器挟住针柄，将针尖以15~25角度斜刺入穴内3~5分深，针柄贴皮肤上用胶布固定。

3. 留针时间：春季3天，夏季2天，秋冬季3~5天。在埋针期间，嘱患者每日用手指按压局部数次，以增强针感，提高疗效。

4. 注意事项：夏季埋针时间不宜过长，一般不超过两天，以防感染。并嘱患者在埋针期间要保持局部清洁，不要沾水。

共治疗196例。经治1疗程，诸症消失，能坚持工作，1年之内未复发者为显效，共82例。经治1疗程，诸症消失，能坚持工作，1年之内复发次数和程度均减轻50%以上者为有效，共101例。经治1疗程，症状基本消失，1年之内复发次数和程度减轻不足50%者为无效，共13例。

王全树 针刺结合埋针治疗哮喘 196例临床观察 北京中医
(2), 39, 1988

割脂法

肥皂水洗净两手，两手掌心向上并排放在手术台上，用2%碘酒及75%酒精消毒掌二穴或掌五穴，无菌洞巾遮盖。术者带无菌手套，以2%普鲁卡因4毫升加0.1%肾上腺素1毫升（儿童酌减）局麻穴位。左手绷紧手术部位皮肤，右手持刀在穴位上做纵行切口，长约1

厘米，深约0.5厘米，弯剪将溢出的脂肪剪除1克左右（根据患者脂肪的多少而定），再用弯止血钳伸入刀口深处，夹两三次深部软组织至病人有酸麻胀，感觉通往前臂及手指，缝合皮肤，敷消毒纱布，胶布固定。同法做另一手。七天拆线。

术后用药及注意事项

1. 刀口保持清洁、可疑感染点0.25%氯霉素眼药水。
2. 术后两周内特别注意防止呼吸道感染，可用3~5天常规量青、链霉素。使用激素患者勿骤然停药，症状重者可加适量激素并服中药。寒痰症病人可配合服哮喘片（北京中药厂出品，含红信石），夏季停服。

3. 严格忌口一年，避免接触、吸入和食用易引起过敏的物质。

中医辨证施治原则

在割脂疗法同时，各类型哮喘仍按辨证进行治疗。痰热证宜清热化痰平喘，用麻杏石甘汤、千金苇茎汤、葶苈大枣泻肺汤加减。寒痰证宜温肺、豁痰平喘，取小青龙汤或紫金丹、哮喘片。久郁痰阻证宜降气开郁、豁痰平喘，用苏子降气汤合二陈汤加减。有兼证者，如表寒、表热、暑热、里虚证（阴虚、气虚、阳虚）和淤血证也当兼顾治疗。

共治疗100例，两年以上未复发者84例，症状不缓解者仅一例。

5~15岁儿童可根治。

陈文孝 割脂治疗哮喘100例 山东中医学院学报（2）；27，
1988

热 针 法

1. 选穴：主穴：定喘、风门透肺俞。配穴：外感风寒取合谷、列缺；喘促取天突、孔最、痰多取足三里、丰隆、气短取关元、膻中，咳嗽取尺泽、太渊。

2. 针法：主穴交替选用，采用1.5~2寸热针，应用GZH型热针仪，热针温度指示40~70℃。配穴采用一般毫针，用提插捻转平补

平泻法，留针20分钟。哮喘发作时每日治疗一次，听诊哮鸣音消失后改为隔日一次。六次为一疗程，休息3~5天，继续下一疗程。

3. 辅助治疗：风寒、痰火型哮喘针后在大椎、风门、肺俞等穴交替拔罐。部分患者配用了药物小剂量穴位注射：药物有喘定注射液、硫酸链霉素加普鲁卡因注射液或醋酸强的松龙注射液，主要取天突、内关、膻中、魄户等穴。每次1~2穴。

共治疗64例。显效：哮喘停止，能参加劳动或工作，随访半年以上未复发；好转：症状改善，发作次数减少，但未完全停止；无效：病情无明显变化。经治疗1~2个疗程，显效38例，好转24例，无效2例。

管遵惠 热针治疗哮喘64例临床观察 中国针灸 (1); 11, 1987

三针一罐法

(一) 针刺取穴：大椎穴，孔最穴。

(二) 操作方法：患者取坐位，抬头，目向前方，曲肘仰掌。三穴进行常规消毒，取1寸或1寸半的毫针，用75%酒精消毒，先取大椎穴向上斜刺2~3厘米，使之得气（要求有沉麻感觉，并向颈、胸、腰椎方向传导）后，不留针，以闪火法拔上火罐。再取孔最穴进针1~2公分，得气后针感要求呈双向传导（向下传至拇、食指端，向上传至胸部，即气至病所）。提插捻转角度在90~180之间，刺激频率为100~160次/分。留针40~60分钟，其间每5~10分钟行针一次，每次2~3分钟。多数患者在40分钟左右即可缓解，然后起针，去火罐。

共治疗38例。完全缓解：自觉症状和体征完全消失，恢复发作前状态。

基本缓解：自觉症状消失，体征明显减轻，基本恢复发作前状态。

疗效较差：自觉症状减轻，体征无明显变化，未恢复发作前状

态。

88例患者经三针一罐治疗后，40分钟完全缓解者13例，基本缓解者22例，疗效较差者3例，总有效率为92.1%。

韩文刚 三针一罐治疗哮喘38例 山西中医 (2); 34, 1990

红外线电灸法

1. 器械: DJ₁ 电灸器。

2. 穴位: (1) 列缺(双)、定喘(双)。

(2) 肾俞(双)、足三里(双)。

3. 方法: 先取(1)组穴位, 灸治一、二周, 心衰病人加用膻中、关元, 症状缓解后, 取(2)组穴位治疗一周。日一次, 每穴灸治30分钟, 一般调在3档, 患者常有热灼感觉, 局部有潮红现象。如起水疱, 不必处理, 只要保持清洁, 一周左右可自行吸收。起疱的穴位不要再灸, 也不要改换穴位, 经临床观察起水疱的效果更好。治疗期间一律停用其他疗法。

共治疗30例。临床症状消失为显效, 共20例; 症状明显缓解为有效, 共7例; 经灸治两周, 症状虽有缓解, 但不稳定为无效, 共3例。

连维真等 红外线灸治哮喘病临床观察 浙江中医学院学报 (4); 48, 1989

3. 支气管哮喘

艾 灸 法

用大于艾条的生姜切成3毫米厚度的生姜片, 置于穴位。艾条火直接烧在生姜片上, 以患者感觉皮肤灼热为度, 或以忍受热度为度。即把生姜片及艾条火置另一穴位上。以此类推灸完所需灸的穴位为

止。自拟“八华穴”为天突、膻中、中府（双）、云门（双）、大椎、定喘（双）、肺俞（双）、肾俞（双）、每日1次，21次为1疗程，一般灸1~2个疗程。外感风寒、流涕、鼻塞选灸风池、风门、太渊、合谷1~2个穴位；痰多胸满不得卧加灸足三里或丰隆。佐以辨证论治加服中药。中药基本方：核桃50克，五味子10克，蝉蜕、乌梅各15克，熟地20克，罂粟壳9克。肺寒证加附子10克，桂枝4~6克，蛤蚧12克（研粉冲服）；肺热者加天竺黄8克，浙贝10克，生牡蛎15克，去熟地；气冷结滞者加炙麻黄5克，杏仁10克。

共治疗80例。痊愈37例，临床控制16例，显效11例，有效11例，无效5例，总有效率为93.6%。本法疗效寒证优于热证，无哮喘家族史优于有哮喘家族史，轻、中度患者优于重度患者。

黄进贵 艾灸自拟“八华穴”为主治疗支气管哮喘80例 陕西中医 (12), 553, 1989

天 灸 法

药物配制：白芥子35%、洋金花35%，细辛18%，甘遂12%，上药研末用生姜水和匀，做成重5克的圆形药饼，同时备麝香少许。操作方法：每年夏季三伏天进行治疗，先用1.5寸毫针在患者背部肺俞（双）、膈俞（双）、心俞（双）等穴位强刺激不留针，然后把少许麝香放在已做好的药饼上，对准穴位，用橡皮膏将饼固定起来，贴药时间不超过2小时即取下，每伏贴1次，3次为一疗程。

共治疗157例。痊愈51例，显效87例，好转11例，无效8例。

孙 伟 天灸治疗支气管哮喘157例 陕西中医 (5), 207, 1988

穴位敷贴法

（一）处方：白芥子840克，洋金花720克，细辛420克，甘遂420克，麝香10克，冰片36克，生姜10公斤。约可供150人治疗使用。

(二) 制作：取生姜洗净，切成碎片，加少量水湿润，研磨成糊状，取汁备用。将洋金花、细辛、甘遂烘干，轧成粉，另将白芥子烘干，研成粉，而后将药粉混匀，过120目筛。将冰片、麝香用适量90%乙醇溶解后慢慢成细流状加入以上药粉中，搅匀即可。

先将棉球取生姜汁涂擦两侧百劳、肺俞、膏肓穴处皮肤至发红，然后将摊有药饼的纱布敷贴于上，胶布固定，2小时左右取下。每年于夏日三伏施治，每10天1次，共3次。

共治疗150例显效：咳喘症状控制，体征消失39例，占26%。有效：咳喘症状减轻，发作次数减少92例，占61.3%。无效：咳喘症状无变化或加重19例，占12.7%。

陆慧君 穴位敷贴治疗支气管哮喘与慢性支气管炎 150例 江苏中医 (3); 27, 1991

4. 慢性支气管炎

穴位埋线并兔垂体埋藏法

取穴：以膻中、肺俞、天突为主穴，以定喘、丰隆、足三里等为配穴。按患者的不同症状辨证选用主穴一至二个、配穴二至三个。

操作方法：取四斤以上健康家兔的垂脑体，放在无菌容器中备用。再将羊肠线剪成0.5厘米的小段浸于75%酒精中备用。嘱患者仰（俯）卧，常规消毒，用1%奴夫卡因浸润局麻，在主穴旁1厘米处沿脊柱方向纵行切开皮肤约一厘米，深达肌层，分离周围组织，用刀柄按摩深部，待病人有麻、胀感后，将备好的垂体送入穴位深部，全层缝合，消毒切口，外敷无菌敷料，七天拆线。配穴常规消毒后，将备好的肠线装入穿刺针内，在局麻下将针刺入穴位下肌层，待病人有酸、麻、胀感，将针管内的肠线送入穴位，边推针芯边抽针管，不使肠线外露，消毒针眼，外敷无菌敷料，胶布固定。

每埋一次为一个疗程，每个疗程为30天。

注意事项：1) 术中严格无菌操作，防止感染；2) 埋藏不要过深，严防造成气胸；3) 埋藏后禁烟、酒、酸辣等刺激性食物，一周内禁止重体力劳动。

共治疗1203例。埋藏后停用各种药物，咳喘症状完全消失，胸透无明显异常，两年以上未复发者为痊愈；埋藏后咳喘症状比以前明显减轻；不需再服药者为显效；埋藏后咳喘症状减轻，服药量比以前减少者为好转；埋藏后病情无明显变化者为无效。痊愈475例，占39.5%；显效522例，占43.4%；好转206例，占17.1%；总有效率为100%。疗程：埋藏一次有效者461例，占38.3%；二次者508例，占42.2%；三次者203例，占16.9%；四次以上者31例，占2.6%。

田广勤 穴位埋线治疗慢性支气管炎1203例 中国针灸 (2), 12, 1987

穴位埋线法

寒痰型：肺俞、膻中、天突、玉堂、身柱。

痰热型：肺俞、天突、膻中、孔最、玉堂、中府、足三里。

虚喘型：肺俞、膻中、丰隆、身柱、玉堂、定喘、天突、鱼际。

实喘型：肺俞、膻中、鱼际、定喘、玉堂、天突。

以上均用0~2号医用羊肠线，20天左右治疗一次，一般治疗3个疗程，共2个月。

埋线用具：上海产医用埋线针。

方法：按分型取穴，在穴位下方0.6寸作为进针点，常规消毒，局麻，将线埋入穴位，针眼处挤出点血后用酒精小棉球小胶布固定1~2天即可。

共治疗500例，近控174例，显效182例，好转124例，无效20例。

余跃华 穴位埋线治疗慢性气管炎500例 上海针灸杂志 (2), 14, 1987

穴位敷药法

1. 穴位选择：肺俞、心俞、膈俞（均双侧）。

2. 药物组成及配制：洋金花30克，甘遂10克，细辛15克，白芥子35克。上药共研末，用生姜水调匀，做成5克重圆形药饼，麝香少许备用。

3. 贴敷方法：每年伏天治疗。先针刺上述穴位，得气后出针，然后在药饼上放麝香0.01克，用橡皮膏将药饼固定于穴位上，一般2小时左右取掉。个别患者贴药后有烧灼感，可提前去掉，以防水泡溃烂，影响再次贴敷。连续三次为一疗程。

共治疗298例。痊愈：咳、痰、喘症状基本控制，病情稳定三年未再复发者，共33例，占11.1%。明显好转：发作次数明显减少，发作后程度明显减轻，体力有明显改善者，共69例，占23.2%。好转：部分症状减轻，发作次数减少，发作后程度减轻，一般情况好转，共154例，占51.6%。无效：经三个疗程后，症状无改善或加重者，共42例，占14.1%。总有效率为85.9%。

随访251例，连续2年不复发者118例，虽复发，但次数减少，程度减轻者133例。

治疗前嗜酸性细胞最低4%，最高6.3%，平均4.9%，治疗后，最低0.8%，最高5.1%，平均2.1%。

刘长安等 穴位敷药治疗慢性支气管炎298例 陕西中医 (4), 176, 1987

耳压敷贴法

1. 耳压法：以胶布条粘王不留行子，贴于耳穴神门、肝、肾、皮质下、内分泌、肾上腺、平喘、肺，每穴耳廓内外对贴，隔日调换一次，左右耳穴交替、嘱病人每日捻压药子4~6次，以微痛为度。

2. 俞穴敷贴法：以中药止咳平喘散（麻黄、细辛、肉桂、川

乌、胡椒、冰片等)撒于定喘穴(双)、大椎穴、天突穴、肺俞穴、涌泉穴,再以4×6厘米的复方凤茄膏敷贴。痰多加丰隆,胸闷加膻中,病久加膏肓。隔日调换一次。一般敷贴24小时,若有皮肤过敏反应,亦可贴12小时。

疗程: 9次为一个疗程,一般2~3个疗程。

若病情较重,适当加用中成药。咳嗽痰多加服半贝丸,喘者加服蛤蚧定喘丸,痰黄者加用竹沥油,气阴不足者,加服生脉饮。

共治疗143例,按照1972年全国修订的统一疗效标准判定疗效。显效66例(46.15%),好转74例(51.75%),无效3例(2.10%)。

郭云等 耳压敷贴法治143例慢性支气管炎 上海中医药杂志 (12), 16, 1987

耳针法 (一)

(一) 取穴: 支气管、肾上腺、前列腺。痰多加脾, 罗音加肺。

(二) 方法: 采用耳贴或埋针, 前者使用白芥子或王不留行籽压穴疗法; 后者使用皮内针或揸针。双耳取穴, 每5天更换耳穴1次, 5次为1疗程。

共治疗100例疗效标准: 按1972年全国慢性气管炎临床专业会议修订的疗效判断标准。

临床控制: 咳、痰、喘好转9成以上, 哮鸣音消失。

显效: 咳、痰、喘好转7~8成, 哮鸣音明显好转(*→+)。

好转: 咳、痰、喘好转3~5成, 哮鸣音好转(*→++或++→+)。

无效: 咳、痰、喘好转不足3成者, 哮鸣音无改变或加重。

疗效: 患者普遍反映使用耳针后, 即感咳嗽减轻, 哮喘逐渐缓解。疗效发生在耳针5次以下者44例, 6~10次者43例, 11~20次者9例, 无效者4例。

100例慢性支气管炎中, 临床控制者47例, 占47%; 显效43例, 占43%; 好转6例, 占6%; 无效4例, 占4%。近期总有效率为

98%。

尉迟静等 耳针治疗慢性支气管炎100例 上海针灸杂志 (2),
12, 1987

耳针法 (二)

(一) 取穴: 以神门、肺、肾上腺、平喘为主穴。咳喘症状明显者加喘点或交感。痰多者加脾。老年患者或体质较差患者加肾。长期使用耳针治疗, 可以用皮质下代替神门, 内分泌代替肾上腺, 气管代替肺, 咽喉代替平喘。上述穴位的交替使用可以提高疗效。

(二) 操作方法:

1. 用75%酒精在针刺部位做常规消毒。

2. 使用5分毫针在所选穴位上进行针刺。针刺不宜过深, 以不刺入耳廓软骨为度。留针30分钟, 每10分钟捻转一次, 每次捻转半分钟。捻转幅度不宜过大, 刺激不宜过强, 以耳廓有烘热感为度。

3. 如需长时间治疗, 可以作耳针埋藏。具体做法为: 局部消毒后, 将埋藏耳针按穴位刺入, 并用胶布给予固定。要求患者每日揉按耳针两次(早晚各一次)。每次按压后以局部有热感为度。留针时间: 冬季埋藏五至七天, 夏季埋藏三至五天。如需继续埋藏应注意更换穴位。如果单耳埋藏, 可以两耳交替埋针。

(三) 疗效标准:

1. 临床控制: 经针刺治疗后, 症状基本消失, 或偶有轻微咳嗽和少量咯痰, 维持两个月以上者。

2. 显效: 咳嗽、气喘明显好转, 咯痰量减少50%以上, 哮鸣音减少(+++→+)者。

3. 好转: 咳嗽、气喘有所好转, 咯痰量减少不足30%, 哮鸣音无明显改变者。

(四) 疗效:

在121例患者中, 临床控制26人, 占21.5%。显效43人, 占35.5%。好转50人, 占41.7%。无效2人, 占1.7%。

在上述121例“慢支”治疗过程中，没有使用任何药物和其它辅助治疗方法。

张鸿声等 耳针治疗慢性支气管炎 121 例临床小结 中医药学报 (5); 32, 1988

5. 肺 炎

针 刺 法

1. 尺泽、合谷、足三里; 2. 孔最、曲池、丰隆; 3. 列缺、天突。

对伴有水电解质紊乱者予以相应补充和纠正; 对部分高烧病例偶或加用解热剂复方阿斯匹林; 恢复期病例加用肺俞穴拔火罐。

共治疗24例。疗效标准:

痊愈: 治疗后症状、体征完全消失, 血象恢复正常, X线检查(胸透或摄片)肺部病变完全吸收或仅残留少许条索状阴影者;

近愈及好转: 症状、体征基本消失, 血象正常, X线检查肺炎病灶尚未完全吸收者;

无效: 经本方案治疗不能有效控制症状, 或因某种原因不能坚持, 而改用抗菌药物治疗者。

体温恢复时间: 除3例中途改用抗生素或中药未列入统计外。21例中, 发热者12例, 治疗后体温恢复正常最短时间6小时, 最长达7天, 平均值2.57天。体温在24小时内恢复正常者4例, 48小时内恢复正常者5例, 72小时内恢复正常者1例。因此, 体温在3天之内恢复正常者占83.3%。

血象恢复情况: 针刺21例中, 有19例血象异常, 占总例数79.2%。白细胞总数10,000~12,900/立方毫米4例, 13,000~20,000/立方毫米6例, 21,000~30,000/立方毫米6例, 30,000/立方毫米以上者2例。最高值达41,000/立方毫米。中性核分类>80%者14例, 占66.7%。经治疗后, 复查血象16例, 血象恢复正常最短1天, 最长14

天, 平均值5.83天。

X线改变: 治疗后X线追踪检查, 21例中14例完全吸收, 7例近愈好转出院, 6例于10天内病变完全吸收, 占42.9%, 在14天内完全吸收12例, 占85.7%。

甘富容等 针刺治疗肺炎 湖南中医杂志 (6); 24, 1988

6. 肺结核咯血

电 针 法

电针组: 采用G6805治疗仪及2寸毫针两根。选择一侧内关、孔

电针治疗各类型肺结核咯血分析

疗 效	类 型 例 数	浸 润 型 核		慢 纤 洞 核		支 气 管 张		总 计	
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
显 效		110	69	82	62	3	50	195	65
有 效		44	27	43	32	3	50	90	30
无 效		7	4	8	6	0	0	15	5
总 计		161	100	133	100	6	100	300	100

电针治疗不同咯血量效果分析

疗 效	咯 血 量 例 数	大 量		中 量		小 量		总 计	
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
显 效		43	60	75	70	77	64	195	65
有 效		25	35	24	23	41	33	90	30
无 效		3	5	8	7	4	3	15	5
总 计		71	100	107	100	122	100	300	100

最穴，局部酒精消毒，用2寸毫针刺入，得针感后，针柄与治疗仪输出导线相连，电流定为1.8mA、输出电压0.2V，方形波、频率160、连续脉冲。

经电针治疗30分钟内大咯血（大量：500ml以上者；中量：150~500ml者；小量：<150ml者）停止，痰中仍带少量血，经12小时不再大量咯血者为显效。经电针治疗30分钟内大咯血停止，痰中仍带少量血，并在12小时内又发生咯血者为有效。经电针治疗大咯血不止，改用其它方法治疗者为无效。

孟雪英 电针治疗肺结核咯血疗效观察 中国针灸 (1);9,1986

耳 针 法

主穴：气管、支气管、肺、神门。配穴：交感、支扩点、激素、三焦、咽喉、枕等。每次取主穴及随症选用配穴3~5个。用75%酒精棉球消毒耳前区至少3次。用牙科弯头镊子取34号不锈钢环形皮内针（苏州针灸用品厂出品），在其距针尖3~4毫米处弯成45°角，然后刺入穴位，再用氧化锌胶布固定之。双耳交替，每日或隔日换针，酌情于止血后用2~3次即可。

注意必须针对病因作相应的治疗。

共治疗9例，耳针1次止血者6例，2次止血者2例，6次止血者1例，有效率为100%。其中6例止血后又治疗1~2次，以巩固疗效。除针刺某些敏感穴位（通常为主穴）有轻微刺痛外，未出现任何副反应。

胡卞新 耳针治愈咯血9例 中国针灸 (4);24,1987

附：咳引尻痛

针 刺 法

取穴：鱼际穴。刺法：患者取坐位或仰卧位，选准该穴，每次只

刺一侧穴位，刺时针尖向掌心斜刺，深度为5～8分左右，用提插捻转手法，留针20～30分钟，留针期间，每隔5分钟行针1次，并嘱患者配合多姿活动和自动咳嗽，方能收到满意效果。

共治疗85例。针刺后咳而不痛，动作自如，一切恢复正常者为痊愈；针刺后咳而不痛，动作欠自如者为显效；针刺后咳而疼痛减轻者为有效。获痊愈者58例，显效21例，有效6例，总有效率为100%。

王建德等 针刺鱼际穴治疗咳引尻痛85例 陕西中医 (10)，472，1988

第四节 心血管系统疾病

1. 心律失常

针 刺 法

主穴：左右内关。

方法：选定穴位，局部皮肤消毒后，以常法进针，捻、转、提、插，使其有酸、麻、重、胀之“得气”感。对年高体弱，久病多虚者，以补法轻刺激，留针15—30分钟；对年富力强，新发病者，用重刺激，并大幅度运针或加指弹以增强感应，留针3—5分钟，或不留针。

辅穴：部分病例，按病情需要，适当配用其它相应的穴位，辅助治疗。如高血压配曲池，失眠配神门，眩晕配风池，高血脂配丰隆等。

疗程：每日针刺一次，连针10天为一疗程，接受全程治疗者，列为统计对象。

共治疗84例。(1)痊愈：患者自觉症状与心脏听诊及心电图检

查，原有异常均消失，恢复正常者。（2）显效：患者自觉症状基本消失，心脏听诊和心电图检查，原异常有明显改善者。（3）好转：患者自觉症状减轻，心脏听诊和心电图检查，原异常有一定改善者。（4）无效：患者自觉症状与心脏听诊及心电图检查，原异常均无改善或改善轻微者。痊愈14例，占16.7%；显效20例，占23.8%；好转44例，占52.3%；无效6例，占7.2%；总有效率为92.8%。

孙步洲 针刺内关治疗心律失常 84例 江苏中医 (1); 28, 1988

2. 室上性心动过速

针 刺 法

主穴：人迎穴、内关穴，均取双侧。

人迎穴：平甲状软骨体上缘水平，胸腺乳突肌内侧，颈动脉内缘，斜向内侧进针，深度1寸~1.5寸，以针体随动脉搏动而抖动为度，不做手法。

内关穴：仰掌，腕横纹上2寸，前臂内侧两筋间，垂直进针0.5寸，用雀啄手法，使针感向中指及肘部放射为度。

属于虚证：因惊吓、劳累而发者加神门、三阴交穴，神门进针0.3寸，三阴交进针0.5寸，施捻转补泻手法的补法。

属于实证：因情志波动、烦闷而发者加太冲穴进针0.5寸，用提插补泻手法的泻法。

共治疗17例，用针刺一次治疗后，恢复正常15例，占88.2%，无效2例，占11.8%。

丁 汀 针刺治疗室上性心动过速 天津中医 (1); 36, 1990

3. 早 搏

当归液穴位注射法

穴位常规消毒，选用 5 ml 注射器和 5.5 号针头，针尖垂直刺入内关（双）、神门（双）穴，上下提插 2～3 次，有酸胀感后，每穴注入 5 % 当归注射液 0.5 ml，每天 1 次，10 次为 1 疗程。

共治疗 41 例。显效：治疗后过早搏动消失；有效：治疗后过早搏动次数较原有减少 50 % 以上；无效：治疗后无变化；恶化：治疗后过早搏动较治疗前增加 50 %。

治疗结果 显效 24 例，有效 12 例，无效 5 例，总有效率 87.80 %。

周庆伟 当归液穴位注射治疗过早搏动 41 例 陕西中医 (9)；
420, 1990

针刺法（一）

1. 取穴：主穴分两组，交替选用。第一组：膻中、神封、神藏、乳根、内关。第二组：夹脊穴胸 4～5、心俞、心平。

2. 操作方法：患者取卧位，选用 28 号不锈钢 1～1.5 寸毫针。针刺胸背部穴时宜斜刺，针身与皮肤表面呈 45° 角，背部穴针尖斜向脊柱，胸部穴针尖斜向上方，四肢穴直刺为宜。进针得气后，留针 20 分钟，中间行针 1～2 次。操作时应根据病人年龄、体质及临床证型之不同，灵活运用补泻手法。凡年老体弱、心气不足明显者，偏重补法，进针慢、出针快、少捻转，针时先浅后深、重插轻提；年轻体壮或心血淤阻较著者，偏重泻法，进针快、出针慢、多捻转，针时先深后浅、轻插重提。虚实不典型者多采用平补平泻法。

3. 疗程：每日针刺 1 次，15 次为 1 疗程，疗程间休息 5 天，共观察两个疗程，以后酌情巩固疗效。

共治疗30例。显效：症状消失或基本消失，早搏消失或由频发转为偶发，心电图正常或大致正常。有效：症状减轻，早搏减少，心电图改善。无效：治疗一疗程，症状、体征、心电图均无改变。

30例中，显效18例，占60%；有效9例，占30%；无效3例，占10%；总有效率为60%。

史继忠等 针刺治疗过早搏动30例 山东中医杂志 (9)；23，1989

针刺法 (二)

治疗 第一组：神门、膻中、足三里。第二组：太渊、膈俞、丰隆。两组穴位交替使用，神门、太渊用补法，膻中、膈俞用平补平泻法，足三里、丰隆用泻法。泻法不留针，其余均留针20分钟，每日一次，10次为一疗程。

共治疗14例。第一疗程后6例症状消失，4例早搏消失。第二疗程后8例症状消失，2例早搏消失。第三疗程后，2例早搏减少。复查心电图6例恢复正常，2例偶发室性早搏。

邢锦秀 针刺治疗频发性室性早搏 上海针灸杂志 (2)；46，1987

4. 肺 心 病

脊电针法

病人取坐位，头稍低下，选大椎、二椎下、陶道穴，皮肤消毒后以28号2寸毫针缓慢刺入，深度一般在1.5~2寸之间，主要标志为手下落空感及通电后胸背部有电麻样感，通电后如针感未感传到胸部时以手法调正之。治疗机为国产G—6805治疗仪，频率80Hz，强度3~20毫安，一般以病人有满意之针感和能耐受为度。三穴可交替使

用，隔日一次，10次为一疗程。治疗期一般停用其它药物，气喘严重者可临时服用氨茶碱。本法治疗操作中必须注意严密消毒，针刺深度必须适度，逐渐增加电流强度，儿童孕妇和有出血倾向的疾病且勿使用。

1. 本组134例经治疗后心电图恢复正常52例，显著改善16例，改善26例，无效40例。2. 心电图各主要诊断条件的恢复情况：①QRS额面电轴：本组治前 $\geq +90^\circ$ 者共计37例，占本组的17.35%，治疗后恢复者8例，占28.68%，其右偏范围均在 $+90^\circ \sim 98^\circ$ 之间， $>100^\circ$ 者无1例恢复。②肺型P波：治前出现肺型P波者93例（包括 $P > P_{1/2}$ ，P电压 $0.2\text{mv} + \text{P电轴} > +80^\circ$ ）经治疗后恢复者57例占61.29%，P波 $>0.22\text{mv}$ 者76例，治疗后恢复到 0.20mv 以下者46例，占60.53%，治疗后出现肺型P波者4例，占2.9%。

商凤楼等 脊电针法治疗肺心病134例心电图观察 陕西中医(5), 195, 1988

5. 风湿性关节炎

针刺放血艾灸法

主要根据发病部位，以循经取穴与局部配穴相结合，灵活运用。

(1) 针术：均用毫针，刺入穴位后使其得气，然后根据病情虚实，采用不同的补泄手法，一般用捻转或提插的补泻手法，行手法后留针20~30分钟。局部有红肿时，可在病灶周围用三棱针刺破放血，如出血不畅，可配用拔火罐拔吸，对急性病例较为适宜。

(2) 灸术：本组病例以艾卷灸者为多，少数病例应用艾炷灸。对慢性关节炎针灸同时并举效果满意。艾卷灸一般每穴10~20分钟，使局部出现红晕为止。艾炷灸一般每穴5~7分钟，局部产生轻微的灼痛感即可。

(3) 疗程：一般急性病例每日针灸一次。慢性者隔日针灸一

次，12次为一疗程，治疗一个疗程以后，可休针1~2周，再继续针灸。

共治468例。痊愈：指自觉症状消失和检查所见均恢复正常者。

显效：指自觉症状消失和检查所见基本近于恢复正常者。

好转：指经过治疗后，症状有不同程度的减轻者。

无效：指经过治疗后，无明显好转者。

本组468例中，痊愈94例，占20.1%；显效107例，占22.9%；好转211例，占45%；总有效率达88%。无效56例，占12%。

贺普仁 针灸治疗468例风湿性关节炎临床疗效分析 北京中医(3)，38，1988

针刺加火罐法

(一) 取穴原则：局部和邻近取穴，多用以痛为腧（压痛点）的取穴原则。

1. 肩关节：肩髃、肩髃、肩髃、肩井、天宗或局部压痛点。

2. 肘关节：曲池、天井、手三里或压痛点。

3. 腰、髋关节：腰阳关、关元俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、环跳或局部压痛点。

4. 膝关节：梁丘、血海、膝阳关、曲泉、鹤顶、内膝眼、外膝眼、足三里或局部压痛点。

5. 踝关节：绝骨、解溪、丘墟、太溪、昆仑或局部压痛点。

(二) 施术方法：按上述各关节部位取穴或压痛点，先针刺，施泻法或根据体质状况，可用平补平泻针刺手法。但针刺得气必到病所，留针5~10分钟后，再行针一次，然后按针刺穴位或痛点，选好罐的形号，将针扣在罐里。一般留罐10~15分钟，把罐启下，行针一次，再留针10分钟，施术毕。

根据病情，一般每日或间日一次，12次为一疗程。如果施罐穴位或部位瘀血过重，患病部位可每日针刺，但施罐则间日一次，防止患部皮肤损伤。疗程中休息5~7天。

共治疗300例。本病经针刺加火罐治疗后，患者皮下结节，环形红斑、红肿、关节疼痛症状消失，白细胞、血沉和抗“o”恢复正常者，为临床治愈，共128例；症状基本消失，实验室检查，白细胞、血沉和抗“o”接近正常，为显效，共81例；症状显著减轻，实验室检查略偏高者，为有效，共66例；症状和实验室检查无变化者，为无效，共25例。

孙景德 针刺加火罐治疗风湿性关节炎 300 例临床疗效总结 中国针灸 (6); 7, 1986

温和灸法

(一) 全身酸痛，麻木者，可用固定式艾条熏灸器（安徽中医学院附属针灸医院出售）长时间熏灸大椎穴，每次两小时以上；待灸感到达命门穴以下，加熏灸命门穴；再等待灸感抵病痛关节以下，更加熏灸病痛关节处的经验穴或压痛点。灸后病痛感觉范围会逐渐缩小，再依下列二、三点办法施灸。

(二) 在背部或有不适感处先找出痛点，再用点燃的艾条在痛区巡回熏灸（没有压痛点则在肤温降低区，或者功能障碍的关节处熏灸，灸时如有特殊感觉直往体内钻，钻得最快、最深的点就是该病区的反应点。长时间熏灸反应点，会取得满意的疗效。

(三) 如果病痛只在一条经络的某一节段，则这一节段上的任何一点，接近艾火马上就产生条状灸感，而灸其它任何经络的任何节段都不会出现此现象。如果条状灸感不趋向肢端方向，则改灸有感线的上端（近心端），灸感就会下行。循着这条有感线相距约3寸处各灸5分钟，灸至不再有灸感出现的地方，便算完成一次灸治。每天可灸两三次，逐日灸下去，有感线会自上端起逐渐缩短，病痛也跟着逐渐转好。

共治疗199例。灸后临床症状完全消除者为痊愈。灸后所有症状改善一半以上者为显效。灸后症状有明显改善者为有效。灸后与灸前症状没有区别者为无效。

199例中痊愈69例，显著有效53例，有效73例，无效4例，总有效率为98%。

蔡耀明 温和灸法治疗风湿病199例 中国针灸 (6); 3, 1988

B₁B₁₂ 穴注法

用 B₁100 毫克，B₁₂0.25 毫克混合，分注双侧委中穴，要求针刺酸胀痛，每日一次，10次为一疗程。

101例中，痊愈68例；显效28例；好转4例；无效1例。一般1~2个疗程可愈。

肖 均 B₁B₁₂ 穴注治疗风湿性关节炎101例 中国针灸 (1); 10, 1987

针 灸 法

以患部和辨证取穴为主。膝关节部取：犊鼻、内膝眼、阳陵泉、梁丘；踝关节部取：申脉、照海、丘墟、昆仑。行痹加风市、血海；痛痹加阿是穴；着痹加足三里、阴陵泉；热痹加三阴交；久病体弱，得气较慢者加肾俞、命门。

手法：行痹、热痹用泻法；痛痹、着痹用平补平泻法；有瘀血者加刺络法。每次留针30min，中间行针1~2次，留针期间均加灸，每天1次，10次为1疗程，未愈者休息5天后，再行第2疗程。

共治疗115例。临床治愈：经过1~2个疗程后，临床症状及体征基本消失，关节功能复常，1年内未复发者。好转：临床症状大减，关节功能基本不受限制。

临床治愈55例，占47.82%；好转60例，占52.18%。

蔡贵生 针灸治疗风湿性关节炎115例 陕西中医 (6); 274, 1991

针 刺 法

取内外膝眼、委中穴。操作方法：均用28号1~2寸针，针刺时

宜快速进针，使针尖向对侧刺入，至有针感为止。留针 20min，每 3～5 min 捻转 1 次，采用平补平泻手法。起针时宜摇大针孔，委中点刺放血，并加拔火罐 5 min；然后采用点、按、揉手法按摩 10～15min。

共治疗 87 例。治疗后，关节不痛不肿，天气变化及长途跋涉无明显感觉，随访 1 年未复发者为痊愈；随访半年因天气变化关节稍有不舒者为好转。

痊愈 79 例，好转 8 例，总有效率为 100%。

方永彦 膝三针治疗风湿性关节炎 87 例 陕西中医 (6)；275，1991

附：痹 症

激 光 法

(一) 适应症：风湿寒性关节痛、风关炎及类关炎所致的关节疼痛、肿胀。其次是增关炎、肩周炎、坐骨神经痛、神经性头痛、面瘫、咽炎、鼻炎、等多种疾病，治疗前明确诊断，填写治疗登记表，便于观察和总结。

(二) 操作方法：首先选定拟治疗受累关节的部位。如属手足小关节（对称性肿痛），用两台 5 毫瓦 He—Ne 激光仪作对称性局部直接照射，光照处先涂龙胆紫液，激光器距皮肤 5 厘米，每次照射 20～30 分钟，每天一次，10 次为一疗程，疗程间间歇 2～3 天；如属较大关节（肩、肘、腕、膝、踝等），采用 20～30 毫瓦的 He—Ne 激光器，以光斑直射或散焦投照，激光器距皮肤 5～10 厘米，每次照射 10～15 分钟。有部分病例在光照中加针刺（或用光针同时进行），常用配穴，如膝关节针膝眼、鹤顶穴；踝关节针绝骨等。

(三) 注意事项：①机器置于平整桌面上远离一切热源及高频设备装置；②开机前检查有无漏电、混线等，避免发生触电及毁机事

故；③调整定时组；④治疗完毕关闭电源；⑤在开机治疗中医患应戴防护镜。

共治疗100例。显效：受累关节肿痛消失，关节功能活动增大或恢复正常。有效：受累关节肿痛好转，关节功能活动改善。无效：受累关节症状无改善或加重者。

本组100例中，显效27例（占27%），有效64例（占64%），无效9例（占9%），总有效率91%。

常季云 激光治疗痹症100例临床报告 天津中医（6）；21，1989

6. 高血压病

头皮针法

每日针刺一次，十次为一疗程，连针五次休息二日再针五次。疗程间隔3—5日，连续针刺三个疗程，治疗期间停用一切降压药物及其它疗法。取穴为书写、呼循、思维、听觉。配以伏像头部。根据不同症状和中医辨证施治的原则随症加减。进针须达骨膜、留针30分钟，中间捻针一次。

观察方法：针刺前后各测一次血压，每一疗程后均作各项复查。半年、1年、1年半后对部分病人做了家访和复查。

共治疗1292例患者，平均血压由治前的172.37/103.57毫米汞柱降为140.66/83.46毫米汞柱。近期降压疗效非常显著（ $P < 0.01$ ），收缩压舒张压下降均显著（ $P < 0.01$ ），显效999例占77.32%，有效266例占20.59%，总有效率97.91%，无效2.09%。

方云鹏等 头皮针治疗高血压病1292例疗效观察 北京中医学院学报（4）；21，1988

穴位割治法

取穴方法：取3、4、5等胸椎两旁夹脊穴和心俞、肺俞、厥阳

俞、天宗、肩髃等穴，一般从第4胸椎水平线以上，由下而上取穴，顺序不能乱。如果治疗两个疗程，血压顽固不降，可采取第二治疗方案，除选以上穴位外，另选肢体穴位，顺序从上而下，所选穴位根据辨证而定。

割治方法：选穴后常规消毒，每穴皮内注射2%普鲁卡因0.1毫升，用6号针头刺入皮肤0.2厘米，转向上沿皮刺入0.5厘米，再把针尖挑出皮外，看到针尖后挑起皮肤，用手术刀沿针割开，不缝合，常规包扎。每次10个穴位以上，隔日1次，穴位轮换使用。割治4次为一个疗程，二个疗程间隔10~30天。一般治疗3~10个疗程，多数治疗4个疗程。

共治疗550例。显效：血压降至正常，病情改善。好转：血压下降，接近正常。无效：治疗前后无变化。本组显效433例，占78.5%，好转58例，占10.7%，无效59例，占10.8%，总有效率占89.2%。

随访观察：对显效的101例进行随访，一型38例，2~5年复发5例，6~10年复发8例；二型35例，2~5年复发1例，6~10年复发2例；三型25例，2~5年复发1例。（多数复发病例均因血压降至正常后未坚持治疗至疗程结束）

副作用：治疗中发现2例因血压下降快而出现头晕、恶心、乏力和心中不适感，未发现其它副作用。

卫玉秀等 穴位割治疗法治疗高血压病 550 例观察 北京中医(4)，37，1989

降压膏穴位外敷法

白花蛇3条、蜈蚣9条、土鳖虫6克、地龙9克、蝉蜕9克、葛根15克、黄连6克、甘遂3条、白芥子6克、细辛3克、元胡6克、三七3克，以上共研细末，麝香1克，姜酞适量。将药粉用姜酞拌成膏，做成饼，直径2厘米，厚0.5厘米。药饼中心放少许麝香末，置放在有纱布的塑料纸上。将两侧心俞、肝俞、肾俞及关元穴，用酒精擦净，以使药力利于渗透和固定。

共治疗100例,显效:①舒张压下降10毫米汞柱以上并达到正常范围。②舒张压虽未降至正常,但已下降20毫米汞柱以上。

有效:①舒张压下降不及10毫米汞柱,但已达到正常范围。②舒张压较治疗前下降10~20毫米汞柱,但未达到正常范围。③收缩压较治疗前下降30毫米汞柱以上。

无效:未达到以上标准者。

疗效:降压疗效,显效80例(80%),有效15例(15%),无效5例(5%),总有效率为95%。

王德文 降压膏穴位外敷治疗高血压病100例疗效观察 中国针灸 (6); 12, 1986

眼 针 法

1. 取穴:取双侧肝区。如伴有头痛目胀者加刺太阳穴。

2. 操作方法:以0.5寸毫针刺入双侧肝区,留针10分钟。针前测定血压,针后再即刻测定血压,每日针刺一次。

共治疗99例。显效:针后立即测定血压,舒张压下降20毫米汞柱以上或接近正常血压,收缩压下降20—30毫米汞柱以上。三天之后所有症状消失,一星期后血压仍维持正常。

有效:针刺后两天内舒张压较治疗前下降10毫米汞柱以上,但未达到正常范围,症状大部分消失。

好转:针刺后舒张压无明显下降,但收缩压下降10毫米汞柱以上,症状有所缓解。

治疗结果:针刺99例,显效63例,有效20例,好转16例,总有效率100%,针刺后绝大多数患者立即降压,所有针刺降压的病人均有不同程度的疗效。

王曼丽等 眼针治疗高血压病99例临床观察 中医药信息 (3); 33, 1991

穴位埋线法

1. 敏感穴位的探测：根据四诊确定证候类型，按证型分析出病变所属脏腑及有关经络（如肝阳上亢型，病在肝，即测本经肝经、表经胆经、同名经心包经和三焦经）。然后用拇指对腹背部及所选经络的穴位进行按压、推移，如有压痛、结节等异常现象出现的穴位即为敏感穴位。埋线选取敏感反应最明显的穴位 2~4 个，以胸腹及背部敏感穴位为主，配以四肢敏感穴位。

2. 埋线方法：穴位皮肤消毒后，在穴旁各 1.5cm 处作局麻皮丘，用穿有 1 号羊肠线的三角缝合针从一侧皮丘中刺入，穿过皮下组织，从另一侧皮丘中穿出。紧贴针眼剪断肠线，使其留植皮下 2cm。四肢穴位埋线用装有 2cm 羊肠线的 12 号腰穿针刺入穴下肌层，然后边退针边推针芯，将肠线推入穴内，外盖敷料。每次埋线间隔 20~30 天，5 次为 1 疗程。

共治疗 60 例。基本痊愈：症状基本消失，血压降到正常水平，追踪 3 个月疗效稳定；显效：主要症状消失或大部消失，舒张压下降 3.0~4.0kPa，收缩压下降 1.4~2.6kPa；有效：症状有所减轻，舒张压下降 1.4~2.6kPa，收缩压下降 0.6~1.3kPa；无效：症状基本无改善，血压下降不及上述有效指标。

治疗结果 1. 近期疗效：基本痊愈 18 例，显效 26 例，有效 11 例，无效 5 例，有效率 92%。有效病例中，埋线次数最少 2 次，最多 8 次。

2. 远期随访：对显效以上 44 例进行 1~5 年跟踪随访，疗效巩固者 32 例，基本巩固（有轻度复发）6 例，复发（复发至原来水平）6 例，巩固率 84.6%。

温木生 穴位埋线治疗高血压病 60 例 陕西中医 (9); 421, 1990

附：高血压眩晕

耳穴压迫法

令患者停用药物治疗3天以上，改用耳穴疗法。用75%酒精消毒耳廓皮肤，继用84~1型诊疗仪在耳廓上寻敏感点，电刺激10分钟，再将胶布裁成3mm大小的方块，每块上粘一颗王不留行籽，贴压于敏感点，使患者产生热、麻、胀、痛感为度，隔日换1次，左右耳交替，并嘱其每日按压耳贴数次。此疗法每10次为1疗程。

共治疗35例。治疗2个疗程后，BP能控制在正常范围内，即收缩压 $>13.6\text{kPa}$ ，舒张压 $<12.0\text{kPa}$ ，临床症状随之消失为治愈，共16例；治疗2个疗程后BP明显下降，接近正常值，临床症状基本缓解为显效，共7例；治疗2个疗程后，BP无明显下降，症状无明显缓解为无效，共2例。

洪新亮 耳穴疗法治疗精神性高血压眩晕35例 陕西中医 (4)；
176, 1991

附：眩 晕

山莨菪碱穴位贴敷法

取南通市卫生材料厂生产的山莨菪碱贴膏，贴于患者两侧内关、翳风穴上，20分钟后即取得效果。一般眩晕者可贴至症状消失后揭下贴膏，晕车、船者于上车、船之前20分钟贴上，下车、船后揭下。一般1次可见效，如第1次治疗效果不显，可于次日复治，方法不变。共治疗200例。优：贴膏20分钟后头晕止，晕车、船者在旅程中不出现眩晕症状，且均无胃肠道反应。良：眩晕症状减轻，能坐起行走，

晕车、船者有轻微的胃肠不适。差：第1次贴敷效果不明显。结果1次贴敷优者80例占40%，良者100例占50%，差者20例占10%。治疗中未发现毒副反应。

周虹 山莨菪碱穴位贴敷治疗眩晕 200 例 中西医结合杂志 (10); 620, 1990

针 刺 法

取内承浆穴（即下唇系带近唇端处），先用左手拉开患者的上下唇，再以酒精棉球局部消毒，然后右手持1.0寸毫针在口下唇系带近端处刺入（与唇系带呈30~45度角刺入唇里穴位内5分深），至下腹部有舒适感为度。施捻转泻法或平补平泻法，留针30~60min，每隔15min行针1次，每日针1次，10次为1疗程。

共治疗30例。症状消失，生活恢复正常者为痊愈，共17例；症状消失，但活动后仍有轻微眩晕者为显效，共12例；经10次治疗病情无改变者为无效，1例，总有效率为97.5%。

张化南 针刺内承浆穴治疗眩晕 30 例 陕西中医 (2); 82, 1991

7. 冠状动脉粥样硬化性心脏病

针 刺 法 (一)

主穴：华佗夹脊第四、第五胸椎、内关。配穴：膻中、三阴交。
手法：华佗夹脊第四、第五胸椎棘突左右旁开5~7分，针尖向椎体横突方向刺入；寻找针感，要求针感向心传导，或上、下走串为度，然后轻刮针柄1~2分钟。内关、三阴交二穴要求针感向心传导。同样轻刮针柄1~2分钟。共治疗115例，显效96例，改善51例，无效8例。

艾条悬灸法

灸法组采用山东省济南市中药饮片厂产“药艾条”作灸料。选穴内关(双)、膻中、心俞(双)。患者取平卧位,充分暴露胸穴部位。点燃艾条一端后,先施灸一侧内关穴,灸火约距皮肤0.5~1寸,采用温和悬灸法,使患者局部有温热感而无灼痛为宜。施灸5分钟,以局部皮肤呈红晕为度。然后再以同样方法施灸另一侧内关穴,施灸5分钟。再依次以同样方法施灸膻中、心俞(双),各灸5分钟。每天灸治一次,灸治6次为一疗程,休息一天后再继续进行第二疗程治疗。

共治疗138例。症状疗效:显效67例,改善45例,无效26例;心电图疗效:显效41例,改善46例,无效48例;降压疗效有效率为82.4%;降脂疗效有效率为88.5%。

张登部等 艾条悬灸法治疗冠心病 138例临床观察 中医杂志 (3); 35, 1991

针刺法(二)

(一) 取穴: 双侧内关。

(二) 操作方法: 按骨度法折量,手腕横纹正中直上2寸处定穴,快速垂直进针,抵达2~2.5厘米深度,快速捻转2分钟,使之出现酸、麻、重、胀之感,并激发针感向肘、腋、胸部传导。若针感局限内关局部,可附加压指手法,再次运针,诱发感传;若针感向指端放散,提示刺中正中神经,可将针体退于皮下,调整针尖方向,使之向上,再次进针,待有针感后,留针30分钟,中间行针一次,全过程专人操作。

(三) 疗程: 每日一次,每周六次,10次为一疗程,每个病例共

计三个疗程。

共治疗36例患者，实证 16 例，胸痛、心悸、胸闷等主症全部消失。虚证20例，18例主症消失，提示针刺内关对实证疗效较好，虚证次之。

赵颖等 针刺内关穴治疗冠心病疗效分析及机理探讨 中国针灸 (3), 15, 1987

羊 线 埋 植 法

中庭透玉堂、左侧少海、阿是（左胸、左肩臂、背部痛处的压痛点）。埋线次数：一般仅作埋线 1 次，埋线 1 个月接着作第 2 次埋线的有 6 例。埋植方法：在无菌操作下，采用简便埋线针作羊肠线埋植主要工具，将“〇〇”号羊肠线剪成 4～8 厘米，折成双线，穴位作垂直埋植，而中庭透玉堂及阿是穴作皮下横向埋植。

30例心绞痛患者，埋线治疗后 1 月有效者27例，有效率90%。埋线治疗 3 月后复查的22例心绞痛患者，有效者19例，有效率为86.4%。埋线30例中，治疗前 ST-T 改变者19例，治疗后显效 7 例，改善 5 例，无变化 7 例，有效率为63.2%。治疗后 3 月有12例复查心电图，其中显效 6 例，改善 4 例，无变化 2 例，

周裕民等 羊肠线埋植法治疗冠心病30例疗效观察 湖南中医杂志 (2), 34, 1991

8. 冠心病心绞痛

电 针 法

(1) 取厥阴俞透心俞、内关；(2) 机理：心俞是心经的俞穴，主治心病，厥阴俞是心包经俞穴主治心病，内关是八脉交会穴和心包经的络穴主治胸心病证。(3) 针刺方法：取上述穴位，有针感

后再通电至耐受为度，每日一次，每次20分钟，7次为一个小疗程，21次为一个大疗程。（4）针刺强度：选用电针针麻治疗仪，用脉冲电连续波频率为150赫兹，波宽300毫秒，根据病人耐受情况随时调节强度大小。

共治疗30例。心绞痛症状疗效：显效10例，占33.3%，好转18例占60%，无效2例占6.7%，总有效率为93.3%，心电图疗效：显效4例占13.3%，好转6例占20%，无变化20例占66.7%，总好转率为33.3%。治疗前后做胆固醇检查者27例，经治疗胆固醇下降20mg%者8例占29.6%。接受治疗的病人普遍睡眠好转，食欲增加，精神状态好转。30例病人中合并高血压者17例，治疗后收缩压下降20毫米汞柱者共15例占88%，舒张压下降10毫米汞柱者12例占70.6%。

金燭莉 电针治疗冠心病心绞痛30例 中国针灸 (2); 4, 1987

针 刺 法

1. 取穴：主穴内关，配穴膻中或心俞。

2. 手法：内关约60°角，向心斜刺0.5~1.2寸。膻中约15°角，向下斜刺0.5~1.5寸。心俞约30°角，向脊柱斜刺0.5~1.0寸，勿深刺伤及壁层胸膜，内关提插捻转，膻中、心俞捻转，持续行针至心绞痛消失。其后，酌情留针。一般20~30分钟，个别2小时许。

共治疗5例，均获迅速止痛效果。其中3例内关配膻中，2例内关配心俞，均同样迅速止痛。其中1例，连续发作3晚，连针内关、膻中3晚，每晚均迅速止痛，其后一直未复发。

刘祝尧 针刺治疗冠心病心绞痛5例报道 湖南中医杂志 (2); 13, 1990

9. 高血脂症

氦氖激光法

以波长6328Å，输出功率2~3mm，光斑直径为1~1.5mm之

G2—1A氩氦激光纤维光针仪（上海医用激光仪器厂生产）直接置于内关穴上，两侧交替照射，每日一次，每次15分钟，10~12次为一疗程，休息3~5天后再进行第2疗程。治疗期间停用其它降血脂药物，且不并用对血管有影响的药物。不增加体力活动。饮食习惯如常。全部病例在治疗前后均经详细询问病史及体检，并在治疗前后进行血胆固醇测定。

经治疗后，50例血胆固醇增高降脂疗效之患者中，37例有不同程度之下降（74%）。下降最多者为106mg%。平均降低20.12mg%，经统计学处理， $P < 0.01$ 有非常显著差异。

彭悦 氩氦激光照射内关穴治疗高脂血症50例的临床观察 中国针灸（2），15，1986

针 刺 法

穴位选择：风池、足三里、三阴交。高血脂者加内关，肝火亢盛者加太冲，肝肾阴虚加太溪，痰湿壅盛者加丰隆。手法：风池穴用捻转泻法为主；内关、足三里用平补平泻法；三阴交用捻转补法为主；太冲、丰隆穴用泻法；太溪穴用补法。留针20分钟，隔日针刺1次，连续治疗6周。

共治疗18例。一、治疗前后血压变化：治疗前血压（ $\bar{x} \pm S$ ，下同）为 $20.5 \pm 1.0 / 14.0 \pm 0.5$ KPa，治疗后为 $18.0 \pm 1.0 / 12.0 \pm 0.5$ KPa。收缩压平均下降2.5KPa，舒张压下降2.0KPa，均有显著意义（ $P < 0.01$ ）。

二、治疗前后血脂变化：胆固醇治疗前为 164.2 ± 33.8 mg%，治疗后为 172.5 ± 38.0 mg%，统计学处理无显著性意义。甘油三酯治疗前为 265.0 ± 119.2 mg%，治疗后为 126.1 ± 81.3 mg%，有显著差异（ $P < 0.05$ ）。

殷之放 针刺治疗高血压高血脂18例 浙江中医杂志（11），520，1990

第五节 泌尿系统疾病

1. 尿 道 炎

耳 针 法

患者取坐位或仰卧位，以外生殖器、肾为主穴，内分泌、尿道为配穴，两耳交替针刺，一次选取2~3个穴位。常规消毒后，医者右手持针，左手拇、食两指固定穴位，中指顶于耳背防护，垂直刺入，留针15~20分钟，5~10分钟行针一次，每日一次，7次为一疗程。

治疗17例中，2例针1次后症状消失，其余均针2~4次后症状消失，1例20天后症状复发，遂又针刺2个疗程，至今未复发。

谢树清 耳针治疗尿道炎 中国针灸 (2); 56, 1987

2. 小便不禁

温 针 灸 法

1. 取穴：肾俞、膀胱俞、关元、气海、足三里。2. 方法：分两个阶段，先让患者俯卧取背部俞穴，每穴温针灸3艾段，每段2.5cm长，时间约20分钟后起针，然后再让患者仰卧，取腹部穴位及足三里，方法同上。隔日1次，15次为1个疗程。

治疗1个疗程症状完全消失且随访半年以上无复发者为痊愈；经治疗后小便不禁次数明显减少或症状已消失但随访偶有复发者为好转；治疗1个疗程症状无改善者为无效。共治疗35例，痊愈24例，好

转10例，无效1例。

姜旭强 温针灸治疗小便不禁35例·陕西中医 (7), 306, 1990

3. 泌尿系统结石

山莨菪碱耳穴注射法

先用耳穴探查仪在两侧耳部穴位如：肾、输尿管、肝、脾、交感、三焦、内分泌、耳尖、皮质下等穴位检查，找准阳性反应点均可作为药物穴位注射点。选用 1ml 兰芯注射器套上 4 号普通针头，抽取盐酸山莨菪碱注射液 0.1ml (含 0.1mg) 再抽注射用水至 1ml 混合。每次选用阳性耳穴点 3~5 个。每穴皮内注射上述混合液 0.1ml，两耳交替，每隔 3 日注射一次，10 次为一疗程，一疗程结束后，X 线摄片复查对照。治疗中嘱病人口服 P. P. A，并注意观察记录排石情况。

共治疗 410 例治愈：临床症状消失，结石排出，X 线摄片（腹部平片或静脉肾盂造影）结石影消失。显效：临床症状明显减轻或消失，排出结石一块以上，X 线摄片结石数量减少。有效：临床症状减轻，X 线摄片，结石位置下移 5cm 以上。④无效：X 线摄片复查结石位置无移动。

治疗结果：治愈 337 例（占 82.2%），显效 40 例（占 9.7%），有效 29 例（占 7%），无效 4 例（占 1.1%）。排石 377 例，排石率 91.9%。377 例排石者，55 例治疗一次后排出结石，72 例治疗三次后排出结石，56 例治疗五次后排出结石，42 例治疗八次后排出结石。377 例排石者，其 79 例为肾结石，290 例输尿管结石，7 例膀胱结石，1 例尿道结石。排出最大结石为 $2.0 \times 1.5\text{cm}$ ，最小为 $0.5 \times 0.4\text{cm}$ ，排出结石数量最多者为 6 块，排出结石最快者为治疗后 1 小时，最慢者为 42 天。结石部位越靠下，越易排出。

王志英等 山莨菪碱耳穴注射治疗尿石症 410 例 北京中医

针 刺 法 (一)

1. 取穴: 主穴: 京门、肾俞。配穴: 足三里、三阴交、阿是穴等。

2. 嘱患者屈膝侧卧, 患侧在上。穴位消毒后针刺患侧京门, 针刺肾俞透京门、足三里或三阴交选用一穴即可, 给中强或强刺激, 得气后留针30分钟。每3~5分钟行针一次, 每日1~2次, 7日为一疗程。疗程后停针1~2天再行针刺。

共治疗150例。绞痛: 针刺5~20分钟停止绞痛108例, 21~30分钟停止绞痛26例, 31~40分钟停止绞痛16例。在当日再次出现绞痛21例, 经再次针刺后绞痛停止。其止痛有效率100%。

排石: 针刺3日内排石9例, 4~7日内排石31例, 8~14日内排石37例, 15~21日内排石15例, 22~49日内排石8例, 50~100日内排石11例。总排石率为74%。排石所需时间平均为16.4天。余下39例中, 结石都有不同程度的下降和缩小, 最多下降18毫米。所有排出结石患者, 都作了X线摄片复查, 证实结石阴影消失。

杨丁林 针刺治疗尿系结石及绞痛 150 例初探 中国针灸 (4); 9, 1987

耳穴埋压法

1. 耳穴埋药按压: 用王不留行子贴下列穴位: 肾、输尿管、膀胱、神门、交感、外尿道、肾上腺。每日按压2~3次, 每次持续20分钟, 两耳隔日换贴1次。

共治疗66例。以治疗一个疗程以上为观察对象, 治疗中止后排石不统计在内。治愈: 结石排出, 复查全尿路平片或排泄性尿路造影结石阴影消失。有效: 有排石, 但未排尽或结石位置下移, 摄片结石阴影减少或下移一个椎体以上。无效: 结石未排出, X片提示结石在原

位置或结石下移<2厘米。

66例中，治愈26例，有效8例，无效32例，治愈率39.39%，总有效率51.52%。

沈心豪 以耳穴埋压为主综合疗法治疗肾、输尿管结石87例临床观察 上海中医药杂志 (11)，17，1986

针药结合法

针灸：以迎随补泻法针刺太溪（补）、飞扬（泻）京门（平补平泻）、三阴交（多用泻法）。肾区绞痛时针刺涌泉穴，泻法，留针30~60分钟，每隔6~7分钟捻转一次。其它四穴每日针刺一次，10次为一疗程，休息四天再进行第二疗程。

中药：冬葵子18克，石苇12克，滑石15克，川断12克，白术12克，鳖甲15克，王不留行12克，川牛膝12克，生蒲黄10克，胡桃肉10克，琥珀末3克，车前草12克。有明显瘀血指征者加三棱、莪术各9克，湿热表现明显者，加金钱草30克。

共治疗118例。排出结石或X线摄片示结石阴影消失者为痊愈；见结石向下端移动但未排出者为显效；治疗后症状消失，但未排石，X线下未见结石移动或移动不明显者均为无效。

118例中，痊愈72例，占61%；显效28例，占23.7%；无效18例，占15.2%。5~10天排石者12例；10~20天排石者21例；20~30天排石者25例；30天以上排石者14例。

江有源 针药结合治疗尿路结石118例临床报道 中国针灸 (1)，5，1987

电针法

多选用肾、膀胱穴，（XD型耳穴电疗器备有探穴装置，为选穴提供依据），将该治疗器的正负极两个夹子置于所选耳穴上。每日一次，每次30分钟，左右耳交替治疗。

治疗结果 经本疗法治疗（疗程最短为一月余，最长为三个月），结果结石排出而痊愈者3例，结石下移者25例，病情稳定者19例，3例无效而改手术治疗，有效率为56%。

曾锐 电针刺激耳穴治疗泌尿系结石 50例 湖北中医杂志 (5); 16, 1989

针刺法（二）

用26号4寸长毫针，病人取侧卧位，主穴取京门透肾俞，配穴取足三里，一般采用强刺激手法（以病人能耐受为度），大幅度快速捻转，刺激50~100次，患者有较明显麻胀感，不留针。同时嘱患者多饮水，加强活动，以利结石向下移动。

我们对30例输尿管结石患者，采用单纯针刺治疗，取得了满意效果。

慈文江等 针刺治疗输尿管结石 上海针灸杂志(1); 45, 1987

针刺法（三）

主穴：关元、中极、太溪（双侧）、三阴交（双侧）。

配穴：太冲（双侧）、大横（病侧）、京门（病侧）。

手法：关元，行轻刺激施补法，补肾固本。

中极、太溪、三阴交，捻转提插，行重刺激施泻法，清泻湿热，通淋排石。

配太冲、大横、京门提插泻法，行气开郁止痛。

针刺关元、中极得气后，行手法使针感传至前阴，大横、京门取一侧，针感由同侧传至前阴及会阴部，三阴交、太溪、太冲针双侧使针感上传过膝。

留针30分钟，每隔5~10分钟施手法予强刺激。以增强肾盂的收缩及加强输尿管的蠕动易使向下排石。

21例经针刺2~5次，疼痛基本消失。

最快者于针刺 8 天后石排出，2 例最慢者于针刺 34 天后排出，大部分在针刺 2 ~ 3 周结石排出。

魏仲华 输尿管结石针刺治疗体会 天津中医 (5), 29, 1988

4. 肾绞痛

踝 针 法

病人取俯卧位。在肾绞痛区同侧小腿内、外踝骨隆起最高点上方三横指处各取一个进针点。内侧进针点在小腿内侧面中央，靠胫骨内侧缘；外侧进针点在小腿外侧面中央，腓骨嵴与邻近肌腱（腓长肌肌腱）所形成的浅沟内。

常规消毒皮肤。用 30 号的 1.5 寸不锈钢毫针二根，分别在内、外侧进针点与皮面呈 30° 角倾斜向上，快速刺入皮肤，然后将针放平，沿皮肤向上捻转，进针 1.4 寸左右即可。胶布固定后，可让病人起床缓慢行走。留针 30 分钟。若针法正确，病人多自感疼痛逐渐减轻以至消失。

针法正确的关键在于针体应尽可能紧贴真皮下潜行。我们在治疗中体会到，当绷紧皮肤时，能见到位于真皮下的针体略呈直线状隆起，即为针位正确的标志。凡遇进针有阻力，绷紧皮肤见不到线状隆起，或扪不到针体，病人有酸麻胀痛的感觉，均表示进针过深，应退出重新施针。

本组 101 例均未发生晕针或断针现象。

疗效标准制定如下。疼痛消失：踝针治疗后疼痛消失，不需要用任何镇痛、解痉药物；疼痛好转：踝针治疗后疼痛减轻，但未消失，尚需辅以解痉药物如阿托品或山莨菪碱等；无效：踝针治疗后疼痛无变化，需要用镇痛药物如杜冷丁或强痛定等。

本组 101 例经踝针治疗一次后，疼痛消失 82 例 (81.2%)，疼痛好转 12 例 (11.9%)，无效 7 例 (6.9%)，总有效率为 93.1%。

张先涛等 踝针替代杜冷丁治疗肾绞痛 中医杂志 (11), 43, 1987

针 刺 法

针刺双侧太溪穴，中强刺激，以患者有发麻胀样针感并向足等部位放散为度。留针 30—90 分钟。留针过程中也可间断刺激，加强针感。如恶心、呕吐甚者可加刺双侧内关穴。多数患者无需间断刺激及配穴。

共治疗23例。经针刺 1—3 次疼痛基本消失者18例，明显减轻者 5 例，总有效率100%。

王志义 针刺治疗尿石所致绞痛23例疗效观察 中国针灸(5), 21, 1986

5. 尿潴留

针刺法 (一)

针刺穴位：关元、水道（双）、三阴交（双）。常规消毒皮肤后，快速直刺，进针后用捻转和上下提插手法，取得针感后留针15分钟，每日一次，至小便通畅。

59例患者中，最短的针刺 1 次即愈，最长 7 次痊愈。59例中，痊愈51例，好转 7 例，无效 1 例。总有效率为98.3%。值得提出的是，神经性尿潴留患者痊愈率达100%。

漆菊英 针刺治疗尿潴留 59 例疗效观察 江西中医药 (3), 57, 1990

针刺法 (二)

取关元、阴陵泉、三阴交、膀胱俞，针刺得气后留针20分钟。间

隔10分钟捻转一次，注意针刺关元穴，针感须向下放射至会阴部；针刺阴陵泉、三阴交穴，针感有不同程度的向上放射，并根据虚实情况采取补泻手法。

共治疗38例，全部治愈。其中痔术后尿潴留，一般针刺1—3次即能自动排尿；产后尿潴留，针刺1次均能自动排尿；有1例截瘫患者，因尿潴留后一直作保留导尿，仅针刺1次即自动排尿。

邹仲清 针刺治疗尿潴留38例 陕西中医 (12)，553，1987

电 针 法

取穴水道（双侧）、中极、三阴交（双侧）。针刺双侧水道透中极，采用15度角进针，强刺激，以病人不感痛为宜，频率2次/秒，时间10~15分钟；三阴交用1.5~2寸针，进针后提插捻转，得气后留针10~15分钟，针感要上传至膝。

本组15例，14例均针1次排尿。1例年龄较大患者针刺后排出部分潴留尿液。总有效率100%。

侯美荣 电针治疗尿潴留 山东中医杂志 (6)，49，1990

6. 慢性前列腺炎

针 刺 法 (一)

1. 经外前列腺炎特定穴（待定名）：位于任脉经会阴穴至肛门的中点。2. 针法：采用泻法，留针。用28号3~4寸毫针，直刺1.5~2寸深，待得气后小幅度提插2~3次后，间或捻转，留针约20分钟出针。每日1次，10次为1疗程。

共治疗30例。9例治愈（症状消失，前列腺液检查：WBC+以下，卵磷脂小体++以上）。15例显效（症状基本消失，前列腺液检查：WBC+，卵磷脂小体++）。3例好转（症状减轻，前列腺液检

查：WBC 较治疗前减少，卵磷脂小体+）。3例无效（症状化验治疗前后无变化）。

韩崇华等 经外选穴治疗慢性前列腺炎三十例 浙江中医杂志 (6); 280, 1988

针 刺 法 (二)

穴位：关元，中极，阴陵泉，三阴交，会阳，肾俞。

针法：两组穴位均采用泻法，不留针。会阳穴用26或28号的3~4寸毫针，直刺2~3寸深，当患者的会阴部出现酸胀感时，提插3~5次后出针。肾俞穴用28号2寸针，斜向脊椎方向刺入1寸左右，待局部有酸胀感时出针。每日或隔日针1次，10次一疗程。

共治疗80例。治愈：自觉症状消失，前列腺液常规检查：白细胞数10个以下/高倍视野，卵磷脂小体75%以上，共32例。显效：自觉症状基本消失，前列腺液常规检查：白细胞较前减少2/3以上/高倍视野，小体在50~70%之间，共17例。好转：自觉症状减轻，前列腺液常规检查：白细胞数较前减少，小体较治疗前增多，共15例。无效：症状无变化或虽有改善，但化验检查无变化，共16例。

徐笨人等 针刺治疗慢性前列腺炎80例 中国针灸 (2); 19, 1987

氦氖激光法

采用激光针灸仪，光纤直径为50/125微米，末端输出功率为1.8 mW。消毒患者会阴穴周围，用特制的空心针，将光针插入针芯，左食指插入肛门内为引导，从会阴穴刺入前列腺内每日照射1次，每次20分钟，4次为1疗程，不愈者，休息一周再行第二疗程。

共治疗30例。临床症状完全消失，前列腺大小恢复正常者为痊愈，共19例。症状明显改善，前列腺大小恢复正常为好转，共10例。症状稍有改善或无改善，前列腺仍有肿大者为无效，共1例。

7. 阳 萎

针 灸 法 (一)

按中医辨证分四型, 主穴均取肾俞、关元、三阴交, 针用补法。

1. 肾阳虚衰型 (28例): 治以温肾壮阳, 加取命门、足三里, 针后加灸。

2. 肝郁气滞型 (23例): 治以疏肝解郁, 加取太冲 (泻法)、气海 (平补平泻)。

3. 阴虚阳亢型 (16例): 治以滋阴潜阳, 加太溪 (补法)、太冲 (泻法)。

4. 湿热下注型 (9例): 治以清热利湿, 加次髎、气冲、阴陵泉、行间, 均用泻法。

其中关元向曲骨方向透刺, 使针感向龟头放射为佳。隔日针刺一次, 留针30分钟, 10次为一疗程。

共治疗76例。治愈: 性功能恢复正常, 同房成功, 随访1个月无复发。有效: 性功能基本正常, 同房成功, 但持续时间未达原有水平。无效: 经三个疗程治疗后, 病情无明显好转。

76例经三个疗程治疗后, 治愈 49 例, 占64.4%; 显效19例, 占25%; 无效 8 例, 占10.6%; 总有效率为89.4%。

何玉倍等 针灸治疗阳痿76例临床观察 江苏中医 (3), 25, 1989

针刺及穴位药物注射法

(一) 针刺: 取穴: 关元、三阴交 (双)。操作: 针关元前, 让

患者排空小便，针尖稍向下，刺入1寸左右，行平补平泻手法，使麻胀针感沿任脉向下部可达龟头。疗程：每日针刺1次，7次为1个疗程，休息7天后再进行下个疗程。

(二) 穴位药物注射：取穴：八髎穴。先将其左右八穴取准，用龙胆紫或拇指重掐为记以便注射。药物：5%葡萄糖液31毫升，硝酸士的宁注射液1支（2毫升/1毫升），将上药抽入接有6½或7号针头的50毫升注射器内，充分混合备用。注射法：令患者反坐在靠背椅上，穴位皮肤常规消毒，将注射针先后垂直刺入以上八穴各1寸深，每次分别注入药液4毫升。必须使针刺入骶孔中（针下有落空感为准），抽无回血后方可注入药液。一般每隔2日注射1次，3次为一个疗程。一个疗程结束后休息7天，再开始下一个疗程。

共治疗34例，近期治愈28例（阴茎能正常勃起，举而坚挺有力，性交成功），其中经1个疗程治愈21例、2个疗程治愈7例，近期治愈率占82.3%。

来心平 针刺及穴位药物注射治疗阳痿 中国针灸（2）：55，1986

针 灸 法（二）

针刺方法：取穴：病人仰卧，在阴包穴上2寸许，压痛明显处（双侧）消毒后进针，深度为1.5~2寸，得气后以针感向外生殖器放射为宜，用补法。留针30分钟，每10分钟捻针1次。同时艾灸双侧列缺穴，每穴5~10分钟，七天为一疗程。

张润民等 针灸治疗阳痿 四川中医（4）：48，1991

士的宁穴位注射法

1. 药物：士的宁注射液（上海第七制药厂），为中枢兴奋药，对大脑皮层及视听分析器有一定的兴奋作用，但本品毒性大，在治疗中要特别注意，严格掌握剂量。

2. 选穴和操作，取穴分为两组，一组为关元、百会；二组为太溪、哑门。两组穴位轮流使用。

穴位注射时，患者要取卧位，局部常规消毒后，以六号针头刺入5分至1寸，待有针感后，每穴注入土的宁1mg，推药要缓慢，注射毕休息15分钟。3日1次，3~7次为一疗程。

本组25例中近期治愈24例，占97.5%；好转1例占2.5%。起效时间，有的注射后当天见效，最晚7天。平均时间3天，一般不少于一疗程。在我们治疗中，无一例出现过副作用。

刘建洪 土的宁穴位注射治疗阳痿25例 中国针灸 (1)，43，1986

8. 功能性不射精

针刺法 (一)

取穴：曲骨、足五里、三阴交。

针法：针刺前令患者排净小便，足五里用28号三寸毫针，曲骨和三阴交用28号二寸毫针，穴位和捻针的手指均用75%的酒精严格消毒，快速进针，足五里用提插捻转手法，使针感传至会阴。曲骨进针后单用捻转手法，使下腹和外阴感到有酸、麻、胀为止。三阴交用提插捻转手法，使小腿内侧有酸、麻、胀为止。如阴茎持久不萎，可加刺太冲，以泻肝经之郁火；如有阳痿，可加刺太溪、照海、次髎，加灸神阙、关元以益肾壮阳。留针30分钟，每日针一次（星期日休息），10次为一疗程。同时给以性知识辅导，如经一疗程未愈，休息一周后，再进行下一疗程。

共治疗130例。同房能正常射精为治愈，130例中治愈118例，治愈率90.7%，在治愈病例中，一疗程内治愈者93例，占治愈病例78.9%，二疗程内治愈者18例，占治愈病例15.1%，三疗程内治愈者5例，占治愈病例4.2%，四疗程内治愈2例，占治愈病例1.6%；经

四疗程治疗未愈者为无效，共12例，无效率9.3%。

江玉文 针灸治疗功能性不射精 130 例临床观察 北京中医
(2); 37, 1990

针刺法 (二)

主穴: (1) 关元、归来; (2) 气海、大赫;

配穴及手法: 归来、大赫均用青龙摆尾、赤凤迎源法; 关元、气海及配穴依各型选择。

配穴: 肾阳不足型: 足三里、三阴交, 用烧山火法。阴虚火旺型: 太溪、三阴交, 用阳中隐阴法。湿热下注型: 太冲、阴陵泉, 用透天凉法。虚实不明显型: 太溪、足三里、三阴交, 用导气法。

每天治疗 1 次, 间歇运针 30 分钟, 针刺腹部穴位务使针感到达龟头, 下肢穴位针感亦应有较长距离的传导。两组主穴各疗程交替使用, 7 天为一疗程, 每疗程间隔 5 天。

共治疗 39 例。在 5 个疗程以内, 性交能射精, 随访半年未见复发者为痊愈, 否则无效。共治愈 35 例, 痊愈率 89.7%, 有效者最快治疗 5 次, 最慢 35 次。

袁少英 针刺治疗功能性不射精症 39 例 上海中医药杂志 (3),
25, 1991

电针加灸法

取穴与治法: 第 1 组取穴, 三阴交 (双)、关元、中极、曲骨; 第 2 组取穴, 会阴、会阳、次髎、肾俞。治疗两天为一疗程。第 1 日, 用 3 寸不锈钢毫针, 刺关元、中极、曲骨穴, 进针 2.5 寸, 以向下传导酸麻胀感为度 (曲骨应传导至阴茎, 均应慎用), 然后再刺三阴交 (双), 进针 2 寸, 以酸麻胀感为度, 留针 20 分钟, 接电疗器 (B. T701 型)。第 2 日, 改用 2 寸不锈钢针, 刺会阴穴, 进针 1 寸, 然后取膝胸卧位, 刺会阳、次髎、肾俞等穴, 进针 1 寸, 接电疗器,

通电留针20分钟。另加艾灸上述穴位。休息一天，再行第2个疗程。个别患者曾结合服用“通窍活血汤”加减。

共治疗25例，有24例痊愈。其中，经2次治愈者8例，3~7次治愈10例，10~20次治愈6例；大多数患者，愈后妻子即怀孕。

郭连澍等 电针加灸法治疗射精不能症 中国针灸 (1)；55, 1986

9. 精液异常

针 灸 法

取穴：主穴：关元、中极、命门、肾俞。配穴：精子活力减弱、畸形者加足三里、三阴交、太溪；计数减少者加蠡沟、次髎；不液化者加三阴交、气海、太溪；前列腺炎者加会阴、次髎。

操作：刺关元、中极、气海时，要求针尖向下斜刺1.5~2寸，然后采用捻转补法，使针感向下传导至阴茎或会阴部为止；刺腰骶及其他部位诸穴，要求局部出现温热感或酸胀感；留针30分钟，针后加灸关元、命门、肾俞、足三里，以局部皮肤充血潮红为度。

疗程：隔日一次，20次为一疗程。每个疗程后复查精液常规，伴前列腺炎者再复查前列腺常规，与治疗前的检测指标对照。若常规转为正常，应再复查一次；若未转为正常，休息一周后，继续治疗。

共治疗78例。1.痊愈：临床症状与体征消失，精液常规各项指标均恢复正常或治疗期间其妻妊娠。

2.好转：临床症状和体征基本消失，精液常规较治疗前有较大进步，符合下列两项以上者：（1）每毫升精子密度提高 20×10^6 个以上；（2）一次排精量中精子总数提高 100×10^6 个以上；（3）精子活动率提高20%以上；（4）精子运动级别提高一级以上；（5）伴前列腺炎者，临床治愈。

3.无效：临床症状与体征虽基本消失，但精液常规改善不显著。

78例患者，痊愈48例，占61.5%（其中女方妊娠15例，占痊愈病例的31.3%）；好转19例，占24.4%；无效11例，占14.1%；总有效率为85.8%。

刘 喆 针灸治疗精液异常型不育症 78 例疗效观察 江苏中医
(8)；19, 1989

10. 精液不液化症

针 灸 法

取穴：关元、中极、肾俞、三阴交。阴虚火旺者加太溪、照海、神门。湿热下注者加次髎、会阴（或曲骨）、阴陵泉、丰隆。

操作：刺关元、中极、曲骨时，针尖向下斜刺1.5~2寸，采用捻转手法，使针感向下传导至阴茎或会阴部为止。针肾俞、三阴交时，要求局部有酸胀或麻热感；针次髎与会阴时，要求会阴部产生较强针感。

疗程：隔日一次，10次为一疗程。疗程结束后复查精液常规，伴前列腺炎者再复查前列腺常规，与治疗前对照。若转为正常，应再复查一次；若未正常，休息一周后，继续治疗。

共治疗32例。痊愈：临床症状与体征消失，精液液化时间为30分钟以内，精液中脓细胞及前列腺常规转为正常者26例，占81.25%。

好转：临床症状与体征基本消失，精液液化时间缩短，但未达到正常范围，其它检查亦未完全转为正常者6例，占18.75%。

其中女方妊娠人数：痊愈者中为12例，好转者中为1例，合计为总数的40.63%。

刘 喆 针灸治疗精液不液化症32例临床小结 江苏中医 (2)，
23, 1990

11. 不育症

针灸法（一）

取穴：主穴：肾俞、次髎、关元、气冲。配穴：阳萎配：足三里、太溪。不射精配：三阴交、太冲、阴陵泉。精子异常配：足三里、太溪、太冲、命门、挟脊。

操作方法：

1. 先刺腰骶部诸穴，不留针，继针刺腹部及下肢穴位，留针半小时，需灸者，用艾条温和灸关元穴20分钟。

2. 针刺腹部诸穴，采用直刺或针尖向下呈75度角斜刺1.5~2寸，然后再采用捻转手法使其针感向下传导至会阴部为止。针感弱者，采用留针候气或用右手中指端，循环轻按穴位的上下以助经气的来复后再行针，催气之法。

3. 若针感向上传导，病人即感腹部不适，即将针身上提，轻揉按所刺之穴位，再略改变进针（向下或内下）方向，得气后不急于放手而略加运气。

4. 疗程：隔日治疗一次，20次为一疗程。精液异常的，每治疗一个疗程复查精液常规。如果未痊愈的，休息一周后，继续治疗。若中断治疗或四个疗程无变化者称之无效。

共治疗248例。阳萎：痊愈：阴茎勃起坚硬，同房成功，共42例。好转：阴茎勃起较治疗前坚硬，性欲有所增强，共66例。无效48例。

不射精：痊愈：射精通畅有快感，共34例。无效11例。

精子异常：痊愈：精虫总数超过6000万/ml。活动力达到60%以上，畸形降到20%以下，共13例。好转：精虫总数增长2000万以上，活动力提高20%以上，畸形减少但仍不低于20%（以上三项中达到其中两项者），共11例，无效26例。

张家声 针灸治疗男性不育症 248 例 临床观察 (1); 3,
1987

针灸法 (二)

(一) 取穴: 第一组: 太溪、三阴交、关元、肾俞、复留。第二组: 照海、阴陵泉、气海、志室、地机。配穴: 随证加减穴位, 如伴失眠加百会、内关; 脾胃虚弱加足三里; 阳痿加次髎, 灸命门。

(二) 操作: 采用提插和捻转手法, 得气后留针15~20分钟加艾灸。针刺关元、气海时, 一定要使针感放射到前阴部, 有胀、热、勃感为佳。

以上穴位隔日轮流交替使用, 10天为一疗程, 两疗程之间休息一周。

共治疗45例。治愈: 精液常规检查恢复正常。显效: 精液常规检查基本恢复正常。有效: 精液常规检查较治疗前有所好转。无效: 治疗5个疗程, 精液常规检查无明显变化。

本组45例, 治愈22例, 显效13例, 有效6例, 无效4例, 总有效率为91.1%, 其中显效率为77.7%。

陈言霞等 针灸治疗45例男性不育症临床观察 天津中医 (3), 11, 1988

第六节 血液、新陈代谢、 结缔组织疾病

1. 白细胞减少症

穴位敷贴法

一、药物组成: 本方由人参(以红参为佳)15克, 补骨脂、当

归、红花各10克，附子、干姜、血竭各6克。上药共为细末，装瓶备用。

二、穴位及用法：所取穴位有脾俞（双）、胃俞（双）、肾俞（双）、肝俞（双）、足三里（双）、中脘、血海。将上药末调入生理盐水，搅拌成泥膏状，取适量置于穴位之上，用胶布固定。每3天换1次，连续5~10次。在观察期间除白细胞 $<2000/\text{mm}^3$ 者加用青霉素外，一律停用其它升白细胞药物。

共治疗40例。①显效：临床症状消失，白细胞较前增高 $2000/\text{mm}^3$ 以上，且于治疗后3个月内白细胞数稳定者。②有效：临床症状基本消失，白细胞较前增高 $1000\sim 2000/\text{mm}^3$ ，但停药后3个月内白细胞数有轻度起伏者。③无效：临床症状改善轻微或无改善，白细胞数增高 $1000/\text{mm}^3$ 以下，或未见升高者。

40例中，显效27例，有效11例，无效2例，总有效率为95%。其中17例血色素减低者，有16例升至正常（11克以上），12例血小板减少者，均升至正常范围（10万以上）。

郭文灿等 中药穴位敷贴治疗白细胞减少症40例 浙江中医杂志（4）；158，1991

2. 化疗引起白细胞减少症

针 灸 法

患者在化疗期间凡白细胞值低于 $4 \times 10^9/\text{L}$ 时立即停用化疗及其它对白细胞有影响的药物。

1. 温针组（121例）主穴：双侧足三里、三阴交。配穴：内关、阴陵泉、关元、气海、血海。穴位常规消毒。双侧足三里穴用1.5寸或2寸长28号毫针针刺，得气后将毫针留在适当深度，于针柄口插置一段长约2~3cm的艾条，点燃施灸。三阴交施以提插与捻转相结合的补法。根据患者临床症状每次取配穴2~3个，施以相应

的提插捻转补泻手法。每日治疗1次。

2. 艾柱灸组(221例)取穴:大椎、膈俞、脾俞、胃俞、肾俞。除大椎穴外,余穴均取双侧。将艾绒捏成直径约1.5cm,高1.8×2cm的圆锥形艾柱27个,把鲜姜切成直径2~3cm、厚约0.3cm的薄片备用。患者取俯卧位,暴露背部,选取以上诸穴,每穴置鲜姜1片。把艾灸点燃后分别放在姜片上,使其自然燃烧。当艾柱燃烧到4/5,患者有烧灼感时,易柱再烧,每次连灸3次。灸后以穴位局部皮肤红润但不起泡为佳。每日治疗1次。

共治疗376例。显效:治疗6天内白细胞值上升至 $4 \times 10^9/L$ 以上者,温针组共89例,艾柱组共173例。有效:治疗7~9天白细胞值上升至 $4 \times 10^9/L$ 以上者,温针组共18例,艾柱组共28例。无效:治疗9天后白细胞值仍在 $4 \times 10^9/L$ 以下者,共14例,艾柱组共20例。

陈惠玲等 针灸治疗化疗引起白细胞减少症376例疗效观察 中西医结合杂志 (6); 350, 1991

3. 苯引起白细胞减少症

针 刺 法

(1) 取穴:大椎、命门、足三里、三阴交。(2) 刺法:大椎穴用拇指后退为主的捻转泻法;命门穴用拇指前进为主的捻转补法;足三里、三阴交穴用拇指前进为主的捻转,结合重按轻提的补法。留针30分钟。(3) 疗程:隔日针刺1次,6周为1个疗程。

共治疗30例。1. 显效:症状显著改善,白细胞计数平均增加 $1000/mm^3$ 以上,共15例。

2. 好转:症状改善,白细胞计数平均增加 $500/mm^3$ 以上,共11例。

3. 无效:症状改善不多,白细胞计数变化不大,共4例。

殷之放 针刺治疗苯引起白细胞减少症30例疗效观察 江苏中医

4. 血液病出血

针药并用法

184 例均以中药、针灸为主治疗,个别病人采取了中西医结合方案。

(一) 子宫出血: 中药: 党参40克, 白术10克, 黄芪50克, 山药30克, 茜草10克, 煅龙骨30克, 煅牡蛎30克, 乌贼骨30克, 黑地榆30克, 五倍子5克(研末冲服), 白芍30克, 每日一剂, 水煎服。

针刺: 断红穴: 位于第二、三掌骨指端下一寸处, 25~45度进针八分~一寸, 留针15分钟, 每日一次, 连续3~5天。

(二) 皮下出血: 黄芪30克, 党参30克, 白术10克, 茯苓10克, 陈皮10克, 茜草10克, 红花5克, 丹皮10克, 每日一剂, 水煎温服。

(三) 胃肠出血: 黄芪30克, 党参30克, 三七10克(研末冲服), 白芍30克, 紫珠草30克, 甘草5克, 黑大黄10克, 黑地榆30克, 花蕊石30克, 水煎服, 日1~2剂。

(四) 脑出血昏迷(闭证): 中药鼻饲方: 羚羊角粉3克, 生石决明15克, 生地30克, 丹皮10克, 白芍10克, 龟版15克, 益母草30克, 三七10克, 同时鼻饲至宝丹或安宫牛黄丸, 日一次, 中药每日一剂。

(五) 鼻、齿龈出血:

1. 鼻出血: 安络血1毫升, 双侧孔最穴封闭。

2. 齿龈出血: 安络血1毫升, 双侧伏兔穴封闭。

附:

①内服中药者要注意辨证施治, 有阴虚证者加旱莲草、黄柏、元参、生地、熟地。气虚较甚者加重参、芪剂量。失血较多, 有虚脱证

者加入参以益气固脱，阳虚者加附子、黑姜，有瘀血征象，或长期反复出血不愈者加黑大黄、三七等以化瘀止血。

②脑出血及胃肠道出血者加6-氨基己酸，止血环酸、止血敏等。

③出血量较多，贫血严重者可给以输血，以鲜血为佳。

共治疗184例。痊愈：出血控制，症状消失。显效：出血基本控制，或明显减少，症状好转。无效：症状无改善或死亡者。

子宫出血64例，痊愈者48例，占75%；显效9例，占14%；无效者7例，占11%。鼻齿龈出血者83例，痊愈者44例，占53%；显效者21例，占25.3%；无效者18例，占21.7%。皮下出血者33例，痊愈者27例，占81.8%；显效6例占18.2%。胃肠道出血2例，脑出血3例，虽经中西医结合治疗，但因出血量较大，病情严重，均死亡。

李富生等 针药并用治疗血液病出血184例临床观察 天津中医(3)；7，1988

针 灸 法

1. 主穴：地机、孔最。

2. 各病配穴：

①门静脉性肝硬化（胃底与食管静脉曲张破裂引起大出血）：配郄门、梁丘。

②支气管扩张咯血：配郄门、太溪。

③肺痿咯血：配郄门、太溪。

④过敏性尿血：配血海、三阴交。

⑤肾绞痛尿血：加10%葡萄糖18毫升、维生素B₁100毫克，穴位注射肾俞15毫升，三阴交5毫升。

⑥创伤鼻血：单取主穴。

⑦胃癌术后创口渗血不止：配郄门、梁丘。

⑧小肠切除术后便血：配下巨虚。

⑨妇女倒经鼻血：配血海、三阴交、太冲。

⑩崩漏：虚证加灸肾俞、脾俞、隐白。实证加针大敦、筑宾。

固本调治：灸膈俞、胆俞、脾俞、肾俞、气海、膻中、足三里。

⑪产后大出血：加灸气海、足三里、隐白。

共治疗35例。临床痊愈：针一次后血止或减少，三天内出血停止者。临床好转：针后出血减少，但配合中药使出血停止者。无效：针治后出血可能控制改用中西药综合处理者。

35例血证疗效观察表

病 种	性 别		治愈	好转	无效	小计 (例)
	男	女				
门静脉性肝硬化	1			1		1
支气管扩张，咯血	2	1		1	2	3
肺癆咯血	2			1	1	3
过敏性尿血		1		1		1
肾绞痛尿血	6	3	7	2		9
创伤鼻血	1	1	2			2
胃癌术后创口渗血	1		1			1
小肠切除术后便血	1		1			1
妇女倒经鼻血		8	6	2		8
崩 漏		6	3	2	1	6
产后大出血		1		1		1

王照浩 针灸治疗血证35例 广州中医学院学报 (3), 44, 1987

5. 血小板减少性紫癜

针 刺 法

针刺分两组：甲组治疗组：气阴两虚型21例，取脾俞、膈俞、足三里、三阴交；乙组脾气虚寒型16例，取脾俞、肾俞、足三里、三阴交。

手法：膈俞、脾俞、肾俞的针刺深度为1~1.5寸，针身为45°，针尖斜向脊椎方向，足三里的针刺深度为1.5寸，直刺，三阴交的针刺深度为1~1.5寸，直刺，各穴均小幅度提插捻转，得气后留针30分钟，中间行针2次。每日1次，甲组和乙组穴位隔日交替使用，10次为1个疗程，共治疗2个疗程，中间休息3天。

各治疗组疗效及其比较

	痊愈	有效	进步	无效	痊愈率	总有效率
针刺甲组	10	3	2	6	47.6%	71%
针刺乙组	7	2	2	5	43.8%	69%

共治疗37例。治愈：头昏、乏力消失，血小板计数 $>100 \times 10^9/L$ ，束臂试验（—）；有效：乏力基本消失，紫癜消失，血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ ，但较治疗前上升 $20 \times 10^9/L$ ，束臂试验（—）；进步：头昏、乏力较好转，紫癜明显减少，血小板上升不满意，束臂试验（—）/（+）；无效：主要症状、体征、血小板计数和束臂试验均无改善。

郭诚杰等 针刺治疗血小板减少性紫癜37例 陕西中医（4），177，1989

6. 糖 尿 病

针 刺 法

取穴：双侧曲池，双侧三阴交，双侧阳陵泉，双侧复溜。多饮者加鱼际；多食者加中脘，多尿者加关元。

方法：直刺，平补平泻，得气为度。日1次，每次留针20分钟，21次为1疗程，均治疗2疗程。治疗期间停用与本病有关的任何药物。

共治疗16例。针刺治疗前平均血糖为207.63mg%，针刺后平均为169.56mg%，平均下降38.07mg%。有效12例，占75%，其中血糖降至正常4例。无效4例，占25%。经统计学处理， $P<0.01$ 。有效病例血糖下降幅度为：下降150~100mg% 1例（6.25%），99~50mg% 5例（31.25%），49~20mg% 4例（25%），19~1mg% 2例（12.5%）。

宋长俭等 针刺对血糖作用的临床观察 吉林中医药（1），9，1989

7. 红斑狼疮

针 刺 法

针灸取穴以手足阳明经为主（均双）Ⅰ型：大椎、委中、陷谷、大陵、阳陵泉；Ⅱ型：曲池、合谷、迎香、风池、劳宫、涌泉；Ⅲ型：百会、曲池、合谷、足三里、商丘、命门；Ⅳ型：膻中、气海、合谷、太冲、章门、内关、印堂。隔日一次，一般平补平泻，留针30分钟。

穴位注射以任督二脉及足太阳膀胱经为主，根据辨证选用药物及穴位，Ⅰ型用三黄注射液，取肾俞、太溪、阳陵泉、三阴交穴。Ⅱ型用生脉注射液，取膈俞、肝俞、肾俞、太溪、三阴交穴。Ⅲ型用维生素B₁、B₂、三磷酸腺苷注射液，取脾俞、肾俞、关元、天枢、中脘穴。Ⅳ型用当归、红花注射液，取肝俞、膀胱俞、血海、三阴交、及背部诸俞穴（有阳性结节者）。每次各1—2支，吸入注射器，刺入选好穴位，用提插雀啄方法，待得气后推药，每穴0.3~0.5毫升。隔日一次，与针灸交替使用。

共治疗12例。发热、红斑退清，可不用激素，病情完全缓解，各项检查均正常，狼疮细胞和抗核阴子转阴，能恢复工作，为基本治愈；发热退清，红斑明显退掉，大部分检查趋于正常，激素不用或用

量减少，生活能自理为有效；症状和检查无改善，需激素维持者为无效。

本组病例基本治愈 6 例，有效 4 例，无效 2 例。

常明启 针刺与穴位注射治疗红斑狼疮 12 例 陕西中医 (2),
76, 1987

第七节 神经、精神系统疾病

1. 原发性三叉神经痛

针 刺 法

1 选穴：鱼腰（眼眉中心，眶上缘处），四白（瞳孔直下 1 寸，眶下孔凹陷中），下关（耳屏前一横指，颧弓下凹陷中），夹承浆（前正中线左右旁开 2.5 厘米，口角下一横指处）。

2. 针法

I 支痛：取鱼腰穴。从鱼腰穴斜向下方刺入 0.3~0.5 寸左右，待局部有胀痛或触电样针感时，轻轻捣刺 3~5 次。

II 支痛：取四白穴。从四白穴斜向上方约 45 度角刺入 0.5 寸左右，待有触电样针感传至上唇或上牙等处时，提插 20~30 次。

III 支痛或 II、III 支痛：取下关穴或配夹承浆穴。从患侧下关穴刺入 1.5 寸左右，待有触电样针感传至舌或下颌等处时，提插 20~30 次。针下关穴疗效不明显时配用夹承浆穴，从患侧夹承浆穴斜向前下方约 30 度角刺入 0.3 寸左右，待胀痛或触电样针感传至下唇时，轻轻捣刺 3~5 次。

每日或隔日针刺 1 次，10 次为一疗程，疗程间休息 3~5 天。

共治疗 1500 例。疼痛消失：疼痛完全消失，三个月内未复发者，

815例。显效：疼痛明显减轻，发作次数显著减少，424例。好转：疼痛减轻，发作次数减少，248例。无效：治疗后无变化，13例。

葛书翰等 针刺治疗原发性三叉神经痛1500例疗效分析 中医杂志 (6); 53, 1987

深 刺 法

一、选穴：主穴取患侧下关，辅穴取健侧合谷。第一分支痛加阳白、攒竹、鱼腰；第二分支痛加四白、迎香、禾髻；第三分支痛加承浆、颊车、翳风。

二、针刺方法：根据病情，选取上述有关穴位，针用泻法，不灸；针刺下关穴用30号2.5寸毫针，进针后，针尖以85度角向后下方朝对侧乳突方向深刺2寸左右；用紧提慢按手法，不捻转，使针感向下颌方向或四周扩散，持续20~30秒。留针30~60分钟，留针期间，隔10~15分钟用提插法行针一次；出针前，再予提插法行针30秒左右，然后出针。每日1次，10次为一疗程，每个疗程后停针一周。若三个疗程未效者，视为无效。

共治疗32例。近愈：疼痛发作完全消失，无自觉症状，三个月内未复发者。好转：疼痛发作的频率和程度明显降低。无效：症状无变化。

32例患者中，近愈15例，其中最短治疗10次，最长60次，平均32次；好转16例，其中最短治疗15次，最长40次，平均29次；无效1例。所有近愈病例，均经巩固治疗10~20次，三个月内未复发。

周继荣 深刺下关穴为主治疗原发性三叉神经痛32例 江苏中医 (2); 18, 1989

浅 刺 法

1. 取穴：I支痛取阳白、鱼腰、丝竹空、合谷穴；II支痛取下关、颊车、颧髻、迎香、合谷穴；III支痛取下关、颊车、地仓、承

浆、合谷穴。面部腧穴均取患侧部，合谷穴取对侧部。对于两支或两支以上同时痛者，可同时取相应部位的腧穴。

2. 针刺方法：选用30号毫针，与皮肤呈 15° 夹角沿皮浅刺，以针下有轻微针感即可。I支痛从阳白穴分别向鱼腰、丝竹空穴透刺1寸左右；II支痛从下关穴向颊车穴透刺3寸左右，颧髻穴向迎香穴透刺1.2寸左右；III支痛从下关穴向颊车透刺3寸左右，颊车向地仓穴透刺3寸左右，地仓向承浆穴透刺1寸左右。合谷穴可直刺1寸左右，每隔5分钟轻微捻针1次，勿提插。每次留针30分钟，日针1次，10次为1疗程，疗程间休息3日。

共治疗31例。近愈：疼痛完全消失，半年内未复发者；显效：发作次数明显减少，疼痛明显减轻，已能正常生活、工作者；有效：发作次数较针前减少，疼痛减轻者；无效：针刺前后无变化。

近愈17例，显效8例，有效5例，无效1例。

郑少祥等 透穴浅刺治疗原发性三叉神经痛 31例 陕西中医 (3)；130, 1990

针 刺 法

1. 主穴：止痛灵健侧（屈肘成 90° 度，在曲池前、下各1寸，距手三里2寸处）。

辅穴：一支痛加太阳，二支痛加下关，三支痛加颊车。

2. 操作方法：止痛灵穴，用30号3寸的毫针直刺，采用快速无痛进针法，进针1.3寸左右，得气后行龙虎交战手法，使针感放散至肩峰为最佳。太阳用30号毫针，呈 30° 角向下关方向刺寸余，以针下酸胀感为度。下关用30号毫针，针尖以 85° 角向后下方，朝对侧乳突方向刺1寸左右，使酸胀感扩散至耳区。颊车用32号针沿皮刺透地仓，以局部酸胀或向周围扩散为宜。留针20~30分钟，5分钟行针1次，行补泻兼施手法，日针1次，10次一疗程。

共治疗28例。痊愈：疾病症状完全消失，饮食及休息均正常，随访半年未见复发者。显效：局部疼痛明显减轻，仍有阵发性疼痛，饮

食、休息欠佳者。进步：局部疼痛有所减轻，疼痛次数已减少。无效：经治疗16次，疼痛症状无任何改善。

28例中，治愈20例，占71.4%，显效3例，占10.7%，进步4例，占14.3%，无效1例，占3.6%，总有效率96.4%。

袁永珍 针刺止痛灵穴为主治疗原发性三叉神经痛28例疗效观察
山西中医 (3); 37, 1991

附：眉棱骨痛

针 刺 法

取穴：以病侧昆仑穴为主，如当时不见效者，改用健侧昆仑穴。

操作：用一寸毫针，刺时务求达到“得气”。病程长者用平补平泻（迎随补泻）手法，病程短者用泻法，使患者疼痛立时减轻或消失。

共治疗16例。针刺后即刻取效（疼痛减轻50~80%，或症状完全消失，最多不过5次痊愈者。

1次痊愈者10例，2至3次痊愈者3例，3至5次痊愈者2例，针5次以后无效者1例；有效率93.8%。

席润成等 昆仑一穴治疗眉棱骨痛16例 中国针灸 (3); 41, 1986

2. 偏 头 痛

耳穴压迫法

1. 取穴：①三焦、胆、神门、皮质下、镇静；②太阳、交感、

枕小神经、肾、脑干。每次选贴一组，两组交替。

2. 操作方法：将胶布剪成 $1 \times 0.8\text{cm}$ 的小方块，再将王不留行籽一粒，贴在胶布中心备用，耳廓常规消毒后用电子耳穴探测仪或探针棒找准穴位（最佳敏感点），将贴药的胶布紧贴在耳穴上。并适量按压以患者感到酸麻胀痛或发热为宜，并嘱其患者每日自行按压 4 ~ 5 次，隔日贴压 1 次，两耳交替换贴，7 次为 1 疗程，每疗程休息 2 天。

共治疗 58 例。痊愈：临床症状消失，3 月以上未复发者；好转：临床症状明显改善，偶有轻微头痛者；无效：临床症状无明显好转，或虽有好转但停止治疗即复发者。痊愈 36 例，好转 19 例，无效 3 例，总有效率 94.8%。

刘汉城 耳压治疗偏头痛 58 例 陕西中医 (3); 109, 1990

针刺法 (一)

先刺丝竹空穴，针尖向率谷方向，沿皮刺入 1 寸左右，然后捻转 50 次左右，使针感向头侧部扩散，停 1 分钟，继续捻转进针 50 次，再停一分钟，再继续捻转进针，针尖部直达率谷穴，此时针感扩散至半个头部，有酸、麻、胀感。同时斜刺双侧列缺穴，使针感向肘部传导。伴有眩晕者，配四神聪穴。恶心呕吐者，齐刺双侧内关穴。失眠多梦者，刺双侧神门穴、心俞穴。本病大多为实证，宜用泻法。每日早晚各针 1 次，病程短者留针 10~20 分钟，病程长者，1 日 1 次留针 30 分钟。

55 例中，48 例痊愈，症状完全消失。一般疗程是 7 天，病程长者 14 天。5 例显效，症状基本缓解，时有微痛。2 例无效，针时痛止，过后仍然发作疼痛。

杨家麟 针灸治疗偏头痛五十五例 浙江中医杂志 (10); 461, 1989

针罐疗法

针法：主穴取患侧天宗穴，手太阳小肠经穴，位于肩部后面当肩胛冈下窝中央。

1. 肝阳上亢型：先刺太冲穴，再刺天宗穴，泻法，挤出血一滴。

2. 气血虚弱型：先刺三阴交，后刺天宗穴，补法，挤出血一滴。

3. 气滞血瘀型：针刺天宗穴，挤出血4~5滴。

4. 外感型：针刺风池留针15分钟，针刺天宗穴挤出血一滴。

罐法：针后于天宗穴处，取一直径5~6cm火罐，用闪火法形成负压，置于穴位处，半小时后取下，取下后可见针孔处存有少许血及灰白色分泌物。

共治疗51例。上法每隔一周治疗一次，六次为一疗程。一般1~3次即可显效或痊愈，顽固者六次可显效或痊愈。本组病例51例，总有效率92.1%。

李宝华等 针罐疗法治疗偏头痛51例疗效观察 天津中医 (3), 7, 1989

针刺法 (二)

针刺患侧绝骨穴，针深2寸左右，在捻转过程中，力求针感沿足少阳经上行，最好能使针感上达痛侧头部。留针20分钟，每日1次。发作频繁者可针2次。以10日为1疗程。

本组38例中，显效（在1疗程内，疼痛消除，半年未复发者）23例（占60.5%）；有效（在1疗程内，疼痛减轻，发作减少者）8例（占21%）；无效（经1疗程症状无改善者）7例，有效率为81.5%。其中有18例针感上达痛处而立即止痛。

谢玉兰 针刺绝骨穴治偏头痛38例小结 湖南中医杂志 (2),

针刺法 (三)

主穴取太阳、风池、合谷、太冲。配穴：头顶痛者加百会；前额痛者加印堂。采用快速进针，之后提插捻转至患者觉局部酸、麻、重、胀感为止。留针20分钟，每5分钟捻转1次，每日针刺1次，连针3~5次直至病情控制，针后痛处可用皮肤针轻叩达微出血。

共治疗35例。痊愈：头痛发作控制，半年内无发作，好转：头痛发作次数减少，疼痛减轻；无效：针刺3次症状无改善。痊愈9例，好转24例，无效2例（只针1次）。

李仁琴 针刺治疗偏头痛35例 陕西中医 (3); 131, 1990

穴位药物注射法 (一)

(一) 应用药液： V_{B12} 注射液。

(二) 临床取穴：病人取仰卧位，头微向上抬，在颈部与喉节相平处，在胸锁乳突肌之前缘，相当于距喉节1.5寸，颈动脉搏动处即为人迎穴。

(三) 操作方法：人迎穴作常规消毒，用2毫升注射器，装上5号针头，用左手把颈动脉推向外侧，垂直快速刺入皮肤，然后缓慢进针，待进入皮肤1.2厘米左右，病人感明显酸胀时，抽无回血，则将药液徐徐注入。隔日一次。头痛剧烈者可每日一次。五次为一疗程。

共治疗32例。治愈（治一疗程后，症状消失，三个月内不复发者）22例；显效（治一疗程后症状消失，但三个月内头痛又复发者）8例；好转（治疗后头痛减轻，精神好转）2例。治疗时间最长为10天，最短为3天，平均为6.5天。

胡芝兰等 人迎穴注治疗偏头痛三十二例 浙江中医学院学报 (3); 50, 1988

药物穴位注射法 (二)

采用当归注射液穴位注射内关穴, 1ml/穴。急性期以交叉取穴为原则; 缓解期左右穴位交替使用。操作时必须在针刺得气后, 抽无回血方推药液。十次为一疗程。急性期每日一次, 缓解期隔日一次。疗程间隔一周。随证配穴: 肝阳上亢型配风池、太冲; 风邪袭络型配风池; 气滞血瘀型配阿是穴; 气血不足型配足三里。配穴均用毫针刺法, 补虚泻实。治疗期间停服一切中西药物。

共治疗31例。痊愈: 经治疗后, 临床症状全部消失, 追踪半年以上未复发者。显效: 经治疗后, 临床症状全部消失, 追踪半年偶有复发, 但其程度大为减轻者。有效: 经治疗后, 临床症状明显减轻, 发作次数减少者。无效: 经治疗后, 临床症状无明显好转者。痊愈: 16例, 显效: 8例, 有效: 7例。

叶德宝 当归注射液穴注内关穴治疗偏头痛31例临床观察 浙江中医学院学报 (2); 47, 1991

3. 头 痛

手 针 法

1. 阳明头痛: 取印堂、前头点 (食指桡侧, 近端指关节赤白肉际处)。
2. 少阳头痛: 取太阳、偏头点 (无名指尺侧, 近端指关节赤白肉际处)。
3. 厥阴头痛: 取百会、头顶点 (中指桡侧, 近端指关节赤白肉际处)。
4. 太阳头痛: 取风池、后头点 (小指尺侧, 近端指关节赤白肉际处)。

方法：令患者半握拳，根据头痛的部位而取穴，采用28号毫针，向上斜刺，捻转20~40次。

共治疗102例。头痛消失，其它伴随症状也消失者为痊愈；头痛及伴随症状明显好转者为显效；头痛有所好转，伴随症状也有所好转者为有效；头痛治疗前后无变化者为无效。

手针102例，治愈39例，显效36例，有效20例，无效7例，总有效率为93.14%。

马登旭 手针治疗头痛102例 北京中医 (3)，41，1988

头皮针法

取穴：“伏象”头部，配血穴书写、信号、结合辨证施治，采取相应取穴，仿体取穴，特定取穴。

针法：进针必须深达骨膜（0.5厘米），手法分快、慢刺或快慢结合，可以直刺、斜刺、亦可透穴。留针30分钟，中间捻针一次，每日观察病情的变化。

疗程：每日针刺1次，10天为1疗程，疗程间隔3~4天，共3个疗程。

共治疗52例。痊愈：治疗1疗程后，症状完全消失，随访半年不复发者；显效：治疗1~2疗程后，症状有显著好转，随访半年头痛稳定者；无效：治疗1~3疗程症状仍未减轻。治疗患者52例，痊愈46例，显效4例，无效：2例，有效率占96.1%。

慕兰芳 头皮针治疗头痛52例 陕西中医 (12)，563，1988

梅花针法

1. 梅花针叩刺疼痛部位。

2. 毫针刺风池穴，一侧痛取同侧风池，完骨全头痛取双侧。

操作方法：取坐位。先用梅花针叩刺局部，使叩刺头皮上形成多个 $\phi 2\sim 3\text{mm}$ 血滴为度。针风池穴使酸麻胀感传至前头部，留针20—

30分钟。

共治疗147例。1.治愈：头痛完全控制，稳定半年以上未复发者。
2.有效：治疗10次以上，疼痛面积或发作次数减少50%以上，疼痛明显减轻。3.无效：治疗20次以上，症状变化不大者。

147例中治愈103例，占70.06%，有效40例，占27.2%，无效4例，占2.72%，总有效率为97.26%。

李连生 梅花针为主治疗顽固性头痛临床观察及掌纹学研究 天津中医 (1); 41, 1991

4. 颈源性头痛

指 针 法

患者取俯卧位，用10厘米高的枕头垫在前胸，使头低下靠床，医生双手中指沿手少阳三焦经在颈项段循行路线上左右对照查找具有凸起顶手的压痛点，一般多在乳突后下方，胸锁乳突肌后缘，约平下颌角处的天牖穴触到，然后用钢笔记上符号。医生先在三焦经颈项段轻轻推拿，接着用拇指尖对准顶手的天牖穴向健侧同名穴顶推，若压痛点消散，表明指针成功，若压痛点仍在，可再施指针一次，或者在手太阳小肠经的天容穴和阿是穴辅以指针亦可凑效。手法分弱、中、强三种，因人体质而异。隔日一次，1~3次即可。

共治疗461例。头痛完全消失，天牖穴压痛消散，X片环枢关节和环齿侧间隙左右对称，患者睡眠和工作恢复正常者为痊愈。头痛明显减轻，天牖穴压痛不明显，X片环枢关节和环齿侧间隙接近常态者为显效。患者症状体征与治疗前一样者为无效。461例中痊愈161例占34.92%，显效299例占64.86%，无效1例占0.22%，总有效率99.78%。

吴 穆 指针天牖穴治疗颈源性头痛461例疗效观察 中国针灸 (3); 7, 1986

5. 血管神经性头痛

刺 血 法

1. 经络定位辨证取穴：前头痛连及眉棱属阳明经证，局部取阳白、头维、百会、印堂、四白；循经远取商阳、厉兑。侧头痛连及耳部属少阳经证，局部取颌厌、率谷、角孙、太阳；循经远取关冲、足窍阴。后头痛下连项背属太阳经证，局部取玉枕、百会、风府、脑空、风池；循经远取少泽、至阴。头顶痛连及目系属厥阴经证，局部取百会、四神聪、印堂；循经远取中冲、大敦、涌泉。以上均取患侧穴位，并加用阿是穴，双侧发病取双侧。

2. 针法及注意事项：局部取穴用七星针叩刺出血（手法由轻到重，由慢至快，出血量第1次较多，以后递减）。远道取穴用三棱针点刺出血（动作宜轻快，不宜过深，出血量首次2至4滴为宜，以后递减）。3日1次，5次为1疗程。凝血机制差者、贫血、素体衰弱及孕妇禁用。针具及刺血部位应严格消毒，以防感染。刺血乃泻法，若1疗程后效果不佳者，改用其它方法治疗，以免损伤正气。

共治疗102例。痊愈：头痛及诸症消失，1年内未复发者，共88例。显效：头痛及诸症消失，1年内偶有发作，但程度明显减轻，共8例。有效：头痛间歇明显延长，疼痛程度亦减轻，共4例。无效：治疗前后无明显差异，共2例。

马应垂 刺血治疗血管神经性头痛102例 陕西中医 (7), 822, 1990

针 刺 法

风湿侵袭型取穴风池、头维、太阳、合谷、三阳络。肝阳上亢型取穴悬颅、颌厌、太冲、太溪、关冲。痰浊阻络型取穴中脘、丰隆、

百会、印堂。气血虚弱型取穴上星、血海、足三里、三阴交。

操作：病人取侧卧位。风湿侵袭型头痛，肝阳上亢型头痛，痰浊阻络型头痛，皆用毫针泻法；气血虚弱型头痛用毫针补法。无论用补法，还是用泻法，当针刺入穴位后，必须得气，并意守其气勿失，力争气至病所。而后，根据补泻原则，迎随开合得当，再留针20~30分钟，每日一次，15次为一个疗程。

共治疗55例。头痛及各种症状消失，6个月内未见复发者为显效，头痛消失者或显著减轻，6个月内仍有发作者为无效，症状无变化者为无效。

在全部55例中，显效42例，有效10例，无效3例。最少者治疗7次，最多者治疗6个疗程。大部分患者治疗1~2个疗程症状既获改善，少数患者获效后有反复，但继续治疗仍能见效。粗略统计，所治55例病人，显效率约为76%，总有效率约92%，其中，病程在3个月以内者全部治愈；病程在1~5年者显效27例，有效3例，无效1例；病程在5年以上者，显效4例，有效6例，无效2例。从这里可以看出，凡病程短者疗效好，病程愈长，疗效愈差。

温玉忠 针刺治疗血管神经性头痛临床观察 天津中医学院学报(4); 21, 1990

头 针 法

治疗方法：取头针安神穴（双）、感觉区下2/3（双）。用捻转补法，频率100次/分，幅度90~180°，每隔5分钟捻针一次，使其有酸、胀、麻得气感，留针15分钟。隔日一次，7次为一疗程。

观察方法：患者停药影响血管药物1~3天，以脑电图测定收缩波波幅、上升时间、下降时间、流入容积速度、流出容积速度、周围阻力指数、转折高比值。针刺后再侧脑血流图指标。

共治疗34例。显效：治疗后头痛、失眠、恶心等症状消失，脑电图指标好转，能正常工作，并停止服止痛药。

有效：治疗后头痛减轻或不痛，偶有轻微发作，脑血流图指标部

分好转，偶尔服止痛药。

无效：治疗后仍头痛，脑血流图指标无好转。

34例中，经头针治疗，显效6例，有效23例，无效5例，总有效率为85.3%。

盛玲玲等 头针治疗血管性头痛34例疗效观察 上海针灸杂志 (4); 15, 1987

耳穴放血法

1. 取血管及耳穴：选耳背近耳轮处明显血管1根，神门、皮质下。加减：颞侧痛加太阳，后头痛加枕，前头痛加额，头顶痛加顶、肝，伴失眠加心、肾，女病人加内分泌等。2. 用品制备：①持针钳。②刮面刀片。用持针钳挟紧刀片一角，折断成三角形的刀片针，浸泡在消毒液中备用。3. 操作方法：患者端坐。放耳背血管血：用手揉搓2分钟左右使其充血。消毒后用持针钳挟紧刀片针，于钳端留针尖2分左右、用左手拇、食指将耳背拉平，中指顶于下，右手持钳针，对准应刺血管，垂直轻快刺入即拔出，见自然出血，约放血30滴，用消毒棉球拭去血并加压一下。耳穴放血方法同上，每个耳穴放血1~2滴即可。刺点经消毒后贴盖胶布，两天内不沾水，以防感染。7天1次，3次1疗程。有出血倾向者不用此法。

共治疗220例。头痛及各种症状消失为治愈。头痛明显减轻为显效。头痛减轻为好转。症状无变化者无效。220例中，经1~3次治愈的126例，显效21例，好转48例；经3次以上治愈的22例，显效2例，好转11例，无效3例。总有效率达98.6%。本组对80例病人进行随访，保持治愈疗效的达72例，低于治愈标准的8例之中，保持显效者6例，好转者2例。

王第道 耳穴放血治疗神经性头痛 中国针灸 (4); 12, 1987

6. 多发性神经炎

针 刺 法

上肢取穴：第一组为曲池、外关、八邪。第二组为手三里、合谷、后溪。下肢取穴：第一组为足三里、承山、八风。第二组为阳陵泉、三阴交、太白。脾胃虚弱者，加中脘、胃俞、脾俞；若气血淤滞者，补合谷，泻三阴交、加太冲；若湿流肢体者，加阴陵泉、公孙。

针刺得气后，一般采取先泻后补的方法。体质虚弱者，采用平补平泻，然后接通6805治疗仪，电流强度逐渐增强，以病人能耐受为度。留针20~30分钟，15次为一个疗程。

共治疗56例。痊愈：经治疗一至三个月后，症状消失，无蚁走、麻木、刺痛的感觉，行走活动如常，三个月后随访无复发者。好转：经一至三月治疗后症状消失，但仍有轻微麻木者。无效：治疗后与治疗前症状无明显改善者。

56例中，痊愈29例，占51.79%；好转12例，占21.43%；无效15例，占26.79%；总有效率为73.22%。

钱志云 针刺治疗多发性神经炎56例临床观察 湖北中医杂志 (6); 30, 1987

7. 急性感染性多发神经根炎

电 针 法

治疗工具：不锈钢毫针及“G 6805治疗仪”。

主穴：上肢：第一组，取肩髃、曲池、外关。第二组，取肩髃、手三里、合谷。下肢：第一组，取髀关、伏兔、足三里、阳陵泉、悬

钟。第二组，取环跳、殷门、委中、承山、跗阳。

随症配穴：如果不能翻身者，加风池、腰背夹脊及肾俞、足有外翻者，加纠正外翻穴等。

操作：两组穴交替轮刺，每次上下肢各取一组穴的2~3个穴位。进针后出现针感，采用中强度刺激，继将“G6850治疗仪”输出导线一对接在左侧上下肢体上，另一对接在右侧上下肢体上，或用四对输出导线分别接在上下左右肢体上亦可。通电后，选用疏波或断续波型，频率每分钟20~30次，通电治疗20~30分钟。电量大小、刺激强弱、以肌肉抽动和患者能耐受为度。

疗程：每日一次，治疗10次为一疗程，疗程间隔为7天。

在治疗过程中，嘱患者和家属要加强患肢自动或被动功能锻炼，以促进肌肉和功能的恢复。

5例患者中，治疗2个疗程者2人；3个疗程者2人；4个疗程者1人。

疗效评定标准：

1. 痊愈：肢体功能恢复，萎缩肌肉恢复常态，生活完全自理。
2. 显效：肢体功能基本恢复，肌肉恢复未达常态，生活基本自理。

治疗效果：3例痊愈，2例显效。

李荣阁 电针治疗格林—巴利综合征5例 现代中医 (4)，
24, 1989

针 刺 法

每次治疗，均先用红外线适温照射患肢25分钟，继之选穴治疗。上肢不能高举者选用肩井、肩贞、肩髃、臂臑、曲池、手三里、合谷、八邪穴等；不能坐立者取臂俞、肾俞、华佗夹脊穴等；下肢不能抬高，迈步困难者取环跳、白环俞、次髎、殷门、风市、阳陵泉等；踝关节不能活动者取昆仑、解溪、丘墟等；身体虚弱、消化不良者加足三里。以上穴位视病情交替选用，得气后通电用连续波、疏密波各

10分钟，电量以病人耐受为准，并用698点送机治疗。每日1次，15次为1疗程。

共治疗30例。痊愈：功能完全恢复正常；显效：功能大部分恢复正常；好转：较治疗前功能进步。痊愈18例，显效8例，好转4例。

刘桂英 针刺治疗格林—巴利综合征30例 陕西中医(3)，132，1989

8. 根性神经痛

穴位注射加中药法

观察组：复方丹参注射液（江苏东台制药厂生产，每安瓶2ml，每毫升相当于丹参、降香生药各1g），穴位注射。取穴原则：以病变神经根上缘椎节的双侧夹脊为主穴，根据疼痛部位选择不同配穴，如颈、项、背痛取风池、肩外俞、风门、天宗；肩臂痛取肩髃、手三里、外关；腰及下肢痛取肾俞、次髃、环跳、承山、悬钟等穴。注射方法：每次选主穴2个，配穴2个；颈、背部穴位用5~5½号针头；肩、上肢、腰、下肢用6~7号针头。取复方丹参注射液，局部常规消毒后注射，每穴1ml，隔日1次。注射时夹脊穴针尖向外与皮肤成45°角，其它配穴针身与皮肤大都垂直。徐徐进针，有酸、胀感后，回抽无血，缓慢地将药液注入。蠲痹止痛汤：熟地、白芍各20g，威灵仙、秦艽、木瓜各15g，川乌、没药各10g，土鳖虫6g。每日1剂，水煎，早晚口服。30天为一个疗程。对照1组：单纯用蠲痹止痛汤口服。其方剂组成、药量、服药方法、疗程同观察组。对照2组：针刺加服蠲痹止痛汤。根据病变部位，酌取1~2寸毫针，按照观察组的取穴原则，每次亦取主穴2穴，配穴2穴。采用穴位注射的进针角度，得气后留针20分钟，隔日1次。本组蠲痹止痛汤方剂组成、药量、服用方法以及疗程均同观察组。

共治疗84例。临床治愈：疼痛消失，感觉异常，肌萎缩等完全恢

复正常，阳性体征消失；显效：疼痛基本消失，遗有轻度伴随症状，无明显阳性体征；好转：疼痛减轻，伴随症状有所改善，可引出阳性体征；无效：病情无变化或加重。结果见表。

三组疗效比较

组别	例数	治愈 (例)	显效 (例)	好转 (例)	无效 (例)	有效率 (%)
观察	32	20	7	5	0	100.0
对照 1	22	7	8	6	6	72.2*
对照 2	30	12	5	10	3	90.0**

注：与观察组比较，* $P<0.01$ ，** $P<0.05$

朱瑞生 穴位注射加蠲痹止痛汤治疗根性神经痛 中西医结合杂志 (10)，510，1990

9. 进行性脊肌萎缩症

针 刺 法

针具用30号2寸长毫针。取穴分2组，一组：肩髃、手三里、阳池，合谷，肾俞，环跳，阳陵泉，解溪。二组：手五里、外关、中渚、风市、悬钟、丘墟、足三里。手法平补平泻，一般留针20~30分钟，一日一次。针刺时病员针感强，酸、麻、胀明显。在针刺的基础上兼服归脾汤加减。（汤剂）每日一剂。

此例经上述治疗一月余，四肢肌力明显恢复。治疗五月，四肢活动自如，持物、行走一如常人，生活完全自理。

徐世蓉 针刺治疗进行性脊肌萎缩症 四川中医 (3)，40，1987

10. 脑动脉硬化症

耳针及头皮针法

(1) 耳针、先取一侧(左右均可)，针刺交感、肾上腺、心、降压沟、内分泌等穴。用胶布固定，留针三天，然后换另一侧，穴位方法同前。针刺4次(两耳交替)，12天为一个疗程，病情好转后可再针一个疗程，以巩固疗效。

(2) 头皮针：单用耳针效果不显著者，可与耳针同时针刺头皮区前顶、目窗、头维、后顶、百会、通天、风池等穴位，(与耳针同侧)左右交替，方法与耳针同，针刺有微痛胀感，可不用胶布固定。

34例患者，最短经过一个疗程，最长经过4个疗程，临床症状均得到明显地改善和消失，效果显著。

黄素贤 耳针、头皮针治疗脑动脉硬化症34例 内蒙古中医药(3)，24，1987

11. 脑出血

微波针灸法

1. 仪器：华北光电研究所制的 DBJ-I型微波针灸仪(中国江苏省江都无线电厂制造)。针具：28号或30号针若干支。2. 选穴：曲池、手三里、阴市、足三里。3. 操作方法：患者仰卧位，选穴针刺后，运用手法使之“得气”然后将“微波导管”接到针柄上，并将支架固定好。而后按下电源开关，再分别按下输出分路开关，调整好输出功率，以患者无刺痛为适度。4. 疗程：隔日微波针灸一次，每次15~20分钟，10次为一疗程，每次疗程后检查并记录。

共治疗100例。痊愈：语言清楚，上肢能抬举握物，下肢可以行走，肌力在Ⅳ级以上，生活能自理。显效：语言存在，可以行走，肌力较治疗前提高二级，生活大部分自理。进步：语言和肢体功能较治疗前有进步，肌力提高一级。无效：治疗前后症状、体征无变化。

痊愈37例，显效33例，进步27例，无效3例，治愈率为70%，总有效率为97%。

许武定等 微波针灸治疗脑出血100例疗效观察 陕西中医(5)，199，1988

12. 脑血栓形成

头穴透刺疗法

选顶中线，即从督脉经的百会穴向前顶穴沿皮斜刺1~1.5寸，顶颞前斜线，自百会穴起向悬厘穴透刺1~1.5寸，贯穿督脉、足太阳膀胱经和足少阳胆经之脉。若腰痛者配枕上正中线；视觉不清者配枕上旁线；血压高者配额旁2线；语言不清、甚至昏迷者配合额中线；咳嗽、胸闷、气短者配额旁1线。每日或隔日一次，留针2~48小时。手法：以进针后采用抽气或进气法，同时要求病人配合吐纳、导引活动。一般5次为一个疗程。急性病3次为一疗程，休息3天；慢性病5次为一疗程，休息7天，以后进行第二疗程。

共治疗33例。近愈：瘫痪肢体功能显著恢复，生活能自理。显效：瘫痪肢体功能基本恢复，手可抬举，扶杖能站立行走。好转：肢体功能部分恢复。无效：经头穴透刺一个疗程无任何变化。

本组33例中，痊愈16例，显效9例，好转7例，无效1例。

王纪春 头穴透刺疗法治疗脑血栓形成33例临床小结 江苏中医(4)，21，1990

13. 缺血性中风

针刺加中药法

一、药物治疗：根据病人发病时间的长短、病情的轻重程度、临床表现，将本病分为如下两型：

1. 风阳痰火型：治法——平肝熄风化痰通络。常用药为半夏、天麻、白术、钩藤、山栀、炒白芍、鸡血藤等。常规剂量。2. 气虚血瘀型：治法——益气活血化痰通络。常用药为黄芪、太子参、丹参、当归、川芎、牛膝、赤芍、地龙、鸡血藤等。黄芪用量较大，一般宜在100~250克左右。其余为常规剂量。

二、针刺疗法：治疗大法与上相同。取穴原则，以取手足三阳经穴为主，其中以阳明经为重点。配以足厥阴肝经、足太阴脾经、足少阴肾经穴位等。头针取穴，多在患侧，亦可两侧交替取穴针刺。十天为一疗程。

1. 风阳痰火型：常用穴位为风池、曲池、太冲、合谷、肩髃、丰隆、阳陵泉等。用泻法。

2. 气虚血瘀型：常用穴位为肩髃、曲池、外关、合谷、环跳、肾俞、膈俞、风市、悬钟、足三里、百会等。平补平泻。

头针：选运动区、感觉区、语言区等针刺后快速捻转，勿提插，配以电针。

共治疗54例。基本痊愈：运动、感觉功能完全恢复正常，仅有手指、踝关节活动欠利；言语蹇涩、口眼歪斜消失，能参加部分工作。显效：半身不遂明显恢复，能扶杖行走，口眼歪斜、言语不清基本恢复。好转：半身不遂恢复有进步，偏身麻木、语言蹇涩好转。无效：经针刺、药物治疗三个疗程症状无好转。

56例病人中属风阳痰火型12例，气虚血瘀型44例。基本痊愈23例占41%，显效20例占34.7%，好转9例占15.2%，无效5例占9.1%。总

有效率90.7%。

冯祯钰 针刺和中药辨证治疗缺血性中风56例 南京中医学院学报 (2), 91, 1991

14. 脑梗塞

颅 针 法

(一) 选针：一般用2~2.5寸的26~28号针。

(二) 体位：大多数取坐位，部分患者取平卧位或侧卧位。

(三) 操作方法：常规头皮消毒后，右手拇、食、中三指持针柄，左手拇、食指挟一棉球持针体，双手配合进针，针身与头皮表面呈 165° 角左右，利用指力及腕力，迅速将针沿头皮刺入皮下，直至刺达病所。此法进针具有取穴准，减少疼痛，轻巧快速，安全实用之优。

(四) 选区：主要选取运动区和感觉区，单独或交替使用。每次捻转2分钟，200次/分，留针10~15分钟，每日或隔日针刺一次，10次为一疗程，每疗程间隔2日。

(五) 针感：捻针1分钟左右时即有针感，且在面部、肩背和相应的肢体出现热、胀、麻之感，部分患者有血液在肢体血管内流动之觉。多数患者有手掌潮汗，患肢温度升高的表现。

共治疗60例。治愈：偏瘫症状完全消失，无后遗症，生活可自理，恢复工作能力。

显效：偏瘫症状基本消失，生活可自理，基本恢复工作能力。

有效：偏瘫症状好转，留有较轻的后遗症，生活可自理但丧失工作能力。

无效：偏瘫症状无改善。

60例中治愈27例占45%，显效8例占13.3%，有效12例占20%，无效4例占6.7%，总有效率为93.3%

附：中风及后遗症

醒脑开窍法

1. 处方:

主穴: 内关 (手厥阴心包经)

人中 (督脉)

三阴交 (足太阴脾经)

副穴: 极泉 (手少阴心经)

委中 (足太阳膀胱经)

尺泽 (手太阴肺经)

配穴: 吞咽障碍加风池 (足少阳胆经)、翳风 (手少阳三焦经)、完骨 (足少阳胆经), 手指握固加合谷等。其它随症加减。

2. 针刺操作方法:

主穴: 先刺双侧内关, 直刺0.5—1寸, 采用捻转提插结合的泻法, 施手法1分钟, 继刺人中, 在鼻中隔下斜刺0.5寸, 用重雀啄手法至流泪或眼球湿润为度。

三阴交在内踝上三寸, 沿胫骨后缘进针, 针尖向后斜刺与皮肤呈45°, 进针1—1.5寸, 用提插补法, 使病人下肢抽动三次为度。

副穴: 极泉直刺进针1—1.5寸, 用提插泻法, 使上肢抽动三次为度。针尺泽时操作同极泉。

委中穴采取仰卧位直腿抬高取穴, 进针1寸, 用提插泻法使下肢抽动三次为度。

假球麻痹者风池穴针向结喉, 进针2—2.5寸, 采用小幅度高频率捻转补法施手法1分钟, 翳风、完骨穴的操作同风池穴。手指握固者合谷针向三间穴, 第二掌骨下缘部位, 采用提插之泻法, 使第二指抽动为度, 语言蹇涩者予金津、玉液放血。

3. 治疗时间:

每日针二次, 十日为一疗程。

共治疗2336例。临床治愈: 思维正常, 语言清楚, 肢体功能基本恢复, 生活能自理或能恢复轻工作者, 共1281例。

显效: 思维正常, 语言、上肢或下肢有一项恢复不完全者, 生活尚能自理者, 共542例。

好转: 病情有所好转, 意识、语言及上下肢功能有一定恢复, 生活不能自理者, 共453例。

无效: 治疗前后无任何变化者, 共18例。

死亡: 在治疗过程中死亡, 共42例。

石学敏 醒脑开窍针刺法治疗中风2336例的临床分析及实验研究
天津中医 (6), 2, 1989

针 灸 法

风中经络, 表邪未解, 在三阳经上选穴。如合谷、风池、外关、头维等穴。

阴虚阳亢, 肝胆火旺, 在肝、胆、肾及督脉选穴。如太冲、太溪、侠溪、百会等穴。

肝肾亏损, 阴阳俱衰: 取任脉的气海、关元为主, 配合肾俞、太溪、三阴交、命门等穴。

脾肾阳虚, 痰饮窜经: 取中脘、丰隆、配足三里、三阴交。

气血两虚, 经脉失养: 取足三里、三阴交、阳陵泉、脾俞等穴。

刺皮部: 风中经络, 表邪未解, 用28~30号、1.5~2寸毫针, 在所取的腧穴上沿皮针刺, 施迎随补泻法。刺络法: 邪在三阳, 肝胆火旺, 阴虚阳亢, 用粗毫针或三棱针, 于所寻取的血络上点刺, 出血数滴。刺经脉: 即深刺, 主要用于肝肾亏损、阴阳俱虚、脾肾阳虚, 痰饮窜经及气血两虚等型。一般用1.5~2寸毫针直刺。得气后, 用捻转补泻法。刺经筋: 用于气血两虚, 筋脉失养出现拘挛, 内翻及强直等症者。于拘挛之处, 用26~28号1.5~2寸毫针深刺, 一般要求针尖抵

达肌膜或肌腱深处，用捻转补泻法，不留针。艾灸法：多用于肝肾亏损，阴阳俱衰，脾肾阳虚，痰饮窜经等型，或久刺真元之气损耗者。多采用艾条雀啄灸法。脏腑阳气欲脱时，可于关元、气海等穴用大艾炷灸法。在刺灸时，对比两寸口脉及观察血络盛衰的情况，在脉力较强或盛络出现的一侧选取穴位，一般不双侧同时取穴。

病程在15天内者，每天针刺一次，每次取3~5个穴，如效果不显著时，停针休息，7天为第一个疗程。从第二疗程起，隔日一次，每次8穴左右。若针刺期间出现神疲乏力，气短自汗者，可当即停止针刺或改用艾灸方法治疗。

痊愈：说话正常，生活自理或恢复工作者，211例。显效：上肢握物无力，下肢单独行走，说话能表达意思，136例。进步：语言不清或上下肢功能明显好转，尤其下肢扶杖可行短距离者，113例。无效：虽有进步但不明显或中断治疗者。

王新明 针灸治疗偏瘫480例临床观察 中国针灸 (6); 5, 1986

针 刺 法 (一)

口眼喎斜取颊车、地仓、承浆、阳白、四白、翳风、下关、合谷，神经干针刺面神经点、咬肌神经点、颧神经点、眶下神经点；语言蹇涩取风府、廉泉、金津、玉液、内关、百会，神经干针刺舌下神经点、喉返神经点；上肢瘫痪取大椎、肩髃、曲池、外关、合谷、八邪，神经干针刺臂丛神经点、桡神经点、颈神经点、尺神经点、正中神经点、颈5~6；下肢瘫痪取肾俞、环跳、阳陵泉、悬钟、髀关、风市、委中、足三里，神经干针刺坐骨神经点、股神经点、腓总神经点、腓浅神经点、胫神经点、腰3~5。两种治疗方法交替使用，以10次为一疗程。遵循“虚则补之，实则泻之”的原则，运用提插捻转补泻手法。瘫痪程度较重者用神经干针刺疗法，肌张力减退或肌肉萎缩，肢体无力，可用维生素B₁、B₂、三磷酸腺苷合并使用，根据病情，每次各1支或2支，每穴0.3~0.5毫升作穴位注射。若突然发

病，且血压高，暂不宜针，待血压及病情稳定后，再作针刺治疗。

共治疗200例。基本治愈：上肢上举至头，能作自由旋转活动，下肢可独立行走，生活基本自理，神志、语言清楚，其中有的还可以骑自行车，操持家务、书写、缝纫等细小动作。显效：上肢上举过肩、能作旋转活动，下肢可以独立行走或扶拐迈步其中一项者，语言较清楚，但生活不能完全自理。好转：患肢活动范围和功能较治疗前有好转。无效：经两个月治疗，未见进步。基本治愈72例，显效35例，好转60例，无效33例，总有效率为83.5%。

常明启 针刺治疗偏瘫200例疗效分析 陕西中医 (5)，208，1988

头皮针抽添法

体位：取坐位。暂不能坐立者，可取仰卧位。

取穴：按照中国针灸学会公布的，经联合国世界卫生组织西太地区通过的《头皮针穴名国际标准化方案》，取健侧顶颞前斜线，顶旁1线，顶旁2线。血压偏高者加顶中线，腰脊酸软者加枕上正中线、枕旁1线。

手法：常规消毒后，用30号1.5寸毫针刺入帽状腱膜下层，然后将针体平行缓进1寸，当指下不松不紧，有吸针感时，行抽添法补泻。抽气时用暴发力向外速提3次，每次至多提出1—2分许，继又缓插至1寸；添气法相反，用暴发力向里速插3次，每次插入至多1—2分许，继又慢提至1寸，如此反复运针，以取得即时疗效为得气。留针2—48小时。急性期10次为1疗程，慢性期5次为1疗程。间隔时间分别为3—5天和1个月。

运动：在运针时，要求患者把注意力集中在病侧肢体，做意识运动，并由意识运动带动患肢自动运动，不能做自动运动者，则可用意识运动结合被动运动。在留针期间，术者要帮助患者反复做起坐动

作，并在此基础上，搀扶下步行，进而让其独立行走。不能坐立者，可在床上做屈膝、伸腿、屈肘、伸臂等运动。每次针后，运动时间的总和一般不能少于2小时。

疗效标准根据康复医学 Barthel 生活活动指数对偏瘫病人的功能评价为标准。（1）痊愈：偏瘫基本消失，生活自理，能参加一般工作，共146例。（2）显效：肢体功能明显改善，下肢功能完全恢复（能独立行走30米以上，上下楼梯），上肢功能（穿衣、进食、上厕所、整洁修饰、刷牙等）需要在帮助下完成，共34例。（3）有效：下肢功能完全恢复，上肢功能完全丧失，共10例。（4）无效：虽有肌力的增加，功能完全缺乏，生活完全需人护理，共2例。

孔尧其 头皮针抽添法加运动治疗中风偏瘫192例临床观察 江苏中医（7），23，1989

针 刺 法（二）

以百会和行间为主穴，上肢瘫配条口穴，下肢瘫取手三里和后溪，语言障碍取上腭穴和下腭穴。手法：百会、行间穴同时进针，相反方向捻转和提插，起针时先行间后百会。疗程：每次1~3min，隔日1次，10次为1疗程。

共治疗122例。痊愈：瘫痪肢体肌力恢复到4~5级，上肢可自理，下肢可独步行走；显效：瘫痪肢体肌力提高2级，如3级到5级；进步：瘫痪肢体肌力提高1级；无效：瘫痪肢体肌力无变化。

痊愈28例，显效74例，无效19例，总有效率81%，其中语言恢复10例，手足指恢复11例。

高允旺 针刺百会行间穴治疗偏瘫122例 陕西中医（8），267，1990

头 针 法

针具：选用28号或30号1.5寸不锈钢毫针。

取穴：根据头皮针国际标准化方案，取患肢对侧头部顶颞前斜线（前顶穴至悬厘穴连线）从上向下，上1/3，中1/3，下1/3连针3~5针。血压偏高加顶中线（顶部正中中线，自百会达前顶穴），语言不清加额中线（额部正中发际内，自神庭穴，沿督脉向前针一寸）。选定刺激线后，分开刺激区头发以暴露头皮，用2%碘酒及75%酒精棉球进行严格消毒。

手法操作：从头顶到颞前，沿顶颞前斜线进针，针尖斜刺到头皮帽状腱膜层。

针感：临床上通常以胀、重、热，压迫感为最多见，亦可出现麻、抽等反应。部分患者原来有异常感觉，如麻、凉、抽、痛等，在针刺过程中这些异常感觉往往能减轻或消失。这些针感常出现在对侧患肢上，但也有时出现在其它部位，甚至出现循经感传现象。有针感反应的患者一般效果为佳。

疗程：针10次为一个疗程，每日或隔日针一次。休息7~10天后再进行第二个疗程，一般治疗三个疗程，最长为五个半疗程。

共治疗106例。

基本治愈：神经系统体征基本恢复正常，进步四分以上，总分达二十三分以上者。

显效：神经系统体征明显好转，记分三分以上，总分达二十一分以上者，或虽总分不到二十分，而有效在五分以上者。

无效：体征与治疗前后无变化。

2. 评分标准：神志清楚五分，无面瘫三分（轻、中、重各为一分），语言正常四分（失语0分，能说单词、吐字不清一分，能说成句，但不能持久二分，能说成句，也能持久，但吐字不清三分），上下肢肌力正常各五分（完全丧失肌肉运动0分，可见肌肉纤维收缩一分，可在肌体水平移动二分，能离开床位活动三分，能离开床位并克服地面吸引力四分）。

治愈18例，显效63例，进步23例，无效2例，总有效率98.11%。

刘方木 头皮针治疗中风偏瘫106例疗效观察 浙江中医学院学报（2），53，1988

艾 灸 法

(一) 灸料：采用济南市药材站中药加工厂所产的药艾条。

(二) 取穴：天窗（肢体健侧）、百会。

(三) 施灸操作步骤：患者平卧位，充分暴露头颈部，于百会穴处剪去头发。点燃艾条，先灸肢体健侧的天窗穴，艾火距离皮肤3～4厘米，以患者感觉温热舒适为度，灸15分钟。后灸百会穴，方法同天窗穴。每穴亦灸15分钟，每天灸1～2次，30天为一疗程，休息3～5天，再进行下一疗程。

共治疗33例。基本治愈：症状基本消失，肢体、语言功能基本恢复正常。

明显好转：症状大部分消失，肢体、语言功能明显改善。

好转：部分症状消失，肢体、语言功能部分改善。

无效：症状基本同治疗前。

基本治愈13例，明显好转13例，好转6例，总有效率97%，无效1例，占3%。

张登部等 艾灸治疗中风偏瘫疗效观察 山东中医杂志 (6), 12, 1987

按摩加体针法

病情基本稳定，取患侧对侧头皮运动区，用手掌小鱼际紧贴之，进行快速、轻柔来回按摩，要求轻、频率高，每分钟100次以上，持续2～3分钟，直至该区头皮发热，休息二分钟，再继续第二次按摩，反复进行3次为一个周期。体针取患肢、肩髃、曲池、外关、合谷、阳陵泉、足三里、丰隆、太冲、绝骨、三阴交、解溪等穴进行治疗。根据患者病情及体质情况采用补泻结合手法，并留针15分钟。病情时间长采用深刺透穴法，以激发经气，如合谷透后溪、曲池透少海、阳陵泉透阴陵泉、绝骨透三阴交。操作时头皮按摩与体针捻动交

替进行，每日一次，10次为一个疗程。每疗程结束休息5—7天，再继续第二个疗程。

共治疗20例。痊愈：瘫痪肢体功能基本恢复，肌力4—5级，说话清楚。显效：临床症状明显改善，肢体功能显著恢复，手可抬举，腿可站立，肌力3—4级，语言欠清楚。有效：瘫肢功能基本恢复，肌力2—3级。无效：持续几个疗程，功能无任何改善。本组20例中风偏瘫，治愈6例，显效10例，好转2例，无效2例，总有效率达90%。

郭雅卿 按摩加体针治疗中风偏瘫20例 浙江中医学院学报 (6); 45, 1989

附：中风患肢浮肿

头 针 法

取健侧血管舒缩区和运动区。胸闷腹胀加胸区和胃区。用28号2—3寸毫针。患者取卧位，沿头皮斜刺，进针2—3寸，每隔10分钟行针一次，留针1小时，7天为一疗程，休息3天再开始第二疗程。

本组25例，治疗不超过三个疗程，22例患肢水肿完全消失，3例明显减轻，对其它症状均有不同程度的改善。

宋修亭 头针治疗肢体浮肿25例 上海针灸杂志 (4); 30, 1987

15. 脑血管意外

头 皮 针 法

均采用头皮针治疗，运动障碍以伏象、倒象患侧为主，感觉障碍

以伏脏、倒脏患侧为主；神志不清取思维、头部、记忆、信号为主，血压不稳者取头部、书写、听觉、呼吸为主，语言障碍以说话、记忆、信号为主。还要根据病人具体情况，结合中医辨证施治选取头皮针其它穴位或适当配合其它穴位。（指个别患者头皮某部位因有疤痕、炎症等或其它原因不宜针刺者，适当配合头皮针以外的穴位。）

每日针刺一次，10—15次为一疗程，留针30—50分钟。休息3—5日，再进行第二个疗程。

共治疗707例。基本治愈：偏瘫、麻木、失语等主要症状恢复生理功能，能够劳动或工作。显效：偏瘫、麻木、失语有明显恢复，生活基本自理。有效：症状有不同程度的改善。无效：症状无明显变化。

治疗结果：707例基本治愈437例，占61.8%。显效115例，占16.27%。有效138例，占19.52%。无效17例2.4%。总有效率97.6%。

方云鹏等 头皮针治疗707例脑血管意外偏瘫疗效体会

针 刺 法

脑血栓形成与脑梗塞者用中医治疗，脑溢血者先用西药降压、止血、抗感染，病情稳定后用中医疗法。1.主穴：华佗夹脊穴 T1~5，针刺1~1.5寸，风府1.5~2寸。2.配穴：①半身不遂：一般均刺病侧穴，上肢取曲池、外关、合谷；下肢取环跳、足三里。②兼口面喎斜取下关、颧髎，失语取哑门。针刺得气后，要求针感传导直达病所，配穴根据寒热虚实施行补泻手法，留针20分钟后加火罐15分钟，10次为一疗程，休息3~5天后再施第二疗程。

共治疗77例。痊愈：语言清晰，患侧肢体活动正常，肌力Ⅲ级以上，生活自理，共27例。显效：语言清楚，患肢活动基本正常，肌力较治疗前提高，共26例。好转：语言存在，患肢活动较治疗前好转，共20例。无效：经治疗后上症毫无改善者为无效，共4例。

张 栋 针刺夹脊穴为主治疗脑血管意外77例 陕西中医 (5)，201，1988

胞二磷胆碱穴位注射法

取穴：肩髃、曲池、合谷、环跳、足三里、阳陵泉为主穴，手三里、内关、承山、悬钟为配穴。每次取胞二磷胆碱1支（2毫升、0.25克）分注，选2～4穴，主、配穴合用，取病人患侧，上下肢同时施术，每日1次，10次为1疗程，疗程中适当施以按摩并嘱患者功能锻炼。

共治疗40例，经2～7疗程治疗，7例基本痊愈（肌力增加3级或基本达V级）；21例显效（肌力增加2级或基本达IV级）；9例有效（肌力增加1级或基本达III级）；3例无效（肌力略有改善，或无变化，或反较治前下降）。

李增林等 胞二磷胆碱穴位注射治脑卒中偏瘫40例 浙江中医杂志（11）；500，1988

CT 定位围针法

以颅脑电子计算机断层摄影（即“CT”）所显示的病灶在头皮的相应投射区四周为针刺部位，以1寸毫针4—8针（针数视病灶大小而定）围针，方向皆刺向投射区的中心，进针方法同常规头皮针。得气后以200次/分左右的频率捻转片刻，然后留针6—8小时。结合体针治疗：以手足阳明经穴为主，上肢如肩髃、曲池、手三里、外关、合谷、八邪、下肢如环跳、阳陵泉、足三里、解溪、昆仑、八风。口角歪斜配地仓、颊车、太冲，语言不利配哑门、廉泉、通里，另外还选用十二井穴、人迎、极泉。对于病情较顽固或病情较重的患者，还配合中药辨证施治。

共治疗46例。1. 基本痊愈：瘫痪肢体运动功能基本恢复，上、下肢肌力均达IV级以上，生活基本能自理，能参加一些劳动，共13例。

2. 显效：（1）病史在6个月以内者，瘫痪肢体运动功能明显改善（瘫痪一侧上下肢肌力相加共提高V级以上），能自理部分生活

或从事一些轻劳动。(2)病史在6个月以上或二次以上发生脑血管意外者,瘫痪肢体运动功能较治疗前改善较明显(瘫痪一侧上下肢肌力相加共提高了Ⅱ级以上),共20例。

3. 好转:瘫痪肢体运动功能较治疗前有所改善,共12例。

4. 无效:瘫痪肢体运动功能较治疗前无改善者,1例。

杨文辉等 “CT”定位围针为主治疗脑血管意外后遗症46例 广州中医学院学报 (3); 150, 1988

眼 针 法

(一) 取穴:眶周眼区双侧上焦区、下焦区。

(二) 眼针穴位的划分和取穴方法:

1. 两眼向前平视,经瞳孔中心做一个水平线并延伸过内外眦,再经瞳孔中心做该水平线之垂线,并延伸过上、下眼眶。于是将眼分成四个象限,再将每个象限划分成两个相等区(即四个象限共分八个相等区)此八个相等区就是八个经区。

2. 八区所属脏腑:一区肺和大肠,二区属肾、膀胱,三区属上焦,四区肝和胆,五区属中焦,六区心和小肠,七区脾和胃,八区属下焦。

3. 每区占的领域,以钟表作比喻,用时针计算为90分钟,如:左眼三区(上焦区)由1点30分至3点,八区(下焦区)由9点至10点30分,右眼逆行,三区4点30分至3点,八区(下焦区)由9点至7点30分,余此类推。

4. 上焦区、下焦区所治疾病范围:由膈肌以上,胸背部,胸腔内容脏器,颈项,头面五官及上肢,为上焦区治疗范围。脐水平以下,小腹、腰、臀、盆腔生殖、泌尿系统及下肢,为下焦区治疗范围。

(三) 操作方法:选30号5分毫针,常规消毒,在每取之穴距眼眶边外缘2分处,按取穴顺序横刺进针,留针5~10分钟,起针后用棉球压迫针刺处,以防出血。针刺前两个疗程每日一次,10次为一疗

程,一个疗程结束后,休息3~5天,两个疗程以后改为隔日一次。

共治疗40例。经治疗后,除生活自理外,尚能操持部分家务劳动,或参加较轻工作者为痊愈,9例。经治疗后,瘫痪肢体显著好转,,但次于痊愈程度者为显效,9例。经治疗后,瘫痪肢体有所改善者为进步,15例。经治疗后,毫无改善者为无效,7例。

赵立志 眼针治疗脑血管意外后遗症40例疗效观察 中国针灸 (3), 16, 1986

硫酸镁穴位注射法

患者取平卧位,露出上下肢穴位,常规消毒,用5毫升注射器,5~7号针头吸取25%硫酸镁注射液4毫升,每个穴位注射1毫升。上肢取穴:内关、曲池、手三里。下肢取穴:三阴交、足三里,胫陵泉、承山。每次上、下肢各选两个穴,隔日一次,连用5次为一疗程。休息3天,进行第二疗程。在治疗中患肢肌力达到4级即停止治疗。注射时先用针头在穴位内提插,增强刺激,有酸胀、疼痛感后推药。拔针后不加压,有出血加压止血,并在穴位注射前后观察血压变化。

共治疗24例。显效:治疗后肌力较治疗前好转3级以上,或达到4级者。有效:治疗后肌力好转1~2级者。无效:治疗后肌力无变化者。

本组病人于穴位注射两个疗程后进行疗效统计:上肢获显效10例(占42%),有效14例(占58%)。下肢获显效16例(占67%),有效8例(占33%)。上肢总有效24例(100%),下肢总有效24例(100%)。

何万春等 硫酸镁穴位注射治疗脑血管意外偏瘫24例 北京中医学院学报 (4), 封三, 1989

附：脑源性瘫痪、失语

头 针 法（一）

1. 备26—28[#]、40—50mm 毫针，电动头针捻转机。

2. 根据不同肢体瘫痪选取对侧“顶颞前斜线”（运动区）、常规配取“顶旁Ⅰ线”（足运感区），瘫肢麻木疼痛者加“顶颞后斜线”（感觉区），瘫肢水肿或高血压者加“血管舒缩区”，失用症加“顶旁Ⅱ线”（运动前区），上肢功能（手指精细动作）恢复迟缓者加“手指加强区”。失语按其性质选穴，运动性失语取“顶颞前斜线”（言语Ⅰ区），感觉性失语取“颞后线”（言语Ⅲ区），恢复迟缓者加“言语加强区”，合并偏瘫者取健侧穴，单纯失语双侧交替取穴。

3. 操作步骤：取合适体位，按病情需要选取施术标准线，确定进针点，常规头皮消毒，持针与头皮呈30度角，沿头皮快速推针，刺入帽状腱膜下层，各点顺序进针后针柄插入电动头针捻转机套管，打开电机开关起动捻转。可按补泻需要调节捻转频率，130—200次/分钟为补，310—400次/分钟为泻，200—300次/分钟为平补平泻，捻转2分钟自动关闭电源，停转后除去捻转机头件，保留头针10—20分钟，再捻转第二次。每日或隔日一次，15次为一疗程，疗程间歇3—5日。

共治疗444例。治愈：瘫肢功能基本恢复，肌力4—5级，说话流畅如前；显效：瘫肢功能显著恢复，手可抬举，腿可站立行走，肌力3—4级，言语稍欠清晰流畅；好转：瘫肢功能部分恢复，肌力2—3级，仅能说单词；无效：经头针2个疗程功能无任何改善。

瘫痪组335例，治愈208例，占62.1%；显效58例，占17.3%；好转49例，占14.6%；无效20例，占8%，总有效率94%。失语组109例，治愈67例，占51.5%，显效19例，占17.4%，好转15例，占

13.8%，无效8例，占7.3%，总有效率92.7%。

陈道翼 头针治疗脑源性瘫痪、失语444例报道 中国针灸 (2), 9, 1987

头 针 法 (二)

一、头针配体针组

根据病变部位出现的运动障碍，结合大脑皮层功能定位，采用相应的对侧区域针刺。如下肢瘫痪，选对侧运动区上1/5及足运感区，再配隐白、环跳，针感以下肢屈动为佳。上肢选对侧运动区中2/5，配刺少商、极泉。使肢体屈动。面瘫、流涎、舌偏及运动性失语，选对侧运动区下2/5，配廉泉、哑门，针感至舌根麻胀。若偏瘫有感觉障碍，可选取对侧感觉区（上下肢取法同运动区）。若为小脑病变，步态蹒跚，左右歪斜。可选平衡区。若上下肢活动尚好，但手功能障碍，不能作精细动作，可选取运动区。如果精神失常、哭笑无常，可选用情感区（百会透神庭或悬颅），配刺内关、神门。用28号毫针，刺1~1.5寸深（沿头皮刺），针刺感应为热、胀、沉，少数病人有痛感，留针30~40分钟，可行针2~3次，每次5~8分钟。一般病人捻针感应为身上有热感。在行针时，令活动患肢，配合治疗。以每日一次，15天为一疗程，每疗程后，间隔3~5天，再进行第二个疗程。

二、头针组

同第一组头针选区，治疗方法亦同。

三、体针组

1. 下肢取环跳、阳陵泉、悬钟。上肢取肩井、风池、曲池、外关。

2. 取四神聪和下肢取髀关、足三里、血海、三阴交；上肢取极泉、手三里、合谷。

若伴有精神障碍，再配人中穴、神门，失语流涎配廉泉（泻）、哑门，遗尿者配关元、太溪，用补法。若上下肢肌力“0”度，针刺隐白、委中、少商、极泉，以强刺激手法（泻），使其患肢抽动为

佳，余穴用平补平泻手法。

上述两组穴可交替使用，以15天为一疗程，每疗程间隔3~5日，再继续治疗。

共治疗72例。基本治愈。瘫痪肢体运动完全恢复，生活自理，能参加一定的工作与力所能及的劳动，10例。

显效：瘫痪肢体功能明显好转，一般生活自理，能自行走路，尚遗留某些功能障碍，26例。

有效：各种症状、体征均较治疗前有一定进步，33例。

无效：治疗前后症状无改善，3例。

申秀兰 头针治疗脑源性瘫痪72例 上海针灸杂志 (2)，18，1987

16. 假性延髓麻痹

针 刺 法

主穴：A. 内关、人中、三阴交。B. 风池、翳风、完骨。配穴：痰涎壅盛者加丰隆、上廉泉；阳亢头晕者加百会、太冲；舌强紫暗者加金津、玉液点刺放血。

操作要点：先刺双侧内关穴，直刺0.5~1.0寸，行捻转插提相结合的泻法一分钟。继刺人中，向鼻中膈下斜刺0.5寸，行雀啄手法(泻法)至流泪或眼球湿润为度。再刺三阴交，从胫骨后缘进针1.0~1.5寸，行提插手法之补法一分钟。风池，针尖向喉结，震颤进针，深入2.5~3.0寸，施小幅度高频率捻转补法一分钟。翳风、完骨二穴之操作同风池。每日上下午各施针一次。

针感要求：以患者咽喉部产生麻胀感为度。

共治疗227例。1.痊愈：吞咽功能恢复，饮食正常，能发音，吐字清楚，一般情况良好。2.显效：吞咽功能基本恢复，但进食水偶有发呛，吐字能听清，构音略差。3.好转：吞咽功能有所改善，可不用

鼻饲保证入量，构音较差。4.无效：治疗前后吞咽、构音障碍无改善或死亡。

227例假球麻痹经本法针刺治疗后，临床痊愈178例，占78.41%，显效30例，占13.22%，好转18例，占7.93%，无效1例，占0.44%，总有效率达99.56%。

蒋戈利等 针刺治疗假性延髓麻痹 227例临床观察 北京中医 (1); 38, 1990

附：肌注所致下肢瘫痪

电针水针法

根据瘫痪部位选取穴位。腓总神经损伤取穴：足三里、阳陵泉、环跳、委阳、绝骨、解溪等穴为主。胫神经损伤取穴：环跳、委中、承山、三阴交、太溪等穴为主。针刺后可加用低频脉冲治疗仪，刺激频率选用疏密波，电流强度以能引起瘫痪肌肉出现明显准确的收缩为标准。每次2—4穴，10—15分钟。每日一次，10次一个疗程。休息5天重复治疗。

水针穴位注射：选用维生素B₁注射液100毫克、B₁₂注射液500微克、氢溴酸加兰他敏注射液1—3毫克，三种药物混合穴位注射，每次注射3个穴位，隔日一次。

共治疗39例。痊愈：患肢运动功能恢复，肌力5级；显效：患肢运动功能大部分恢复，肌力3—4级；好转：患肢运动功能部分恢复，肌力1—3级；无效：无明显好转者。

39例中，治愈33例，显效5例，好转1例。

曾昭杰 针刺治疗肌注所致下肢瘫痪39例 中国针灸 (4); 6, 1987

17. 癲 癇

穴位埋线法 (一)

一、取穴：第1组穴：合谷、后溪、内关、足三里；第2组穴：哑门、大椎、间使、曲池；第3组穴：鸠尾、腰奇、癲癇、心俞。选穴原则，按各类癲癇临床发作表现确定。其中头重加颅息，痰多加丰隆，惊癇加本神，头痛不可忍加脑空，夜间发作加照海，胸闷加通谷。

二、操作方法：1.三角全层缝合针埋植法：皮肤常规消毒，于穴位中点两侧注入普鲁卡因，使成皮球，再将1—3号铬制肠线穿于三角针上，从一侧植入穴位正中适当深度，由另一侧穿出，剪断肠线两端，稍提皮肤，盖上无菌敷料胶布固定。2.注意针头埋植法：皮肤常规消毒后将00号或02号肠线穿入8~9号针头空间，刺入消毒后的选定穴位，用一剪去针尖的针灸针，由针头尾端顶入穴位，将肠线埋入肌层，棉球按压片刻，旋即包扎。

三、疗程：每20天或一个月埋植一次，一般一、二天内即可控制发作，或发作时间缩短。

四、辅助用药：发作频繁又在使用药物治疗的病人可维持原来用药剂量，待症状控制后逐渐减量或停药；对未用药治疗的病人，可不必加药；对首次治疗症状未被控制的病人加服丹参25克，或复方白金散（白矾、郁金、全虫、硃砂、菖蒲）以加强疗效。

共治疗865例。显效：六个月以上无发作，在此期间口服抗癲癇药物已停，或药物减低到最低限度。2.有效：发作间隔延长，持续时间缩短，症状减轻，发作前有先兆，能预防或药量减少。3.无效：术后短时间症状有所减轻，但维持时间较短。

随访观察865例，其中显效635例，占73.4%；有效187例，占21.6%；无效43例，占5.0%。总有效率为95.0%。

穴位埋线法 (二)

(一) 取穴: 以脊中和筋缩二穴为主穴, 以大椎、长强、膻中、中脘、气海、内关等穴为配穴。每次埋线首选主穴一个, 再按患者发作时的先兆症状, 辨证选用配穴一至二个, 如心中烦乱者配膻中, 胃脘嘈杂不适者配中脘, 胆怯、心神不安者配内关等。

(二) 具体操作: 令病人俯卧, 腹部垫高, 暴露腰背部, 双手交叉置于头前, 以碘酒和酒精棉球对准选穴及其周围常规消毒, 铺好洞巾, 用2%盐酸普鲁卡因作浸润局麻 (术前需作皮试), 用手术刀在距主穴旁开1.5~2厘米处一侧, 沿脊柱方向纵行切开皮肤, 切口0.3~0.5厘米, 用小号弯嘴止血钳向左右两侧分离皮下组织, 深达肌膜, 然后弯侧朝皮侧直插穴位深部进行按摩, 约1~2分钟, 使病人有麻、胀感方止。抽出止血钳, 将事先准备好的3号羊肠线3厘米对折, 用止血钳送入穴位深处, 抽出止血钳, 不可使羊肠线露出皮外, 对皮, 再用酒精棉球消毒切口处, 不须缝合, 外敷消毒敷料, 胶布固定。

配穴处也用碘酒和酒精棉球消毒, 局麻下用18号脊髓穿刺针, 刺入穴位下肌膜层, 待有麻胀感后, 抽出针芯, 将3号羊肠线2厘米用镊子镊住装入针管, 用针芯送入, 边推针芯边抽针管, 不使肠线露出皮肤, 消毒针眼, 消毒敷料外敷, 胶布固定 (必须无菌操作)。

每次埋线为一个疗程, 每个疗程三个月。埋线后不需休息, 仍可从事轻体力劳动。

埋线治疗前没有长期服用抗癫痫药者, 可以不服药, 已经长期服抗癫痫药者, 不可突然停药, 应嘱其逐渐减量两年内完全停药, 必要时还可根据出现的证候给予中药辅助治疗。

共治疗846例。埋线后发作控制, 停药后三年以上未曾发作, 无人格或智能障碍, 脑电图正常者为痊愈。埋线后, 发作基本控制, 偶而因劳累或其他原因发作一次, 症状较前明显减轻, 不发作时与常人

无异者为好转。埋线后，发作次数减少，症状减轻，但未能完全控制发作者为有效。埋线后，病情无明显变化，发作如故者为无效。

本组846例经埋线治疗后，痊愈30.2%，好转53.3%，有效16.3%，总有效率为100%。

李凤太 穴位埋线治疗癫痫846例临床观察 中国针灸 (1), 1, 1986

穴位埋药法

1. 取穴：取两侧臂臑及其附近皮下组织，作为埋药部位。

2. 药物：苯妥英钠0.4，苯巴比妥0.12，作为一次埋药量，经高压消毒，分为各半，埋入两侧穴位局部皮下组织。

3. 操作：令病人露出两上臂，然后仰卧在手术台上。先将一侧上臂三角肌尽端处，用2%碘酊消毒，再用75%酒精棉球脱碘，作常规消毒。用1%普鲁卡因4~6毫升，作皮下浸润麻醉。（先经皮试）用手术刀在穴位附近，切开皮肤约0.5厘米，用弯嘴止血钳分离周围皮下组织，然后将上述药物各一半慢慢埋入，最后缝合皮肤，外加消毒纱布复盖，并以胶布固定。再以同样方法，将剩下的药物埋入对侧臂臑穴。手术完成后给病人口服三天量消炎药，以预防感染。术后8~10天拆线。一般埋药前长期服用抗癫痫药者，不能立即停药，需埋药1~2次，待症状控制后才逐渐减量。

4. 疗法：每30~40天埋药一次，6次为一疗程，一般埋药一个疗程观察疗效，以后视需要延长埋药时间，以维持控制发作。

共治疗241例。基本痊愈：埋药后控制发作，不需服抗癫痫药，脑电图复查基本正常，追踪观察一年以上无复发者；显效：埋药后只需极少量药维持控制发作，或埋药后基本控制发作，偶尔疲劳或其他原因，发作一次但症状较轻；有效：埋药后发作次数减少，症状较轻，或服减量药物便能控制发作者；无效：埋药后发作次数及症状无明显改善。241例中，基本痊愈者13例，占全组病例5.4%；显效者76例，占31.5%；有效者135，占56%；无效者17例，占7.1%。总有效

率为92.9%。但治愈率较低。

附院针灸门诊 穴位埋药治疗癫痫 241 例临床观察 广州中医学院学报 (3); 153, 1988

穴位埋线法 (三)

用三角针埋线法：皮肤消毒后，在穴位两侧 1.5 厘米处局麻，用持针器夹住带羊肠线之三角针，由局麻一点穿过穴位，由另一局麻点穿出，多次来回牵拉羊肠线，使穴位产生酸麻胀感，然后紧贴皮肤剪断羊肠线，局部消毒后敷盖消毒纱布。线头一定植入皮内，不得外露。

取穴以督脉穴为主：大椎、陶道、灵台、筋缩、脊中、命门、腰阳关、无名穴（第二胸椎棘突下）、癫痫穴（大椎与尾骨端联线之中点，相当第十一胸椎棘突）、腰奇穴（第二骶椎棘突下）一般症例仅取上述督脉穴及督脉上奇穴；不配体穴，上下各取一穴，常用大椎、腰奇、陶道、癫痫穴两对。个别症例痰湿明显配丰隆，胃脘不适配足三里、鸠尾，智力障碍配内关等。每 2～3 周埋线一次，穴位上下配对轮换使用。一般治疗 2～5 次，长者 10 余次。

埋线前没有长期服用药物者，可以不服药。原长期服用抗癫痫药物者暂不停药，随埋线疗效发挥，药物递减直至停止。

共治疗 110 例。埋线后发作控制，停药后观察半年未曾发作，或频繁的大发作明显控制，偶有 1—2 秒钟的小发作者，谓显效。发作次数明显减少，发作症状减轻，发作时间缩短，谓好转。埋线后症状少有改善但不明显者，谓无效。

110 例中显效 32 例 (29.09%)，好转 69 例 (62.73%)，无效 9 例 (3.18%)，总有效率为 91.7%。

赵 兰等 督脉穴位埋线治疗癫痫病 110 例临床观察 中国针灸 (4); 7, 1987

针刺法 (一)

根据“治病求本”的原则，在癫痫间歇期治以化痰开窍，通络定痛为主。取穴：鸠尾、筋缩、腰奇、间使、太渊、丰隆、太冲、足三里。手法：常规消毒后，快速捻转进针，得气后留针15分钟。一般用平补平泻手法，邪实者用泻法，体虚者施以补法。每次辨证选穴4~5个，间日一次，十次为一疗程。禁忌：针刺治疗期间禁食羊肉、奶酪、酒等辛温之品，避免惊、恐吓等精神刺激。

共治疗54例。经针刺治疗后控制发作，随访一年以上癫痫未复发者为痊愈；发作得到控制，停针半年后复发者为显效；发作时症状减轻，发作次数减少或推迟为好转；不能控制发作及减轻症状者为无效。痊愈者34例，显效者10例，好转者4例，无效者6例。总有效率为95.6%，治愈率为64.8%。

彭光超 针刺治疗癫痫54例的疗效观察 江西中医药 (3), 40, 1990

针刺法 (二)

主穴：身柱、神道及二穴之间（即胸椎4、5之间）、鸠尾穴；配穴：昼发加申脉，夜发加照海；肝风痰浊加太冲、风池；肝火痰热加行间、丰隆；肝肾阴虚加太溪；脾胃虚弱加太白、百会。如治疗中发作时，急针人中、太冲、长强。手法：主穴前三穴直刺1~1.2寸，灸3~5壮，鸠尾斜刺0.5~1寸；配穴按常规针刺并灸3~5壮。隔日1次，12次为1疗程，休息7天后再行第2疗程，一般1~4疗程。

共治疗35例。痊愈：针灸治疗后，观察5年未发作；显效：治疗后半年以上未发作或发作症状被控制3/4以上者；有效：发作症状被控制1/4以上或3/4以下者；无效：发作症状控制在1/4以下或无变化者。痊愈12例，显效11例，有效8例，无效4例，总有效率88.6%。无效病例中，大发作者2例，小发作和混合发作各1例。

冯文华 针灸奇经俞穴为主治疗癫痫 35 例 陕西中医 (3),
131, 1989

意气行针法

取穴：丝竹空、三阴交、太冲、阴陵泉、阳陵泉、丰隆、内关，
均双侧，鸠尾、关元。

操作：每次针治均从头至足，依次取穴、丝竹空采用意气行针
法，余穴采用平补平泻手法。留针一小时左右，每日一次，不计疗
程。针治前没有长期服用抗癫痫药者，嘱停药单纯针刺治疗，长期服
用抗癫痫药者，嘱针治同时逐渐减量，至完全停药，单纯针刺治疗。

针法：意气行针法具体操作是针入所欲刺之穴后，使之得气，密
意守气勿失，继而拇指向前捻转（约180°），紧捏针柄不动，保持针
体挺直不颤，意守针尖，以意聚气（针下有跳动感时，说明经气已
聚），然后以意行气，使上逆之气下行，三焦气机疏调。

共治疗35例。痊愈：癫痫发作被控制，停止治疗后，二年以上未
再发作，人格改变，智能减退均不明显，脑电图恢复正常者。显效：
癫痫发作次数明显减少，发作程度减轻，发作时间缩短，间隔时间延
长，脑电图明显改善者。好转：癫痫发作次数减少。发作程度减轻，
发作时间缩短，间隔时间延长，但脑电图无明显改善者。无效：经一
个月治疗，病情无明显变化，脑电图无改善者。35例中，痊愈25例，
显效7例，好转2例，无效1例，痊愈率71.43%，总有效率97.14%。

张智龙 意气行针法治疗癫痫35例临床观察 天津中医 (1),
30, 1990

针刺法 (三)

取穴：百会、神庭、筋缩、足三里、太溪、关元；脑电图定位
灶：额区取本神透阳白，顶区取承光透通天，颞区取率谷向前刺1.5
寸，枕区取玉枕向下刺1.5寸。

针法：头部穴位用2寸毫针快速平刺，进针约1.5寸，施捻转手法，出现酸胀感即止，然后接G 6805治疗仪，频率为20次/分，强度以患者能忍受为度。筋缩穴用26号3寸毫针向下刺入约2.5寸，施捻转手法，出现酸胀感和向上或两侧放射感即止。其他穴位用2寸毫针，施补法。以上每次30分钟，每日一次，75天为一疗程。疗程结束后复查脑电图，休息一周，继续治疗。共观察三个疗程。

根据1979年全国神经科青岛会议制订的疗效标准，本组34例中，显效（完全停止发作或发作次数及时间减少75%以上）11例，占32.4%；有效（发作次数及持续时间减少25%以上）13例，占38.2%；无效（发作次数及持续时间减少25%以下）10例，占29.4%；总有效率为70.6%。

此外，34例患者均有不同程度的脑电图异常改变，其中高度异常8人，中度异常10人，轻度异常16人。经治疗后，高度异常3人，中度异常5人，轻度异常20人，正常6人，总好转率为53%。

李 智 针刺治疗癫痫34例临床观察 江苏中医 (9), 21, 1989

18. 面肌痉挛

电 针 法

1. 仪器：上海产G 6805电针治疗仪。

2. 选穴：主穴：翳风、牵正、下关。配穴：合谷（健侧）、风池（双）、三阴交（双）、太冲（双）。眼睑抽搐加太阳、四白、阳白、鱼腰，面颊抽搐加颧髎、迎香，口角抽搐加地仓、颊车、上穴均取患侧，交替使用。

3. 操作：进针后，有丁针感再接上G 6805电针治疗仪。采用连续波，小的电流强度，高频率70次~90次/秒，通电30~60分钟，一日一次或一日二次，6次为一疗程，中间休息2~3天，再行第二疗

程。

共治疗24例。经过10天~30天治疗，其疗效：痊愈（临床症状完全消失）8例，显效（临床症状基本消失，在劳累或情绪不安时偶见轻度发作，但无需治疗即能自行停止）9例，进步（面肌痉挛程度减轻或发作次数减少）6例，无效（治疗前后症状无明显改变）1例。

吴绪荣 电针治疗面肌痉挛24例 湖北中医杂志 (5); 41, 1990

揠 针 法

先将患侧面部常规消毒，然后用梅花针轻轻叩打患侧面部，按部位由上至下、由左到右全部叩打，当叩打某部位时，针尖一触，立发痉挛，即在该处埋揠针1支。3天后取掉所埋揠针，继用前法，按其反应点再埋揠针。5次为1疗程，一般1~2个疗程即可收效。

共治疗45例。痊愈：面部肌肉抽动停止，随访半年未复发；显效：面部肌肉抽动基本停止，偶有复发；有效：面部肌肉抽动次数明显减少，间隔发作时间延长，持续时间明显缩短；无效：症状无变化。

45例患者中经治疗后痊愈35例，显效5例，有效3例，无效2例。总有效率为95.6%，病程短者疗效较好。

杜元灏等 揠针治疗面肌痉挛45例 陕西中医 (12); 554, 1990

针药并用法

①内服基本方：蜈蚣2条，僵蚕8克，地龙10克，生牡蛎（先煎）、生龟版（先煎）、生白芍、生黄芪各15克，全当归10克。每日一剂，水煎分2次服。②以棉签蘸四物酊（白芍、当归各60克，川芎、熟地各50克，研粗末浸入500毫升黄酒中，三天后滤渣取液）涂擦面部，然后以七星针轻轻叩刺太阳、下关、颊车、地仓穴15分钟，每

日一次，6天为一疗程，两疗程之间休息一天。

共治疗57例。41例治愈（面肌抽搐完全消失，两侧面部对称，半年以上未复发）；14例显效（面肌抽搐频率显著减少，抽搐程度明显减轻，或经10疗程治疗仍偶有轻微抽搐）；无效2例。一般3~5疗程见效，4~10疗程治愈。

刘远坝 针药并用治疗面肌抽搐症57例 湖北中医杂志 (6); 21, 1988

19. 面神经炎

针刺按摩口腔紫筋放血法

取穴：以取手足阳明经穴及邻近穴为主，治则：通经活络法。

地仓透颊车，四白透地仓，阳白透鱼腰，三里、合谷。初中期平补平泻，后期施补法。

按摩：用“牵拉法”，在面部按摩。由四白开始按摩足阳明胃经诸穴。

口腔紫筋放血法：如口腔内有一条白线和青筋用手术刀片将白线和青筋割开放血，面部肌肉则由紧张状态变为正常状态。每周放1次。15天为一疗程，一般一疗程可愈。

共治疗750例，显效：面部表情肌肉运动功能完全恢复正常。抬眉、闭眼、皱额、鼓气、耸鼻、示齿等动作自如660例（88%）；好转：面部表情肌肉运动功能基本恢复正常，但因气候变化时自觉患侧发板，上述动作两侧不对称略受限56例（7.5%）；无效：治疗后无明显改善34例（4.5%）。

孙士文等 针刺按摩口腔紫筋放血治疗面瘫750例 辽宁中医杂志 (4); 35, 1991

分型透刺法

一、取穴:

A型中枢性: 兑端透巨髎、地仓透颊车、承浆透大迎、翳风、合谷、配合头针、顶颞前斜线下五分之二。

B型乳突孔以下至末梢部位损害: 阳白透鱼腰、攒竹透丝竹空、四白透承泣、兑端透巨髎、地仓透颊车、承浆透大迎、翳风、合谷。

C型面神经管至面神经核部位损害: 以B型取穴加耳门透听会、液门透中渚。

二、手法及疗程:

面神经麻痹在整个治疗过程中分为三个阶段: 第一阶段(发病的第一周), 每日针刺一次(患侧四次、健侧两次), 手法: 泻法(捻转补泻法)。第二阶段(发病第二至第四周), 隔日针刺一次(每周患侧两次, 健侧一次), 手法: 平补平泻, 体质虚弱及老年人可适当加入补法(捻转补泻法), 并在起针后进行约5分钟的面部肌肉按摩。第三阶段: (发病的第五周以后), 隔日针刺1次(每周患侧两次, 健侧一次), 手法补法(捻转补泻法), 在针刺过程中用艾条灸面部的针刺腧穴约半小时, 起针后进行约5分钟的面部肌肉按摩。一般以12次为一疗程, 每疗程之间休息五至七天。

共治疗400例。痊愈: 面部功能完全恢复, 不留任何后遗症。

各型面瘫疗效统计

分 型	痊 愈		显 效		有 效		无 效		合 计
	例	%	例	%	例	%	例	%	例
A 型	24	50	16	33.3	4	8.3	4	8.3	48
B 型	172	89.6	16	8.3	4	2.1			192
C 型	108	67.5	40	25.0	8	5.0	4	2.5	160

显效：面部功能基本恢复，偶留局部发紧，发木及眼睛迎风流泪等后遗症。

有效：面部功能有所恢复、但留有上述后遗症。

无效：症状无改善者。

注：A型、C型（其中在面神经核受损时），可同时伴有肢体瘫痪，在评定疗效时，瘫痪肢体的恢复程度不包括在内。

任留江 分型透刺法治疗面神经麻痹 400 例临床观察 中国针灸 (3), 13, 1987

针 刺 法

上唇歪斜明显多选下关配颧髻，下唇歪斜明显多选牵正配颊车，上下唇均歪斜明显多选下关配颊车。均针患侧，得气后接通 G 6805—1 治疗仪，断续波治疗，留针 20 分钟，每日 1 次，7 次为一疗程。

200 例中，病程最短 1 天，最长 10 年，平均治疗 15 天。165 例症状消失，功能恢复正常，23 例症状、功能显著改善，12 例无效。

许 峰等 精选穴位治疗面神经麻痹 200 例 浙江中医杂志 (12), 560, 1990

三 棱 针 法

（一）取穴：主穴：吊线穴即口角内肌平行于牙齿的经络线，（口腔内出现如纸绳粗的白线或红线即是此穴。）口向左歪，线在右面，口向右歪，线在左面。配穴：地仓透禾髻，地仓透承浆穴。如眼斜配阳白穴，攒竹透丝竹空、睛明穴。加减：体弱者配足三里；头痛者配风池穴、太阳穴；面部及耳后疼痛者配翳风穴。

（二）操作方法

吊线穴：酒精棉球常规消毒，用三棱针对准此线强刺出血，间隔 0.5~1.0 厘米，排列、点刺，以出血为度。或者用三棱针对吊线穴划刺，以及平行吊线穴的上下，从后向前划刺亦可。主穴用泻法；配穴

用平补手法，体弱者用补法。针刺后按摩患侧面肌、口角、眼睑周围、眉梢、额颊等部位，以皮肤发热为度。每日针刺1次或隔日1次，12次为一疗程。

共治疗200例。治疗两个疗程口眼歪斜已纠正，面部表情恢复正常，无自觉症状者为痊愈。面部表情基本恢复正常，说话时口角微现歪斜者为显效。治疗后面部表现及自觉症状无改善者为无效。

本组200例，痊愈186例，显效14例，有效率为100%，痊愈率为93%。疗程最短8天，最长5个疗程。

李文斌 吊线穴为主治疗面瘫200例疗效观察 山西中医 (6), 31, 1990

药物穴位注射法

1. 穴位：合谷、下关、地仓、太阳、阳白、颊车、颧髎、外关。

2. 操作：用2ml注射器抽吸维生素B₁₂ 0.2mg，用6号注射针头，穴位周围常规消毒后，左手固定穴位周围的皮肤，右手持注射器刺入穴位，待患者出现酸、麻、困、重或抽动感时，一边推药一边退针。每次选4个穴位，每个穴位注射0.05mg。注意面部穴位不宜刺入太深，一般直刺或斜刺为6号针头的1/2。

3. 疗程：隔日1次，5次为1疗程。

共治疗160例。痊愈：面瘫症状消失，体征检查正常；有效：面瘫症状基本消失，体征检查接近正常，平静时面容如常，受寒或劳累之后面肌板结不舒或大笑时口角轻度喎斜；无效：治疗前后无变化，或出现“小眼”“兔眼”，“面肌痉挛”等后遗症。痊愈137例，有效21例，无效2例，总有效率为98.7%。病程短，治疗愈早，疗效越佳。

赵学升 维生素B₁₂穴位注射治疗面瘫160例 陕西中医 (7), 325, 1990

针 刺 法

1. 深刺纠正穴：纠正穴部位位于手小指尺侧、指掌关节横纹头赤白肉际处。操作方法：轻度握拳至半横位，针刺从外侧沿掌骨前向内刺入后透至合谷穴。2. 穴位注射：维生素 B₁或当归液（含量 5 %）用雀啄手法注入双侧手三里穴，每穴 2 毫升。3. 治疗时间：每日治疗 1 次，10 次为一疗程，休息 2 ~ 4 天可进行第二疗程。

共治疗 155 例。症态消失，外观正常，检查无异常表现为痊愈；症状基本消失，外观大致正常，皱鼻或鼓腮稍差或有不适者为显效；症状稍有好转，外观稍有改变者为进步；症状无明显改变，功能有障碍者为无效。

痊愈 125 例，显效 14 例，进步 11 例，无效 5 例。总有效率 96.77 %。

梁振仓 针刺治疗面瘫 155 例 陕西中医 (5)，216，1988

多针浅刺法

一般采用 5 分毫针 10 ~ 15 枚，刺法浅而快。捻转进针，留针 5 ~ 15 分钟，取针后配以梅花针和轻度面部按摩，并嘱患者早晚各揉捏眼睑部及唇周 5 ~ 10 分钟。10 次为一疗程。第一疗程每日一次，后间日一次。根据面瘫表现，选用患侧面部穴位。如阳白、攒竹、鱼腰、睛明、迎香、颧髎、地仓，太阳等穴。攒竹、睛明、地仓等穴可采用“直针刺”法；在患侧面部鼻翼旁、唇上、下方肌及颊部用 5 分毫针，采用“扬刺法”；取患侧翳风、颊车、外关、双侧太冲，健侧合谷，采用分刺与经刺相结合（均留针以泻肌肉中的邪气并疏通经脉，此法一般于面瘫急性期辨证选用；病程在两月以上者，双侧同刺，患侧仍用多针浅刺，少留针，健侧只选用颧髎、下关、颊车等二至三穴，深刺，强刺激，留针约 20 ~ 30 分钟。

共治疗 137 例。经过 0.5 ~ 3 个疗程治疗，本组 137 例中，治愈 111 例，好转 22 例，无效（治疗后无明显改善）4 例。

张秀芬 多针浅刺治疗周围性面瘫137例 湖北中医杂志 (1),
37, 1990

透穴加梅花针法

主要穴位有：地仓透颊车、阳白透鱼腰、四白透迎香、瞳子髎透太阳，以及针刺下关、翳风、人中、完骨等穴位。每次取穴2~3组，交替使用。

针刺手法 风寒型：采用热手法，得气后留针40分钟；用梅花针轻叩穴位，每穴20秒钟左右；并可辅以艾灸，消散面肌僵硬。风热型：采用凉手法透穴刺，得气后留针30分钟；用梅花针重叩穴位，每穴30秒钟左右，并用三棱针在穴位上放血。外风型：采用平补平泻手法，透穴针刺后，出现柔和的酸胀感即可留针20分钟；用梅花针轻叩穴位，每穴10秒钟左右。

共治疗126例。各种症状全部消失，面部完全恢复正常为痊愈；症状消失，外观如常，但说话或开口笑时，仍有轻度歪斜为好转；症状虽有减轻，但体征改善不明显为无效。结果：治愈119例，占94.4%，好转7例，占5.6%，总有效率为100%。

赵晓菁 透穴加梅花针治疗面神经麻痹126例临床观察 国医论坛 (1), 28, 1991

电针加鳝鱼血外敷法

取穴：眉中、地仓、颊车、攒竹为甲组；牵正、阳白、眉梢、太阳为乙组。两组穴位交替使用，每天1次，每次30min，配用透穴手法，并可选用合谷、下关作配穴。

操作：采用G6805—1治疗仪，刺激频率一般在150次/min左右，电流强度以病人能忍受为限，每次30min，每天1次。同时患侧用新鲜鳝鱼血外敷，并包扎。10天为1个疗程，1个疗程后，休息2~3天，如未见效，继续使用第2个疗程。

共治疗115例。痊愈：面瘫症状消失，体检正常；有效：症状基本消失，笑时口角稍向健侧歪；皱眉时患侧额纹比健侧浅，患眼闭不紧，口角轻度歪斜；无效：治疗前后无变化。

痊愈100例，好转13例，无效2例，总有效率98.26%。其中有效在1个疗程80例，2个疗程25例，3个疗程以上10例。

陈国栋等 电针加鳝鱼血外敷治疗面瘫115例 陕西中医 (4)，179，1991

透针加拔罐法

常用穴位有阳白透鱼腰、丝竹空透攒竹、地仓透颊车、地仓透人中、地仓透承浆、地仓透迎香、四白透颧髻等。刺时酌情选择3~4组穴，用浅刺或平刺从一穴向另一穴进针，得气后反复提拉2~3次，留针20~30分钟，接G 680治疗机以加强针感和针刺的持续作用。还可加风池、翳风等穴。出针后用闪火法在患侧拔罐，反复至罐口发烫为止。12天为1个疗程。

共治疗107例。痊愈81例，占75.7%，有效24例，占22.4%，无效2例，占1.9%。

王淑湘 透针加拔罐治疗口眼喎斜107例 吉林中医药 (6)，24，1987

针 刺 法

患者仰卧位，取双侧丰隆穴，常规消毒后用3.5寸长毫针快速刺入皮下后，将针刺入3寸深度，得气后施捻转提插补法。留针30分钟，间歇行针2~3次。

共治疗102例。痊愈：眼睑闭合良好，其他面肌功能也基本恢复77例占75.49%；好转：临床症状改善，遗留不同程度的面肌功能障碍23例占22.55%；无效：治疗前后，临床症状无变化2例占1.96%。总有效率为98.04%。

王宪利 深刺丰隆穴治疗周围性面瘫102例 辽宁中医杂志
(3); 32, 1991

针刺加特定电磁波法

主穴：翳风、颊车、地仓、阳白、四白、瞳子髎、合谷。配穴：攒竹、迎香、水沟、承浆、下关等。

治疗方法 每次选用3~4个主穴，另加二个配穴，留针20~30分钟。均用特定电磁波治疗机（重庆市硅酸盐研究所生产）照射局部，距离辐射板30cm。10天为一疗程，一般治疗1~2疗程。

共治疗100例。重点观察面容及面肌运动机能。症状消失，面肌功能恢复为痊愈，62例；症状消失，但皱额、闭目、露齿三项指标中尚有部分未完全恢复为显效，33例；症状减轻，但皱额、闭目、露齿三项指标未恢复正常为好转，5例症状及三项指标均无改善者为无效。

胡 辉 针刺加特定电磁波治疗周围性面瘫100例 湖南中医学院学报 (3); 170, 1990

挂线法

选用患侧颊车穴，备好无菌马尾线，缝皮针，持针器，镊子。常规消毒，在颊车穴位上缝合一针，其宽度约0.5厘米，深0.2厘米，扎双结，敷料包扎，1周后拆线。嘱患者每天自己按摩合谷、人中、四白、太阳、睛明、阳白、翳风、风池、下关穴，由轻而重，先按后揉，以促进脉络流通。然后五指指尖合拢（如同梅花型），放松腕关节，轻松而灵活的叩击，直到面部有热、麻、胀、放射传导感为止。

共治疗100例。治愈：自觉症状消失，患侧表情肌运动同健侧，功能恢复正常71例，占71%。

显效：自觉症状基本消失，面部表情肌运动近似健侧19例，占19%。

好转：症状减轻，面部表情肌运动部分恢复9例，占9%。

无效：症状和面肌活动障碍无改变1例，占1%。

本组病例总有效率99%，最少挂线1次而愈，最多挂线3次。

赵淑英 挂线治疗面神经麻痹100例 天津中医 (6)，28，

1988

头皮针法

1. 取穴：头皮针伏象：头、面、颈部，相应脾俞、胃俞、肝俞、肾俞、肺俞、膈俞、关元俞、呼循、平衡等。

倒象：上部、脾俞、肝俞、大椎。

2. 根据病情取以上穴，每次选3~6个穴位，可随症加减、交替使用。

3. 针具、针法：用28号1寸针，常规消毒后，快速刺入所选穴位（又名飞针法），虚则补之，实则泻之，不虚不实则平补平泻。

4. 疗程：10天为1个疗程，每日治疗1次。基本恢复期间，可改为2日或3日1次，痊愈为至。头皮针每次治疗可以留针20至30分钟。

共治疗80例。痊愈：症状消失，功能完全恢复正常，无任何异常表现或不适感；显效：外观症状消失，功能恢复正常，但有不舒适感；无效：治疗前后无明显变化。痊愈72例，占90%，显效8例。

吴健民 头皮针治疗面瘫80例疗效观察 陕西中医 (2)，81，

1989

灵龟八法

一、选穴

1. 开穴：灵龟八法临时开穴，此为主穴，每次必用，包括配对穴，如公孙、内关互为配对穴，开公孙则同时取内关。

2. 局部配穴：耳后或完骨处疼痛或触痛者，完骨、风池、翳风

交替用作配穴；额纹消失，眼睑不能闭合者，阳白（透鱼腰或透临泣）、丝竹空、攒竹，交替作配穴；齿颊嵌食，不能鼓腮吹气、口角漏水等，下关、颊车（透听会或透颧髻或透巨髻或透地仓），交替作配穴。

每次选取1~3个配穴，亦可不加配穴。

二、操作

1. 体位：依据取穴及操作的需要，患者采用侧卧或仰卧位，医者采用坐或站位。舒适自然，身心松静，精神专一。

2. 方法：常规消毒，快速进针，施徐疾、提插、捻转、雀啄等手法令针下得气，并使气循经行或气至病所。留针28.8分钟或其2~3倍的时间，留针期间频频行针以维持气感。阳日在得气后于针柄上加艾温针灸（亦可艾条单灸28.8分钟）；阴日于针或梅花针轻叩渗血后加拔罐，不灸。

上法每日1次，5次为1疗程，观察治疗数疗程。

共治疗67例。痊愈（症状体征消失，功能完全恢复）60例；有效（症状体征基本消失，功能明显改善）3例；无效（症状体征未见明显变化，功能没有明显恢复）4例。痊愈率为89.5%，总有效率达94.3%。

麻福昌 灵龟八法治疗周围性面瘫67例临床小结 江苏中医（5），21，1989

经络电冲击疗法

取穴：耳穴取面颊区；体穴取地仓、颊车、迎香、阳白、四白、攒竹。操作方法：用JJ20I型中国经络诊疗器的探头在患者患侧穴位上探测变阻点，在变阻点上电冲击治疗，波型为疏密波。治疗原则：每次取3~4个穴，每穴不连续使用，可交替进行。耳穴每次必取，电流强度以患者能耐受为宜。每穴10分钟，每日1次，7次为1疗程。

共治疗60例。症状全部消失，面肌活动正常者为治愈；症状大部

分消失，只有轻微不易察觉者为显效；症状改善1半以上者为好转；经治疗1～2个疗程后无任何改变者为无效。

治愈48例，显效8例，好转3例，无效1例，总有效率为98%。
治愈者追访1年情况良好。

张友陇 经络电冲击疗法治疗面瘫60例 陕西中医 (5); 229, 1990

代针丸与耳针配合法

(一) 用代针丸贴敷患侧面部丝竹空、下关、颊车、地仓、翳风穴，口角歪斜严重者加迎香。用1.5×1.5厘米伤湿止痛膏或胶布固定，一日更换一次，五日为一疗程。

代针丸制作：公丁香、吴茱萸、白芥子、五倍子、磁石各等分共研细末，加冰片（为以上药量的十分之一），麝香少许，用凡士林调合为丸如绿豆大。

(二) 耳针疗法：在健侧耳部作好常规消毒，将消毒的揲针用镊子挟起，在眼、太阳、额、颊、皮质下准确快速地刺进穴中，并用胶布固定，每日指压3次增强刺激，五日更换一次，即为一疗程。

共治疗56例。口眼歪斜恢复正常，无自觉症状者为痊愈。56例患者用上法治疗后全部获愈，一般为3～5个疗程，最短者一个疗程，最长者十个疗程。

杨 茹等 代针丸与耳针配合治疗颜面神经麻痹56例 天津中医 (1); 20, 1988

耳背放血配合针灸法

(一) 选患者耳背近耳轮处，明显血管一根，揉搓2—3分钟使其充血，常规消毒后，持高压消毒过的刮脸刀片，以刀尖纵型垂直划破血管，放血3—4ml，青壮年可放4—5ml，然后盖上无菌敷料，胶布固定，术后一周勿水浸，以免感染，如1周后仍无痊愈或好转，可

仍对它条血管，进行第二次割治。

(二) 针刺治疗：割治后 30 分钟即可行针刺治疗，无任何妨碍。

主穴：阳白、攒竹、四白、地仓、迎香、颊车、风池、合谷、颧髻。

(三) 对症加减

1. 风寒痹阻证：针刺以泻法，侵及阳明胃经加足三里、中脘、天枢。

2. 肝胆湿热证：针刺以泻法，加太冲、曲池、行间、冲阳。

3. 气阴两伤证：针刺以补法，加三阴交、足三里、内关，日 1 次，7 天 1 疗程。

共治疗 40 例。症状和体征消失，面部表情肌运动恢复功能为痊愈。症状和体征基本消失，讲话或笑时口角微有歪斜，但额纹及鼻唇沟仍未恢复者为显效。经割治 1 次，针刺 1 周症状及体征无改善者，为无效。痊愈 33 例，占 82%；显效 6 例，占 15.5%；无效 1 例，占 2.5%。总有效率为 97.5%。

韩晓军 耳背放血配合针灸治疗周围性面神经麻痹 40 例 北京中医学院学报 (1)，45，1988

穴位划痕敷药法

1. 取穴：主穴为下关或下关后方点（即面神经干点）、地仓、颊车。配穴：根据不同症状选取，不能蹙额者取阳白；眼裂扩大配攒竹、四白；上睑下垂取丝竹空上外点（即面神经颞支点）；上唇不能上抬配禾髻；鼻唇沟平坦配迎香、颧髻；口角下垂配地仓；不能鼓颊、食物滞留配颊车或大迎；耳后痛者配翳风。以上均在患侧取穴，每次 5～6 穴，每周 2～3 次，一般治疗 7～12 次。2. 划痕敷药方法：在穴位常规消毒后，用消毒刀片在穴位皮肤上快速划一十字形或廿字形小口，每划长约 2～3 毫米，以划破表皮不出血为度。然后将药散敷在穴位上，用胶布贴盖。3. 药物组成：白花蛇 15 克、白胡椒 10

克、麝香2.5克。各研细末均匀混合。如上药缺乏可用下列药物：金蝎、蜈蚣、土鳖虫、僵蚕等分磨成细面，装瓶备用。

共治疗43例。痊愈：症状与体征消失，外观正常或电检查正常。显效：症状与体征基本消失或尚有轻微面瘫，体征或电检查有一定恢复者。有效：症状体征改善两项以上者。无效：症状体征均未明显改善者。43例中痊愈13例占30.2%；显效14例占32.6%；有效15例占34.9%；无效1例占2.3%。

金完成 穴位划痕敷药法治疗面瘫 中国针灸 (3), 53, 1987

割 治 法

割治前先让患者张口用2%碘酒，75%酒精消毒两侧颊部粘膜，然后用手术刀片在两侧颊部距口角约4厘米处，做纵行切口约1厘米长，深约2毫米，放出少量瘀血，用消毒干棉球清洁后嘱患者闭口，禁食2~3小时，保持口腔内卫生，防止感染。5至7天割治1次。

共治疗51例。面部表情恢复正常，无自觉症状者为痊愈。

面部表情基本恢复正常，讲话或笑时唇角微现歪斜者为显效。

面部表情及自觉症状无改变者为无效。

本组51例，痊愈49例，占96%；显效2例，占4%。病史长者1年，短者几天。割治1次治愈8人，2次16人，3次25人，8次1人，10次1人。总有效率100%。

刘衍富 割治法治疗周围性面神经麻痹51例 吉林中医药 (6), 23, 1990

麝 火 疗 法

药物制备

一、麝火药块：取麝香3克，明雄2克，朱砂2克，硫磺50克。先将硫磺置于铝锅内，取文火熔化，至锅内产生蓝色火焰时，将碾细

和匀的其余三味药倒入锅内迅速搅拌均匀，待锅内再度产生蓝色火焰时端锅，立即倒在备好凉干的土砖上摊平。此时药料似在燃烧，用备好的黄草纸盖在药料上，火焰即灭，冷却后分成小块装瓶密封备用。

二、拔毒膏：麻油100克，黄丹40克，同置于铁锅内，文火煎熬20分钟左右，至滴水成珠，不粘手即成。用干净竹片取少许药膏，薄摊于1.5平方寸的油纸上备用。

操作方法：

一、取患侧对侧之地仓、颊车、睛明、瞳子髎穴，将麝火药块（如绿豆大小）点燃后，用镊子夹好，迅速放在选好的穴位上，使其继续燃烧，用指头在所烧的皮肤周围轻轻柔按，以减轻疼痛，8秒钟左右药尽火灭。

二、贴膏药：烧后第二天所烧处呈Ⅰ度烧伤将拔毒膏贴上，每天换一次，3～5天伤口自然愈合。

注意事项：烧后近两天，少言语，少笑吃软食，避风寒。

共治疗30例。在发病一周内接受治疗的28例，烧后口角立即恢复正常。发病一月内接受治疗的2例，烧后1～2天内口角恢复正常。一般3～5天内，伤口愈合而痊愈。

周祖良等 麝火疗法治疗面瘫30例 湖北中医杂志（5），37，1989

20. 颈椎病

深 刺 法

1. 穴位：①哑1穴：位于后正中线，第二、三颈椎棘突间。针法：直刺1～2寸。针感：四肢触电感。②哑2穴：上穴下一寸，针感同上。③哑3穴：位于哑2穴旁开各0.5寸处。直刺1～2.5寸。针感：若触电感放射到上肢。④哑4穴：大椎穴上1寸处。针感针法同

哑1穴。

2. 针刺手法：常用强刺激手法，其方法是取准穴，进针（不捻转）达1~2.5寸得气后，轻提插3~5分钟或捣针2~3分深，维持刺激时间半分钟左右，以获得由弱到强的针感为度。随后缓慢出针，出针后揉按针孔片刻。

3. 注意事项：①颈部穴位深刺，一般以每日针治一次为宜，每次选穴一个，上四穴交替使用，7次为一疗程，中间休息一天，在同一天不能针刺两次，选穴不能多。针刺以1~2.5寸深为度。有的患者针刺1寸深时针感就很满意，此时就不要再深刺。取穴不准或针感很差的，有时针刺到2.8寸深时也没有反应，这时就不要再深刺，可将针缓慢退至皮上，调整方向后再刺。如经调整几次仍无针感，就不要勉强，轻轻弹针后出针即可。②针刺时应当注意选用体直，细软无勾的针，针刺时患者取俯卧位，进针沿颈椎突缓慢进针，遇到阻力改变方向，以免擦伤脊椎神经，进针后提插、捣针的动作要轻巧，退针缓慢，出针后按局部片刻。③如果出现头晕、目眩、周身无力，应采取必要措施，以免出现意外。个别病人针刺后出现类似颅内低压综合症，病人额枕部疼痛，恶心呕吐，一般对症处理即可；对头痛较重的病人，可做前顶、四神聪快速针刺处理，恶心、呕吐者可针刺内关、足三里缓解。由于进针手法较重，有的病人可表现一时性软瘫，下肢行动不变，稍加休息即可恢复。

共治疗1337例。临床痊愈：临床症状消失，颈椎活动自如。显效：临床症状明显减轻，劳累后颈部稍有不适。进步：临床症状部分较前减轻，常见肩背痛，颈部不适，但可做轻工作。无效：临床症状未见改变。

临床痊愈581例，显效399例，进步329例，无效28例，总有效率为97.91%。

周志杰等 哑1~4穴深刺治疗颈椎病1337例 陕西中医 (5), 197, 1988

针 灸 法

一、输刺、温针：取颈部病变椎体的双侧夹脊穴，用28或29、30号的1.5寸毫针快速进针，在提插捻转得气后，再用输刺法，将针尖刺入至骨，然后温针。

二、头皮针：颈或肩胛内上角疼痛者，取顶结后线，向百会穴透刺1寸；上肢麻木酸胀、疼痛、功能有障碍者，取顶颞前斜线（前顶透悬厘）和顶颞后斜线（百会透曲鬓）的三分之一段；头痛、眩晕、至而昏厥者，取顶中线（百会透前顶）和额中线（自神庭沿正中线下针刺1寸）。手法用抽添法中抽气法，即用30号1.5寸毫针，快速进针，达帽状腱膜下层时，将针体平卧，缓插进1寸许，然后用暴发力速提3次，每次至多提出1~2分。如此重复运针，以症状消失或减轻力度，再留针4~8小时。在运针和留针的同时，要求患者不断地运动患部。

以上针灸隔日1次，10次为1疗程，每一疗程间歇3~5日。

针灸治疗结束后，部分患者加服笔者自拟的“骨刺风痛灵”糖浆（主要成分为乌梢蛇、透骨草、老鹳草、威灵仙等浸酒），以巩固疗效。

共治疗162例。治疗3个疗程后，65例治愈，即症状消失或基本消失，可以正常工作和生活，占总数40.1%；72例显效，即主要症状大部分消失，其余症状显著减轻，但受凉或劳累后仍有不适，占总数44.4%；23例好转，即主要症状部分消失，其余症状减轻，能做一般工作和家务，占总数14.3%；2例无效，即主要症状仅稍减轻，占总数1.2%。总有效率为98.8%。临床痊愈者进行随机抽样X线摄片复查者10例，有好转改变者6例，无改变者4例。

孔尧其 针灸治疗颈椎病162例 浙江中医杂志（9），418，
1989

穴位注射法

(一) 取穴：大抒、肩贞、曲池，为主穴。配穴：风池、天柱、合谷、外关等。

(二) 药物：开始我们用维生素 B₁₂ 注射液，后与当归注射液合用，近年来我们又与骨宁注射液合用，三种药物以维生素 B₁₂ 注射液为主其他两种药可配一种，即二种混合注射液。

(三) 具体操作：随症选准穴位，常规消毒后，刺入穴位，用提插雀啄法得气后拉动注射器针栓，看有无回血，无回血后再推药，每次 3—4 个穴位，每穴 0.5—1 毫升，隔日一次，10 次为一疗程。休息一周后开始第二个疗程。

共治疗 100 例。症状完全消失一年以上，不因气候变化或过度劳累而出现原症状，并能正常工作者为痊愈。

症状消失后，而在劳累或气候变化时，出现轻微的原症状，但休息后不再进行治疗而症状又消失，并能正常工作者为显效。

症状减轻而没有完全消失，夜间能够入睡，能坚持工作者为好转。

经一个疗程十次的治疗后，症状未见减轻者为无效。

在这 100 例患者中治疗时间最长，用四个疗程，最短仅用一个疗程，症状出现的时间短治疗的过程就短。症状出现的时间长，又经其他治疗无效者，疗程用的就长。其中 56 例患者曾经肌肉注射骨宁注射液及维生素 B₁，维生素 B₁₂，但症状不减轻而后来我科就诊，改为穴位注射疗法。

经用上法治疗的有 45 例痊愈。53 例好转和显效的，两例因没有坚持治疗一个疗程而自行中断，停止治疗。

韩斌如 穴位注射治疗颈椎病 100 例临床观察 内蒙古中医药

(3)，23，1987

穴位注射加点送电疗法

药物组成 颈宁 I 号分甲乙两组。其中甲组由川芎、桂枝、羌

活、五加皮等药组成；乙组由红花、丹参、马勃、秦艽等药组成。

颈宁Ⅱ号由枸杞、丹参、白菊花等药组成。

配制方法 颈宁Ⅰ号，先取甲组药物，用常用水洗净，加注射用水浸泡30分钟～1小时，按蒸馏法提取蒸馏液，稍冷置冰箱。取乙组药材，经常用水洗净，煎煮提取药液过滤，放冷后置冰箱冷藏。然后将两种药液混合而成注射用药。

治疗方法 患者端坐位，取大椎穴旁开5分的两侧部位为注射点，每天注射1次，30天为1疗程。先用“颈宁Ⅰ号”14ml加10%葡萄糖注射液6ml，使总量至20ml，每侧注入10ml，于注射部位快速推入。20天后再用同样剂量和部位注射“颈宁Ⅱ号”10天。点送电疗于每天穴位注射后4～6小时进行。用698—I型点送电疗机，双手持圆型手柄电极，侧取颈项、双肩、双上肢的阿是穴，肩髃、曲池、下廉等穴位送电治疗。电疗程度以患者能耐受的最大限度为佳，每次3～5分钟。

共治疗83例。临床治愈：临床症状及体征完全消失；显效：症状和体征大部消失或减轻；好转：症状和体征部分消失或减轻；无效：治疗前后症状和体征无变化者。

本组83人中，临床治愈27人，显效29人，好转16人，无效1人。

张永红 穴位注射加点送电疗治疗颈椎病83例 湖南中医学院学报 (3); 163, 1989

梅花针配合拔罐法

首先在病变椎体周围寻找压痛点或阳性反应物，一但触及索状物、结节物、泡状软性物或压痛点，先叩打这些部位，然后叩打颈夹脊4～7和大椎穴，叩打见患处整个皮肤出血后立即拔罐，定罐5～10分钟，各部出血量不等，一般约为0.5～3ml，一般多采用泻法（重叩），虚证配肾俞行补法（轻叩），去罐后拭去瘀血，常规消毒。每周治疗2次，10次为1疗程，一般治疗1～3个疗程。

治疗期间要求患者加强颈项部的功能锻炼（包括转颈、提捏斜方肌、热敷），防止诱因。

共治疗66例。治愈：主要症状消失，无功能障碍，恢复正常生理活动；显效：主要症状消失，但受凉或劳累后略有不适；有效：主要症状改善，个别症状尚存；无效：治疗后主要症状未见好转。

66例患者经电针配合拔罐疗法治疗1~3个疗程，痊愈18例，显效36例，有效10例，无效2例，总有效率96.97%。

傅永民 梅花针配合拔罐治疗颈椎病 66例 陕西中医 (10)，467，1990

电针配合按摩法

一、电针

取穴：病变颈椎夹脊穴、大椎穴。

针法：若单个颈椎病变，则取该颈椎夹脊穴，用1.5寸毫针，向脊柱方向斜刺；若多个颈椎病变，则取最上面一个病变颈椎夹脊穴，或取两个患病颈椎夹脊穴，用3寸长毫针与皮肤呈30°角，向下斜刺，针尖方向与脊柱平行。得气后用G 6805型电针治疗仪通电，选用连续波，频率为500~800次/分钟，电流大小，以患者能耐受为度。大椎穴用1.5寸毫针直刺，得气后持续提插，使针感沿脊柱向上或向下放射。留针20~30分钟。

二、按摩

用分筋、理筋手法，配合拿、捏、揉、点、按等手法，使浮起之棘上韧带复位，脊椎两侧的阳性反应物软化或消散。在施行棘上韧带复位时，要找准剥离面，一拇指向上作逆向牵引，另一拇指沿脊柱纵轴顺滑按压。

每次治疗同时采用电针和按摩。每日或隔日治疗一次，7次为一疗程，疗程间隔3~5天。

共治疗65例。1.痊愈（39例）：自觉症状完全消失，功能完全恢复，颈部浮起的棘上韧带已复位，压痛消失，其他阳性反应物均软化

或消散，臂丛牵拉试验及叩、压顶试验均阴性。2.好转（21例）：自觉症状明显好转，颈部浮起的棘上韧带部分复位，其他阳性反应物较前缩小，压痛减轻，功能较前好转，臂丛牵拉试验及叩、压顶试验仍为阳性。3.无效（5例）：自觉症状及体征均无好转。总有效率为92%。

仲跻尚 电针配合按摩治疗颈椎病 65 例疗效观察 江苏中医
(7)；29, 1989

耳穴压迫法

主耳穴：肝、肾、颈、项。配穴：内分泌、交感、脾、神门、心、太阳、上背、枕、肩等，主穴每次必用，配穴视病情加减。痛甚者加神门、交感；骨质软化控制不理想加内分泌；帮助复位加交感、心；沉困无力加脾；后头痛加枕；背困痛加上背；肩冷痛加肩等。

治疗时，用探棒先寻求敏感点，在压痛最明显的反应点上，用胶布贴压王不留行籽，贴好后每穴每次按压5分钟，要两指对撮，一紧一松的按压，每天所贴穴位按压5次，每隔一天换贴一次，双耳轮换贴压，十次一个疗程。休息十天，可继续第二疗程，并配合适当的颈项运动。

共治疗51例。治愈：临床病状消失，恢复正常工作，随访一年以上未复发。显效：临床症状显著减轻，平时无症状，过劳后有轻微症状出现，可正常工作。有效：临床症状减轻，大多数症状消失，工作稍久，则症状又部分出现。无效：临床症状稍有减轻，或者没有变化。

本组病例共51例，痊愈30例，显效18例，有效3例，有效率为100%。最少贴压2次，最多贴压32次，一般连贴10次左右，即可显效或痊愈。神经型最多，共42例，效果也最好。

潘纪华 耳穴压丸法治疗颈椎病51例疗效观察 陕西中医 (8)，
389, 1987

21. 颈椎综合征

针 刺 法

取穴：四天穴（天柱、天髎、天宗、天井）、脾缝（奇穴：在沿肩胛骨内缘的压痛点上，针0.3寸深）。有肩周炎症状者加肩髃、臑会；吞咽困难者加哑门；有前庭症状者加百会、足三里。中等度刺激，留针15分钟，每日或隔日一次，10次为一个疗程。

共治疗250例。疗效：①颈肩部痛250例治疗后消失者83例，减轻者161例，无效者6例。手指麻木者220例中消失者101例，减轻者96例，无效者23例。肩关节活动障碍等症状者241例，基本痊愈61例，显著好转69例，好转者92例，无效14例。部分病例出现严重的回顾不利，吞咽困难、失眠、胸闷、胸锁骨肿痛、头晕、耳鸣、下肢麻木等症状，针后都能消除或减轻。根据以上疗效分析，颈肩部疼痛有效率为97.6%，手指麻木有效率为89.54%，肩关节活动障碍等有效率为94.19%。

周云鹏 针刺治疗颈椎综合症250例临床观察 中国针灸（2），14，1986

22. 神经衰弱

耳穴压迫法

主穴：神门、皮质下、神经衰弱点、枕；配穴：根据辨证选定，如心脾两虚加心、脾、小肠；心肾不交加心、肝、肾；腹胀纳差去神门，加脾、胃、三焦等。操作：先用84—1型肿瘤探诊仪（湖北仙桃产），在所取耳穴上，通电1~2min，并将治疗探头在穴区内移动，以寻找最佳敏感点，然后将粘有王不留行的胶布块贴在耳穴上，再以

拇食指两指适量捏压，并嘱患者每天自行捏压数次，睡前捏压1次，每次操作以耳廓有热胀麻痛等感觉为度。每天1次，每次用1侧耳穴，两耳交替，10次为1疗程，每疗程间隔3~4天。

共治疗156例。痊愈：不用辅助药物，自觉症状消失，睡眠时间维持在6小时以上者；显效：自觉症状改善，睡眠时间增加2~3小时者；好转：自觉症状部分改善，睡眠时间增加1~2小时者；无效：治疗1个疗程以上，症状无明显改善，或虽有好转，但易反复者。痊愈89例，显效30例，好转22例，无效15例，总有效率90.4%。

陈龙全等 耳压治疗神经衰弱156例 陕西中医 (4)，178，1991

耳穴压迫法

1. 取主穴：心、肾、神门、皮质下。其作用是降心火、升肾水、养血、安神定志。配穴：患者急躁、易怒，肝阳上亢配肝穴，疏肝理气；月经不调配内分泌调节内分泌功能；大便秘结、纳差配肺、脾、便秘点，因肺和大肠相表里，脾主运化水谷；伴有头晕、头痛、头胀等配枕、太阳、额。2. 操作方法：根据病情选好穴位，以75%的酒精常规消毒耳廓，用镊子夹起准备好的贴有王不留行子的胶布贴压于耳穴上，然后用手指按压耳穴，患者有酸、麻、胀、痛感、耳廓发热、发红即可。嘱咐患者每天自行按压耳穴3~5次，尤其是在夜间睡前半小时，要按压得耳穴感到疼痛、耳廓发热为宜。3. 疗程：2~3天贴压1次耳穴，5次为1疗程，可连续治疗2~3个疗程。

共治疗136例。痊愈：不用安眠药辅助，恢复正常睡眠，睡眠在6小时以上，自觉症状消失；显效：睡眠比治疗前明显好转，自觉症状基本消失；好转：睡眠比治疗前好转，自觉症状减轻；无效：睡眠和自觉症状比治疗前无明显进步。

治疗结果 136例中，痊愈20例，平均治疗5次；显效54例，平均治疗4次；好转60例，平均治疗2次；无效2例，平均治疗3次。

总有效率为98.5%。

董玉梅 耳压治疗神经衰弱 136 例 陕西中医 (9), 421,
1990

附：失眠症

针 灸 法

(一) 取穴：以神门为主，佐以完骨、足三里。心脾亏损，加大陵、三阴交；心胆气虚，加丘墟、百会；肾虚，加照海、太溪；胃中不和，加中脘、内关；情志抑郁、肝阳上扰，加行间、肝俞、百会。

(二) 刺法：进针后，以提插结合捻转，通调经气，依法施行补虚泻实，一般留针20~40分钟出针。每日施针1次，12~15次为一疗程。

(三) 施灸：部分久病体虚患者，以艾条温灸神门或百会20分钟。对入睡难者，睡前温灸，获效尤佳。

(四) 减免用药：全部2485例失眠病例中，有327例治前曾长期服用镇静安眠类药物，当接受针灸后10日内，逐渐减去，其余各例仅针灸治疗均未用药。

共治疗2485例。经治后1个月以上，达到入睡顺利深熟，睡眠时间充足，醒后解乏者为痊愈，共1096例。自觉失眠症状有所好转，睡眠时间有一定增加者为进步，共1362例。治疗前后睡眠无变化者为无效，共27例。

程隆光 针灸神门穴为主治疗失眠症2485例 中国针灸 (6),
18, 1986

耳穴压迫法

1. 取穴：主穴：心、神门、皮质下；配穴：肾、肝、胃。

2. 治疗方法: 耳廓皮肤用75%酒精消毒、待干, 用耳穴探测仪或弹簧探棒探测取准穴位。用 $7 \times 7 \text{mm}^2$ 的医用胶布将王不留行籽固定在所选耳穴上。嘱患者将拇指放在耳廓后面, 食指和中指放在耳廓前面, 按压所贴耳穴, 每天3~4次, 睡前必按压1次, 使其出现酸、胀、痛、热等得气感。隔2天治疗1次, 两耳交替使用, 5次为1疗程, 疗程之间隔5~7天, 也可连续治疗。

共治疗138例。治愈: 症状消失, 入睡顺利, 深熟, 每晚睡眠时间在6小时以上者; 显效: 症状明显改善, 每晚睡眠时间达5~6小时者; 好转: 症状减轻, 睡眠时间有增加者; 无效: 治疗一个疗程, 病情无明显改善者。

138例患者, 治愈68例(49.3%), 显效39例(28.3%), 好转24例(17.4%), 无效7例(5.1%), 总有效率为94.9%。

来心平 耳压治疗失眠症 138例 陕西中医 (6); 273, 1990

耳压冰片法

1. 选穴: 主穴取脑、神门、皮质下、交感、神经衰弱点、失眠点。配穴、根据病情选取心、脾、胰、胆、肝、肺、肾等。上述各穴分2—3组, 交替使用, 每次选主穴2个, 配穴1—2个。2. 操作方法: 取米粒大小的冰片贴于 0.5×0.5 厘米的橡皮膏中心。贴于双耳所取的穴位上, 压紧并揉按1分钟。3日更换1次, 4次为1疗程。嘱患者每晚睡前揉按3—5分钟。耳压期间不宜洗澡, 耳部炎症及冻伤者不宜用本法。

共治疗92例。睡眠时间每晚7—8小时, 翌日头脑清醒, 精神饱满者为显效, 40例。睡眠时间增加到4—5小时, 但仍睡眠不稳者为有效, 48例。睡眠时间无明显改善症状如故及未来复诊者为无效, 4例。

吴锡强 耳压冰片治疗失眠 92例 中国针灸 (4); 54, 1987

纳 甲 法

一、针刺的时机：约定患者逢天干为甲日开始，每天午、戌2时辰按时开穴，值时闭穴则不开。

二、针刺的疗程：十天为一疗程，甲日开始癸日结束，如不见效，休息十天，再进行第二疗程。

三、针刺的补泻：午时开穴用泻法（吸气时进针，呼气时出针，出针时摇大针孔，并放血少许），戌时开穴则用补法（呼气时进针，吸气时出针，出针时揉按针孔，不放血）。

四、针刺的穴位：据子午流注纳甲法开穴规律（自甲日至癸日午）。戌二时辰应开穴位是：甲日一午时（闭穴）戌时：窍阴 乙日一午时：委中 戌时：阳谷 丙日一午时（闭穴）戌时：内庭 丁日一午时：中渚 戌时：曲池 戊日一午时：厉兑 戌时：束骨、冲阳 己日一午时（闭穴） 戌时：窍阴 庚日一午时：通谷 戌时：阳谿 辛日一午时（闭穴） 戌时：内庭 壬日一午时：后溪、京骨、阳池 戌时：曲池 癸日一午时 厉兑 戌时：束骨

共治疗22例。结果痊愈（每晚能睡7小时以上）12例，显效（每晚能睡5~6小时）5例，有效（每晚能睡3~4小时）5例。

胡润树 纳甲法治疗顽固性失眠症 江西中医药（2），51，1988

针 刺 法

主穴取双侧申脉，配穴是：心脾两虚加心俞、脾俞，阴虚火旺加大陵、太溪，胃中不和加厉兑、隐白，肝火上扰加行间、足窍阴。对症取穴：多梦加魄户，健忘加志室，耳鸣加听宫，懊恼加内关，头晕加印堂。以上各穴均常规进针，有针感后留针15~30分钟，每日1次，7日为1疗程。病情好转后隔日1次。共治疗200例。经治1~4疗程，175例睡眠正常，35例基本正常。

23. 焦虑性神经症

针药并用法

一、中药治疗：宁神解虑汤（先父丁浮艇拟方）：龙齿、灵磁石各30克，枣仁、远志、菖蒲各15克，郁金24克，甘松12克，合欢皮、甘草各9克。另琥珀、朱砂各3克，和匀研末，分3次冲服。加减：若肝气郁结者加白芍、香附各24克，柴胡18克，青皮12克，薄荷9克，若痰气郁结者加枳实、生姜、香附各12克，胆星9克，茯苓、半夏各15克，浮海石、礞石各30克，苏叶5克；若心血虚者减远志、菖蒲、郁金各至9克，枣仁增至30克，加党参、当归、五味子各30克，龙眼肉、茯神、麦冬各15克，大枣9枚；若瘀血者加丹参30克，桃仁、红花、赤芍、水蛭各15克。

二、针刺：选风府、百会、通里、神门、内关为主穴；耳穴：脑点、皮质下。若肝气郁结加肝俞、行间；痰气郁结加肺俞、合谷、列缺、天突、丰隆；心血虚加心俞、脾俞；瘀血者加血海、膈俞。除心血虚用补法，其余均用泻法，留针3小时，每30分钟捻针1次。

三、精神疗法：首先进行“解释性心理治疗”，即告知患者此症是功能性的，不会危及生命，以减轻患者之精神压力及焦虑情绪，继之进行“支持性心理治疗”即告诉患者一定能治愈，以树立患者之信心。

四、工娱疗法：鼓励或督促患者做一些力所能及的劳动、体育锻炼或文娱活动，以转移或分散患者对于疾病的注意力。

经上述治疗后临床症状消失，则以扶正治本之方善后。肝气郁结者予一贯煎，痰气郁结者予六君子汤，心血虚予养心汤，瘀血者予四物汤加丹参、枣仁。病轻者服药年余，重者则须服药2~3年。

共治疗266例。近期疗效：266例全部获愈（焦虑症状消失，植物神经功能紊乱及睡眠障碍解除）。远期疗效：追访至1988年12月，除因其它疾病死亡24例外，211例良好（未复发，精神状况一直良好），31例显著进步（曾复发过，又经此疗法治疗有效，目前仍有稍许病态反应，不影响日常工作和生活）。

丁德正 中药针刺为主治疗焦虑性神经症 266 例 浙江中医杂志 (1), 20, 1990

24. 抑郁状态

电 针 法 (一)

取穴位：百会、印堂。斜刺一寸，用G 6805型电针治疗仪，电量以穴位局部可见肌肉轻微抽动及患者感到轻微能耐受为宜。频率为80~90次/分治疗时间为1小时，日一次，30次为一疗程。

共治疗33例。33例病人经一疗程后痊愈14人，显效10人，好转7人，无效2人，总显效率为72.7%。

王 辉等 电针治疗抑郁状态33例疗效观察 北京中医 (4), 40, 1988

电 针 法 (二)

取穴为百会、印堂两穴。手法均采用沿皮刺入，针尖相向。每日针一次，每周针6次，星期日休息，30次为一疗程。波幅最高6V，最低1.5V，平均3.54V（以调至患者感到舒适而穴位处皮肤肌肉微微抽动为度）。平均电量8~9mA、Hz8×100。每次治疗通电1小时。

共治疗30例。治疗后获痊愈13例（43.3%），显著好转9例（30%），好转3例（10%），无效5例（16.7%），总有效率为

83.3%。

刘广志等 电针治疗早老期、老年期抑郁状态的临床疗效观察
中医杂志 (5), 36, 1991

25. 幻 觉

头 皮 针 法

1. 选穴: 主穴: 督脉穴后顶透百会。辅穴: 视幻觉取正营透目窗; 听幻觉取颅息透翳风; 味幻觉取头窍阴透天柱; 嗅幻觉取承光透五处; 触幻觉取百会透正营; 前庭幻觉取风府透风池; 内脏幻觉取头窍阴透颅息。根据幻觉存在的部位选其所在经穴配合主穴调治。

2. 针法与手法: 针沿头皮呈 15° 横刺穿透至另穴或另经, 行捻转和震颤术 1~3 分钟, 病人有得气感时最好引气至病所, 然后留针不动 1~3 小时。每日针刺一次, 连续 10 次为一疗程。以后改隔日一次, 连续 10 次为第二个疗程。必要时可继续每星期 2 次, 连续 10 次为第三疗程。

共治疗 296 例。经头皮针治疗 1~2 个疗程后, 一种或多种幻觉完全消失, 病情稳定者为基本痊愈; 经头皮针治疗 1~2 个疗程后, 一种幻觉或多种幻觉已模糊不清, 病情较稳定者为显著进步; 部分幻觉消失或模糊, 病情欠稳定者为进步; 经针治 1~3 个疗程后, 幻觉无改善者为无效。

本组 296 例中, 基本痊愈 209 例 (占 70.6%), 显著进步 56 例 (占 18.9%), 进步 19 例 (占 6.4%), 无效 12 例 (占 4.1%), 总有效率为 95.9%。

张鸣九 头皮针治疗幻觉 296 例的经验 中医杂志 (6), 15, 1987

26. 梅核气

割刺疗法

准备压舌板一个，长柄手术刀一把。患者取坐位，仰面张口。术者左手用压舌板压着患者的舌头，务使咽部充分暴露，右手持手术刀将咽后壁粘膜刺破出血即可。隔两天割刺一次。割刺时要避开大血管，动作要轻柔灵活，并注意用具消毒，有出血疾病者禁忌。

共治疗110例。割刺3~7次症状消失者69例，割刺12次症状消失者24例，无效17例。总有效率为84.5%。

马新平等 家传割刺疗法治梅核气 110 例 国医论坛 (1), 84, 1991

刺络拔罐法

膻中穴常规消毒后，以三棱针快速刺入1~2分，出针后将火罐以闪火法吸附其处，使出血达2毫升左右即可。兼见胸膈痞闷，两胁胀满，纳食泛恶，舌苔薄白，脉象弦滑者加刺中脘、章门、内关；痰涎壅盛，纳少呕吐，气逆喘急，舌苔白腻，脉象弦滑者加刺丰隆、足三里、太冲；咽干少津，口渴，干咳少痰，大便不畅者加刺太溪、鱼际、支沟。以上刺太溪用补法，章门用平补平泻法，余穴均用泻法。每次留针30分钟，每隔10分钟捻转1次。

治疗40例，病程1年以内31例，1年以上9例。针1~3次后，症状消失35例，有效5例。

景宽等 膻中刺络拔罐法治梅核气 浙江中医杂志 (1), 38, 1991

柴胡针穴注法

天突穴局部消毒后，用6～6号半针头，先刺入皮下，然后将针头朝足方向沿气管壁深入1～2厘米，局部有酸麻胀感后回抽无空气或血液，即可缓慢注入柴胡针液2毫升。每日或隔日一次，每次1支（2毫升），4次为一疗程。

注意点：（一）患者取正坐位，头颅要固定，避免转动；（二）进针时应避免偏斜或进针过深，以防止刺入气管、损伤血管或深部组织。

25例中，痊愈（临床症状消失，二个月内无复发）15例，好转（临床症状明显减轻或当时消失，以后偶有复发者）6例，无效（治疗三个疗程后无明显改善）4例。在痊愈的15例中，一个疗程者4例，二个疗程者4例，三个疗程者2例。治疗中未见不良反应和并发症。

卢锡华 柴胡针穴注治疗梅核气 浙江中医学院学报（6），52，87

27. 瘧 症

针 刺 法

先对患者足心进行揉按，常规消毒后，以左手固定足腕，右手持80号毫针，露出针尖2～3分，快速刺涌泉穴，一边行紧按、慢提伴旋转的手法，一边观察患者表情进行语言诱导。3分钟后仍不缓解者加对侧涌泉穴，憋气者加内关穴，经双侧行针仍不能恢复者，每隔5分钟左右交替行针一次直至恢复。

共治疗50例。针刺1次即愈者49例，1例无效。

肖仁鹤 毫针刺涌泉治疗瘧症50例 湖北中医杂志（5），39，1987

28. 精神分裂症

氩—氦激光穴位照射法

(一) 治疗方法：用 5.9~25 毫瓦的氩—氦激光照射哑门穴，每日 1 次，每次 10 分钟，6 周（30 次）为一疗程，本治疗期间不合并任何抗精神病药物治疗。此外在治疗前、中、后各查一次尿常规，白细胞计数及分类，肝功试验（GPT、TTT），以及淋巴细胞微核实验以动态观察激光治疗后对肝、肾功能及染色体之影响。

(二) 疗效评定标准：选用四种国际上常用的精神病评定量表，即：“慢性精神病人标准化精神评定量”（简称五分量表）；“简明精神病评定量表”（简称简明量表）；“临床总体印象量表”；以及抗精神病药物副作用量表。由两位医师共同对患者在治疗过程中，每周进行 1 次疗效评定。两位医生评定的一致性测验在 75% 以上。

(三) 按我国传统评定疗效的方法：24 例中显著好转以上者 18 例，显效率为 78%；

贾云奎等 氩—氦激光穴位照射治疗精神分裂症的研究 中国针灸 (1)，19，1986

29. 精神病症

头 针 法

1. 头针刺激区

取额中线，额旁 1 线、额旁 2 线、额旁 3 线。选用 29 号 2 寸毫针，自前发际向后沿皮下刺 1.8~2 寸，针刺于皮下帽状腱膜中，获明显针感后，留针 20~30 分钟。

2. 随症选穴

躁狂明显者选鸠尾、足三里，有听幻觉选听宫、风池、外关，抑郁明显者选通里、神门，胸脘痞满选丰隆、膻中，强迫感明显者选四神聪、丰隆。

隔日针刺一次，三个月为一个疗程。

共治疗12例患者，经过治疗后均有不同程度的改善。其中精神状态完全恢复正常，可进行正常工作7例，7例中6例全部停药，1例夜间需服眠尔通 0.2mg，经半年以上随访，患者精神状态稳定，仍进行正常的工作。3例精神症状明显好转，可进行日常家务，但尚有情绪波动或烦躁失眠，常服少量镇静剂(安定 2.5~5mg/日)。2例老年性痴呆，1例原来二便失控，经治疗，大便已可控制，小便仍有遗溺，另1例中断治疗。

恒健生 头针为主治疗精神病症12例 上海针灸杂志 (4)，20，1987

附：癲 狂

针药并用法

(一) 狂躁型：

1. 急治其标：三棱针刺人中、十宣穴，毫针刺心俞、肝俞，泻法；针后在心俞、肝俞穴拔火罐10~20分钟，以出血为宜；再针刺合谷、内关、神门、涌泉等穴，均用泻法。

2. 缓治其本：内服开窍豁痰汤(拟方)。代赭石 100克 青礞石 50克 龙骨 50克 牡蛎 50克 (以上四味碎后先煎30分钟) 郁金 20克 桃仁 20克 菖蒲 15克 黄连 15克 胆星 10克 大黄 20克 (后下) 沉香 10克 大枣 5枚 水煎服，日二次，饭后服。

3. 配合汤药效果，加服清心镇静散(自拟方)牛黄 5克 麝香 1.5克 珍珠 3克 琥珀 30克 硃砂 30克 黄连 15克 龙齿 50克 冰片 1.5克 上药共为细面，每次 5克，白水送服，每日三次，七天为一疗程。

(二) 抑郁型:

1. 针刺合谷、内关、神门、肝俞、心俞、风池、风府等穴，手法以平补平泻为主，留针15~30分钟；心俞、肝俞穴针后拔火罐以出血为宜，七天一疗程。

2. 内服柴胡疏肝汤（自拟方）加减：

柴胡15克 郁金20克 当归15克 云苓15克 赤芍15克 木香15克 青皮20克 菖蒲30克 桃仁15克 胆南星10克 青礞石30克 枳壳20克 半夏10克 川连15克 甘草10克

3. 配合汤药效果，加服清心镇静散每次5克，日三次。

共治疗73例。治愈：精神正常，症状消失，半年无复发者。

显效：精神基本正常，症状基本消除，有时感到心情不佳或烦躁，能自控而不发作者。

好转：用上方法治疗效果明显好转者。

无效：经治疗症状无明显改善者。

狂躁型：共计42例，治疗最短4个疗程，最长23个疗程。其中治愈29例，显效5例，好转4例，有效率为90.48%。

2. 抑郁型：共计31例，治疗最短8个疗程，最长38个疗程，其中治愈17例，显效8例，好转3例，有效率为90.33%。

本组病例总有效率为90.4%。

马景盛 针药结合治疗癫狂症73例临床报道 北京中医 (4)；

35, 1990

第八节 内分泌系统疾病

1. 甲状腺瘤

扬 刺 法

1. 扬刺：患者仰卧，局部常规消毒后，于甲状腺瘤顶部中心垂直刺入毫针1枚，再于四周呈45°角向心刺入毫针各1枚，深度均到

达瘰瘤中心。此乃合“浮刺”之意，不致刺穿对侧囊壁，损伤邻近器官。留针15~20分钟。每3日针1次，10次为一疗程。

2. 中药：以海藻玉壶汤、四海舒郁丸加减内服。常用药：海藻、昆布、蛤壳、海螵蛸、牡蛎、陈皮、法半夏、贝母、玄参、连翘、夏枯草、王不留行子、青皮、当归、川芎、海浮石、甘草。阴虚火旺者加生地、麦冬、知母、玉竹、龟版、鳖甲、珍珠母；瘤大质硬者加三棱、莪术、炮山甲、山慈菇。

共治疗51例。经治6月，瘤体消失，症状解除，达痊愈者38例，占74%；瘤体缩小50%以上者为显效，计8例，占16%；瘤体缩小不足50%者为有效，计5例，占10%。

陆之庆 扬刺法配合中药治疗甲状腺瘤51例临床小结 江苏中医(6)；26, 1990

2. 甲状腺机能减退症

针 刺 法

针刺人迎穴，每周3次。手法选用迎随补泻和《神应经》中论述的补泻方法，即“一进三飞”为补，“三飞一退”为泻的手法。（但本病不用泻法）

“三飞一进”的补法，按下列方法操作：

1. 进针至人迎穴部位后，静候5秒钟。
2. 用指甲轻弹针柄3次。
3. 以喉头为中心，往喉头方向向上向内搓针三下（名为飞）。
4. 再把针推进0.5—1厘米，将针向喉头方向拨一下（此为一进）。

治疗本病需要得气，即患者甲状腺要有明显胀感。同时，注意针此部位，不能用呼吸补泻法，否则会因喉头上下起伏，导致刺破血管而形成血肿。

药效标准 临床痊愈：临床症状及同位素指标恢复正常；显效：临床症状基本恢复正常，仅有个别症状未恢复，同位素指标恢复正常；有效：临床症状显著好转，但生化、同位素指标未恢复正常。

治疗效果 14例中，临床治愈6例，占42.9%；显效1例，占7.1%；有效6例，占42.9%；疗效不明1例，占7.1%。总有效率为62.6%。经三年随访，疗效巩固。

栗蕊 针刺治疗甲状腺机能减退症14例 中国医药学报 (2), 12, 1986

3. 甲状腺功能亢进症

针药并用法

1. 针刺：①取穴：气瘰（相当水突穴，视甲状腺肿大程度稍有出入）、内关、间使、足三里、三阴交。②手法：颈部气瘰穴用斜刺，采用拇指后退为主的捻转泻法；肢体部穴用捻转提插补泻法，补法（足三里、三阴交）用拇指前进为主的捻转，结合重按轻提，泻法（内关、间使）用拇指后退为主的捻转，结合重提轻按。留针30分钟。

上述的针刺取穴及手法，针药Ⅰ—Ⅲ组均相同。

2. 药物：①他巴唑组：单纯服用他巴唑40毫克/日（10毫克，4次/日）。②针药Ⅰ组：他巴唑40毫克/日，服法同上。③针药Ⅱ组：他巴唑30毫克/日（10毫克，3次/日）。④针药Ⅲ组：他巴唑10毫克/日（5毫克，2次/日）。

3. 疗程：连续观察2个月。住院患者每日针刺一次，门诊患者隔日针刺一次，他巴唑均每日服用。

根据治疗后血清 T_4 、 T_3 含量的恢复情况和症状的改善（采用邝安堃等的甲亢疗效积分计合法）判定疗效，其标准制订如下：①控制：血清 T_4 、 T_3 含量恢复正常，症状基本消失，积分 < 5 。②有效：血清 T_4 、 T_3 含量较治疗前下降30%以上，甲亢症状明显改善，

他巴唑组与针药各组疗效比较

疗 效	他巴唑组 41例	针药Ⅰ组 33例	针药Ⅱ组 22例	针药Ⅲ组 22例
	例数(%)	例数(%)	例数(%)	例数(%)
控 制	27(65.85)	27(81.12)	19(86.36)	17(77.27)
有 效	8(19.51)	4(12.12)	2(9.09)	2(9.09)
无 效	6(14.63)	2(6.06)	1(4.55)	3(13.64)
有效率 (%)	85.37	93.94	95.45	86.36

积分 5 ~15。③无效：血清 T_4 、 T_3 含量较治疗前下降不及30%或反增高，甲亢症状未改善，积分>15。

何金森等 针药结合治疗77例甲状腺功能亢进症的疗效分析 上海中医药杂志 (5)；17, 1987

4. 内分泌性突眼

穴位注射法

1. 取穴和药物：取双侧上天柱穴（在天柱上 5 分），用透明质酸酶 1500^u 加醋酸氢化可的松 25mg 为一次注射量。

2. 操作与疗程：标定上天柱，进针后向前方深入1~1.5寸，待针感向同侧眼部或头部放散时，再缓慢推入药液，隔日一次，十次为一疗程，停十天可作第二疗程，一般用 1 ~ 3 疗程。

眼部症状主要为眼球外突、酸胀，眼睑肿胀，视力减退，畏光多泪，结膜充血、复视等。超声波检查可见眼球后间隙增宽（因球后组织增生水肿所致）、参考上海市针灸经络研究所的数据，定球后间隙在 13mm 及以下者为正常。

共治疗50例，98眼。痊愈：眼突基本平复，上述症状消失，球后间

隙在 13mm 及以下者，9 眼。

显效：眼突明显好转，上述症状基本消失，球后间隙减小 2mm 及以上者，48 眼。

有效：眼突好转，上述症状有不同程度好转，球后间隙减小 1mm 者，25 眼。

无效：眼突及上述症状、球后间隙均无变化，16 眼。

朱慧宝 穴位注射治疗内分泌性突眼 50 例临床观察 中国针灸 (3)；7，1987

5. 单纯性肥胖症

针 刺 法 (一)

胃中蕴热型：取曲池、内庭、上巨虚；耳穴取肺、饥点。

肠燥便秘型：取曲池、天枢、支沟；耳穴取肺、大肠。

湿困脾胃型：取阴陵泉、中脘、丰隆；耳穴取脾、三焦。

肝阳上亢型：取太冲、曲池、三阴交；耳穴取肝、肾。

心脾两虚型：取心俞、脾俞、神门、隐白（灸）；耳穴取心、脾。

肺脾肾气虚：取脾俞、肺俞、列缺、复溜；耳穴取肺、肾。

气阴两虚型：取膻中、太溪、阴谷、照海；耳穴取肾、内分泌。

针灸方法：体针隔日 1 次，留针 20 分钟，实证多用泻法，虚证多用补法，虚证者加灸，1 个月为 1 疗程。耳针先常规消毒，然后埋入揸针或王不留行籽，胶布固定，嘱患者每日自行揉按数次，以痛为度，5 天换 1 次，两耳交替埋藏，体针与耳针同时进行。

共治疗 342 例。显效：症状、体征基本消失或体重下降 5 公斤以上者。有效：症状、体征得到改善或体重下降 2 公斤以上者。无效：症状、体征无明显改善或体重下降不足 2 公斤者。本组 342 例，显效 63 例，占 18.4%；有效 172 例，占 50.3%；无效 107 例，占 31.3%。总

有效率为68.7%。

胡丽梅等 针灸减肥 342 例临床观察 江苏中医 (1), 18,
1991

耳穴埋针法

选穴：神门、胃、大肠、内分泌、肺、心、三焦。操作：每次选用 1～2 穴，常规用 75% 酒精消毒。中等刺激，并用小块胶布固定。

疗程：每次留针 5 天，5 天治疗一次，5 次为一个疗程。

根据正常人的身长与体重的比例关系确定，即体重（公斤）= 身长（厘米）- 100。通常以体重超过正常标准 10% 为过重，超过正常标准 20% 者为肥胖。

共治疗 1015 例。疗效标准：显效：体重减少 15 公斤以上者，264 例。有效：体重减少 3 公斤以上者，370 例。无效：体重减少 3 公斤以下者，381 例。

崔述贵等 耳针治疗肥胖症 1015 例疗效观察 中国针灸 (1),
17, 1987

针 刺 法 (二)

取穴：梁丘、公孙（均刺双侧）。

每次针一穴，交替使用，用泻法。针刺至患者有酸胀感后，反复轻插重提，大幅度、快频率捻转，使患者产生较强烈的针感，然后将 G6805 治疗仪连接在针柄上，应用连续波型，把微量电流通于针上，电流量以患者能耐受为度，连续 20 分钟。起针后，在当日所针刺的穴位上，用麦粒型皮内针沿皮下刺入 1 厘米左右，针身与经脉循行方向呈“十”字型交叉状，用胶布固定针柄，留针 3 天。留针期间，嘱病人每日轻按埋针俞穴 2～3 次，每次 1～2 分钟，并在有饥饿感时和进食前 10 分钟对埋针穴位进行较强刺激的揉按。每 3 天针 1 次，10 次为 1 疗程，间歇 1 星期后，再作第 2 疗程，连续观察 3 个疗程。

共治疗42例。治疗3个疗程后，体重减轻5公斤以上评为显效者14例；体重减轻1~5公斤评为有效者17例；体重减轻1公斤以下评为无效者11例。总有效率为73.8%。

治疗3个疗程后，显效组体重下降均值为7.5公斤，有效组体重下降均值为2.8公斤，无效组体重下降均值为0.4公斤。于每个疗程结束时复查体重发现，治疗时间越长，体重下降幅度越大。观察表明体重越重，疗效也越明显，体重下降幅度也越大。

在治疗停止半年后，对18例患者进行随访，其中显效组7例，有效组11例。体重均值较治疗结束时回升0.75公斤，远期疗效尚稳定。

雷振萍 针刺减肥42例临床观察 中医杂志 (5)，52，1987

针 灸 法

取穴 体穴以足阳明胃和足太阴脾经穴为主，取上巨虚、丰隆、内庭、曲池、三阴交、阴陵泉；耳穴取脾、胃。临证加减：肠燥便秘，体穴加天枢、支沟、耳穴加肺、大肠；易饥饿加足三里(手法重泻)；自幼发胖，体穴加肾俞，耳穴加肾；产后肥胖，体穴加曲泉、石门，耳穴加屏间；月经不调，体穴加地机、血海，耳穴加屏间；下肢肿胀，体穴加水分，耳穴加三焦。

手法 体针实证用泻法，虚证用补法，虚寒证加灸，每次留针20~

40例单纯性肥胖患者针灸

前后体重和身体围度的变化表

	针灸前	针灸后	P值
体重 (kg)	75.01±8.64	71.27±8.41	<0.001
胸围 (cm)	99.11±4.83	97.27±4.72	<0.001
腰围 (cm)	93.59±8.59	89.92±6.96	<0.001
髋围 (cm)	105.49±5.51	103.46±4.72	<0.001
股围 (cm)	60.51±3.87	58.70±3.72	<0.001

30分钟,隔日1次,15次为1疗程。耳穴按压王不留行籽或埋藏揸针,嘱病人于每日进餐前半小时自行按压1分钟左右,酸痛为度,5天更换1次,6次为1疗程。

疗效标准 参照1987第一届全国中西医结合肥胖病研究学术会议确定的单纯性肥胖病疗效判定标准,体重下降2kg以上(不含2kg)为有效;体重下降不足2kg为无效。

赵银龙 针灸治疗单纯性肥胖病初探 辽宁中医杂志(6); 38, 1991

6. 男子乳房发育症

灸 法

主穴:乳中(患侧),足三里(双)。

配穴:肝火型,去足三里加太冲;气血双亏型,加灸气海;肝肾阴亏型,去足三里加太溪。用艾条灸,日灸1次,10次为1疗程,休息3日,可进行下一疗程。肝郁、肝火型用泻法,每次灸20分钟;气血双亏、肝肾阴亏型用补法,每次灸40分钟,火力要足,灸后以胸内发热以及下肢有热、酸、困感为佳。

共治疗25例。疗效标准:乳房肿块完全消失,无压痛为痊愈;

乳房肿块体积缩小在1/2以上,仅有轻微压痛为显效;

肿块明显变软,体积缩小不及一半为有效;

治疗前后症状无变化为无效。

治疗结果:25例患者,治愈13例,显效6例,有效4例,无效2例。治愈率为52%,总有效率为96%。治疗次数最多42次,最少12次,平均27次。

郑少祥等 灸法治疗男子乳腺增生 上海针灸杂志(3); 30, 1987

第三章 外、皮、 骨 科 疾 病

第一节 外科疾病

1. 脑外伤及后遗症

头 针 法

分两组穴位交替针刺。第一组为健侧的运动区、感觉区、胸腔区、脑干区，如有语言不清者增加语言区。第二组穴位为百会、四神聪，颞三针、额五针（在额部以相等距离刺入头皮五针），痴呆者加情感区。每日针刺1次，每次留针2小时，留针时嘱病人主动或被动活动肢体，20次为1个疗程，2个疗程之间休息7天。

50例中，32例治疗2个疗程，12例治疗3个疗程，6例4个疗程。8例上肢肌力由0级恢复到4级，42例上肢肌力由1~2级恢复到4~5级。原8例下肢肌力1级恢复到4级，42例下肢肌力1~2级恢复到4~5级。语言不清者全部恢复正常语言功能，对话流畅。50例精神全部恢复正常，头痛、头晕消失。

翟绪璞 头针治疗脑外伤及后遗症50例 山东中医杂志 (3);
31, 1990

2. 脑外伤昏迷

醒脑开窍法

(一) 针刺穴位：主穴：内关、人中、三阴交。配穴：风池、极泉、尺泽、委中。

(二) 针刺操作方法：先刺双侧内关，直刺0.5—1寸，采用捻转提插相结合的泻法，施术1分钟。继刺人中，在鼻唇沟中，斜刺0.5寸，用重雀啄手法，至流泪或眼内充满泪水为度。三阴交斜刺与皮肤呈45度，进针1—1.5寸，用提插补法，令患者肢体抽动三次为度。极泉穴直刺进针1—1.5寸，用提插泻法。尺泽直刺0.5寸，手法同极泉。委中仰卧位抬腿取穴，进针0.5—1寸，用提插泻法。均使肢体抽动三次为度。

此例患者已昏迷147天，针刺治疗1周后，可张口大哭，有泪无声，仍呼之不应。2周后，热退且呼吸平稳，停止给氧。仍闻喉中痰鸣。3周后，可张口吃水果片，饮水，喂奶。可间断停止输液。4周后，右手开始活动，有时可自己拔掉头面部的针。5周后，神志清醒，视力恢复。

杨新高 醒脑开窍针刺法治愈昏迷147天一例 天津中医 (3), 22, 1990

3. 颈淋巴结核

火针加药捻法

针具：用直径1.5~1.8毫米的不锈钢丝，做成长8~12厘米、前

端磨尖、后端有柄的钢针。

药品：陈醋、猪胆汁、红粉、轻粉、漳丹。

药捻的制做：以陈醋和猪胆汁各 500 毫升，盛入搪瓷盆内，用火煎沸致膏状为止（煎沸时需不断搅拌，以免煎糊）。然后放入红粉 5 克，轻粉 2 克，混合揉匀后搓成长约 2~5cm，如火柴杆粗的药捻，药捻焙干后放入装有漳丹的容器中密封备用（漳丹能够防止药捻粘合）。

用酒精灯将钢针烧红，刺入已液化的淋巴结核中央（如已破溃的，也刺入破溃的中央处，如为窦道，沿其窦道刺入）。刺入深度根据病情而定。以不刺激正常组织为度。使刺入部位形成孔道，待脓液排出后，选合适的药捻放入孔道内，外敷纱布。根据分泌物的多少，决定换药的次数，分泌物多者每日换药一次，分泌物少者隔日换药一次。直致痊愈为止。

共治疗 280 例。根据病情轻重，疗程 20~90 天不等。平均疗程为 30~35 天。痊愈率为 100%。

适应证：已液化的、干酪化的、破溃的淋巴结核和已形成窦道的淋巴结核。

禁忌证：尚未液化的、尚未干酪化的硬节性淋巴结核及汞过敏者均不得应用本疗法（红粉、轻粉分别为氧化汞和氧化亚汞）。

朱应超等 火针加药捻治疗颈淋巴腺结核 280 例报道（2），13，1987

割肝俞法

1. 取穴：肝俞、膈俞。2. 操作：将穴位定准后，皮肤常规消毒，用 1~2% 普鲁卡因行局部麻醉。在肝俞穴上切开皮肤，长约 1 厘米至 1.5 厘米深达肌肉表层，用挑截器挑断肌纤维 10~20 根。然后用碘酒涂擦切口，再敷盖无菌纱布，施加压力以创膏固定之。注意挑截时术者用右手持挑截器，左手捏起被挑截的部位以防出血。左侧患病割左侧肝俞；右侧患病割右侧肝俞，两侧同时患病同时割治。

共治疗 211 例。痊愈：局部淋巴结全部萎缩、吸收，破溃者浓汁

减少，漏孔愈合，无任何自觉症状，显效：局部硬结变小，还留有小的结节，停止发展，无任何不适感。

治疗结果：211例全部有效，治愈率93%，显效率7%。

刘桂芳 割肝俞穴治疗淋巴腺结核211例 中国针灸 (3); 45, 1987

4. 胃 扭 转

针 刺 法

取穴：①足三里（双）补法，太冲（双）泻法，中脘平补平泻。
②脾俞，胃俞，膈俞，均平补平泻。

两组穴位交替应用，每日一次，留针30分钟，十次为一疗程。

此例患者经治疗一个疗程后，胃胀痛明显减轻，两疗程后，症状完全消失。经X线复查，胃已复位，形态正常。化验检查：血红蛋白11g%，红细胞350万，白细胞5200。而痊愈出院。

郭全有 针刺治愈胃扭转2例 陕西中医 (7); 323, 1987

5. 急性痉挛性腹痛

针 刺 法

取任一侧行间穴常规消毒后，用1.5寸毫针快速捻转进针，针尖略斜向病所方向，进针深度约1~1.5寸，用平补平泻法，强刺激，得气后一般的捻转30秒即可，必要时每隔3分钟捻转1次或加取对侧行间穴。留针30分钟，多数能在1~10分钟内完全缓解。

共治疗83例。在30分钟内能完全缓解者为治愈，共79例。减轻但未完全缓解、须配合它法者为有效，共4例。有效率100%。

苏建华 针刺行间穴治疗急性痉挛性腹痛83例 中西医结合杂志 (4); 234, 1991

6. 急性阑尾炎

针 灸 法

1. 天井穴：针刺找到明显针感后，以平补平泻手法，提插12次，尔后向左捻转12次，再向右捻转12次，最后轻轻提插12次。

2. 艾灸天井穴上1.5寸处共10壮（双）。

3. 大肠俞：进针取得针感后，左侧穴，朝反时针方向捻转30次，重提插40次，出针后不封针口；右侧穴，于进针取得针感后，顺时针方向捻转30次，重提插40次，出针后不封针口。

4. 尾骨尖穴：针沿尾骨尖缘刺入，针尖朝患者脐孔。取得针感后，反时针方向捻转30次，重提轻插40次，出针后不封针口。（取穴体位、屈体呈90度，俯于床缘取之）

每日针灸两次，用28号1.5寸长毫针。

治疗效果：针灸治疗期间，不配用任何中西药物。

疗效标准：治疗后，临床症状和体征全部消失，血检恢复正常者为痊愈。

疗效：50例急性阑尾炎患者，经上法治疗，全部痊愈，疗效百分之百，无后遗症。

张 伟 针灸治疗急性阑尾炎50例临床观察 中国针灸 (2); 22, 1986

蒸馏水封闭法

患者仰卧位，医者立（或坐）于其右侧，用灭菌注射用水10~20

毫升双侧阑尾穴（足三里穴下约1~2寸处）封闭。操作时，若患者体质强壮、针感迟钝，注射馏水的速度可稍快（单侧在3分钟内推完）、用量稍大（单侧可达10毫升），针头向上斜刺（于皮肤成45度角）。否则，注射速度要慢，用量要小（单侧5毫升），针头直刺或向下斜刺。总之，要以有较强烈的酸沉麻胀感（患者能够忍受）且沿足阳明经脉向足传导为宜。起针后嘱患者卧床休息半小时。每日一次。全部病例在治疗过程中均只使用蒸馏水穴位封闭法，而未用任何药物及其它疗法。

一般封闭一次自觉症状消失，两次压痛、反跳痛消失，继封1~2次巩固疗效，血象恢复正常。97例均经封闭2~4次而获痊愈。随访1~5年无一例复发。

韩铁山 蒸馏水封闭阑尾穴治疗单纯性阑尾炎97例临床观察 光明中医（1），15，1989

7. 急 腹 痛

电 针 法

1. 穴位选择

胆绞痛 日月、不容、巨阙、胆囊穴、足三里，均右侧。肝郁加期门（右）、太冲（双）；肝胆湿热加曲池（双）。

胃痉挛 中脘、巨阙、足三里。胃寒加梁门（艾条灸）；胃热加内庭；肝气犯胃加太冲。

肾输尿管结石 肾俞、京门、腹结、三阴交（均患侧），阴陵泉（双）。

急性阑尾炎 麦氏点、天枢（均右侧），阑尾穴（双）。发热加曲池。

痛经 关元、归来、三阴交。气滞血瘀加太冲、地机；寒凝胞宫加关元（艾条灸）。

2. 针刺方法

腹部穴位除期门、日月、不容等穴须采用斜刺外，其它穴位均采用直刺，一般先针腹部穴位，进针得气后，采用紧提慢按结合大幅度捻转的方法，反复施以针刺泻法使针刺感应向患部四周扩散，然后接通电针仪，选择疏密波，频率为18次/分，导线的正极一般接压痛点附近的穴位，如胆绞痛患者，压痛点邻近不容穴，可将正极接不容穴上，负极接巨阙穴上。电流强度以病人最大耐受为度，通电30~60分钟，留针期间可视病人情况，逐步加大电流强度。

共治疗164例。痊愈：疼痛和体征全部消失，留院观察或随访未见复发者，占56.7%。显效：疼痛和体征缓解，复诊或随访未复发，占32.3%。好转：疼痛和体征减轻，复诊或随访未复发者，占7.3%。无效：疼痛改善不明显或复发者，占3.7%。

顾月华 电针治疗急腹痛症164例 上海针灸杂志 (3) ; 15, 1987

针 刺 法

针刺梁丘穴。

共治疗40例，疼痛全部缓解（消失），观察2天以上无复发，近期疗效100%。

·屈德全 针刺梁丘穴治疗急腹痛40例 中国针灸 (3) ; 10, 1987

8. 溃疡病急性穿孔

维生素 B₁ 双足三里封闭法

本组对有非手术适应症的患者均按三期疗法治疗。第一至第二期用维生素 B₁100mg 双足三里封闭，每3小时一次，症状缓解后改为

一日二次至转入第三期。第二期同时按辨证应用中药，多以清热解毒、通里攻下为治则，效果较好。第三期按病人证型应用中、西药物。

155例中有3例中转手术，中转手术率为1.94%，2例死亡，150例治疗成功率占96.77%。住院天数平均为12.5天，最短的4天，最长的46天。

王 佩等 维生素 B₁ 双足三里封闭为主治疗溃疡病急性穿孔
天津中医 (5) ; 19, 1988

9. 肠 粘 连

体针及耳压法

一、体针：1.疤痕两端取穴法，即在疤痕两端进针，以45~55角度向对侧互透，针的深度达到腹横筋膜层为宜，另取双侧足三里穴。2.配穴：腹痛取天枢、太冲（泻）；腹胀取中脘（泻）、胃俞（补）便秘取长强（泻）；3.针刺方法：应用上海医疗器械八厂产的G 6805型电脉冲治疗仪，连续波，频率150~180Hz，剂量由小到大，以病人能耐受为限，并在治疗中随时调整输出。

上述治疗每日一次，每次30分钟，12次为一个疗程，疗程间休息一周，继续下一个疗程。

二、耳压法：1.取穴：a组取神门、大肠、胃；b组取肝、交感、小肠。2.操作：以耳穴压痛棒或耳部信息诊断仪选择穴位，经75%酒精棉球消毒后，采用氧化锌胶布剪成1×0.8cm大小，将王不留行子一粒粘在胶布中心，对准上述耳穴中心点贴紧后稍加按压，以便固定。双侧耳穴同时贴压，嘱患者每日自行按摩耳穴3~5次，每次约5分钟，3~5天换贴一次，a、b两组交替贴压。

共治疗110例。110例中，临床治愈71例，症状、体征消失；显效19例，症状明显减轻，体征基本消失；有效20例，治疗后症状及体征

有好转。治疗次数最短 8 次，最长 4 个疗程，平均治疗 19.7 次，总效率为 100%。

王小马 电针治疗肠粘连 110 例疗效分析 中国针灸 (1)，9，1987

10. 术后腹胀

闪罐腹部四募穴法

取穴：中脘、天枢、关元。

操作：将 95% 酒精，用铁丝棒蘸好，在酒精灯上点燃，往 2 号玻璃罐里一闪，立即闪扣在募穴上，又马上起罐，如此连闪连扣，每穴闪扣 20 下，留罐 3 分钟，依次将四个 2 号玻璃罐分别扣拔在腹部四个募穴即中脘 1 罐，天枢 2 罐，关元 1 罐。四个募穴共扣闪 80 下，留罐 3 分钟后再一同起罐，再以前法续作 2 次，前后共计连续闪罐 240 下。

80 例中，显效者 55 例；有效者 25 例，总效率为 100%。

曲祖贻 闪罐腹部四募穴治疗术后腹胀 80 例观察 中国针灸 (6)，35，1986

11. 腹股沟疝及嵌顿疝

针 灸 法

主穴用大敦（双），针后加灸，配以关元灸，神阙灸，血海针。

患疝时间短，症状轻者针刺大敦穴即可。学龄儿童可留针，小儿不留针。

共治疗 43 例，痊愈 38 例，好转 4 例，无效 1 例。针 1～2 次痊愈

者12例, 30次痊愈者7例, 以4~7次痊愈或好转者为多见。

廉臻等 针灸治疗腹股沟疝及嵌顿疝43例 中国针灸 (2), 1986

12. 胆 囊 炎

电冲击耳穴变阻点法

选用山西平遥卜宜仪器厂 JJ202 型或 JJ301 型中国经络诊疗器探头在相应耳穴探测变阻点, 进行电冲击治疗。波型以疏密为主, 痛甚调以单调波型。每日1次, 每次选4、5个穴位, 每穴10分钟, 20天为1疗程。按照中医辨证分型在耳部取穴。

1. 肝胆湿热型 证见右胁胀痛, 痛引肩背, 口苦, 恶心食少, 便干, 舌质红苔黄腻, 脉弦滑。治以舒肝利胆, 清热利湿。取穴: 交感、胰、胆、三焦、肝、内分泌。

2. 肝郁血淤型 证见胁痛如刺, 痛处固定不移, 拒按, 舌质紫黯, 脉沉涩。治以舒肝解郁通络。取穴: 交感、胰、胆、胃、肝、神门。

3. 血不养肝型 证见胁痛持续隐痛, 遇劳痛甚, 口干烦热, 舌质红苔少, 脉虚弱。治以养阴柔肝。取穴: 交感、胰、胆、脾、十二指肠、内分泌。

随证加减: 口苦加胆囊穴, 食少加足三里, 肩背痛加肝俞、胆俞、排石加耳迷根。

共治疗50例。痊愈: B超检查, 胆囊恢复正常大小, 临床证状与体征消失, 40例。好转: B超检查, 胆囊肿大较前明显缩小, 症状与体征明显改善, 9例。无效: B超检查, 胆囊无改变, 症状与体征无明显改善, 1例。

王晓英等 电冲击耳穴变阻点和中药对照治疗胆囊炎100例 辽宁中医杂志 (4), 26, 1988

针 刺 法

以季肋部相当于胆囊解剖部位为中心点，呈扇形向上，逐次寻找压痛点，即是宁胆穴。如有多少压痛点，则以离中心点最近、疼痛最明显的为是穴。如疼痛有放射至右肩背者，以疼痛的中心点呈圆形渐次向外，寻找压痛点，亦为是穴。操作方法及选用配穴，据辨证分三型。

湿热壅滞型 在季肋部日月穴外平行两横指处找得宁胆穴，左手食指切按，右手持针刺入0.3~0.5寸，用泻法，使针感尽量放射至整个疼痛部位，留针30分钟，每7~8分钟重复手法1次，并以同法刺关元、太冲。

气血瘀阻型 在右侧期门穴以30度角向外下方1.5寸处，以及右肩背部在天宗与神堂连线的中点处，各找得宁胆穴，刺法同气血瘀阻型，出针时行补法，并以同法刺足三里、血海。

气阴两虚型 在右侧锁骨中线与肋弓相交点向外平行一横指处，找得宁胆穴，刺入方法同前二型，但留针仅15分钟，每隔5分钟行补法1次，并以同法针足三里、三阴交。

共治疗88例。所有病例针后均获痊愈，其中针刺1周37例，2~3周22例，1~2月29例。

程指明 针刺宁胆穴治疗胆囊炎88例 浙江中医杂志 (7)，324，1990

13. 胆 石 症

耳压法 (一)

取穴：主穴为肝、胆、脾、皮下质、耳迷根交感。配穴为神门、胃、胰、便秘点。

操作：以准备好的边长为0.20cm的橡皮胶布，中心粘一粒王不

留行籽，贴于所取之耳穴部位，隔日治疗一次，30天为一疗程，嘱患者每日饭后20分钟自行按压5—8分钟。鼓励患者适当采用脂餐（结石直径 $<1\text{cm}$ 者）以使胆汁分泌增加，胆囊收缩有利冲刷肝胆结石随胆液排出，提高疗效。

近期临床治愈：淘洗大便发现结石排出，B超复查未见结石存在，临床症状明显改善或消失者。好转：有结石排出，B超复查结石减少超过二分之一，临床症状有明显改善者。无效：未见结石排出，临床症状亦无明显改善者。

122例患者经过2—3疗程治疗，治愈8例（占6.5%），好转112例（占91.8%），总排石率为98.3%。其中临床治愈8例中疗程约为2—3个疗程。结石直径在 1.0cm 以下。

王家瑞 耳压法治胆石症122例临床小结 天津中医学院学报 (2), 32, 1990

耳穴为主综合法

103例中，耳穴加中药汤剂组35例，耳穴加中成药利胆片者42例，耳穴加体针加汤剂组6例，耳穴加体灸1例，耳穴加体针1例，单纯耳穴组18例。

（一）耳穴压迫法：主穴：胰、胆、胆总管、神门、交感。配穴：肝、脾、十二指肠、胃、三焦、皮质下、肾上腺。主穴每次必用，配穴以电阻式经络仪探出敏感点时加用。用小块胶布粘王不留行贴在耳穴上。每日压3次，各10分钟。隔2天换1次。12次为一疗程。嘱以猪蹄做菜佐餐，每周2~3次。

（二）中药：有并发症者、排石略有困难者、有胆囊炎症状者，加服利胆中药。基础方：柴胡6克，枳壳15克，郁金15克，蒲公英20克，芒硝6克，木香15克，煎服。便秘加大黄，黄疸加茵陈，兼热加芩连，兼湿加佩兰、泽兰、藿香，兼寒加干姜，阴虚加麦冬、元参。每周3~4剂间断服药，随证加减。

（三）针灸：临床证有疼痛或呃逆者，加针灸治疗。疼痛或胀

感，取足三里、阳陵泉、胆囊。疼剧，加刺耳穴神门、交感、肾上腺，留针。呃逆悬灸气海15分钟。

103例中有100例排出了胆石，排出率为97.09%。现将排出之胆石按大小（直径或长度）分为5组：

（一）1厘米以上者140块，其中2.0×1.4厘米者1块，1.5厘米者4块，1.3厘米者2块，1.2厘米者12块，1.1厘米者6块，1.0厘米者104块。排出此种结石者有37例。

（二）0.8~0.9厘米者有501块，排出者有50例。

（三）0.6~0.7厘米者有480块，排出者有46例。

（四）0.2~0.5厘米者有1086块，排出者有80例。

（五）有24例排出泥沙样结石。

排出胆石之100例患者，自治疗开始日起至初次排石时之时间，最短者为2天，最长者为44天（常因胆囊积液），平均为10.87天。

赵炳灿 耳穴为主综合治疗胆石病103例小结 上海中医药杂志（1），19，1987

耳 压 法（二）

（1）取穴部位：均取耳甲艇，肝、胆、脾、胃、十二指肠、小肠、大肠，耳甲腔：三焦、内分泌，三角窝：神门、交感，耳背部：耳迷根。

（2）操作方法：将王不留行籽，放于0.5厘米正方形的胶布上，然后贴在穴位上固定之，并逐穴进行压迫，使患者有明显疼痛为宜。8—5次，每次3—5分钟，三天换一次，双耳交替十次为一疗程，一般的只需一个疗程即可把结石排尽。患者如体质弱者，不应进行第二个疗程，应在患者休息7天后进行，治疗期间对大便干结的患者，加用便秘点一穴或用番泻叶10克泡饮，以保持大便通畅。

（3）脂肪餐配合：每天早餐吃油荷包鸡蛋1—2个，中餐吃猪蹄，晚餐吃一点蔬菜。如果是不愿吃或是回族患者，则先可改换成牛肉罐头，煨牛肉或鲫鱼煮花生米等配合食用。

共治疗 100 例。胆石全部排出，临床症状消失，B 超报告正常肝胆者为痊愈，胆石没全部排出，症状消失者为显效，没有结石排出，症状减轻为好转，无结石排出、症状无变化者为无效。

100 例患者痊愈 5 例占 5%，显效 85 例占 85%，好转 8 例占 8%，无效 2 例占 2%，总有效率占 98%，排石量最重 5g（泥沙样）最小的一块，最大的 $1.2 \times 0.6 \times 0.4$ 厘米，最早 24 小时内排出、色有黑、灰、黄、白褐色结石。

陶 涛 耳压治疗胆石症 100 例临床观察 按摩与导引（1），20，1988

中药和电针法

（一）中药 口服自拟利胆排石汤。方药组成：柴胡 12 克 郁金 15 克 枳实 15 克 赤芍 15 克 木香 15 克 厚朴 10 克 茵陈 30 克 金钱草 30 克 黄芩 12 克 玄明粉 10 克 大黄 12 克。

辨证加减：热重者加银花、夏枯草；痛剧者加元胡、川楝子；呕吐者加白蔻、淡竹茹；身目深黄者加山栀、龙胆草。

（二）电针 选胆俞、日月、期门穴，采用 4 寸银针斜刺入日月、期门，进针 8 厘米左右，配合电疗（上海医疗器械厂 G 6805 型治疗仪开放通电，取疏密波），每日 1 次，持续 90 分钟，病重者可每日 8 次，一般 7 天为 1 疗程；若需再用则中间休息 3 天。针刺胆俞穴，用 1 寸银针，进针 0.5 寸，留针通电 15 分钟即可。

（三）少数患者可择期口服硫酸镁，必要时给予适当静脉补液。

共治疗 98 例。显效：症状及体征消失，体温及实验室检查复常，排下肉眼结石，“B 超”复查结石消失或接近消失者；好转：症状及体征消失或基本消失，体温及血象正常，排下肉眼结石，“B 超”复查结石明显减少或有减少者；无效：症状及体征不减，甚至加重或中转手术者。

98 例中，显效 17 例，占 17.3%；好转 70 例，占 71.5%；无效 11 例，占 11.2%。总有效率为 88%。疗程最短者 9 天，最长者 31 天，平

均为26.3天。排石最快者3天。

周志光等 中医辨证配合电针治疗胆系结石98例临床观察 湖南中医杂志 (1), 14, 1991

电 针 法

(1) 电针穴位: 阳陵泉(双)、胆囊穴(双)。刺激的频率以每分钟80次为佳, 通电30分钟。

(2) 脂餐: 嘱患者每餐加食猪蹄, 或油煎鸡蛋, 高蛋白饮食, 有利于胆汁分泌增加, 胆囊收缩使胆结石随胆液排出。

(3) 自身锻炼: 嘱患者每晨早起散步, 做广播体操等活动, 有利于新陈代谢。

(4) 淘洗大便、筛找结石: 通过淘洗大便, 可测知观察结石的多少、大小和结石形状。通过筛找结石, 可经临床化验分析结石的性质, 提供可靠的依据。

共治疗98例。(以B型超声检查为准)痊愈: 临床症状和体征消失, 结石全部排出; 显效: 临床症状和体征消失, 结石大部排出;

有效: 临床症状和体征基本消失, 结石部分排出;

无效: 临床症状及体征无改善, 无结石排出。

痊愈43例, 占43.88%; 显效51例, 占52.04%; 有效3例, 占3.06%; 无效1例, 占1.02%; 总有效率达98.98%。

冯世华 电针治疗胆石症98例临床疗效观察 现代中医(1), 34, 1990

针 刺 法

(一) 以日月、胆俞为主穴, 以阳陵泉为副穴, 肝内胆管结石加太冲为配穴。

(二) 操作: 胆俞、日月、阳陵泉3穴均取右侧。胆俞斜刺0.8寸, 用提插泻法, 运针一分钟, 针感向右少腹部或肝胆区感传。日月

穴直刺1.5寸（要避免刺到肝脏），用提插泻法，运针一分钟，针感向剑突下感传或局部酸胀。阳陵泉穴刺1.5~2寸，用提插泻法。运针一分钟，针感沿胆经向上感传至右少腹部或肝胆区。

共治疗216例。症状、体征完全消失、血象正常，经“B”超及胆道造影报告未见异常者为痊愈。针刺后排石，但症状、体征消失或明显改善者，血象正常者为有效。在治疗过程中病情恶化，中转住院或手术、或治疗过程中症状、体征无改变者为无效。

216例患者，临床痊愈25例，占11.57%，排石者214例，占99.07%，总有效率为100%。

张庆年 针刺治疗胆石症216例临床观察 中国针灸（6），9，1983

耳穴电针法

1. 方法用JJ201型中国经络诊疗器探头，在相应部位上探测耳穴，并在耳穴上进行电针治疗。

2. 耳穴电针治疗波型的选择：

常用耳穴点：胰、胆、肝、三焦、胃、十二指肠、食道。

随症加减：痛著加交感、神门，予以单调密波；黄疸加肾上腺、内分泌，予以疏密波；炎症期加内分泌、神门、耳炎，予以疏密波；排石困难加耳迷根、交感，予以疏波。

3. 治疗时间：每日治疗一次，每次选用4个穴位，治疗10分钟，一个月为一疗程。

4. 辅助治疗：治疗期间，每晨服油煎鸡蛋2个，若有便秘时服硫酸镁15克。

5. 收集标本：将大便于盆内用清水浸泡约1~2小时，然后进行搅拌，用清水进行漂洗，将沉淀于盆底之结石过筛晾干后收藏起来，自治疗之日起，当天大便即进行淘筛。

510例患者治疗后，临床症状与体征显著好转者（包括排石与未排石）508例（99.61%），无明显好转者2例（0.39%），排石者462

例 (90.59%)，其中排空者90例 (19.48%)。治疗1~10次排石者274例 (59.31%)，11~20次排石者152例 (32.90%)，21次以上排石者38例 (7.79%)。

张育西等 耳穴电针治疗胆石症 510 例临床报道 中国针灸, (5); 5, 1986

14. 胆 绞 痛

耳穴注射法

先用耳穴探查仪在两侧耳部穴位如肝、胆、胰、胃、十二指肠、神门、交感、皮质下等穴位检查，找准阳性反应点均可作为药物穴位注射点。选用 1ml 兰心注射器套上 4 号普通针头，抽取盐酸山莨菪碱注射液 0.1ml (含 0.1mg)，再抽注射用水至 1ml 混合。每次选用阳性耳穴点 2~3 个。每穴皮内注射上述混合液 0.1ml，两耳交替，每日 2 次。3 日为 1 疗程，如果连续注射 1 疗程后无效改用他法。

共治疗 115 例，临床疼痛消失，可食入高脂餐饮食为显效；临床疼痛缓解，其它症状明显减轻为好转；临床疼痛及其症状改善不明显为无效。本组 115 例中经治 1 个疗程获显效者 76 例 (占 66%)，好转 25 例 (占 22%)，无效 14 例 (占 12%)，总有效率为 88%。一般注射 1~2 次疼痛即可减轻或消失。

王志英等 小剂量山莨菪碱耳穴注射治疗胆绞痛 115 例 中西医结合杂志 (4); 205, 1990

针 挑 法

先用古铜钱蘸水在背部脊柱两侧刮痧法刮至皮色紫红为度，再用自制卧龙丹 (闹羊花 鹅不食草各 25 克 马蹄细辛 12 克，共研细末，

瓶装备用)。噓鼻取嚏,然后再用常规消毒,取大号缝衣针在剑突下之红色、紫红色或棕褐色之皮肤异点上用针挑法。每点均须将白色坚韧的肌纤维挑断挑尽至出血少许为度,皮肤异点之分布一般在剑突下或上腹部。但有时也可分布在期门、日月一带,重症尚须再在背部大椎穴、膏肓穴附近寻找异点挑刺,轻症每次挑3~5点,重症每次挑5~7点,每天1次,一般针挑1~3次。

共治疗32例。近愈:经第1次针挑后,镇痛时间能维持24小时以上,全身症状缓解,经连续针挑3次,全身症状消失,随访3个月未复发者,9例显效;经第1次针挑后,有即时镇痛止呕效果,全身症状显著缓解,在24小时以内仍偶有微痛腹胀恶心等症状,必须在针挑止痛后配合内服中药者,17例。好转:经第1次针挑后,绞痛缓解,呕吐停止,全身症状有所减轻,必须配合耳穴压丸,体针及内服中药者,4例。无效:经第1次针挑后,有即时镇痛,止呕效果,但全身症状无明显减轻,2小时后又复发如故,必须改用他法治疗者,2例。

唐泰来 针挑为主治疗胆绞痛32例疗效初探 湖南中医杂志 (2); 36, 1991

针刺拔罐法

1. 针刺法:第一组取阳陵泉、胆囊穴、足三里、丘墟。均取右侧,用强刺激手法;第二组取日月、期门。取右侧,均沿肋间缝向外斜刺1寸,取快速捻转强刺激手法;第三组取胆俞、肝俞,一般取右侧,均向脊柱斜刺1寸。一般留针30min,每10min行针1次。

2. 拔罐法:取胆俞穴,以广口罐头瓶代替火罐。按常规拔罐法,一般10min左右起罐。

共治疗100例。有效:立即止痛;无效:疼痛稍减或疼痛不止。所治100例,全部有效。全部病例均先用针刺第1组穴,60例有效;余80例经用针刺第2组穴,20例有效;余20例又用了针刺第3组穴,10例有效,另10例用拔罐法而达有效。

杨同锡 针刺拔罐治疗胆绞痛100例 陕西中医 (1); 34, 1991

针 刺 法

主穴：取太冲、期门、日月、阳陵泉或巨阙，辨证选用1~2穴即可。配穴：取内关、合谷、足三里或三阴交等。用捻转泻法，有时提插兼用，留针10~30分钟，对有兼症者从本论治，取相应穴兼治。

共治疗48例。针刺后15分钟内剧痛缓解为显效；半小时内缓解为有效；半小时以上无变化者为无效。本组显效23例（占47.9%）；有效16例（占33.3%）；无效9例（占18.8%），总有效率81.3%。

倪少华 针刺治疗顽固性胆绞痛48例 湖南中医杂志（4），48，1990。

15. 胆道蛔虫症

针 刺 法（一）

用毫针分别先后由左右迎香穴垂直进针约至0.5cm，有针感后将针斜向外上方，刺向四白穴。到达四白时，患者有麻胀感，有时可麻及上唇。若患者面部组织较厚、无法判定针尖是否到达四白穴时，可继续向前进针，将另一手食指按于眼眶缘（承泣穴外侧）可感到针尖与指尖相触（也为防止刺伤眼球），再将针退出少许，使针尖定于或略穿透四白穴。针刺完成后，用胶布固定左右针柄于唇上。用强刺激，留针12~24小时。

共治疗22例。一般针刺后半小时左右疼痛即可缓解，两小时左右疼痛消失。本组患者疼痛均获缓解。

孙锦章 针刺迎香透四白穴治疗胆道蛔虫症22例 中国针灸（2），13，1986

针 刺 法（二）

针刺组选四白透迎香，从四白穴直刺约0.3厘米，再将针透向迎

香穴，得气后用强刺激手法；留针30分钟，留针期间每隔10分钟行针1次。出针后观察2小时。

共治疗45例针刺3分钟或用药10分钟后痛止并持续2小时者为显效；针刺10分钟或用药30分钟内其痛缓解并持续2小时者为有效；针刺或用药30分钟后其痛不减者为无效。

针刺30例，其显效21例，有效8例，无效1例，总有效率为93.6%。

马登旭 针刺治疗胆道蛔虫症45例 陕西中医 (7)；315，1989

针刺加穴位封闭法

主穴：足三里（双），阳陵泉（双），胆俞（双）。配用穴：日月，内关，合谷。药物：维生素K₃，每支1毫升（含量1毫克）。治疗：先针主穴。呕吐加内关，胁肋痛加日月，发热加合谷。均用强刺激手法。留针10—30分钟，在留针期间每隔5~10分钟运针一次。留一主穴（任一侧）作局封，常规消毒后将维生素K₃吸入已消毒的注射器内，直刺快速刺入穴内，推入药液2~4毫升。每日1~3次。其中足三里、阳陵泉双侧交替使用，疼痛缓解后，给予驱蛔剂。

35例患者经用上法治疗，临床症状均消失，痊愈出院。平均住2天，最短26小时，最长住4天。其中26例经一次治疗疼痛即缓解，仅个别患者有恶心、胃部不舒感，经两次治疗后临床症状即消失，患者精神如常，给予驱虫剂驱蛔后痊愈出院。9例患者因有程度不同的脱水表现，除用上法治疗外，同时配合液体支持疗法，亦获痊愈。

吴作敬 针刺加穴位封闭治疗胆道蛔虫35例 河南中医 (4)；37，1988

大柴胡汤加耳穴压丸法

中药选用大柴胡汤加减：柴胡10g，枳实15g，黄芩10g，法夏10g，白芍10g，大黄10~20g（后下），木香6g，乌梅

10 g。伴有恶寒发热者加金银花 20 g，连翘 10 g；伴有黄疸者加茵陈 30 g，栀子 10 g。每日一剂煎服。

耳穴压丸采用王不留行籽 1 粒，置于 0.3cm×0.3cm 大小的伤湿止痛膏或代温灸膏上，压贴耳穴。常用耳穴有：肝、胆、耳迷根、胰、十二指肠、胃、神门、交感、腹、内分泌等。一次选穴 6 至 8 个，其中肝、胆为必选穴，并隔日交替轮换一次，嘱病人每日自行按压耳穴 3 至 4 次，每次 15 至 20 分钟。

共治疗 26 例。痊愈：症状、体征完全消失，B 型超声波复查，胆道系统内条索状回声消失。

有效：症状、体征完全消失（但未做 B 型超声波复查）。

无效：症状、体征无改善或加重。

按以上标准，26 例病人经上述治疗后，21 例痊愈，4 例有效，1 例无效（伴有胆石症），最后转外科手术治疗。其中，症状、体征消失最快者 2 天，最慢者 18 天，平均 5.6 天。

谭晓红 大柴胡汤加耳穴压丸治疗胆道蛔虫 26 例 湖南中医学院学报 (3); 27, 1988

16. 精索神经痛

针 刺 法

令患者俯卧，取同侧秩边穴，以 28 号毫针垂直进入皮下，而后针尖稍向内侧斜入 3 寸，务使气至病所，此时睾丸与附睾即出现上提紧缩感。行平补平泻手法，留针 20 分钟，出针后患者痛苦立即消失。

李明善 针刺秩边治疗精索神经痛 浙江中医杂志 (6); 253, 1990

17. 砍 头 疮

针 刺 法

取3.5寸~4寸毫针一根，在患者背部找黑褐色斑点，针刺斑点处，针尖向下沿皮刺，毫针全部刺进无疼痛感即出针。若皮肤不净，黑斑较多，与黑褐斑混在一起易刺错，若刺错则有扎刺般疼痛感，应马上出针另找斑点。所刺针数，根据病情轻重而定，一般5~10针。所刺斑点越靠近患处效果越好。

共治疗15例，均治愈。初起证轻，多针刺一次疼痛止，针两次疮回收，对重者，疼痛并见破溃者，针2~3次即可止疼并开始收口，针5次结痂后不治渐愈。

阎键 针刺治疗脑后发 天津中医 (6); 31, 1988

18. 臃 疮

针 刺 法

取血海、足三里、阴陵泉、三阴交、商丘为主穴，进针得气后行平补平泻法。在创面边缘1厘米处，按经络走行方向对刺3~4针为配穴。针尖向心方向针刺4~8分深，待针下得气后留针15~30分钟。每日针刺1次，5次为一疗程，休息1~3天，继续下一个疗程。对疮面一般采用外科常规消毒，清理创面之后或用生理盐水冲洗后，直接敷盖无菌纱布，阳光照射创面15分钟以上，使其干燥。

共治疗40例。症状消失、血象正常，创面完全愈合者为痊愈；大部分症状消失，但患处仍留有轻度肿胀，久立或较长时间走路时加重者为显效；临床症状好转创面缩小但尚未完全愈合者为有效；治疗前

后无变化者为无效。本组40例临床治愈34例，显效4例，有效2例。

林敏华 针刺治疗脓疮40例 中国针灸 (1), 51, 1987

19. 软组织感染

针刺拔罐法

治疗部位：根据病灶所在部位选定治疗部位。如头、面、颈部感染（包括颈、颌下淋巴结），治疗部位在第7颈椎，以大椎穴为中心；手指及上肢感染（包括腋窝淋巴结），选用对侧肩胛间区，相当于4～6胸椎与肩胛骨内缘之间；足趾、下肢、臀及会阴部位感染（包括腹股沟淋巴结），治疗部位在腰骶关节以下，以双上髂穴为中心；胸、腹部软组织感染，在背、腰部相对应处拔罐。

治疗方法：据治疗部位采取适当体位，腹部以上的宜取坐位，臀部及会阴以下的采用俯卧或侧卧位。选好体位后，在治疗部位上以75%的酒精棉球消毒，用三棱针将其轻刺三下（出血、不出血均可），随即在针刺部位拔火罐。拔火罐的方法：将95%的酒精棉球贴于罐壁，略近瓶口处，便于点燃。点燃后立即扣在所针部位上（一定要将三个针眼扣在罐内），如用玻璃火罐或者罐头瓶子，此时可见到血液自针眼处外溢。留罐10分钟取下，如超过10分钟，拔罐处可能出现水泡，不足10分钟则影响疗效。

共治疗81例。疗效标准：经以上方法治疗后、红、肿、热、痛急性炎症消失，局部功能恢复正常者，为治愈。本组81例均治愈，1次治愈者38例，2次治愈者27例，3次11例，4次3例，5次1例，6次1例。81例共拔罐148次，平均1.8次。

李源温 针刺拔罐治疗软组织感染81例 山东中医杂志 (3), 27, 1990

20. 臀上皮神经炎

齐刺加水针法

按顺序进行。取阿是穴。局部皮肤常规消毒，用2.5—3.0寸毫针在压痛点正中直刺1针，并于上下两旁向中心各斜刺1针，进针得气后平补平泻，轻捻转，少提插，留针5~10分钟，出针后以大号火罐（1罐扣3个针孔）用闪火法拔罐5~10分钟。水针：用5毫升注射器及6½号针头，无菌操作吸取2%普鲁卡因（皮试阳性者用利多卡因代替）2毫升，加强的松龙混悬液25毫克及维生素B₁₂ 1毫升（0.5mg），行阿是穴注射。每3天1次，5次为1疗程。

治疗108例，经1个疗程治愈（局部疼痛消失，功能活动恢复正常）101例，占93.5%；2个疗程治愈5例，占5.1%；2个疗程后显效局部疼痛基本消失，但剧烈运动后仍有隐痛）2例，占1.4%。

彭启琼 齐刺加水针治疗臀上皮神经炎108例 江苏中医（8），26，1990

按摩针刺法

首先用拇指按压臀上皮神经处，由轻到重旋转按压5分钟，然后用拇指做横向上下弹拨由轻到重持续5分钟。施手法后，取阿是穴（患侧髂嵴中下5厘米处），采取直刺进针，轻轻捻针使针感达足跟，留针20分钟。

58例中获基本治愈（疼痛消失，患侧局部已触及不到条索状物，也无压痛）39例（67.2%），有效（症状基本消失，仍可触及条索状物，有轻度压痛）15例（25.9%），无效（症状及体征均无改变）4例（6.9%）；总有效率为93.1%。

李晓春等 按摩针刺治疗臀上皮神经痛58例 中医杂志（4），44，1991

21. 臀上皮神经损伤

针 刺 法

取第二腰椎夹脊穴，阿是穴（髂嵴中点直下二横指）。患者俯卧位，同侧取穴，常规消毒后，用28号3寸毫针针刺，行泻法，得气后持续运针，使针感向侧下肢放射，然后用G6805型治疗仪之导线分别联于两枚针柄上，用连续波段，频率为1000~1500次/分钟。电流大小，以患者能耐受为度。留针20分钟，每日针刺1次。

共治疗40例。痊愈：疼痛消失，患侧髂嵴下，臀上皮神经行走部位，已触不到“绳索样”物，亦无压痛。

好转：疼痛减轻或消失，仍触到“绳索样”物，有压痛。

无效：症状体征无改善。

痊愈27例，占67.5%，好转10例，占25%，无效3例，占7.5%，总有效率为92.5%。无效3例中有2例仅治疗一次，即自动放弃治疗。1例并发梨状肌损伤综合征，治疗2次后，即自动放弃治疗。

本组治疗次数最少者，针1次，最多者，针7次。平均针2.3次。其中针1次后，当即病情痊愈或好转者27例。

仲跻尚 针刺治疗臀上皮神经损伤40例 上海针灸杂志（4），14，1987

22. 肋间神经痛

梅 花 针 法

针具一律采用自制有机玻璃柄式梅花针。其针柄长度不得少于25~35cm，直径约0.5至0.7cm（目的使针具弹性增强），在针柄

一端钻一小孔，将梅花针头与针柄用螺丝固定，即可使用。

嘱患者俯卧，沿脊柱两侧华佗夹脊穴和足太阳膀胱经循行处，用75%酒精消毒皮肤，然后自上而下，由华佗夹脊穴胸1至胸8、足太阳膀胱经大杼穴至关元俞，采用自制梅花针叩刺5遍，叩击后在该部位拔火罐（闪火法）10分钟。尔后，令患者侧卧，患部向上，沿病变区肋间隙和足少阳胆经胁肋部循行段自后向前用75%酒精消毒，采用自制梅花针叩刺5遍，叩击后还应叩刺疼痛区上下各一肋间隙部位2遍。叩毕，在疼痛区用闪火法拔罐，留罐10分钟。每日一次，5次为一疗程，间休2天续治。

注意事项 1. 叩击的次数一般不超过5遍，以防损伤皮肤；2. 叩刺的强度因体质而分为强、中、弱；3. 叩击频率不宜过快或过慢，一般应以每分钟75~85次为度；4. 叩击部位要准确，叩刺手法要正确；5. 肝俞、胆俞穴，其叩击强度和叩击频率应酌情增加；6. 局部患有皮炎、溃疡或高热、孕妇者，不宜使用。

共治疗30例。经10次叩刺后（两个疗程）痊愈者（症状体征消失，随访一年无复发）25例。经四个疗程叩刺，症状明显改善，痛疼轻微，无阵发性加剧者属好转3例。无效者2例。

高辉等 梅花针治疗特发性肋间神经痛30例 湖北中医杂志 (6) ; 37, 1988

23. 股外侧皮神经炎

艾条灸揉法

患者侧卧，患侧朝上。医者在患处用圆珠笔作好标记，然后用点燃之艾条旋转熏灸，距离皮肤约0.5~1寸，使患处有温热感而无灼痛。灸至皮肤稍呈红晕时，用右手掌根小鱼际部压患处，由轻而重，作有节奏的旋转揉动。通过揉动使产生的压力协同艾灸之热力向肌肉深层组织透达。待揉至皮肤表层艾灸之热力消失后，照上述方法再灸。

再揉，反复数遍，至所灸揉部位皮肤明显发红，患者自觉热力已透达肌肉深层，且轻松舒适为度。本法每天1次，若治疗过程中症状逐步改善，改为每2~3天治疗1次，10次为一疗程。

共治疗106例，61例痊愈（患处皮肤感觉恢复正常，其它症状完全消失，随访1年以上不复发者）。30例显效（患处面积缩小2/3以上，局部麻木、疼痛及蚁行感消失，皮肤感觉增进，但久行、久立及受寒湿后，患部仍有轻度沉重、板滞感）。11例有效（局部麻木、疼痛明显减轻，但患处面积缩小较少，皮肤浅层感觉障碍恢复不明显）。4例无效（经治1疗程后病情无明显好转）。有效11例中有7例因多种原因中断治疗。

李宇俊 艾条灸揉法治疗股外侧皮神经炎 浙江中医杂志 (12); 548, 1988

梅花针法

先将电疗机的两根输出线，一根接在梅花针上，另一根接电极片固定在患肢阳陵泉穴上。随后将患部和针具进行常规消毒。启动电疗机开关，输出疏密波，频率16~300次/分，以病人能耐受的电流量为宜。用梅花针在患部自上而下作3~5排纵行叩刺，频率一般为80~120次/分，以皮肤明显发红并微出血为度，叩刺完毕，再用艾条作20~30分钟的温和灸。每日一次，连续五日为一疗程，休息二日再进行第二疗程，持续1~3疗程。

共治疗42例：痊愈34例，好转（症状减轻1/2以上）6例，无效2例，总有效率达95.24%。

张针 梅花针治疗股外侧皮神经炎 上海针灸杂志 (3); 10, 1987

扬刺加电疗法

“扬刺”：先用针刺患处，测出皮肤感觉异常区的大小范围。选

用25号或26号，3至4寸毫针，在区正中心垂直刺入一针，再在区边上下左右相对约20°~30°角斜刺入四针，患者得气后，以G 6805 治疗仪，选连续波，频率为200次/分，刺激5分钟，留针5分钟取针，每日一次，十次为一个疗程。每疗程完后嘱患者休息3~5日，再针第二个疗程。

共治疗34例：经治疗症状完全消失，局部感觉正常者为治愈；经治疗麻木、僵滞区明显缩小，自觉症状减轻为显效；经治疗三个疗程后，症状或区域无任何变化者为无效。

本组34例中，治愈者23例，占67.65%；显效者10例，占29.41%；无效者1例，占2.94%；总有效率达97.06%。

武承迅等 “扬刺”加电疗法治股外侧皮神经炎34例临床观察
山西中医 (6)；42，1989

24. 坐骨神经痛

针 刺 法 (一)

(一) 取穴：以大肠俞、关元俞、环跳、臀正中（腰俞穴平外量4寸处）为主穴。以委中、合阳、腓点（委中穴上1寸处）为第一组配穴，以浮郄、委阳、腓点（腓骨头外面最凸点直下0.5寸处）为第二组配穴。以上均为患侧腧穴。

(二) 治则：全腿痛者选用主穴。腰或大腿后侧痛重者选用前两个主穴。小腿后侧至足跖痛重者选第一组配穴。小腿前外侧至足背痛重者选第二组配穴。小腿外侧至足小趾痛重者选配第一、二组穴。各穴交替施用。

(三) 治法：每次治疗选用1~2个穴位。各穴均用直刺法、行雀啄术后留针，不捻转。大肠俞、关元俞各深刺可2寸。臀正中穴刺3~4寸。腓点刺0.5~1寸。腓点刺0.5寸。要求每次针感，必须“气至病所”，达到患者最痛苦的远端部位3~10次。一般留针20分

钟，病情减轻者也可不留针。少数患者配用6.26医疗机或G 6305治疗仪时，每次选用两个穴，近心端接负极、远心端接正极，留针20分钟，弱电流，低频率治疗。疼痛重者每日治疗1次，见轻后隔日治疗1次，并逐渐延长针治间隔时间，至停止治疗。不计疗程。

共治疗400例。症状与体征全部消失，腿活动自如，能恢复原工作者为痊愈。症状与体征大部分消失，腿活动自如，劳累后偶有酸痛，能恢复原工作者为显效。症状与体征均有好转，能行走，但常有疼痛者为进步。经治疗5次以上，症状与体征均未好转者为无效。

本组400例中，痊愈352例（占88%），显效41例（10.25%），进步3例（0.75%），无效4例（1%）。总有效率99%。

吴经纬 针刺治疗坐骨神经痛400例临床观察 中国针灸（3），1，1986

针刺法（二）

取穴：主穴：秩边。配穴：足太阳型加承山、昆仑穴。足少阳型加阳陵泉、绝骨、丘墟。湿重加阳陵泉、丰隆。久病体虚加足三里、肾俞。根性型：加肾俞、夹脊腰2～5、大肠俞等穴。随证加减取穴，偏虚寒者用艾灸或火罐。

操作方法：秩边穴选用28号3～4寸毫针，刺入3～4寸，以中强度刺激，使局部有酸麻胀重感，并向下肢远端放射，有时可达足底或足趾部。寒湿型可采用温针灸或艾条灸沿疼痛部位循经温熏，以病人有温热舒适感为度。风热型针用泻法，一般不留针。瘀血型宜用泻法，中强度刺激，局部加拔罐。虚弱型用补法宜轻刺激，每5分钟行针1次。急性发作时用泻法，慢性期用平补平泻，可用电针。每天针一次，10天为一疗程。休息3天，再继续治疗。

共治疗300例。痊愈：临床症状及主要体征完全消失，行走正常，恢复原来工作。显效：主观症状明显减轻或消失，或稍有不适感但能照常工作。好转：主要症状好转或时有发作，能从事轻工作。无效：症状及体征无改善。

300例患者中，痊愈113例，占37.6%；显效121例，占40.4%；好转46例，占15.2%；无效20例，占6.8%；总有效率为93.2%。

崔述贵 针刺秩边穴治疗坐骨神经痛300例疗效观察 山西中医 (4) ; 36, 1990

针刺拔罐法

1. 取穴：环跳穴，秩边穴。2. 方法：先用4寸长毫针直刺入环跳穴，行雀啄术待针感沿足少阳经向下传导；再用同样方法刺秩边穴，使针感迅速传至病变部位。然后在此两穴上，用闪火法将针扣在罐内，留针20分钟。痛重者每日1次，见轻后隔日1次，直至症状消失。

共治疗200例。症状与体征完全消失，能从事一般体力劳动者为痊愈；症状与体征基本消失，能从事一般体力劳动，但劳累后偶有酸痛者为显效，症状与体征与治疗前有所改善，能行走为好转。经治疗症状与体征无改善者为无效。

200例中，痊愈128例，显效41例，好转27例，无效4例，总有效率98%。

马登旭 针刺拔罐治疗坐骨神经痛200例 陕西中医 (2) ; 82, 1990

电针加穴位注射法

1. 针刺穴位：主穴取坐骨神经点（位于手部无名指掌指关节背侧尺侧缘）、秩边、闪电（位于臀部尾骨尖旁开6寸）。腰部及大腿后侧痛者配大肠俞、殷门、承山；大腿外侧痛者配环跳、绝骨。以上均配患侧输穴。

2. 针刺方法：先刺患侧坐骨神经点，采用泻法，捻针3~5分钟，多数患者即感患肢轻松，留针30分钟。秩边、闪电穴直刺3~4寸，待有触电样针感时行烧山火手法3~5分钟，即有热感传达小腿

或足部。然后接 Br—1B 型半导体间动电流刺激器（北京医疗器械厂生产）。输出电机接到针柄上。选择起伏波形，强度以病人能耐受为度，留针30分钟，每日1次，治疗6次休息1天。

配穴：按常规深度采用烧山火手法，达到酸麻热胀为度，不留针。

3. 穴位注射：每次在上述穴位中选2个穴位，每次注入1毫升丁公藤注射液（上海中药一厂出品），每周2次，穴位注射当天不作电针治疗。

共治疗130例。痊愈：症状完全消失或接近完全消失，体征阴性，能恢复原来工作；显效：症状基本消失，体征阴性，能恢复原来工作或做一般工作；有效：症状部分消失或见轻，体征阳性，能做轻工作；无效：经10次治疗症状及体征无改善者。

130例中，痊愈101例，显效16例，有效10例，无效3例。其中病程在半年以内98例，治愈77例，显效14例，有效5例，无效2例；病程在半年以上者32例，治愈24例，显效2例，有效5例，无效1例。

张林昌 电针加穴位注射治疗坐骨神经痛130例 陕西中医（2），86，1990

电冲击疗法

对于不同的患者和不同的症型选择不同的穴位。原发性坐骨神经痛，均采用循经取穴与交经取穴相结合的原则，一般多取患侧足少阳胆经和足太阳膀胱经的输穴；而对于继发性坐骨神经痛，则按病变位置采取“阿是穴”与远经取穴相结合的原则。对于久病体虚者则配合大椎穴和挟脊穴，以调整脏腑功能和增强抗病能力。

操作时应首先将 TENS 治疗仪的四个电极板浸湿，置于选好的穴位上，用胶布固定，然后打开电源开关，频率选择高档（100~150赫兹/秒），电流强度连续可调，以病人的耐受量为准，每次治疗20分钟，10次为一疗程，如局部有炎症者，可配合神灯照射20分钟。

共治疗100例。疗效标准以症状消失，体征阴性，活动自如，能

从事正常工作为基本治愈；症状大部分消失，只有轻度不适为显效；症状减轻但仍有较明显的阳性体征者为好转；症状及体征无改变为无效。

治疗结果：基本治愈32例，显效43例，好转22例，无效3例，总有效率为97%。

丁洁贞 电冲击疗法治疗坐骨神经痛 天津中医 (6)，17，
1987

温 针 法

1. 取穴：肾俞（双）、腰阳关、大肠俞（双）、17椎、秩边、环跳、委中、阳陵泉、足三里、悬钟。

2. 体位和针具：让病人取侧卧位，健腿下伸，患腿上屈。

除环跳穴、秩边穴用3寸长毫针外，其余诸穴均用1.5寸长毫针为宜。再剪取1寸长艾条3节备用。

3. 操作方法：腰阳关、17椎二穴均采用直刺进针，针刺深度1.2寸，针感局部酸胀。肾俞（双）、大肠俞（双）、均采用直刺进针，进针后向脊柱方向斜刺1.3寸深，针感局部酸胀，麻感，若能向下肢传导则疗效更好。环跳、秩边二穴均采用直刺进针，针刺深度2.5寸左右，使局部有酸、麻、胀感或有触电感向足跟放散，然后行提插捻转手法，使下肢出现2~3次肌肉抽动，则疗效显著。委中、阳陵泉、足三里、悬钟四穴均采用直刺进针法，使针感达到局部酸、胀或沿经脉向下传导为宜（出现放射性感应时，将针稍略提起，以免损伤神经）。尔后，取1寸长艾条3节，点燃后分别套在环跳、秩边、足三里三穴针柄上。针柄下各垫一6cm²的硬纸片以防烧伤皮肤。针后，还可在腰部、及环跳穴处加拔火罐15~20分钟。

共治疗52例。治疗1~2疗程后（一个疗程10次，每天一次），行动自如，腰腿无任何疼痛感，能从事体力劳动者为治愈。治疗2~3个疗程，疼痛基本消失，能从事一般体力劳动者为显效。治疗3~4个疗程以后，疼痛减轻，能从事一般轻体力劳动者为好转。治疗4

~5个疗程以上,病情有所好转,但不明显者为无效。52例中治愈38例,显效9例,好转4例,无效1例。总有效率98%。

王进才 温针治疗坐骨神经痛52例 河南中医 (2); 26, 1991

截 法

1. 取穴:患侧跗阳、飞扬、委阳、阳陵泉、环跳、骶部压痛点(阿是穴)。

2. 手法及操作:

(1) 手法:从下向上循序针跗阳、飞扬、委阳、阳陵泉。每个穴得气后,用捻转比较重的补法置针。再针环跳、骶部压痛点,泻之。要捻到针下轻快滑利,同时病人有舒适感,疼痛与小腿胀感消失。然后与前置之针,不做任何手法,一齐拔出。

(2) 具体操作:拇指向前,食指向后。拇指向前有力,食指向后无力为“补”,反之为泻。所谓拇指向前,食指向后的捻转手法,并不是单方向的捻转,其左右交替转动的幅度是一样的,只是在捻动时的轻重有所不同而已。

共治疗50例。症状完全接近消失,体征阴性,能恢复工作者为治愈。症状大部分消失,体征阴性,能恢复工作,或能做一般工作者为显效。症状减轻,仍有阳性体征,但较治疗前有显著改善,可做较轻工作者为进步。与治疗前比较,症状及体征无改善者为无效。50例患者中治愈者21例,占42%;显效者19例,占38%;进步者10例,占20%。

佟秋芬 用截法治疗原发性坐骨神经痛50例疗效观察 黑龙江中医药 (4); 46, 1990

穴位埋线法

一、术前准备:①无菌手术包(内有12号腰椎穿刺针、剪子、

镊子、针管、纱布等)，1号羊肠线；②确定治疗穴位：常用穴有白环俞、秩边、殷门、委中、承扶、环跳、阴陵泉，腰痛配肾俞、气海、大肠俞。每次选3~5穴；③确定穴位后，先用针刺探测穴位寻找敏感点，做好标记；④要熟悉穴位局部生理解剖，掌握深浅度，以免损伤血管和神经。

二、操作方法：①穴位常规消毒，用2%的普鲁卡因皮下浸润麻醉；②将穿刺针芯抽出0.5~1.0厘米，把剪好等长的羊肠线填入针芯内，刺入穴位达一定深度，刺激针感，一边送针芯推线，一边退针，线脱出针腔留在穴位内；③穴位刺激法：穿刺针进入穴位达到一定深度，施小幅度提插，有针感后拔出针，用纱布复盖，指压按摩刺激。术后当日内不做强度较大的活动，适当休息。隔3周以后不愈者可行第二次埋线治疗，一般不超过三次。

共治疗23例。自觉症状消失，体征和运动功能基本恢复，一年内无复发者为痊愈；症状明显减轻，受寒、过劳后有不适感，但能坚持一般工作者为好转；症状无改善者为无效。

本组病例经1~3次治疗，痊愈18例，好转3例，无效2例。

石振岭等 穴位埋线治疗坐骨神经痛23例 山东中医杂志 (4)；22，1989

刺血疗法

(一) 取穴 1. 主穴：膀胱俞、委中、委阳、承山、阳交，丘墟。
2. 配穴：腰俞、白环俞、秩边、环跳、承扶、殷门、悬钟、昆仑。每次取主穴1~2个，酌情取配穴1~2个，但每次不超过4个。

(二) 针具 用16号三棱针消毒备用。

(三) 操作 选取穴位周围淤阻或显露的静脉血管作常规消毒，用三棱针点刺出血，见血流止后拔罐，约3分钟后去罐，然后对针孔作常规消毒，操作完毕。

(四) 出血量 第1次刺血，出血量宜多，方能缓解疼痛，各穴总出血量少则50毫升，多者100毫升有余。第2、3次刺血，出血量

可略少，分别可在30~40，10~20毫升之间。

(五) 相隔时间 根据患者缓解情况而定，如果第1次治疗疼痛缓解，可隔10天左右再进行第2次，若疼痛尚未缓解，或缓解不明显，间隔3~5天再刺。

(六) 辅助方法和辅助药物 本组53例中有37例首次刺血就见显效，属单纯性刺血治疗。有10例第2次刺血后加用了推拿点穴手法治疗；有6例第2次刺血后加用了舒筋活血片和风湿骨痛丸（成药）。

共治疗53例。痊愈：症状消失，功能恢复正常者，33例。好转：功能基本恢复正常，但因负重或远行有轻度疼痛，或在1年内又复发者，11例。无效：症状与体征无改变或无大的改变者，4例。刺血1次即愈者12例，最多刺5次，若5次不愈或无明显好转者，为失败。治疗时间短者1天，长者月余。

彭友胜 刺血疗法治疗坐骨神经痛 湖南中医杂志 (4)，31，1988

25. 肌注损伤坐骨神经后遗症

针灸结合药物穴位法

1. 针灸取穴：足三里、阳陵泉、悬钟、阳辅、解溪、太冲、商丘。伴坐骨神经痛者加环跳、殷门、秩边。手法一般采用轻中刺激，留针15~30分钟。2. 穴位注射：加兰他敏1~2.5毫克或维生素B₁₂ 0.25~0.5毫克。每次选上述穴位2~3个，缓慢注射，隔天一次，10次为一疗程，休息一周后重复治疗。

共治疗135例。治疗后临床症状完全消失，患肢行走时步态如同健侧者为痊愈，共76例。治疗后临床症状消失，患肢行走时接近健侧者为显著进步，共23例。临床症状改善，但患肢行走尚有拖拉状步态者为进步，共27例。经治疗后症状未见改善者为无效，共9例。

董敖齐 针灸结合药物穴注治疗肌注损伤坐骨神经后遗症 135例

26. 腓总神经麻痹

辰时封闭法

每天早晨 7~9 点, 于双侧足三里穴找针感, 找到酸、麻、胀感后, 将维生素 B₁100 毫克、维生素 B₂100 毫克的混合液徐徐注入。每日 1 次, 10 日为一疗程。治疗期间停用一切其他疗法。

治疗 28 例, 除 1 例无效, 其余均自觉症状消除, 步履正常。其中治疗 1 疗程者 12 例, 2 疗程者 10 例, 2 疗程以上者 5 例, 均经 6 个月至 1 年随访。

张连城等 辰时用药封闭足三里穴治疗腓总神经麻痹 浙江中医杂志 (11), 501, 1990

第二节 肛肠科疾病

1. 痔 疮

耳穴压迫法

1. 取穴: 肺、交感、直肠下段、神门、大肠、皮质下、脾、肾上腺。每次选穴 4~5 个, 两耳轮换贴, 每隔 1~2 天换 1 次, 5 次为 1 疗程。2. 操作: 先用探棒找好敏感点后, 用酒精棉球消毒, 将王不留籽放于 0.6×0.6 厘米胶布中心选贴在穴位上, 每天按压 4~5 次, 以稍有压痛或灼热感为度。

共治疗60例。症状及痔疮结节完全消失，活动无异常感者为痊愈，共60例（换贴3次痊愈21例，4次痊愈者16例，5次痊愈者11例，6次痊愈者7例，8次痊愈者3例）；症状改善不明显者为无效，共2例，总有效率为96.5%。

张化南 耳穴贴压治疗痔疮60例 陕西中医 (5)，222，1989

龈交穴割治法

医者以左手或右手拇指食指，翻起被检查者上唇，唇内正中与牙龈交界处的系带上，有形状不同、大小不等的小滤泡及小白疙瘩。用红汞棉球消毒后，用小止血钳将小滤泡或小白疙瘩夹牢，用小剪刀或小手术刀将其剪掉或切除，出血少许即完成了整个割治手术。

共治疗100例。自觉症状完全消失，肛门镜检查齿状线上下痔核完全消失者为治愈；自觉症状好转，肛门镜检查齿状线上下痔核较前缩小者为显效；自觉症状减轻，疼痛减轻，大便不带血，肛门镜检查较前好转，痔核部分吸收者为有效；无变化者为无效。100例中，治愈64例，显效24例，有效10例，无效2例。

韩岗等 龈交穴割治法治疗痔疮100例 中国针灸 (6)，19，1986

挑刺加拔罐法

1.部位：长强穴上端，臀纵纹尽头中央。2.方法：患者俯卧于床上，选好挑刺点，常规消毒后，左手将其局部皮肤捏紧，右手持三棱针对准挑刺点快速进针，挑破络脉后拔上火罐，10~15分钟去罐，将拔出的瘀血擦净即可。每天1次，5次为1疗程。一般治疗3~5次后见效。

共治疗80例。大便无血，肛门部疼痛、肿胀以及痔体消失为痊愈；大便血止，肛门部疼痛消失，痔体缩小为有效；若症状无变化，

痔体无明显缩小为无效。

用本法治疗80例患者，痊愈74例，有效4例，无效2例，总有效率为97.5%。其中60例经3次治疗后痊愈，内痔和混合痔疗效最高，共63例全部治愈；17例外痔经5次治疗后，4例显效，2例无效，且6例患者均为外痔合并肛裂。说明该治疗方法获效较为迅速，但外痔合并肛裂者疗效欠佳。

张春景等 挑刺加拔罐法治疗痔疮80例 陕西中医 (2)，84，1990

2. 痔疮疼痛

针 刺 法

(一) 取穴：承山穴（双）。

(二) 针刺方法：患者取俯卧位，术者一手托患者足跟，嘱其用力着术者掌心，术者另一手拇指标记穴位，然后用26号2寸毫针，于穴位皮肤常规消毒后，快速进针约1.5寸，作强刺激捻转每分钟约350次，以患者感到酸麻胀样针感向腘窝、小腿、足底部放散（多数向小腿、足底部放散），或局部胀痛为度，留针30分钟，5分钟行针一次。

共治疗100例。针刺后患者即感到疼痛明显减轻，肛门部疼痛基本消失，患者可下床活动者为显效，70例。针刺后即感到疼痛明显减轻，起针后稍留微痛感者为有效，27例。针刺后与针刺前一样疼痛者为无效，3例。

赵宝文 针刺承山穴对痔疮疼痛100例止痛效果的观察 中国针灸 (2)，23，1986

3. 内痔便血症

针挑法

嘱患者坐在靠背椅上，两手扶住椅架，暴露出背部皮肤，医者站在患者背后，用左手扶在患者左肩上，右手从患者脊椎第一胸椎大杼穴沿脊椎向下直摸、数到第十六椎（即第四腰椎），旁开一寸五分处便是大肠俞穴。用棉签沾上紫药水，在此穴位上涂上标记。在用碘酒、酒精常规消毒后，用三棱针挑破表皮，向内深刺，可挑出白色纤维样物，患者仅感微痛，不易出血。挑后以酒精棉球消毒，贴上胶布。一次挑一侧穴位，3～5天后再挑另一侧穴位，一般挑两次即可。

注意事项：（1）针挑后三日内禁重体力劳动。（2）尽量不吃刺激性食物。（3）孕妇禁用。

共治疗19例，单纯内痔15例，混合痔4例，均收到满意效果。

程绍勋 针挑大肠俞穴治疗“内痔”便血症 上海中医药杂志（5）；19，1987

4. 内外痔急性炎症性水肿

穴位注射法

用6号针头和5毫升针管吸取654—2注射液10毫升，消毒足三里穴位处皮肤，直刺穴位皮下1寸，抽吸无回血后缓慢推药。每日1次，直至痔炎症肿胀消退、疼痛停止停药。

共治疗8例。治疗2天后痊愈2例，3天后痊愈2例，5天后痊愈2例，6天后痊愈1例。1例水肿性内痔合并脱肛经6天治疗无效而停药。其中1例炎症水肿内痔合并出血，经2天治疗后肿消血止。

5. 痔科术后尿潴留

针 刺 法 (一)

(一) 取穴 1.主穴: 中极、关元、三阴交; 2.辅穴: 血海、阴陵泉、委阳、膀胱俞。

(二) 操作方法 取 2 寸毫针消毒备用。

1. 气滞血淤: 取中极、三阴交 (双)、血海。重刺捻转, 得气后留针 30 分钟, 用泻法行针 2 ~ 3 次, 可调理膀胱气机, 行气活血使小便通利。

2. 湿热下注: 取中极、三阴交 (双)、膀胱俞, 疾针捻转, 得气留针 30 分钟。用泻法行针 2 ~ 3 次, 可分利湿热, 行气利尿。

3. 肾气不足: 取关元、三阴交、委阳, 针刺补法或隔姜灸 3 ~ 4 次, 可温肾补气, 使经气来复, 癃闭得解。

共治疗 98 例。显效: 针灸时得气传感明显, 施术后 15 分钟内小便自行解出, 量在 300 毫升以上, 此后尿潴留消失者;

有效: 针灸时得气传感稍差, 施术后 30 分钟后尿分次排出, 每次量在 100 毫升以上, 此后仍有部分症状, 但尿潴留基本缓解者;

无效: 针灸时无得气, 施术后 1 小时以上不能排尿。而改用中西药物治疗或导尿术后缓解者。

显效 54 例, 有效 27 例, 无效 17 例 (其中前列腺肥大者 11 例), 总有效率为 83%。

谷荣生 针灸治疗痔科术后尿潴留 湖南中医杂志 (3) ;
32, 1989

针 刺 法 (二)

穴位: 气海、关元、中极、双委中。

手法：直刺0.5~1寸，强刺激。

留针：半小时。

共治疗28例。24例显效，针刺后半小时至1小时内自行排尿。3例有效，针刺半小时至1小时后加热敷，流水声诱导而排尿。1例无效，插导尿管后症状解除。

张苏平等 针刺治疗肛门病术后尿潴留28例 北京中医学院学报 (2)，36，1987

6. 脱 肛

针 灸 法

取穴：针长强、承山、大肠俞、气海俞、次髎，灸百会、次髎，每次2~3穴，留针20~30分钟，灸20分钟，每天一次，7次为一疗程，休息3~5天再进行第二疗程治疗。一般针感，最好能气至病所，或往肛门感传为佳。

共治62例。症状完全消失者为痊愈；症状明显消失，或有配合中药1~2贴者为显效；症状略改善者为进步；与治疗前对比无变化者为无效。

62例中，痊愈27例，占43.5%；显效30例，占48.4%；进步5例，占8.1%；有效率为100%。

高琪瑜 针灸治疗脱肛62例观察 中国针灸 (6)，6，1986

7. 肛 裂

穴位封闭法

患者取侧卧位，在肛门与尾骨尖端联线中点处（即长强穴）用碘

酒、酒精消毒，取川芎嗪注射液 6ml，加 1 %普鲁卡因 2ml 进行穴位封闭。术后从新消毒，盖以无菌敷料包扎固定。

共治疗101例。本组注射 1 次者20例，2 次者68例，3 次者13例。71例痊愈，24例好转，6 例无效。总有效率 94.06 %。此法对陈旧性肛裂疗效较差。

薛勇宏 川芎嗪长强穴封闭治疗肛裂 101 例 陕西中医 (7)，321, 1990

第三节 皮肤科疾病

1. 疔 痛

针 刺 法

1. 巨针疗法：患者取端坐位，两臂交叉放在胸前，头尽量前倾，两肩下垂，使背部皮肤紧张。医者选准神道、身柱穴，局部常规消毒后，右手持巨针，针尖向下，与皮肤成 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 角，快速刺入皮肤，顺脊柱向下沿皮下横刺1.5~2寸。

2. 透天凉刺法：取穴合谷、外关、足三里、肩井。令患者口吸气，将针尖迎着经脉来的方向直刺，随其吸气进针于地部，逆时针方向迅速捻转，使其产生酸麻或触电样感觉，然后令患者鼻呼气，将针提到人部，再逆时针方向捻转 6 次，再提到天部，反复操作 2~3 次，直到患者肢体发凉，方可将针退出，出针时不加揉按，摇大针孔，令邪气外泄。

3. 三棱针在委中穴点刺放血。

4. 如有脓液，用注射器配12号针头抽出脓液，再将鱼腥草注射液 2ml 注入阿是穴，未抽尽的脓液可随针眼排出。

共治疗 102 例。经治疗后，硬结消失，脓液吸收，体温、血象恢复正常，随访 2 月以上未见复发，总治愈率达 100%。其中治疗 1 次者 31 例，占 30.4%；治疗 2 次者 32 例，占 31.4%；治疗 3 次者 20 例，占 19.6%；治疗 4 次者 13 例，占 12.7%；治疗 5 次者 4 例，占 3.9%；治疗 6 次者 2 例，占 2%。

马慧平 针刺治疗疖痈 102 例 北京中医学院学报 (4)，43，1989

2. 指（趾）头炎

艾 熏 法

病灶部已化脓者用 0.9% 生理盐水清洗患处，用三棱针点刺放出脓液，并取脓液少许做细菌培养加药敏试验。嵌甲者，剪去部分指（趾）甲，肉芽增生用三棱针点刺破坏肉芽组织。因致病菌引起感染者用 0.9% 生理盐水清洗创面后，在病灶局部用极度敏感药物涂于病灶处，然后再用艾熏。艾熏后以消毒敷料包扎患指（趾）。每日一次，十次为一疗程。

共治疗 300 例。痊愈：局部症状、体征消失，创面愈合，患指（趾）功能完全恢复。无效：连续艾熏 15 次以上病情无改善。

急性炎症 50 例，嵌甲 80 例，甲下瘀血 29 例，肉芽增生 35 例均完全治愈，106 例已化脓患者 103 例痊愈，3 例无效（脓液培养均为乙型链球菌感染，以本法结合全身抗炎治疗，局部外用敏感药物治疗）。治愈率为 99%。

吕 荻等 艾熏治疗指（趾）头炎 300 例临床观察与实验研究 中国针灸 (4)，18，1987

三棱针火罐法

取肝俞穴（交叉取穴，即左取右，右取左），局部消毒后，以三

梭针刺入 0.5cm 后再用火罐或真空穴位拔罐器拔 10 分钟左右，拔罐后可见少许血液为正常现象，擦净后即可。

共治疗 37 例。一般一日即能见效，可见局部红肿消退，疼痛减轻，第二日痊愈。

刘永利 针灸治疗早期脓性指头炎 37 例 中西医结合杂志 (4); 217, 1991

3. 疮

艾 灸 法

疮面有脓性分泌物，首先用盐水棉球清洗干净，然后、根据生疮部位，将患肢平放于床或桌上，取艾条一支点燃，对准疮面，距离约 3 cm 左右，以患部有温热感，能忍受为宜，先灸疮的正中，后逐渐向外温和灸之。以疮疼灸至不疼时，疮面干燥红润为度。每次灸后，将艾条上烧透而未脱落的艾灰敲落于干净纸上，冷却后，视疮面大小，洒于疮面上，然后用消毒纱块敷盖。一日一次，灸至疮面结痂为止。

共治 10 例，均获满意疗效。

李扬军 艾灸治疮疗效好 陕西中医函授 (5); 52, 1987

4. 带状疱疹

梅 花 针 法

在疱疹周围正常皮肤，用 75% 酒精进行常规消毒，干燥后，用梅花针沿疱疹团边缘正常皮肤行密集叩刺，叩刺横面约 2~3 厘米，叩刺速度 70~80 次/分，中等度刺激，致局部微渗血，日 1 次，直至痊

愈。

叩刺时应注意：一、针头方向与皮肤垂直，以增加刺激面积，减轻疼痛；二、首次治疗者，叩刺手法要轻，以防病人产生畏惧心理；三、禁止叩刺疱疹，以防感染。

192例病人全部治愈，其中3次治愈者166例，4次治愈者20例，5次治愈者3例，7次治愈者2例，10次治愈者1例。3次治愈率达86.5%。

王善生 梅花针治疗带状疱疹192例 山东中医杂志 (2); 24, 1989

回旋灸法

施灸时选用苏州针灸用品厂“念盈药条”，燃着一端在病变部位均匀缓慢地向左右上下回旋移动。

本组120例患者均全部治愈。皮肤疱疹损害9.3%在1~3天内干涸、结痂、向愈；10.7%在3~5天治愈，平均2.21天(次)。

对120例患者伴有不同程度神经灼痛感的观察，止痛效果在5分钟至24小时出现的112例，余8例在24~72小时痛感消失。

梁波 回旋灸法治疗带状疱疹120例 陕西中医 (5); 214, 1988

火罐法

本组均用单纯火罐疗法，罐后破溃者外涂龙胆紫药水，局部感染较重者撒氯霉素粉，不用其它药物。

1. 选穴：均选用皮损局部阿是穴。罐数按病区范围多少不定，以排满为度。

2. 操作：暴露病区，选好体位，用闪火法，先在皮损两端拔罐，然后沿带状分布将火罐依次拔在疱疹集簇处，火罐要求拔紧，松弛不紧者，重新吸拔。留罐15分钟，留罐期间出现水疱，不必介意。

一般每日1次，直至痊愈为止。

共治111例。皮疹消退，症状消失者为痊愈。皮疹基本消退，症状有所缓解者为好转。经治7次以上皮疹仍未消退，或有新疹出现，症状缓解不显著或经3次以上中断治疗者为无效。本组111例均获痊愈。其中疗程最短者两天（次），最长者10天（次），平均治愈时间为4.2天（次），无1例后遗症。

张天文等 火罐疗法治疗带状疱疹111例 中国针灸（2）；46，1986

火 针 法

1. 选穴：（1）循经取穴，以足太阳膀胱为主，常用肺俞、肝俞、胆俞、脾俞，病变在腰以上者配支沟，病变在腰以下者配阳陵泉。（2）局部取穴，在带状疱疹区域周围火针点刺，限制皮损扩散。

2. 操作：（1）采用自控弹簧火针，针体由不锈钢制成，通过自控升降器与弹簧的作用，随意调节针刺深度。（2）根据病情将火针刺入深度调到1—3毫米，置于酒精灯上烧灼，至针尖红而发亮时刺入所取穴位，快刺疾出。每隔3日火针1次，一般病人连针1—3次。注意针孔处保持清洁，切勿抓搔。

共治疗105例。全部病例经火针治疗1—3次，疱疹干涸消退，疼痛消失，治愈率达100%。其中火针1次治愈者70例，2次治愈者30例，3次治愈者5例。针后疼痛逐渐减轻，消失时间一般为12小时，疱疹干涸结痂平均3天。

郑学良等 火针治疗带状疱疹105例 江苏中医（8）；26，1988

围 刺 法

围绕红肿处及簇集水泡群的周围皮肤，用三棱针或毫针点刺，每隔1~2cm点刺一下，见出血即可。也可用两手轻轻挤压点刺处见有

出血。其目的使其恶血出尽，以消肿痛。若伴发热或疱疹重者，可配体针，在足三里、曲池、血海等穴施针。采用平补平泻手法，留针15分钟。上述方法可隔日一次。如见疱疹溃破，针后涂龙胆紫药水，外敷消毒纱布，即可防止感染。

共治疗83例。一般经用上法1~3次，可达止痛效果，5~10次可基本治愈。

王原凤 围刺治疗带状疱疹 辽宁中医杂志 (9); 38, 1987

灯火灸法

根据患病部位取患侧穴位，颜面部取合谷，头项部取列缺，胸胁部取内关，腹部取足三里，少腹部取三阴交，腰背部取委中，臀部取环跳，四肢取阳陵泉。以灯心草1根（约3寸长），一端蘸菜子油，点燃后，迅速将灯心草油火接触在穴位的皮肤上，一点即起，每日1次。施灸处可出现绿豆大的水疱，不必处理，可自行消退。

本组52例患者均治愈（水疱干涸，皮疹结痂，疼痛或自觉症状消失），一般1~4天疼痛及炎症基本消失。2~5天水疱开始干涸结痂。其中最少治疗1次，最多6次，平均治愈天数为4.8天。

刘远坝 灯火灸八穴治疗带状疱疹52例 陕西中医 (9); 419, 1989

穴位药物注射法

(一) 药物：醋酸强的松龙0.5毫升至1毫升，加2%普鲁卡因4毫升至6毫升（药量根据病灶范围大小而定）。

(二) 注射方法：先将醋酸强的松龙1毫升（含25mg）吸入注射器内，然后再吸普鲁卡因充分混合匀后，用5号牙科长针垂直刺入选好的穴位，得气后将药物等量缓缓注入。每日一次，连续注射，轻者2至3次，重者4~5次即可完全止痛；个别遗留有轻微疼痛，经过一段时间，可以自行消失。

(三) 取穴:

1. 辨证取穴: 根据病情如属肝胆湿热者可取肝俞、胆俞、太冲等穴。如属脾虚湿盛者可取脾俞。

2. 循经取穴: 根据皮疹分布部位, 按其所属经脉选穴。如第一到第三胸椎之间肋间神经分布区发生疱疹时可取大杼、风门、肺俞三个穴位, 大腿外侧发生皮疹可取环跳穴、足三里等穴, 三叉神经第一支所属范围发生疱疹可取攒竹穴, 第二支可取四白穴, 以此类推。

共治疗40例。疼痛完全消失者为痊愈, 疼痛基本消失但偶有轻微疼痛发生者为显效。疼痛未止者为无效。

本组共40例, 痊愈者38例, 占95%, 显效者2例, 占5%, 总有效率为100%。在40例有效病例中疗程最长5天, 最短2天, 在显效病例中适当配合活血化瘀、扶正固本的中药。

杨春兰 穴位药物注入治疗带状疱疹40例 中国针灸 (2), 11, 1986

围刺配合华佗夹脊法

1. 取穴方法: 病变在头部者仅采用局部围刺法; 病变在胸腰部者, 除采用局部围刺外, 还可针刺病变同侧部位的夹脊穴。

2. 针刺方法: 用28号2寸长的毫针在疱疹的前后左右进行围刺, 针身通过病变中心部位达到对侧。围刺完毕后, 将针逐一捻转, 通常采用泻法, 然后再接电麻仪通电20分钟。

3. 疗程: 一般为二疗程, 每一疗程为七天, 中间休息3天, 然后再进行下一疗程治疗。

共治疗35例。痊愈: 疼痛及疱疹完全消失; 显效: 疱疹范围缩小, 疼痛偶有发作; 进步: 疼痛有所缓解, 疱疹范围略缩小。

痊愈: 26例 (74.29%); 显效: 8例 (22.85%); 进步: 1例 (2.86%), 总有效率: 100%。

孙远征等 围刺法配合华佗夹脊穴治疗带状疱疹35例观察 黑龙江中医药 (6); 38, 1990

5. 扁平疣

耳 压 法

取穴：肺、神门、肾上腺、大肠、皮质下。另加分部穴：发于颜面的加面颊区、颧、下颌；发于手背的加指、腕；发于前臂的加腕、肘。方法：取 5×5 毫米胶布小块，将王不留行籽放在胶布上贴于耳穴（发于手背和前臂的可用 5×15 毫米的长方形胶布将王不留行籽数粒均匀排列于胶布上贴于耳穴处，如从指穴到腕穴连贴）。隔日治疗 1 次，两耳轮流贴，10 次为 1 疗程，嘱患者每日自行按压 4~5 次，每次 10 分钟，中强度刺激，以耳廓潮红，面部有热感为最佳。

治疗扁平疣 50 例。一般 1 个疗程可愈。有效率为 88%。

倪赛男 按压耳穴治疗扁平疣 50 例 浙江中医杂志 (8); 352, 1988

6. 跖 疣

针 刺 法

治疗时先用碘酒、酒精棉球将跖疣损害处消毒，然后用修脚刀将损害表面角质削去，暴露底部，以鉴别是跖疣或胼胝。确诊为跖疣后，再用碘酒、酒精棉球消毒。然后，以左手食指及中指捏疣之基底，用 20 号针在疣之表面选三角形 3 点快速进针，并用食指及拇指压迫疣之基底，使其表面出血，再用碘酒棉球消毒患处，並以消毒敷料，胶布固定。如此每日 1 次，连续 3 天。一周内勿被水浸，以防感染。

共治疗 37 例。经针刺 5 天以内，疣表面即干燥成块状脱落，针刺

后10~20天即全部脱落，并稳定6个月无复发者为治愈；疣损害表面无干燥脱落者为无效。其中2~3天治愈者21例，4~5天治愈者14例，5天无效者2例，总有效率为94.6%。

高志源 针刺治疗疣37例 黑龙江中医药 (1); 43, 1991

7. 跖 疣

穴位封闭法

取2%普鲁卡因4毫升，于患侧“太溪”穴刺入，进针后要刺激该穴“得气”。并使之传到疣的部位。即刺激后的酸、麻、胀感要由太溪穴传导向足底疣的部位，此时方可推药。如未出现传导感就推药，则疗效不明显。

王志润 太溪穴位封闭治疗跖疣 北京中医学院学报 (2); 27, 1991

8. 冻 伤

针刺放血法

患处皮肤常规消毒，在红肿部位中心进针。视红肿面积大小刺1~4针。针尖刺入皮肤后斜向肢体远端，达红肿边缘即可；应用补法捻转提插，不留针，出针后挤出血液少许。可轻轻按摩局部再挤压或针刺使其出血。隔日针刺一次。

在1000例中治愈922例，占92.2%，其中一次治愈825例，占82.5%；好转47例，占4.7%，无效31例，占3.1%。总有效率为96.9%。

张俊涛等 针刺放血治疗冻伤1000例 中国针灸 (6); 54, 1986

9. 鸡 眼

艾 灸 法

操作方法: 1. 先用温水 (41℃左右) 浸泡患处30~45分钟, 使皮肤软化, 然后用75%酒精棉球消毒皮肤, 再用刀片削去老皮为目的, 但不要削痛、出血。2. 将艾炷直接放在鸡眼上, (艾炷按鸡眼大小而定) 点着艾炷尖端, 自行燃烧, 待局部有灼痛时, 用镊子夹掉, 再放1壮, 连续灸5~7壮, 每日1次, 下次做法仍按前面程序进行。307例全部治愈。治愈标准: 局部皮肤柔软, 色正如常, 无压痛。

解昌科 艾灸治愈鸡眼307例 内蒙古中医药 (4); 41, 1990

火 针 法

患者取腹卧位于诊断床上, 术者右手持5分毫针一根, 左手将患者鸡眼捏紧, 酒精灯一盏, 将5分毫针烧红, 立即刺入鸡眼中央硬索处0.5~1cm深度后即可拔针。(根据鸡眼大小及部位实施针刺深度)。针刺后无需包扎, 待20天~30天后鸡眼可自行脱落, 一般只刺一次。

共治疗60例。痊愈: 鸡眼脱落无瘢痕愈合。好转: 鸡眼面积缩小。

经用此法治疗60例患者观察一年以上无复发, 治愈59例占98%, 总有效率达100%, 只要方法得当, 深度适宜无需第二次治疗, 针刺后每晚睡前也可用热水浸泡鸡眼小角刀拔离, 硬及较小的鸡眼脱落早, 软及较大鸡眼脱落迟, 鸡眼脱后不留瘢痕, 无继发感染。

李 炜 火针治愈鸡眼60例 天津中医 (2); 89, 1990

10. 黄褐斑

耳压法

1. 使用84—1多功能肿瘤探测仪(湖北仙桃市电子仪器厂产品)对本文50例患者逐个进行耳穴测试。选择出共有的最佳穴位进行准确贴压。主穴有:神门、子宫、肾、肝、脾、内分泌、皮质下。配穴有:大肠、胃、卵巢、心、胆。

2. 方法:常规贴压法。隔日1次,15次为1疗程。每次主穴必贴,配穴按不同伴随的相关病症选加。3个疗程后进行疗效判定。贴压期间,停止其他任何治疗。

共治疗50例。显效:色素沉着显著改善(色泽明显变淡,同时色斑内区出现正常肤色或色素面积缩小),相关病症同时显著好转。好转:色素明显变淡,相关病症好转。有效:色素变淡,相关病症减轻。无效:症状无改善。

50例中,显效26例,好转15例,有效7例,无效2例,总有效率为96%。

杜 玮等 耳压治疗黄褐斑 50 例疗效观察 陕西中医 (6); 269, 1989

附: 蝴蝶斑

耳压法

取肝、肾、肺、内分泌、皮质下、交感、神门、面颊;体虚者加脾、胃。找出以上诸穴敏感点后,每穴按压王不留行籽1~2粒,以胶布固定,两耳交替使用,隔日1次,以免耳廓感染。

共治疗80例。10次为一疗程，一个疗程内“蝴蝶斑”基本消退者为优，计36例，占45%；二个疗程明显消退者为良，计38例，占47.5%；二个疗程后消退不显者为差，计6例，占7.5%。

施易安 耳压治疗“蝴蝶斑”80例 江苏中医（2），8，1989

11. 雀 斑

火 针 法

让面部雀斑患者仰卧床上，先在患处常规消毒后再涂麻沸散（见《华佗秘传》）液局部麻醉，约过十分钟后即可开始点刺。如遇雀斑较重患者，可加用穴位注射1%利多卡因。穴位选择，是根据雀斑分布密度而定，如：印堂、四白、颧髻、颊车、阳白等，每个穴位注药量为0.5ml。还可配合针刺麻醉，选用足三里、合谷。以上三种麻醉法，可单用也可同时并用。

在进行点刺前，备好酒精灯一盏（火苗宜大）、不同型号平头火针若干支。医者左手持酒精灯，右手拇指食指持针柄，将针在酒精灯上烧到针尖端发红时，对准斑点迅速点刺，斑点立变灰白色后结痂。过10~15天结痂自行脱落，斑点消除，不留疤痕。有时结痂刚落，局部皮色呈淡粉状，再过一周后皮色可恢复正常。

选用针具：大雀斑点，用粗号平头火针点；小雀斑点，用细号平头火针点；一般雀斑点，中号平头火针点最宜；对老年性斑痣且明显高出皮肤者，可用三头火针点刺。

用针温度：要根据患者年龄大小，皮肤坚嫩灵活掌握。点儿童雀斑时的火针温度，要略低于成年人；对老年性斑痣或高出皮肤的深色斑点，针温要略高于成年人。

下针力度：视不同斑点的色素深浅掌握，色深者，用针力度稍大；斑色浅者，力度要小。点刺速度宜快，每针都能准确地点到斑点

中心，疗效最佳。

根据雀斑轻重程度，可分为轻、中、重三种。轻者斑点分散，色浅，粒小（芝麻粒大），一般点刺一次即可全除；中度雀斑：色稍重，黄、黑两色并存，鼻部集聚，面部密度不高，经一次治疗后隔一个月复查，如有漏点或未除净者，可做二次点刺；重度雀斑往往黑、黄两色夹杂，斑点大小不一，几乎盖满了全脸，对重度雀斑治疗，可采用分片或分批点刺的方法，分片：将雀斑区分为三片，每次点一片，三次点完；分批：先点大斑点，再点中斑点，最后清除小斑点。半年之内或一个夏季过后未发现有明显雀斑出现，即为痊愈。

共治疗雀斑患者1200例，经火针点刺治疗痊愈的936例，治愈率为78%；有效者233例，占19.4%；无效者31例，占2.6%；总有效率为97.4%。

张喜兰 火针治疗面部雀斑1200例疗效观察 中医杂志（2），40，1991

12. 黧黑斑

针刺和药物穴位注射法

一、针刺治疗

体针主穴为大椎、曲池、血海、足三里、三阴交、风岩（耳垂下端与后发际中央连线的中点微前五分处）。头痛目眩、心烦易怒加行间穴；形寒肢冷、腰酸耳鸣加太溪、命门、神门、内关穴；月经不调、性功能减退加乳根、中极穴；心悸气促、食少纳差加内关穴；皮肤瘙痒加夹脊穴上下透针。体针每日或隔日一次，10次为一疗程，不留针，刺激强度以患者能耐受为度，多为平补平泻手法。主穴每日必取。

耳穴取神门、交感、肾上腺、内分泌、皮质下、肺、肝、肾。每日每侧取2穴，间隔半小时患者自行按压针柄一次以增强刺激，留针

4小时后自行取下。

二、穴位注射治疗

当归、丹参、川芎均制成单味针剂，每支含生药2克。偏血虚用当归注射液，偏血瘀用川芎注射液，偏肝郁而兼血瘀用丹参注射液。偏虚患者可注射胎盘组织液、维生素B₁₂。注射穴位为肺俞、心俞、肝俞、肾俞（均双侧）。每日或隔日注射一次，注射10次为一疗程。根据病情每次选二穴（均双侧），注射1支或2支。皮肤瘙痒者每次用维丁胶性钙2支分注于大椎、曲池、血海穴。

针刺和药物穴位注射同日进行，每疗程间休息2~3天，5~6个疗程间休息半月。一般需要20~25个疗程。

共治疗100例。皮肤色素减退，皮色接近正常，伴随症状消失或基本消失，评为临床治愈者16例，占16%；皮肤色素减退明显，伴随症状基本消失或明显减轻，评为显效者39例，占39%；皮肤色素及伴随症状均较治疗前减轻，评为好转者40例，占40%；治疗4疗程后仍无改善，评为无效者5例，占5%；总显效率为55%。有伴随症状70例，伴随症状消失者36例，减轻者29例，无效5例。

欧阳群等 针刺和药物穴位注射治疗黧黑斑100例观察 中医杂志 (12); 39, 1987

13. 皮肤表面病症

新火针法

我们以古代火针与现代电烙原理研制的新火针治疗器治疗鸡眼、色痣、老年斑、皮肤癌、血管瘤、各种疣等21种病症567例，收到较好的疗效。

接通电源，加热针具，迅速点刺病区，如蜻蜓点水，由表及里，直至健康组织披露为度，继而用钝刀清除皮损，最后用火针点刺止血，术终。注意事项：瘢痕体质、出血性疾患、孕妇等慎用；大面积

病变应分期治疗，如面部的血管瘤；对鸡眼、色痣、各种皮炎等病变，施行此法必须披露到健康组织。尽量少伤正常皮肤。若施术后局部渗出者可用紫金锭外敷，并嘱患者近期不洗澡，防止局部感染。

567例中近期治愈者557例占98%。无效者10例占2%。

张华勤等 新火针治疗皮肤表面病症 辽宁中医杂志 (11); 6, 1988

14. 蜘蛛状血管瘤

火 针 法

用酒精灯一盏，大小缝衣针数只。局部消毒后，根据瘤体膨胀部位的大小，选用适宜的针。在酒精灯上烧红针尖，立即垂直插入瘤体中心凸出部位约0.1~0.2厘米，随即拔针，这时瘤体的全部或绝大部分向周围辐射的分枝即随之消失。术后2~3天勿洗术处，以免感染。

共治疗50例。治疗后原皮损消失为治愈；原皮损大部消失为显效；原皮损小部分消失为有效；治疗后无变化为无效。经治疗，当时皮损消失者40例，一个月后消失者5例，共45例（90%），显效4例（8%），有效1例（2%），总有效率100%。绝大部分治愈后不留瘢痕，仅3例留下轻微的米粒至芝麻大的浅痕，其中2例是夏季术后着水感染所致。

汉维亭 火针治疗蜘蛛状血管瘤 50例 中国针灸 (2); 14, 1987

15. 湿 疹

穴位注射法

①采用维生素 B₁₂ 0.1mg，分注于双侧足三里、曲池，每日一

次，10次为一疗程，休息5至7天，再进行第二个疗程。②治疗期间，停用一切内外药物。③治疗前后测定部分免疫球蛋白、细胞免疫功能。

1. 疗效标准：皮损完全消失，基本无搔痒者为痊愈。皮损大部分消失，超过50%以上，仍有搔痒感者为显效。皮损一部分消失，搔痒明显减轻者为好转。治疗前后无变化者为无效。

2. 疗效：痊愈率66%，显效18%。显效以上占84%。好转病例有些是中途停止，如能继续进行1~2疗程，可能疗效会提高。仅有一例在针灸15次后才见效，30次才痊愈。效果快者针灸4次即痊愈，大部分均在10次左右。

孙梅倩等 穴位注射维生素 B₁₂ 治疗顽固性湿疹50例 中国针灸 (3), 45, 1986

16. 阴囊湿疹

穴位注射法

1. 选足太阴脾经上的箕门穴，常规消毒后，用5ml注射器抽取当归注射液2ml快速进针刺入，提插得气后，回抽无血即将药液注入，此后外艾灸15分钟左右。

2. 急性发作者，每天穴注1次，7天为1疗程；慢性病者，每天穴注1~2次，双侧穴交替注射，以20次为1疗程，共治3个疗程。

共治疗42例。经穴注治疗3个疗程后，皮损愈合，无丘疹痒症，无复发为有效；经治3个疗程后，症状减轻，发作次数减少或间期延长为好转；症状改善不明显为无效。

本组42例中，有效24例，好转13例，无效5例。

陈 驰等 当归箕门穴注射治疗阴囊湿疹42例 陕西中医 (11), 518, 1990

17. 荨 麻 疹

梅 花 针 法

在发疹部位常规消毒，用梅花针在荨麻疹上反复叩刺，以轻微渗血为度，每日2次，10次为1疗程。

22例中急性8例，慢性14例，发病后即用法者10例，用法无效而改用本法者12例，叩刺3次痊愈者11例，10次痊愈者9例，2例无效。

马凤友 梅花针治疗荨麻疹22例 江苏中医 (1); 29, 1991

泻 血 疗 法

取大椎、血海为主穴。疹发上肢加曲池，疹发下肢加风市、委中，疹发背部加膈俞、风门。先在穴位的局部按揉，使其达到红润充血，常规消毒，然后用三棱针点刺，当血溢出，速用闪火法将玻璃火罐吸附在穴位上，并左右旋转，使出血量增加，留罐15分钟。隔日一次，7次为一疗程，休息3天再进行下一疗程。

共治疗15例。经2次治愈4例，7次治愈7例，10次治愈3例，15次治愈1例。3年后随访均未见复发。

刘志国 泻血疗法治疗荨麻疹 上海针灸杂志 (3); 46, 1987

18. 寒冷性荨麻疹

针 刺 加 电 罐 法

取穴：曲池、血海、足三里（均双）。得气后留针20分钟，起针

后再单刺大椎、肺俞（双）、肾俞（双），然后加电罐10分钟，每天1次，6次为一疗程。每疗程休息3天。

共治疗33例。痊愈：冷水试验不见风团，不痒，在1个月内未见复发者0例；显效：冷水试验不见风团，不痒，在1个月内偶见轻度复发者10例；有效：遇冷起风团，但风团持续时间较治疗前明显缩短，搔痒减轻19例；无效：与治疗前比较无任何变化4例。总有效率为87.9%。

高元芝等 针刺加“电罐”治疗寒冷性荨麻疹33例 辽宁中医杂志（3），11，1988

19. 皮肤瘙痒

针 刺 法（一）

自然握拳，掌心向下，手背四五指缝纹尖上方约5分处陷中。避开可见浅静脉，用毫针顺掌骨间隙刺入0.5至1寸，左右捻转，以得气为度。一般先刺单侧，15分钟后效差者加刺对侧。留针30~60分钟，中间每15分钟运针一次。

共治100例。病因为荨麻疹、皮肤瘙痒症、皮肤划痕征、风疹、药疹、皮炎等。

初诊即时效果，完全消失57例，基本消失25例，显著好转6例，好转8例，无效4例，总有效率96%。

申 健 针刺下都穴治疗皮肤瘙痒 上海中医药杂志（5），24，1990

针 刺 法（二）

取穴：合谷、曲池、足三里、血海、环跳。上肢及躯干瘙痒为主者配神门、外关、肝俞；下肢瘙痒为主者配委中、承山、三阴交。先

用酒精常规消毒，然后直刺穴位，以产生沉胀麻木感为度，进针深度约0.5cm，留针15~30分钟。每日一次，10次一疗程。

共治疗21例。瘙痒完全消失者8例（6例随访1年未发）；偶而瘙痒者10例；自觉瘙痒减轻者2例；无效1例。

虞敏彪等 针刺治疗瘙痒症 21例 湖北中医杂志 (4), 56, 1988

20. 神经性皮炎

针 灸 法

1. 取穴：风池、大椎、曲池、合谷、足三里、血海、承扶、委中等，每次选2~3穴，用中强刺激。

2. 皮下针：沿患部四周皮下横刺，不断捻针，使其胀感向四周放散，留针30分钟，每日一次。

3. 皮肤针：先用75%酒精对患部消毒，再用皮肤针重叩患部，然后拔火罐，每日一次或隔日一次均可。

4. 艾条灸：一日2次，每次30分钟。针刺后再用艾条灸尤佳（拔火罐、艾条灸不适宜会阴部）。

37例中，痊愈27例，占73%；好转8例，占22%；无效2例，占5.4%，总有效率95%。

杨庆林 针灸治疗神经性皮炎37例 上海针灸杂志 (2), 23, 1987

耳针加锌离子透入法

病人取坐位，将3%硫酸锌溶液浸湿的衬垫(15×15平方厘米)，对折4折后贴于需治疗的皮损上，将脉冲直流电治疗仪（输出电压为

12 V, 最大电流强度为 5 mA, 脉冲次数为 30~80 次/分) 的正极板 (4 × 2 平方厘米) 置于衬垫上, 铺上塑料布并用胶布固定, 负极导线接短毫针, 然后按常规刺入耳穴 (主穴: 肺, 配穴: 神门、内分泌。配穴每次针 1 穴), 开机并逐渐增大输出电流, 至治疗的皮损处有麻感为止, 再调整脉冲次数在 40~70 次/分, 治疗 15 分钟后交换正负极性, 再治疗 15 分钟; 每日 1 次, 6 次为 1 疗程。对照组: 用手法针刺耳穴 (穴位同治疗组), 每穴留针 15 分钟。每 5 分钟捻转 1 次, 每日 1 次, 6 次为 1 疗程。均停用其他药物。

共治疗 70 例。痊愈, 症状和皮损全部消失, 仅留色素沉着; 显效, 皮损消退八成以上, 症状显著减轻; 有效, 皮损消退五成以上, 无新疹出现; 无效, 皮损消退不足五成, 且出现新疹。痊愈 45 例, 显效 9 例, 有效 10 例, 无效 16 例, 总有效率 91.4%。

王鹏辉 耳针加锌离子透入治疗湿疹、神经性皮炎 265 例 浙江中医杂志 (12); 561, 1990

21. 银 屑 病

穴位注射法

药物: 654—2 10mg 加维生素 B₁₂ 100ug。取穴: 主穴神阙穴, 头皮皮疹重者加百会穴, 左下肢重者配右后溪穴, 右下肢重者配左后溪穴。操作方法: 注射神阙穴时患者取仰卧位, 双下肢呈屈式, 右脐旁开约半寸处常规消毒, 进针时倾斜 30~40 度 (根据病人胖瘦而定), 缓慢刺入脐中, 待有酸、麻、胀感后徐徐注入药物。每日 1 次, 每次 1 穴。每 25 次为 1 个疗程, 2 个疗程无效者, 改用其他疗法。辅助治疗: 平屑酊 (含肉桂、细辛、斑蝥、消炎痛等) 或白降汞霜外用, 每日 1 次; 矿泉浴, 每日 1 次。

共治疗 70 例。皮疹完全消退或基本 (95% 以上) 消退者为痊愈; 皮损大部 (60%~95%) 消退者为显效; 部分皮疹 (30~60%) 消退者

为有效；皮疹消退不足30%者为无效。

在70例中，临床治愈46例，占65.72%；显效14例，占20%；有效8例，占11.42%；无效2例，占2.86%。总有效率97.14%。在治愈病例中，一般在治疗5天后，瘙痒减轻，皮损变薄，颜色变淡。约80%患者治疗20天后皮损消退70~80%。治愈时间最短者18天，最长者45天，平均34天。

王孟柏等 神阙穴654—2注射治疗银屑病70例疗效观察 河南中医(3)，31，1991

耳穴埋药法

在耳部的肺、心穴上常规消毒后，划一长2~3mm小口，使之微有血出，随即把煨成炭末之中药涂于切口处，再置无菌棉球固定之，以使药物不至脱落。1周割治1次，5次为1疗程，如皮损搔痒或影响睡眠，可配神门穴。药物组成：艾炭、血余炭、野菊花、马齿苋、地榆、苦参、蛇蜕、大枫子、乳香、没药等煨后合研细末。

共治疗500例。割治3~5次，皮损完全消退者283例；割治3~5次，皮损消退50%以上者131例；割治5次以上，皮损消退20%~50%者74例。割治3~5次，皮损无改变者15例。

周瑞华 耳穴埋药治疗银屑病500例临床观察 辽宁中医杂志(7)，38，1987

22. 掌跖脓疱性银屑病

穴位注射法

强的松龙注射液，每穴30~50mg（可加2%普鲁卡因1~2毫升），交替选取合谷、内关、足三里、三阴交等穴位。经常规消毒后，垂直进针，得针感后缓慢推注。皮损局限于双掌部者，取上肢左

右穴位交替注射；局限于腕部者，取下肢穴位交替注射；双侧掌腕部同发皮损者，取上左下右和上右下左肢穴位交替注射。间隔5~10天注射一次。治疗期间停用其它内服药物，外用蒺藜软膏或皮质激素类软膏。

共治疗6例。1例注射3次，2例注射4次，2例注射5次，1例注射6次后，痂皮脱落，皮损消退。

税典福 穴位注射治疗掌跖脓疱性银屑病6例 湖北中医杂志 (3); 31, 1988

23. 痤疮

耳穴割治贴药法

取穴：肺、大肠、内分泌、子宫（精宫）、面颊区为主穴。血热者配小肠；顶端有脓疱配心；湿甚者配肾上腺；风甚者配神门；皮脂溢出重者配脾；气虚者配胃。另外可根据病变皮损区域灵活选取配穴。

药物及用具：1.香胡散：食用纯香油、纯胡椒粉。上述两味药适量，调成稠糊状，放入消毒瓶中备用。2.消毒手术刀片。3.方形胶布块（1.2×1.2cm）。4.消毒牙签。

操作方法：轻揉搓患者耳廓，使其红润充血，常规消毒，左手固定耳廓，右手执刀，在选择穴位上刺破皮肤，溢血少许（1~3滴），用消毒棉擦去血迹，然后用消毒牙签挑取药糊（如火柴头大小）敷在穴位上，用小胶布块覆盖固定伤口，隔日或两日割治一次，两耳交替进行，10次为一疗程。

注意事项：1.要求取穴准确，割治深度适宜，以不伤及软骨为度。2.注意无菌操作，以防感染。3.治疗期间忌食腥辛辣酒之品。4.对于血小板减少性紫癜，血友病及其它出血性病患者要慎用。5.常用温水洗面部，禁止用化妆品或其它外擦膏剂。

450例中痊愈304例，占67.5%（丘疹完全消失，皮肤润滑，未见复发者）；显效140例，占30.2%（丘疹基本消退，偶尔有1~2个丘疹出现）；无效6例，占1.3%（经15次治疗无改变者）；总有效率为97.7%。一般经5次治疗，痤疮面红肿消退，痛痒减轻，未有新痤疮出现，10次后疮面痂脱而愈。

石信箴 耳穴割治贴药治疗青年痤疮450例 河南中医 (2), 28, 1991

耳 压 法

1、取穴：肺、肝、内分泌、肾上腺、神门。月经不调者加子宫、卵巢；胃肠功能紊乱者加胃、脾、面颊、下颌。重者按压双耳，轻者取一侧，1周后换另一侧。2、操作方法：先用75%酒精棉球消毒王不留行籽及耳廓，然后用0.6cm×0.6cm胶布，把王不留行籽固定在穴位上，然后按压，使患者有胀痛感为止，并嘱患者每日自行按压3~4次，每穴1~2分钟，按压要轻，避免损伤皮肤，

6天为一疗程，休息1天再行第二疗程。

共治疗300例。痤疮全部消退为痊愈，偶尔出现1~2个者或基本消退为显效，消退2/3以上者为有效，无变化者为无效。结果痊愈181例，显效108例，有效8例，无效3例，总有效率99%。

张秀英 耳穴压豆治疗痤疮300例 山东中医杂志 (1), 25, 1991

耳 针 法

主穴：肺（双）、肾（双）；辅助穴：脓疱加刺心，皮脂溢出较重加刺脾，大便秘结加刺大肠，痛经加刺肝、内分泌，皮损集中在某一区域时，加刺其表面投影反应点。

方法：被刺耳区皮肤先用75%酒精棉球消毒，取五分之一毫针，快速刺入反应点，以不透过软骨为宜。留针15~30分钟，其间轻巧捻转3

~6次。2日针一次,30次为一疗程。

80例中,在施用本疗法的过程中,不配合其他药物治疗,大多数病例经过10~25次的耳针治疗就能见效。获临床痊愈62例,占77.5% (皮疹完全消失,便秘或痛经等症基本解除);显效11例,占13.8% (皮疹基本消失,偶尔有2~3个丘疹或针帽大小的脓疱出现);无效7例,占8.7%(耳针治疗20次后,皮疹无变化,或有恶化趋势),总有效率为91.3%。其中以炎性粉刺痤疮,丘疹性痤疮和脓疱性痤疮效果最佳,经治疗的62例全部获愈;严重性痤疮次之;结节-囊肿聚合性痤疮和恶病质性痤疮合计7例,均无效。

徐宜厚 耳针治疗80例痤疮的临床观察 中医杂志 (6), 18, 1987

中药结合挑刺法

(一) 内治法

1. 湿热蕴结型: 处以野菊牛子汤加减: 野菊花15g, 牛蒡子12g, 白芷12g, 栀子12g, 土茯苓15g, 白花蛇舌草30g, 丹皮12g, 生苡仁15g, 赤石脂15g, 赤芍10g, 黄芩10g, 生甘草6g。日一剂, 水煎服。

2. 气滞血瘀型: 处以消瘰丸加味: 土贝母15g, 生牡蛎30g, 元参10g, 皂刺15g, 桃仁10g, 夏枯草15g, 半夏10g, 红花10g, 莪术12g, 丹参20g, 连翘12g, 陈皮6g。日一剂, 水煎服。

加减: 若湿邪偏盛者酌加滑石、苦参; 热毒盛者加生石膏、丹皮; 瘙痒剧烈加白鲜皮、僵蚕; 便秘加制大黄、生枳壳; 油脂较多者加炒白术、山楂等; 发于面部加蔓荆子、羌活; 月经不调者加白芍、益母草等。

(二) 外治法

皮损油腻脂垢明显者, 外涂10%硫磺洗剂、肤乐霜等, 每日1~2次; 黑头脂栓多者, 用消毒针头分次将脂栓状物挑剔; 白头丘疹、小囊肿及脓肿已成熟者, 用三棱针从其顶部点刺, 排出内容物; 结节

肿硬不消，或出现疤痕样损害者，配合局部按摩并贴敷消癍膏（本院配制），每2至3天更换一次。

60例中痊愈32例（皮损基本消退，仅留轻度色沉斑或皮肤凹陷）；有效22例（皮损大部分消退，结节及疤痕软缩）；无效6例（皮损无减轻或仍有新疹出现）。痊愈病例中服药最少11例，最多60剂，平均26剂。总有效率为90%。

李治牢等 中药结合挑刺法治疗顽固性痤疮60例 北京中医学院学报（1），28，1989

耳背放血法

操作方法：选病者双侧耳背近耳轮处明显的血管一根，揉搓数分钟后，使其充血，按常规消毒后，左手拇指食指将耳背拉平，中指顶于下，右手持消毒好的修面刀片划破选好的静脉血管，使血自然流出5~10滴。流血过少者可轻轻挤压，然后用消毒棉球抹去血液，消毒切口，盖上消毒敷料，患部忌水以防感染。1次为1疗程，1次未愈者，间隔1周后在另选一根血管放血。一般1~3疗程可愈。

共治疗40例。放血1次，面部痤疮全部消失，不再长出新的痤疮为痊愈。放血2次后，面部痤疮全部消失，不再长出新的痤疮为显效。放血3次后，面部痤疮不完全消失，或长出新痤疮为有效。放血3次后面部痤疮同前为无效。

痊愈18例，显效12例，好转6例，无效4例。

刘康平 耳背放血治疗痤疮40例 天津中医（5），29，1987

点刺放血法

选用背部足太阳膀胱经内侧线上的心俞、肺俞、肝俞、脾俞、肾俞。每次使用其中2~3穴，以上诸穴轮流使用。先在所用俞穴周围挤按，使血液瘀积，继则常规消毒，然后以三棱针快速刺入，出针后挤出瘀血数滴，以消毒干棉球揩净后，按压针孔片刻。隔日一次，6

次为一疗程，疗程期可间隔 2～3 天。

共治30例。痊愈：原疹全部消退，疹痕逐渐消失，面颊已恢复红润。

显效：原疹基本消退，新起皮疹减少，留有色素沉着。

好转：原疹有吸收，新疹减少，或疹块由大变小。

无效：治疗前后无变化者。

本组30例中，痊愈16例，占53.3%；显效11例，占36.7%；好转3例，占10%。

景宽等 五脏俞点刺放血治疗痤疮30例 北京中医 (3); 37, 1990

24. 斑 秃

穴位注射法

用维生素 B₁₂ 1 ml (0.5mg) 穴位注射，每次二个穴位。第一次双侧曲池，第二次双侧足三里，穴位处皮肤消毒后，右手持针快速刺入，上下缓慢提插，待病人有酸、麻、胀感后，回抽如无回血，即将药液慢慢注入，每穴 0.5ml，交替穴注。隔日一次，十次为一疗程，一般用三个疗程。

共治疗60例。痊愈：脱发停止，皮损内完全长出黑发；

好转：脱发减少或停止，皮损内有部分毛发生长；

无效：脱发仍继续发展，皮肤内无毛发生长。

痊愈42例 (70%)，好转12例 (20%)，无效6例 (10%)，总有效率90%。

何慧英等 穴位注射治疗斑秃60例临床观察 浙江中医学院学报 (3); 48, 1990

25. 早 秃

针 灸 法

(一) 穴区划分：根据经脉和皮部的分布原理，在头部自拟 5 个针灸刺激区域，即双头维穴之连线处为一区；上星穴与百会穴之连线处为二区；双率谷穴连线处为三区；百会穴四周旁开 2~4cm 处为四区；双风池穴连线处为五区。

(二) 取穴：以取头部划分区域为主，兼以配合全身取穴。即前发际与颞部脱发者取一区、二区；以头顶部为中心脱发者取四区、三区、二区；全头性脱发者取五区、四区、三区、二区。每区刺激宽度约为 2cm 左右。全身穴位随症选择，头晕、乏力者加刺肾俞、太溪、足三里；胃部不适者加刺脾俞、胃俞、足三里；失眠、心烦加刺内关、心俞、太冲；有瘀血证者加刺大椎放血。

(三) 操作：选定头部刺激区域，常规消毒，然后以梅花针叩刺。叩刺密度要均匀，力量适度。一般应由轻至重，慢慢叩击至局部出现点状出血为度。3~5 分钟之后，以鲜姜或鲜蒜切片涂擦叩击过的部位，至患者有热感或局部潮红为佳。体针操作视患者整体虚实情况施以补泻手法。

(四) 疗程：隔日 1 次，30 次为 1 疗程。如无新发再生者，休息 1 个月后，重复上法 1 至 2 个疗程。

本文统计病例均为治疗 2 疗程以上者。标准：脱发区域普遍有新发再生者为完全再生，共 42 例。脱发区域仅部分有新发再生者为部分再生，共 31 例。2 疗程后无改变者为无效，11 例。

朱凤山等 早秃的针灸治疗 辽宁中医杂志 (3); 36, 1988

26. 脱 发

针 刺 法

主穴：百会、头维、生发穴（风池和风府连线之中点），配穴：翳明、上星、太阳、风池、鱼腰、丝竹空、四神聪、安眠穴。

每日或隔日针刺1次，每次选取5—7穴，交替使用，随症加减，视体质强弱及证情虚实运用补泻手法，可不留针或用电针，10次为一疗程，大多一个疗程即可奏效。

治疗期间嘱患者每日早晚自行按摩头皮。

共治疗880例。治愈507例，占57.61%；脱发停止，全部脱发区长出正常头发（有时可见头发稍细），头皮厚度恢复正常（5—7毫米），头皮温度恢复正常（30—34℃），头皮皮脂溢出、脱屑及瘙痒等症状消失或明显减轻。

显效213例，占24.21%；脱发停止，脱发区80%以上长出新发，头皮厚度、温度恢复正常，头皮皮脂溢出、脱屑、瘙痒等症状明显减轻。

有效98例，占11.14%；脱发减轻或停止，脱发区50%以上长出新发，但生长较慢，头皮厚度、温度基本恢复正常。

无效48例，占5.45%；头皮厚度、温度改善不明显或虽正常但不见新发生长或极少生长。此类患者多数接受过外用药涂擦或紫外线照射治疗。

另有14例占1.59%的患者因故中断治疗。

张翠屏 针刺治疗脱发880例的临床体会 江苏中医（6），17，1988

27. 脂溢性脱发（油风）

头皮针、七星针法

1. 针具及头皮，常规消毒。七星针叩打脱发处，使头皮发红发热或微有出血为度，叩打后再用鲜姜按揉，然后用28号1寸针快速刺入伏象的头部及肝俞、脾俞、肾俞、膈俞或呼循、伏脏上焦（心肺）、中焦（脾胃）、下焦（肝肾）、或关元。每次选3~6个穴。

2. 1个月一个疗程，每日治疗1次或隔日治疗1次。头皮针每次留针20~30分钟。

共治疗40例。一般患者经1~2个疗程的治疗后，均能在患部长出新黑发茬，患者精神充沛，体质亦有增强。本组治疗40例，痊愈30例，显效8例，无效2例，总有效率95%。

吴健民 头皮针、七星针配姜揉治疗“油风”40例 陕西中医（5），233，1988

28. 褥 疮

针 灸 法

针刺取穴：第一组天枢、肾俞、足三里（均取双侧）、命门。第二组脾俞、关元俞、三阴交（均取双侧）、关元。以上针刺手法均用针补艾灸，每次温灸2壮。

创面用双氧水清洗后再用0.9%生理盐水清洗，患者取侧卧位，然后用艾条灸熏作雀啄食样动作（避免烟灰掉入创面），使局部感到红润灼热即可停止。然后均按外科无菌换药法处理消毒敷料包扎，每日1次，每次针刺各取一组穴位，两组交替使用，10次为一疗程。

共治疗15例。二便能控制自调，褥疮面愈合者为痊愈；二便基本自调偶尔失禁，褥疮面愈合者为好转；治疗二个疗程以上病情变化不大者为无效。

痊愈13例，好转1例，无效1例。其中痊愈者最短时间为10次，最长为30次。

凌泽治 针灸治疗老年性二便失禁伴褥疮15例 陕西中医 (4), 177, 1988

艾烟熏灸法

熏治时病人暴露病灶部位，先用消毒镊子镊取生理盐水棉球，将疮口渗液或脓液拭去，如有脓痂必须除尽。然后将事先准备好的灶式上带弯管的熏灸器（由白铁皮分两部焊接而成，上部如喇叭状，顶端略带弯头，下部如茶缸，中间如炉灶带有炉算）。将艾条放进点燃，待冒浓烟时将熏灸器盖上，让艾烟从熏灸器的上端弯管冒出，对准疮面熏灸，使灼热感向深层肌肉透入。熏灸器与疮面的距离应根据病人的耐受程度而定，每处熏灸5~10分钟，待疮面艾烟油晾干后，用消毒纱布覆盖疮面，胶布固定，以防再感染。每日熏治一次。

本组10例中，治疗两次结痂者5例，三次结痂者3例，五次结痂者2例。

王立峰 艾烟熏灸治疗褥疮10例 中医杂志 (6), 61, 1987

29. 过敏性皮肤病

耳 针 法

1. 取穴

(1) 主穴：肺、内分泌、风溪（荨麻疹区、结节内）、神门。

(2) 辨证加配穴：

①实证加，耳尖、大肠。

②虚证加，肾、肾上腺、枕。

③病久不愈，血虚血瘀者加，膈、肝，耳轮（轮4～6中的敏感点）。

2. 方法：耳尖以5分针速刺放血5～10滴，其余穴位以聚苯耳珠贴压。

3. 疗程：每次取单侧耳穴4～7个，两耳轮流。每周两次，四次为一疗程，休息4～7天，再作第二疗程。

共治疗206例。临床痊愈：在二个疗程内皮疹消退，自觉症状消失，不必服用任何抗过敏的中西药，一个月内无复发为临床痊愈，134例。

好转：经过二个疗程治疗，皮疹减少，自觉不适减轻，或病愈后在一个月内又复发，仍在继续治疗；或在急性期开头1～3天，临睡前配合服一次抗过敏西药而后以耳针治愈者，49例。

无效：急性患者经2次治疗，慢性患者经1个疗程治疗无效，皮疹无变化，改用其他方法治疗者为无效，23例。

王照浩等 耳针治疗过敏性皮肤病206例 广州中医学院学报（4），23，1984

第四节 骨科疾病

1. 踝部骨折并下胫腓分离

经皮穿针法

操作方法：股神经加坐骨神经阻滞麻醉成功后，皮肤消毒铺无菌巾，一助手握持膝关节稍下方并内曲膝关节，另一助手握持足跟足背

使足呈跖屈位对抗牵引，术者两拇指推外踝向内，余指环拉小腿远端向外，此时远端助手在持续牵引力下尽力内翻足背以使骨折复位（如复位不满意可再复位）。用一根2.5mm 克氏针由外踝最高点上2cm，外踝前后径中点刺入皮肤，使钢针与外踝成 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 角，针尾低于外踝中轴线 15° 钻入，钢针尖端达胫骨内侧骨皮质，针尾折弯于皮下0.5cm，无菌纱布包扎。整复后术者用拇指触摸内踝，若不平整，用拇指推挤使其平整，U型石膏夹固定，保持此位。

共治疗35例。根据踝关节的功能恢复及X光片骨折复位情况可分四级。

优：局部无不适，行走正常。踝关节活动度正常，X光片显示骨折解剖对位。

良好：无不适或劳累后偶有酸痛。踝关节活动度基本正常。X光片显示骨折近似解剖对位。内踝骨折片向前后或向下移2mm以内，侧向移位1mm以内，外踝骨折片移位5mm以内，后踝骨折片向后上移位2mm以内。

一般：轻度酸痛，在不平整路面行走时疼痛加重，踝关节活动度有正常的一半。X光片显示内踝骨折片向前后或下方移位3mm以内，侧向移位1mm以内，距骨移位1mm以内，外踝骨折片移位5mm以内，后踝骨折片向后上移位3mm以内。

不良：疼痛较重，行走较为困难，踝关节活动度不及正常一半，X光片显示较上述移位大者。

本组35例中有34例获得随访，最长3年1个月，最短6个月；平均18个月。疗效优者9例（26.5%），良好者23例（64.7%），一般者2例（5.9%），不良1例，是因为术后第二周自动解除外固定导致内踝错位，改为切开复位，占2.9%。

谭庆远等 经皮穿针治疗踝部骨折并下胫腓分离35例 山东中医杂志（2），32，1991

2. 踝关节扭伤

针 刺 法

取穴：以八风穴为主，配用足三里、冲阳穴。

操作方法：一般用23号毫针，取患侧八风穴的1～2个穴位，如肿胀明显者配用冲阳穴，进针的深度达到“针感”（即酸、胀、麻并向足背反射）为宜。待疼痛消失后留针30分钟，每日针刺一次。

治疗89例，均痊愈，其中针刺最少1次，最多7次，痊愈率100%。

陈远发 针刺治疗踝关节扭伤 中国针灸（2），55，1987

3. 肱二头肌长腱滑脱

手法整复结合针灸法

治疗分两步进行，大多先采取耳针疗法，即在患侧耳廓反应点（肩、肩关节、锁骨）的周围寻找敏感痛点，经常规消毒，用（32*1寸）毫针由敏感点直刺或向上斜刺，以不穿透耳廓为原则，进针后行连续捻转手法，当患者感到针刺局部剧痛，而且肩部有温热轻松感时，嘱患者活动肩关节，顿觉疼痛消失或减轻，医者随之进行手法复位。复位后，主要采取局部温针灸或艾条熏灸，每日1次，7次为1个疗程。外伤性滑脱者治疗1～2个疗程即可，习惯性滑脱者视病情轻重一般需治疗2～4个疗程。

手法整复操作是患者正坐，体质较弱者也可仰卧在床上，医者立于患者对侧，用一手拇指桡侧放于肱骨小结节的内侧，手掌固定在三角肌部，另一手握患肢腕部使其掌心向前，肘关节屈曲约20°，然后将患肢内旋至最大限度。此时，术者另一手拇指桡侧向肩的外上方弹

拨一下，同时将患肢作急剧旋前活动。在拇指弹拨时患处可触到摩擦感，听到弹响声，证明滑脱之长头腱已复位。最后用掌根从肱二头肌上部向肩前部方向做理经手法，边理边接，反复做5~7遍。手法整复后，使患肢休息3~7天，习惯性滑脱者休息1~2周，以后逐步增加患肢活动量。

共治疗21例。局部疼痛及肿胀消失，功能活动恢复，1年内不复发者为痊愈；局部疼痛及肿胀基本消失，功能活动恢复，但1年内复发者为有效。痊愈17例（外伤性滑脱者6例，习惯性滑脱者11例），有效4例，总有效率达100%。

何卫等 手法整复结合针灸治疗肱二头肌长腱滑脱21例 浙江中医杂志 (2); 68, 1991

4. 臀肌筋膜炎

踝 针 法

(1) 取穴：针刺区域一般在患肢的外侧，在外踝上约3横指处，分别选择内、中、外三点作进针点。(2) 方法：采用30号1.5寸毫针，嘱患者取卧位，放松肌肉，皮肤消毒后用常规针刺法将针尖刺入皮肤，使针体与皮肤呈30°角，方向以针尖朝痛点，即朝臀部，向上刺入，针尖刺进皮肤即使针自然垂倒并贴近皮肤表面，缓慢推针，不必捻针，不需要引起酸、麻、胀、痛等感觉，若有阻力或有如上感觉，表示针刺入太深，当退针后再提表浅插入。针推入皮下长度在1.4寸左右，留针一般在0.5~1小时，一日一次，重者一日两次。

共治疗30例。痊愈：疼痛完全消失，功能恢复，无阳性体征。好转：疼痛减轻，功能基本恢复。有效：疼痛症状有减，但持续时间较短，一旦停止治疗病情又作。30例患者中痊愈者8例，占26.7%；好转者为20例，占66.7%；有效2例，占6.6%。疗程最长者为半个月，最短者为一次。

5. 软组织损伤

小型负压药酒罐法

(一) 药酒制作: 取防风、荆芥、没药、乳香、白胡椒、骨碎补、当归各75 g, 三七粉30 g, 放入75%酒精 3000ml 中浸泡一个月备用。

(二) 小型负压罐的制作: 将肝精或青霉素瓶底磨去即可。

(三) 治疗方法: 将小负压罐的开口(瓶底)向上, 内装半瓶左右药酒, 并将此药罐贴于患处, 用注射针筒于罐的橡皮盖处抽出空气, 使药罐处于负压状态, 然后纠正体位, 使药罐内的药酒置于皮肤上即可。药酒罐的多少视患部的大小而定, 如损伤部位较大则药罐可在15分钟内移动一次部位, 去罐后也可施加温灸, 这样疗效更佳。

在治疗过程中, 适应针刺的患者, 可先在局部针刺, 也可以用包围式的皮下针, 针尖均指向病处, 留针30分钟, 同时在患处使用药酒罐。

治疗时间: 一般每日或隔日一次, 10次为一疗程。

共治疗134例。经治疗后临床症状消失, 能参加一切体力劳动为痊愈; 临床症状消失或减轻, 但劳动后或负重后仍稍有疼痛为好转; 经30次治疗后临床症状无明显改善者为无效。

男性52例中痊愈45例, 好转5例, 无效2例; 女性82例中痊愈56例, 好转23例, 无效3例, 合计134例, 总有效率为96.27%, 无效占3.73%。

盛振华 小型负压药酒罐治疗软组织损伤134例 浙江中医学院学报 (1); 54, 1988

空气痛点封闭法

在病损部位找出1个或数个明显压痛点，固定体位，压痛点局部皮肤常规消毒，以无菌注射器及5~7号注射针头，在盛有少量95%酒精的加盖瓶内抽取适量空气，刺入压痛点，经提插捻转，找到针感后，回抽无血，据病损部位肌肉厚薄，注入1~30ml空气，拔针后立即按压针眼并给以适当局部按摩即可。一般每次1~2个点，每个压痛点均按上述方法注气。注射完毕后可立即让病人活动病损部位。未愈者每隔1日注射1次，再治疗1~3次。

共治疗73例。以症状完全消失、活动自如为治愈；疼痛明显减轻、活动尚有轻度痛感或不适为好转；经治疗1次症状无改善为无效。本组73例中，经1次治愈者32例，2次治愈者32例，3次治愈者6例，1次治疗好转中断治疗者2例。2次治疗好转，中断治疗者1例，总有效率100%，治愈率95.89%。

李吉祥 空气痛点封闭治疗软组织扭挫伤73例 陕西中医 (10); 506, 1990

针刺结合点穴法

针刺取穴及手法：取患侧中渚穴，用28号1.5寸毫针局部常规消毒后，斜刺（45°进针），进针深度约1寸，得气后采用强刺激泻法，留针5分钟。留针期间嘱其患部多姿势活动，幅度由小到大，以局部疼痛消失或缓解为度。2点穴取穴手法：点拿腰阳关、气海俞、天宗、风池；推揉华佗夹脊；点曲池、列缺、合谷、中渚、太溪以行气活血。背法、颠法、扳法以活利局部关节。

上法每日一次，病情严重者可一日两次。

共治疗100例。痊愈：疼痛消失，局部活动自如，无不适感。无效：治疗后症状如前或经多次治疗症状缓解后复发如前。

100例患者中，痊愈97例，无效3例，治愈率为97%。疗程最短

者1次，最长者5次。其中1次而愈者54例，2次而愈者31例，3次而愈者8例，5次而愈者4例。平均疗程1.5次。一般病程短者见效快，病程长者见效慢，年老体弱者效差。

毛育民 针刺结合点穴治疗急性软组织扭挫伤100例小结 江西中医药 (4); 39, 1990

6. 颞下颌关节功能紊乱症

药 罐 法

1. 取穴：下关、颊车。

2. 方药：伸筋草60g，钻地风60g，威灵仙60g，三七30g，木瓜120g，白酒2500ml，浸泡二个月后备用。

3. 操作：将药酒约5ml倒入磨去底的青霉素样式小瓶中，底边缘用凡士林涂拭后，以便与皮肤密切接触，将小瓶置于穴位上，用注射器抽出瓶中空气，使其形成负压，使药液与皮肤完全接触，放置20分钟，隔日1次，10次为1个疗程。

共治疗50例。痊愈：自觉症状完全消失，开口度正常，关节区及其周围肌群压痛、关节弹响消失者。

显效：症状体征基本消失，仅留有轻度关节弹响或张口大时有不适感者。

有效：症状体征有好转，但未能全部消失者。

无效：症状体征治疗前后无改变。

接受治疗的50例患者中，痊愈12例，占24%；显效17例，占34%；有效19例，占38%；无效2例，占4%。总有效率为96%。

金蕙芬等 药罐治疗颞下颌关节功能紊乱 上海针灸杂志 (3), 29, 1987

针 刺 法

采取坐位或卧位。取穴：以下关、听宫、合谷为主，颊车、安眠

为辅。原则上采用泻法（时间长的用平补平泻手法）。留针30分钟、留针期间每5~10分钟捻针一次。也可在得气的基础上接G6805治疗机（接下关、听会或听宫、颊车），用疏密波形通电20分钟，刺激强度以患者能耐受为度，由于患者很快产生耐受，故应不断调整强度。局部发凉的患者还可在针上加灸。一般每日一次，症状减轻隔日一次，七次为一疗程，疗程间休息一周。

共治35例。痊愈：症状完全消失，功能恢复正常。

显效：两种症状均消失，功能基本正常。

进步：疼痛减轻或一种症状消失，功能较前好转。

无效：治疗后无改变者。

在针刺得气的基础上可接G6805治疗机（个别针上加灸）治疗的35例患者痊愈30例，显效2例，进步3例（治疗不足一疗程而中断）。本组病例在六次以内治愈者24例，一般是颞颌部疼痛先消失，张口度恢复正常（可容3指尖），弹响声后消失，有的病例三种症状同时消失。

丁金榜 针刺治疗颞下颌关节功能紊乱症35例 陕西中医（1），38，1988

7. 落 枕

针 刺 法（一）

取患部压痛点、落枕穴（握拳手背2、3掌骨间，掌指关节后半寸处），均用泻法，留针20至30分钟。每天1次。

共治170例。160例针1次告愈，10例针2次告愈。痊愈率为100%。

周连仲 针刺治疗落枕170例 中国针灸（4），8，1987

针 刺 法（二）

取双悬钟穴（又名绝骨）。让患者坐在靠背椅上，放松全身肌

肉，暴露穴位，常规消毒后，用1.5~2寸毫针垂直刺入1.5~1.8寸。根据病人体质，分别采用强刺激或中强刺激手法，使之产生明显的酸、麻、胀、沉感。如能使针感上行过膝关节效果更佳。留针15~20分钟，每隔3~5分钟行针一次，行针时嘱患者前后左右转动头颈部，活动范围由小逐渐加大，多数患者当场可愈或明显好转。

共治44例，均获满意疗效。

谷瑞起 针刺悬钟穴治落枕 山东中医杂志 (2); 53, 1990

8. 肩臂痛

针 刺 法

主穴：极泉上穴。(1) 部位：在腋横纹上2寸。(2) 穴位取法：让病人仰卧，患肢屈肘，手掌置于胸前，从腋横纹直上2寸，稍向内2分许即是穴。(3) 针刺手法：用三寸毫针迅速刺入皮下后，以捻转手法进针，达2寸至2寸半时，停止捻转，行轻慢提插手法，待有触电样感觉沿上臂放射至五指时是为达到治疗目的的现象。并留针30~50分钟，中间行针一次。如病人没有感觉，须将针稍向四周轻微提插深刺，以达上述感觉为止。针刺该穴不要刺之过猛，以免伤及内脏或主要神经和血管。其他配穴的手法同一般针灸手法。

配穴选择：肘中痛难屈伸，手不可举重加曲池；臂膊疼痛加肩髃、手三里、外关；肩胛背部疼痛加天宗、肩外俞、曲垣、肩贞等。

共治50例，疼痛全部消失，患肢上举、外展未有不舒，活动自如，并恢复工作者为痊愈。

疼痛全部消失，上肢活动自如，只有上举及外展时稍有酸困者为有效。

症状有不同程度改善者为好转。

50例患者，痊愈29人；显著好转者13人；好转者8人。

郭耀康 针刺“极泉上穴”治疗肩臂痛50例疗效观察 山西中医

9. 肩关节周围炎

针 刺 法

1. 取穴位置: 中平奇穴位于足三里下一寸, 上巨虚穴上二寸处。
2. 针刺手法: 采用3—5寸毫针(28号), 行直刺法、大幅度的用力提插捻转、以泻为主。待针感具有向上、向下传导得气为宜。同时令病人活动患肢, 做上举、外展、内旋等功能锻炼。对体虚久病患者手法宜补泻结合以泻为主。
3. 留针与疗程: 对急性期因疼痛引起的功能障碍, 没有形成严重粘连, 针刺后很快疼痛消失, 功能正常可不留针。对后期粘连引起的功能障碍, 可留针20—30分钟, 五分钟行针一次, 七次为一疗程。
4. 针刺方法: 巨刺法, 左肩针刺右侧穴位, 右肩针刺左肩穴位, 双侧针刺双侧穴位。

共治疗345例。临床治愈, 临床症状消失。肩关节功能恢复或基本恢复正常, 并能参加工作劳动。显效, 临床症状基本消失, 疼痛明显减轻, 肩关节功能明显改善。好转, 临床症状改善, 肩关节范围加大, 疼痛减轻。无效, 临床症状无变化, 疼痛未减轻, 功能未改善。

临床治愈255例, 显效49例, 好转38例, 无效3例。其中一针治愈68例, 占19.7%。

王文远等 针刺中平奇穴治疗肩关节周围炎345例临床疗效分析
中医药学报 (6); 25, 1988

针刺配合红外线法

1. 肩臂后廉痛, 怕凉喜温, 臂不能后屈, 伴中指、无名指、小指麻木者, 多属手少阳三焦经病, 取肩髃、中渚、外关为主穴, 配肩髃、天泉、阳池。手法用平补平泻。

2. 肩臂外廉痛、酸楚、麻木或后屈、平抬臂受限者，多属手太阳小肠经病。应以臑俞、肩髃、肩外俞、肩中俞为主穴，配肩贞、外关、养老、后溪。

3. 肩臂前廉伴内廉痛引肘腕，肩臂前，平抬或后屈受限，肌肉萎缩，属手阳明大肠及手三阴经病。取肩髃、肩内陵、臂臑为主穴，配手三里、列缺、内关透外关。手法用平补平泻。以上诸穴针刺治疗得气后，同时配合红外线照射15~30分钟，10次为一疗程。

共治疗293例。经三个疗程，症状完全或基本消失者为痊愈，共182例，占62.12%。经二至三个疗程，症状明显减轻或部分症状消失者，为显效，共55例，占18.77%。经二至三个疗程，症状部分好转者为好转，共48例，占16.38%。经二至三个疗程，主要症状稍好转，但疗效不巩固者为无效，共8例，占2.73%。总有效率达97.27%。

阎国瑞 针刺配合红外线治疗肩关节周围炎293例 中国针灸 (1), 20, 1986

火 针 法

取穴为肩髃、肩前、肩后、天宗、臂臑、曲池。每次选其中3~4穴。针刺时，嘱患者侧卧，医者左手持酒精灯，右手持火针柄，针头向下，在灯焰上烧红后迅速刺入穴内5分至1寸深，并即刻敏捷退针，然后用干棉球揉按针孔。若活动受限，不能上举、外展、后伸者，加用毫针针刺对侧条口透承山；痛剧者，加用毫针针刺同侧扶突。多数患者针后即感显效。隔日1次。6次为1疗程。

共治疗290例。经治后220例痊愈（症状消失，肩关节功能恢复正常），56例显效（症状基本消失，疼痛明显减轻，肩关节功能显著改善），14例有效（症状改善，疼痛减轻，肩关节活动较前进步）。

袁清顺 火针治疗肩关节周围炎290例 浙江中医杂志 (10), 460, 1989

水 针 法

1. 取穴：主穴为肩髃、肩前、天宗、曲池。合并颈椎病者加大

椎夹脊、伴肌肉萎缩或臂部疼痛者加臂臑均取患侧。

2. 用药：黄芪注射液 4 ml（若无黄芪，可使天麻注射液 4 ml 代替），复方当归注射液 4 ml，胎盘组织液 2 ml，上药混合后注入以上穴位。妇女月经过多者，待经期过后再进行注射。

3. 操作方法：穴位局部常规消毒。用 10ml 注射器，5 号局麻针头，药液摇匀后分注于以上穴位。肩髃、肩前、臂臑斜刺进针，天宗、曲池直刺进针，深度均为 1 寸 2 分，大椎夹脊进针 5 分。进针后如无回血，即轻轻提插，待得气后，再把药液注入各 2 ml 左右。

隔日一次（首次治疗后，部分患者局部出现酸胀不适，或有低热等反应，但在穴注第二、三次后，即无此现象）。10 次为一疗程，一般需经 1～2 疗程。

共治 234 例。痊愈：疼痛消失，关节活动基本恢复正常。

显效：疼痛显减，上举达 160° ，后伸 $<45^\circ$ 内旋时手指能触及第一、二腰椎，内收基本恢复正常。

有效：疼痛减轻，上举 $>120^\circ$ ，后伸 $>30^\circ$ ，内旋时手指能触及第四腰椎，内收接近正常。

无效：症状及活动功能均无改善。

钱忠顺 水针治疗肩凝症 234 例 南京中医学院学报 (1)，40，1991

针刺配合隔姜灸法

取穴：患侧肩髃、肩贞、臂臑、合谷、外关、中渚，用毫针强刺激使其得气，不留针，每次选 3～4 穴。针刺后，取厚约三分的新鲜姜片一块，用针在姜片上穿刺数孔，置艾炷放在穴位上，点燃施灸。如患部灼热，可将姜片提起，稍后再灸，直至皮肤潮红湿润为止。一般每次灸 3～5 壮。对病程较长、疼痛较甚者，可增加到 10 壮。每天 1 次，10 次为 1 疗程，治疗 1 疗程后，休息 2 天，继续治疗。

治疗 187 例中，临床治愈 121 例（疼痛完全消失，手臂上举、外展及后伸活动自如）；显效 41 例（肩关节功能恢复，疼痛消失，但肩

部还有酸困感觉)；好转25例(疼痛减轻)。

杨庆林 针刺配合隔姜灸治疗肩周炎187例 湖北中医杂志(6)；
35, 1987

红外线温针法

1. 针刺组：因该病主要是邪阻经络，气血凝滞，故以疏通经络，散风止痛、调理气血、通利关节为治则，采取痛点(局部)取穴、循经取穴和经验取穴相结合，因证施以泻或平补平泻针法，留针20分钟，其间行针三次。

局部痛点取穴：肩髃、肩贞、肩髃、天宗、臂臑。循经取穴：曲池、中渚、养老。经验取穴：条口透承山、阳陵泉透阴陵泉、手三里。

2. 红外线组：主要目的在于改善血液循环及代谢，消炎止痛，缓解肌痉挛。采用福州产立式碳棒红外线灯，功率500W，灯距40厘米，肩部照射。

3. 温针组：上两法结合，针刺后加红外线照射温针。

按照“其痠坚，转引而行之”的治则，为防止粘连，均于治疗后辅以肩部功能锻炼。

三组均每日治疗一次，每次20分钟，12次为一疗程。

痊愈：疼痛消失，肩关节运动恢复正常；

好转：疼痛明显减轻，肩关节活动度增加，功能有改善；

无效：疼痛无减轻，肩关节运动功能无改善(包括治疗后自觉舒适，但次日如故，二个疗程仅有缓解但收效甚微者)。

共治疗150例。温针组50例，治愈33例，占66%；好转17例，占34%，无效0。针刺组50例，治愈11例，占22%，好转34例，占68%，无效5例，占10%；红外组50例，治愈4例，占8%，好转29例，占58%，无效17例，占34%。

公 平 红外线温针治疗肩关节周围炎150例疗效观察 中国针灸 (4)；20, 1987

温和灸法

针刺患侧之肩髃、肩贞、肩前、曲池后，用二支艾条同时施灸，或将1寸长艾段置于针柄上施灸，连续灸4段，使整个肩部肤红热透，最佳者是使热感徐徐下行、达于手腕。每天1次，10次为1疗程。

共治疗80例。经治1~4疗程后，80例中39例痊愈（肩关节功能恢复，疼痛消除），32例显效（肩关节功能明显改善，能上举150度以上，有时轻微疼痛），7例好转（肩关节功能障碍改善不明显，但疼痛减轻），2例无效（肩关节疼痛及功能障碍均无改善者）。

陶首业 温和灸为主治疗八十例肩周炎 浙江中医杂志 (10), 450, 1988

药棒点穴法

药液的配制 将乳香、川乌、红花、细辛、田三七等药物按一定比例浸泡在市售白酒内，10天后去渣取汁瓶装备用。

药棒制作 用桑枝或九里香等树枝，制成长约一尺左右，直径为1.5cm~3cm粗细不等的药棒。可根据治疗时不同部位制成圆形、扁平形等不同形状，亦可在一端制成锥状。

叩击方法 以右手拇指，食指持药棒蘸药液在穴位叩击。随干随蘸。根据病情轻重、穴位肌肉的厚薄、病人体质，反应的敏感程度，可采取不同的叩击手法：

①平叩 以扁平状或圆状药棒叩击。特点是接触面大，适宜疼痛较剧、关节僵硬较重、肌肉丰厚的穴位，体质强壮、反应不太敏感的病人等。

②点叩 以小圆状的药棒叩击。特点是接触面小，刺激较强。适用于病人体质较弱，体瘦、骨关节中的穴位、反应较敏感的病人。

③直叩 以药棒末端（或制成锥状），直接撞击穴位。特点是用

力较重，接触面小，适用于体质强壮，肌肉特别丰满的穴位（如环跳穴）或者经点叩、平叩无明显反应，病人又能耐受的情况。但只宜叩击数下或数十下，不宜较长时间使用。上述各法可单一使用，亦可混合使用，以病人能耐受又有疗效为度。

穴位选择 多选用肩髃、肩髃、肩前、巨骨、秉风、肩井、臂臑、曲池、肩贞、天宗、阿是穴等，另外还可以痛为俞。

叩击次数和时间：一般病人壮实，病情较重的每穴叩击180~200下。病人体弱、体瘦、病情较轻每穴叩击90~100下。每日治疗一次，一次选2~3个穴位，次日更换一组穴，交替使用，连续治疗。7次为一个疗程。

共治疗132例。患者经过一次治疗，疼痛、僵硬均明显减轻。少数因关节僵硬不能活动，经一次治疗可外展90°甚至可梳头。132例中，近期治愈：疼痛消失、关节功能恢复96例，占72.73%。显效：疼痛减轻、关节活动度增加36例，占27.27%。有效率100%。无一例无效。经一个疗程治疗者110例。经两个疗程治疗22例。

晏建立 药淬点穴治疗肩周炎132例介绍 湖南中医学院学报(4); 240, 1990

针刺加火罐法

取穴：肩三针（即肩髃、肩前、肩后）、臂臑、曲池。上举困难者加商阳，后伸困难加中渚。治疗：用28号1.5寸毫针直刺1—1.5寸，行平补平泻，留针20分钟，起针后，在针刺穴位处拔罐10分钟，取罐后让患者自己活动肩部，必要时可协患者活动。活动方法：上举：患者两手交叉，健手带动患肢向头顶活动；后伸：健手握住患肢腕部向对侧肩胛下角方向活动；内收：健手协助患肢向对侧肩部做内收搭肩动作；外展：做外展外旋划园式活动；嘱患者按此法锻炼，每日二~三次；针刺隔日一次，十次为一疗程。

共治疗90例。痊愈：肩关节疼痛消失，功能活动完全恢复正常。显效：肩关节功能接近正常，但有时仍有轻度疼痛者。好转：肩关节

活动进步，疼痛减轻。无效：治疗前后症状无明显变化。

90例中，治愈62例，占68.9%；显效9例，占10%；好转10例，占11%；无效9例。

刘英茹 针刺加火罐治疗肩周炎90例 陕西中医函授 (1)，87，1990

针 刺 法

1. 取穴：肩贞、肩前（肩内陵）、肩髃、肩井、手腕（踝）针（根据疼痛的所在部位而选其区）。

2. 操作方法：患者取舒适的位置，用2寸毫针刺入肩贞、肩前穴约1.5寸，使患者的局部有较强的酸麻胀感，并向前后臂和手指放射。再用3寸毫针自肩髃穴进针，向下斜刺约2.5寸，以肩关节及上肢有较强的酸麻胀重感为度，肩井穴用1寸毫针向下刺入约5分即可。另外，根据疼痛的部位选用患侧的手腕（踝）针，用2寸毫针向上平刺约1.5寸。各穴针后，隔5分钟行针1次，留针30分钟，或接通626电针疗机，时间为20~30分钟。每日1次，6~10次为1个疗程，休息6天后，不愈者可进行第2疗程。

疗效标准 临床治愈：疼痛消失，上肢活动自如，1年内无复发。显效：疼痛消失，上肢活动仅有部分受限，1年内多有复发，但在用法上治疗效果仍然较好。有效：疼痛减轻，但上肢活动仍受限。无效：疼痛及上肢活动无改善。

治疗结果 临床治愈46例，显效19例，有效10例，其临床治愈、显效率达86.7%。

呼婵玉等 针刺治疗漏肩风75例 陕西中医 (10)，463，1989

穴位注射法

取患侧手三里穴，注射前先按揉3~5分钟，寻找准确的压痛点，消毒，直刺行针，待得气后缓慢推入安痛定（山东新华制药厂出

品，每支2 ml，批号：870314-1) 1~2 ml，此时患者局部酸、胀、麻感觉加重。穴位注射每日1次，3日后改隔日1次，7次为1疗程。如未愈者，间隔3日后进行第2疗程。对病程日久者可加服中药配合治疗：党参、茯苓、秦艽各15 g，红花、桂枝、木瓜各10 g，当归、大枣各9 g，按病情酌情加减，每日1剂，水煎服。5~7剂为1个疗程。

共治疗74例。临床治愈：临床症状及体征全部消失，肩关节活动完全恢复正常者；好转：临床症状及体征缓解，肩关节活动功能部分改善者；无效：用上法治疗后，症状体征未见缓解者。结果：经2个疗程治疗后，本组74例中，痊愈者54例（其中第一疗程痊愈41例），好转18例，无效2例。

李浩琦等 安痛定手三里穴注射治疗肩周炎74例观察 中西医结合杂志 (6)；350, 1990

10. 肱骨外上髁炎

针灸加局封法

取阿是穴，采用旁针刺，即先直刺一针，再于此针旁约0.5 cm处斜向痛点加刺一针，另取配穴曲池。行针得气后，均施以捻转泻法，再施以温针灸，即用1 cm许长的艾条，套置于针柄上，点燃靠近皮肤一端，使皮肤潮红不损伤为度，留针30分钟。出针后作局部封闭，令屈曲患肘，用醋酸确炎舒松-A 10 mg加1%普鲁卡因2 ml混合，于肱骨外上髁下1 cm处斜向刺入最痛点，当局部出现胀重，抽吸无回血，即将药液缓慢注入（若注射时阻力较大，可稍退针后再注入）。隔日复诊，肱骨外上髁处仅轻微压痛，继用上法针灸1次，以后再隔日1次。

如上治疗共173例，患病右肘116例，左肘45例，双肘12例。针刺配穴也可用肘髁，局封注射液醋酸确炎舒松-A用量可5~10 mg，

也可用醋酸强的松龙12.5~25mg, 并加1%普鲁卡因1~2ml, 注射药量可根据病灶范围的大小而定。针刺隔日1次, 10次为1疗程。局封每周1次, 3次为1疗程。在1疗程内, 135例治愈(患肘活动正常, 无压痛, 1年内未复发), 26例显效(活动时疼痛基本消失, 局部无明显压痛, 但端提重物时尚有酸重感), 12例有效(活动时疼痛减轻, 局部仍有轻度压痛)。

汪洪明 针灸加局封治疗肱骨外上髁炎173例 浙江中医杂志 (3); 117, 1991

上病下刺法

垂足取同侧阴上穴(在阴陵泉上方1.5寸处, 股骨内髁之高点下方, 内膝眼与腘窝横纹头联线之中点处, 属经外奇穴), 找到敏感点。常规消毒后, 用1寸毫针快速刺入穴位, 针尖向上斜刺, 得气后留针30分钟, 每日1次。留针5分钟后令患者前臂做内外旋转、握拳动作。如病人感觉疼痛减轻大半或疼痛全部消失, 则证明穴位已取对。

治疗64例, 其中1次治愈(肘关节疼痛及其它症状全部消失, 活动恢复正常)者54例; 2次治愈者8例; 3次治愈者2例, 总治愈率为100%。

侯士文 上病下刺法治疗肱骨外上髁炎64例 广西中医药 (1); 24, 1991

针 刺 法

主穴: 曲池、手三里、合谷、肘髁、肘部压痛点。

配穴: 天井、外关、中渚、尺泽、列缺。

操作方法: 令病员仰卧或正坐, 屈肘拱胸。针具和刺穴均以常规消毒。每穴刺入1寸左右, 得气后用捻转配合提插的泻法。留针30分钟, 起针后, 再以枣核大的艾柱隔姜灸3~5壮, 如灸穴部位过热而难

以忍受时，可将姜片顺经上下移动，以免灼伤皮肤。每日治疗1次，6次为1疗程。

共治疗52例。痊愈：肘关节区疼痛及其它症状全部消失，活动正常者；显效：肘关节区疼痛及其它症状基本消失，活动正常，但紧握拳时肘关节区尚有酸痛感者；好转：肘关节区疼痛明显减轻，活动灵活，但劳动时仍感乏力酸痛者；无效：经治疗症状无改善或未坚持治疗者。

52例患者中，痊愈25例，占48.07%；显效19例，占36.53%；好转6例，占11.53%；无效2例，占3.84%。总有效率为96.15%。

梅忠英 针灸治疗肱骨外上髁炎52例 上海针灸杂志 (3), 28, 1987

温针加艾炷灸法

取穴：右曲池，手三里及曲池穴后上方、前下方各一寸处两穴。

方法：患者正坐伏案，屈肘，前臂内收。用28号1.5寸毫针，曲池、手三里穴直刺、曲池的后上方、外下方一寸处各下一针、向肱骨外上髁方向斜刺。进针后行捻转提插手法，得气后平补平泻，然后剪艾条0.5寸长置于曲池、手三里两穴的针柄上，每针灸2壮，留针20分钟，起针后再在肱骨外上髁，环状韧带，肱桡关节间隙部位摸准压痛点，局部涂凡士林少许，将细艾绒搓成直径1.5cm、高1.5cm的圆锥形艾炷，置于其上灸之，每次5壮，至局部皮肤潮红，每日1次，5—7天为一疗程，每疗程休息3—5天。

本组20例，痊愈（疼痛消失，无压痛，握力正常，一年内未复发）12例；显效（疼痛显著好转或不痛，压痛不明显，握力基本恢复，半年以上无明显症状）7例；无效（局限性疼痛依然，握力无改善）1例。其中疗程最短3次，最长3个疗程，一般为1—2个疗程。

沈美兰等 温针加艾炷灸治疗肱骨外上髁炎20例 湖南中医学院学报 (1), 72, 1991

11. 肘关节骨化性肌炎

扬 刺 法

局部皮肤常规消毒后，用28号2寸毫针在肘关节硬性肿物的中央直刺1.5~1.8寸，然后再在肿物的边缘上下左右各刺一针，待上述5针得气后，轻插重提，快速捻转，不留针，出针时摇大针孔。起针后选口径适中的火罐（火罐口径以能扣住五个针孔为佳）用闪火法拔罐8~10分钟，以出血为宜，起罐后常规消毒去污即可。不需服药及外敷药。嘱患者每天加强肘关节的屈伸和内外旋转功能锻炼。每1~2天治疗一次，10次为一疗程。

治疗58例，经上法治疗1~2个疗程，肘关节功能活动完全恢复正常，X线摄片复查骨化阴影消失。

彭启琼 扬刺治疗肘关节骨化性肌炎58例 江苏中医 (10), 17, 1989

12. 腕管综合征

针 刺 法

1. 取穴：主穴取大陵，配穴取合谷、二白、外劳宫。视病情及症状选用配穴，每次取穴1~3个。2. 操作：大陵用轻刺激手法，针尖向腕管内刺入；合谷、二白、外劳宫中强刺激手法。均以有酸麻胀感为度。留针15分钟，每5分钟捻转1次。每日针治1次，连续3次为一疗程。

共治疗40例。痊愈：手指麻痛完全消失，腕关节活动功能恢复正常，能进行日常工作无不适感；进步：手指麻痛基本消失，腕关节活

动功能有所恢复，能进行日常工作仅有轻度不适感；无效：治疗3个疗程以上，症状未见改变者。

本组40例中，痊愈23例，进步14例，无效3例，总有效率为92.5%。

马庆林 针刺治疗腕管综合征40例 陕西中医 (3)，133，1988

13. 腱鞘囊肿

火 针 法

右手持血管钳子，挟住三棱针，呈注射姿式，拇、食、中指扣住钳子。左手拇、食指挤住囊肿，将内容物推至一边，避开血管，使囊肿突起，将三棱针在酒精灯上烧红，对准囊肿迅速刺入深部，快刺快出针。两手持干棉球在针孔周围挤压，放出胶状粘液，挤压干净。用酒精棉球擦干消毒后再用挤干酒精棉球压迫包扎。3日内不要沾水，8日后取下敷料即愈。

治疗效果：160例中共治疗169次，1次治愈者152例，两次治愈者7例，3次治愈者1例，160例全部治愈，追访2~3年未见复发。在治疗中无1例感染。

注意：1.将针烧红，迅速刺入，则不感觉疼痛，若不烧红刺入，疼痛难忍。

2.针刺入要深刺到囊肿基底部。较大的囊肿浅刺表皮，虽然挤出粘液，但可能复发。同时也不可过深，避免刺伤骨膜和血管。

3.囊肿过小不明显，又在深部不宜用火针治疗，以免刺不到囊肿，达不到治疗目的。过小的可用毫针治疗，亦可待长得稍大后再用火针治疗。

赵怀儒等 火针治疗腱鞘囊肿160例 中国针灸 (1)，16，1986

指针疏导法

指针疏导法，即指针按压疏导法。系医者以拇指（小囊肿用一拇指）大囊肿用双拇指）指腹代针按压在囊肿上，其余四指握住患者肢体，由小到大地均匀加力揉挤，呈螺旋形疏导，当指下感到囊肿较前变软时，便猛加指力，挤压囊肿，至指下有囊肿破溃感受时，再由大到小地均匀减力，并以囊肿中心为圆心，向四周作划圆状揉按疏导患部60~70次，令囊液均匀分布于组织之间，以利囊肿迅速消散和囊液被完全吸收。

治疗腱鞘囊肿53例，其中原发性腱鞘囊肿25例，复发性腱鞘囊肿28例。除在治疗中突加指力猛压囊肿至破溃时，患者觉局部胀痛（一般均能忍受）外，治中及治后无其它任何不适。囊肿破溃后，肿物旋即消散，酸胀疼痛顿即消失，腕（踝）关节立即活动自如，用力有劲。53例均为一次性治愈，经一年随访，无一例复发。

邓世发 指针疏导法治疗腱鞘囊肿53例疗效观察 北京中医（5），40，1988

针 刺 法

腕关节部位囊肿，患者取正坐位，屈肘平腕；踝关节部位囊肿，取正坐位，屈膝平足或侧卧位伸足。局部常规消毒，医者持30号毫针沿囊肿边缘，等距离进4针，针尖要相互接触，角度为针斜，不超15度。第5针直刺囊肿中央，针尖须深达囊肿基底部，留针30分钟，每隔10分钟，以轻度手法捻针一次，有针感即可，每日针刺一次。

治疗效果：本组17例中，有13例针刺5~9次囊肿消失，针刺10~13次后17例全部治愈。

杨熙萍 针刺治疗腱鞘囊肿17例 中国针灸（3），12，1986

针刺加隔姜灸法

先将囊肿部位皮肤常规消毒，继用不锈钢针呈三角形扎进囊肿

内，以强刺激手法，然后在囊肿上用一块生姜盖上，再用艾条在姜上熨灸，每次治疗20~30分钟，拔针后，将囊肿向四周挤压，使内容物溢出囊外，最后将患处包扎，每天或隔日治疗1次。

共治疗12例。治疗3次痊愈者3例，治疗7~10次痊愈者8例，治疗16次痊愈者1例。2个月复发者1例，继续治疗获愈。

易珍瑜 针刺加隔姜灸治疗腱鞘囊肿12例 湖南中医杂志 (3)，29，1991

14. 腰软组织伤痛

走提罐法

1. 体位：病人俯卧，暴露腰肌或找出痛点。

2. 操作：火罐以玻璃罐或罐头瓶均可，罐口壁需宽，应涂上薄薄的凡士林一层。先用毛笔蘸上冷开水，由上向下在腰部皮肤上涂抹。然后两手操作，左手拿罐，右手握持针器，夹上95%酒精纱布或棉团，火柴点燃后，用闪火法，当火罐吸紧后，从上向下移动火罐约2cm，即速将罐向上提，提到一定程度，火罐倾斜走气即取下。再顺接上次部位，照前法操作，每日1次。第2天可以从上向下，或从脊柱向两侧拔之，或绕疼痛点拔之亦可。

3. 疗程：每日1次，5次为1疗程，疗程间休息2天，2疗程后疼痛不减为无效。

共治疗100例。疼痛在第1疗程后消除者34例，第2疗程后消除者28例，占62%；明显好转38例，占38%；全部有效。2个月后随访，仅复发8例。

王祥福 走提罐法治疗腰软组织伤痛100例 陕西中医 (1)，35，1989

穴位注射法

采用丹参注射液和黄芪注射液各1支（规格均为10 ml/支，含生药1克/ml），抽取混合后以9号长针头作痛点深部注射。对梨状肌综合征患者为治疗，进针后凭下肢有无“触电样”感觉而加以证实深度是否已经到位，然后适当提起0.2—0.5cm，将20ml药液一次推入。腰部痛点注射者先以针尖探得椎板或横突等骨性标志，然后亦将针提起0.2—0.5cm，快速推入药液。因腰部软组织损伤，常可在腰3—5椎旁横突、横突与棘突间、骶髂关节上缘或腰骶关节处查及多处压痛点，治疗时当根据具体情况将药液分成2—3点注入，一般3天1次，3—4次为一疗程。

共治疗43例。痊愈（症状和体征全部或基本消失，恢复正常工作）23例，占53.5%；好转（疼痛等主要症状和体征基本消失，恢复原工作，但需减轻工作量）14例，占32.6%；无效（症状、体征无明显改善或加重者）6例，占13.9%。

43例共进行了401次532个痛点注射，无一例发生感染或出现局部硬结。注射后部分患者短时间内有局部胀痛。1例共行6次治疗，在第2次注射过程中感头昏、出虚汗，经卧床休息15分钟好转。

董亦明等 丹参、黄芪注射液治疗软组织性腰腿痛43例临床小结
江苏中医 （2），27，1988

15. 梨状肌综合征

针 刺 法

主穴：环跳、秩边、居髎（或臀部压痛点）。配穴：疼痛沿下肢外侧放射者，加阳陵泉、丘墟；疼痛沿下肢后侧放射者，加委中、昆仑；疼痛沿下肢前面放射者，加足三里；腰痛者，加相应背俞穴。方

法：环跳、秩边穴深刺2—3寸，运用提插法使酸麻感向下肢放散，居髂或臀部压痛点针刺手法宜重，使得气感向四周扩散，针后拔火罐；肢体阴寒怕冷者加温针灸1—3壮；疼痛剧烈者，加用电针，刺激强度适中。每日针治1次，疼痛缓解后隔天1次。

共治疗100例。痊愈（症状和阳性体征消失，行走自如）61例，好转（疼痛缓解，梨状肌压痛减轻，下肢活动有改善）39例。

严金保等 针刺治疗梨状肌综合征100例临床小结 江苏中医（7），21，1988

刺 血 法

先取“以痛为俞”，常规消毒后，针具选用梅花针，操作时右手握针柄的后段，食指压针柄中段，使用手腕之力在压痛点最明显处反复进行叩刺，待皮肤微出血时，再加火罐帮助瘀血外排，留罐15~20 min。起罐后根据“循经取穴”的原则，在患部下肢委中穴处用三棱针点刺出血，待黯色血排净，见红赤血时即将消毒棉球按压在针孔上。隔天1次，7次为1疗程。

共治疗35例。痊愈：患肢疼痛消失，恢复正常工作；显效：疼痛基本消失、患肢功能有显著好转；好转：患肢疼痛减轻，功能障碍有所改善；无效：刺血治疗后患肢疼痛及功能障碍均无改善者。痊愈20例，显效11例，好转4例，治疗最少者3次，最多者14次，一般3~7次，即可控制疼痛。

包贵兆 刺血治疗梨状肌损伤综合征35例 陕西中医（2），557，1990

16. 腰椎肥大性脊椎炎

热 针 九 宫 法

1. 腰椎“九宫穴”取穴法：自T₁₂—S₁沿脊椎自上至下仔细压

诊，寻找最明显的压痛点，参阅x线摄片或CT片，确定病变椎节。以压痛点最显著的病变椎节棘突间定为中宫，沿督脉在中宫上下棘突间各定一穴，分别称为乾宫、坤宫，然后挟乾宫、中宫、坤宫旁开0.5—0.8寸，依次取巽、兑、坎、离、艮、震六宫穴。因取穴定位是按伏羲八卦九宫方位图，故称腰椎九宫穴，简称九宫穴。

2. 九宫穴的针刺方法 根据中宫定位，采取俯卧位或侧卧位。进针时应尽量使中宫部位棘突突起，椎间隙加大，以利于进针。进针顺序为：先针中宫，次针乾、坤宫，直刺或略向上斜刺0.8~1.2寸，然后按巽、兑、坎、离、艮、震六宫穴依次进针，针尖斜向椎体，进针1.5~2寸，获得针感后，行捻转补泻手法，九宫穴的行针顺序与次数，按“络书九宫数”施行，即“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，而五居中。”。一度行针后，坎、离宫加用热针，应用GZH型热针仪，热针温度指示40°~70℃，留针20分钟。

3. 配合穴位注射：主选药物：复方丹参2ml，加复方当归2ml混合液；辅助药物：醋酸强的松龙混悬液1ml（25mg）与2%普鲁卡因2ml混合液。巽、兑宫或艮、震宫，每穴注射1ml。

共治疗82例。显效：症状消失，肢体活动自如；肥大性腰椎炎合并坐骨神经痛者，直腿抬高试验达70°以上，恢复正常工作，56例。好转：症状减轻；活动功能改善，可以从事轻微体力劳动或一般性工作，23例。无效：症状无明显改善，3例。

管遵惠等 热针九宫穴治疗腰椎肥大性脊椎炎82例疗效观察 河南中医（2），23，1989

17. 急性腰扭伤

针 刺 法

取穴后溪，选取28号3寸不锈钢毫针，垂直刺入后溪穴，针透至合谷穴后，施以大幅度提插捻转手法。得气后，令患者带针做腰部前

屈、后伸、侧屈，并旋转活动15~60分钟（以腰部疼痛消失为度），若活动后腰痛减轻不明显即出针，按无效处理，改用其它疗法。

共治疗1000例。出针后，症状完全消失，活动恢复正常者为治愈；大部分症状消失，腰部尚有轻微疼痛者为好转；症状减轻不明显者为无效。本组1000例，治愈631例，占63.1%；好转286例，占28.6%；无效83例，占8.3%。

按辨证分型分析，本组气滞型672例，治愈71.13%，好转22.17%，无效6.7%；气滞血瘀型328例，治愈46.65%，好转41.77%，无效11.59%。

任钦明等 针刺治疗急性腰扭伤1000例 中国针灸 (2), 40, 1987

电兴奋穴位法

(一) 取穴：以命门、腰阳关、肾俞、痛点为主穴，以殷门、委中为配穴。

操作时让患者作腰部活动，前俯后仰数次（多取坐位），如此可间歇治疗2~3遍，以第一次治疗取得显效为好。

(二) 采用青岛第52中学工厂产DL2型电兴奋治疗机作穴位治疗，先行感应电作穴位轻微按摩点送刺激，每穴点送3~4分钟，电量因人而异，一般常用2~8伏。最后变换直流电，方法同上，电量每次点送每秒20~40毫安，每穴3~5秒即可，每日1次，每次治疗15~20分钟，3~7次为1疗程。

(三) 采用江苏省江阴科研器械厂产，立式远红外线灯，功率600瓦，矽化炭灯棒600瓦，行痛点照射，皮距以患者舒适为宜，时间20分钟，（一般均先照射再行电兴奋治疗）。

共治疗248例。疼痛消失、腰部活动自如可以上班者为痊愈；症状基本消失，腰部可活动，但仍有余痛者为显效；疼痛减轻、可以走动者为好转；疼痛无改变者为无效。

248例中，痊愈183例，占74%；显效52例，占21%；好转13例，

占5%；有效率为100%。

孙法轩等 电兴奋穴位治疗急性腰肌扭伤243例 中国针灸(2), 17, 1987

针 刺 法 (一)

手三里穴常规消毒, 用28~30号2~3寸针, 直刺1~2.5寸, 以穴下酸沉感扩散至整个上臂为佳, 针感出现, 腰部疼痛即可消失。嘱患者活动腰部, 俯、仰、蹲、侧屈等反复活动, 留针30分钟, 每5分钟行针1次, 强刺激, 以患者能耐受为度。治疗过程中一般不配它穴, 针治一次不愈者, 也可根据疼痛部位配穴: 腰正中痛配人中、后溪; 两侧痛重配委中、昆仑; 臀、腿部放射性痛可加次髂、委中、环跳等; 瘀肿者可配委中、阿是穴。有腰椎退行性变者可加肾俞、志室、腰阳关等。

203例全部痊愈(症状、体征消失, 恢复正常工作或劳动)。其中治疗1次者146例, 2次者38例, 3次者19例, 平均治疗1.4次。

郭龙恩 针刺手三里治疗急性腰扭伤203例 浙江中医杂志(6), 280, 1991

针 刺 法 (二)

主穴取水沟穴, 配穴取承山穴(双)。患者取站立位, 双手扶一物体。先针刺配穴承山(双), 直刺2寸深, 用捻转泻法, 行强刺激, 使针刺处有酸、胀, 发热并向上抽的感觉。接着取毫针针刺主穴水沟, 向上斜刺0.5寸深, 缓慢捻转, 使局部有强烈的胀痛感。针刺的同时, 嘱患者向左、右、前、后, 不断地活动腰部, 直至病人感觉腰部有发热感或有一轻微响声为佳, 留针30min, 每5min行针1次。

共治疗200例。显效: 针刺1次, 症状、体征消失, 行动自如者; 好转: 针刺2~3次后, 体征基本消失, 行动不受限, 仅感轻微疼痛不

适者，无效：针刺4～6次后，症状无变化者。

200例中，针刺1次治愈53例，针刺2～3次治愈108例，针刺4～6次治愈39例，总有效率为100%。

赵平原 针刺水沟穴治疗急性腰扭伤200例 陕西中医 (2), 84, 1991

手 针 法

取穴：腰痛穴在手背掌骨横纹下1寸处，指总伸肌腱的两侧，一手两穴，分别在第二伸指肌腱桡侧旁和第四伸指肌腱尺侧旁。针刺操作：常规消毒后，取约3.3cm30号毫针4根，用拇食二指肌力快速进针，以30～45度斜刺入伸指肌腱下，约1～1.5cm深，双手同时捻转两针，并令病人起立，来回走动和作弯腰动作，待腰痛消除后起针。

共治疗100例。①痊愈：疼痛及压痛完全消失，腰部活动功能恢复到正常范围，患者恢复日常工作，无不适感。②显效：疼痛及压痛基本消失，腰部功能活动达到或基本达到正常范围，恢复日常工作，但过劳时患部仍有轻度不适感。③好转：疼痛及压痛减轻，腰部活动障碍得到较明显改善。④无效：连续手针10次后，症状及体征基本未改善或改善不明显。

100例患者经治疗后痊愈72例，占72%；显效13例，占13%；好转10例，占10%；无效5例，占5%。总有效率为95%。气滞型30例，痊愈27例；血瘀型20例，痊愈15例；气滞血瘀型50例，痊愈30例。病程对痊愈疗效的影响：病程在3天以内70例，有效68例；病程在4天以上者30例，有效18例。

赵生富 手针腰痛穴治疗急性腰扭伤100例 浙江中医杂志 (7), 325, 1990

微波针灸法

1. 取穴：以疏通督脉及足太阳膀胱经经气为主，常用穴为17椎

下、肾俞、大肠俞、志室、腰眼、委中、天应穴。

2. 方法：患者取俯卧位，每次选1~3个穴，直刺，行捻转提插手法，得气后将 DBJ-1 型微波针灸仪输出天线套在主穴针柄上，打开开关，调节各路微波输出功率，以患者穴位局部出现温热酸胀或轻微刺痛感为宜。每次15~20分钟。治疗后穴位局部出现红晕和红斑属正常现象。

3. 疗程：每日一次，10~12次为一疗程。急性患者一般1~2次即愈。

共治疗86例。治愈：症状消失，体征阴性，恢复原工作。

显效：症状明显好转，体征呈阴性。

进步：症状减轻，体征呈弱阳性。

无效：症状及体征无改善者。

86例患者中治愈32例（其中6例为1次治愈），占37.2%；显效28例，占32.6%；进步23例，占26.7%；无效3例，占3.5%。总有效率为96.5%。

鲍治安 微波针灸治疗腰扭挫伤86例 上海针灸杂志 (1), 15, 1987

刺络拔罐法

取穴：痛点，委中（患侧）。操作方法：患者俯卧，医者持三棱针在患者痛点先散刺（豹纹刺），在委中穴点刺出血数滴，然后在痛点行拔罐术（用大号玻璃罐），每次留罐10~15分钟。每日一次，5次为一疗程。注意散刺必须做到浅而快，点刺委中穴时，切勿刺伤动脉，且出血量不宜过多。

共治疗68例。痊愈46例（腰痛症状消失，活动自如，能参加工作）；显效18例（腰痛症状显著减轻，腰脊活动明显好转，劳动时偶有轻度疼痛）；无效4例（治疗前后症状无改变）。68例中，治疗二次者42例，三次者19例，三次以上者7例。

吴绪荣 刺络拔罐治疗急性腰扭伤68例 湖北中医杂志 (6),

腰 三 针 法

我们把治疗急性腰扭伤的三个有效穴，承筋、腰阳关和腰眼简称为“腰三针”。患者取俯卧位，先针双侧承筋穴，针尖略向上得气后，押手拇指压承山穴，持针手捻转针柄，使针感向腰部扩散，以气至病所。再针腰阳关和腰眼，得气亦使针感扩散至痛点，留针五分钟。

共治疗81例。痊愈：疼痛完全消失，腰部活动不受限，局部压痛消失。显效：疼痛明显减轻，腰部活动稍受限，局部有轻微压痛。好转：疼痛减轻，腰部活动中度受限，局部压痛亦减轻。无效：治疗前后无变化者。治疗效果：81例患者中，针治一次痊愈者76例，针二次痊愈者5例。

郑学良等 “腰三针”治疗急性腰扭伤81例 中国针灸 (4), 21, 1987

耳 针 法

取穴：神门、肾、腰部疼痛相应部位。

操作：先以2.5%碘酒和75%酒精局部常规消毒。尔后找准穴位施针，对神门、肾两穴直刺至软骨对腰部疼痛相应部位采用45°斜刺法。双耳同时进行，留针10~15分钟，同时嘱患者随意活动腰部。

共治疗51例。痊愈(腰部疼痛消失，活动自如)46例，占90.2%；显效(腰部疼痛基本消失，能直腰独立行走)5例，占9.8%。总有效率达100%。其中接受一次治疗者43例，二次治疗者6例，三次治疗者2例，平均治疗1.2次。

戴厚炳 耳针治疗急性腰扭伤51例临床观察 江苏中医 (5), 28, 1990

头 针 法

取顶中线可分为三段：前段前顶透百会，中段百会透后顶、后段后顶透强间穴。以常规消毒，用28~30号1.5寸毫针二枚接力快速刺入帽状腱膜下，多用泻法，快速捻转(200/分以上)，嘱病人做俯仰，转侧，踢腿，下蹲活动，待手法操作后留针30分钟，每5分钟用泻法行针一次，根据患者腰痛部位，选择顶中线治疗，1~2腰椎及双侧腰肌疼痛，应取顶中线的前段，3~4腰椎及双侧腰肌疼痛，应取顶中线中段，腰骶部疼痛者，可取顶中线的后段。

痊愈：腰痛症状消失，活动自如，42例。

有效：腰痛症状基本消失，用力活动时略感疼痛，2例。

申秀兰 头针顶中线治疗急性腰痛44例 北京中医学院学报(4)，24，1988

指 针 法

取穴：稍屈肘，半握拳，掌心向内，在阳池穴与曲池穴连线的上1/4与下3/4交界处即扭伤穴。操作：患者暴露前臂，医者面对患者站立，双手的四指托起患者的前臂，大拇指用力按压患者两臂的扭伤穴，使局部产生酸、沉、痛、麻的感觉，同时令病人作俯仰转侧、踢腿下蹲等活动，以患部微出汗为度，约3~5分钟即愈。

共治疗31例。效果：治疗1次痊愈者19例，2次痊愈者12例。

李志安等 指针扭伤穴治疗急性腰扭伤31例 江苏中医(2)，19，1989

刺 血 法

穴取委中(双)、后溪(双)、腰阳关、腰天应(即腰部压痛点)。操作：先用手拍击委中穴周围，使其静脉血管怒张后，局部常

规消毒，用小号消毒三棱针刺破静脉血管，流出10—20ml 紫暗色瘀血，如放血不自流出，可采用刺血加拔罐约五分钟，去罐后用盐水棉球擦净针孔处血迹，继用2%碘酒棉球消毒针孔。如需进行第二次治疗，须隔3—7天方可再刺。辅助穴后溪、腰阳关、腰天应用强刺激手法，留针30分钟，并令病人配合活动腰部，针刺操作隔日一次。二十七例中有五例刺血后加服身痛逐瘀汤（牛膝10g，地龙10g，秦艽10g，羌活10g，当归10g，香附10g，桃仁10g，红花6g，乳香6g，五灵脂10g，甘草3g）。

共治疗27例。结果一次痊愈（腰部疼痛消失，俯仰或转侧功能恢复正常）11人，二次治愈者7人，三次治愈者为5人，四次治愈者3人，五次治愈者1人。

李德明 刺血疗法治疗急性腰扭伤 27例报告 江西中医药 (2), 47, 1988

18. 慢性腰背关节痛

穴位注射法

经络综合疗法：以发病部位不同选压痛明显的经穴采用归经用药的方法，如：腰痛选肾俞，配手针腰眼；背痛、肩甲痛选天宗，肩甲上痛选肩外俞，肩甲下痛选督俞。可配健侧条口透承山；肩痛选臑俞、肩髃，配健侧条口透承山；肘痛选曲池透曲泽，可配健侧条口透承山；膝痛选阳陵泉、犊鼻穴，配健侧曲池透曲泽；踝痛选解溪、商丘，配健侧曲池透曲泽。

药物及用量：复方防风液（防风、牛膝、桂枝）按中药常规制剂法，每穴注射0.5~1ml，每日1次，5~7次为1疗程。

共治疗336例。治愈：临床症状消失，功能恢复正常；显效：疼痛基本消失，功能恢复明显好转；好转：疼痛减轻，活动受限有好转；无效：无明显变化。

治疗效果：336例中治愈134例（40%），显效92例（27.2%），好转97例（28.7%），无效13例（4%），总有效率96%。

雷 伦等 复方防风注射液治疗慢性腰背关节痛336例 陕西中医（10）；461，1988

19. 四肢慢性关节疼痛

穴位注射法

本组 577 例患者全部应用强的松龙12.5~50mg, 0.5%~2%普鲁卡因 1~3 ml 混合后，在患部压痛点进行注射，进针应刺到骨膜及较硬的部位，当患者有明显胀感时，将针退回约1mm，抽吸无回血将药液注入，每 5~7 日一次，每 5 次为一疗程。

共治疗577例。（1）治愈：注药后疼痛完全消失，经 3~6 个月后随访未复发者。（2）显效：注药后疼痛消失，经 3~6 个月后随访患处有时有不适感者。（3）无效：注药后患处疼痛无明显改善者。本组577例中，经过 2 个月至 5 年的随访，痊愈529例，无 1 例复发，占91.8%；有48例关节疼痛消失，但有时还有不适感，我们定为显效，占8.2%。总有效率为100%，治愈所需时间平均为15天。

杨丁林等 阿是穴注射强的松龙治疗四肢慢性关节疼痛 577 例 中国针灸（3）；36，1987

20. 腰肌劳损

穴位注射加微波照射法

取穴：上腰痛取肾俞，下腰痛取白环俞。方法：观察组，1%当归注射液，每穴注射 1~1.5ml，然后置江苏 DBJ-I 型微波无针天

线探头于注射药物的穴位，启动电源开关，照射20分钟，每日一次，每七天为一疗程，间隔四天。

共治疗102例。疼痛消失，无复发者为痊愈，40例。疼痛减轻，但劳累后时有复发者为好转，9例。疼痛无变化者为无效，无。

李百敏 穴位注射加微波照射治疗腰肌劳损102例 陕西中医(4)，177，1987

21. 腰 痛

眼 针 法

以双眼下焦区为主穴，急性腰痛配双眼肝胆区穴；慢性腰痛配双眼上焦区和肾区穴。施术时，可用特制眼针在眼球周围，眼眶边缘0.66cm处沿皮下按辨证先后取穴，轻轻刺入。留针20~30分钟，在留针过程中配合肢体运动。

共治疗120例。经治疗，急性腰痛病人腰部疼痛消失，活动自如，慢性腰痛病人活动时腰部疼痛消失，肌肉不僵直、3个月内观察不再犯者为痊愈；经治疗，腰痛在3个月内再犯者为显效。

急性者56例，经1~2次全部治愈，慢性者64例，经5~8次治疗疼痛消失，活动自如，仅有8例在3个月内复发。有效率100%。

韩育斌等 眼针疗法治疗腰痛120例 陕西中医(4)，181，1989

附：瘀血腰痛

药 锭 灸 法

药锭处方 麝香3g 朱砂9g 硫磺18g。

配治法 先将硫磺置铜勺内用文火熔化，即下朱砂拌匀，离火下

麝香迅速搅匀倾在玻璃板上，待稍冷（未硬化）立即捏成米粒大小之药锭，瓶装密封备用。

用法 在腰椎、骶椎及两侧找出最明显之压痛点或皮下阳性反应物之压痛点1~2处，以龙胆紫标记，经常规消毒后，用药锭1粒安点上，用火点药锭顶部，待燃烧至3/4时，急以小块胶布复盖灭火按压。次日揭去胶布，涂以龙胆紫，盖消毒敷料固定即可，一般不会化脓，无疤痕及色素沉着。燃灸时有数秒钟最多10秒钟之灼痛，但痛点深部却有极其舒快之感觉。

共治疗68例。近愈：经施灸后症状体征全部消失，功能恢复正常，经半年以上随访未复发者；显效：经施灸后症状体征基本消失，功能显著恢复，在半年内偶有轻度复发，经再用锭灸法仍显效者；好转：经施灸1~2次后，当时症状基本消失或显著减轻，功能有所改善，但数天后又复发，必须加用其他针法或灸法始能控制者；无效：经施灸1~3次，症状体征无任何好转者。

本组68例均采用锭灸法为主进行治疗，其中8例配合了先在局部刺络拔罐法，23例湿热患者配合（灸后）在腓肠肌小静脉刺血法。结果：近愈16例，显效40例，好转10例，无效2例，总有效率为97.05%。

詹永康 药锭灸法为主治疗瘀血腰痛 湖南中医杂志（1），81，1989

22. 腰椎间盘突出症

三联法

卧硬板床，骨盆牵引6—8周，牵引重量为20—25公斤，每次牵引2—3小时，牵引后即作如下治疗。

（一）针灸：前期缓解疼痛主穴取人中、后溪、腰部阿是穴。进针后采用泻法，一两分钟后，即用艾条灸后溪、阿是穴，后期（生髓

充骨)主穴取肾俞、足三里。进针后采用补法2—3分钟后,加艾灸。

(二)手法:1.伸髋拉腿法,即患者俯卧位,术者一手按住腰骶部,另一手握住患侧踝部,缓缓将患侧下肢呈抛物线拉至最大限度,然后,撤定腰部的手用力下按,握住踝关节的手顺势用力上拉,有时可闻及“咯嗒”声。

2.斜扳法,即患者侧卧,朝上的下肢屈曲,朝下的下肢伸直,术者站在患者背后,一手向后扳拉肩部,另一手向前推髻髂关节部位,两手同时作相反方向斜扳,常听到“咯嗒”声。

3.提腿压腰法,即患者俯卧,助手站在床上,双手握住患者两踝并抬起,使腹部离开床面,术者双手重迭,按于腰骶关节部位,用垂直的力量连续按压腰部数次。

4.分筋,即患者俯卧,术者站在患者一侧,用双手拇指末端沿垂直肌肉走行方向左右弹拨,并顺肌腱起点向肌腹方向移动,以此剥离粘连。此法应用于病程壹个月以上者。

5.理筋,即患者俯卧,术者站在患者一侧,用一手的食、中、环指并拢,用末节的指腹在腰脊柱的两侧顺肌肉、肌腱走行的方向按压、梳理,再以空心拳在上述部位轻轻叩打,以起到疏筋、顺脉的作用。

(三)中药:补肾充髓生骨为主,基本方:熟地、肉苁蓉、鸡血藤各30g,骨碎补18g,淫羊藿12g,透骨草15g,威灵仙、续断、槟榔、桑寄生、地龙、小茴香各10g,虚寒者,加入制川乌、桂枝等药;兼热者,加羚羊角、水牛角、桑枝之类;大便秘结者,加大黄;脾气虚者,加党参、白术;失眠梦多者,加熟枣仁、珍珠母。

共治疗22例。显效为疼痛消失,腰部功能基本正常,并恢复原工作;有效为疼痛消失,部分功能恢复,能从事轻微劳动;无效为疼痛稍减轻或无改变,功能无变化。

显效18例,有效3例,1例未坚持治疗。

吴继光 针灸、手法、中药并用治疗腰椎间盘突出症22例 江西中医药 (6); 35, 1987

23. 腰棘间韧带损伤

针刺按摩法

患者取卧位，用28号2寸毫针，直刺委中穴，然后施以提插、捻转泻法，使针感向腰部或下肢放射，留针30分钟。留针期间术者以双手在腰骶部捏拿椎棘间韧带，使局部软组织的事急松弛；约15分钟后，用右手背和小鱼际部在腰骶部施摇滚手法10分钟，最后双手握拳，在局部轻轻拍打3~5分钟，然后起针，施术完毕。上法每日一次，6次为一疗程，隔日继续治疗。

共治疗80例。（1）治愈：主要症状与体征完全消失，腰部活动达到正常范围，恢复原工作，67例。

（2）显效：主要症状与体征基本消失，腰部活动接近正常范围，恢复原工作，但劳累后仍有轻微腰部酸痛感。9例。

（3）好转：主要症状与体征明显好转，腰痛减轻，腰部活动范围增加，3例。

（4）无效：症状与体征未见任何改善，1例。

王富春等 针刺按摩法治疗腰棘间韧带损伤80例临床小结 江苏中医（8），22，1989

24. 胸胁挫伤

针 刺 法

主穴：支沟、阳陵泉，均取对侧穴。

配穴：局部或临近夹脊穴1~2个，取同侧。

操作：二个主穴中任选一个，常规消毒。取30号1.5寸毫针垂直刺入大约1寸左右，在正常行针中得气。当病人出现良好的酸、胀或沉重以及放射感时行“龙虎交战”手法。即左转（大指向前）九次，右转（大指向后）六次。在“龙”“虎”（九、六）之间，也就是完成第九次左转时，应紧握针柄守气片刻。完成后如果疼痛不止，可再行1—2次，不留针。一般急性挫伤当行手法完毕时至少可以解除百分之五十至八十的疼痛。然后，按照受损的部位沿肋骨寻找相应的夹脊穴（背俞穴）。夹脊穴可直刺0.8~1寸，背俞穴应斜向脊柱方向刺0.8~1寸。行抽气法。即重提轻插，次数不限，以针感略有放射为度。以上手法操作的要点是：1.行手法时及行手法前（得气时），病人不应有疼痛的针刺感应，以保证手法顺利施实。同时，术者应神守一处，牢持针柄，“令志在针”。2.在行“龙虎交战”手法时，须嘱病人配合做深呼吸和活动患侧上臂的动作，以帮助疏通经气，否则，效果不佳。

共治疗32例。局部无压痛，临床自觉症状消失为痊愈。局部压痛不明显，或有轻度压痛，自觉症状基本消除为显效。症状及局部压痛无明显改善则为无效。此32例中，痊愈24例，显效7例，无效1例。

程晓明 针刺治疗胸肋挫伤32例 浙江中医学院学报（6），47，1989

25. 肋软骨炎

针 刺 法

取痛侧内关穴，中度刺激，用泻法。选局部痛点周围1cm处为阿是穴，每次可选取两处，斜刺或横刺，针尖对痛点，轻度刺激，用泻法，每日针刺1次，每次留针15~20分钟。

共治疗30例，均针刺3~10次。痊愈：疼痛、肿胀消失，活动正常，9例占30%；显效：疼痛、肿胀明显减轻，或疼痛消失仍有轻度肿胀，13例占43%；好转：疼痛、肿胀减轻，6例占20%；无效：治

疗前后无变化，2例占7%。总效率为93%。

陈式范等 针刺内关配阿是穴治疗肋软骨炎30例 辽宁中医杂志 (1); 32, 1991

26. 胸 肋 痛

针 刺 法

穴位：下都穴自然握拳，手背四五指缝尖上方约0.5cm处。

刺法：避开可见静脉，用毫针顺掌骨间隙刺入0.5—1寸，左右捻转数次，以得气为度。一般先刺单侧即效，15分钟后效差者加刺对侧。留针20—60分钟，中间每10—15分钟运针一次。出针后稍压针眼片刻，以防出血。

共治238例。只计初诊即时效果，复治不计。完全消失124例；基本消失（减轻80%以上）46例；显著好转（减轻50%以上）33例；好转（减轻50%以下）29例；无效（毫无变化）6例。总有效率97.5%。

申 健 针刺下都穴对胸肋疼痛的治疗作用 浙江中医学院学报 (5); 55, 1989

27. 膝关节创伤性滑膜炎

针刺加穴位注射法

按顺序进行：（一）取穴：内、外膝眼、犊鼻、鹤顶、阿是穴。依局部具体情况，每次选2~5个穴位，用28号1.0~2.5寸毫针，进针得气后用泻法（大幅度提插捻转，出针时摇大针孔），不留针；起针后用闪火法拔罐5~10分钟。（二）用5ml注射器及6~6½号

针头，吸取2%利多卡因3ml和醋酸氢化泼尼松混悬液（3ml，125mg）2ml行局部腧穴及痛点注射（快速进针，勿注入关节腔内，待得气后回抽无血，即可将药物缓慢推入，注射完毕，快速出针）。一般每穴注射1~2ml，三天治疗1次，5次为一疗程。

128例经1个疗程治愈（局部症状完全消失，功能活动恢复正常）121例，占94.5%；6次治愈4例，7次治愈2例，8次治愈1例，128例全部治愈。

彭启琼 针刺加穴位注射治疗膝关节创伤性滑膜炎123例 山西中医（1），38，1990

28. 膝关节侧副韧带损伤

电 针 法

1. 体位：坐位或仰卧位，腿部肌肉放松，膝关节呈90°位。
 2. 取穴：外侧副韧带损伤取：梁丘、犊鼻；内侧副韧带损伤取：血海、内膝眼。
 3. 治法：一般用3寸毫针，采用泻法。针尖向病变部位刺入，以出现较强酸胀感即可。用G6805治疗仪，波型为疏密波，通电30分钟。
- 共治疗128例。症状消失，体征阴性为痊愈，共117例。症状基本消失或减轻为好转，共8例。经治疗5次症状无改善，或经一次治疗后，未继续治疗者为无效，共3例。

钱德金等 电针治疗膝关节侧副韧带损伤128例临床小结 江苏中医（1），25，1990

29. 腓肠肌痉挛

温 针 法

取承山穴，针刺1.5至2寸深，行提插平补平泻手法，使针感放

射到足底部 3、4 次，然后把艾条剪成 1 寸长，插到针柄头上，实施温针，待燃烧完毕，留针 15 分钟，每日一次。

共治疗 43 例。结果 30 例患者经 1～3 次治疗痊愈，13 例经 4～7 次治疗痊愈，均未用任何药物和其它疗法。

薛 浩 温针治疗腓肠肌痉挛 43 例 上海针灸杂志 (2)，47，1987

30. 跖腱膜炎

敲 打 法

患者卧位，术者一手握患肢前足，一手拿叩诊锤，先令患者屈趾、屈踝、屈膝，敲打痛点周围。然后令患者伸趾、伸踝、伸膝，再继续敲打。敲打时先轻后重，然后再由重到轻。轻要使患者感到有敲打力在局部起作用，但不能使患者感到有明显疼痛。每敲打一下，移动一次敲打部位，但不能敲打痛处。治疗期间尽量减少站立与行走。隔日敲打一次，每次敲打 2～3 分钟。

治疗 34 足中，疼痛完全消失者 12 足，其中经 1 次敲打者 1 足，2 次敲打者 3 足，3 次敲打者 5 足，4 次敲打者 1 足，5 次敲打者 2 足。经 5 次敲打疼痛减轻，但没完全消失者 16 足。经 5 次敲打疼痛不减者 6 足。

熊昌源等 敲打疗法治疗跖腱膜炎 30 例 湖北中医杂志 (3)，45，1988

31. 类风湿性关节炎

内服外灸法

内服药基本处方：青风藤、九节兰(即接骨金粟兰)、海风藤各 20

8, 雷公藤、皂角刺、乌梢蛇各10g, 生甘草梢6g。风热型加麻黄、防风、羌活、独活、桂枝各10g, 淡竹叶15g; 湿热型加忍冬藤、生石膏各30g, 土茯苓20g, 川萆薢10g; 寒湿型加胆南星、淡附片、细辛各10g, 土茯苓20g; 虚寒型加炮姜、淡附片、川芎、白芍、胆南星各10g, 全蝎3g。外灸法: 艾绒50g, 没药、小茴香、皂角刺、冰片各2克, 共研末, 拌匀, 捏成塔状, 隔姜灸督脉经上穴位: 腰阳关、腰俞、命门、至阳、神道、悬枢、中枢、灵台、大椎, 每次选取5穴, 每穴5壮, 以皮肤红晕而不起泡为度。

共治疗了68例。临床症状消失, 实验室检查血沉降至正常, 类风湿因子转阴, 骨质破坏静止(以上检查至少有1项转为正常)。好转: 疼痛基本消失, 症状缓解, 实验室检查无变化。治疗后痊愈28例, 好转31例, 无效9例。总有效率为86.8%。其中风热型痊愈15例, 好转3例; 湿热型痊愈4例, 好转6例, 无效2例; 寒湿型痊愈7例, 好转17例, 无效4例; 虚寒型痊愈2例, 好转4例, 无效4例。

施鸿明 内服外灸结合治疗类风湿性关节炎68例 浙江中医杂志(11); 501, 1988

32. 增生性关节炎

针 灸 法

取穴: 主穴: 膝下, 位于髌骨下缘中点, 沿髌骨内面进针1.5寸左右, 有酸胀感放射至全膝。配穴: 犊鼻、内膝眼、足三里、阳陵泉、血海、梁丘、膝阳关, 根据不同情况每次选取2~3个配穴。操作: 针刺使患者有酸胀感, 留针15~20分钟。留针期间加灸3~5分钟, 以局部皮肤红润为度。10天为一疗程, 两个疗程后休息3天。一般观察2~3个疗程。

共治疗30例。显效: 平时疼痛基本消失, 或仅轻微疼痛, 9例。

有效: 疼痛较前减轻, 17例。

无效：临床症状与针前无明显变化，4例。

李连生等 针灸膝下穴为主治疗增生性关节炎30例临床视察 天津中医 (2), 16, 1989

33. 急性关节扭伤

恢刺加刺络拔罐法

按压扭伤部位，找到压痛点，在压痛点上下左右各约2cm处进针，直刺0.5~1寸，然后行针使得气，再用三棱针在压痛点处疾刺数次，以出血为度。然后用小号玻璃火罐拔罐，留罐15min，起罐后行针5min，并嘱患者同时活动关节，最后出针。

共治疗35例。治疗后关节活动自如，肿胀疼痛均消除者为治愈；肿胀消除，活动时关节仍有轻微疼痛者为好转；经3次治疗后仍无改变者为无效。

治愈32例，其中1次治愈者18例，2次治愈者12例，3次治愈者2例；好转2例，无效1例。

赵永刚 恢刺加刺络拔罐法治疗急性关节扭伤35例 陕西中医 (8), 369, 1990

34. 增生性脊柱炎

夹脊刺法

1. 针刺穴位：取相应病变椎体部位的夹脊穴。夹脊穴位于脊柱两侧，第一颈椎起至第五腰椎止，每椎棘突旁开0.5~1寸。上肢疼痛麻木者配以曲池、养老、合谷等穴，下肢疼痛麻木者配以环跳、委中、昆仑等穴，头晕重者配以风池穴。

2. 操作手法：颈部夹脊刺患者取坐位或俯卧位，腰部夹脊刺患者取俯卧位。夹脊穴向棘间韧带进针1~1.5寸，施轻度均匀的提插手法，使感应向四周扩散，以有放电样针感向对侧脊柱或肢体传导为好。其它穴位皆以得气为度。

共治疗77例。痊愈：症状全部消失，头晕及肢体麻木疼痛消失，肢体功能恢复正常，共21例。显效：头晕及肢体麻木疼痛明显减轻，活动时仍有轻度不适，体征好转，共33例。好转：症状和体征稍有好转，活动仍受影响，共20例。无效：症状和体征无明显改善，共3例。

侯冬芬 夹脊刺治疗增生性脊柱炎77例 山西中医 (1), 25, 1991

35. 强直性脊柱炎

穴位注射法

采用我院自制中药制剂“追风速”穴位注射，每次用药6~8毫升。穴位以病变相应部位的华佗夹脊穴为主，配以大椎、大杼、至阳、命门、阳关、肾俞、大肠俞等，每次选10~12个穴位。隔日注射一次，10次为一疗程，三个疗程后休息2~3周。另外服用中药汤剂，以滋补肝肾为主，辅以疏风通络，养血通脉为法。常用药有：寄生、川断、狗脊、杜仲、威灵仙、络石藤、羌活、独活、桂枝、白芍、鸡血藤等药。

病情重者，还可酌加远红外线照射、针灸、药物导入等疗法。

共治疗10例。显效：患者疼痛明显减轻，血沉明显下降或恢复正常，呼吸差数增高，能正常工作。有效：关节疼痛好转，脊柱功能活动增强，血沉略有下降但仍未恢复正常。无效：体征和化验未见好转。

经治疗，10例中显效3例，有效7例。其中病程短、无骨性强

直、疗程愈长者疗效好。

金伯华 强直性脊柱炎的中医药治疗 北京中医 (4); 36, 1989

36. 脊柱退行性病变

隔姜灸法

1. 选穴: 以督脉上的阿是穴为主, 即以病变椎体为主, 若病变椎体较多者则取其首尾椎骨或间隔 1~3 椎取之, 腰痛甚者加肾俞, 颈椎肥大者加大椎及阿是穴, 一般每次选 3~4 穴。

2. 操作: 按隔姜灸常规操作, 每穴灸 7~10 壮, 以局部皮肤潮红为度。

3. 疗程: 10 次为一疗程, 未愈者休息 2 天再进行第二个疗程。

8 例患者中, 经治疗后临床症状及主要体征全部消失者 6 例, 大部分消失者 2 例 (其中 1 例因故中断治疗), 治疗次数最少者为 3 次, 最多者为 10 次, 但经 X 片复查, 椎体退变并无明显改变。

祁晓华 隔姜灸治疗脊柱退行性病变 上海针灸杂志 (2), 24, 1987

37. 骨质增生

热熨法

(一) 热熨药物: (自拟方) 骨痹散: 乳没各 15 g, 生马钱子 6 g, 花椒 7 g, 生川乌 15 g, 白花菜子 20 g 为一剂, 共研细末以醋调湿装纱布袋内。蒸热敷骨增生处 1—3 小时 (热水袋加温) 日敷 1—2 次, 一剂连用 5—7 日 (药干后可以醋再调, 不可内服, 注意防止

烫伤)。

(二) 独活 9 g, 桑寄生 12 g, 秦艽 9 g, 防风 9 g, 细辛 3 g, 赤芍 12 g, 川芎 9 g, 熟地 12 g, 甘草 9 g, 茯苓 9 g, 党参 10 g, 黄芪 20 g, 当归 10 g 水煎服。加减法: 颈部病变者, 可加葛根 30 g, 白芷 12 g; 腰部病变者, 可加杜仲 15 g, 狗脊 20 g; 上肢病变者, 可加桑枝 30 g; 下肢病变可加牛膝 15 g; 足跟部病变者, 可加熟地、何首乌各 15 g; 疼痛剧者可加三七; 眩晕者, 加钩藤 9 g, 有瘀血见症加桃仁、红花。

共治疗 110 例。痊愈: 局部症状消失, 形态功能正常, 一年后随访未复发。

显效: 疼痛消失, 关节活动部分受限, 一年内有复发, 但用上方治疗后效果仍然较好者。

有效: 疼痛减轻, 关节活动受限或不能坚持工作者。

无效: 治疗前后疼痛和关节功能活动均无效者。

110 例骨质增生患者, 经热熨骨痹散配合加减独活寄生汤治愈 67 例, 显效 30 例, 有效 11 例, 无效 2 例, 总有效率为 98.2%。

杜见斌 热熨法为主治疗骨质增生 110 例疗效观察 浙江中医学院学报 (5); 48, 1989

38. 足跟骨骨质增生

针 刺 法

选用健侧手针足跟点(大陵穴下 8 分处), 常规消毒, 一般用 26—28 号 0.5~1 寸毫针, 刺入皮肤后向上斜刺, 深 3~5 分, “得气”后(手掌、腰背部有发热感, 患足疼痛明显减轻)即行大幅度捻转(以病人能忍受为度), 同时嘱患者以足部原痛点踩于硬物上, 由轻到重自行活动, 留针 30 分钟。每日一次, 15 天为一个疗程, 每疗程之间要间隔 5~7 天。

30例经用上法治疗, 12例足跟症状消失, 活动功能正常者为痊愈。15例足跟疼痛明显减轻, 活动功能基本正常, 早晨下床时稍有疼痛, 活动后疼痛消失者为显效。3例足跟疼痛减轻, 活动功能好转者为好转。针刺次数与疗效的关系: 痊愈12例平均16.6次, 显效15例平均17.1次, 好转3例平均7.6次。好转的治疗不足10次; 痊愈、显效需要治疗15次以上, 个别需要45次。

车宗贵等 针刺治疗足跟骨骨质增生 30例 中国针灸 (3), 17, 1986

捶 击 法

患者取仰卧或侧卧位, 术者站在患者右侧, 将患足跟部略抬高, 随之以自制尼龙捶于患侧足跟压痛处及其周围, 从外向内呈螺旋形由轻至重进行捶击, 然后再从内向外, 由重渐轻捶击, 如此反复多次, 每次约5—10分钟。每日一次, 十次为一疗程。

治疗40例患者, 结果足跟痛消失或基本消失者32例, 减轻者7例, 无效1例。

周荣兴 捶击法治疗跟骨刺 江苏中医 (2); 28, 1988

39. 足跟疼痛

头 针 法

取患足对侧的足运感区。横刺进针一定深度后, 以一分钟150~200次的快速频率持续捻转2~3分钟, 间歇10分钟, 再按上法反复运针3次。隔日一次, 10次为一疗程, 休息一周后再作第二疗程。

共治疗25例。治疗二个疗程以内, 足跟疼痛与压痛完全消失为显效; 治疗三个疗程以内, 足跟疼痛与压痛明显减轻为有效; 治疗三个疗程以上症状改变不明显为无效。

显效14例，有效7例，无效4例，总有效率84%。

戴毅君 头针治疗足跟疼痛 上海针灸杂志 (4); 16, 1987

附：足跟痹

针 灸 法

1. 取穴：风市、阴陵泉、三阴交、太溪、昆仑为主，必要时配以阿是穴。

2. 手法：嘱患者仰卧，穴位常规消毒，以28~30号1~2.5寸毫针直刺以上穴位，进针深度为1~1.5寸，用补法加灸。留针20~30分钟。隔5~10分钟运针1次，每日1次，两周为1疗程。

共治疗55例。症状完全消失无其他不适者为痊愈，共45例。症状减轻但未完全消失者为好转，共9例。症状无变化为无效，共1例。

王 洁 针灸治疗足跟痹55例 山东中医杂志 (3); 16, 1987

40. 外伤性截瘫

针 刺 法

(一) 主穴：

损伤平面上(1~2个棘突)下(1~2个棘突)的督脉穴；或损伤平面上(1~2个棘突)下(1~2个棘突之间)的夹脊穴。

主穴具有疏通经脉，调节脏腑，强健腰膝的功能。针刺主穴可疏通督脉经穴，使元阳之气重伸，损伤平面以下的诸脉可重得督脉之统摄。华佗夹脊正置督脉与足太阳膀胱两经之间，亦为联系二经之纽带，故针刺夹脊既可疏通督脉，又可借膀胱经之脏腑俞穴调节脏腑的功能。

(二) 配穴

1组：关元、中极、天枢，可协同主穴调节二便功能。

2组：秩边、殷门、委中、昆仑，是临床治疗腰及下肢疾患常用而确有实效的穴位。在外伤性截瘫中，用以疏通经络，行气活血，起痿缓挛。

3组：髀关、伏兔、冲阳、足三里，根据“治痿独取阳明”的原则采用。

4组：阳陵泉、绝骨，根据“筋会阳陵泉”，“髓会绝骨”的原理，以强筋补髓。

针刺操作方法

(一) 督脉穴针刺法：双手进针法，左手食、中指固定所要针刺的督脉穴上下二个棘突间的皮肤，以防皮肤移位，右手拇指、食指夹持针柄，中指、无名指抵住针体，进针时，运用指力，使针尖垂直刺入皮肤，入皮肤后必须缓缓均匀地提插，以测知针刺所遇到的阻力，并体会到手下感觉，进针深度一般为1.5~2.5寸。当刺到黄韧带时，医者手下出现一种弹性阻力，患者受针局部可出现酸、重、胀感，此时可继续向下针刺，但如果手下突然出现一种突破感时，或患者的前后二阴及双下肢出现电掣样感觉时即当终止继续向下进针，以防刺伤脊髓。

(二) 华佗夹脊针刺法：双手进针，根据穴位的不同，针感可分别向两侧放射，或相应部位的体腔内出现紧束感，进针深度为1.5~2.5寸。

(三) 腹部及下肢配针刺法

“中极”和“关元”两穴可交替使用，直刺深度1.5~2寸，针感为局部酸胀，并向外生殖器放散，针前要排空尿液，对尿潴留的病人要先用指压利尿穴的方法，将膀胱内的尿液排空。下肢配穴针刺与腹部一样，均以提插和捻转相结合。

共治疗150例。基本痊愈：能自由行走，二便随意或近似随意，81例。

显效：能扶拐独立行走，反射性膀胱形成，36例。

好转：运动及二便功能有不同程度改善，79例。

无效：运动及二便功能无改善，4例。

陈志华等 150例外伤性截瘫的针刺治疗与体会 天津中医(5)，
5,1989

电 针 法

电针：主穴：受伤脊髓水平的上下1至2个椎体督脉穴和相应夹脊穴。用毫针刺，一般督脉穴进针1至1.5寸；夹脊穴进针2.5至3寸，待得气后（患者有触电感并向下放射至足趾）稍退针，接通6805治疗仪，低频率、连续波，留针15至20分钟。隔日一次。配穴：辅助主穴恢复肢体功能取足三阳经穴髀关、伏兔、足三里、解溪、阳陵泉、肾俞、次髎、委中、承山；调理二便取秩边（用5寸毫针进针约3.5寸左右，针尖略向内侧偏斜）、中极、提托等穴。根据穴位的分布，分仰卧、俯卧位电针治疗，隔日一次、交替进行。俯卧位时取主穴1至2个、配穴2至4个，仰卧位仅取配穴2至4个。30天为一疗程，疗程间隔5至7天。

辅助治疗：

穴位注射：用维生素B₁ 100 mg加维生素B₁₂ 300 μg，每次选用配穴2至5个，每穴注射1 ml。隔日一次。

按摩：以足太阳、足阳明经循行的部位为主，每日按摩一次，每次约1小时左右。

功能锻炼：根据患者运动功能恢复的情况，进行具体指导。包括床上运动、床边运动、室内外运动等。

治疗结果：

痊愈（肌力Ⅳ至Ⅴ级、肌张力明显增强、肌肉大部分增长，不需扶拐杖步行2里左右、二便完全控制）1例，显效（肌力Ⅲ至Ⅳ级，肌张力有所增强，肌肉部分增长，需扶单拐行走，二便基本控制）2例，有效（肌力Ⅰ至Ⅲ级，肌张力有所增强，肌肉少部分增长，二便基本控制，能扶双拐在室内移动）3例。

李燕燕 电针为主治疗外伤性截瘫 6 例 湖北中医杂志 (1);
35, 1991

针刺、穴注、按摩法

取穴：一组肾俞、大肠俞、次髎、环跳、秩边。二组关元、中极、曲骨、气冲、足三里。三组阳陵泉、太溪、昆仑、太冲。一、二组手法为中等强度刺激。三组手法为重刺激。留针2~5分钟。隔日针1次，30次为1疗程，疗程间隔3~7天。用V_{B1} 100mg、V_{B12} 100μg混合后注入气海、环跳、居髎、风市、足三里、阳陵泉、血海、委中、承山、太溪、昆仑、解溪、肾俞、中极、关元。隔日注射1次，每次5穴，每穴0.5ml，交替使用。疗程与针刺相同。按针刺穴位进行推拿，每日一次，每次1小时。

共治疗8例。结果：经12个疗程，显效3例，好转4例，疗效不显著1例。

李希贤 针刺治疗外伤性截瘫 8 例疗效观察 中医针灸(6); 封4, 1986

41. 外伤性截瘫所致尿闭

眼 针 法

按照彭氏仿用钟表时钟的算法，根据华佗眼部八卦分区，把眼球周围分成8区13穴。取双眼8区（下焦）2区（肾、膀胱）。局部常规消毒后，选用5分长，30号毫针，左手按紧眼睑，保护眼球，右手持针，距眼眶边缘2分处沿皮横刺达皮下组织，留针10~20分钟，其间不用手法。出针时用干棉球按压针孔，以防出血，1日针刺1次，7次为1个疗程。1个疗程未愈，休息2日，再针第2个疗程。

治疗结果 治愈：治疗2个疗程，患者排尿正常者26例占74.3%；

有效：治疗2个疗程，患者出现尿意，努力后滴沥而下者6例，其中高位截瘫1例；无效：治疗两个疗程，患者仍无尿意者3例，均为高位截瘫。

王龙泉 眼针治疗外伤性截瘫所致尿闭35例 辽宁中医杂志 (6); 39, 1991

42. 伤 筋

散瘀通络法

1. 取穴法：按照《灵枢·经筋》篇提出：“以痛为俞”的原则，先取伤处“阿是穴”皮部，再以阿是穴为中心取上下左右约10~20cm皮部。

2. 浅刺气罐法：先用多针浅刺器对准选取经线皮部，进行反复浅刺3~5次，然后再用橡胶气罐吸拔，留罐20~30分钟。

3. 温灸法：点燃灸条在阿是穴上施灸，采取温和灸法，灸30~50分钟。

4. 疗程：每日治疗1次，5次为一疗程，休息1天，再行第二疗程。

共治疗185例。凡经检查伤处肿胀消退，疼痛消失，关节功能正常者为痊愈；伤处肿胀消退，疼痛明显减轻，关节活动范围接近正常者为显效，伤处肿胀消退，疼痛减轻，关节活动范围稍有增大者为进步；治疗后肿胀减退，疼痛稍有减轻，但关节活动范围没有进展者为无效。

经用散瘀通络法针灸治疗骨关节韧带肌腱损伤者185例，其中痊愈者138例，占74.59%；显效者28例，占15.14%；进步者14例，占7.57%；无效者5例，占2.70%。

罗庆道等 散瘀通络法治疗韧带肌腱损伤症185例临床观察 上海针灸杂志 (3); 13, 1987

针 刺 法 (一)

1. 取穴方法: 稍屈肘, 半握拳, 掌心向下, 阳池穴与曲池穴之间划一直线, 此直线近曲池穴的 $1/4$ 处是穴 (即扭伤穴)。

2. 针刺方法: 用75%的酒精做常规消毒, 用1.5寸长的28号毫针, 在扭伤穴向下直刺进针。进针深度为0.8~1.2寸深处 (根据瘦者浅刺、胖者深刺的原则), 提插捻转, 进行强刺激, 使患者产生酸麻胀痛感, 同时令患者活动扭伤部位。强刺激30秒, 患者感到扭伤部位疼痛明显减轻或消失, 即可出针。一次未愈者可隔日一次。

左半部扭伤针右侧扭伤穴; 右半部扭伤针左侧扭伤穴; 腰背部扭伤左右分不太清者, 可针双侧扭伤穴。

150例扭伤患者中, 针一次治愈者62例; 针两次治愈者44例; 三次治愈者23例; 四次治愈者10例; 五次治愈者6例; 八次治愈者2例; 十次治愈者1例; 有效者2例。痊愈率为98.67%, 总有效率为100%。

姚光寰 针刺扭伤穴治疗扭伤 150例临床观察 中医药学报 (1), 32, 1988

针 刺 法 (二)

取穴: 动痛点。令患者做引起疼痛的动作, 在维持最疼痛的姿势中寻找1~2个最痛点, 此点即为动痛点。

治法: 将针刺入动痛点, 得气后捻转小提插1~2分钟, 每日1次, 10为1疗程。

共治疗32例。结果: 痊愈30例, 有效2例。

刘会生 针刺动痛点治疗扭伤32例 河南中医 (4), 15, 1986

针刺加中药法

温水洗净患处，消毒后用针刺损伤局部压痛点明显处和附近经穴3~5穴，深0.5~1cm，捻转后拔针，以见点血为佳。外敷二黄浆（姜黄、大黄各3份，桃仁2份，生栀子和白芨各1份，共研末，酒醋各半调成浆糊状）厚约0.5cm，绷带包扎固定，酒水喷洒保持湿润，3日换药1次。

共治疗84例。结果：除5例腰椎间盘突出、膝关节内半月板破裂伤、股骨颈骨折转手术外余均治愈。治愈率为94%。

彭登祥 针刺加中药治疗跌打扭伤84例 四川中医 (6), 26, 1986

第四章 妇、儿科疾病

第一节 妇科疾病

1. 功能性子宫出血

艾 灸 法

1. 取穴：大敦、隐白。

2. 具体操作：患者仰卧，取双侧大敦或隐白穴（肝郁气滞型取大敦穴，脾气虚型取隐白穴，肝脾失调型取大敦、隐白同时灸）均用麦粒壮直接灸，每次5至7壮，每日一次。每壮待焰熄火存时，医者用右手拇指桡侧端将火按灭，续灸下一壮。灸后局部不作任何处理。

共治疗50例。灸1次血止，临床症状消失，随访4个月月经周期恢复正常者为显效；灸2次血止，其它症状基本消失，随访3个月月经周期恢复正常者为有效；灸3次以上，临床症状无改善或轻微改善者为无效。

50例中，显效者36例，有效者12例，无效2例，总有效率为96%。

王建德 艾灸治疗功能性子宫出血50例 陕西中医 (4); 176, 1988

穴位封闭法

局部皮肤常规碘酒、酒精消毒，用 2ml 注射器7~8号针头抽吸药物后在预选的穴位上刺入，边进针边左右旋转注射器并进退针等反复刺激，当患者有酸麻胀感即所谓“得气”后推注三七当归注射液 1ml。每次封闭 2 个穴位，每天封闭 1 次，7 次为 1 个疗程，疗程间隔为 3 天。常用穴位：子宫、关元、肾俞、内关、合谷等穴。主要方剂：黄芪 50 g，党参 25 g，生地榆 20 g，茜草 15 g，血见愁 20 g。辨证脾虚型加白术、山药各 20 g，升麻 15 g；血热型加生地、黄柏各 20 g；肾虚型加女贞子、山萸肉各 20 克；血止后去掉止血药加当归、熟地、阿胶等药以复旧。

共治疗 48。疗效标准 痊愈：子宫出血停止，临床症状消失，观察 3 个正常月经周期，经期 5~7 天，经量中等；显效：子宫出血停止 10 天以上，临床症状基本消失，但不能维持正常月经周期和经期；无效：经 3 个以上疗程治疗后，症状可缓解，但阴道流血不止，无固定月经周期。

治疗结果 本组治愈 45 例，显效 3 例，总有效率 100%。其中在 5~10 天内治愈者 32 例，11~15 天治愈者 11 例，16~20 天治愈者 2 例。

邓 荣 穴位封闭为主治疗功能性子宫出血 48 例 陕西中医 (5)，226，1991

2. 痛 经

梅花针法

取行间、隐白、公孙、太冲、三阴交、关元等穴。用 75% 酒精常规消毒。术者右手持梅花针在上述穴位上以腕力弹刺。刺时要求落针

稳准，针尖与皮肤垂直接触。每分钟扣刺70~90次。每月经前3天开始治疗，每日一次，观察治疗3个月（九次），行经期间禁食生冷和涉水。

共治疗106例。痊愈：扣刺3次后，行经3月无任何不适。显效：扣刺3次后，第一月行经略有微痛，2、3月行经无不适。进步：扣刺6次，自第3月起行经不痛。无效：扣刺9次，3个月行经疼痛虽减，但未消失。

106例中痊愈30例，显效39例，进步25例，无效12例。总有效率为88.7%。年龄29岁以下痊愈率29.1%，有效率为93.1%，30岁以上痊愈率26.5%，有效率为79.4%，表明年龄小者疗效好。病程在5年以下者，痊愈率32%，有效率为92%，病程在六年以上者痊愈率19.4%，有效率为80.7%。说明病程短疗效高。

梁淑娟 梅花针治疗痛经106例 中国针灸 (4); 25, 1987

耳道刺激法

用75%酒精先后灌满两耳的外耳道（以下简称为灌耳），然后用药棉塞住外耳道口，以防药液外流。在灌耳同时让病人看好手表，注意疼痛消失时间，待疼痛完全消失后，即可除去药棉，不需另外处理。

疼痛越剧烈，奏效越迅速，101例病人中，7例病人只灌一只耳道，疼痛在20秒内消失，39例病人灌二只耳道，疼痛在30秒内消失，53例病人亦灌二只耳道，疼痛在1分钟内消失；仅2例继发性痛经病人只减轻不消失。

林赛蓉 耳道刺激法治疗痛经101例

耳穴压迫法

取耳穴：子宫、卵巢、附件、肾上腺、内分泌、腰痛点、肝、脾、肾。治法：把胶布剪成0.5~0.5cm²大小，将王不留子贴在剪成

的胶布上，固定于以上各穴位，每三日换药一次，双耳交替贴压，嘱病人每日按揉3次，每次15分钟，以耳部发热为度，12日为一疗程，一般治疗2~3个疗程。

共治疗85例。治愈：月经期腹痛消失，随访5个月未复发。显效：治疗3个疗程腹痛消失，停止治疗腹痛明显减轻。有效：腹痛明显减轻，停止治疗腹痛如前。无效：治疗4个疗程腹痛不减轻或加重者。

治愈59例，显效17例，有效4例，无效5例，其中2例治疗2个疗程终止治疗。

观察中还发现，39例月经不调患者，治疗后27例月经周期、颜色恢复正常，血块消失，因此说明耳穴贴压对月经不调有一定疗效。

逯明霞等 耳穴压丸治疗痛经85例临床观察 河南中医 (3)，33，1991

针药并施法

1. 针灸：选取次髎、三阴交穴（针刺），关元、照海（先针后灸）。留针15分钟，每5分钟行针1次。如剧痛加归来穴；腰脊痛加命门，肾俞；胸闷加内关，胁痛阳陵泉；头晕耳鸣加悬钟、太溪；腹痛加大赫穴、气海穴。2. 内服方：丹参15g，泽兰、续断各14g，制香附、赤芍、熟地各12g，当归、玄胡各10g，红花、牛膝各4g。如有血块且多者，重用当归、牛膝；月经量过多者，加荆芥炭10g；阿胶12g（烊化兑服）；四肢或面部肿胀者，加茯苓15g；腰腿酸软困痛者，重用续断，加杜仲12g；月经先期者，加丹皮，栀子；月经后期者，加炒小茴香6g，台乌药10g；月经先后无定期者，加柴胡9g，白芍12g。

疗效标准 痛经消失，且三月经周期以上未复发者为临床治愈；此次痛经消失，但下次月经期又有不适感，再用针药治疗，疼痛消失者为显效；经治有效，而未能持续治疗者为有效；经治疗3~5天，无明显改善者为无效。

治疗结果 本组70例中，疗程最长者3个月，针灸15次，服药15剂，最短者针灸3次，服药3剂。结果治愈58例，显效7例，好转4例，无效1例。

杜见斌等 针药并施治疗痛经70例 湖北中医杂志 (2)，
24, 1990

针 刺 法

嘱患者俯卧取十七椎下，即第五腰椎棘突下方。常规消毒，直刺1寸许，待得气后，快速捻转，予强刺激，使针感向少腹传导，持续行针半分至1分钟，疼痛减轻或消失后，留针10分钟，待面色转红后起针。

共治疗64例。59例行针后半分钟至3分钟内疼痛减轻或消失，留针10分钟后面色转红，腹痛消失为痊愈；4例行针后疼痛虽减轻，但未完全消失者为显效；1例行针后疼痛无减轻者为无效。

骆方 针刺17椎治疗原发性痛经64例 浙江中医杂志 (8)，
379, 1988

针 灸 法

在经行小腹疼痛较为明显时进行针刺，施平补平泻法，留针20min，同时将灸盒放置在小腹灸治20min观察即见效果。

取主穴气海、中极、足三里；随症可配用三阴交、血海等。

共治疗30例。显效：治疗后疼痛消失；有效：疼痛明显减轻；无效：疼痛略减未缓解者。

本组30例中，显效19例，有效10例，无效1例，总有效率96.7%。

张耀华等 针灸治疗痛经30例 陕西中医 (5)，227, 1991

扬针加温针法

扬刺法：脐下三寸取关元穴，常规消毒后，用28号2寸长毫针垂

直刺入1.5寸深，得气后用提插、捻转手法，强刺激1分钟。以关元穴为中心点，上下左右1寸处，各刺一针，深1.5寸，取1.2cm长的艾段，套在针柄上点燃，每日1次，每次在每根针上连用2~3个艾段，3次为一疗程，痊愈后为巩固疗效，分别在下两月经周期治疗1~2次，23例患者均治疗了3~6次痊愈，治愈率达百分之百。

刘继先 扬刺法加温针治愈痛经23例 上海针灸杂志 (1), 14, 1987

3. 慢性盆腔炎

氦氖激光照射法

照射方法及穴位：采用低功率氦~氖激光照射穴位，波长6328埃，输出功率4mw，光斑直径1~2mm，照射距离0.5cm左右，按辨证取穴，脾肾阳虚，湿热下注，肝肾阴虚，冲任不调，均取气海、中极、子宫、肾俞、三阴交；症瘕积聚，取气海、中极、子宫、肾俞、血海，每穴照射5分钟，每周照射4次，10次为一疗程，疗程间休息7~10天。

共治疗38例。临床症状消失，妇科检查压痛、包块、增厚等均消失者为痊愈。临床症状基本消失，妇科检查有明显进步者为显效。临床症状和妇科检查均有不同程度改善者为好转。治疗后无变化者为无效。

38例中，经按上法治疗，痊愈9例，显效14例，好转10例，无效5例。愈显率为60.52%，有效率为66.84%。

吴希靖等 氦氖激光照射穴位治疗慢性盆腔炎疗效分析 中国针灸 (3), 501, 1986

隔姜灸法

(一) 方法：将病人随机分成隔姜艾柱灸与隔姜光照二组。

1. 隔姜艾柱灸组：用艾绒做成直径 1.5cm，高 1.8cm，重约 800mg 的艾柱，置于 0.4cm 厚的鲜姜片上（放在所选的穴位上）点燃灸之，每穴灸 3 壮，每壮约 6～7 分钟。

2. 隔姜光照组：是采用 8301 型经穴灸疗仪，将其灸头固定安放在穴位上，其光斑处放 0.2cm 厚的姜片，每次光照 20 分钟。

两组治疗时均要求其灸点皮肤温度保持在病人较为舒适的温热感为准，每日治疗一次，每次 20 分钟左右，共观察 2～3 个疗程。

（二）穴位：取气海、中极、归来为主穴，少数根据症状不同，也可配用大肠俞、次髎。

共治疗 71 例。临床症状消失，内诊检查阴性者为痊愈。症状基本消失，内诊检查明显改善者为显效。症状及内诊检查有所改善为有效，症状及体征治疗前后变化不大者为无效。本次二组共治疗 71 例患者，痊愈 35 例占 49.8%，显效 19 例占 26.76%，有效 16 例占 22.53%，无效 1 例占 1.41%。显效率为 76.06%，有效率为 98.59%。

张耀华等 隔姜灸治疗慢性盆腔炎 71 例疗效分析 中国针灸（6），36，1986

4. 带 下 症

针 刺 法

主穴取关元、气海、归来，肝郁带下（经前乳房胀痛及小腹、胁肋胀痛明显，心烦易怒，月经色黯块多）配穴取肝俞、血海，肾虚带下（腰痛、头晕耳鸣）配穴取肾俞、命门，脾虚带下（纳差乏力）配穴取脾俞。手法用快速进针，补法，得气后不留针。日 1 次，10 次为 1 疗程。

共治疗 144 例。经治 1～2 疗程，106 例治愈（带下正常，不外溢体外，临床症状消失，半年未发），32 例好转（带下量减少，临床症状减轻或消失），6 例无效（治疗前后无变化，或量暂时减少，但症

状无明显改善，经化验，患阴道滴虫及霉菌感染各3例。治愈者大多在针3～5次时即见显效。

王本元 辨证针刺治疗带下症一百四十四例 浙江中医杂志 (8) ; 332, 1989

5. 单纯性外阴瘙痒症

针 灸 法

针灸取穴以局部为主，辅以远端穴。分三组，可交替应用。第一组是止痒穴（耻骨联合旁开2 cm，左右各一）、蠡沟、关元。第二组是曲骨、阴廉、三阴交。第三组是次髂、委阳、支沟。

针刺手法是，针止痒穴选4寸毫针，沿皮向会阴部斜刺，轻轻捻转，不作提插，使局部有酸胀痒感为佳。针关元宜快速进针，得气后，行中等频率的提插捻转，使针感向外阴部放散。针曲骨用2.5寸毫针向下斜刺，使有兴奋感为度。在针刺的同时，用艾条在局部施温和灸，使有温热感为度。针灸余穴，遇病程短、痒甚者用泻法，刺激量要大，多针少灸；病程长、反复发作、局部症状不甚者用补法，多灸少针。一般留针30～60分钟。10次为一疗程，第一疗程后休息3天，进行第二疗程。

治疗16例中，9例痊愈，即外阴瘙痒完全消失，局部皮损有明显改善；4例显效，即瘙痒明显减轻，可忍受，皮损改善不明显；3例有效，即瘙痒减轻，但皮损无改善。其中治疗1～2疗程11例，3疗程以上者5例。

甄德江 针灸治疗单纯性外阴瘙痒症十六例 浙江中医杂志 (11) ; 501, 1990

6. 外阴白斑

子午流注纳甲法

采用徐凤《针灸大全》子午流注逐日按时开穴法治疗，依病人来诊时间，针刺该时辰开穴，除井穴外，余者得气后辨证行补泻手法，一般多用补法。疾刺不留针。不配用其它任何穴位。日针一次。

共治疗40例。临床治愈：阴痒、疼痛、皸裂、溃疡等症状和体征消失，患处色泽复原，萎缩恢复，皮肤弹性正常，7例。显效：症状、皸裂、溃疡消失，病变局部色泽呈粉红或灰黄色，萎缩明显减轻，皮肤弹性基本恢复，19例。有效：症状、体征部分消失或减轻，患处色泽有所改观，13例。无效：症状、体征无变化或加重者，1例。

阎润茗等 子午流注纳甲法治疗外阴白色病变40例临床观察 中国针灸 (4)，42，1987

艾灸加耳针法

1. 艾灸足三里（双）、三阴交（双），每穴10分钟；外阴局部艾卷灸20~30分钟，每日1次，10次为一疗程。2. 耳针：神门、外生殖器区、皮质下区、内分泌区。隔日1次，两耳交替进行，10次为一疗程。若一疗程不愈，休息5~7天，再行第二疗程。

共治20例。治愈9例。外阴变为红润或褐色，表面光滑润泽，溃疡愈合，瘙痒消失。显效8例。外阴白色变小，红润，瘙痒消失，夜能入睡。有效3例。外阴白色逐渐变红，瘙痒明显减轻，溃疡面缩小。

赵晶华等 艾灸加耳针治疗妇女外阴白斑症20例 辽宁中医杂志 (2)，37，1986

7. 子宫肌瘤

针 刺 法

(一) 取穴

子宫：一般取双侧，有时根据个别情况，可取单侧。针刺 0.8~1.0寸深（斜刺法）。

曲骨：针刺0.6~0.8寸深（直刺法）。

横骨：针刺同曲骨穴。

以上3个膻穴为主可以交替使用并配合腰部与下肢穴位。针刺曲骨、横骨穴前，尿要排空。

耳穴：常以皮质腺穴作为配用。

(二) 针刺法：一般用平补平泻，待有针感后，留针15~20分钟。隔日针一次，10次为一个疗程。

共治疗346例。

从下表可见痊愈率为83.2%，接近痊愈率为11.8%，缩小 $\frac{2}{3}$ 率为5%，总效率为100%。

	病例数	针灸次数	治 疗 情 况				
			痊愈	接近痊愈	缩小2/3	无效	有效率%
超 鸡 卵 大	12	10~11	11	1			100%
鸭卵与超鸭卵大	85	10~25	82	3			100%
鹅卵与超鹅卵大	102	10~30	93	6	3		100%
手拳与超手拳大	115	20~40	94	15	6		100%
近 儿 头 大	32	20~40以上	8	14	10		100%
合 计	346		288	39	19		

王 雨 针刺治疗子宫肌瘤346例临床观察 中国针灸 (1), 27, 1986

8. 子宫后位不孕

针 刺 法

1. 取穴：1组取阴交、气海、关元、中极、子宫（双）、三阴交（双）；2组取八髎（双）、肾俞（双）。

2. 操作方法：每次月经净后第1～3日取1组、第4日取2组为1疗程，连续2疗程；用毫针进针1～1.5寸，有针感后5分钟捻针1次，留针20～30分钟。

共治疗53例。治疗1个月经周期、孕后足月生产为显效；2～4周期为有效；5个周期不孕为无效。

显效25例，有效24例，无效4例。总有效率92.5%

李万涛等 针刺治疗子宫后位不孕症53例 陕西中医 (4)，179, 1990

9. 促 排 卵

针 刺 法

选用两组俞穴。第1组：关元、大赫、子宫、三阴交；第2组：肾俞、肝俞、十七椎下、次髎、太溪。

方法：捻转、提插、中强刺激，得气后留针20分钟。隔日1次1组，两组交替。

疗程：1个月为1个疗程，连续3个疗程。经期停针，为疗程的自然间隔。闭经者连续治疗3个月为度。

共治疗63例。显效：具有下列之一者：①受孕；②检查提示卵泡发育或排卵；③基础体温单相转为典型双相；④月经来潮达2个周期

以上。

有效：具有下列之一者：①基础体温不典型双相转为典型双相；②基础体温单相转为不典型双相；③月经来潮一个周期。

无效：治疗后无变化。

结果：显效41例，占65%，其中受孕5例，卵泡发育及排卵20例，基础体温单相转为典型双相11例，月经来潮2个周期以上5例。有效17例，占27%，其中基础体温不典型双相转为典型双相7例，单相转为不典型双相8例，月经来潮一个周期2例。无效5例，占8%。

浦蕴星等 针刺促排卵63例临床观察 上海中医药杂志 (2)，8，1991

10. 妊娠恶阻

穴位注射法

(1) 接受本法治疗的患者，除极少数因剧吐呈重度脱水和电解质失衡者应予适当补液、补充电解质外，一般均停用其他任何治疗药物和方法。(2) 患者端坐或平卧，足三里穴常规消毒后，用注射器接7号针头，吸取维生素B₆100mg/2ml，于足三里穴直刺进针1.5~3.0cm (以患者诉有酸、麻、胀、重得气感为度)，再推注药物，而后退针。每日1次，两侧交替进行。

共治疗97例。显效：穴位注射后2~8小时内吐止，可进流食，以后饮食逐渐恢复正常，并未再发生呕吐者89例，显效率达91.8%；好转：穴位注射后呕吐减少，有时尚感轻微泛呕者8例，好转率达8.2%。总有效率100%。

莫 测等 维生素B₆足三里穴注射治疗妊娠恶阻97例疗效观察 中西医结合杂志 (7)，405，1990

11. 胎位不正

耳 压 法

穴取：子宫、交感、皮质下、肝、脾、腹。用火柴头或针灸针尾在相应穴位处找到敏感点，常规消毒后，将王不留行子压贴在上述耳穴上，胶布固定。每3~4天更换新子，耳压1次，左右轮换。要求孕妇每天早、中、晚饭后约30分钟，用手指依次压穴15分钟左右；每晚临睡前，放松裤带，取半卧位，再耳压1次，次日即可作胎位检查。

169例中，矫正成功者138例，成功率为81.66%。其中初产妇矫正成功者118例，成功率为81.38%；经产妇矫正成功者20例，成功率为83.33%。经统计学处理，两者无显著性差异，说明胎次的多少并不影响本法的疗效高低。其中臀位矫正成功者128例，成功率为81.01%；横位矫正成功者8例，成功率为88.89%；足位2例全部矫正成功，成功率达100%。经统计学处理，三者亦无显著性差异，说明不同类型的胎位不正，均可收到满意的效果。在138例矫正成功者中，1次矫正成功者111例，占80.43%；2次成功者17例，占12.32%；3次成功者10例，占7.25%。可见1次矫正成功率最高，2次次之，3次又次之。169例中，怀孕7~8个月84例，矫正成功者77例，成功率为91.67%；8个月以上~9个月73例，矫正成功者58例，成功率为79.45%；9个月以上12例，矫正成功者3例，成功率为25%。经统计学处理，三者有极显著性差异（ $P<0.001$ ），从而说明孕期短者的效果比孕期长者为好。

秦广凤等 压迫耳穴法矫正胎位不正169例效果观察 浙江中医杂志 (2); 83, 1988

艾 灸 法

每天艾灸至阴穴2次，每次20分钟。

共治疗193例。转正150例，未转正43例。

黄维新 艾灸与膝胸卧位矫正胎位的对比研究 中西医结合杂志 (2); 105, 1990

针 灸 法

取仰卧位，选用双侧至阴、足三里，穴位常规消毒，进针通电（接用国产G6805治疗仪），同时点燃艾卷，在双侧至阴穴位上进行熏烤，注意热力要适当，以能忍受为度，留针时间20分钟，每日一次，7次为一疗程。

87例中，臀位66例，横位21例。66例臀位中，矫正成功者51例，失败者15例；21例横位中，成功18例，失败3例。

章逢润 针灸矫正胎位不正87例 陕西中医 (11); 516, 1987

12. 滞 产

针 刺 法

取穴：合谷、三阴交。手法：进针得气后用提插捻转手法，使针感均向上传导，尔后用6805电疗机通电，其程度以病人能耐受为宜。治疗次数：每日2次，每次留针约2小时，特别是第1次治疗，必须使宫缩达到规律后方可起针。

共治疗30例。针刺距宫缩发动时间：针刺后即出现宫缩者2例，在5分钟内出现宫缩者1例，在6~10分钟出现宫缩者12例，11至20分钟者4例，行至30分钟者7例，行至40分钟者1例，行至60分钟者2例，在2小时以内者1例。

针刺后距胎儿娩出时间：最短者2小时50分钟，最长者15小时。多数在6~10小时。

王鹤琴等 针刺治疗滞产30例疗效观察 河南中医 (2); 22,

13. 产 后 病

电针配合中药法

(一) 电针治疗

1. 取穴：合谷、子宫、归来、足三里、三阴交。
2. 手法：合谷穴直刺0.5寸；子宫、归来穴斜前刺1~1.5寸；足三里、三阴交穴直刺1~1.5寸。腹壁切口愈合欠佳取双合谷配子宫或归来穴，其余均取双合谷配足三里或三阴交穴。进针后，患者有“得气”感，用G6805治疗仪，以直流电，取连续波，频率为160~320次/分，刺激强度从0开始，逐渐增加至患者能耐受为止，时间15~20分钟，每日1次，以6次为1疗程。产后尿潴留及未排矢气患者，仅只需扎针1次。

(二) 中药治疗

1. 宫腔积血和少数子宫复旧欠佳患者，以生化汤加味：当归12g 川芎3g 桃仁10g 炮姜3g 益母草30g 蒲公英12g 五灵脂10g 蒲黄10g 甘草3g，水煎服。

各 类 症 征 疗 效 统 计

疾 病 分 类	例数	治疗 次数	平均 次数	痊愈例数 (%)	好转例数 (%)	无效例数 (%)
子宫复旧欠佳	154	375	2.4	153 (99.4)	1 (0.6)	0
子宫切口愈合欠佳	57	293	5.1	30 (52.6)	25 (43.9)	2 (3.5)
腹壁切口愈合欠佳	15	81	5.4	10 (66.7)	5 (33.3)	0
阔韧带血肿	3	23	7.7	2 (66.7)	1 (33.3)	0
宫腔积血	7	17	2.4	2 (28.6)	5 (71.4)	0
产后尿潴留	54	71	1.3	52 (96.3)	0	2 (3.7)
剖宫产术后无矢气	30	31	1.0	30 (100)	0	0
合 计	320	891	2.8	279 (87.2)	37 (11.6)	4 (1.2)

2. 切口愈合欠佳者, 药用: 丹参12g 当归12g 川芎3g 赤芍10g 桃仁10g 三棱10g 莪术10g 夏枯草12g 生牡蛎12g 穿山甲6g 蒲公英12g 甘草3g, 水煎服。

产后尿潴留及未排气者, 一般不须用药, 针刺即愈。

共治疗320例。痊愈: 临床症状消失, B超复查切口愈合好, 液暗区、低回声区、强光团等消失者; 好转: 临床症状明显减轻, B超复查切口处液暗区等缩小者; 无效: 治疗1个疗程后, 液暗区等无变化者。

按以上标准评定, 痊愈279例(占87.2%), 好转37例(占11.6%), 无效4例(占1.2%), 总有效率为98.8%, 各类症征疗效见上表。

钱平等 电针配合中药治疗产后病的体会 湖南中医杂志 (6), 12, 1990

14. 产后尿潴留

针 刺 法

取关元、中极、阴陵泉(双)为主穴, 配三阴交(右)复溜(左)为辅穴, 直刺8分~1.5寸, 留针20~30分钟, 每5分钟行针一次, 以平补平泻手法, 关元、中极针感均要达尿道口, 其它穴针感最好沿下肢内侧至阴部, 如膀胱高度充盈者, 可以用右手中指以适当指力按压中极3~5分钟; 因剖腹产所致尿潴者以针刺远端穴位为主。

治疗结果: 显效(针刺一次后30分钟~2小时, 能自行排尿且通畅)154例, 占76%; 有效(针刺2次后自行排尿且通畅)46例, 占23%; 无效(针刺3次后仍不能自行排尿)2例, 占0.1%, 总有效率达99%。

鄂建设等 针刺治疗产后尿潴留202例 湖南中医杂志 (1), 23, 1991

针 刺 法

患者取仰卧位，常规消毒后，以 28—26 号毫针，针刺双侧三阴交，平补平泻，留针 20—30 分钟，每隔 5 分钟行针一次。

共治疗 50 例。经治一次即能解出小便者 43 例，二次后能解出小便者 5 例，3—5 次后仍不能排尿者 2 例。

马小平 针刺三阴交治疗产后尿潴留 江苏中医 (2)，27，1988

电子针灸法

采用福建霞浦电子仪器厂生产的 LY-5 型电子针灸按摩器，针灸频率调至 8.5~10.0Hz，电极面积 $0.8 \times 0.8 \text{cm}^2$ 。分别置曲骨、中极、双侧三阴交穴，每穴持续刺激 3~5 分钟。治疗时安慰患者，消除其紧张情绪，并令患者排尿。

共治疗 44 例。经治疗后，患者能自行排尿为治愈。本组 1 次治愈者 41 例 (93%)，其中治疗后 <10 分钟自行排尿者 7 例，10~20 分钟自行排尿者 34 例，2 次治愈者 3 例。

朱 丹等 电子针灸穴位治疗产后尿潴留 44 例 中西医结合杂志 (6)；359，1990

15. 产后缺乳

针 刺 法 (一)

主穴取 1. 乳根 (双)，膻中 (向左右横刺)；2. 屋翳 (双)、少泽 (双、点刺出血)。

两组穴轮换使用，每天针刺一组，肝郁型加配太冲，平补平泻，

气血不足加配足三里用补法；无症可辨者不加配穴，先做通思想工作，使其认识到母乳喂养的优点，哺乳对母亲体形健美的促进作用。不论何型针后均加艾条灸，每次5~10min，5次为1疗程。

共治疗67例。症状消失，乳汁增多，可满足婴儿需要者为痊愈；症状减轻，乳汁增多30%以上为好转，乳汁增多不足30%者为无效。

痊愈56例（占83.5%），好转9例（占13.4%），无效2例（占3.1%）。

潘纪华 针刺治疗产后缺乳67例 陕西中医 (5); 223, 1991

针 刺 法 (二)

1. 取穴：足三里、乳根、膻中、少泽。2. 具体操作：患者取仰卧位，全身放松，首先取足三里穴双，中等刺激，再取乳根穴双，沿皮下向乳房方向进针1~1.5寸，使针感向四外扩散，发胀。再取膻中穴，沿皮下向两侧乳房方向进针1~1.5寸，上穴各留针15分钟后出针，再点刺少泽穴见血。针后让患者双手放平，由膻中向乳头方向按摩5~10分钟，以增加针效。

共治疗286例。1. 疗效标准：经治疗后能满足乳儿需要者为痊愈。能达到乳儿需要50%者为有效，低于20%以下者为无效。2. 分型疗效：肝郁气滞者痊愈率占82.7%。治疗次数，最少1次，最多6次。气血两虚者有效率为2%。治疗次数1~6次。

颜世贵等 针刺治疗产后缺乳症286例 中国针灸 (3); 19, 1986

乳三针灸法

“乳三针”取法，先定一条标定线，令患者屈肘微握拳，拳与肩平，手心向前方，从大陵穴起至少海穴旁开2分为止，此长度为标定线。再用标定线去量取此三穴。乳源，以标定线长度从膻中穴起平行至该线之尽头为穴。乳海，将标定线对折成为1/2长，从乳头起（平第

四肋间隙，锁骨正中为起点）向下垂直量之尽头即穴。乳泉，取标定线的1/2长，从乳源穴起平行向背后量至尽头即穴。针灸方法，乳三针逐一针之，向乳中心方向针刺1~1.5寸，施小幅度捻转，乳房内有胀感为得气。再施针膻中穴，向下平刺1.5寸，得气后均留针五分钟。乳三针再加艾条灸5分钟。肝郁气滞者加太冲（或少泽）泻之，以疏肝解郁通络；气血亏虚者加足三里，以补气健脾养血；伴头痛失眠者加风池，意在清头宁神。

治疗本证69例，痊愈49例，好转15例，无效5例。

刘志谦 乳三针治疗缺乳 辽宁中医杂志 (3); 35, 1987

耳 压 法

取穴：主穴选用胸区（取压痛敏感点处）、内分泌、交感。肝郁气滞型加肝、神门；气血虚弱型加脾、胃。操作：耳廓常规消毒，把王不留行籽固定于0.3cm²胶布中央，贴于所取穴位上，两耳同时应用，3天换1次胶布，留置过程中嘱患者每日按压5~6次，一般多在哺乳前半小时进行。按压时以达到酸、麻、胀、热感为宜。

共治疗30例 以乳汁增多、充足、婴儿吃不完为痊愈；乳汁从无到有、从少到多，但尚不能满足婴儿吃饱为好转；治疗时乳汁增多不明显，或稍有增多，但仍需每天加喂奶粉者为无效。

治疗结果 本组30例中，痊愈21例，好转7例，无效2例，总有效率为93.4%。

景 宽等 耳穴贴压治疗产后缺乳 30 例 陕西中医 (11); 517, 1990

针 灸 法

1. 虚型：治疗取穴：膻中、中脘、脾俞、胃俞、足三里、合谷。用捻转补法，针后加灸，留针10~15分钟。

2. 实型：治疗取穴：膻中、乳根、天宗、期门、少泽、内关。

用捻转泻法，留针20分钟，每5分钟行泻法1次。

3. 虚实夹杂型：治疗取穴：膻中、膺窗、乳根、内关、足三里。用平补平泻法，留针15分钟，针后可灸。

共治疗50例。显效：针后流乳，自觉乳房发胀，足够婴儿食用，不必加代乳品。有效：针后乳汁比治前增多，但仍需加用少量代乳品。无效：乳汁分泌缺少仍同治疗前。

本组50例，除2例仅针1次中断治疗外，其余48例中，显效28例，有效20例。总有效率为96%。治疗次数均经2~10次。

杨元德 针灸对乳少50例的辨证论治 陕西中医 (7)；327，1988

16. 急性乳腺炎

针药并用法

中药以疏肝清胃为主：蒲公英20g，金银花30g，连翘12g，青皮、陈皮、归尾各10g，生甘草6g。热盛者，加黄芩；肿块硬结者，加皂刺、穿山甲；疼痛甚者，加香附、金铃子；大便干结，加大黄。

针刺涌泉穴：取卧位，皮肤用酒精消毒后，快速进针，手法以强刺激震颤约2分钟，留针10分钟。拔针后再用吸乳器将乳房之乳汁吸尽。

局部处理：取鲜蒲公英150~200g洗净，捣烂成泥糊状，外敷患处，一日2~3次，用于乳痛早期硬结阶段。红肿硬结不消，可用安福消肿膏或金黄散外敷。脓肿成熟，及时切开排脓引流。

治疗104例中，治愈75例，占72.1%；自溃而愈者19例，占18.2%；经切开排脓而愈者10例，占9.6%。

徐昌陵 中药和针刺治疗乳痛104例 江苏中医杂志 (11)，13，1987

针 刺 法

体位：病人端坐、侧卧、俯卧均可。**部位：**背部肩胛间区，上平第七颈椎棘突水平线，下至两肩胛骨下角连线，外齐两肩胛骨内侧缘，脊柱棘突连线两侧区域的皮肤和毛囊孔都可作针刺点。**操作：**暴露上区皮肤，常规消毒，不取穴位，不分左侧右侧乳腺炎，也不论炎症所在象限。用选好的治疗针（取小号银针、钢针、或5～6号注射针头亦行）随意垂直刺入皮下。采用强刺激，以病人难以忍受或针下有明显挟持感为度。每一针刺点行针约1～2分钟，可逐一分点针刺行针，亦可同时刺入3针后循环行针，不留针。刺入深度按病人体质胖瘦而定，以不伤及胸膜为准。每日1次，每次2～3针，针次以愈为限，通常2～3次，如有全身症状消失，局部仍有无痛性硬结者需继续治疗致硬结消散。

共治100例。治愈：全身和局部症状消失，检查无异常，随访无复发者。无效：全身症状未好转，有脓肿形成或加用抗生素者。有效：全身症状消失，局部红肿消退部分或加用其它药物者。

病程在3日内98例，治愈96例，无效2例；病程超过3日2例，有效1例（后加服中药3剂愈），无效1例。治愈率96%。治疗中仅少数病人感头晕、心慌、恶心、出冷汗等不适，仅停针拔针后平卧休息片刻自行恢复，无需用药，未见其它反应，亦不影响下次治疗。

林更焰 针刺治疗急性乳腺炎100例 陕西中医 (8); 368,
1989

梅花针点刺拔火罐法

1. 操作。先将患侧局部红肿处常规消毒后，用梅花针叩打数次后，赶快将火罐拔在患处，过15分钟取下火罐，擦去血迹即可，隔日一次。2. 配穴：如有严重患者可加足三里、期门。手法：快针刺入用

泻法。

共治疗30例。一天内局部肿块消失者为痊愈；2—3天内局部肿块较治疗前消失50%以上者为显效；4天以上者为无效。治疗效果：30例患者经治疗后单侧急乳20例：痊愈10例、显效9例，无效1例总有效率为95%。双侧急乳10例：痊愈5例，显效3例，无效2例，总有效率为80%。

王桂英 梅花针点刺拔火罐治疗急性乳腺炎30例 内蒙古中医药 (1)，26，1989

针刺加拔火罐法

主穴为阿是穴（背部和乳头相对处的穴位）。

配穴为内关（左侧乳肿针右侧，反之针左侧）。

方法：用28号1寸或1寸5分毫针刺入背部和乳头相对点，进行捻捣手法，患者有麻胀感觉后继续捻捣3—5分钟后快出针。立刻在针孔上拔火罐，越紧越好，最好在针孔上拔出血珠。笔者在临床上拔罐时间一般超越常规范围，三十分钟左右看针孔有血珠即可。拔火罐后，立即行针刺内关穴，快速刺入，针尖稍向上斜捻捣，针感传导至上臂处则停捻，留针15分钟起针。乳痛初起只是红肿还没有结块者，采取上述疗法，治疗1—2次即可消肿。如果乳房红肿有结块，排乳不畅，严重时伴有发热，发冷等全身症状，除用上法外可配合中药治疗。

治疗乳痛12例，就诊者大多是产后炎症初起，红肿疼痛。10例患者经1—2次治疗即告痊愈，没有配合其它中西药物；有1例经4次治疗，肿痛全消；有1例接近化脓期的患者，配合口服中药汤剂，外敷消炎膏而痊愈。

韩冰 针刺加拔火罐综合治疗乳痛 中医药学报 (2)，31，1988

17. 乳腺小叶增生症

耳 压 法

取耳穴交感、内分泌、皮质下、乳腺、垂体、卵巢、子宫、肝等8个穴位。常规消毒后，用伤湿止痛膏剪成 0.5×0.5 厘米大小，将王不留行籽粘压固定于所取穴位，拇、食指分别置耳穴内外两侧进行压揉，直至耳部潮红、发热。一般于月经前半月开始治疗，每隔3日换药1次，每日按揉3次，每次15分钟，连续3个月经周期。

共治疗35例。痊愈（胀痛解除，结节消失）18例；好转（症状减轻，结节缩小）9例；无效（症状、体征无改善）8例；总有效率为76.1%。

沈志忠 耳压治疗乳腺小叶增生症35例 江苏中医 (8), 81, 1989

18. 乳腺增生

针 刺 法

乳腺增生病的病机主要是肝气郁结、胃经经气不畅所致，故治以疏肝解郁，疏畅胃经之气为法而选穴，并据证加减。

甲组：屋翳（双）、膻中、合谷（双）。

乙组：肩井、天宗、肝俞（均双侧）。

加减：肝火去合谷加太冲；肝肾阴虚去肝俞加太溪；气血两虚去合谷加足三里；月经不调加三阴交。

刺法：屋翳穴针体呈15度向外平刺1.5寸；膻中穴向下平刺1.5寸；天宗穴针体向外下45度刺1寸；其它穴位按常规刺法进行。两组

穴位交替使用，每日1次，每次留针20~30分钟，行针2~3次。手法虚补（小幅度、低频率提插捻转），实泻（操作同补法相反）。

疗程：10次为一疗程，每一疗程结束后，休息3~4天，再行下一疗程。

3. 临床疗效：114例患者中痊愈62例，显效33例，有效13例，无效6例，治愈率为54.39%，总有效率为94.74%。

郭诚杰等 针刺治疗乳腺增生病114例疗效观察及机理探讨 陕西中医 (5), 193, 1988

微波针灸法

选用 DBJ-1 型微波针灸仪（华北光电研究所产）为治疗仪器。患者均选用：（1）乳根（双），阳陵泉（双）；（2）膻窗（双），膻中。两组交替。气滞痰凝型加丰隆或足三里。气滞血瘀型加血海或膈俞。

治疗时将无针辐射器放于所取穴位上，调整调节器幅度，至患者有温热针感为度，一般20~25伏。开始治疗每穴20分钟，症状减轻后每穴15分钟，每日一次（少数患者隔日一次）。10次为一疗程，连续治疗2个疗程后休息5~7天。

本组53例，经2~5个疗程治疗，肿块、疼痛均消失评为痊愈者25例（47.2%）；肿块缩小1/2以上，疼痛消失或肿块消失，疼痛减轻评为显效者13例（24.5%）；肿块缩小不到1/2，疼痛减轻或消失评为有效者12例（22.6%）；肿块与疼痛改善不明显评为无效者3例（5.7%）。

袁 硕等 微波针灸治疗乳腺增生病53例疗效观察 中医杂志 (6), 55, 1987

19. 乳 痛 症

针 刺 法

因乳痛症与肝有关，故以疏肝理气及局部用穴为主。取穴：甲组

穴：屋翳（双）、膻中、合谷（双）。

乙组穴：肩井、天宗、肝俞（均双）。

加减穴：肝肾阴虚型去肝俞加肾俞；月经不调加三阴交；胸闷肩臂酸困加外关；气血亏损去合谷加足三里、气海。

方法：以上两组穴交替使用，每日一次，留针20~30分钟，留针期间运针2~3次。

10次为一疗程，每一疗程结束后休息3天。

共治疗36例。近期治愈：乳痛及向肩臂部放散完全消失，乳腺腺体恢复正常无压痛；显效：乳房疼痛明显减轻，但遇情志不畅或经前及劳累后乳房略痛，腺体微压痛；有效：乳痛减轻，但遇情志不畅、经前或劳累后疼痛略减或同前，腺体有压痛；无效：症状体征无变化。

36例中，近期治愈19例，显效10例，有效5例，无效2例。总有效率为94.5%。

张彩梅等 针刺治疗乳痛症36例疗效观察 陕西中医(6)；275，1988

20. 预防人流综合征

针 刺 法（一）

取穴 取子宫（双侧）、三阴交（双侧）、合谷、内关等穴。

方法 病人取截石卧位，用不锈钢毫针，常规消毒局部，以中等强度刺激两侧子宫穴、三阴交穴，留针并捻转提插至手术完毕。术中出现恶心、呕吐等症状者，加刺合谷、内关等穴。

共治疗102例。在人工流产术的全过程中，根据病人的病情及子宫收缩好坏和阴道流血量的多少，将人工流产综合反应分为4度。

1. 无反应：病人无任何不适，子宫收缩好，阴道流血量少，29例。
2. 轻度反应：病人感觉下腹胀痛，56例。
3. 中度反应：病人感觉下腹胀痛难忍，面色苍白，阴道流血和

子宫收缩一般，17例。

4. 重度反应：除出现中度反应的症状外，还有出冷汗、恶心、呕吐、胸闷，甚至昏厥，阴道流血量多，子宫收缩欠佳，无。

周艳华 针刺对人工流产综合反应的疗效观察 湖南中医杂志 (3), 29, 1988

针 刺 法 (二)

取穴：1. 主穴：中极。2. 配穴：三阴交、人中、承浆。

方法：常规消毒，中极直刺1.5寸，快速捻转（不作提插）1分钟，中等刺激，体弱者再适当减轻刺激强度，隔3~5分钟捻转1次，20~30分钟后出针，即可行人流术。一般在吸宫时腹部疼痛或不舒多已甚微，个别在吸宫时尚感腹部不舒较显者可针人中、承浆，均向上斜刺0.3寸，余法同刺中极，吸宫净后出针，若吸宫净后出血量多者加针三阴交，方法同刺中极，一般刺单侧即可，下血不多后再出针。

共治疗20例，术后均未发生人流综合征。

吴善法 针刺预防人流综合征 江苏中医 (9), 18, 1990

21. 脏 躁 病

针 刺 法

针法 患者取坐位、卧位均可，一般取坐位为宜。术者用左手持纱布块，将患者下唇拉开，露出下唇系带。局部消毒后，右手持一寸毫针，与下唇系带呈30度角，稳、准、快地刺入减痛点内一分左右深。根据病情的虚、实、寒、热而施以补法、泻法或平补平泻法。若

能辨证施针，常可收到卓效。补法：术者右手持针，拇指向前推，食指往后拉，按顺时针方向，搓针百次，患者觉有温热感，适于虚寒症。泻法：术者右手持针，拇指向后拉，食指向前推，按逆时针方向，搓针百次，患者觉有凉爽感，适于实热证。平补平泻法：术者右手持针，拇、食两指用同等幅度，来回一进一退，搓针百次，患者觉有舒适感，适于虚实夹杂症。

每日针1~2次，七天为一疗程。针刺后，必须每隔15分钟，搓针百次，以增强疗效。根据病情轻重而定。一般留针30~60分钟为宜。

共治疗359例。痊愈143例，针后自觉症状完全消失；显效165例，自觉症状明显改善；好转40例，自觉症状有所减轻；无效11例，针1~7次，症状未见改善。总显效率为85.8%。

张耀武 针刺减痛点治疗脏躁病 辽宁中医杂志 (6); 43, 1986

22. 功能性肢体瘫痪 (绝育术后神经症)

针 刺 法

首先要使患者对医生有高度信赖，对针刺治疗有高度的信心，患者治疗的信心十足，只要患者具备这三点方可进行针刺治疗。1. 普通针刺“泉中”穴，（涌泉穴后2cm）当病人出现针感后，说明患者深浅感觉瞬间恢复，不起针让患者在床上活动患肢，然后立即下床行走。2. 电针：通过上述治疗患者仍无针感，可在上述穴位上给予电针，采用国产普通电针治疗机用高频率，病人能忍受为输出强度，当患者出现针感可让其活动患肢。有的患者采用电针神经干，具体方法是：上肢针刺臂丛神经（相当于扶突穴），桡神经（相当于曲池穴），下肢取股神经（相当于冲门穴），和腓总神经（相当于阳陵泉穴），以每分钟60~80次频率刺激，此时上述神经支配的肌肉即可出现规律

的收缩，病人针感迅速出现。

共治疗200例 治愈：指患者感觉、运动恢复正常，从事工作，其它神经症状消失者。未愈是指通过治疗感觉恢复而运动或其它神经症状未消失者。一次针刺或电针治愈者189例占94.5%，两次以上治愈者7例占3.5%，未愈者4例占2%，总治愈198例，治愈率98%。

赵吉民等 针刺治疗女性绝育术后神经症分析 辽宁中医杂志 (9), 37, 1988

第二节 儿科疾病

1. 腮 腺 炎

灯火灸法 (一)

选患侧角孙穴（将耳轮角向前曲折，当耳尖所指部位），剪去该处的毛发，面积约五分硬币大小，用三寸长灯心草（可用纸卷成火柴棒粗代替），少蘸桐子油（或菜籽油），迅速将灯心草油火点在穴位的皮肤上，一点即起。每当灯心草油火接触皮肤时，就会发出“啪”的响声。每次一至二壮，一天一次，施灸后穴位处可呈现绿豆大的白泡，嘱患者不要抓破。白泡会自行消退。

共治疗334例。治疗四次评定疗效，结果：痊愈312例（2次治愈的85例，3次治愈的165例，4次治愈的62例），有效5例，无效17例。

胡德华等 灯火灸角孙穴治疗腮腺炎 334例 湖北中医杂志 (6), 49, 1988

火 柴 灸

1. 取穴：角孙、大迎、外扁桃穴。主穴：角孙，治腮腺炎。配

穴。大迎、扁桃穴，治疗预防并发症。

2. 操作方法：将角孙穴定准，剪少许穴位旁头发，约 1.5×1.1 cm（不影响操作者不剪），选用一支粗而坚硬的火柴棒，划燃，以火柴棒之火对准穴位呈垂直方向迅速按于穴位之中央（火即自燃熄灭），火灸后局部皮肤发红，或呈白色，别无不适和异常。

大迎穴和外扁桃穴定准后常规消毒，进针1 cm左右，强刺激不留针，无并发症及颌下淋巴结不肿者不用此穴。每日治疗1次，3~5天一疗程（一般1~3次痊愈，多者3~5次，包括并发症）。

共治疗504例。腮腺部红肿及颌下淋巴结肿大消失者为痊愈，共464例；症状明显减轻者为显效，共36例；经治疗后症状无任何改变者为无效，共4例。

王春辉等 火柴灸治疗腮腺炎504例 陕西中医 (5); 232, 1988

灯火灸法 (二)

小艾条一端蘸桐油少许，点燃后对准患侧列缺穴（桡骨茎突的上方，腕横纹上1.5寸，以左右两手虎口交叉，食指尽处两筋骨罅中）。迅速点灸，一触即起。此时该穴处可发出清脆的“嗒”一声响，则为操作成功。点灸后局部起一小水泡，数日后结痂自愈。如两侧腮腺同病，取双侧列缺穴。点灸1次后，疼痛即缓解，腮腺部位逐渐消肿。

86例中除并发睾丸炎1例，颌下腺炎1例的加用抗菌素外，其余全部灸愈。

杨兆惠 灯火灸列缺穴治疗流行性腮腺炎 湖南中医杂志 (6); 28, 1988

耳穴点刺放血法

1. 先用酒精棉球消毒耳廓的耳尖穴。

2. 用消毒后的三棱针迅速点刺耳尖穴，使其出血，用双手挤出数滴血即可，然后用消毒的干棉球敷盖点刺的穴位上。

8. 一般双侧的点刺双侧的耳尖穴，一侧的点刺一侧或交替点刺。

4. 一般1~3次为一个疗程，每日点刺1次。

1 共治疗30例。痊愈：3天以内症状及体征全部消失者。

2 有效：3~6天症状及体征全部消失者。

3 无效：6天以上能痊愈者。

30例流行性腮腺炎患者，耳尖点刺一次放血后，临床症状均有不同程度的改善，一般患者治疗1~2次，自觉症状均有减轻。发烧减退的24人；腮腺肿疼症状基本控制的20人；痊愈22例，有效6例，无效2例。总有效率达93.3%。

陈少孚 耳穴点刺放血治疗流行性腮腺炎疗效观察 天津中医(6)，19，1987

火柴点烧法

取穴：取患侧角孙穴，双侧患者取双侧。方法：将患侧耳壳向前曲折，耳尖正上方入发际处，剪掉毛发，用龙胆紫作标记，75%酒精棉球消毒后，点燃火柴对准角孙穴一烧即可，一般一次痊愈。如果患者发烧38℃以上可加用中药蓝花汤（自配方）：板蓝根20~30g，银花10~15g，甘草6~10g。

共治疗81例 点烧一次后病人耳下无压痛，逐渐消肿，可进食物者为痊愈。点烧一次后局部仍肿少痛，可进食者为有效。点烧后症状如前者为无效。81例患者中痊愈者80例（98.8%）。总有效率100%

张 洪 火柴点烧治疗腮腺炎81例 中国针灸(2)，26，1987

针刺放血法

穴位以少商穴为主，配合谷穴。将少商穴严密消毒，用三棱针点刺，挤压出3~6滴血。再配合针刺合谷，施平补平泻，不留针，每日一次。

共治疗350例。腮腺肿痛症状消失者为治愈。350例中，经一次治疗痊愈者165例，二次者142例，三次者43例，疗效达100%。

孙景德等 针刺放血治疗流行性腮腺炎350例 中国针灸 (2), 14, 1987

灸耳尖穴法

(1) 取耳尖穴 (位于耳廓上方耳轮的顶端)。(2) 取穴方法: 将耳廓向前折叠, 在耳轮最高处之尖端点以紫药水作标志; 以左侧患病取左, 右侧病取右, 两侧同病取治双侧耳尖穴。(3) 灯火灸法: 右手取灯芯一根, 一端蘸以菜油 (油渍长度约0.5厘米, 拇指与食指距蘸油的一端约1厘米), 点燃后对准穴位迅速点灸, 并略带按压, 一触即离。灯芯火随即熄灭, 与此同时, 可发出清脆的“喳”一声爆响, 可作为操作成功的标志, 如无爆响则应按原法重做。点灸局部起一小水泡, 无需处理, 数日后结痂自愈。

共治疗78例。采用本法, 每天治疗1次, 2天内腮腺肿胀等症状完全消退者19例, 3天者21例, 4天者32例, 5天者6例。

杨樟辉 灸耳尖穴治腮 中国针灸 (3), 56, 1987

针刺敷药法

(一) 针刺 1. 取穴: 主穴: 翳风、经验穴 (耳垂下3分); 配穴: 曲池、合谷、丰隆、足三里。有恶寒发热者加外关; 睾丸肿痛者加太冲、曲泉; 高热、昏迷、痉厥者加人中、大椎; 张口困难者加颊车。2. 方法: 泻法强刺激, 留刺15~20分钟, 每5分钟捻转1次, 每日针1次。年龄太小或不能配合者可不留针, 每日针2次, 先针后敷药。

(二) 敷药 轻者用鲜蒲公英捣烂外敷患处; 重者用青黛散加醋调敷或加蒲公英, 或用紫金锭外敷, 每日2~3次。

共治疗200例。以红肿疼痛消失, 体温降至正常, 其他症状消失

为痊愈标准。

2天痊愈者108例，3天痊愈者82例，4~5天痊愈者9例，1例合并肺炎、高热、抽搐，配合使用抗菌素及中药普济消毒饮内服，7日痊愈。

黄中柱等 针刺敷药治疗疳腮200例 湖南中医杂志 (4): 44, 1990

2. 百日咳

强督充任五指点穴法配合穴位药贴法

1. 五指强督点穴手法：患儿俯卧或由大人扶抱，暴露背部，医者站于一侧，始用小鱼际由骶部循脊椎两旁揉按至大椎穴，往返3—5分钟，尔后中指指端居大椎穴，其余四指自然分开，分居于膀胱经侧1、侧2线。首先从大椎穴部按5次/秒的速度循脊椎节节而下点打至尾椎部，往返3分钟。然后改施振颤手法，从大椎穴部循脊振颤至尾椎部，往返3分钟。最后同样顺序施以揉按推拿手法。

2. 五指充任点穴手法：患儿取卧位，医者中指居天突穴，食指与无名指分居胸骨旁侧，大小拇指分居锁骨中线乳根穴处。首先五指指端点打所居部位2分钟，然后中指沿任脉经，其余四指保持原姿势的距离揉按下行至膻中穴部，振颤该穴部2分钟后又揉按下行至神阙穴部，振颤该穴3分钟。稍停片刻，术者掌根贴腹，以患儿神阙为中心，先按逆时针方向摩腹2分钟，再按顺时针方向摩腹2分钟即可收功。

说明：点穴手法宜缓柔忌暴烈，以皮肤出现潮红为度，点穴时间是以5岁小儿为基准，医者可根据患儿年龄大小，形体强弱适当调整，此法每日一次，5天为1疗程，2个疗程无效则停止治疗，一般不服任何中西药物，治疗期间注意保暖，戒生冷油腻食物。

3. 穴位药贴：取吴茱萸、生大蒜、细辛、葶苈子、檀香、百部

各10g，甘遂5g，麝香1g，研极细粉，装瓶备用，用时取药粉10g，用猪胆汁或鸡胆汁适量调如稠膏状，点穴之后分别贴敷在涌泉、神阙、身柱、膏肓等穴，外用胶布固定，每天贴8—12小时。

共治疗103例。痊愈：典型症状消失，白细胞总数及淋巴细胞正常，无并发症者86例。

显效：主症大部分消失，白细胞总数及淋巴细胞接近正常，无并发症者7例。

有效：症状明显减轻，增高的白细胞数及淋巴细胞明显减少，无并发症者5例。

本组治疗最短3次，最长11次，平均5次。

黄际群 强督充任五指点穴法配合穴位药贴治疗小儿百日咳103例 江苏中医 (7)，23，1988

针 罐 法

(一) 处方：列缺T、合谷T、足三里T、大椎↓○。

注：“T”针刺，“↓”点刺放血，“○”拔罐。

(二) 刺法：每日针治一次，五次为一疗程。每次均依处方穴位顺序之先后，先针前三穴，留针15分钟后起针，再点刺大椎穴拔罐，留罐3—5分钟后起罐。第一疗程中咳止即可停针。若咳不止，停针休息一日再针第二疗程。咳止后二日即做白细胞相复检。

共治疗63例。痊愈：凡阵咳、喉鸣、痰涎、呕吐、面目浮肿等证候完全消除，白细胞相恢复正常，患儿全身一般情况皆恢复常态者。

好转：大部证候缓解，但阵咳及白细胞相尚未完全恢复者。

无效：凡诸证候不显减轻甚或加重者。

63例中痊愈者58例，占92%；好转者2例，占3.2%；无效者3例，占4.8%。痊愈者中原有咳喘病者3例，均针6—8次而痊愈消除，白细胞相恢复正常。好转者中原有慢性咳喘病1例，经针9次；另1例固有较重咳喘病，经针10次后余轻度痊愈而停针。无效者中1例针3次阵咳虽减轻，但突然并发脑病而急诊入院；1例并发肺炎针

5次亦停针入院；1例原固有重症哮喘针5次痉咳尤重而停针。

陈子富 针罐治疗百日咳63例疗效观察 黑龙江中医药 (8),
37, 1986

针 刺 法

取穴：四缝穴。刺法：患儿取坐位，仰掌伸指，穴位局部及针具严密消毒。医者左手握住患儿指尖，右手持针，按食、中、环小四指的顺序，用28号1寸不锈钢针或三棱针点刺0.1~0.2寸，挤出少量黄色透明样粘液或血液，隔日一次，三次为一疗程。一般一个疗程即可获愈。

共治疗50例。临床症状及体征完全消失者43例，临床症状及体征基本消失者5例，临床症状及体征明显减轻者2例。

李明山等 针刺四缝穴治疗百日咳50例 吉林中医药 (6),
33, 1987

针刺及穴位注药法

针刺取穴：少商、商阳、大椎。常规消毒后，用三棱针点刺少商、商阳二穴出血如粟米状；大椎点刺以出血为度，拔罐5~10分钟。隔日一次，5次为一疗程。

穴位注射：天突、曲池（双）、肺俞（双）、足三里（双）。胎盘组织液4ml，吸入注射器。用4½号针头，常规注入穴位，每穴0.5ml。隔日一次，与针刺交替使用，5次为一疗程。

共治疗106例。2次治愈54例，3次治愈31例，5次以上治愈8例（合并哮喘3例，肺炎5例）。无效13例。

王 文等 针刺及穴位注药治疗百日咳 四川中医 (4), 52,
1991

三棱针点刺法

本组除6例就诊时体温在38~38.5℃配合应用庆大霉素肌肉注射

外，余均采用单纯针刺疗法。取经外奇穴四缝穴（双侧），在常规消毒下用三棱针疾速点刺后挤出少许澄明黄色液体或血液，并以消毒干棉球拭去即可。一次未效者，次日继针二次。

共治疗116例。1.痊愈。痉咳消失，时有单声咳嗽，但无痰液者；2.显效：痉咳明显减少；3.无效：病情无明显改善。

治愈83例，其中针一次治愈者42例，二次治愈者41例，显效33例，有效率为百分之百。

孙福生等 三棱针点刺四缝穴治疗百日咳116例 陕西中医函授（5）；25，1989

3. 小 儿 麻 痹

针 灸 法

一、急性期：针刺取穴：大椎、曲池、合谷、足三里，以达清热镇静和增强抵抗力。如果肢体瘫痪已经出现，体温还高，精神萎靡、颈项强直或软弱，情绪激动，应针刺风府、哑门、大椎、陶道、命门、腰阳关等穴，以达清热醒神，阻止瘫痪进展之功效。再根据瘫痪部位局部取穴，促进肢体功能恢复。

在急性期采用速刺手法，达到一定深度，捻转提插3~5次，不多停留即行出针。刺风府、哑门宜缓慢进退，捻转幅度不宜过大，刺针方向要直对鼻尖，刺针深浅要视患儿年龄，体质而定，（无经验者宜慎重，切不可深刺）每日一次，直至体温、情绪等正常为止。

二、恢复期和后遗症期：

1. 针法：针刺用轻刺激一补法。得气即止，不留针。

2. 灸法：施行温和灸，每次选3~4个主穴，每穴约灸5~10分钟，达到局部潮红，微微出汗，皮肤湿润为度。以能起到疏通经络，温暖肌肉的作用。

3. 疗程：本病是慢性疾病，必须长期耐心施治，一般前三天每

天针灸一次，以后隔日一次，一个月为一疗程，休息20天再继续治疗。避免患儿过度疲劳，影响疗效。不限几个疗程，根据病情需要，可长期耐心施治。

共治疗2296例。治愈：症状、体征消失，功能恢复正常。

基本治愈：临床症状基本消失，肌肉稍有萎缩，但不松弛，皮温接近正常，畸型基本矫正，功能恢复接近正常。

显著好转：萎缩肢体较治疗前明显增粗，大部肌力提高二级以上，畸型部分矫正，患部功能部分恢复。

好转：症状、体征较治疗前减轻，肌肉松弛和瘫痪程度好转，部分肌力提高1~2级，功能有所改善，但萎缩肢体无明显增粗。

无效：经治疗二至三个疗程后基本无变化。

2296例患者中，治愈的639例，为27.83%；总有效为2276例，为99.12%。住院时间最长的320天，最短的15天，大多数为2~4个月。

秦宁泰等 针灸治疗小儿麻痹 2296例临床报道 中国针灸 (6); 2, 1986

4. 小儿麻痹后遗症

氦氖激光穴位照射法

辨证归经，循经论治：在治疗中根据患者病变的部位，经络分布和循环走向，结合麻痹肌肉的分布和功能状态而选择有关穴位组方。采用西安激光仪器厂生产的氦氖激光治疗机，波长6328埃，输出功率5~7毫瓦，功率密度为9600毫瓦/平方厘米，光针芯径 $\phi < 200$ 微米。光斑直接对准穴位，每次选4~6个穴位，每穴位照射8分钟。每日照射1次。12次为1疗程，间隔1周，再施行下1疗程，3个疗程为1阶段。2个治疗阶段之间须休息3个月。

共治疗100例。显效：跛行纠正或基本纠正，能跑步，行走3公

里以上，患肢蹬力20公斤，单肢跳40次，肌力差缩小3/4以上，肌围差缩小1/3以上。有效：治前拄单拐或扶腿助行，治疗后弃拐行走，原拄双拐现能拄一拐助行或原爬行，经治疗而能拄拐行走者；患肢蹬力10公斤，肌力差缩小1/2以上，肌围差缩小1/4以上。好转：运动功能及肌力较治前改善，症状减轻者。无效：运动功能及肌力无明显改变。

显效36例，有效34例，好转26例，无效4例，总有效率为96%。

王富龙等 氦氖激光穴位照射治疗小儿麻痹后遗症100例 陕西中医 (4); 177, 1990

穴 位 埋 线 法

采用穿刺针埋线法。常规消毒局部皮肤，镊取一段约1~2cm长已消毒的羊肠线，放置在腰椎穿刺针针管的前端，后接针芯，左手拇指绷紧或捏起进针部位的皮肤，右手持针，刺入到所需的深度。当出现针感后，边推针芯，边退针管，将羊肠线埋植在穴位的皮下组织或肌层内，针孔处敷盖消毒纱布。常用穴位：上肢瘫痪取肩井、肩髃、肩髃、曲池、手三里、外关、合谷等；下肢瘫痪取大肠俞、肾俞、环跳、居髃、秩边、髀关、伏兔、足三里、阳陵泉、悬钟、解溪。每次选2~3穴，10天1次，5次为1疗程。

共治疗284例。基本痊愈：患肢功能完全恢复正常，无或有轻微的肌萎缩和足畸形，共100例。显效：患肢功能较治疗前有明显的改善，尚遗留轻度的后遗症，共102例。好转：患肢功能有一定程度的进步，有较重的后遗症，共67例。无效：症状无明显好转，共15例。

董敖齐 穴位埋线治小儿麻痹后遗症284例 浙江中医杂志 (3); 112, 1987

5. 小 儿 腹 泻

小儿乐温熨法

用药原则与制作方法 婴幼儿形气未充，脾胃薄弱，易感外邪，

加之小儿常乳食不节，脾胃运化失常，故婴幼儿腹泻多属于脾胃虚寒性质。所以用药以补气养血、健脾和胃、温中止泻、散寒止痛为主。因系外用，主要取其气，因此选用芳香渗透性强的药物。经临床实践，筛选出了党参、丁香、藿香、苍术、木香、砂仁等药。制作方法：将生铁落磨成细粉，加热处理，药粉炒香粉碎。然后将铁粉、药粉加醋均匀混合，分装于约 $8 \times 8\text{cm}$ 塑料袋内，用两层塑料袋密封两次，备用。用小儿乐温熨神阙穴。使用时，将小儿乐袋用针扎孔，使其通气然后将其放在患儿的神阙穴之上，5~10分钟后小儿乐袋即可释放热量，温度可达 $40 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ，维持24小时，以温熨神阙穴。亦可在患儿兜肚上缝一个 $9 \times 9\text{cm}$ 的棉布口袋，装入小儿乐，对准神阙穴，24小时更换1次，5次为1疗程。

①治疗时，药袋必须用衣物保温。②袋内如有结块，轻轻地将其松动开，温度即刻升高。

共治疗100例。痊愈：腹泻止，大便成形，每日排便2次以下者。显效：腹泻次数减少2/3者。无效：温熨5次症状无明显改善者。

温熨1次痊愈者18例，2次痊愈者24例，3次痊愈者18例，4次痊愈者4例，共64例，占64%；显效32例，占32%；总有效率为96%。无效4例。全部病例均经随访后统计。合并他药治疗者未做疗效统计。

张洪美 小儿乐温熨神阙穴治疗婴幼儿腹泻100例 山东中医杂志 (1)，18，1990

穴·位·划·痕·法

取背部脾俞、胃俞（均双侧）。患儿取俯卧位，局部皮肤常规消毒后，医者左手固定穴位治点，右手持30号0.5寸毫针在每个穴位上自左而右依次划痕 $2.0 \sim 2.5\text{cm}$ ，深度以皮下有点滴出血为准，术后敷以无菌纱布，用胶布固定。1周后可施行第2次治疗。

共治疗73例。治疗1次而愈者32例，治疗2次而愈者27例，治疗3

次而愈者10例，治疗3次而未能痊愈者4例，总治愈率为95%。

张丽民等 穴位划痕治疗小儿腹泻73例 山东中医杂志 (1),
15, 1990

针 灸 捏 脊 法

长强穴与尾骨平行刺1~1.5寸，捻转10~20秒钟出针（虚寒者留针30分钟）；腹泻穴采取90度直刺3分，捻转10~15秒钟出针。配穴三阴交、足三里浅刺不留针；四缝穴浅刺出血即可；神阙拔罐仅于3个月以内小儿；百会艾条悬灸约10~30分钟；尾窍骨穴浅刺疾出或拔罐出血最好；兑端刺入2分，留针10~20分钟。

捏脊疗法：患者取俯卧位，医者以两手拇指捏起皮肤自长强至大椎穴，中间不脱手，连捏3遍，第3遍时每捏3次可猛提1次，最后在肾区用拇指掌侧按摩数次。每日1次。10~15日为1疗程（可嘱患儿家长在家中进行）。

共治疗1250例。痊愈：泄泻停止，大便成形，诸症消除者；显效：大便次数接近正常，并已成形，诸症基本消失或有腹胀肠鸣者；好转：便泻次数减少，其它症状减轻者；无效：大便次数减少，但诸症无明显改变者。

痊愈1025例，显效125例，好转88例，无效12例，痊愈率为82%。

崔景胜等 针灸治疗小儿腹泻1250例 陕西中医 (4), 175,
1990

华佗夹脊穴刮法

术者于患儿胸10、11、12夹脊部位先涂适量的生姜汁或麝香风湿油，再以瓷汤匙施行刮法，轻重以勿使皮肤破损为度，每侧一般刮200次左右，至皮肤呈潮红，若呈暗红色或紫色，疗效更佳，每日一次，连续治疗2~3次。

伴呕吐者，同时用维生素B₆注射液0.5~1cm，注一侧内关穴，

通常呕吐即止，约半小时后病儿可安然入睡。

治疗期间，宜进食米汤。

共治疗284例。本组284例，治疗1次痊愈者211例，2次痊愈者62例，3次痊愈者8例，无效3例。

周光明 华佗夹脊穴刮法治疗婴幼儿腹泻284例 湖北中医杂志(3); 39, 1991

VitB₁₂ 穴位注射法

患儿呈俯卧式，取长强穴，直刺0.5~1cm，注入维生素 B₁₂ 1 ml (含 0.25mg)，务必快速推注，每日一次。同时加强护理。

共治疗142例。显效104例（临床症状和体征1~2天内消失），有效26例（临床症状和体征2~3天内消失），无效12例（临床症状和体征3天后仍未见改善），经分析，其中8例因患儿哭闹而致取穴不准，3例因饮食无节制，另1例因夜间睡眠受凉。

周光明等 维生素 B₁₂ 穴位注射治疗婴幼儿腹泻142例 湖北中医杂志 (4); 32, 1990

耳压配合激光针法

(一) 耳穴贴压：取中药王不留行子，用0.5×0.5cm 胶布粘贴于耳穴上，并适当加压。取穴：小肠、胃、皮质下、大肠。久泻气阴两虚者，加脾、肾上腺；嗳气欲吐者加膈膈；发惊者加肝、神门；大便酸臭者加三焦、腹外或直肠下端。每隔1~2小时按压一次。每日更换贴物一次。

(二) 配合激光针灸：采用天津第四光学仪器厂生产的激光针灸机进行体穴照射。取穴：神阙、中脘、足三里，各穴位用激光照射15~20分钟，一日一次。

(三) 3日为一个疗程，治疗过程中停用一切中、西药物，并嘱患儿家长严格控制患儿饮食，每隔6小时方可进乳食一次，间隔期间

可以给予饮水。

共治疗255例,经1~3次治疗,泻吐止,大便正常,观察5天以上未复发者为显效;经治疗大便次数明显减少,治疗4~6次临床症状消失,大便基本正常者为有效;经5次以上治疗并遵医嘱控制饮食后,大便仍无明显改观者为无效。

本组255例患儿中,显效者163例,占63.92%;有效者92例,占36.08%;无效者为0。总有效率为100%。

王秀兰等 耳压配合激光针治疗婴幼儿单纯性腹泻 255例报告
江苏中医 (12); 23, 1989

火柴灸法

取长强为主穴,肾俞、脾俞为配穴。用火柴一支在磷片上划燃对准穴位迅速灸点,手法要轻,刹那间离穴,此时可听到响声即可,灸点后有米粒大斑痕,一般不需处理。每日1次。

共治疗126例。经3次治疗,痊愈:诸症消失96例(76.2%),显效:诸症明显好转21例(16.8%),无效:诸症不减9例(7.1%)。

王玉顺等 火柴灸治小儿腹泻 辽宁中医杂志 (5); 45, 1988

悬灸法

随患儿体位任意取其一侧下肢上的足三里和腹泻特效穴(腹泻特效穴位于外踝最高点直下至赤白肉际交界处)。以燃着之艾条依次、定点在暴露穴位的皮肤上悬灸之。足三里穴,约灸5分钟,务使穴周皮肤泛红;腹泻特效穴需灸20~30分钟。每日施灸2次以上,单次灸量及日灸次数,可视病情轻重程度灵活掌握。

对原患疳积者,先刺双手四缝穴,再依上法施灸,对伴见呕吐较剧者,如上法施灸后,针内关穴,留针5~10分钟。

16例中,经1次灸治而愈者3例;经2次灸治而愈者6例;经3~6次灸治7例,其中痊愈者5例,好转者2例。全部有效。

张孝闻 悬灸单侧足三里、腹泻穴治疗小儿急性腹泻16例 湖南中医杂志 (4); 24, 1989

耳 压 法

选穴: 耳前取神门、盆腔、交感、肝、脾、大肠、小肠、胃、胃1 (在耳屏外侧与面部交界处——自拟穴); 耳背取消化线、健脾、胃、肠。方法: 选用炮制好的王不留行籽置 $0.7 \times 0.7\text{cm}$ 的胶布上, 每次只贴一侧耳廓, 首次以男左女右为序, 隔日1次, 每日按压2~3次, 以患儿能忍受为度。

共治疗114例。痊愈: 临床症状与体征全部消失; 好转: 临床症状与体征明显减轻, 腹泻次数减少为日行2~3次; 有效: 临床症状和体征无改变, 或转为药物治疗。

痊愈62例, 好转25例, 有效18例, 无效9例, 总有效率91.1%。

罗兴中 耳压治疗小儿单纯性腹泻114例 陕西中医 (5); 227, 1989

针 刺 法

采用以“脐四周穴”(天枢(双)、水分、阴交)为主穴, 并以足三里(双)、三阴交(双)为配穴, 刺激后不留针, 拔罐5分钟后, 将罐取下, 用TDP照射20分钟, 每日治疗一次。

共治疗175例。痊愈为3天内大便次数恢复正常, 其它症状消失。有效为3天内大便次数虽未恢复正常, 但次数明显减少, 其它症状减轻。无效为3天后症状与治疗前无明显差异。

痊愈149例, 好转23例, 无效者3例。临床治愈率达85.1%, 总有效率达98.2%。

钮玉忠 脐周四穴治疗婴幼儿腹泻175例 中医临床与保健 (1); 12, 1991

针 灸 加 推 拿 法

主穴：足三里、阴陵泉、天枢。泻下暴注如水者加长强，发热者加上巨虚，久泻不止者加止泻穴（肚脐直下 2.5 寸）。取 1 寸长毫针进针 0.5 寸用捻转补泻手法，行针后不留针。风寒型用平补平泻，辅以艾灸天枢；脾虚型用补法，兼以艾灸阴陵泉；伤食型与湿热型均用泻法。针灸后均揉神阙、止泻穴各 1 分钟，捏脊 4～8 遍。

共治疗 100 例。痊愈〔经 1～3 次治疗，大便恢复正常，大便镜检（一），诸症消失，一周内未复发者〕92 例。好转（经 1～3 次治疗，大便次数减少，诸症减轻，大便镜检好转者）6 例。无效 2 例。其中伤食型痊愈 15 例，好转 4 例，无效 1 例；风寒型痊愈 27 例；湿热型痊愈 25 例；脾虚型痊愈 25 例，好转 2 例，无效 1 例。

王国平 针灸加推拿治疗小儿泄泻一百例 湖北中医杂志 (1), 19, 1988

6. 小 儿 泄 泻

针 刺 法

①取穴：以上脘、中脘、天枢、大横、足三里为主穴。以不容、承满为配穴。每次治疗均取主穴，胃脘胀满隐痛、有呕吐者加刺配穴。②具体操作：常规穴位消毒后，用 1 寸 30 号毫针，快速点刺腹部穴 2～4 分深，足三里 2～5 分深。针刺方向：腹部穴针刺时针体要垂直稍偏向下方，刺足三里针尖要斜向腹部。本组病例不配合任何中西药。在治疗过程中嘱患儿家长定时定量喂奶或进食，寒温适度。免食生冷油腻过甜之食物。针刺次数：一般 1 日针 1 次，严重者 1 日内针 2 次。

临床症状全部消失，大便成形，每日便次不超过 2 次，镜检无白

细胞、脂肪球、红细胞，腹满隐痛，呕吐消失者为痊愈。

215例患儿，经针刺3~7次后，均获痊愈。痊愈后观察一个月以上，复发者11例，再予以针刺，又获痊愈。贫血者均在止泻后10~20日内血色素上升至11g以上。

陈文 针刺治疗小儿脾虚泄泻215例 中国针灸 (3); 48, 1986

针 灸 法

(1) 针刺及选穴：主穴为天枢、足三里、中脘，呕吐加内关，发热加合谷，积滞甚加四缝。采取快速进针法，不留针。(2) 艾灸：采用雀啄法，以皮肤稍红晕为度，每日治疗1次，连3天为一个疗程。(3) 据病情分别随机选用针刺、艾灸或针刺加艾灸治疗。

共治疗110例，治愈104例，占94.5%。好转5例。无效1例。

张玉荣等 针灸治疗小儿泄泻 中国针灸 (5); 56, 1986

耳 针 法

主穴：小肠、大肠、脾、神门、交感；配穴：腹胀加艇中，恶心呕吐或纳差加胃穴，发烧加耳尖放血。操作：任取一侧耳穴，每日1次，可连针3次，进针后留20分钟，留针期间轻微捻转行针2次。

共治疗98例，经针刺1次治愈者62例，针刺2次治愈28例，疗效比较满意。

张耕田 耳针治疗小儿泄泻 中国针灸 (5); 56, 1986

7. 小 儿 肠 炎

灸 治 法

患儿入院之后分为两组：灸穴组(100例)和西医对照组(41例)。

两组在年龄、发病季节、临床表现等方面均基本相仿，其它方法的处理如液体疗法、饮食疗法和对症处理等，均按婴幼儿腹泻对待。灸穴组：应用艾条灸双侧止泻穴，每日一次，重者可一日两次，直至腹泻控制为止。取穴方法：在足外踝向足底作一垂直线，此线与足跖底皮肤相交处即止泻穴所在。西医对照组：应用庆大霉素肌注：剂量4000~6000单位/千克/日，分两次注射。

共治疗100例。①痊愈：治疗后体温正常，呕吐消失，脱水纠正，大便由水样便恢复正常软便，每日1~2次；婴儿每日4次以下。②好转：治疗后体温下降，呕吐减轻，脱水减轻，大便次数减半；③无效：治疗2天，症状无明显改善。

灸穴组100例中，痊愈91例，占91%；好转6例；无效3例。

林源震 灸治小儿肠炎100例临床分析 上海中医药杂志 (6)，8，1987

8. 小儿单纯性消化不良

针 灸 法

以中脘、天枢为主穴，以肩髃、足三里为配穴，备用关元、曲池、合谷。

手法：身热者泻合谷或曲池、寒泻者灸关元穴（用温和灸）。主穴每次只用一穴，虚甚者必配肩髃。施针时多以捻转为重，不留针。

共治疗36例，经3次治疗后，痊愈31例，好转3例，无效2例，总有效率为94.4%。

李毅文 针灸治疗小儿单纯性消化不良 36例 中国针灸 (2)，36，1986

9. 小 儿 疳 积

穴 位 注 射 法

患儿平卧床上，固定双下肢，按常规消毒后，取5号针头抽取维生素B₁₂ 2 ml，快速刺入双侧足三里穴，稍捻转，回抽无血时，缓慢注入药液。每穴1 ml，隔日一次。三次为一疗程。

124例患儿中，经治疗后痊愈48例（症状消失，饮食如常，体重增加）；显效64例（症状改善，饮食增加）；无效12例（治疗前后无变化者）。

夏晓川 足三里穴位注射治疗疳积124例 湖北中医杂志(3)，19，1988

针 灸 法

取穴：四缝（包括上、下四缝）、足三里、脾俞、胃俞、内落枕（劳宫穴上一横指、食指与中指缝处）、（均双侧）。操作：先令患者仰卧或坐好（多为家长抱坐），定好穴位，常规消毒后以右手拇、食、中指持住针柄（已消毒的三棱针）迅速在四缝穴点刺，挤压出黄白粘液，然后配合毫针针刺足三里、脾俞、胃俞、内落枕，得气后出针，不留针。每日1次，3—6次为1疗程。计治疗1—2疗程即告痊愈。

治疗后食欲睡眠恢复正常、无哭闹、精神振作、脸色红润为痊愈。食欲增加但未恢复正常，急躁吵闹口渴症状消失者为好转；症状无改善者为无效。共治疗1455例患者中，痊愈1210例，占83.2%；好转220例，占15.1%；无效25例，占1.7%；总有效率为98.3%。1455例患者均经随访一年。

黄荣活 针灸治疗小儿疳积1455例 中国针灸 (2)，4，1987

针 刺 法

(一) 选穴 双侧四缝穴。

(二) 疗程 一般3天针1次，3次为1疗程。

(三) 具体操作 采用坐位，患儿两手掌心朝上，定好穴位，常规消毒，男性先针左侧四缝，女性先针右侧四缝。用0.5寸或1寸的毫针对准穴位快速点刺，然后挤出少许黄白色液体、或淡血水、或白色颗粒状物，然后再用75%酒精棉球消毒局部。

共治疗小儿疳症342例，总有效率为98.38%。

金 红等 针刺四缝穴治疗小儿疳证 342例临床观察 湖南中医杂志 (2); 37, 1991

刺 贴 法

1. 刺四缝：将患儿两手洗净，由家属抱坐，胸前持住手臂勿使乱动。施术者用左手捻住患儿手指，掌心向上，使四缝穴暴露在外，局部消毒后用三棱针快速在四缝穴浅刺，挤出浅红或黄白色透明粘液，用消毒药棉拭净，不必包扎。2. 贴神阙：方用治疳理脾丸加减：神曲、麦芽各10g，木香5g，蚕砂10g，芦荟5g，胡黄连、芫荽、雷丸各10g，吴茱萸5g，藿香10g，陈皮、苍术、五谷虫各5g，诸药研极细末备用。取神阙经局部消毒后用上药3g填放其中，以胶布贴敷防药粉外漏。上刺贴法每周进行1次，连续3~4次为1疗程，治后1个月复查。

共治疗52例。显效：食欲显增，症状体征消失，体重增加。35例。有效：食欲增加，症状体征显著改善。13例。无效：食欲无增，症、征无改善。4例。总有效率为92.3%。

谭俊臣 刺贴法治疗小儿“疳积”52例 辽宁中医杂志 (101), 48, 1987

针刺五腧穴法

主穴：胃经合穴足三里，脾经荣穴大都，俞穴太白。一律针刺双侧。

配穴：心经俞穴神门，肾经俞穴太溪，均双侧。

针刺方法：1岁以内针刺时仅行提插捻转手法一分钟即可，不留针；1岁以上患者针刺时施用迎随捻转手法中的补法，留针3~5分钟。

每日1次，7次为1疗程，疗程间隔1周。

共治疗60例。年龄均在5个月~3岁零3个月。

结果：痊愈39例，显效12例，有效8例，无效1例，有效率98.3%。本组有4例是原经四缝穴针刺治疗后复发的病例，用此法针治后未见复发。

胡文寿 针刺五腧穴治疗小儿疳症60例 山西中医 (2)，29，1986

10. 小儿积滞内热

耳 压 疗 法

取穴：

主穴：直肠下段、大肠、三焦、肺、心、腹、神门、内分泌。

配穴：脾、胃、小肠。

手法：

用针灸针柄找到穴位的最敏感点，用5mm²中间放有一粒中药王不留行的胶布贴在穴位最敏感点，4—6天换一次，主穴可取两个，配穴取3—4个，一般取双耳，每日在穴位上按压不应少于5次，每次按压至耳部发红，如对胶布过敏，嘱其父母及时取下，以免造成耳部水肿。

共治疗30例。痊愈7例，有效21例，无效2例。总有效率为93.3%。

刘建平 耳压疗法治疗小儿积滞内热30例 中医药学报 (2), 40, 1988

11. 小儿厌食症

针 刺 法 (一)

将患儿手掌放平，75%酒精消毒，用26号5分针刺四缝，放出白色粘液。隔日1次，5次为1疗程。

共治疗1200例。1200例中最少针2次则有食欲，5次而愈；最多10~15次愈；一般10次以内为多。总有效率100%。

张连城 针灸治疗小儿厌食症 1200例 陕西中医 (10), 470,

针 刺 法 (二)

1. 取穴：主穴取天枢、足三里。配穴根据临症而定，有呕吐腹胀者可加内关、中脘腹痛者可加合谷，症状较重者可加四缝。

2. 操作：选取28号1~1.5寸毫针，进针后用捻转手法待气至后10~20秒即行出针，每日1次。四缝穴在严密消毒的情况下，用三棱针进行点刺，出针后用手轻轻挤出液体即可。针刺时尽量将患儿肢体把持稳妥，以免发生弯针、折针等意外事故。

共治疗50例。治疗效果按痊愈，好转，无效进行统计。治愈是指食欲增加，饮食正常，精神状态明显好转，随后2~3个月内体重与正常儿童相当。好转是指食欲较前有所增加，但饮食量还不及正常儿童。无效是指针刺前后食欲无明显变化，或因故中止治疗。

根据以上标准，50例患者，痊愈者32例，（占64%），好转者16例（占32%），无效2例（占4%），总有效率为96%。痊愈者平均

治疗天数15天。

王强虎 针刺治疗小儿厌食50例 陕西中医 (10); 467, 1989

耳压配合中药合剂法

胃热阴虚型: 药用自制的开胃合剂, 内含生地、元参、麦冬、石斛、荷叶、焦三仙等; 脾胃不足型: 药用自制健脾合剂, 内含党参、茯苓、白术、陈皮、麦谷芽等。选一侧耳的脾、胃、神门、皮质下等穴, 用橡皮膏粘贴王不留行药子, 根据上述分型服用中药。4天后复诊, 换另侧耳穴粘贴王不留行药子, 并再投药。一般1~3次即可。

共治疗93例。1.痊愈: ①食量大增(每日增加50~100 g或更多)。②体重增加0.5~1 kg。③其它症状基本消失。2.好转: ①食量增加(每日增加25~50 g)。②体重增加0.25~0.5 kg。③其它症状减轻。3.无效: 治疗后上述指标无明显改善。

共治疗93例, 痊愈67例, 占72%, 好转26例, 占28%, 无效0。

商庆国等 耳压疗法配合中药合剂治疗小儿厌食症93例 北京中医 (4); 39, 1988

12. 小儿呼吸系统疾患

激光针穴位照射法

一组采用上海医用激光仪器厂和浙江鄞县天童激光仪器厂生产的氦氛激光治疗仪, 功率为1~5毫瓦, 波长为6328埃, 光斑直径为0.5~0.8厘米, 通过光导纤维直接点在穴位上进行照射治疗。另一组应用上海跃进电表厂生产的半导体砷化镓激光治疗仪, 波长9040埃, 输出激光峰值功率300毫瓦以上, 连续可调, 光脉冲频率250~1000赫兹, 光斑直径为0.1~7毫米。

穴位取天突、膻中、肺俞为主穴，鼻塞、流涕加迎香、鼻通，喘促加定喘，痰多加丰隆，每穴照射5分钟，每天1次。急性感染5次为一疗程，慢性疾病10次为一疗程。如经一疗程治疗有效但未恢复正常者，继续治疗直至治愈为止；经一疗程治疗无效，改用其它方法治疗。

基本治愈：咳嗽等临床症状消失，肺部听诊正常。好转：咳嗽减少，喘促减轻，其他症状及肺部听诊均较前有明显改善。无效：与治疗前相比，症状与体征均无明显变化。

共治疗113例，患儿采用氩氦激光针治疗的有70例，其中，基本治愈40例，好转26例，无效4例；采用半导体砷化镓激光治疗43例，其中，基本治愈24例，好转16例，无效3例。两种不同类型的激光治疗结果基本相同，总有效率达92.8%，平均治愈次数为9.1次。

施炳培等 激光针穴位照射治疗小儿呼吸系统疾患113例 上海中医药杂志 (4); 16, 1990

13. 发 热 惊 厥

针 刺 法

(一) 主穴：百会，用1寸半不锈钢毫针，沿头皮刺入针体2/3，留针6小时，一般均上午针刺，下午起针。隔日针一次，5次为一疗程。

(二) 配穴：根据不同症状，加刺适当腧穴。抽搐发作时刺人中，高热者加大椎、曲池、合谷，强刺激，呕吐者加上脘、梁门、气海、内关，腹胀者加中脘、章门，腹泻者加足三里、关枢，咳嗽者加肺俞，面黄体弱，食欲不振者加四缝（点刺挤出黄白色组织液）。全部配穴不留针。

(三) 全部病例均配用治疗原发病的药物。

共治疗40例。由治疗后到总结材料前未惊厥者为基本痊愈。发作

一次，经再次治疗后已有两年以上未发作者为好转。经治疗后惊厥发作两次以上，间歇时间不足一年者为无效。

一个疗程治疗后基本痊愈38例，其中5年以上未发作者6例，4年以上未发作者3例，3年以上未发作者15例，两年以上未发作者14例。好转2例，其中一例针刺一疗程后，9个月又因高热惊厥一次，继针百会一个疗程，至今已两年多未发作；另一例于针后4个月又因高热惊厥一次，经第二疗程治疗后，至今已年余未发作。

杨景柱 百会穴长时间留针治疗发热惊厥40例临床观察 中国针灸 (2); 15, 1987

附：小 儿 惊 风

针 灸 法

1. 急惊风 主穴：十宣、印堂、人中、曲池、太冲，均用泻法。共治31例，痊愈26例，好转4例，无效1例。

配穴：昏厥不醒加劳宫、涌泉；抽搐不止加行间、阳陵泉、昆仑、后溪；高烧不退加大椎（点刺放血）、合谷。

2. 慢惊风 主穴：中脘、关元、足三里、章门、印堂，均用平补平泻法。配穴：同上。共治29例，痊愈22例，好转5例，无效2例。

3. 慢脾风 主穴：肝俞、脾俞、百会、神阙（灸）、足三里，均用峻补法。配穴同上。共治24例，痊愈18例，好转4例，无效2例。

聂汉云等 针灸治疗小儿惊风84例 上海针灸杂志 (2); 20, 1987

14. 哮喘

挑 四 缝 法

在患儿双手内侧面第二指关节缝中（除拇指），用0.75%碘酒或75%酒精消毒，用6~8号注射针头或三棱针，或大号缝衣服，直刺指缝正中间，深度以刺到骨为度（约0.1~0.3cm），针拔出后即有白色或淡黄色粘稠液体溢出，挤出血也无妨，然后用干棉球擦干净，每3天或一周挑一次。挑后双手当天不下冷水，并防止弄脏，以免发生感染。

共治疗120例。挑四缝后数小时哮喘减轻或消失，饮食增加。挑1次治愈38人，挑2次治愈48人，挑3次治愈16人，挑四次治愈6人，计108人，治愈率占90%，无效12人，占10%。

陈林才 挑四缝治疗小儿哮喘120例 天津中医 (5); 44, 1989

耳 穴 压 迫 法

一、选穴：主穴：咽喉、气管、肾、肺、脾、风溪、神门、平喘、肾上腺；随症加减：咳嗽痰多者加口、脑干、三焦；食欲不振加胃；便秘加大肠、内分泌。

二、操作方法：治疗前先将耳廓局部皮肤酒精消毒，取0.4cm方形胶布，中心粘一粒王不留行籽，对准双侧耳穴贴压。用拇指与食指在贴压的胶布处轻轻按压，使之产生疼痛或胀感。嘱家长每日按压数次。每周贴压1次，治疗6次为1个疗程。疗程结束休息1周，可继续第2疗程治疗。

三、对部分内源性哮喘患儿，同时配合皮下注射转移因子，每周注射1次，每次1支（2ml），6次为1个疗程。不用其它药物治疗。

共治疗 112 例。近期控制：经治疗 1 个疗程以上，症状消失，观察 3～6 个月无哮喘发作者；显效：经 1 个疗程以上的治疗后哮喘发作基本控制，发作次数减少、症状轻，发作时间缩短者；有效：凡经 1 个疗程治疗后症状减轻或发作次数减少者；无效：经 1 个疗程治疗后，症状与体征无变化者。

本组 112 例经耳穴压迫法治疗，临床近期控制 54 例（48.21%），显效 27 例（24.11%），有效 18 例（16.07%），无效 13 例（11.6%），总有效率为 88.39%。

刘心莲等 耳穴压迫法治疗儿童哮喘 112 例疗效观察 中西医结合杂志 (10)；689，1990

15. 缺铁性贫血

穴 位 敷 贴 法

选用中药党参、苍白术、茯苓、黄芪、丹参、骨碎补、陈皮、使君子、莱菔子、丁香、肉桂、冰片等制成药膏。敷贴取穴：血海、足三里、三阴交、膈俞、脾俞、神厥、气海、中脘，每次选单侧穴位四个，每穴上敷药直径约 1 cm，外覆消炎止痛膏贴牢。隔 3 天换药，每周换药 2 次，10 周为一疗程，共敷药 20 次。另外每天加服小剂量硫酸亚铁 0.15 g。

共治疗 92 例。经一疗程治疗后，血红蛋白 $\geq 110\text{g/L}$ 为治愈；经一疗程治疗后，血白蛋白虽有升高，但仍 $< 110\text{g/L}$ 为好转；经一疗程治疗后，血红蛋白无变化或降低为无效。

治愈 80 例，好转 9 例，无效 3 例，总有效率为 96.74%。

周黎明等 幼儿缺铁性贫血用穴位敷贴疗法的临床观察 上海中医药杂志 (9)；14，1990

16. 不安腿综合征

针 灸 法

针具：28~30号不锈钢针1.5寸、2.5寸、3寸，艾条。

取穴原则：以小腿部取穴为主，多取阳经穴，第一组：足三里（双），承山（双）、绝骨（双）。

第二组：阳陵泉（双）、解溪（双）、三阴交（双）。

第三组：外丘（双）、委中（双）、八风（双）。

具体操作：局部常规消毒后进针，用平补平泻手法，得气后，使患者局部或小腿部有酸、麻、沉重或轻微的放射感，术者针下有沉紧感，每日取一组穴治疗，三组交替使用，留针20分钟，针后加温和灸5分钟，以皮肤红晕为度。

共治疗16例。痊愈一局部症状消失或基本消失；显效一局部症状缓解或减轻，有效一局部症状减轻，有时加重，但较治疗前为轻；无效一局部症状无改善。

16例中，痊愈9例，显效2例，有效2例，无效3例。显效以上11例患者，随访2年，有3例复发，但症状较前减轻，发作时间较短，经针灸治疗后又得到控制。

甄德江 针灸治疗不安腿综合征16例 陕西中医 (8)：374，1988

17. 小 儿 尿 频

针 灸 法

1. 选穴：关元穴、三阴交。2. 操作方法：患儿平卧，用一寸毫

针刺入双侧三阴交穴，用捻转补泻法的补法行针10分钟（使针感上传为佳）；另将艾条点燃后在关元穴处回旋温和灸，以局部潮红为度。

共治疗16例。根据全国高等医药院校教材《儿科学》中规定，学龄前期和学龄期儿童每天排尿6—7次者为正常，达此标准即为治愈，每天排尿10—15次者为好转。16例中治愈13例，好转3例。疗程最短者3次，最长者7次，平均为5次。

陈一飞 针灸治疗小儿尿频16例

18. 遗 尿

针 刺 法

患者仰卧，术者用左手拇食指紧捏其鼻端，右手持1寸针向上斜刺素髻穴，刺入约0.5寸，左右捻转，以患者两眼含泪为度。尔后直刺关元穴，约1.5寸，用捻转补法，使针感下达阴部，留针30分钟，10分钟行针1次，1日1次，6次为1疗程。

以此治疗102例，病程1年以内63例，1年以上39例，均排除有器质性病变。经治疗1疗程，39例痊愈（随访半年以上无遗尿），47例显效（不遗尿，但随访偶遗尿），16例有效（遗尿次数减少）。

秦 刚 针刺素髻关元治疗遗尿症102例 浙江中医杂志 (4), 162, 1991

睡 前 针 法

针刺主穴：中极、三阴交。配穴：大赫、百会、太溪。手法操作：睡前1~2小时进行针刺。令患者仰卧位，先针刺中极穴1寸深，出现较强得气，放散至会阴部最佳，反复提插数次使得气加强，留针10~15分钟，每5分钟再施捻转补法1次，然后再针三阴交1~1.5寸深，得气后用捻转补法，留针10~15分钟，每5分钟用刮柄法

加强得气1次。继针百会，沿皮向后顶穴刺1寸，得气后留针15分钟即可。必要时配合大赫穴深刺1寸左右，针感必须向下放散至会阴部，太溪直刺0.8~1.2寸，均用捻转补法，留针10~15分钟。起针时，上述穴均用刮柄法后再将针快速起出。

84例顽固遗尿症，采用上法治疗，均经3~15次痊愈。半至1年后随访亦无复发。治愈率为100%。

杨元德 睡前针治顽固遗尿症84例 陕西中医 (11)；513，
1989

穴 位 磁 疗 法

1. 取穴：中极、关元、归来、三阴交（均双侧）。

2. 操作方法：采用CL-2型电磁疗机。磁头直径为8cm，磁场强度650~1100GS，50Hz，磁覆盖面积 $15 \times 15 \text{mm}^2$ 。患儿取仰卧位，将双磁头线接通磁疗机后，置于穴位上。每穴每次15分钟，每日1次，5次为一疗程。

共治疗20例。以3个疗程内遗尿消失，半年内无复发者为痊愈，共19例；5个疗程内一周遗尿1次者为好转，1例；6个疗程后一周内仍遗尿3次者为无效。本组治愈率为95%，有效率为100%。

何福秀 穴位磁疗治小儿遗尿20例 上海中医药杂志 (4)；29，
1991

耳 穴 贴 压 法

选穴：取耳部肾、膀胱、三焦为主穴。根据病症不同可酌情配穴，如睡眠不安、多梦、烦躁者可配肝和神门穴；纳食差者配脾与胃穴。治法：用探棒测取穴位范围内的最敏感点，作常规消毒后，再用准备好的王不留行药籽、胶布贴于耳穴部位，每穴位贴压一粒药籽，每天按压3~4次，每次按压20次。隔3~4天换药1次。两耳交替使用，4次为1疗程。

共治疗28例。症状消失1年未复发者为痊愈；症状消失或明显减轻，能维持半年，但复发后症状较治疗前轻者为显效；症状减轻或易发，复发较治疗前轻者为好转；症状未减轻，或治疗后不久又复发如初者为无效。

本组28例中，痊愈18例，显效6例，好转2例，无效2例。总有效率为92.85%。

赵秀清 耳穴贴压治疗小儿遗尿28例 湖南中医杂志 (5)，40，1990

温 针 法

关元温针灸4—10壮，一周三次，次髋拔罐15分钟，10次为一疗程。

共治疗41例。治愈：观察3个月并随访一年无复发者。

显效：观察3个月偶见数天遗尿一次者。

好转：遗尿次数减少，或仅尿湿内裤者。

无效：针灸前后对比无变化者。

治疗总有效率为95.12%。

刘秀华 温针助阳法治疗夜尿症41例 北京中医学院学报 (2)，38，1991

654—2穴位注射法

药物654—2 (5 mg/ml)，取通里、大钟，穴位局部消毒，用5ml注射器吸入药液，而后准确刺入穴位，如无回血，即轻轻提插，达到强烈针感，通里穴向上扩散到肘关节，向下放射到指端，大钟穴向上扩散到膝关节或股内侧，向下放射到大钟穴周围，然后把药液徐徐注入，每穴0.5ml，左右交替，隔日一次，六次为一疗程。

共治疗25例。治愈19例，好转6例，疗程最长12天，最短1天。
陈英 654—2穴位注射治疗遗尿症25例 湖北中医杂志 (2)；
36, 1990

针 刺 法

采用体针为主，配用头针。

1. 体针：取肾俞、膀胱俞、关元与气海为主穴，配用阴陵泉、三阴交交替使用。用2~4寸毫针，采用快速针刺捻转，强刺激。留针三十分钟。

2. 头针：取足运感区，以2~3寸的毫针，从前向后平刺深2寸，原地快速捻转100次，持续2分钟，留针三十分钟。

共治疗187例。每日以体针为主治疗1次，连续5次而遗尿症状无变化者改头针，如头针连续10次仍无变化者为无效。经过治疗遗尿停止5天后停针，5天后无复发者为痊愈。

187例中，痊愈者175例，其中针刺最少一次，最多10次，痊愈率为96.5%，无效者12例，占3.5%。

郑益民 针刺治疗多哥湿热性遗尿症187例疗效观察 北京中医杂志 (2)；33, 1989

针 灸 法

取穴 主穴关元，属任脉，为小肠之募穴、足三阴任脉之会，在腹正中线上，脐下3寸处，为治疗遗尿之要穴；配穴百会，属督脉，为足太阳督脉之会，在头正中线上，距前发际5寸处，有醒脑健神之功效。

针法 嘱患者排空小便，取仰卧位，穴位局部常规消毒，用3寸毫针刺关元穴向下透刺中极穴，进针2寸5分。用2寸毫针斜刺百会穴，进针1寸5分深，中强刺激，平补平泻手法，留针30分钟。要求有酸、沉、麻木、胀、痛、热及触电样感觉，放射到下腹及会阴部，

针感明显者，效果显著。

灸法 针刺后，自带艾条回家，均由亲属帮助施灸，灸时将艾条对准“关元穴”，距离1寸左右，以温热感为度，局部穴位红润充血，防止烧伤皮肤。

疗程 每日针灸治疗一次，每次20~30分钟，7~10次为一疗程，中间休息3天，再进行第二疗程，一般都是1~2疗程治愈。

共治疗306例。治愈：症状和体征完全消失，晚间能警觉自行小便，随访半年无遗尿现象。显效：症状和体征明显改善，警觉程度好转，遗尿次数减少或偶有遗尿现象。无效：治疗前后遗尿无明显好转。

治疗结果 本组306例中，治愈226例，占73.8%，显效56例，占18.4%，无效24例，占7.8%（经检查均有器质性病变，针灸治疗不理想，应改其它疗法）。总有效率为92.2%。

治疗次数 8~10次治愈162例，11~14次治愈64例，针灸15次以上显效者56例，无效24例。

王全仁等 针灸关元配百会治疗遗尿306例疗效观察 河南中医(5)，32，1990

经穴按摩法

1. 主穴：中极 关元 三阴交 百会 肾俞 中脘 阴陵泉
箕门 脾俞 膀胱俞

2. 备穴：命门 气海 复溜 阴谷 血海 气冲 八髎

1. 先令患儿排尿后取俯卧位，在双下肢的复溜、三阴交、阴谷、阴陵泉等穴，施按、揉、推补手法。

2. 施内科按摩基础手法：在背部督脉及膀胱经诸穴位，施按揉法，连续做3~5遍，着重按揉肺俞、脾俞、胃俞、三焦俞、肾俞、膀胱俞、命门等穴。在督脉施捏脊法，由长强穴捏至大椎穴止，共捏3~5遍。后施啄法3~5遍。

3. 在骶部用掌根向上推揉“八髎”穴（约二分钟）。

4. 令患儿取仰卧位：用拇指点、按中脘、气海、关元、中极等穴，点中极穴时一定要向生殖器方面传导的反应（各穴点一分钟），

5. 两手掌分别按压两气冲穴（约二分钟），然后手徐徐抬起，再推摩两下肢，按揉箕门、血海等穴。

6. 用拇指按揉百会穴（约1～2分钟）。

共治疗40例（治疗次数均在10次以内）。

痊愈：治疗后半年内已无遗尿者。

显效：治疗后1月内偶有1～2次遗尿者。

有效：治疗后遗尿次数减少者。

无效：治疗后未见改善者。

本组46例经半年以上随访结果：痊愈43例，93.5%；显效2例，4.4%；无效1例，2.1%；总有效97.9%。

庞承泽 经穴按摩治疗小儿遗尿症40例 北京中医 (1)，47，1991

头皮针法

选顶中线，即从督脉经的百会穴向前顶穴沿皮斜刺1—1.5寸；每日或隔日1次，留针时间4—8小时。10—15次为1疗程，疗程间隔休息4—6天。一般需1—2疗程。

分基本痊愈、显效、进步、无效四级。基本痊愈：针后未尿床3个月以上者；显效：针后未尿床2个月以上者，或偶有1—2次，但尿量显著减少者；进步：针后基本不夜尿，尿量减少者；无效：症状无改变者。

共治疗37例。基本痊愈6例，占16.3%；显效21例，占57%；进步9例，占24.2%；无效1例，占2.6%。总有效率达97.4%。

临床观察：年龄小效果较差，年龄大效果较好。在治疗时间方面，下午针治比上午针治效果好。

陈再文 头皮针治疗遗尿37例临床小结 江苏中医 (3)，38，1988

氦—氖激光穴位照射与针刺法

1. 取穴：主穴取关元、气海、命门、三阴交、百会。

配穴属下元虚寒加肾俞、中极、膀胱俞、水道；脾肺气虚加中脘、足三里、膀胱俞、肺俞；肝经湿热加太冲、阴陵泉。以上穴位每次选取4~5个，交替使用。

2. 仪器及操作：采用低功率氦—氖激光仪（天津第四光学仪器厂研制 JG—I 型激光针灸仪），波长6328 Å，输出功率4 mV，光斑直径1~1.5mm，照射距离0.5~1 cm，照射时间每穴5分钟，治疗1次不超过20分钟为佳。每日1次，10次为1疗程，疗程间休息7~10天。

共治疗96例。治愈：治疗后遗尿完全消失，观察3个月未复发者；显效：治疗后遗尿基本停止，偶尔有遗尿但量少；好转：治疗后遗尿次数明显减少，1个月内少于4次者；无效：治疗前后症状改善不明显，1个月内遗尿多于4次。

	治 愈		显 效		好 转		无 效	
	例	%	例	%	例	%	例	%
下 元 虚 寒	6	18.18	6	18.18	14	42.42	7	21.21
脾 肺 气 虚	13	37.14	15	42.86	5	14.29	2	5.71
肝 经 湿 热	9	32.14	12	42.86	5	17.86	2	7.14

宫军 氦—氖激光穴位照射与针刺治疗小儿遗尿症96例 陕西中医 (8), 372, 1988

三穴八针法

取穴 四神聪（在百会穴前后左右各旁开1寸，共4个刺激点）。环中上穴（在环中穴上2寸外上5分，左右共2个刺激点）。遗道穴

(在中极穴左右旁开5寸,共2个刺激点)。

操作 用麦粒型揸针4枚埋入四神聪穴三天;针尖皆向百会穴;刺环中上穴时,取3~4寸毫针,针尖向前阴部刺入,并使针感向前阴部传导,不留针;取遗道穴时,针尖向前阴部斜刺1.5寸,若患儿能合作可留针20分钟。不合作者,针下产生针感后即可出针,每天1次,10次为1疗程。

共治疗58例。痊愈54例,显效3例,有效1例,总有效率为100%。

刘慧生等 三穴八针治疗遗尿58例疗效观察 河南中医 (4); 81, 1990

穴区带针刺法

取穴区带一躯前四带和下肢一带,在穴区带内用指压法找到敏感点,即指压有痛感为敏感点。

采用“快进针,慢退针,扎出针感,就地捻转”的手法。皮肤酒精消毒后,先针下肢一带,得气后,再针躯前一带,使针感向会阴或阴茎放散。留针30分钟,每隔10分钟行针1次。每日针1次。针前复查敏感点,做为针刺穴位。

共治疗10例病人中,针10次痊愈者(1年以上无遗尿)7例,检查敏感点消失。针10次显效者(偶尔疲劳后遗尿1次)2例,针2次显效1例。其中两人为敏感点压痛伴椭圆形反应物者,检查敏感点仍存在,但程度明显减低,反应物面积缩小。7例痊愈病人中随访5例,其中最长16年,1例。最短1年,4例。均无复发。

王贵臣 穴区带针刺治疗遗尿症 山西中医 (4); 39, 1990

手 针 法

(一)针刺穴位:将患者双侧手小指伸直,手小指掌侧第一、二关节间即为“夜尿点”。(二)针刺方法:令患者将双手心向上,手小指伸直平放。取5分或1寸毫针2支,皮肤经常规消毒后分别将二

针刺入两侧“夜尿点”2~3分深，施平补平泻手法。15分钟行针1次，留针45分钟。1日1次，一般针10次左右即可痊愈。经治疗后夜尿终止，半年以上无复发者为痊愈。

共治疗20例。针5次痊愈者5例，占25%；针7次痊愈者14例，占70%；针10次痊愈者1例，占5%。20例患者经过治疗，均获痊愈。

王振龙 手针夜尿点治疗小儿夜尿20例 山西中医 (4); 38, 1990

针刺“阴三角”法

取穴：阴三角，即1.阴茎正面根部上0.5厘米；2.阴茎背面根部右侧0.5厘米；3.阴茎背面根部左侧0.5厘米。三穴呈等腰三角形。女性病人1穴可选耻骨联合正中线上1厘米，2、3穴旁开2厘米，三穴呈等腰三角形。

手法：先对三个穴位直刺，以产生沉胀麻木针感为度，进针深度约0.5厘米，留针10~15分钟。

疗程：14岁以上患者连续针刺7~9日，3~14岁患者连续针刺14~15日。

辅助疗法：针刺前应向患者做心理治疗，树立信心。治疗期间每晚应限制饮水量。还可根据中医辨证，按肾气不足、脾肺虚损、肝胆郁热不同证候循经配穴或耳针相应穴位针刺。

共治疗268例。完全不尿床者为治愈，偶尔尿床者为好转，症状无改变者为无效。268例中，治愈224例，占83.6%；好转38例，占14.2%；无效6例，占2.2%。总有效率为97.8%。治疗后半年至一年随访，疗效巩固者占被随访人数的90.41%。

李化同 针刺“阴三角”治疗遗尿症268例 中国针灸 (4); 19, 1987

隔姜饼灸法

1. 取穴：中极、三阴交。2. 干姜15g，水200ml，煎至100ml

然后滤渣取液和面粉调成糊状，再摊于3块二寸见方布上，晒干，即成姜饼。治疗时将其置于选定穴上，用艾条熏灸，每日2—3次，每次30分钟，3天为一疗程。

共治疗50例。1个疗程后已停止遗尿者为痊愈42例；1—2个疗程后遗尿次数减少或停止，但因紧张、疲劳，受凉后又复发者为好转7例；3个疗程以上不见效者为无效1例。

田小玲 隔姜饼灸治疗遗尿症50例 陕西中医 (1)，35，1987

19. 下肢软瘫

针 刺 法

治疗取足阳明胃经俞穴为主，配以足太阴脾经俞穴及局部穴位，采用体针、皮肤针、穴位注射、按摩等综合治法。体针所取主穴是梁丘、足三里、上巨虚、条口、下巨虚、丰隆、解溪、阳陵泉、绝骨。所选配穴分两组，一组是血海、地机、太溪、八风，另一组是阴陵泉、三阴交、胸清（解溪穴上二横指，胫骨外缘）、足临泣。每次选用主穴3~4个，配穴二组交替，而阳陵泉与阴陵泉，绝骨与三阴交，太溪与昆仑，可用透穴法。均用30号毫针浅刺、轻刺不留针，日1次，10次为1疗程。皮肤针治疗是用莲蓬形七星针在皮肤感觉迟钝区域的胃经、脾经、胆经循环线上轻轻叩刺，以局部皮肤潮红不出血为度，隔日1次，5次为1疗程。穴部注射是选用维生素B₁₂或胎盘组织液，或硝酸一叶秋硷，于以上肌肉较丰厚的穴位进行注射，每次取3~4穴，每穴注入0.5 ml，日1次，10次为1疗程。局部按摩每日1次，10次为1疗程。

共治疗3例。治疗本病的疗效除争取时机外，坚持较长时间治疗亦是一大关键。另2例均因故中途停治，从而慢行正常，快行见跛，其中1例因马蹄足而作矫治手术。

胡桂英 针刺治疗婴幼儿下肢软瘫3例 浙江中医杂志 (12)，

20. 脑 积 水

针 灸 法

针刺穴位分两组，每日用一组。初期采用快速点刺风府、风池用泻法。待患儿适应后，四肢穴位可留针20~30分钟。

一组：头脑（额中）、水沟、支沟、合谷、水分、阴交、水道、中极、足三里、阴陵泉、三阴交。

二组：风府、风池、大椎、命门、腰俞、殷门、委中、承山、悬钟、复溜。

每次针前均用梅花针轻叩打背部夹脊，从上到下，至皮肤潮红为度。

穴位加减：呕吐加内关，腹胀加天枢、中脘。失明加攒竹、瞳子髎、目窗、光明、太冲。抽风加印堂、筋缩、阳关、金门。尿少、囟不缩小及肢冷者加药线灼灸水分、阴交、关元。

以30~50次为一疗程，间歇10天再继续。共治疗35例。具有一般症状好转、前囟缩小、头围增长变慢或超声波复查示脑室稳定或缩小者为有效，仅具一般情况好转而无其他条件者为无效。交通性脑积水13例，有效11例（占84.6%），无效2例（15.4%）；阻塞性22例，有效9例（占40.9%），无效13例，（占59.1%）。

陈学南等 阻塞性及交通性脑积水的针灸治疗35例疗效观察 中国针灸（3），13，1986

21. 脑 瘫

水 针 法

（一）、取穴：主穴（1）哑门、内关、足三里，（2）风池、

曲池、环跳，（3）大椎、肾俞、阳陵泉。每次选择上述一组穴位，三组穴位轮流交替使用。亦可随症加减，单纯智力低下仅取哑门、风池、大椎穴；伴视力差者加承泣、球后；伸舌流涎加上廉泉、地仓。

（二）、治法：单纯智力低下者，用复方麝香注射液 2 ml / 支，伴有肢体轻瘫者用上述药物 2 支；伴四肢瘫痪严重者除上述药物外加用乙酸谷酰胺 1 ~ 2 支（100mg / 2 ml / 支）。视力差或流涎者用维生素 B₁₂（100μg/ml/支）。每穴 0.5 ml，哑门、大椎可注入药液 2，其他每穴注入药液 0.5 ~ 1ml。头部及大椎穴针深不超过同身寸 1.5 寸，以免发生意外。隔日针一次，10 次为一疗程，休息 7 ~ 10 天再按上法治疗，一般治疗 3 ~ 6 疗程。病程长，症状重，有效者疗程可延长，症状明显改善者应坚持治疗。

共治疗 50 例。基本治愈：智力和运动功能接近正常儿童。

显效：智力和运动功能在自身原来的基础上提高二级。

有效：对周围环境反应较前灵敏，肢体活动稍有改善。

无效：治疗后无明显进步。

基本治愈 2 例，占 4 %；显效 16 例，占 32 %；有效 30 例，占 60 %；无效 2 例，占 4 %。

林丽玉等 水针治疗小儿缺氧引起的脑瘫 50 例疗效观察 上海针灸杂志（1），9，1987

针 刺 法

1. 选穴：智能低下取百会、风池、四神聪；语言功能障碍取通里、廉泉、金津、玉液；颈项软瘫取天柱、大椎（或身柱）；上肢瘫痪取肩髃、曲池、外关、合谷；下肢瘫痪取环跳、髀关、伏兔、足三里；腰部软瘫取肾俞、腰阳关；肘关节拘急取手三里、支正；指关节屈伸不利取合谷透后溪；腕下垂取外关、阳池、阳溪；足内翻取绝骨或昆仑，或承山外一寸；足外翻取三阴交、太溪，或照海、承山内一寸；足掌下垂取解溪、商丘、丘墟；剪刀步态取风市、阳陵泉、绝骨；抽筋取阳陵泉、太冲、承筋；食欲不佳取足三里。2. 方法：每日

针刺一次，补法为主，捻转提插后不留针。3. 疗程：三个月为一疗程，每一疗程结束后休息一周。25例中治疗时间最长为四个疗程，最短不足一个疗程。

共治疗25例。显效（瘫痪肢体功能和智能基本恢复正常者）7例，占28%；好转（瘫痪肢体功能好转，但肢体某些部位活动欠灵活者）6例，占24%；有效（颈软、腰软、斜视及语言功能基本恢复正常，但行走时步履欠稳者）10例，占40%；无效（经针刺一个疗程，症状未见改善者）2例，占8%。

李美琪等 针刺治疗小儿脑瘫25例临床小结 江苏中医 (4), 25, 1988

耳 压 法

取耳前交感、神门、脑干、皮质下、心、肝、肾、肾上腺、小肠、胃穴；耳背脊髓1、2、上背、中背、下背穴。下肢软瘫者加髋、膝、踝关节穴；上肢软瘫者加肩、肘、腕穴。

用王不留行籽置 $0.7 \times 0.7\text{cm}$ 的胶布上，每次只贴一侧耳廓，以男左女右为序，隔日一次，15次为一疗程。每日按压2~3次，以患儿能忍受为度。

痊愈：临床症状基本消失，上肢可以准确握物，下肢可以自由行走；好转：临床症状明显减轻，上肢可以握物，但不准确，下肢可以向前移步；有效：临床症状有所减轻，四肢活动较前进步，握物行走仍有困难；无效：治疗前后症状无变化。

共治疗33例。痊愈5例，好转13例，有效12例，无效3例。治疗时间最短一个疗程，最长七个疗程，一般2~3个疗程。

罗光中 耳压治疗小儿脑性瘫痪33例 陕西中医 (1), 39, 1988

针 刺 法

头针选区：运动区、感觉区、足运感区、运用区、平衡区。交

替，每日1次，留针2小时，10天为1疗程，疗程间隔7天。

体针：上肢取穴：肩髃、臂臑、曲池、手三里、合谷。下肢取穴：髌关、伏兔、阴市、梁丘、足三里、解溪、跟平。交替，每次取2~4穴，隔日1次，不留针。针刺手法、痉挛型用泻法，肌张力低下型用补法，体针取患侧，头针取对侧。

共治疗31例。显效：肢体功能有明显好转，即在治疗6个月中运动功能提高4~5个月龄，共11例。有效：肢体功能有进步，运动功能提高2~3个月龄，共18例。无效：肢体功能无明显改善，运动功能提高<2个月龄，共2例。

王洁荣 针刺治疗小儿脑性瘫痪31例疗效观察 山西中医 (2), 36, 1991

22. 智力低下

耳 压 法

以伤湿止痛膏加王不留行籽贴压耳穴，一般取双侧，每周2次，10次为一疗程。提前半天撕下膏布，以使耳廓血液循环恢复。

主穴：心、肺、肾、肝、脾、耳神门、交感、内分泌、皮质下、脑干、脑点、枕。

配穴：枕小神经、脊髓、镇静、失眠等。

(1) 基本治愈：接受能力、模仿能力、思维能力接近正常人，智商(达韦氏法)70分以上。(2) 显效：较治疗前有明显进步，但与正常儿童有差距，智商提高15~23分。(3) 有效：较治疗前有进步与改善。(4) 无效：较治疗前无进步。

共治疗200例。基本治愈80人，占40%；显效92人，占46%；有效20人，占10%；无效8人，占4%；总有效率达96%。

闻韶华 耳压治疗智力低下200例临床小结 江苏中医 (3); 21, 1990

23. 尺偏型肱骨髁上骨折

肘外侧经皮穿针法

以伸直尺偏型为例。采用臂丛神经阻滞麻醉，患儿仰卧位或坐位，第一助手握伤肢上臂，第二助手握前臂下段及腕部。常规局部皮肤消毒，铺无菌巾，令助手对抗牵引，术者在无菌操作下，首先整复旋转、尺偏及向后移位，然后充分矫正尺侧嵌插及倾斜，尽力造成桡偏及桡侧嵌插并维持固定。将患肢外展30度，肘关节屈曲80~90度，前臂始终保持旋前位。由另一助手在无菌操作下，选用直径1.5~2 mm克氏针，用骨钻将钢针由尺骨鹰嘴外方约2~3 cm（肱骨小头外后缘）与肱骨纵轴相交处，经皮刺入，直达骨膜下，向内上呈35~50度、向前呈5~10度的方向缓慢钻入，针尖穿到对侧骨皮质，一般即可稳定。如不稳定，可在第一枚针内或外0.5~1 cm处按上述方向再插入一枚，针尾弯曲留于皮外，无菌敷料包扎。将前臂旋前位或中立位，肘关节屈曲90度，小夹板或铁丝托超肘关节固定（本院特制）。术后3~4周拔出克氏针，解除外固定，进行肘关节功能锻炼。

屈曲型（尺侧）骨折，整复向前移位方法与伸直型相反，整复旋转、尺偏（尺侧嵌插及倾斜）和穿针治疗及固定方法与伸直型相同。

共治疗107例。本组病例随访时间最长32个月，最短6.5月，平均19.2月。结果，肘关节功能及外型与健侧相同者102例，肘关节伸屈活动正常；肘内翻5~10度者5例，无一例超过10度或关节受限。其中2例针眼轻度感染，经换药后痊愈。

王培森等 肘外侧经皮穿针治疗小儿尺偏型肱骨髁上骨折107例
(3); 444, 1989

24. 小儿睾丸鞘膜积液

点 穴 法

患儿取仰卧位，也可在哺乳或睡觉时进行，其母亲用手略固定双腿，医者以双手中指端，轻轻点在双侧三阴交穴上，两手做反向平揉，由轻到重，以患儿无痛苦为度，每次平揉各100下，在平揉法操作完毕时，仍以中指端在原穴位上，向深部下压，达到穴位皮肤水平之下，有落实感为度，压下即上提中指，不离开皮肤为一放，压放100下，用力要均匀、协调、节律一致。

然后再依同样手法，在双侧蠡沟穴上进行平揉和压放各100下，每日进行1次，7回为1疗程，间隔2~3天，再行下疗程。恢复慢者，可加艾条悬灸水道穴，皮肤潮红为度。

痊愈：阴囊内积液全部消失，与健侧比较无明显差别，且无任何不适感，半年内无复发；显效：阴囊内积液消失三分之二以上或全部消失后，半年内又有轻度复发；有效：阴囊内积液，消失二分之一以上；无效：症状无变化者。

共治疗7例。本组7例经7~15次治疗，全部治愈，随访半年未复发。

刘智 点穴治疗小儿睾丸鞘膜积液 辽宁中医杂志 (5), 39, 1991

25. 疥 疮

砒硫薄艾条外熏法

1. 药物的组成:

砒霜0.5g，硫磺5g，薄荷5g，焦艾叶5g，

2. 制法：烘干共碾粗末。

3. 用法：用较厚草纸卷药末或纸卷，燃烟熏患处，每次15—30分钟，隔日一次，温度以病人能耐受为宜，一般只需2—5次即可。

4. 注意事项：

①病变部位局限，只需局部外熏，若病变遍及全身，可睡卧在床上，脱尽衣服，外用被单复盖于身躯上，裸体熏治，头部暴露于外，可戴口罩。女性熏治时，阴道口要用它物遮盖。

②方法简单，经济实用，易于操作，几年来的临床实践，疗效可观。（对于成年人患此病，方法同样）。未见其它不良反应和副作用。

③熏完后，往往上面有一层油胭脂，不要立即擦掉，保护时间越久，疗效越高。

④由于卷条内有砒霜，其药物主要含三氧化二砷，砷有原浆毒的作用。能麻痹毛细血管，抑制含巯基酶的活性，并使肝脏脂变，肝小叶中心坏死，心肝肾肠充血，上皮细胞坏死，毛细血管扩张，因此，对孕妇，久病体虚，急性炎症皮损者禁用。

共治疗34例。治愈：皮疹消退，自觉症状消失。

显效：皮疹消退较慢，时有搔痒感，但能忍受。

无效：病情无变化，搔痒无度。

在34例中，治愈32例，治愈率达94.2%，显效2例，使用本法，治疗疥疮未见无效。

黄新云 砒硫薄艾条外熏治疗小儿疥疮的初步观察 中医药学报
(5)，38，1990

26. 单纯性腹痛

耳 压 法

取耳穴脾、胃、神门、内分泌。若大便溏薄加大肠、小肠、肾上。

腺。用王不留行子贴压在选好的穴位上，每天按压3~5次，每次按压5~10分钟。3天换1次。两耳交替贴压，同时停用一切药物。

共治疗60例。治疗后，23例3天腹痛消失；11例6天腹痛消失；12例9天腹痛消失；9例12天腹痛消失；5例15天后腹痛消失。

杨喜晶 耳压法治疗小儿单纯性腹痛60例 浙江中医杂志 (7), 809, 1990

27. 肠 痉 挛

耳 压 法

主穴：皮质下、小肠、交感、神门、三焦、脾。伴有食欲不振者配胃、肝、胆；便秘者配大肠、直肠下段；有蛔虫指征者配耳迷根；精神不振者重按脾。

操作方法：上述主穴分成两组，每组2~3穴，并酌情选用配穴。找准穴位后，将王不留行籽用 $0.5 \times 0.5 \text{cm}^2$ 胶布贴压在选好的耳穴上，嘱患者每日自行按压耳穴3次，每次5~10分钟，以所压耳穴出现胀痛且能忍受为度。每次取双侧耳穴，两组穴交替使用。隔日治疗1次，5次为1疗程。

共治疗53例。显效：经耳压治疗后患者自觉腹痛完全消失，饮食增加，精神好转，二便正常，触诊腹软、无敏感及压痛者；有效：治疗后患者自觉腹痛消失，或明显减轻，或偶有轻微疼痛，但不影响正常生活、学习者；无效：耳压治疗2个疗程以上，患者腹痛未见减轻，或反有加重者。显效44例，有效6例，无效3例，总效率94.34%。

刘森亭等 耳压治疗小儿肠痉挛53例 陕西中医 (8), 369, 1989

28. 肠套叠

针灸揉按法

1. 将患儿仰卧诊床，助手握住四肢，避免动弹，选至阴穴(双)针刺，交替刺激，加灸15~20分钟(须防烫伤)至局部皮肤微红为度。

2. 上法同时，根据包块部位，另手揉按腹部包块处，先用手指轻轻提捏，顺肠蠕动生理，逐渐加重手法揉按，直至包块消散，约1~2小时之久。

3. 在针灸过程中，根据主症先后程度不同，配合辅穴，即呕吐明显者加针内关、下脘；泄泻明显加针足三里、阴陵泉；腹痛明显者加针里内庭、中脘。

共治疗12例。痊愈：临床症状完全消失，乳食复常，腹部包块消散、不哭闹。好转：临床症状明显减轻。无效：经治诸症状无缓解。

经综合治疗12例，1次综合治愈5人，2次综合治愈7人。

陈驰 针灸揉按治愈肠套叠12例 陕西中医 (7)，317，1989

29. 蛔虫症

经穴磁疗法

系磁肚兜(钽钴磁片每片直径7.5mm，厚2.5mm，磁强1000~1500高斯，以神阙穴为中心，分别按中脘、天枢、气海、关元等俞穴定点，将磁片缝在肚兜上)4天。系磁肚兜后每天清晨(空腹)及下午口服我院灌制的磁化水(磁化水器的磁场切割水18次以上，流速小于0.9米/秒，切割磁场强度2000~5000高斯)各1次，每次300~500

ml, 连服 4 天。

共治疗 42 例。治疗结束后 7 天内有蛔虫排出, 或连续粪检蛔虫卵 3 次, 有 2 次以上 (最后一次检查一定要转阴) 转阴者为有效。按此疗效标准统计, 磁疗组 42 例, 有效 40 例, 有效率 95.2%;

任杰 经穴磁疗法治疗儿童蛔虫症疗效再观察 中医杂志 (11); 45, 1987

耳 压 法

甲组: 三焦、胆、耳迷根; 乙组: 大肠、交感、皮质下。上述两组穴位交替使用, 把医用胶布剪成 $0.5 \times 0.5 \text{cm}^2$ 小块, 然后将王不留行籽置于胶布中心贴在选好的耳穴上, 嘱患者每日按压药籽 3—4 次, 每次约五分钟, 隔日治疗一次, 5 次一个疗程, 两疗程间休息 3 天。

本组共 21 例蛔虫症患者, 经耳压治疗排出蛔虫者 18 例, 占 85.71%。未见排虫者 3 例, 占 14.28%。此 3 例中 1 例虽未见排虫, 但患者自觉治疗后脐周疼痛消失、饮食增加、精神好转。似有安蛔作用。有效病例中, 疗效最快者于耳压 1 次后即排虫, 最慢者于耳压 10 次后排虫, 平均约 3.3 次后即可排虫。1 次排虫最少者 1 条, 最多者 21 条。有效病例多在耳压治疗后 1—4 次后排出蛔虫。

刘森亭等 耳压治疗小儿蛔虫症 21 例疗效观察 陕西中医 (10); 466, 1987

30. 小儿流涎症

针 刺 法

取穴: 地仓、颊车。手法: 由地仓穴进针后, 针尖向颊车穴方向平刺, 深度为地仓与颊车联线上的 $1/2 \sim 2/3$ 。得气后做 45° 小幅度捻转, 共 30 转出针, 急闭针孔。5 次为 1 疗程, 疗程之间休息 2 天再进行

第2疗程，2个疗程无效者不再针治。

痊愈：针刺后流涎完全停止，随访1个月无复发者；好转：针刺后流涎明显减轻，但没完全停止者；无效：针刺前后流涎无任何变化者。

1个疗程痊愈者58例（其中针1次即控制流涎者35例），2个疗程痊愈者33例，好转10例，无效2例，总有效率98%。

杨景柱 地仓透颊车治疗小儿流涎症103例 陕西中医 (12), 551, 1990

31. 急性扁桃体炎

穴位点刺与封闭法

发病1~2天内开始治疗。患儿端坐在椅子上，术者站在患儿身后，先用双手按摩双耳5 min，使双耳发红充血，然后用碘酒及酒精常规消毒。以左手食指与拇指夹紧外耳轮，用三棱针或缝衣针，在扁桃1~3穴分别划痕1 cm，然后挤压使出血0.2~0.5 ml左右，扁桃体4穴以点刺出血为度，不可穿透（另一侧以同样方法进行），术后外耳涂碘酒。其后点刺患儿双少商穴放血1~2滴即可。如患儿系急性扁桃体炎反复多次发作者，除上方法治疗外还须进行双内庭封闭加强疗效。其操作方法：患儿取坐位，双腿屈曲。常规消毒双内庭穴局部皮肤，双手各持一具注射器，同时刺入双侧内庭穴，进针0.5 cm左右，有得气感后缓慢同时各注入维生素B₁₂ 50 μg，术后以酒精棉球按压，并同时作环形按摩数十次。

1. 注意无菌操作，皮肤严格消毒，以防止感染。2. 划痕时动作要轻，切勿划及耳软骨。双耳划痕出血量不可超过1 ml。3. 耳部有炎症及出血倾向的患儿禁止操作。

共治疗72例。治愈：扁桃体不肿大，脓性分泌物消失，体温正常；好转：扁桃体缩小，脓性分泌物消失；无效：扁桃体与治疗前无

明显变化。用本法治疗1~2次,共治疗72例,治愈61例,好转7例,无效4例,总有效率为94%。

姬乃平 穴位点刺与封闭治疗小儿急性扁桃体炎72例。陕西中医(2), 85, 1991

32. 慢性鼻炎

针 刺 法

1. 穴位:迎香:鼻翼旁开3分,鼻唇沟平鼻翼外缘中点处即是本穴。

上迎香:鼻唇沟上端终点处即是本穴。

2. 取穴方法:由迎香穴进针,沿皮刺,针尖指向上迎香穴方向,进入5分至1寸深,得气后做45°捻转30次出针,急闭针孔。

3. 疗程:15次为1疗程,1疗程无任何效果者停针,1疗程好转未愈者隔5天再针第2疗程。

共治疗68例。痊愈:针刺后鼻腔通畅,无分泌物,观察1月无复发者。好转:鼻塞减轻,分泌物明显减少。无效:针刺前后无变化,或有短时间好转,以后又恢复原状者。

治疗1个疗程痊愈者32例,两个疗程痊愈者18例,好转12例,无效6例(4例过敏性、2例肥厚性),总有效率91.2%。

杨景柱 迎香透上迎香治疗儿童慢性鼻炎68例 陕西中医(11), 518, 1989

33. 急性中耳炎

半 刺 法

取穴:“聾耳穴”(自拟名),位于耳屏尖与听宫穴间外1/3处。

操作：常规消毒后用30号5分毫针，取患侧穴位，针刺深度为小儿同身寸1分，浅刺而疾出针，出针后不闭孔（即用泻法）。

疗程：每日1次，3次为1疗程。

痊愈（针刺1疗程后流脓停止，耳痛消失，耳镜检见外耳道干燥清洁，外耳道及鼓膜充血消失）；好转（针刺1疗程耳痛消失，流脓明显减少，耳镜检见外耳道及鼓膜充血减轻）；无效（针刺1疗程症状及耳镜检无明显变化者）。

共治疗60例。痊愈（以患耳只数计算，下同。）58只占85.3%，其中1次治愈18只，2次治愈26只，3次治愈14只。好转7只占10.3%。无效3只占4.4%。总有效率为95.6%。

刘靖宇 半刺法治疗小儿急性中耳炎60例疗效观察 江苏中医
(12)，30，1990

34. 乳牙慢性尖周炎伴瘻管

针 刺 法

上牙（包括左上，右上）伴龈瘻，选同侧合谷、曲池、颊车、下关；下牙（包括左下右下）伴龈瘻，选用同侧合谷、大迎、颊车。手法为中等度刺激，隔日针1次，每次留针30分钟。

共治疗40例患儿，56颗牙，最少针刺1次，最多5次，全部治愈。

李元联等 针刺治疗乳牙慢性尖周炎伴瘻管40例 辽宁中医杂志
(3)，36，1989

第五章 五官科 疾病及其它

第一节 眼科疾病

1. 睑腺炎（麦粒肿）

针 刺 法

取阿是穴，即在红肿处酒精消毒后，用0.5~1寸毫针，斜向刺进红肿处2~5 mm；肿物小者浅刺、大者深刺，不捻转，留针5~15分钟。为加强疗效，可同时在耳尖穴或太阳穴，用毫针点刺，稍挤出血。一般在初期或未成脓时，针1~2次即可消散；若已成脓时，则针2~4次，可使红肿消散、症状减轻而愈。

共治疗700例，针刺1~4次痊愈率达92%。

张淑英 针刺治疗麦粒肿 中国针灸 (3); 55, 1986

挑治肩井法

1. 选穴：取患侧眼睑的对侧肩井穴，两侧同时发病，取发病较

重的对侧眼睑的肩井穴。2.用具：把缝皮大弯针的中间弯曲部，用胶布缠绕数周，浸泡到75%酒精内备用。3.操作：常规消毒穴位和医者双手，用缝皮大弯针按挑治法挑断肩井穴5~7根肌纤维，用无菌干棉球盖压针眼，胶布贴压。1~2天胶布自动脱落。

共治疗300例。挑治后，疼痛肿胀消失无化脓现象为痊愈。挑治3天仍疼痛化脓者为无效。300例患者于挑治后3天内，有295例痊愈，5例化脓无效，治愈率98%。

杨桂荣 挑治肩井穴治疗麦粒肿300例 山东中医杂志 (2), 37, 1991

耳 针 法

取穴：患眼同侧耳之眼穴、肝穴、枕穴。

操作方法：患者取坐位，常规消毒后，分别针眼穴、肝穴、枕穴，留针15min。在留针同时，按摩患眼，上部由睛明穴经攒竹、太阳穴至耳尖；下部由睛明穴经承泣穴至耳垂，上下交替按摩3~5min。如不用针，改为耳穴压豆方法也可。

在137例中，1次治愈125例，占91%；2次治愈11例，占8.3%；3次治愈1例，占0.7%

姜文娜 耳针治疗急性麦粒肿 辽宁中医杂志(10); 29, 1988

针 刺 法

取穴：有两个刺激点，分别在第一胸椎和第五胸椎棘突上缘，操作方法：让患者取端坐位，曲肘交叉，放在两臂上，肩下垂，头部向下低，使背部皮肤拉紧，充分暴露椎体，显示棘突。刺激点取准后，用2寸长28号针，与皮肤成15°夹角顺椎体刺入皮下和棘突之间。切勿左右偏离，以免刺伤脏器。具体操作时，针尖可稍往上移3~5分再向下刺入，使针体正好通过穴位，能更好地发挥疗效。每10分钟行针一次，用强刺激泻法。10~15分钟可明显感觉局部轻松，胀痛感减。

轻。在治疗中必须注意如患处成脓，切忌挤压以免脓性分泌物顺血流入海绵窦，引起严重的并发症。

治疗90例，皆用针刺治疗，少则1次，多则4次。治愈30例，显效5例，无效5例，总有效率94.4%。

牛阳中等 针刺治疗麦粒肿90例 陕西中医 (12)，536,1987

灯 火 灸

停用抗菌素和外用药，在患者胸椎两旁及肩胛附近寻找皮肤异点即反应点。其形如粟粒，色红或棕褐色，如果未找到皮肤反应点则灯火灸相当于膏肓穴部位。病人反坐在靠椅上，暴露背，选好部位，常规消毒后，取灯心草一段，蘸以香油或其它植物油约1cm，点燃后，对准穴位迅速爆灸，此时常可听到“啪”的一声响，叫做一焦。灸处有小块灼伤应保持清洁，防止感染。一般于5天左右灸处结痂开始落，每穴只灸一焦，间隔4~5天灸一次。

治疗50例中，痊愈44例，占88%。显效6例，占12%，总有效率为100%。

张莉芳 灯火灸治疗麦粒肿50例 陕西中医 (4)，174，1989

揠 针 埋 耳 穴

取病人患侧的耳穴，主穴：眼；配穴：肝、神门、皮质下。方法是先将病人患侧的耳垂用2.5%碘酊消毒，然后再用75%酒精脱碘。把事先备用的消毒揠针用尖镊子挟起，在耳垂正中的眼穴准确快速地按进穴中，并用胶布固定，症状较轻者一般只埋眼穴，每日指压四次增强穴位刺激。红肿显著者再酌情选加配穴，如肝、神门等，方法同上。

痊愈35例 (74.4%)，总有效率为95.7%。

任守珍 揠针埋耳穴治疗麦粒肿47例 中国针灸 (2)，8,1986

隔核桃皮壳灸

灸器制作与施灸方法：以半圆形核桃壳作为施灸隔物，另将铁丝弯成眼镜框形，再用胶布缠绕以便隔热，并在鼻托处固定一艾条铁丝架，向前水平伸出，弯至双眼正中位置。施灸前先将核桃壳放入开水浸泡的菊花液中约10~20分钟，取出后将核桃壳半圆球面朝外，套在患侧眼镜圈内给患者带上。患侧灸架上插1寸艾条，点燃施灸。日灸1次，每次灸2段，以患处有温热感为宜，过烫可调节眼镜框与眼的距离，注意防止艾灰落于面部。

50例患者全部有效。无硬结形成的早期麦粒肿，一般施灸1~3次可愈；已形成明显硬结的吸收较慢，病程稍长；少数病变进入化脓期者，经灸治破溃出脓后可愈。同时我们观察到，施灸多次的核桃壳，不如新的疗效好。灸治此病50例，痊愈43例（施灸1~3次痊愈30例，4~6次12例，6次以上1例），占86%；其余7例也均有明显好转，自觉症状消失，遗留硬结无压痛，疗效快，无痛苦，患者易接受。

胡秀莲等 隔核桃皮壳灸治麦粒肿 中国针灸 (3);55, 1986

2. 睑板腺囊肿（霰粒肿）

针 刺 法

用一寸长毫针直刺大椎。

共治5例，均经1~2次获愈。

史荣根 针刺大椎治疗麦粒肿、霰粒肿20例 浙江中医杂志 (5); 225, 1989

3. 上睑下垂

针刺配合功能锻炼法

1、针刺：取合谷、百会、阳白、攒竹、丝竹空、瞳子髎、外关穴，常规消毒后，用0.5~1.0寸毫针对阳白、瞳子髎、攒竹、丝竹空用轻刺激补法，不提插捻转；百会、合谷、外关用平补平泻法。均留针40~60分钟。每日一次，10次为一疗程。疗程间休息3天。2、功能锻炼：立正姿势，精神集中向正前方平视5分钟，用双手食指在太阳穴及眼周轻轻揉按20分钟，然后持儿童望远镜并通过镜筒向远方尽力睁望，单眼睑下垂者可闭上健侧眼睛。15分钟后休息2分钟，依此法坚持30分钟，每日早晚各进行一次。

共治疗33例。1、临床治愈：眼皮垂缓上提明显，眼肌睁开有力，外观基本或接近正常。单侧18例，双侧3例。2、有效：眼睑垂缓有轻度变化，眼肌睁开较前有力，单侧8例，双侧2例。3、无效：眼睑下垂与前无变化。双侧1例。总有效率为96.96%。

张和平 针刺配合功能锻炼治疗先天性眼睑下垂33例疗效观察
黑龙江中医药 (5)，43，1990

针 刺 法

1. 取穴：鱼腰（即眉中）在眉毛正中，下对瞳孔处，攒竹（即鱼头）在眉毛内侧端、目内眦直角上，即眶上切迹处，丝竹空（即鱼尾）在眉毛外侧端瞳子髎直上处。

2. 方法：患者仰卧于床，医者用一手拇指，食指绷紧患侧上睑皮肤，再用另一手拇指将患眼上睑皮肤轻轻地按摩2min后，再用75%酒精棉球消毒患眼皮肤（嘱患者闭眼勿使醇水溅入眼内），然后用1寸（30mm）不锈钢针以10~15°斜行进针，由上向下速刺鱼腰穴，

攒竹、丝竹空两穴均向鱼腰方向横刺，进针0.3~0.5寸，得气后留针10min，间隔5min，行针1次，30min后慢慢退针，禁灸。

共治疗30例。痊愈：睑举运动恢复，自觉症状消失；有效：睑举运动轻度有力，自觉症状明显好转；无效：症状未减或加重者。

本组30例（32只眼）中，痊愈23例（25只眼），有效6例（6只眼），无效1例（1只眼），总效率96.67%。

鱼俊杰等 针刺鱼腰穴治疗上睑下垂30例 陕西中医（12），1990

梅花针叩打法

取用七星梅花针叩打眼上胞局部（眉棱骨一线及周围太阳、阳白穴等），依次叩打头及背部督脉经、膀胱经一二侧线（椎体旁开1.5寸、3寸处），按经络走循方向，先头后背，由上而下。叩打前，先用酒精棉球常规消毒皮肤，用右手拇、食指平握梅花针柄后端，用手腕力由轻到重敲打，以皮肤潮红、不出血为度。隔日1次，每次大约5~10分钟。

共治疗6例，上胞下垂恢复正常，双眼瞳孔等大等圆，眼球转动自如，随访半年以上未复发者为痊愈。上胞下垂基本恢复，患者眼裂比健侧稍小，眼球可以转动，但不自如，范围局限为好转。病情无变化为无效。6例患儿，经上法治疗少者10次，多者30次，3例痊愈，3例明显好转（因未坚持治疗）。

李瑞珍 梅花针叩打治疗上胞下垂6例 山西中医（4）；37，1990

4. 急性结膜炎

刺血拔罐法

取双少泽穴，眼点穴及大椎穴，常规消毒。用消毒过的三棱针对

准穴位快速刺入1分，立即出针，使之血出，出血数滴后，可用棉球压迫穴位，使之血止。如不出血，可用手挤捏或再刺。

大椎穴可刺入0.5~1cm，挤捏出血后，在该穴位处进行拔罐，每次15~20分钟。以视见流出黯红或紫黑色血液，皮肤呈瘀血状为度，每次出血量不超过（成人）10ml，每日1次。同时给0.25%氯霉素眼药水和醋酸可的松滴眼液交替点眼。

共治疗1025例。治愈：自觉症状显著减轻或消失，眼睑肿胀和结膜充血水肿消退，出血大部分吸收；有效：自觉症状减轻，眼睑肿胀消退，结膜仍轻度充血，出血未完全吸收；无效：治疗5次以上，自觉症状未见明显减轻，结膜充血和出血未见明显减退。

治愈967例，有效27例，无效11例，总有效率98.93%。治愈的987例中，用刺血拔罐法1次治愈893例，2次84例，3次10例。我们对1次治愈的病人经向周围来诊病人的调查和部分病人的随访，一般治疗后第2天症状就显著减轻，第3天痊愈。无效的病人多是经其它医疗单位治疗无效而转成慢性结膜炎的病人。

毛宽荣等 刺血拔罐法治疗流行性急性结膜炎1025例 陕西中医(10)，468，1989

针 刺 放 血 法

针刺：攒竹、丝竹空、睛明、瞳子髎、四白，（每次任选3穴）配穴合谷。以泻法为主。放血：双太阳穴。

疗程：每日1次，共需1~3次。

治疗253例急性结膜炎患者，一次治疗有效率为100%，治愈率达85%。首次处置后患眼有轻松感，次日结膜充血部分消退或基本消退。

马莉 针刺放血治疗急性结膜炎 山西中医(4)，15，1990

针 刺 法

针刺陷谷透涌泉。

共治疗28例。均于针刺1~2次后痊愈。

王松荣 针刺陷谷透涌泉治疗急性结膜炎的经验介绍 中医杂志
(12), 29, 1987

毫针浅围刺法

取穴：印堂、攒竹（双）、鱼腰（双）、瞳子髎（双）、丝竹空（双）、太阳（双）、承泣（双）、下睛明（双）。

操作：常规消毒后，用1寸毫针分别刺入上穴1~2分，针身由重力作用自然下垂，进针时不用押手，针尖直接刺入皮肤（此法有较强的刺激，能使双泪流）。留针30分钟。每日治1次，如有条件应上下午各治1次。

12例患者全部治愈（针刺半小时后，双目痒痛酸胀不适感消除，经治3次后双目肿消红退为痊愈，疗程在3~4天内）。其中1次治愈者3例，2次治愈者4例，3次治愈者5例。

张淳 毫针浅围刺治疗急性眼结膜炎12例 北京中医学院学报
(2), 34, 1990

挑刺法

让患者反坐在靠背椅上，在背部皮肤的第4~6胸椎左右旁三寸范围内寻找红色或暗褐色的摸之碍手，略带光泽、压之不褪色的“粟米点”。若一下看不出，可用指腹反复推擦至其出现。用酒精棉球消毒后，左手拇、食指固定“粟米点”及附近皮肤，右手持三棱针，用针尖先挑破“粟米点”表皮，然后用半挑半钩的手法寻找纤维状物，挑起时弹扯拉拨一下，再把它挑断。如此反复挑扯少者十多条，多者几十条不等，一般不出血或稍出血，然后用酒精棉球覆盖伤口，胶布固定。单眼患病挑对侧，双眼同时患病挑明显阳性点，3天挑治1次，3次为1疗程，挑治期间不用中西药物。

共治疗53例。挑治一次痊愈者39例，2次治愈者8例。好转4

例，无效2例。

李建国 挑刺法治疗天行赤眼53例 河南中医 (5)，15，
1988

点刺耳尖法

酒精消毒，三棱针，迅速向耳尖穴刺进一分深，快速退出，挤出3~5滴血即可。

112例中，针一次者54例，针二次者58例，1例改用中药治疗。痊愈75例（眼结膜红肿疼痛多眵、畏光均消失），好转36例（以上诸证均减），无效1例（症状无改善），有效率达99%。

胡宏英 点刺耳尖穴治疗红眼病112例 中国针灸 (4)，32，
1987

5. 出血性结膜炎

耳 针 法

病人取仰靠坐位或仰卧位，先取患眼睛明穴，用1寸毫针，左手拇指将眼球向外侧轻轻推按。右手持针，缓慢刺入约4~6分，切忌捻转提插。留针15分钟。再于耳尖部用5分毫针刺入1分许，捻转数次，留针15分钟，起针后挤压使针孔出血数滴。最后于耳垂部“眼区”用胶布将莱菔子（王不留行子、绿豆均可）贴压固定。嘱患者每隔2~3小时按压数10次，以加强刺激。

每日治疗1次，重者可1日2次，对儿童患者不针睛明，只针耳尖放血及贴压眼区，但收效不如加配睛明者。

本组64例全部治愈。针1次治愈者44例，占68.8%；针2次治愈者11例，占17.2%；针3次治愈者9例，占14%；针1次于24小时而愈者35例，针1次或2次于48小时而愈者22例，针2次或3次于72小

时而愈者6例。平均治愈时间为48小时，为自愈时间（2周）的1/7（对个别出血严重，临床症状完全消失，仅瘀血吸收过程者不包括在内）。

靳志荣 耳穴为主治疗出血性结膜炎64例 上海针灸杂志(3), 26, 1987

6. 急性眼病

针 刺 法

取穴 主穴：臂臑（患侧）、太阳（双侧）、睛明（患侧）。

配穴 有全身症状者加合谷、曲池穴；光热眼症者加四白穴。

操作方法 常规消毒。针太阳穴，直刺3分，用泻法，留针10分钟，留针期间捣针3次，红肿严重者用三棱针刺血，效更佳。针睛明穴，令患者直视正前方，直刺2分，留针10分钟，不捻转，不捣针。取针时务必用无菌干棉球立即压迫穴位2至3分钟，以防出血。针臂臑穴，令患者手掌叉腰，针与臂呈25°角度向上捻进1至1.5寸深，行捻转手法10余次，患眼即有清凉感，羞明畏光、沙涩等症稍觉减轻，若无反应，则将针退至皮下，针仍与臂呈25°角度，与第一次进针方向呈30°角度向左上捻进1~1.5寸，行捻转手法10余次，再将针退至皮下，又与第一次进针方向呈30°角度向右上捻进1~1.5寸，行捻转手法10余次，留针10分钟，留针期间捣针3次。

病证分类 光热眼病26例，急性结膜炎212例，尘埃异物入目者4例。

共治242例 结膜充血、眼睑红肿、羞明畏光、流泪多眵、沙涩灼痛消失者为治愈；上述症状减轻，但须配合中药治疗收功者为好转，经本法治疗症状无改善者为无效。

242例针刺治疗后，羞明畏光、沙涩灼热胀痛等症均立即减轻。治愈者240例。其中针刺1次治愈者12例，2次治愈者109例，3次治

愈115例，4～6次治愈者4例，好转者2例，均系尘埃异物入目刺激较重者，针刺7次未愈，然后配合药物治疗。其有效率达100%。

张长生 针刺治疗急性眼病242例 湖南中医杂志 (2); 37, 1990

7. 弥漫性细点状角膜炎

耳穴封闭法

在患眼的同侧耳穴上：目①、目②、眼、肝、内分泌、耳前穴，每次取2—3个穴位、注射聚肌胞注射液0.2ml，隔日一次或隔2日一次。如为双眼患病，则双耳穴轮流穴位封闭。在治疗中眼局部点抗生素眼药水和抗病毒眼水，口服维生素B₁、B₂、C等以辅助治疗。痊愈后嘱病人口服杞菊地黄口服液（或丸）、黄芪口服液。减少复发。

204例患者中，一次耳穴封闭，二天后复诊绝大多数患者的畏光、流泪及眼瘤不适等症状都明显好转。经两次耳穴封闭后，角膜荧光素点状染色阴性者100例占49%；经三次耳穴封闭后阴性者78例；四次耳穴封闭后阴性者22例；五次耳穴封闭后阴性4例，平均治疗天数4—6天，治愈率为100%。

王其惠等 聚肌胞耳穴封闭治疗弥漫性细点状角膜炎 中西医结合眼科杂志 (2); 85, 1991

8. 慢性青光眼

头针法

选用枕上线、额中线、额旁一线、顶颞前斜线下2/5，交替使用。用直刺快速进针法，留针30min。7天1疗程、每疗程间隔3天。

对50例患者的65只眼治疗结果是：显效（自觉症状全部消失，视力有所提高）46只眼；有效（自觉症状消失，视力未提高）15只眼；无效（自觉症状及视力无改变）4只眼。总有效率为93%。

王仰文 头针治疗慢性青光眼50例 陕西中医（4），178,1991.

9. 老年性初期白内障

挑 治 法

1. 用具：1根特制钢针，长5cm，直径约1mm；手术刀1把；小火罐1个；纸块、棉签各1盒。以上物品均须高压消毒后备用。

2. 挑治部位（穴位）：第6颈椎棘突处；第7项椎棘突处；第1胸椎棘突处。以上各处周围约0.5cm处的6个点作为挑治部位，每7个点构成一个梅花形。最初3次分别在第6～7颈椎，第1胸椎棘突处挑。第4～12次分别在棘突处周围左右上下相对称的两个点挑治。

3. 操作方法：患者取坐势，头略低。暴露局部皮肤后选定挑治部位。按常规消毒皮肤，然后用针挑破皮肤。从皮下组织中可挑出白色纤维物数十条，至白色纤维挑净为止。白色纤维病理切片，证明为肌纤维。将白色纤维挑断或用手术刀切断，挑治部位有少量出血，用消毒纸块擦干即可。然后在该处拔火罐，吸出少量血液即行起罐，将血擦干再用酒精消毒，盖上消毒敷料，以胶布固定。

4. 挑治时间：第1～4次每日挑治，从第5次开始，则每周挑1次，12次为1疗程。休息1个月后开始第2个疗程，其部位在上述梅花点旁开或上下挑选，挑治次数根据病情需要而定。

5. 禁忌：挑治过程中禁食辛辣和有刺激性的食物，禁房事。

共治疗40例。采用国际标准视力表测量，疗效判定标准：1.显效：指视力增进4行以上；2.进步：指视力增进2～3行；3.无效：

指视力没有增加或只增进1行左右。

总有效率为67.6%（按眼数计算，下同）其中显效10例，计16只眼，占21.6%；进步18例，计34只眼，占46%；无效12例，计24只眼，占32.4%。

赵治清 以挑治为主治疗老年性初期白内障40例的疗效观察 中国针灸（1），22，1986

10. 白 内 障

针 拨 法

局麻、扩瞳，以剃须刀片在颞侧离角膜缘4—5mm处贯穿切口，进针，拨断韧带，并将晶体推入玻璃体视网膜锯齿缘附近，稍压2分钟，务使韧带全断，达到起针后不再浮起，退针，结注抗生素、激素、包眼、半卧1—2天，36小时后可下床活动，避免低头。

经治，裸眼视力在0.08的40眼，0.04~0.06的75眼，0.02的4眼，增加甚微的8眼，不增加的4眼（22眼未测视力），手术并发症：晶状体半脱位14眼（9.4%），玻璃体混浊15眼（10.5%），虹膜睫状体炎4眼（0.28%）。

罗成虎 针拨白内障89例临床观察 中西医结合眼科杂志（2），98，1991

穴 位 注 射 法

（一）取穴：足光明、足三里、三阴交、养老、曲池、内关、合谷；体弱气血虚者加肾俞、肝俞或血海。上述穴位均取双侧，每对穴位为一组。

（二）药物配伍：第一、三疗程，当归注射液2毫升，维生素C 500毫克，第二疗程，维生素B₁50毫克、B₁₂100微克，当归注射液

1 毫升。

(三) 操作方法与疗程：每天取穴一组。用 4 毫升注射器套上 7 号针头，按配方将药吸入针管混合，然后刺入选定的穴位（进针深浅依穴位而定，养老穴取斜刺），寻找针感，待针感出现后快速注入药液，每穴 1.5 毫升，7 天为一疗程。在结束一个疗程后，应休息 5～7 天，然后再继续下一疗程。

疗效观察：全部病例经用上法注射后，效果满意。注射最少者一个疗程，最多者四个疗程，一般二至三个疗程视力即可得到明显改善。疗效标准：视力提高 0.3～0.5 以上，共 115 只眼，为显效，占 57.5%；视力提高 0.1～0.2 以上，共 70 只眼为有效，占 35%；经注射四个疗程，视力无改善者，共 15 只眼为无效，占 7.5%；总有效率为 92.5%。

温建全 穴位注射治疗老年性白内障 100 例 中国针灸 (2)，36，1986

针 拨 术

术眼在术前连续七天点抗生素眼药水，术前一天清洁结膜囊，充分散瞳，并在睡前给服安宁 2 片，醋氮酰胺 500mg，术前半小时再给服醋氮酰胺 250mg，术眼点 1% 地卡因二滴，患者取半坐位，2% 碘酒，75% 酒精消毒皮肤，铺无菌孔巾，2% 奴夫卡因做球后注射 1.5 毫升，并在上下睑缘皮下注入少许，作上下睑缘牵引缝线，左手用有牙齿镊子固定 6 点钟角膜缘的球结膜，右手用三角刀片在 4—5 点钟角膜缘外 4 毫米处做平行角膜缘切开结膜及巩膜切口长约 5 毫米左右，随后拨障针要垂直进入切口，指向眼球中心，针头凹面朝后，将拨障针的扁平部全部插入切口，后退出一半，针头留在切口内约 3 毫米左右，针柄向面倾斜，必在睫状体和晶体之间，缓缓摆动进针，越过虹膜之后到达瞳孔中心，先断裂 4—8 点钟悬韧带，使针之凹面转向晶体后囊，在这同时用针头划破玻璃体之前界膜，然后退针再依次压迫晶体 1—4 点钟，8—12 点钟，使晶体全断带后，将晶体保留在

6点钟处，用虹膜恢复器平整切口，球结膜下注入地塞米松5mg，结膜囊涂消炎眼膏，单眼包扎，扶病人回病房，取半坐位，可以下地走动，只是三天内不要低头即可，术后四天去掉眼罩。

崔蕴藏 98例老年性白内障伴有全身疾病做针拨术的临床观察
天津中医 (1)，21，1989

11. 中央性视网膜脉络膜炎

针 刺 法

针刺取穴为睛明、承泣、球后、攒竹、鱼腰、太阳，每次选3～4穴。阴虚加太溪，阳亢加风池，肝气横逆加太冲，气虚加足三里。针刺眼眶周围穴时医者持针，用压针缓进法进针，达一定深度得气后留针半小时，出针时宜缓慢捻出，随即用消毒干棉球按压1～2分钟以防出血。针刺其它穴位则用捻转进针法进针到一定深度，得气后留针半小时取出。每日1次，12次为1疗程。针治期间停止服药。经治1～2疗程，6眼视力好转，黄斑区病变改善，中心窝光反射隐约可见，7眼视力明显上升，超过治前1倍以上，黄斑区中心窝光反射出现，但较弱或弥散，渗出质减少，6眼视力恢复至1.0以上，黄斑区仅遗少量渗出质，中心窝光反射出现。

金仁琪 针刺治疗中央性视网膜脉络膜炎十例 浙江中医杂志
(6)，276，1989

12. 视网膜静脉周围炎

针 刺 法

取穴：局部取穴：承泣、球后、太阳、瞳子髎。远部取穴：膈俞、

肝俞、足三里、三阴交。

操作：局部取穴在患侧，取0.5~1寸毫针，以直刺或斜刺进针，施捻转泻法，以取得酸胀感为度。远部取穴均取双侧，以提插、捻转补法为主，以麻胀感为度，留针20分钟，每隔4分钟施手法一次。每日一次，6次为一疗程，隔日继续下一疗程。

共治疗32例。痊愈：眼内出血全部吸收，视力增进5行以上，达到1.0以上并无复发者。显效：眼内出血大部吸收，视力增进3~4行或更高，达到0.6~0.9者。有效：眼内出血有吸收，视力增进1行以上，达到0.1~0.5者。无效：眼内吸收不明显，视力不提高，或达不到0.1，或眼内出血复发，有眼内并发症者。

32例43眼中，痊愈16眼，占37.2%；显效13眼，占30.2%；有效6眼，占14%；无效8眼，占18.6%，总有效率为81.4%。其中，获得疗效最早者为12天，最迟者不超过45天。有22例，32眼进行半年后随访，复发者仅有4例，7眼，占21.9%。复发例数占18.2%。

王富春等 针刺治疗视网膜静脉周围炎32例 北京中医学院学报 (3)，25，1989

13. 视网膜动脉阻塞

针 刺 法

取穴：主穴：睛明、球后、承泣、健明。

配穴：曲池、合谷、风池、太阳

方法：每日一次，每次取主穴2个，配穴1—2个。进针1—1.5寸左右，待有酸、麻、胀感为度，留针20分钟。曲池、合谷、风池则根据病情施以捻转补泻法。每10次为一疗程，休息2—3天，再行下一疗程，至少坚持3—5个疗程。

共治疗50例。根据治疗前后的视力改变将疗效例为四等：

非常显著：黑蒙→0.04以上，光感、手动、1尺以内数指→

0.1和以上, 0.02—→0.3和以上, 0.03—→0.05—→0.4和以上, 0.06—→0.08—→0.5和以上, 0.09~0.1—→增加5行或更多, 0.1以上—→增加5行或更多。

显著: 黑蒙、光感、手动、1尺以内数指—→0.02和以上(低于上组), 0.02—→0.1或0.2, 0.03~0.05—→0.2、0.3, 0.06~0.08—→0.3、0.4, 0.09~0.1—→0.4, 0.1以上—→增加3、4行。

进步: 视力增进比“显著”差。

无效: 无进步或更差。

本文观察50例经上述治疗, 按上述治疗标准分级: 非常显著19例(38%), 显著14例(28%), 进步13例(26%), 无效5例(10%), 总效率为90%。

夏淑珍 针刺治疗视网膜动脉阻塞50例 天津中医 (5), 19, 1990

14. 视网膜色素变性

针药并用法

(一) 针刺: 1. 穴位: 主穴: 睛明、球后、上明等。配穴: 足三里、三阴交、翳明等。2. 手法: 针刺主穴, 施以烧山火手法, 得气产生热感后, 留针30分钟, 出针时再施以烧山火手法。3. 取穴: 每次取主、配穴各两个, 交替进行, 每周隔日1次。

(二) 中药: 以当归、黄芪、丹参、川芎、灵芝、葛根、夜明砂、紫河车等药组成基本方, 随证加减。服药期间, 如患感冒等病时, 暂时停服, 待感冒等愈后继续内服。

共治疗50例, 99眼。显效: 视力增进3排或以上; 或由光感、手动、指数上升到0.06以上。视野(包括岛状)扩大至20°以上。有效: 视力增进1~2排; 或光感、手动、指数上升到0.05或以下, 视野增大5~20°。无效: 视力及视野均无明显改变。恶化: 视力或视野较治

前减退或缩小。

本组99眼经过一个疗程的治疗，在视力方面，获得显效的28眼（28.28%），有效30眼（30.30%），总有效率为58.58%。

姚亦伟 针刺治疗视网膜色素变性50例疗效观察 上海中医药杂志（5），18，1991

15. 视神经萎缩

激光针灸法

1. 取穴 主穴：球后、翳明。配穴：内眼明、瞳子髎、足光明、三阴交。

每次取主穴1个，配穴1~2个，每日1次，每次10分钟，10次为1疗程，休息3日后可进行第二疗程。

2. 治法 打开 JGE-1 型氩-氟激光针灸仪电源，指示灯亮，将2毫瓦光针的针尖调整至红光集中一点，放入75%酒精瓶内消毒10分钟，常规消毒所选的穴位皮肤，把光针刺入穴位内，得气后留针10分钟。每次治疗前后检查眼底。

共治39眼疗效显著者11眼（28.2%），进步者19眼（48.7%），无效者9眼（23.1%）。总有效率为76.9%。

李桂森等 刺入式氩-氟激光针灸治疗视神经萎缩 吉林中医药（4），15，1990

16. 皮质盲

针刺法（一）

1. 取穴：主穴取内睛明，配穴取风池、光明为一组，合谷、太

冲为一组，两组交替使用。

2. 手法：内睛明穴的操作方法，令患儿睁开眼睛，术者持1寸30号毫针沿目内眦红肉上迅速垂直刺入0.5~1寸深，或翻开眼睑针从目内眦红肉上垂直刺入0.5~1寸深，不提插，不捻转。风池、光明、合谷、太冲均行平补平泻法，留针30分钟。

3. 疗程：每日1次，6次为1疗程。治疗次数最短者6次，最长者24次。

共治疗50例。全部病例经治疗后视力恢复，视物清晰，治愈率100%。

袁清顺 针刺内睛明治疗皮质盲50例疗效观察 陕西中医 (11) ; 519, 1988

针 刺 法 (二)

每日针1次，连续12次为一疗程。第一次至第六次选穴为两侧的太冲、光明、头临泣、足临泣、三阴交、公孙、风池、瞳子髎；第七次至第九次选穴为两侧的承泣、合谷、足三里、四白、攒竹、睛明、肝俞；第十次至第十二次选穴为眼区旁的经外奇穴，新穴，两侧太阳、头光明、球后内睛明，此处可刺头针的视区。以上循经取穴的手法用平刺法，留针30分钟，眼区取穴不提插捻转，以免损伤眼球。当一疗程效果差时休息5天后再作一疗程。

治疗40例，男24例，女16例，年龄2~6岁。26例治愈，即细小物体如火柴梗、缝衣针均能辨认、捡起；4例有效，即稍大物体如手绢、钢笔均能辨认、捡起。

崔萍 针刺治疗皮质盲40例 浙江中医杂志 (10) ; 450, 1988

17. 眼底病

针 刺 法

1. 取穴：新明I穴，位于耳垂后皮肤皱裂之中点，相当于翳风

穴前上5分处。新明Ⅱ穴位于眉梢上1寸，外开5分。

2. 针刺手法：新明Ⅰ穴进针时，将耳垂向前推拉，针向前上方呈45°角快速刺入，针尖达下颌髁状突后侧面，深度约1~1.5寸左右，耐心寻找满意针感，出现热、胀、闪电感者效果显著。新明Ⅱ穴进针时，针尖向额部垂直刺入，深达5~8分，出现酸、麻、沉、胀感后，应用快速捻转结合提插手法，使眼球出现热胀感。

3. 疗程：每日针刺1次，新明Ⅰ、Ⅱ穴同时针刺。单眼患病取病侧，双眼患病取双侧。10次为1疗程，疗程间休息10天。本组病例均经过1~3疗程的治疗。

本组28例38眼中。治疗后视力提高1.0及以上，或视力提高5行以上，或由0.01以下提高到0.2以上者为治愈；视力提高3行以上为显效；视力稍有提高但不显著者为进步；视力无变化者为无效。

视神经萎缩16例20眼，治愈10例12眼；显著4例4眼；进步2例4眼。中心性浆液性视网膜炎11例11眼，治愈10例10眼；显效1例1眼。视神经乳头炎1例1眼治愈；视网膜中央动脉不全栓塞1例1眼为进步。

赵秀贞 针刺新明穴治疗眼底病28例 山西中医 (6)；29，
1990

18. 视神经疾患（视神经萎缩、 球后神经炎、视网膜炎）

针 刺 法

1. 取穴：视神经萎缩取合谷、复溜、三阴交、太冲；球后视神经炎和视网膜炎取合谷、复溜、光明、太冲。

2. 手法: ①留针静止术: 针刺入后半小时左右, 适用于阴虚阳盛及阴阳两虚者; ②留针阵动术: 提针 $1/3$, 一退三进, 每隔 $3\sim 5$ 分钟轻微阵动1次, 留针半小时, 适于阳虚者; ③雀啄术: 提针 $2/3$, 上下提插, 如雀啄食, 适于阳盛属实热者。

本组采用留针静止术18例, 留针阵动术24例, 雀啄术8例。

3. 疗程: 最初每日1次, 以后间日1次, 15次为1疗程, 中间休息 $4\sim 5$ 日。一般为 $2\sim 3$ 疗程, 治疗最短21日, 最长75日, 平均38.6日。

共治疗50例, 98眼。主要以中心视力恢复为标准, 同时参考眼底改变、视力与视野的变化。视力恢复正常、视野及眼底基本恢复正常者为痊愈, 36眼。视力增加 0.3 以上者为显效; 34眼。视力增加 0.1 以上者为好转, 20眼。无论原视力如何, 治疗前后无增加或增加不到 0.1 者为无效, 8眼。

张生理 针刺治疗视神经疾患50例 陕西中医 (1); 34, 1989

19. 色 盲

针刺结合 VitB₁₂ 球后注射法

一、针刺: 主穴: 上明 (眉弓中点眶上缘下)、下睛明 (睛明穴下2分)、健明⁴ (睛明穴上5分)、增明¹ (上明穴内侧旁开2分), 增明² (上明穴外侧旁开2分)。配穴: 合谷、足三里、足光明、瞳子髎。具体操作: 每次取穴2个, 配穴1个。针刺每次通电10—15分钟 (脉冲频率为16~20次连续波, 电流量为 $0.2\sim 1.0$ 毫安)。

二、球后注射: 取维生素 B₁₂注射液100mg (1.0ml), 于双侧球后各注射0.5ml。根据治疗的进程, 效果欠佳或进展缓慢时, 药物可加量或增大浓度, 每次最大量为1 ml:500 μ g。

三、疗程: 14天为一疗程 (针刺与球后注射为隔日一次, 交替进

行)。无效或进步缓慢者，休息4~5天后再作下一疗程针刺结合VitB₁₂球后注射治疗。

共治疗1018例。我们以俞自萍氏《色盲检查图》为检查标准。全册共50个数字或图形。

若治疗结束时，能在10秒钟内准确读出每个图上的数字或图形，达47个图以上者为治愈；准确读出30~46个图者为显效；准确读出30个图以上，但较原有基础上增加者为好转；治疗结束时，未有增加者为无效。

本组1018例中，治愈425例（占41.75%），其中治疗一个疗程者50例，治疗二个疗程者99例，治疗三个疗程者276例。显效405例（占39.78%），其中治疗一个疗程者54例，治疗二个疗程者114例，治疗三个疗程者237例，好转188例（占18.47%），其中治疗一个疗程者82，治疗二个疗程者39例，治疗三个疗程者67例。在治疗中尚未发现无效者。

黄学礼等 针刺结合维生素B₁₂球后注射治疗色盲1018例疗效观察 中西医结合眼科杂志 (1)，46，1991

头 皮 针

取穴：枕上旁线，顶颞后斜线下五分之二，额中线、额旁一线交替使用。手法：用直刺快速进针法（不捻转）留针30分钟。每天扎1次针，1周为一疗程，每疗程间休息3天。

共治疗62例。对俞自萍色盲图第一组全部认出无误者为痊愈，共31例；对色盲检查图第一组图，绝大多数都可以认出，仅有1~2个字认错者为基本治愈，共11例；对色盲图第一组图较针前多认5个图以上者为显效，共12例；对色盲图第一组较针前多认3个图以上者为进步，共5例；针后无变化者为无效，共3例。

王仰文等 头皮针治疗色盲62例 陕西中医 (5)，232，1988

20. 青少年近视

针刺配静气功法

1. 取穴：第一组取承泣、头维、解溪；第二组取玉枕、攒竹、申脉；第三组取角孙、瞳子髎、中渚；第四组取风池、丝竹空、光明；第五组取目窗、阳白、行间；第六组取络却、曲差、养老；第七组取承光、眉冲、照海。

2. 刺法及疗程：①针具统一选32号1寸长毫针，施术除承泣、丝竹空、瞳子髎、申脉、照海等穴以常规刺法外，其余穴位均以针尖指向眼部刺入0.5~0.8寸，使针下有沉紧感觉，患者有酸麻胀困或向眼部放射之针感为佳。留针40分钟，留针期间不行针。②疗程：7天为1个疗程，按第一组至第七组穴的顺序，每天针刺一组穴位，七组穴轮完为1个疗程。疗程之间可以不休息。

3. 静气功的配合：在开始治疗时给患者讲述气功的练功要领，嘱其在针刺及留针过程中双目闭合，面部表情自如，双上臂自然下垂，双手放于腿面上，双下肢自然弯曲，腘窝部呈90°夹角，两足自然分开与肩同宽，全身各个部位均放松，消除杂念，配合呼吸默念“自己静”、“大脑清”或“眼睛亮”等三字句；直到将针起完时再嘱患者慢慢睁开眼睛。

共治疗163例。根据国际标准视力表检查，治疗一个疗程以上（1至3个疗程）视力提高到1.0以上者为痊愈；在原来视力的基础上提高0.3以上而且较稳定者为显效；在原来视力基础上提高0.1~0.2而且较稳定者为有效。治疗后有好转而不稳定或在1个月后视力又恢复到原来视力者为无效。

经过1~3个疗程的治疗，309只患眼的视力均有不同程度的提高，其中痊愈56只眼，占18.12%；显效171只眼，占55.33%；有效82只眼，占26.53%。总有效率达100%。

梁安西 针刺配合静气功治疗青少年近视 163例 陕西中医
(8), 373, 1988

针药结合法

治疗方药：主穴：视觉区①、四神聪、睛明。配穴：承泣、阳陵泉。均以30号毫针为针刺工具。视觉区穴以斜刺1寸为度。睛明、承泣、阳陵泉穴均直刺1寸或2寸，得气后即止。以上用中等强度刺激，平补平泻手法。四神聪穴以四根2寸长针，交叉刺入，捻转手法。

加减复明汤酊剂：熟地、山药、女贞子、白蒺藜、苍耳子各15克山萸肉18克，紫河车30克，白菊花10克，以上各药用凉水浸泡5小时后，文火煎煮30分钟，滤渣。把药液加入红白糖浓缩为酊剂。每日3次，每次服100毫升。

疗程：每日针刺1次，连刺5次，间隔1天，10天为1疗程，每次留针25~30分钟。

治疗效果：视力提高1.0以上者为痊愈，共82只眼；视力提高3行者为显效，共97只眼；视力提高2行者为好转，共45只眼；视力提高1行或无提高者为无效，共10只眼。总有效率达96%。

郑新维 针药结合治疗中学生近视眼 117例 陕西中医 (11),
514, 1989

耳压法 (一)

选取耳穴心、肝、肾、目₁、目₂、眼。以小胶布(约0.5 cm大小)把王不留行子一粒贴在上述穴位上，并嘱患者以拇指和食指在被贴压的穴位处按揉，每日按揉三次以上，每次不少于三分钟。每隔三天换另一耳贴压。贴压8次为一个疗程。

从2000例患者中随机抽出200名进行疗效统计，按病情分为重、中、轻三组。以一个疗程的前后视力提高不足0.2者为无效，提高0.2

以上,但不足0.4者为有效;提高0.4以上,但双侧视力各不达1.0者为显效;双侧视力各恢复至1.0以上者为治愈。结果重度70例、中度80例、轻度50例,治愈、显效、有效、无效分别为0、30、24、16,3、34、17、26,17、20、4、9例。总有效率74.5%。

沈新元 耳穴压子治疗青少年近视2000例近期疗效观察 江西中医药 (1); 53, 1990

耳 压 法 (二)

采用中药耳穴贴压法。我们选耳穴中眼、目①、目②、新眼点为主穴;枕、肝、肾为配穴,并根据患者全身症状,依据中医脏腑辨证的理论选加配穴。各穴通常以在该穴区获得胀、疼、麻或有传导放射感为度。中药采用具有行血通络的生王不留行。

具体方法:先将耳用75%酒精棉消毒,以圆头探针寻找穴位,将中药用胶布贴到穴位上。每天按穴3~5次,每次3~5分钟,七天换对侧耳穴,一个月为一疗程。所有病例治疗前测裸眼视力,治疗中每次换药测一视力,以了解改善的情况,视力测定以对数视力表为尺,治疗期间停用其它方法确保观察疗效。

共收治1,459例2,823只近视眼。临床治愈:视力提高到1.0以上者;

显效:视力提高3行以上者;

进步:视力提高1~2行者;

无效:视力无提高或下降者。

(有效包括上述1、2、3项)

无效为493只眼,有效2,330只眼,总有效率82.54%。

刘静 耳穴贴压法治疗青少年近视眼1,459例疗效观察 北京中医 (5); 41, 1988

针 刺 法 (一)

(一) 穴位：承泣为主穴，翳明、风池为配穴。

(二) 手法：局部消毒后，选用30号1.5寸毫针，在承泣穴进针，以30度角向睛明方向斜刺。当刺入1寸左右，眼区周围有酸胀感或流泪时，轻轻捣刺3~5次，然后留针10分钟。针刺时手法要轻，不宜大幅度捻转提插，出针后用棉球压迫局部1~2分钟，以免引起出血。翳明、风池穴，用28号1.5寸毫针刺入8分左右（不可深刺），取得针感后留针10分钟。

每日针刺1次，10次为一疗程，两个疗程中间可休息3天。一般治疗2~4个疗程。每次治疗前后，均在相同条件下进行视力检查。

共治疗1100例。治疗后视力达到1.0以上（距离视力表5米，两眼平行于1.0视标上）者为痊愈，226例。视力增加3行以上，尚未达到1.0者为显效，328例。视力增加1~2行者为好转，419例。视力无增加或增加不足1行者为无效，127例。

葛书翰等 针刺治疗近视眼1100例疗效观察 中国针灸 (1), 12, 1986

耳穴埋针法

取双侧耳部的眼穴（位于耳垂中部）。首先局部严格消毒，然后用止血钳挟紧耳针将其刺入此穴，并用小方胶布固定耳针。同时以肝肾两穴为辅，将生王不留行两粒放在胶布中心分别对准两穴位固定。然后进行按揉，使之出现酸麻胀感，随时观察病人的颜面，防止晕针的可能性。嘱患者每天自行按摩埋针贴药处，并配以按摩太阳、翳风、风池穴。按揉时嘱其患者睁开眼睛向远处观望，使远处的树木从模糊到清晰。一天坚持三次，以晨起为主。5~7天换一次，10次为一疗程，休息一周再行第二疗程。

共治疗500例。本组病例在治疗前和疗程末，均请眼科医生进行视力（远近）、眼底、验光等检查，以观察疗效。一般治疗2~6次见效，多数患者4次以上见效，亦有少数病人一疗程以上逐渐见效，见效后需再行1~2个疗程加以巩固。

500例中，痊愈（双眼视力上升到1.0以上）48例（男19例，女29例）；显效（双眼视力上升到0.6以上）146例（男49例，女97例）；有效（双眼视力上升而未达0.8）218例（男89，女129例）；无效88例（其中戴眼镜者65例）。总有效率达82%。

黄晓珍 耳穴埋针治疗青少年近视眼500例近期疗效观察 江西中医药（1）；51，1990

激光穴位照射法（一）

选两眼的睛明穴、攒竹穴与四白穴，以激光探头探穴，对准穴位，探头接触皮肤，每个穴位依次照射5分钟。

采用天津第四光学仪器厂生产的激光针灸机治疗青少年近视眼100例200只眼，经平均治疗13次，视力增进185只眼，其中恢复正常的30只眼，视力恢复率19%，有效率92.5%。

孙宝敏 激光穴位照射治疗青少年近视眼100例疗效分析 中西医结合眼科杂志（2）；117，1991

梅花针通电法

取穴：睛明、风池、承泣。操作方法：取梅花针2枚，各接FD-1A型半导体脉冲治疗仪，并通上220伏特的交流电。治疗时梅花针分别固定在双侧穴位上，3个穴位交替针刺，10分钟后更换穴位。通电电量以患者能耐受为限度，局部可见肌轻微颤动。每日1次，7次为1个疗程。1个疗程结束时作1次视力测定，一般治疗2~3个疗程。治疗期间停止看电影、电视。治疗结束后嘱坚持做眼保健操，以巩固疗效。

共治疗200例。按国际标准视力表，每1行为1级。经治疗后视力提高3级为显效，2级为有效，1级为进步，视力无提高或虽有提高未达到1级为无效。200例400只眼，经治疗后，结果：显效38眼，有效102眼，进步242眼，无效18眼。

陆碧梧 梅花针通电治疗青少年近视200例 浙江中医杂志 (6); 273, 1989

激光穴位照射法 (二)

1. 主穴：睛明、承泣、瞳子髎；配穴：球后，鱼腰。每次选主配穴各1组。

2. 操作方法：选用功率3毫瓦、波长6328埃氦氖激光针灸仪，用指掐法寻取治疗穴位，然后用光针照射，紧贴皮肤聚光 0.2cm^2 范围内，每次10分钟，使光束聚合于眼底（目系）。

每天1次，10天为1个疗程。

共治疗170例，300眼。视力达1.0以上者为痊愈，视力增加3行以上者为显效；视力增加1—2行者为进步；视力增加不足1行或无增加者为无效。

本组300只眼中，痊愈32只，显效125只，进步112只，无效31只，总有效率89.67%。

晏克勇等 激光穴位照射治疗近视170例 陕西中医 (1); 37, 1991

腕踝针法

选用上①点，上②点在小指侧的尺骨缘前方，用拇指端按压凹陷处。双眼近视选双侧，单眼近视选患侧。按常规操作法，进针一般应不痛，如痛应将针退至皮下表浅部位，再重新进针。留针1小时，留针时嘱患者向远处眺望。每日针1次，10次为一疗程，间隔5天后可行第二疗程，一般治疗2~3疗程。

共治疗151例。经治疗后视力达到1.0以上者为痊愈；视力增加3级（按国际标准视力表每一行为一级，下同）以上，但未达到1.0者为显效；视力增加1至2级者为进步；视力无增加或未达到一级者为无效。

痊愈17只眼，占5.7%；显效97只眼，占32.4%；进步139只眼，占46.5%；无效46只眼，占15.4%。

汪洋 腕踝针治疗近视眼151例 上海针灸杂志 (4); 11, 1987

耳 夹 法

用20号不锈钢丝加工成有弹性的“8”状夹子，尖端打磨光滑，浸泡在加防锈剂的1%新洁尔灭或75%酒精溶液中备用。取主穴：肝、新眼、目₁、目₂、眼。配穴：肾、心、脾、胰胆、神门、交感等，个别伴发其他眼疾者，加用相应穴位。治疗时，先用酒精棉球擦拭耳廓进行消毒，再选准耳廓正面穴位用消毒好的夹子钳夹。每次夹10分钟，10次为1疗程，治疗2次查1次视力并记入病历。操作时手法要轻柔，对外耳皮肤破损或有感染灶者忌用，如个别患者出现虚脱现象，应立即去除耳夹，令其平卧，取头低脚高位，必要时可针刺人中穴，一般愈后良好。

共治疗129例，251眼。痊愈：视力提高到1.0以上；显效：视力提高3行以上，但不足1.0者；进步：视力提高1~2行；无效：视力无改变。

本组患者经6次以上不同疗程的治疗，251只眼中，痊愈25只（9.96%），显效53只（21.11%），进步144只（57.37%），无效29只（11.55%），总有效率88.44%，显效率以上达31.07%。

吴俊华 耳夹治疗近视眼129例 陕西中医 (5); 227, 1990

针 刺 法 (二)

(一) 取穴和针刺：光明配外关，太冲配合谷。两组穴位交替针

刺。治疗时均以手法运针，平补平泻。进针得气后，以小幅度捻转，震颤激发和保持感传。感传显著程度分为五级：Ⅰ级，感传上述面部；Ⅱ级，感传超过相应经脉全程的一半，但未达面部；Ⅲ级，感传不及相应经脉全程的一半；Ⅳ级，无感传；Ⅴ级，针感向离中方向传导。

(二) 疗程：15天为一疗程，共两个疗程。两个疗程之间休息一周。

共治疗100例。根据国际标准视力表检查的结果分为四级。显效：视力提高0.5以上；有效：视力提高0.3~0.4；进步：视力提高0.1~0.2；无效：治疗前后视力不变或下降0.1~0.2。

经过两个疗程的治疗，182只患眼中有157只视力有不同程度的提高，有效率为86.3%。其中42只眼视力恢复正常（1.0以上），占23.1%。

杨碧英等 激发循经感传治疗青少年近视眼100例的疗效观察
中国针灸 (1)，14，1986

鬃针体针法

(一) 鬃针

1. 制作鬃针的方法：①按照患者个体泪点大小来选取粗细不同的猪鬃，然后用剪刀把猪鬃的两端剪掉，用手指把两端头整圆。②猪鬃针身长最好1.5~2寸。③猪鬃针做好后，先用洗衣粉和开水清洗一遍，再用清水洗净，经高压消毒，最后用75%酒精浸泡3小时即可使用。

2. 取穴：眼角双内侧上下共4个泪点。

3. 针刺方法：首先直刺，把鬃针扎到泪点内，再以45度角慢慢进针，扎到泪小管后（一般进针深度0.8~1.5cm），轻轻左右捻转鬃针，眼内自觉酸、胀、麻感。行针2分钟。扎针完毕让患者闭眼，休息10~15分钟。每日针刺1次，10次为一疗程。

二、体针

疗程结束时疗效情况

分 组	眼 数	恢复正常	显 效	有 效		无 效
髻 针	200	96(48%)	84(42%)	20(10%)	200(100%)	
体 针	200	46(23%)	60(30%)	70(35%)	176(88%)	24(12%)

经统计学处理两组近期总有效率相比较差异显著 ($P < 0.01$)。

1. 取穴：①攒竹、四白、合谷、太冲，②瞳子髎、养老、光明、照海。

2. 方法：每日1次，两组穴位交替进行，10次为一疗程，采取平补平泻法。进行第二疗程时，中间休息4天。

视力增加4级左右（按国际标准视力表每行为一级），视力达到1.0以上者为恢复正常；视力增加3级左右，达到0.6~0.9者为显效；视力增加1~2级，达到0.2~0.5者为进步。经针刺，视力仍在原近视基础上者为无效。

朱跃华 髻针治疗青少年近视眼100例 山西中医(3), 35, 1991

针刺微电法

主穴：承泣、下睛明；配穴：养老、合谷。进针1.5寸，手法得气后，再用EDE-1经络近视治疗仪以按需电流量分别刺激上述穴位。留针15分钟，拔针后按压眼部穴位片刻，每天治疗1次，10天为1疗程。

凡经本法治疗1疗程以上，停止治疗已有1年者。按原治疗卡编号顺序随机化取100例作为此次观察对象。共200只眼，其中男性38例，女性62例。

采用“国际标准视力表”。用单盲法作视力检查（检查者不知道被检查者的原视力）。

显效：停止治疗1~3年后，视力仍高于治前5行以上者，1年42眼，3年12眼。

有效：停止治疗1~3年后，视力仍高于治前2行以上者。1年

97眼，3年37眼。

无效：停止治疗1~3年后，视力高于治前1行或与治前视力相同者，1年61眼，3年151眼。

姚善业等 针刺微电法治疗近视眼100例远期疗效观察 上海针灸杂志 (2); 25, 1987

21. 假性近视

头 皮 针 法

取穴：枕上旁线（位于头枕部，枕上正中线外开半寸之双侧平行线上）。凡双眼近视者针双侧，单眼近视者针对侧枕上旁线。方法：常规消毒，用28号1.5寸毫针进针1.0~1.4寸，接着用“抽气法”运针，即用暴发力，迅速而有力地将针柄抽提1~3分，而针体则基本不动。待得气后留针1~2小时。每日1次，10日为1个疗程，疗程间隔3~5日。

共治疗200例，382眼。本组经上法治疗3个疗程后，60例显效（视力提高0.3以上），其中20例基本治愈（视力达到1.0以上），125例有效（视力上升0.1~0.2），无效15例。总有效率为92.5%。按眼球统计，382只眼中显效109只（其中基本治愈37只），有效245只，无效28只，总有效率92.7%。所有病例在治疗过程中均无不良反应。

刘方土 头皮针治疗假性近视200例 浙江中医杂志 (7); 301, 1990

22. 屈光不正

激 光 法

采用 JGE-3A, He-Ne 双路激光针灸仪，激光波长 632.8 μ m，光

纤输出功率 $\geq 1.5\text{mW}$, 消耗功率 $\leq 60\text{W}$ 。方法: 将双路光纤针头对准双眼睛明穴, 照射15分钟。

共治疗120例。以视力提高与否为依据, 屈光度作参考。分: 治愈: 视力达1.0以上; 显效: 视力增加3行以上。进步: 视力增加1-3行。无效: 视力无进步或减退。

每日照射1次, 以半个月为一疗程。可间隔3天, 继续第二、三疗程、至2个月停止进行, 做好小结。

近视160眼, 痊愈16眼, 显效42眼, 进步92眼, 总有效率94%。远视8眼, 显效2眼, 进步4眼, 总有效率75%。弱视32眼, 痊愈6眼, 显效10眼, 进步15眼, 总有效率96%。以上三种眼病的疗效比较, 经统计学处理, 相差不显著, p 值 >0.05 。

赵惠英 He-Ne 激光治疗屈光不正 中西医结合眼科杂志 (1), 49, 1991

23. 眼外直肌麻痹

针 刺 法

选用: 球后、外直肌、睛明为主穴, 承泣、鱼尾腰、太阳、瞳子髎、风池、合谷为配穴。每次针刺主穴1-2个, 配穴2-3个, 针刺眼区穴深1-1.5寸, 要求达到酸、麻、胀感, 针风池、合谷等穴则根据病情施以捻转补泻手法。针刺每日1次, 以10次为1疗程, 休息2-3天后继续第2疗程。

共治疗100例。痊愈(眼肌运动恢复正常, 各方向复视消失, 同视机检查结果正常)45例, 显效(眼肌运动恢复正常, 但周边视野尚存在复视, 同视机检查有相应进步)37例, 进步(眼肌运动部分恢复, 主要视野尚有复视, 同视机检查显示斜度减少)9例, 无效9例, 总有效率91%。

夏淑珍等 针刺治疗眼外直肌麻痹100例 中西医结合眼科杂志

24. 麻痹性斜视

针 刺 法 (一)

以眼区穴为主。攒竹穴，球后穴，下睛明穴，太阳穴配合风池穴，膻中穴，足三里穴等。

针刺治疗麻痹性斜视62例，其中痊愈35例，好转16例，无效11例，有效率为82%。

田培芬 针刺治疗麻痹性斜视 中西医结合眼科杂志 (2), 80, 1991

针 刺 法 (二)

取穴：四白、合谷为主。配用攒竹、丝竹空、瞳子髎、颞颥、风池、足三里、光明、肝俞、脾俞、胃俞、肾俞。用平补平泻法，得气后留针30分钟，每10分钟施刮柄法30秒，以加强针感。

共治疗29例。痊愈：指一切自觉症状，视物正常，客观体征（眼球运动自如）消失；有效：指自觉症状消失、客观体征较前改善，尚未完全好转；无效：指自觉症状及客观体征经治疗无变化。本组痊愈12例，占41.3%；有效13例，占44.9%，总有效率为86.2%；仅有4例经2~6个月治疗仍无效，占13.8%。

杨元德 麻痹性斜视的针刺治疗 辽宁中医杂志 (5), 37, 1988

割治针刺法

割治：于患者上、下大白齿间粘膜上，以三棱针划破粘膜出血，

隔日1次。

针刺：外直肌麻痹（内斜视）取瞳子髕，将眼球向内推移，沿眶内壁缓慢直刺0.5~1寸；内直肌麻痹（内斜视）取内睛明，将眼球向外推移，缓刺0.5~1寸；刺攒竹向睛明方向0.3~0.5寸，每次取1~2次，配合谷，均留针15分钟，隔日1次，10次为1疗程。

共治疗7例。治愈：眼球运动正常，无复视，病眼与正常眼视轴相同，无偏斜状态，一个疗程治愈3例，二个疗程治愈3例，四个疗程治愈1例，7例全部治愈。

李平钊等 割治针刺治疗麻痹性斜视 辽宁中医杂志 (6), 40, 1991

刺 眼 法

患者仰卧或坐位均可，在其上眼睑中央，取眼眶的骨边缘，针刺入内，在眼球和眼眶之间，深达30~40mm。得气时眼球和前头部有胀、酸、麻、重感，即轻轻捻针，不留针。拔针后用消毒棉球压迫止血，每日1次。配穴用合谷、曲池，及内关透外关，每日轮换1穴。10次为1疗程，休息2~3日，继续第2疗程。

治疗结果 21例21眼（男12例，女9例），治疗3、4、5、6次者各1例，10次者6例，15次者1例，20次者4例，30次者2例，40次者3例，未统计次数者1例。治疗后15眼眼肌运动完全恢复，复视消失。5眼眼肌运动接近正常，但有轻微复视。1眼眼肌运动改善，复视减轻。1例无效。所有病例均经1~7年随访，除无效者外，均未见复发。

齐锡淼 针刺治疗眼麻痹性内斜症21例 浙江中医杂志 (8), 375, 1990

25. 先天性内外斜视

核桃皮灸法

采用白菊花40克，新核桃皮壳4对，将两者装入500毫升大口玻璃瓶内，再倒入500毫升温开水，盖好瓶口放置阴凉处，24小时后备用。另选用空眼镜架一副，并镜架的两侧接上小铁丝，以便艾灸时使用。

治疗时，取出核桃皮壳扣在患眼的空镜架上，用0.5~1.0寸长艾条扞至患眼镜架上的小铁丝上灸治。每日一次，每次灸15~20分钟，7天为一疗程。

病情严重者，配合体针治疗。内斜视者，取瞳子髎、四白、太阳、丝竹空、鱼腰、合谷；外斜视者，取睛明、眉冲、攒竹、下睛明、鱼腰、合谷。

1. 疗效标准：双外眼前节正常，角膜瞳孔正常，双眼平视时正位者为痊愈。双外眼前节基本正常，双眼平视时基本正位者为显效。

2. 全部病例治疗前后，都经过本院与外院眼科检查，并摄像观察疗效。6例患者痊愈5例，显效1例，治疗最短次数为5次，最长次数为23次。

贾秀卿 核桃皮灸治疗先天性内外斜视6例 中国针灸 (2); 44, 1986

26. 共转性内斜视

激 光 法

采用国产 He-Ne 激光仪，输出功率1.5mv，波长632.8μm，激

光束直照斜视穴 I 与 II，每天 1—2 次，每天 5—10 分钟，十天为一疗程。

共治疗 100 例。治愈（视力、斜视度恢复正常）29 例，占 29%；显效（视力上升五行以上，斜视度减少 5—10 度）36 例，占 36%；有效（视力上升二至四行，斜视度减少 5 度以内）31 例，占 31%；无效（视力上升一行，斜视度无变化）4 例，占 4%；总有效率达 96%。

马江林 He—Ne 激光治疗共转性内斜视 100 例 中西医结合眼科杂志 (1); 48, 1991

27. 癍病性弱视

针 刺 法

取穴：睛明、太阳、合谷、人中、视区。

视区位置：在枕外粗隆水平线上、前后正中线各旁开 1 cm，向上垂直线长约 4 个 cm 处。

方法：上穴每次取 1—2 个。进针得气后均用小幅度捻转重刺激，留针 20 分钟，每隔 5 分钟在施用手法的同时要让患者看目力表。大部分患者经 1 次治疗，可获得满意效果。

共治疗 18 例。由黑蒙、光感、手动、数指提高 1.0 以上者 19 只眼占 52.8%。视力由黑蒙、光感、手动、数指提高 0.1—0.9 者 17 只眼占 47.2%。患者通过针刺治疗后均达到有效视力。

夏淑珍等 针刺治疗癍病性弱视 18 例的临床观察 天津中医 (1); 17, 1986

28. 电光性眼炎

针 刺 法

取病眼侧太阳穴，直刺 5—7 分，用捻转泻法，使针感向眼部扩

散后稍停，即出针，并要挤出血少许。刺攒竹穴针尖向下以45°角刺入2~3分，使针感向目眦扩散，稍停便可出针。挤出血少许。取病眼侧内迎香，可用三棱针轻轻点刺，放血数滴。每日针1次。

共治疗52例。经治疗1~2天症状消失者为痊愈。治疗3~4天诸症消失者为有效。治疗超过4天为无效。

经治疗痊愈49例（其中针1次者40例、针两次者9例），有效3例。总有效率为100%。

韩国瑞 针刺治疗电光性眼炎52例 中国针灸（3）；27，1986

针 刺 法

取穴：1.丝竹空：向太阳穴方向沿皮刺五分。2.阳白：向鱼腰穴方向沿皮刺五分。3.攒竹：向睛明穴方向沿皮刺五分，均行平补平泻手法。

方法：针刺前先嘱患者将眼闭住，然后再进行针刺，一般留针30分钟，在留针期间每隔10分钟行针一次。起针后患者自觉症状感到明显减轻，多数患者几小时后症状完全消失。

薛 浩 针刺治疗电光性眼炎50例 中国针灸（1）；28，1987

29. 外伤性瞳孔散大

针 刺 法

处方：风池，睛明，太阳，鱼腰，光明。

方法：采取半卧位，先刺主穴风池穴，针尖向健侧眼球方向刺1—2寸，“气致病所”，针感到眼部。针刺鱼腰穴时，针尖对准眶上孔，可刺3—5分。刺睛明穴，令病人闭眼，左手拇指切于目内眦角，右手持针直刺5—8分（不捻转）。太阳穴直刺1—1.2寸，太阳穴也可放血刺；刺健侧光明穴1—2寸。

共治疗20例。11例痊愈，4例好转，3例治疗中断，2例无效。
李坤元 针刺治疗外伤性瞳孔散大20例 内蒙古中医药 (2),
39, 1989

第二节 鼻科疾病

1. 鼻 衄

耳 压 法

选穴分二组：①固定耳穴：“内鼻”“外鼻”。②辨证选穴，主要依据出血的颜色、血量及舌脉和伴随症选用：如鼻衄血鲜红，量多，伴急躁易怒，脉弦数者取肝，肝阳1、2；如鼻衄量少，伴鼻腔内干燥，咳嗽少痰者取肺等。

方法：耳俞穴以75%乙醇棉球拭之。用小镊子持一粒王不留行籽，选粘在约0.7cm²的绊创膏上，再准确地贴到所取的耳穴上，并予以按压。按压时以局部有痛胀感，并感觉胀痛感向鼻腔传导为佳。嘱患者每日按压5~10次，每次3~5分钟，隔日更换一次。三次为一疗程，每一疗程间隔一日，一般贴三个疗程。疗程根据病程长短而定。

共治疗128例。痊愈（一年以上未见鼻出血者）125例；好转（一年内，半年以上未见鼻出血者）3例。有效率100%。

汪绍兴等 辨证贴耳穴治疗鼻衄128例 湖北中医杂志 (6),
15, 1989

火 柴 灸 法

用火柴一支，在磷片上划燃后对准少商穴迅速点灸，手法轻，瞬

时离穴，听到“啪”的响声即可，灸后局部米粒大斑痕（一般不需处理）。再以相同方法点灸身柱。

治疗鼻衄发作无度者84例，每日1次，经治3次，除8例无效外，66例血止，10例出血减少。

王玉顺等 火柴灸治疗鼻衄84例 浙江中医杂志 (8), 375, 1990

2. 过敏性鼻炎

指 针 法

主穴为鼻通——合谷，迎香——少商。二组穴隔日交替进行。操作方法：患者取仰卧位，身体自然放松，医者位于患者身侧，用一手拇指偏峰切之穴位。先取面部穴，然后取手上穴位，每穴施术三分钟左右，使局部有酸麻胀感为得气。先轻切之，逐渐加压，操作过程中适当加指颤动作，最后逐渐减压结束治疗。每日指针一次，十五次为一个疗程。

穴位加减：伴有前额头痛者加阳白、攒竹、上星、百会等。目眶痛者加鱼腰、睛明、印堂。偏头痛者加太阳、头维、率谷等。流黄涕者加风池、曲池等效果更佳。

共治疗500例。痊愈：诸症悉除。显效：诸症明显好转。有效：时有鼻腔发痒，喷嚏消除，清涕量少，头痛减轻，嗅觉改善，镜检鼻腔粘膜微肿。无效：经治疗无好转。

500例患者，痊愈352例，占70.4%，显效104例，占20.8%，好转35例，占7%，无效9例，占1.8%。病程最短二个月，最长五年；治疗效果与病程长短关系不大，而与经络感传效果成正比。

杨桂芳等 指针治疗过敏性鼻炎500例疗效分析 中医药学报 (3), 33, 1988

耳 压 法 (一)

(一) 操作方法:

1. 先将生王不留行籽冲洗干净, 并用75%酒精浸泡30分钟, 晾干后使用。

2. 常规消毒耳部, 用 $0.5 \times 0.5\text{cm}$ 大小的胶布中间粘一粒王不留行籽, 按压在穴位上并施手法, 医生按压穴位至耳部发热或麻胀感或疼痛为得气标准, 每穴留置3天, 每日须让患者自行按压穴位3~5次, 两耳交替, 6次为一疗程。

(二) 取穴

取内鼻、气管、肺为主穴, 配以肾上腺穴, 随症加减穴位如: 头疼加脑点、皮质下, 再根据其疼痛部位择取: 太阳、颧、枕、顶, 伴有咳喘者加平喘穴、神门穴。便秘者加大肠、直肠下段。

共治疗100例。症状完全消失者为显效, 症状明显减轻或在治疗过程中仍有复发者为好转, 症状无改善者为无效。

在100例中有效率占95%, 其中显效占85%, 好转率占10%, 无效率占5%。

乔玉珍 耳压治疗过敏性鼻炎100例临床观察 天津中医 (6), 18, 1987

耳穴压药法

先在耳廓处用取穴仪探找出“肺”、“鼻”“交感”穴位敏感点, 把胶布剪成 $0.6 \times 0.7\text{cm}$ 左右长方块(用麝香虎骨膏效更佳), 在其上方放入王不留行籽2~3粒, 压入上述穴位, 两耳同压(如无耳穴仪, 也可直接把药压入上述穴位), 压后每天在上述穴位处按压2~3次, 每次10~20分钟, 一般4~5天更换一次, 天热可3~4天更换一次(因天热胶布易掉)。对于年龄大、病史久者可加用“肾”“额”穴位, 年青人必要时加用“大肠穴”。在治疗期间可不用任何

药物及滴鼻药水。

共治疗62例。根据患者主观评定，治疗3次为标准。痊愈：经治疗打喷嚏、流清涕、鼻痒均消失。有效：经治疗打喷嚏，流清涕，鼻痒症状明显好转。无效：经治疗症状改善不明显。

52例中痊愈13例，好转30例，无效9例，好转痊愈率82.6%。治疗最短1次，疗效最好的当天即见效。

杨金发等 过敏性鼻炎耳穴压药52例报导 浙江中医学院学报 (4)，19，1989

耳 压 法 (二)

取耳穴：内鼻、外鼻、肺、肾上腺。将各穴点用75%酒精消毒，取消毒后的王不留行籽置 $0.8 \times 0.8 \text{cm}^2$ 的胶布中间，贴于穴位上，双耳均贴，按压药籽，使耳部产生胀、重、疼的感觉。每日让患者自己压按3次以上，力度要适中，每次按压30余次，5天换药1次，休息2~3天，再行第2次压药，4次为1疗程。

50例经治后，26例临床控制（鼻痒、喷嚏、鼻流清涕均消失），20例显效（上述症状明显减轻），3例有效（上述症状减轻），1例无效。

吕云钊等 耳压治疗过敏性鼻炎50例 中西医结合杂志 (9)，548，1990

针 刺 法

取穴：百会，上星，印堂，素髻，迎香，曲池，合谷，足三里，内庭，兼有眼赤痒时加攒竹，丝竹空，四白。手法：针刺得气后，平补平泻，留针20分钟，隔日针一次。

共治疗33例。1. 临床基本治愈：临床症状基本消失。2. 有效：2/3以上的症状明显好转或消失。3. 无效：治疗前后无变化。

临床近期疗效：临床基本治愈13例，占39.39%，有效16例，占

48.48%，无效4例，占12.12%，占有效率占87.87%。其中治疗次数最少3次，最多10次，绝大多数为10次左右。

李传杰等 针刺治疗过敏性鼻炎33例 中国针灸 (3); 29, 1987

针 灸 法

1. 针刺取穴，印堂（眉头连线中点处）、鼻通双（鼻唇沟上端尽头处）。针刺鼻通穴针具选用1寸30毫针。操作：右手持针对准鼻通穴，刺入2分左右，针尖向上朝向印堂穴沿皮下斜透刺，针感鼻腔发胀为宜。针刺印堂穴针具选用1寸30毫针。操作：1. 用提捏进针法，即左手拇、食二指将患者印堂的皮肤捏起，右手持针对印堂穴，刺入2分，得气后针尖向下沿皮下慢慢刺约1寸，用捻转、提插补法，使针感内及鼻腔，留针20分钟。2. 艾灸百会穴，采用雀啄灸，艾条燃着一端，与施灸穴位并不固定一定的距离，而是对准百会穴象鸡啄食一样，一上一下地移动。一般施灸15~20分钟左右为1次，1天可灸2次。针刺每日1次，针刺和艾条10天为1疗程。

共治疗30例。治愈：临床症状消失，1年以上不复发者；显效：临床症状基本消失，偶尔受致敏原刺激，有轻微鼻塞或流少许清涕，但短时自愈；进步：气候变化或其它因素刺激，复发次数减少，症状减轻，并较快控制；无效：针刺和艾灸一疗程不见效果者为无效。

治愈13例，显效11例，进步5例，无效1例，总有效率达96.7%。

包兆贵 针灸治疗过敏性鼻炎30例 陕西中医 (5); 228, 1990

3. 鼻 炎

冷 灸 法

1. 药物组成：斑蝥一味（南方大斑蝥或黄黑小斑蝥均可），生

用，去足翅，研细末，瓶贮备用。

2. 外贴部位：印堂穴。

3. 使用方法：斑蝥粉适量，以水、醋或蜂蜜调为糊状（不宜太稀，以免流溢他处）。印堂穴擦洗干净，病人取仰坐或仰卧位。胶布一小块，中间剪一黄豆粒大小的孔，先贴于印堂穴处，然后将药直接涂于小孔之内，外以胶布贴盖。24小时后去掉。一次不愈者，1周后重复使用。

4. 注意事项：斑蝥为剧毒药品，有强烈的发赤、发泡作用，外贴面积不宜过大，尤其注意不要让药物误入眼内或口中，以免发生意外。

5. 发泡后的处理：斑蝥冷灸一般均会引起皮肤局部不同程度的发红起泡，水泡局限于表皮，不侵入深层，除短期色素沉着外，不遗留疤痕，而且停药后色素沉着也会逐渐自行消失。水泡较小者用75%的酒精棉球经压片刻，促使其尽快吸收；较大者以消毒针头或毫针穿破，放出水液，涂以2%龙胆紫或红霉素眼药膏，外用消毒纱布复盖，以防感染。

共治疗670例。痊愈：鼻塞流涕、头痛脑胀、嗅觉不灵等自觉症状消失，临床检查无异常发现，1年内未见复发者。

显效：自觉症状明显减轻，临床检查较前好转，或愈后1年内又有复发者。

无效：经3次以上治疗，自觉症状无改善，临床检查亦无进步者。

过敏性鼻炎205例：痊愈172例，显效27例，无效6例，有效率97.1%；单纯性鼻炎314例：痊愈274例，显效32例，无效8例，有效率97.5%；慢性副鼻窦炎43例：痊愈18例，显效13例，无效12例，有效率72.1%；慢性鼻炎108例：痊愈63例，显效28例，无效17例，有效率84.3%。

如上所述，本法对单纯性鼻炎、过敏性鼻炎疗效较佳，有效率可达97%以上；对慢性鼻炎、慢性副鼻窦炎则次之。冷灸次数最少者1次，最多者7次，平均3次。

叶长青等 斑蝥冷灸治疗鼻炎 670 例 上海中医药杂志 (2),
17, 1990

第三节 咽喉科疾病

1. 急性扁桃体炎

针 刺 法 (一)

双颊车、双合谷、双曲池，强刺激不留针，每日 1～2 次。

共治疗 220 例。体温恢复正常为 1～5 天，平均 1.95 天；咽痛消失时间为 1～7 天，平均 3.22 天，白细胞降至正常 1～3 天 39 例，4～6 天 9 例，7 天以上 2 例（共 50 例）。

扁桃体假膜消失时间为 1～5 天，平均 2.8 天（100 例）。

陈仁华 针刺治疗急性扁桃体炎 220 例 中国针灸 (3); 54,
1987

针 刺 法 (二)

取穴手三里（双侧扁桃体炎针双手三里、单侧扁桃体炎针患侧手三里）。手法：用透天凉手法，或平补平泻手法，针感传至咽颊部效果最好。

共治疗 50 例。针 1 次而愈者 23 例，针 2 次而愈者 14 例，针三次而愈者 10 例，无效者 3 例。一般进针捻转片刻疼痛即止。

冯纯礼 针刺治疗急性扁桃体炎 50 例 中国针灸 (3); 6, 1987

针刺按摩法

主穴：扁桃穴、鱼际穴。

加减：发热者加大椎、曲池、合谷，针刺用泻法；阴虚者加补太溪。

操作：“扁桃穴”为经外奇穴，位于下颌骨内下缘，颈动脉前方处，在解剖位置上靠近扁桃体。主治扁桃体炎。临证一般不针刺，以免误伤颈动脉。笔者常两手中指同时抵住扁桃穴，按摩1~2分钟，使患处有酸胀感。然后以常规针法泻双侧鱼际穴。临床观察，大多咽痛即止，异物感消失。

共治疗99例。66例不发热者，经治1~2次而愈者41例，3~4次而愈者25例；33例发热者，经治2次而愈者24例；另有9例，经治4次，病情缓解又反复，后加用抗菌素而获愈。

李明高 针刺按摩治疗扁桃体炎99例的临床体会 江苏中医(3)，13，1989

2. 扁桃体摘除术后咽痛

针 刺 法

患者取正坐位，使颈部充分暴露，体质差者及小孩嘱助手扶着患者头部，针刺部位行常规消毒，找准穴位后，先在双天柱穴（发际上2cm，斜方肌外缘）进针1~1.5cm，然后在双侧扁桃体穴（下颌角下方，颈动脉前，翳风穴下一寸）向扁桃体方向刺入2~3cm，咽部感清凉、酸胀即达针感，一般采用中等刺激量，每次留针15分钟左右，每5分钟行刺一次，取针后在双侧少商穴用三棱针挑刺放血1~1.5ml，患者多即感咽部疼痛减轻，有清凉感，吞咽方便，针刺在进食前进行，第一次在术后4小时，每日三次，连续3天，患者即吞咽自

如。如有高热，可加刺合谷、内庭穴。

共治疗33例。全部病例，均见效果，术后四小时可饮流汁，流涎减少，且口腔分泌物较少，第二天可进半流质，第三天可进软食，无流涎，可进行正常会话，四小时查扁桃体窝可见点状白膜生长。10小时呈网状，24小时后即长出均匀片状白膜，全部病例，如无发热，未加任何药物，6~7天后假膜脱落痊愈出院。

王 启等 针刺治疗扁桃体摘除术后咽痛33例初步体会 江西中医药 (3); 42, 1990

3. 咽喉肿痛

放 血 法

取粗三棱针一根绑在竹筷上，放75%酒精中浸泡备用。嘱患者用复方硼砂溶液漱口，医者用压舌板压住患者舌头，用消毒好的三棱针以稳、准、轻、快手法点刺一侧舌腭弓充血明显处三下，男左女右，再点刺悬雍垂正上方充血明显处一下。如果扁桃体呈Ⅱ°、Ⅲ°肿大，或已化脓，可在扁桃体上各点刺一下，令患者吐出口中血液，再用复方硼砂溶液漱口，无论有效与否，只治疗一次。针前应向患者说明情况，使其消除恐惧心理。

注意事项 点刺不能靠近舌腭弓边缘，因点刺舌腭弓边缘有时会出现声音嘶哑。如果出现了这种情况无需特殊处理，停止治疗后15天左右可自行消失。

共治疗152例。治愈为临床症状和体征完全消失，随访2个月无复发。显效为临床症状和体征基本消失或显著减轻。无效为临床症状和体征治疗前后对比无明显改善。结果：治愈119例，占78.3%；好转25例，占16.4%；无效8例，占5.3%；总有效率为94.7%。平均治愈以间为1.2天。

靳新领 放血治疗咽喉肿痛152例 国医论坛 (1); 34, 1991

4. 咽异感症

点刺放血法

点刺法：患者张口，医生对好光线，左手持压舌板抵舌，右手拿针似握笔状向咽后壁正中深处快速刺五~七下，（尽量往下）。隔一分钟左右，再重复一次。令患者吐去恶血。每日或隔日一次，七次为一疗程。点刺手法宜快速、轻捷，针刺点不可过散，深浅适度，过深易留咽痛，过浅则血不出而效不显，一般约2~3mm即可。运针时还要左右活动进退，切勿伤及会厌及左右两侧。刺后创面喷以市售西瓜霜喷剂（桂林中药厂产），以防感染。针用银器制成，不宜太利，长5cm左右，后用竹杆固定。内治法：可根据辨证施治。本人多用半夏厚朴汤合四逆散加减，妇人脏躁者以甘麦大枣汤加味。

共治疗180例。显效（咽异物感消失，慢性咽炎咽部检查恢复正常或明显减轻）93例；有效（咽异物感减轻，慢性咽炎咽部检查仍有异常）64例；无效（治疗两个疗程，症状无明显减轻）23例。总有效率为88%。本组疗程最短针刺2次，最长两个疗程。

周景伟 咽后壁点刺放血为主治疗咽异感症180例 上海中医药杂志（9），27，1989

5. 口 舌 痛

针 刺 法

自然握拳，手背四五指缝尖上方约0.5厘米处，避开可见浅静脉，用毫针顺掌骨间隙刺入0.5~1寸。左右捻转数次，以得气为度。一般先刺患侧即效，15分钟后效差者加刺对侧。留针20~30分钟，每15分钟运针一次。

共治疗64例。以首次针刺判断疗效。症状完全消失25，基本消失13例，减轻22例，无效4例。

申 健 针刺液门穴治疗口舌痛64例 湖北中医杂志 (2); 34, 1988

6. 声带肥厚

针 刺 法

取穴：人迎、水突。

50例声带肥厚患者是职业性用嗓演员。

共治疗50例。施术时，患者取正坐位，避开颈动脉搏动处，以特小号毫针，采取雀啄进针法。进针后的捻转补泻的幅度要求轻柔而细小，刺激量约为其它穴位的刺激量的1~5/10。留针15~30分钟。每天一次。7天为一疗程（针6天、停一天）。

皮 健 针刺人迎、水突穴治疗歌者声带肥厚50例的疗效观察 中国针灸 (3); 17, 1987

7. 声带疾患

针 刺 法

主穴取双侧人迎、水突。辨证配穴如下：风寒感冒，音哑不扬或声带小结者，加针合谷，用泻法，以疏风解表，宣通肺气，化痰散结。痰湿内阻者配鱼际、丰隆，用泻法，以清肺开音，泄热化痰。食辛辣、油炸之品，热积肺胃，上攻咽喉肿痛者，可在少商穴点刺出血，以清热泻火。声哑重者加廉泉以开音。

操作方法：针刺人迎、水突穴时，患者取坐位，头略后仰，使用

1寸毫针，采用雀啄法或弹入式进针法，斜向喉结刺入0.5~0.8寸，中度捻转，平补平泻，局部感觉有鱼骨卡喉的胀感及异物感，感觉传至喉者疗效最佳。留针20分钟至半小时，间歇行针2~3次。也可用电针，留针15分钟，每日一次，5次为一疗程。

74例经治疗后自觉症状消失，功能恢复，声带病变消退，显示声音正常，评为治愈者69例（93.2%）。声带病变有明显的消退，自觉症状明显好转，评为显效者3例（4%）。声带病变有所消退，自觉症状有所改善，评为好转者1例（1.4%）。声带病变无改变1例（1.4%）。

陈 静 针刺治疗声带疾患74例疗效观察 中医杂志（5），47，1987

8. 功能性失音

针 刺 法 （一）

针刺组115例，采用单穴天突33例，合谷10例，廉泉8例。用双穴合谷、天突46例，廉泉、天突15例，合谷、廉泉3例。手法用强刺激（泻法），当病人局部发闷或深刺入气管引起响亮咳嗽则发音迅速恢复。

共治疗115例。经1次针刺完全恢复正常110例，其他1例经多次针刺基本恢复，2例电针治愈，2例改电感应治愈。随访2~17年，12例复发，均经针刺1次而愈。

孙启静 针刺治疗功能性失音115例 上海针灸杂志（4），9，1987

针刺暗示法

1. 暗示治疗：暗示性强是癔病病人的特点。医务人员以简单有力，充满信心的话对病人进行鼓励和保证，就是最简单易行的言语暗示，也可用物理刺激或药物配合。

2. 针刺：主要以环甲膜直刺入声门下，强刺，必将剧咳得音，不取针并鼓励患者大声说话，咳嗽，对话，询问病史，了解患者心理状况，强刺2—5分钟后，说话自如，声调宏亮，即取针，并鼓励患者继续大声说话，至病愈。

患者取端坐位头稍后仰，医生中指触及甲状软骨切迹中点，中指与食指平行向下触及陷点，即为环甲膜，用1.5~2寸针斜30°向上进针直达声门下。

共治疗9例，全部治愈。

高步生 针刺环甲膜配合语言暗示治疗功能性失音 陕西中医 (6); 272, 1987

针 刺 法 (二)

取穴：少商、内关。

共治82例，经过2~6次治疗，75例语言恢复，4例好转，3例无效。

王全仁 针刺治疗失音82例 浙江中医杂志 (6); 276, 1989

9. 软 腭 麻 痹

电 针 法

取双侧增音穴（喉结与下颌骨连线的中点）。采用1寸长28号毫针，患者坐在靠椅上，头微向后仰。穴位常规消毒后，针尖斜向内侧缓慢进针，注意避开动脉血管。约进针5分左右，患者有酸麻感，并向咽喉部放射，停止进针，然后接G6805治疗仪，选直流电连续波，频率以患者能耐受感觉舒适为度，留针30分钟，1日1次。

共治疗13例，全部治愈。疗程最短7天，最长11天。

王爱平 电针增音穴治愈软腭麻痹13例 中西医结合杂志

第四节 耳科疾病

1. 美尼尔氏综合征

针 刺 法

1. 取穴：以印堂、内关、安眠②为主穴。以听宫、风池为配穴。

2. 针刺方法：每次必需针刺主穴，耳鸣、耳聋重者配听宫、风池快速进针，待取得针感时按平补平泻捻针1~2分钟后，留针20~30分钟，每日针一次，10次为一疗程。

治疗75例中，痊愈29例（38.7%），显效25例（33.3%），好转16例（21.4%），无效（6.6%），总有效率为93.4%。

徐笨人等 针刺治疗内耳性眩晕75例 中国针灸（1），31，1986

耳 压 法

主穴：内耳、晕点、肝、肾。配穴：贲门、神门、任②、三焦、太阳、交感、神门。晕重耳鸣者加三焦、神门、太阳等。操作时，先用探棒在耳区寻找反应点，再在反应点上做出记号，然后把粘有王不留籽的5mm见方的胶布，粘贴在穴位上，压实（王不留籽对准穴位记号）并嘱患者每穴每次按压5分钟，每天按压5次，每隔一天换贴一次，双耳轮换贴压，5次为一个疗程。

共治疗68例。症状在一天内全部消失，一年以上未复发者为痊愈。

愈，贴耳压后症状消失，半年期间偶有轻微头晕者为显效。治疗后症状减轻发病时症状持续时间缩短 $1/2$ 以上，3 个月内不复发者为有效。治疗后症状无显著变化为无效。

治愈 61 例，有效 5 例，无效 2 例，总有效率为 97%。最少贴压 1 次，最多 5 次。

潘纪华 耳压治疗美尼尔氏综合征 68 例 陕西中医(2);85,1988

2. 聋 哑

针刺电针法

听宫为主穴，翳风、听会为辅穴。进针深度 9 岁以下的小儿、儿童 1~1.2 寸，10~15 岁 1.3~1.5 寸，16 岁以上 1.6~2.2 寸，针刺后治疗仪工作通电 25 分钟（年老、体弱者、幼儿第一次针刺时一般不通电）。在本组 100 例聋哑病人治疗时采用的电疗仪是该院和上海第九人民医院共同研制的 KSB-1 型光电声治疗仪和上海医用电子仪器厂生产的 BT701 电麻仪，各导联脉宽为 0.5ms，频率 4—100/分，脉冲幅度（峰值）正脉冲 50 伏，负脉冲 25 伏，使用的毫针是苏州医疗器械厂生产 0.5~3 寸的毫针。

共治疗 100 例。聋哑病人来院进行 1~3 个疗程针刺、电针综合性治疗后，在 30 米内听到汽车喇叭音或手表放在耳根部听到滴答音的，语言经过训练能简单和成人对话的为痊愈，25 例。能在三米内听到大人对话声，语言经过训练能较清晰地叫父母及兄弟姐妹的为显效，27 例。家属反映经过针刺、电针治疗后听到关门声和其它音响的为好转，42 例。经治疗一米以内听不到成人对话或关门声的为无效，6 例。

张耀东等 针刺、电针治疗聋哑 100 例疗效观察 中国针灸(6); 22, 1986

3. 抗生素中毒性耳聋

针刺电针法

主穴：耳中穴、耳尖上 2 寸，聋鸣穴耳尖上 2.5 寸，肾俞、翳风、听宫。配穴：中渚。快速进针到应有深度，施以捻转提插（平补平泻法），留针 30 分钟或电疗 20 分钟。10 日为一疗程，疗程之间休息 3—5 天。

共治疗 100 例。我们为获得针刺效果的客观和主观指标，治疗前后均作脑干诱发电位测听、声阻抗、电测听、音叉试验、秒表、语音等测试，以排除精神性聋和中耳病变。

电针治疗 50 例，痊愈 35 例，显效 9 例，有效 4 例，无效 2 例。

高留华等 针刺、电针治疗链霉素类中毒性耳聋 100 例 中医药学报 (2); 37, 1990

针药并用法

1. 针刺疗法：取聋耳同侧完骨穴。该穴位于耳后乳突外下缘接之凹陷处，入发际四分。进针时针尖与颈部呈 60° 夹角，向同侧眼眶外缘进针，深达 1.5 寸左右。以患者自觉内耳有麻、胀、痒、热感为得气，部分患者在针刺时有耳内鸣响声或耳内豁然开朗的通气之感。以平补平泻手法稍许捻转，不留针，每日一次。

2. 中药治疗：“解毒饮”由银花 30 克，连翘、牛蒡子、菊花、生地、白蒺藜、桔梗、甘草各 15 克组成。每日一剂，水煎，分早晚服。

按上法针药并治，以 1 个月为 1 个疗程，复行电测听检查（于同一医院、同一仪器、同一人操作，共有 8 家市级医院进行检查）。治疗 3 个疗程后判断总疗效。

共治疗72例。按北京市耳鼻咽喉科研所聋哑治疗组制订的疗效判定标准为依据，观察纯音电测听语音频率 500、1000、2000 赫兹气导数值变化。显效：单耳听力平均提高 30dB 以上；有效：单耳听力平均提高 15~29dB 之间；无效：双耳听力平均提高均不足 15 dB，或三个疗程后继续接受治疗，听力提高虽达 15dB 以上者仍按无效病例统计。

72例经治疗后，获显效者27例（37.5%），有效者35例（48.6%），无效者10例（13.9%）。总有效率为86.1%。72例127耳，治疗后听力提高 30dB 以上36只耳（28.4%），听力提高 15~29 dB 之间 54 只耳（42.5%），听力改善不足 15dB 37只耳（29.1%）。总有效率为70%。

王乐善等 针药并用治疗抗生素中毒性耳聋 中医杂志（10），44，1987

4. 突发性耳聋

针 刺 法

取穴，先刺肾俞、翳风、外关；次针听会。针刺以上4穴至应针深度后，施以捻转提插（平补平泻法），待针感诱导至耳区后，连接电针治疗仪，通电20~40分钟。对单耳患者同时取以上4穴（患侧），每周治疗6次；对双耳患者交替针刺以上4穴中之两穴（肾俞、听会；外关、翳风。），每周治疗6次，12次为一疗程，疗程之间休息两天。

共治疗37例。治疗后听力逐渐恢复，耳鸣逐渐减轻以至消失，全频率听阈曲线逐渐上升至正常范围或与健侧相近似者为痊愈，26例。全频率听阈曲线较治疗前回升超过30分贝或进入实用听区，主观症状明显好转者为显效，8例。听阈曲线的多数频率回升15~30分贝，主观症状也好转者为进步，8例。听阈曲线的多数频率较治疗前上升不足15分贝，不论主观症状是否好转，均作无效论，3例。

第五节 口腔科疾病

1. 牙 痛

针药并用法

针刺阿是穴(以痛为俞), 针尖须达牙根深部。配合谷穴用泻法, 若虚火牙痛用补法。视病情轻重至少留针60分钟。

内服自拟牙痛一号: 石膏120 g 生地20 g 白芷10 g 升麻5 g 细辛3 g (后下) 金银花20 g 黄柏10 g, 水煎分早晚两次服用。

共治疗410例, 治愈率100%。

李景文等 针药治疗牙痛410例 吉林中医药(5); 22, 1990

针 刺 法

自然握拳, 在手背四五指缝尖上方约0.5cm处取穴。避开可见浅静脉, 用毫针顺掌骨间隙刺入0.5~1寸。左右捻转数次, 以得气为度, 局部可有酸胀麻电感, 向臂肘或指端放射。一般先刺患侧即效, 15分钟后效差者加刺对侧。留针20至60分钟, 每15分钟行针1次。出针后稍压针眼片刻, 以防出血。针后2小时内勿洗手。

共治疗385例。只计首次即时效果, 复治不计。显效(消失或显著好转者)303例, 有效74例, 无效8例, 总有效率约98%。

申 健 针刺液门穴治疗牙痛385例 陕西中医 (2); 83, 1989

针刺、刮药疗法

一、针刺为主。对牙疼病人进行详细检查，分清虚实（轻重），首先取主穴合谷，配以循经取穴。加减：胃火型牙疼，加足三里、内庭、上牙疼加下关，下牙疼加颊车，酌情配人中、承浆等穴；肾虚型牙疼，加太溪、行间等穴；风火型牙疼，加风池、风门等穴；局部有阳性反应物者，也宜作为主要配穴。按“泻实补虚”的原则，实症重症用泻法，虚症轻症用补法。凡是实症重症者合谷穴宜重刺激，提插捻转，针感宜明显向臂、项部放射为佳，以病人能忍受为度。此时大多数患者可立即止疼或疼痛明显减轻，再持续运针3—5分钟以上，疼痛消失或明显减轻后，留针，间歇运针，留针时间3—10小时，疼痛消失三小时以上即可起针，严重者日针二次，转轻后日针一次。虚症轻症用补法，得气为度，手法宜轻，一般留针半小时即可。一日或间日针一次。

二、刮。疼牙局部牙龈见有瘀血、肿块等异常反应物者，用三棱针由轻到重刮治，以病者不痛为宜，放出紫血或其他污物；蛀牙痛轻刮，放出坏血为妙。一般病者刮后即感轻松。

三、药。川乌3g、草乌3g、良姜3g、细辛3g、白芷3g、六十度酒90ml，以上六味放茶缸中加盖炖开水内温之（杯外加温），二十分钟后用药酒连续含漱2—3次；肾虚牙痛者可用升麻9g、黄柏6g、食盐3g水煎服；风火牙痛、风邪偏盛者用蔓荆子6g、白芍6g、川芎6g、葛根6g、升麻5g、甘草3g、羌活6g、独活6g、僵蚕2g、香附9g、柴胡6g、防风9g、生姜大枣为引水煎服。蛀牙作痛以百年陈石灰三两研末，露蜂房三个研细，蜂蜜三两和匀，外以盐泥封固，火煨一日，研末擦牙或放蛀牙洞内，此药为《本草纲目》中“神仙失笑散”加味。以上诸药可因症施治，辨证加减，不可拘泥，针、刮、药相互配合，方可收卓效。

经针、刮、药治疗后，100例患者中即刻疼痛消失，减轻97例占97%，无效3例占3%；百分之九十的牙痛病人经1—3次治疗疼痛

逐步消失,治疗三次以上无效,或疼痛虽有减轻不能消失者占百分之十。随访一年未发者82例。

崔奎学 针刺为主,刮、药为辅治疗牙疼 100 例 贵阳中医学院学报 (3); 62, 1987

耳 压 法

用王不留行子贴压耳穴“牙痛奇效”治疗牙痛38例(急性牙髓炎12例,根尖周围炎17例,冠周炎9例),均在1天内痛止,其中21例治后痛即停止。耳穴牙痛奇效在内分泌、三焦和内鼻等三穴中间。治疗时,将王不留行子固定在7 mm 见方的橡皮膏上,然后按贴穴上,加以压迫,使之产生酸、麻、胀、痛、热的感觉。如兼失眠,加贴枕穴,有炎症者加贴肾上腺穴,头痛者加贴相应耳穴。1天按压3~4次,每次3~5分钟。

来心平 治牙痛38例 浙江中医杂志 (4); 164, 1988

2. 针麻拔牙术

针 麻 法

取双侧合谷,用30号2.5寸毫针快速进针深约2寸,捻转与提插并进,以得气为度,留针10~15分钟后手术。

共针麻127例。结果成功119例,失败8例。

针麻诱导时间以10分钟为佳。针麻下手术后的创口愈合,优于药麻。

刘继先 针药拔除下颌阻生第三磨牙 194 例疗效观察 上海针灸杂志 (2); 26, 1986

3. 智齿冠周炎

针 刺 法

针刺取病侧之颊车、大迎、合谷、下关穴，得气后留针20分钟，每五分钟行较强刺激一次，每日一次。

共治疗93例。治愈标准为患侧无疼痛，肿胀消失，张口度在2.5~3.5 cm，进食正常，口内检查冠周无红肿，无溢脓。本组42例中经一次针刺治愈者10例，二次治愈者28例，3~5次治愈者3例，无效者1例。

高 虹等 针刺治疗智齿冠周炎42例 湖北中医杂志 (2), 19, 1991

第六节 其 它

1. 戒 烟

耳穴加体穴压药法

耳穴中肺、胃、交感分别压白芥子、莱菔子、苏子。体穴压人丹，辨证选穴。

用75%酒精常规消毒，医者用左手固定患者耳廓，右手持用胶布贴敷的药粒，对准穴位埋好即可。每天自行按压次数、以加强刺激，烟瘾发作时随时按压。先按压体穴，后按压耳穴。

疗程：每天治疗一次，六次为一个疗程，左、右侧交替进行。

完全不吸；显效：吸烟量减少1/2以上，有效：吸烟量减少1/2以下。无效：吸烟量基本不变。

共治疗60例。

戒烟 (%)	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)
34 (56.67)	18 (30.00)	5 (8.33)	3 (5.00)

张健敏等 耳穴加体穴压药戒烟 120 例 陕西中医函授 (4), 28, 1989

耳 压 法

1. 耳穴：1组：肺、神门、肾。2组：心、气管、皮质下。两组耳穴均取双穴。2. 药物：黄荆子的果实。晒干后直径约2毫米，圆球形，棕褐色，质坚硬。3. 操作方法：先以75%酒精擦净耳穴，待皮肤干燥后，将黄荆子一粒同适当大小的方块胶布附在穴位上，以拇指两指加压揉按，使稍有压痛感，局部充血发红，并嘱戒烟者每天自己按压3—5次，三天换丸一次，每三次为一疗程，两组耳穴轮流压丸。一个疗程有显效者，可再治疗一个疗程以竟全功。如两个疗程后无明显效果者，不再继续治疗。

33例经压丸治疗后，效佳者自觉口腔有味觉改变，厌恶吸烟，或吸烟时觉烟味变淡，往往吸数口而弃去，或由嗜烟如命到吸不吸均可等。33例中，已戒烟者（追访一年以上）24例，占72.7%；吸烟量明显减少者6例，占18.2%，无效者3例，占9.1%。

李关键 耳穴压丸戒烟33例疗效观察 江西中医药 (4); 40, 1990

耳穴埋针法

在耳穴肺、胃、神门三个穴区内，分别查找出一个最明显的反应

点，埋针治疗。即用探针均匀地用力按压各点，测查压痛最敏感的部位。决定一个最显著的反应点为戒烟埋针部位。施术时、先常规消毒皮肤，以左手固定耳廓，绷紧埋针处皮肤，右手用镊子夹住揸针式皮内针的针环，准确刺入选好的反应点内，贴上小块园形胶布固定。留针5~7天，每日按压3~5次。如出现吸烟要求时，便立即压埋针处，抑制吸烟的要求。埋针期间。要保持耳部干燥和卫生。

疗效与分析：经过1~6次戒烟治疗后，多数获得疗效。戒烟近期有效率为85%。其中完全戒烟者16例；吸烟量减少2/3以上者2例；减少 $\frac{1}{2}$ 以上者5例；减少不显著者4例。有3例治疗2次，1例仅治1次，而他们的吸烟史则较长，吸烟量也较大。

李伯宁 耳穴反应点埋针戒烟27例 中国针灸 (5); 7, 1986

2. 戒 酒

耳 针 法

选耳针穴位，用揸针或粘压王不留行子的方法治疗。选双耳的神门、皮质下、心、胃、内分泌、咽喉等，在此穴附近寻找痛点，或用经穴探测仪测敏感点，如压痛点与敏感点与上穴不符，以痛点与敏感点为针刺或压药部位。每次选2~4穴（双耳）。

按压揸针或王不留行子，直至疼痛难以忍受，用胶布固定。留针3天后再重换针或药子。4~8次为一疗程。超过8次仍无效者按无效处理。要求病人饭前5分钟自行按压耳穴直至欲望消失。

共治疗310例。痊愈：针后不但不再饮酒，而对酒产生厌恶感，见酒或闻到酒味后恶心、寒战、头痛、周身不适，甚则饮酒即吐等，经随访三月未见再饮酒者共238例。好转：针后对酒无成瘾要求，但也无明显反感。酒量较治疗前下降1/2，并多饮用低浓度酒，如啤酒等，针后不超过3个月又开始饮酒者共38例。无效：针后仍饮酒，酒量以及酒后的精神状态与治疗前无变化者共34例。

孙申田等 耳针戒酒310例临床报告 中医杂志 (3), 55, 1987

针 刺 法

针刺内关, 用平补平泻法; 列缺, 用迎随补泻法。留针30钟。

对11例欲戒酒者进行针刺观察, 结果疗效肯定。有的针1~2次便达到了戒酒目的。

李兴业等 针刺戒酒11例治验 吉林中医药 (4), 38, 1990

3. 施行颈部手术

水针注射法

取5 ml注射器, 抽取生理盐水或注射用水5 ml, 套用6号半针头, 注射于合谷穴, 刺向掌心, 深度为1.5~2 cm, 双侧合谷各注射5 ml。在施手术处切皮前20分钟, 肌注杜冷丁50~75 ml (小儿1 mg/每公斤, 若病情需要, 2小时后追加1次)。

共行87例, 甲状腺机能亢进者48例, 甲状腺腺瘤24例, 颈部外伤15例, 麻醉效果好, 诱导期短, 麻醉期间平稳, 术后恢复快。

张 玲 合谷水针注射麻醉施行颈部手术87例 浙江中医杂志 (7), 310, 1988

4. 施行扁桃体摘除术

针 麻 法

1. 手术方法: 剥离法。

2. 术前用药: 与一般扁桃体手术同, 术前一小时服鲁米那0.09

g (对此药过敏者也可不用)。术前皮下注射阿托品 0.5mg。

3. 针刺穴位及方法: 电针刺激双侧合谷穴, 手术前20分钟开始诱导, 连续刺激至手术完毕。

针麻50例。完全无痛, 手术进行顺利者为优良, 8例。有不同程度的疼痛, 但仍能完成手术者为良好, 38例。用针麻不能完成手术而改用其它麻醉方法者为不良, 4例。

陈仁华等 针刺麻醉摘除扁桃体50例 中国针灸 (1), 11, 1986

5. 行 切 脾 术

针 麻 法

一、术前准备 针麻手术对象确定后, 向患者介绍针麻方法和特点, 使其有精神上的准备, 以解除不必要的疑虑。部分病人做了术前预测工作。

二、术前用药 术前1小时, 肌注鲁米那 0.1 g, 皮下注射阿托品 0.5mg。

三、穴位分组 I组取穴: ①体针: 主穴: 内关、合谷、足三里、三阴交。配穴: 公孙、丘墟、太冲、章门、鸠尾。②耳针: 脾、胃、神门、交感、腹。此组由4位医生施针。II组取穴: ①体针: 足三里、切口穴(刀口旁1.5寸处)、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、公孙、章门(诱导后针拔去)。②面针: 脾透胃。③水针: 安眠穴(维生素B₁ 0.5 g, 每穴0.5ml)。此组采用电针。III组取穴: ①体针: 足三里、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞穴、切口穴。②面针: 肺透乳膈。

四、施针方法 先针背俞穴, 用6寸长毫针, 右手持针, 针身与皮肤呈15~25°角, 左手将穴位捏起, 将针逐步分次刺入肌层后, 用1.5寸宽、6寸长胶布贴住针身固定, 病人仰卧。然后用同样的方法针腹部切口穴, 再行面针肺透乳膈, 最后针足三里穴, 针尖向上, 针感要求向腹部传导。耳针要求用1寸毫针, 针刺0.1寸。

五、刺激方法 得气后针尾接G 6805 针疗仪，频率 300~500次/分，电流强度自小到大，以病人能耐受为度，针尾微微跳动，根据手术进程采用不同波型，一般在开腹前用疏密波。在切皮缝皮时适当加大电流量以减轻疼痛。

六、辅助用药 切脾前 5~10分钟一次给予杜冷丁 1~1.5mg/公斤体重，静脉滴注或推注。

七、诱导时间 20~30分钟。

按1975年全国统一针麻评级标准，Ⅰ级38例，Ⅱ级40例，Ⅲ级19例，Ⅳ级（失败）6例。成功率94.2%，优良率达75.7%。

胡丽梅 针麻切脾术103例临床观察 江苏中医 (3), 19, 1990

6. 行妇科手术

唇针电麻法

治疗方法：1.术前半小时肌注鲁米那 0.1g，阿托品 0.5mg。术前 5分钟，均先静注杜冷丁 50mg。2.针刺穴位及方法：①取穴：从人中穴以15度角斜插进针至鼻中膈约入鼻中膈 0.3cm。②由下唇正中下距承浆穴 0.3cm 向鼻的方向以15度角斜刺入承浆穴。两穴进针后接6805针麻机（人中接正极，承浆接负极），以连续波诱导15~20分钟，诱导时间不少于15分钟在诱导时间内以连续波进行刺激，频率由零逐加至九，输出强度由 0 增至 4（频率达6000次/分左右），当刺激强度达到最强时，病人出现流泪或流唾液，个别不能忍受以上刺激者，应适当降低刺激强度及频率。术中以同样的强度及频率持续进行刺激。

①评定标准，病人安静无痛，手术顺利者为优良；有轻度的疼痛或鼓肠，需辅助静注安定或氟哌啶醇或因鼓肠须向腹腔喷射 2%利多卡因 5ml 后手术仍顺利完成者为良好；用针麻不能完成手术而改用其它麻醉者为不良。②麻醉效果：子宫修补术38例中，优良37例，1例

不良。子宫次全切除15例中，优良11例，良好3例，1例不良。总成功率96%。

李荣基 唇针电麻应用于子宫修补术及子宫次全切除术53例 中国针灸 (2); 32, 1987

7. 休克病人手术

针 麻 法

根据休克程度选用术前药。23例未用术前药，14例用杜冷丁50毫克·阿托品0.5毫克，16例单用杜冷丁50毫克，7例单用阿托品0.5毫克。未用其它镇静止痛剂。

56例腹部手术选用耳针取神门、肾上腺、交感、皮质下、肺、枕。根据不同脏器手术选三对对称性穴位。用G6805型电麻仪。电流强度以病人能耐受为宜。频率200~300次/分。4例四肢手术选用体针，以伤处近心端循经取穴。

针麻效果：按1975年全国针麻效果评定标准：I级21例，II级22例，III级12例，IV级5例。

杨生泰 针刺麻醉用于休克病人手术60例 中国针灸 (1); 32, 1987

8. 术后切口痛

按压耳穴

相应部位的敏感点，神门。

将胶布剪成1平方厘米大小菱形或方形备用。然后将耳穴探测仪探棒插头插入探测插孔内。操作者手持探笔，把手握极交给病员，嘱

用手握紧，打开电源开关，把探棒置于上耳根的脊髓穴位上，慢慢地调整电位器，使探测仪的喇叭发出“嘟、嘟”响声，即可开始探测，在疾病相应部位的耳穴上进行均匀的探压（如胆道疾病病员探测肝胆区、肝区，再配以神门或皮质下；阑尾术后病员探测大肠、阑尾穴，再配神门或交感。一般选一个主穴，一个配穴）探测到敏感点时，仪器喇叭发出响声或音调变化为敏感点。尔后将菜籽或火柴头揠压在敏感点，将已准备好的小胶布贴在菜籽或火柴头上压紧。用手指按压1～3分钟，并嘱病员当伤口疼痛时按压1～3分钟。如无耳穴探测仪，可用大头针的圆顶端或毫针针尾在耳部寻找敏感点，病人感到最刺痛的部位即为敏感点。共治疗50例。本组有效者占94%，无效者占6%。

武和平 按压耳穴治疗术后切口痛50例临床观察 上海针灸杂志 (1); 11, 1987,

9. 微波针刺麻醉

微波针刺麻醉法

术前向病人做好解释工作，并进行微波针麻效果预测。常规术前肌注阿托品0.5mg、安定10mg。

以乳腺疾患为例。(1)循经取穴，进针得气后加用 DBJ-1 型微波针灸仪，输入功率 $\geq 2.5\text{W}$ ，工作频率 $\geq 400\text{MHz}$ ，10分钟后测试皮肤耐痛阈，用连续微波诱导维持手术。

当皮肤耐痛阈未明确变化即微波针麻术前预测欠佳时，选用强痛定100mg肌肉注射或选用频率为3—20Hz的电针强化。针刺麻醉组于术前10分钟静注杜冷丁50mg，其它方法同上。

共治疗70例微波针刺麻醉手术病人中，乳腺手术35例，I级率68.57%，II级率28.57%，III级率2.9%，成功率100%。

王仰宗等 微波针刺麻醉的临床应用 中国针灸 (49); 27, 1987

10. 纤维胃镜检查

耳穴压籽醉论法

中药王不留行，氧化锌橡皮硬膏

胃穴、咽喉穴，精神紧张者加神门穴，男取左耳、女取右耳。

取 $1 \times 1\text{cm}$ 氧化锌橡皮硬膏，将王不留行粘于硬膏中央，再将王不留行对准上述选穴，贴紧硬膏，嘱病人自行按摩10分钟后，即可进行胃镜检查。

插镜顺利，检查全过程中无呕吐及恶心者为显效；插镜顺利，检查中偶有恶心呕吐，但能完成检查者为有效；插镜过程中出现频繁呕吐，自行退出咬口，甚至自行拔镜，需多次插镜才能完成检查，或检查后出现并发症者为无效。

共治疗1100例。显效981例，占89.2%；有效110例，占10%；无效9例，占0.8%，总有效率为99.2%，均无不良反应及并发症。

代先富等 耳穴压籽代替麻醉剂在纤维胃镜检查中的应用 中国针灸 (2); 27, 1987

针 麻 法

1. 术前准备：检查前一日晚10时开始禁食禁水，术前10分钟进行针麻操作。

2. 取穴本着少而精的原则，由6穴减至3穴。6穴位4例即：内关₂、合谷₂、足三里₂。4穴位5例即：合谷₂、足三里₂。3穴位91例即：合谷₂、足三里右。共100例。

3. 麻醉方法：针刺合谷₂、足三里右，得气后将合谷₂连接针麻仪，逐渐增大电源流量，其刺激程度以引起针感或局部肌肉抽动而又不觉疼痛为宜。一般给 $\text{HZ}500$ 次/秒，诱导10分钟后即可下胃镜。

针麻效果评定标准:

I级(优): 进出镜顺利, 操作中患者安静无痛苦表情, 检查中胃无过度蠕动及收缩, 能顺利通过幽门, 用返转镜手法观察胃底也无作呕反应, 术后患者反映良好。

II级(良): 进镜时患者稍作呕, 但能顺利进出镜, 返转镜看胃角和胃底时稍有作呕。

III级(尚可): 进镜时作呕明显, 但尚能完成胃镜检查, 进镜和退镜均有作呕反应。

IV级(失败): 因作呕明显进镜困难, 不能完成胃镜检查术。

共治疗100例。

	穴位	I级	I级	II级	IV级	共计
胃镜检查术	6穴	2	2			4
胃镜检查术	4穴	1	4			5
胃镜检查术	3穴	81	7	2	1	91
有效 率		84%	13%	2%	-1%	99%

周大业等 针麻下施行胃镜检查术100例观察 天津中医 (6), 22, 1987

11. 痛 证

头穴透刺法

1. 周身或半身疼痛: 百会透后顶, 风府透天柱, 正营透承灵。
2. 头痛: 头维透曲鬓, 囟会透上星, 脑户透玉枕。
3. 面痛: 上星透神庭, 后顶透百会, 脑空透窍阴。
4. 目痛: 通天透承光, 正营透目窗, 玉枕透天柱。
5. 耳痛: 颅息透翳风, 耳门透听宫, 承灵透正营。

6. 齿痛：浮白透完骨，完骨透翳风，悬颅透曲鬓。
7. 口舌咽喉痛：风府透哑门，浮白透窍阴，颌厌透曲鬓。
8. 颈项痛：本神透头维，囟会透前顶，强间透脑户。
9. 胸肋痛：玉枕透风池，通天透承灵，脑空透风池，灸本神。
10. 上腹痛：率角透悬厘，颅息透瘰脉，风府透哑门。
11. 上肢、肩背痛：耳门透听宫，正营透承灵，强间透脑空。
12. 下腹痛：浮白透窍阴，哑门透天柱，百会透后顶。
13. 臂、下肢痛：浮白透窍阴，哑门透天柱，前顶透颌厌。
14. 脊背腰骶痛：前顶透白会，承光透通天，强间透脑户。

针尖与头皮呈 15° 刺入皮下，施捻转、震颤手法，每隔 5 分钟行针 1 次，留针时间不少于 1 小时，必要时可达 3—4 小时。实证可刺血少许，虚证时可温灸。每日 1 次，5 次为一疗程。

共治疗 126 例。显效（针刺后疼痛消失且持续一周以上）71 例，好转（针刺后疼痛消失，次日或一周内又复发）38 例，有效（针刺时疼痛减轻，出针后又复发如初）15 例，无效（针刺前后症状无变化）2 例。

张鸣九 头穴透刺治疗痛证 126 例临床小结 江苏中医 (6), 20, 1988

针 刺 法 (一)

取耳区的交感穴，头颞部的悬厘穴。坐位、卧位均可。常规消毒后，用 28 号 1.5~2 寸的毫针，从交感穴向悬厘透刺，得气后，小幅度快速捻转 3~5 分钟，边捻针边让患者活动患处，然后留针 20~30 分钟。5~10 分钟行针一次，每日或隔日一次。拔针时用干棉球按压针孔，防止出血。

疼痛消失者为痊愈；疼痛减轻，痛时缩短、范围缩小者为好转；经治疗疼痛无改变者为无效。

共治疗 211 例中，痊愈的 70 例，占 33%；好转的 113 例，占 53%；无效的 28 例，占 13%。

针 刺 法 (二)

1. 取穴: (1)根据上海中医学院编写的《针灸学》夹脊穴的定位方法。即从颈1~骶4后正中线左右旁开0.5寸, 夹脊两旁之椎间隙部位共28对, 56穴。(2)以脏腑在背部俞穴同一水平的夹脊穴。如脾胃功能失调所致的急性痛症, 取与脾俞、胃俞同一水平的夹脊穴。全部病例均取双侧穴。(3)局部取穴, 如急性腰痛者取病位局部夹脊穴。

2. 体位: 根据患者的病情, 可用俯卧位、侧卧位、或仰伏坐位。既要使患者舒适耐久, 又要方便针刺操作。

3. 操作: 采用28~30号1.5寸不锈钢毫针, 直刺1~1.2寸, 进针得气后施用提插补泻手法, 每隔3~5分钟捻针一次, 留针30分钟。

共治疗120例。疼痛完全消失(包括压痛)为痊愈; 疼痛基本消失, 压痛基本消失为显效; 疼痛症状减轻为好转; 症状体征未减, 改用他法治疗为无效。

结果: 痊愈64例, 显效21例, 好转4例, 无效11例, 有效率达90.8%。其中: 止痛时间最短3分钟, 最长30分钟, 超过30分钟为无效。

张 晓 针刺夹脊穴治疗120例急性痛症疗效观察 江西中医药 (3); 38, 1990

耳 压 法

操作: 将王不留行子置于0.6cm×0.6cm的胶布上, 先用火柴棒端按压神门及所取穴位, 以有刺痛、灼痛感为准, 然后把置有王不留行子的胶布对准穴位贴压固定, 由轻到重按压至耳廓发热。嘱患者

每天自行按压3~5次，疼时可加强按压1次，每次使耳廓发热为宜，2~3天换贴1次，两耳交替，5次为1疗程。取穴：所有痛证均取神门穴，配病变相应部位的敏感穴。胃痛加胃、皮质下；头痛加脑干、皮质下、枕；牙痛加牙、颌；落枕加颈、颈椎；肩周炎加肩、肩关节；腰痛加腰椎、肾；痛经加子宫、内分泌；胁痛加胸、肝胆。

共治疗83例。疼痛消失为痊愈，疼痛明显减轻为显效，疼痛略有缓解为好转，疼痛无缓解为无效。痊愈41例，显效28例，好转11例，无效3例。总有效率为96.4%。治疗期间停用止痛药物。

赵联和 耳压神门穴为主治疗各种痛证83例 山东中医杂志 (6), 22, 1990

氢氧化钠溶液穴位注射

取穴原则：以病人疼痛的部位循经取原穴，加辨证取原穴，如足底痛取太溪或配京骨，足底痛取太溪，余症类推。

操作：取1ml皮试针筒，4~5号注射针头。原穴局部常规消毒，快速进针，行轻微提插手手法，得气后抽回血，然后注入0.05ml 10^{-9} gm/ml 氢氧化钠溶液，出针后用干消毒棉球稍压针孔。

经1次注射后疼痛立即消失或缓解为即时有效；观察3个月以上疼痛无复发者为痊愈；疼痛明显减轻者为有效；注射后疼痛缓解不明显为无效。

共治疗100例。100例疼痛患者，其中最多注射8次，最少1次，平均为2次。当即疼痛消失30例，疼痛明显缓解66例，疼痛无改善4例，即时有效率为96%。经3个月以上观察痊愈44例，有效30例，无效26例，总有效率为74%。

许荣正 氢氧化钠溶液穴位注射治疗疼痛100例 上海针灸杂志 (1), 5, 1987

磁镊针法

1. 凡有疼痛症的患者在基本诊断清楚后便可采用本法治疗。

2. 取穴：采用局部与远端循经取穴相结合，每次取1~3个穴位。（先找出病处的敏感点，然后在疼痛部取穴，如该处及邻近处没有穴位，就用阿是穴——痛点）。

3. 操作：将针尖放在穴位上，针体与穴位表面呈垂直、同时用右手拇、食、中三指握住针体向下按压，余强度以患者出现酸、麻、胀或有冷热感为度，如无上述得气现象，则施力按压以患者能忍受为度。

4. 每个穴位施治2~10分钟。每日一次，如1~2次疼痛不消失者以5次为观察结束记录。以最后一次疗效情况为评定指标。

共治疗226例。采用主观疼痛报告法，分四级：（1）重度性疼痛（++++）：疼痛难以忍受并已影响了正常的生活与工作或学习；（2）较重性疼痛（+++）：一般般情况下疼痛不服药物等治疗时能够忍受，但给工作与休息带来不便；（3）一般性疼痛（++）：疼痛可以忍受不影响休息与工作；（4）轻度疼痛（+）：隐痛或微痛。疗效判定：治疗后无任何疼痛为痊愈（-）；疼痛减轻2级以上为显效；疼痛减轻一级为有效；达不到有效标准为无效。

226例中重度性疼痛者73例（32.30%），治愈50例（68.49%），显效3例（4.11%），有效13例（17.81%），无效7例（9.58%）。较重度性疼痛98例（43.6%），治愈63例（64.29%），显效24例（24.4%），有效8例（8.16%），无效3例（3.06%）。一般性疼痛42例（18.58%），全部治愈。轻度性疼痛者13例（5.73%），全部治愈。

侯升魁等 磁镊针治疗226例疼痛症的疗效观察 中国针灸（3），10，1987

电针镇痛法

腹部取穴，主穴以痛点最明显处为膻，配穴均取中脘或同侧肾俞。针刺得气后，加用脉冲电刺激，连续波，所用强度以患者能耐受为度，痛止后持续10~30分钟。杜冷丁组则用654—2 10mg，杜冷丁50mg，肌肉注射。

(1)经治疗后绞痛在1~3分钟内消失,举止如常者为治愈。
(2)绞痛在5~10分钟内减轻,伴全身不适感者为好转。(3)10分钟后绞痛仍未控制者为无效。

电针组治愈者36例,好转10例,无效4例。杜冷丁组治愈12例,好转32例,无效6例。

杨延光等 电针镇痛50例临床小结 江苏中医 (12); 31, 1990

耳 针 法

以病因、经络、脏腑辨证为依据,结合临床经验,以耳廓穴位神门、三焦、胰、胆、脾、胃、交感、内分泌、皮质下为主。腹胀便秘者去神门,加耳后胃肠线及脾胃穴对称处;腹泻者加小肠、大肠;有外感者加肺、咽、鼻;心慌、情绪不定者加心;体虚畏冷者加肾上腺等;呕吐者加贲门、膈、脑干;发热重者加退热点。

根据病症选取耳区3~4个主穴,局部用75%酒精擦试消毒,用小镊子挟持消毒过的30号耳针刺入所选穴位,以不穿过耳壳为宜,用小块橡皮膏固定,其它根据病情所选辅助穴位用耳压法法即可(如用王不留药籽贴压)。大多数病人在2~3分钟左右即可止痛或大为缓解,最长15分钟左右。一般留针30分钟,根据病情也可留针1小时甚至24小时以巩固疗效。一般1次用一侧耳廓,效果差者用双侧耳廓。

疗效标准 耳针治疗急性痛症以即时效果为主分三种情况:1.即时止痛:指耳针处理立即疼痛消失或基本无甚痛。2.痛减:指耳针处理后疼痛明显缓解,但尚有隐痛或小痛者。3.无效:指耳针处理后疼痛基本未减轻或一度缓解但又很快复发如故者。

共治疗288例。即时痛止208例,痛减者69例,无效者11例。总止痛有效率96.18%。

焦汉民 耳针治疗消化系统急性痛症 288例 陕西中医 (5); 212, 1988

12. 竞技综合症

竞技综合症系竞技前或竞技过程中（如比赛或考试）发生的以失眠、心悸、烦躁、口干食欲不振、恶心呕吐、腹泻或便秘、痛经、月经紊乱、手指震颤、小腿痉挛等为常见症状、甚则昏厥。

耳 压 法

①选择与穴位相配的黄荆籽，贴在0.8平方厘米的胶布中心备用。
②用探测棒在心、神门、皮质下、脾、枕等范围，寻找压痛点，随症配下脚端、肝、胃、大肠、额、缘中。均采用单侧。尔后用75%酒精棉球作常规消毒去污。
③一手用无齿镊夹住备好的胶布对准压痛点，另一手指按压胶布片刻，再嘱患者自行用食指、拇指相对按压，以耳穴有压痛感为度。每日3~5次，每次按压10~20分钟，平时看书时亦可按压以加强刺激，睡前20分钟常规按压一次。耳压法要在试前6天开始，保留至考试结束。

注意：耳压期间，避免胶布脱落失效，保证按压时间和强度，耳廓有炎症不宜采用本法，对胶布过敏者不宜采用。

贴后3日内症状消失，睡眠时间每晚达6~8小时者为显效；贴后3日内症状明显减轻，睡眠每晚达5小时以上者为有效。贴后诸症状无明显改善者为无效。

治疗111例中，效70例，占63.1%；有效33%例占29.7%；总有效率为92.8%。无效8例占7.2%。

阙云太等 耳压法治疗竞技综合症111例疗效观察 中国针灸 (2); 9, 1986

13. 梦 游

头穴电针法

头部取穴：百会、前顶、上星、脑户、脑空（双侧）、四神聪。

在上述头部穴位作针刺、深达帽状筋膜、将针柄与G6805治疗仪的电线相联接，用治疗仪上的疏密波进行电针治疗，每天治疗一次，每次20分钟，10次为一疗程。一般需1~2疗程，为巩固疗效尚可加1~2疗程。

共治疗3例，均获满意疗效。

马定详 头穴电针治梦游症3例 陕西中医(12)，553，1987

14. 痛性结节

灸 法

(一) 按型选穴：针对经络不通，气血阻滞，而形成“痛结”的发病机理，再结合“以痛为俞”的法则定阿是穴（即“痛结”）、气海、双血海等为主穴；临床各证型，均以此方为基础。气滞经脉受阻者，加灸膈中穴。血瘀经脉不通者，加灸膈俞。气虚运行不畅者，加灸双足三里。阳虚寒凝不通者，加灸关元、双肾俞。

(二) 具体操作：将燃着的艾条，置于所灸穴上，距离3~5厘米，灸至局部皮肤温热红晕时为度。病情较轻者，每日灸一次，病情较重者，每日早晚各一次。连灸10日为一疗程。最多三个疗程为限。

共治疗146例。本组病例均经1~3个疗程的悬灸治疗，并经6~12个月的随访观察。结果：“痛结”消散，临床症状全部消失，评为痊愈者74例，占50.7%。“痛结”消散，临床症状基本消失，仅在劳

动或性交后，“痛结”处有不快感，评为显效者35例，占24%。“痛结”几近消散，临床症状明显减轻，但在劳动后，疼痛复发，评分有效者21例，占14.4%。经治三个疗程后，“痛结”无减小，临床症状不改善，评为无效者16例。占11.0%。总有效率为89.0%。

邓世发 灸治痛性结节 146 例疗效观察 中国针灸 (1); 29, 1987

15. 少 阳 证

针 灸 法

往来寒热为主者，先针大椎、间使，得气后，平补平泻，留针3~5分钟，出针后各用隔姜灸5~7壮，灸至皮肤潮红为度；口苦咽干为主者，先用火针刺双侧阳陵泉，次用三棱针在手中冲放血2~3滴；胸胁苦满为主者，取丘墟透照海针刺，平补平泻得气后出针；心烦喜呕为主者，针挑剑突下皮肤异点2~5点。若兼目眩者，针刺风池、印堂，留针3~5分钟；兼有默默不欲饮食者，针刺足三里，留针10~20分钟。以上各疗法，每天1次，3~5次为1疗程。

近愈：经治疗后，症状全部消失；显效：经治疗后，症状基本消失；有效：经治疗后，症状明显缓解，停止治疗后有所复发，但较前减轻；无效：经治疗后，症状无任何改善。

共治疗40例。近愈29例，显效7例、好转3例，无效1例，近愈率72%，有效率90.5%。

焦 焰 针灸治疗少阳证40例临床体会 湖南中医杂志 (1); 31, 1990

16. 阴虚盗汗

耳 压 法

1. 耳穴：心、肺、神门、肾、肝、皮质下、交感。伴四肢困乏无力，形体消瘦者加脾。

2. 操作方法：王不留行籽高压消毒后备用将医用胶布剪成 $0.7 \times 0.7\text{cm}$ 之小块，将王不留行籽置于胶布中心，贴压时，病人取坐位，检查耳廓并常规消毒，待皮肤干燥后再行贴压，贴压完毕，每个穴位进行按压，压力之大小以患者可以耐受为度，一般耳廓发红，发热（耳廓充血），并嘱患者每日自行按压耳穴 3～5 次，隔日贴换 1 次，两耳交替贴压，10 次为 1 疗程。巩固治疗：每周贴换 2 次。

30 例患者经上述治疗，痊愈 17 例，占 56.7%（症状消失，巩固治疗期间无复发）；好转 10 例，占 33.3%（症状减轻或症状消失后又有复发）；无效 3 例，占 10%（症状无明显好转）；总有效率为 90%。平均贴压次数为 14 次。

周安平等 耳压治疗阴虚盗汗 30 例 陕西中医 (12)，555，1989

17. 厥证足膝厥冷

针 刺 法

取穴：涌泉穴

操作：常规消毒，用 1 寸毫针垂直进针，深约 0.5 寸，切忌针刺过深。随证施以补泻手法，留针 20 分钟，每日或隔日治疗一次，10 次为一疗程。

阳虚较甚：灸关元，气海；阴阳俱虚：三阴交，气血不足：足三里；阴寒内盛：京骨；兼有足趾麻木疼痛：八风。

痊愈：足膝逆冷、麻木、疼痛及伴随的其他症状均消失，触之与正常皮肤温度相同。

显效：足膝逆冷和伴随症状均有显著好转，触之皮肤转温。

好转：足膝逆冷和伴随症状较前好转，但无显著改善。

无效：足膝逆冷及伴随症状治疗前后无变化。

本组31例中，治愈15例，占48.4%；显效9例，占28.7%；好转8例，占9.7%；无效3例，占9.7%；总有效率为90.3%。

李桂兰 针刺涌泉穴治疗31例厥证足膝厥冷的疗效观察 天津学报 (1)；37，1988

后 记

在本书的编写过程中，适逢“中华人民共和国著作权法”正式实施。为了保证本书所选资料原作者的利益，我们分别向所有的原作者去函征求意见，得到了回函作者的一致拥护，在此我们向这些作者表示衷心地感谢！由于个别原作者地址不详，我们所寄信函被退了回来，希望这些原作者在此书出版半年内，将您的详细通讯地址、邮政编码、身份证明材料及您的资料在本书的页次寄给我们，以便我们为您准确地邮寄稿酬。如果超过半年我们仍收不到您的信函，我们将视您放弃稿酬，不再办理寄酬业务，敬请原作者予以理解。

无论是本书资料原作者，还是一般读者，如果有什么问题，都可以直接给我们写信，我们非常欢迎各种批评意见。

来函请寄北京东单三条甲七号 北京中医杂志编辑部 刘寿永收
邮政编码100005

编者